

**Sabrina
Critzmann**

COMER Y CRIAR

**Guía pediátrica de
alimentación saludable
para toda la familia**

 Planeta

INCLUYE
RECETAS

Comer y criar

Sabrina Critzmann

Comer y criar

Guía pediátrica de alimentación saludable para toda la familia

Índice de contenido

[Portadilla](#)

[Legales](#)

[Introducción. ¿Qué comía mi bisabuela?](#)

[1. La alimentación es patrimonio de la familia](#)

[2. Breve historia de la alimentación infantil: la epidemia de malnutrición](#)

[3. El primer bocado: embarazo, lactancia y alimentación](#)

[4. Somos ecosistema: microbiota y más](#)

[5. Desarrollo infantil de la mano de la alimentación](#)

[6. Crecimiento, aumento de peso y curvas de crecimiento](#)

[7. Alimentación complementaria: guía práctica](#)

[8. Pequeño manual BLW ilustrado](#)

[9. Neofobia y selectividad. El miedo a que no coman nada](#)

[10. Alimentación en la etapa escolar y la adolescencia](#)

[11. Alimentación basada en plantas en la infancia](#)

[12. Hablemos de caca](#)

[13. Reacciones adversas a los alimentos: alergias e intolerancias](#)

[14. Recetas, tips y secretos para comer saludable \(y muy rico\) en casa](#)

[15. Huerteando a todo ritmo](#)

[Epílogo](#)

[Agradecimientos](#)

Critzmann, Sabrina

Comer y criar / Sabrina Critzmann. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Planeta, 2021.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga

ISBN 978-950-49-7500-7

1. Nutrición del Niño. I. Título.

CDD 649.3

© 2021, Sabrina Silvia Critzmann

Diseño de tapas e interior: Álvaro Caldelas

Fotografía de tapas e interior: Alejandra López

Realización gastronómica: Dina Ricci

Foodstyling: Natalia Caneva

Ilustraciones: Julieta Farfala

Edición: Ana Wajszczuk

Corrección: Vanesa Fernández

Todos los derechos reservados

© 2021, Grupo Editorial Planeta S.A.I.C.

Publicado bajo el sello Planeta®

Av. Independencia 1682, C1100ABQ, C.A.B.A.

www.editorialplaneta.com.ar

Primera edición en formato digital: octubre de 2021

Digitalización: Proyecto451

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del “Copyright”, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

Inscripción ley 11.723 en trámite

ISBN edición digital (ePub): 978-950-49-7500-7

Dos cordones tienen los zapatos,
dos hilitos forman el sol,
dos libros reposan en los estantes,
y por dos se multiplica mi amor.

Lisandro y Juani, les amo infinito.

¿Qué comía mi bisabuela?

Mi bisabuela fue una de las tantas italianas que emigró durante una de las guerras mundiales que le estrujaron la panza, le rompieron su sueño de ser maestra y se llevaron a personas muy amadas. Viajó a los 14 años en un barco gigante, y no sé quiénes la acompañaban ni cómo fue el viaje. ¿Dónde dormía? ¿Qué comía en el barco? Cuando llegó a Buenos Aires, ¿le gustó ese puerto de aguas grises?

Poco sé de ella, pues falleció un año antes de que yo naciera. Sé que se casó con un hombre italiano, mi bisabuelo, pero como hablaban diferentes dialectos, siempre se comunicaron en español, que lo hablaba impecable y sin acento. Dejó su lengua materna –el dialecto friulano, del noreste de Italia– en esa guerra que también se llevó su niñez, no se la enseñó a nadie, y se fue con ella.

Sé que en su vejez hacía ravioles caseros, protegida por un gran delantal, y llenaba todo de harina. Sé que odiaba la polenta, porque fue su única comida muchas veces, fría y dura. También que su familia se horrorizaba viendo a los soldados comer choclo, porque el choclo era “comida para los chanchos”. Que los adultos comían la cáscara de la papa y les dejaban la parte de adentro a los chicos. Que al campo se llevaban cebollas y las comían crudas. Sé que en Italia hay una casa grande, con marcas de zapatos de varias generaciones marcadas en la madera, en cuyas habitaciones se escondían niños y niñas riéndose a gritos, esperando que viniera un tío a contarles historias de terror.

La otra rama de mi familia, la de mi apellido, huyó de Alemania unos años después. De ellos sé menos aún, pero recuerdo masitas dulces y mazapán de alguna Navidad escondida en mi memoria, de manos de una abuela que estuvo poco en mi vida.

De ambas raíces, no tengo ni una receta. Crecí en el mundo de los ultraprocesados, como todos en mi generación, y creí hasta los 12 años que el puré venía de una bolsa y se reconstituía con agua, y no tenía nada que ver

con pisar papas. Convencieron a nuestras familias de que las cosas “de paquete” eran lo mejor para nosotros. Las tradiciones se perdieron y la sopa solo salía de un sobre. Nos quedamos sin otros sabores fuera de los propuestos por quienes deciden qué meter en una bolsa de plástico que nos introducirán por todos los sentidos a través de todos los medios posibles.

Atravesé los años de facultad con penas y glorias, como todo el mundo, y me recibí de médica prolijamente **sin saber un ápice de nutrición, sin siquiera sospechar que la alimentación influía en los procesos de salud y enfermedad.** Transité la residencia de pediatría como todos mis compañeros, a base de bizcochitos, mate y gaseosa con cafeína durante la guardia, para estar más despiertos. En el ínterin, desfilé por muchos consultorios de profesionales de la nutrición buscando respuestas a una pregunta que todavía no podía poner en palabras. La mayoría de ellos se enfocaron en “bajar de peso”, a base de cosas con catorce sobres de edulcorante y de ofrecirme la misma fotocopia que a todos sus pacientes, con la misma buena voluntad con la que yo, al mismo tiempo, indicaba leche de fórmula y papillas comerciales a los míos para empezar la alimentación complementaria.

Después de recibirme, empecé a escuchar pistas sutiles y a desconfiar de lo aprendido. Ya había empezado a recorrer un camino de cuestionamiento alimentario, y a comprar especias y frutos secos misteriosos en la dietética, tratando de aventurarme en nuevos sabores y en experimentos culinarios que no siempre salían bien, y que incluían muchos ultraprocesados de dietéticas y cosas de paquete verde.

Y llegó Juan Martín, mi primer hijo. Su vida fue intensa, plena, repleta de amor y corta en tiempo. La primera vez que tomé real conciencia de que faltaba poco para que él llegara a mi vida fue leyendo un libro de alimentación complementaria, que compré en la semana 36 de embarazo. No había pensado mucho en la lactancia ni en que esa pequeña persona compartiría la mesa con nosotros. Poco después, él llegó a este mundo en un torbellino de miedo, oscilando durante días entre la vida y la muerte. En el lactario de la “neo” comenzó mi primera lactancia, y allí transité día tras día hasta que tuve la inmensa suerte de tener a mi hijo en mis brazos.

Vivimos siete meses de inmensa felicidad, y durante el último, compartimos con un bebé alegremente embadurnado papillas, avioncitos, trozos de comida, risas y muchísimos baberos. Poco sabíamos nosotros de microbiota o de Baby Led Weaning: no importaba, nos tiramos de cabeza al descubrimiento.

Poco después, inexplicablemente, Juan se fue. El mundo se volvió un lugar infinitamente triste durante mucho tiempo.

Qué difícil volver a hacer pediatría en ese contexto, ¿no? Era muy duro leer, estudiar y atender a bebés que aplaudían en el consultorio. Pero con el apoyo infinito de amigos, la vida, aunque no pareciera posible, continuó.

En 2018 llegó Lisandro al hogar, y ahora sí, teníamos toneladas de información. Durante su gestación, yo había comenzado a trabajar en redes sociales, a volcar todo lo que iba estudiando y a escuchar lo mismo que yo me había preguntado alguna vez. Me empecé a cruzar con personas increíbles que venían hace muchísimo tiempo trabajando en políticas de salud con relación a la lactancia y la alimentación, y comencé a aprender y trabajar con ellas.

En casa no erradicamos los ultraprocesados de un día para otro. Cuando llegamos a ese nivel de conciencia, quedaban muy pocos en casa, porque fuimos incorporando tantas cosas nuevas que simplemente dejamos de consumirlos.

Antes de 2018 nunca había remojado una legumbre. Hoy forman parte de la mayoría de nuestras comidas. No nos prohibimos comprar galletitas de paquete: simplemente no nos dan ganas de comerlas porque nos es más fácil, rico y económico cocinar un budín que dure varios días y sepamos qué tiene adentro. Un día decidimos realmente sacar los ultraprocesados que quedaban en la alacena y encontramos solamente gelatina vencida.

Este libro es producto de mucho estudio y mucho experimento. La ciencia avanza y soy más que consciente de que mucho de lo escrito cambiará en los próximos años. **Compartir información es fundamental para que las personas puedan tomar elecciones por fuera del bombardeo mediático que nos hacen de productos que no necesitamos y que nos enferman.** Es urgente, pues las infancias se están enfermando y tenemos una responsabilidad entre manos. El respeto a las infancias también debe partir de políticas de salud e información que protejan su alimentación.

Hoy aprendemos a cocinar felices con Lisandro. Muchas veces nos salen mal las cosas. No soy cocinera, soy una persona que cocina. Trabajo muchas horas y crío a una persona que hoy tiene 2 años, por lo que la vida es un constante malabarismo. Y aun así, las comidas salen, algunas mejores y otras peores, y aspiro a dejar en mi familia una tradición de cocina propia, transitada en la polenta que se escurre –hoy con otro significado– entre los deditos de mi hijo.

Disclaimer

En este libro se priorizó el uso de términos neutros con relación al género, como parte de la deconstrucción del lenguaje. La habilidad de la autora para el uso del lenguaje no binario se encuentra en desarrollo, por lo que en muchas ocasiones, por una cuestión meramente práctica, leerán construcciones binarias o términos unificados en masculino. Esperamos que todas las personas puedan encontrar un lugar dentro de este libro para acompañarlas en la crianza y la alimentación.

La alimentación es patrimonio de la familia

Quién sabe qué recordarán nuestras hijas y nuestros hijos.

¿Será la suavidad de la sábana recién tendida?

¿Será la tibieza de nuestros abrazos, las mañanas de invierno?

¿Será el aroma irresistible de la sopa y del pan?



¿Por qué la alimentación nos genera tanto placer y tanta angustia?

Para nuestras tatarabuelas, sugerir que se necesitaría una visita al médico para charlar sobre qué tiene que comer un bebé sería tan sorprendente como sugerir una consulta sobre cómo tiene que hacer pis. Sin embargo, **desde la década de 1980 aproximadamente, se han medicalizado sistemáticamente todos los procesos de salud, además de los de enfermedad, y la alimentación pasó a ser algo científico, lleno de números, calorías y nutrientes.**

No queda muy claro cuándo desde la pediatría empezamos a entregar listas fotocopiadas de alimentos ni por qué alguien determinó un orden en los mismos. Al que lo inventó, ¿le gustaría más el zapallo que la palta y por eso lo puso primero? ¿Le pareció que era más fácil hacer sopa de sémola que de arvejas? ¿Qué pasó que todo se estandarizó tanto que compramos una especie de alimento balanceado para bebés sin importar qué tiene?

Se suele hablar de la alimentación como el acto más complejo que realiza el ser humano. Comer implica poner en juego múltiples mecanismos motores, sensoriales, psicológicos y sociales. Comer implica siempre un otro, y la dimensión social de comer es uno de los determinantes más fuertes de este asunto.

¿Cómo venimos comiendo las adultas y los adultos cuando nos convertimos en mapadres? En medio del cambio radical en nuestras vidas que implica mapaternar y ser absolutamente responsables de una o más pequeñas vidas, la alimentación muchas veces nos toma de sorpresa.

Durante mi primer embarazo, atravesé la residencia de Pediatría (el sistema con el cual nos formamos como especialistas). En medio de guardias y trabajo intenso, aunque había buscado soporte de una nutricionista, no recuerdo haber comido jamás una legumbre durante esas 37 semanas, y haber transitado la vida a base de barritas de cereal, *pizza* y gaseosa (es muy común

en las guardias médicas consumir litros de esa bebida, que nos mantiene despiertos por su contenido de cafeína). Realmente buscaba nutrirme bien para nutrir a mi bebé, solo que no sabía cosas que hoy sí, como que los sabores de lo que comemos pasan por el líquido amniótico e impactan en la aceptación de alimentos de ese bebé más adelante, o que la microbiota de la boca de la madre tiene que ver con la microbiota del nacimiento. La verdad es que tampoco sabía nada de microbiota, para qué les voy a mentir.

Solemos pensar que la “alimentación” de los chicos empieza cuando los sentamos con un platito a la mesa. La realidad es que, silenciosamente, la placenta, un órgano que se forma durante el embarazo, y que tiene células de la persona gestante y células del bebé (cosa que al día de la fecha me sigue asombrando... ¡Un órgano nuevo y transitorio hecho de células de dos personas distintas!), **selecciona y envía nutrientes, anticuerpos y otras sustancias nutritivas constantemente al bebé.** Durante las semanas que dure la gestación, el alimento llega suavemente, constante, placido. El bebé succiona por reflejo, por placer, por las ganas de succionar, pero no necesita esforzarse para que su cuerpo reciba alimento. Tampoco tiene que regular la temperatura, respirar ni pedir que lo levanten a upa y lo abracen. Todo está allí, está abrazado y acunado las veinticuatro horas, se balancea placido en ese mar de aguas calmas adonde llegan sonidos atenuados de voces conocidas y el corazón constante de mamá.

Y de pronto, el nacimiento. Nacimiento que puede venir con un aviso, como es el trabajo de parto, que desencadena hormonas que alertan al bebé y lo preparan para un cambio radical en su vida. **El trabajo de parto es deseable e importante, independientemente de la vía de nacimiento posterior. Las hormonas que se generan ayudarán en la adaptación respiratoria, en la lactancia, en el inicio del vínculo con la familia.** Existen muchos nacimientos sin trabajo de parto, por necesitarse una cesárea de urgencia ante un problema médico o programar una cesárea por deseo, pero está bueno tener la información de que el trabajo de parto es algo positivo para el bebé y para la mamá.

Desde que el cordón umbilical se corta, el bebé queda a merced de sus capacidades para solicitar alimento. Dice Frédérick Leboyer, en su libro *Shantala. Arte tradicional de masaje para bebés* (cito algunos párrafos):

*Afuera, adentro...
De repente el mundo está partido en dos.*

*Adentro, el hambre.
Afuera, la leche.
El espacio
ha nacido.*

*Adentro, el hambre
afuera, la leche.
Y entre los dos,
la ausencia,
la espera,
que es indecible sufrimiento.
Y que se llama
tiempo.*

*Y así es
como, simplemente
con el apetito,
nacen
el espacio
y la duración.*

El bebé no llega al alimento solo, a menos que esté en constante contacto con el pecho. Cuando esto sucede, las personas miran mal a esa diada: “¿Tanto pecho le vas a dar?”. “Si toma a cada rato gasta calorías y baja de peso”. “Se ve que no tenés mucha leche, por eso toma tantas veces”. “Siempre colgado, nunca va a ser independiente”. Y otras frases que, en un momento donde se necesita ayuda y no opiniones, nos hacen dudar de nuestra capacidad para mantener con vida y salud a ese manojito de humanidad.

Cuando el bebé recién nacido llora, pide brazos, pide upa, pide pecho, no lo hace porque tenga necesariamente hambre, sino porque no sabe que estamos al lado, que estamos disponibles y que estamos prontos para alimentarlo. **A él o a ella los alimentaba la feliz placenta, a la cual no había que pedirle nada voluntariamente. Ahora, el bebé debe pedir ese alimento y ese contacto, si no lo pide, no sobrevivirá.** Y de la mano viene el despertarse muchas veces cuando los adultos tenemos ganas de descansar.

Existe desconcierto acerca de lo que hace “normalmente” un bebé. Nos dijeron demasiadas veces que los bebés duermen mucho (o deberían hacerlo),

que se quedan horas en el cochecito, que si les compramos juguetes estarán entretenidos durante horas y podremos hacer otras cosas. Y no. Los niños y las niñas, desde recién nacidos hasta bastante iniciada la adolescencia, requieren nuestro tiempo, nuestra presencia y nuestro cuerpo, ya sea aupando a un recién nacido o abrazando a un escolar cuando no le salen los deberes. ¿Cuál es el problema con esto? Que además de esto, tenemos trabajos que no contemplan estas necesidades, que no están diseñados para preservar los derechos de las personas y que dejan la salud de lado.

Hace varios años trabajo en las redes, en el consultorio y en la docencia relacionada con la alimentación infantil. Semana tras semana, año tras año, se repiten las mismas preguntas, la misma preocupación: “Empezó a comer y come dos bocados”, “Solo lo aplasta y no se lo lleva a la boca”, “¿Comerá alguna vez?”. Los niños y las niñas van creciendo, atraviesan la neofobia –el no aceptar alimentos nuevos, ya lo veremos en detalle más adelante– ante los ojos aterrorizados de sus mapadres, van al colegio, van a cumpleaños. Y, oh, de pronto, el 40 % de esos niños y niñas que no comían nada presentan sobrepeso, obesidad, diabetes, hígado graso y una multitud de otros trastornos que tienen que ver con lo que sí han comido durante todos esos años. ¿Qué sucedió?

La alimentación es patrimonio de la familia

Antiguamente, los médicos no indicábamos cómo tenía que comer un bebé. La alimentación no era un acto médico: el bebé empezaba a comer a alguna edad indefinida (recuerden que antes las personas no tenían muy clara su fecha de nacimiento, dado que anotaban a varios hermanos a la vez en el registro civil), lo mismo que comía el resto de la familia, pisado un poco con el tenedor. No había progresiones específicas, no se sugería que a los 6 meses le dieran zapallo y a los 7 porotos. Lo que había, que no era mucho, porque tampoco había heladeras para conservarlo. Y punto. **La “comida para bebés” surge después, como consecuencia de la medicalización de los nacimientos, la lactancia y la alimentación.** Y de pronto hay una caja de cereal diferente para cada edad, porque a la empresa que lo genera le pareció que era una buena estrategia y no porque fisiológicamente o culturalmente

tenga sentido.

Los médicos adoptamos estas estrategias caprichosas, también influenciados por el *marketing* que puebla nuestros espacios de formación, y armamos las famosas “listitas”, que muchas veces tienen más contenido opinológico que científico.

Brindo talleres de alimentación complementaria y otras cuestiones relacionadas desde 2018. Alrededor de cuatro mil familias concurrieron a los mismos, en forma presencial y virtual desde muchísimos lugares del mundo. Es claro que la información está llegando, se replica, se comparte y se potencia, y eso es hermoso. La información cambia, y no, ninguno de los divulgadores resistimos un archivo, porque precisamente es lo que hace la ciencia: traer nuevos conocimientos ante los cuales tenemos que ser muy humildes, aprenderlos y compartirlos.

La alimentación es patrimonio de la familia: los profesionales podemos acompañar, pero las decisiones sobre qué, cómo, dónde y cuándo comer son de cada familia en particular, y tienen la influencia del entorno, de la cultura, de las tradiciones, de lo imaginado y soñado para la alimentación de ese bebé, niño o niña. Los profesionales damos información, pero no vamos a la casa a ver cómo comen, ni nos escondemos en la góndola del supermercado para vigilar qué compran. Nuestra responsabilidad es dar la información clara, sin mentiras, comprensible para esa familia. Y la alimentación será decisión y patrimonio de esa familia.

Muchas familias, en el consultorio, me expresan que comprenden el problema de los ultraprocesados, pero que de todos modos deciden consumirlos. Perfecto: esa es una decisión informada. Otra cosa es lo que sucede con familias que intentan por todos sus medios tener una alimentación saludable y el entorno (abuelos, escuela, cumpleaños, etc.) les dicen que son exagerados, que les están “robando” la infancia a los chicos, y que “no pasa nada” con que tome gaseosa todo el día.

Se dice que hoy por hoy, hay una “obsesión por comer sano”. No, lo que hay es una epidemia de niños y niñas enfermos por lo que comemos. Y aunque no nos guste verlo, es así.

Si estás leyendo esto, es porque hay algo que te hizo ruido con relación a la alimentación de tu familia, y ya acercarte a la información es un acto hermoso. Yo no tengo la verdad absoluta: la ciencia no la tiene, es un día a día y un descubrimiento a la vez. La intención es acompañarnos en este camino alimentario nuevo y antiguo a la vez, yendo a la par de esos ojitos

exploradores y valerosos que nos ha tocado acompañar.

Alimentación como derecho

Los niños, las niñas y sus familias tienen derecho a tener una alimentación saludable, siendo esto parte fundamental de su salud. Pero, más allá de eso, la Ley N.º 23 849, que adopta la Convención de Derechos del Niño, dice lo siguiente:

Artículo 24

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.
2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para:
 - a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;
 - b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud;
 - c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente;
 - d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres;
 - e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos;

f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y servicios en materia de planificación de la familia.

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños.

4. Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar la cooperación internacional con miras a lograr progresivamente la plena realización del derecho reconocido en el presente artículo. A este respecto, se tendrán plenamente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.

Cuando pensamos en derecho a la alimentación, pensamos en evitar, sin duda, la desnutrición. Pero **hoy por hoy, si bien hay lugares del país donde hay inexcusablemente infancias desnutridas, el mayor problema es la malnutrición. Y la malnutrición muestra un panorama de niños y niñas que consumen suficientes y excesivas calorías diarias, de mala calidad, con escasos nutrientes, de la mano de más de un 50 % de niñas y niños en situación de pobreza.** El problema es que además de que muchas de esas familias no pueden elegir lo que comen, cuando existe la posibilidad de elegir, se siguen eligiendo productos de mala calidad creyendo que son la mejor opción.

Alimentación y crianza respetuosa

Cuando hablamos de crianza respetuosa, hablamos de pensar al bebé, niña o niño como una persona a escuchar, acompañar y respetar. ¿Y por qué es importante remarcar esto? Porque durante muchísimos años, se consideró que la única manera de educar era a través del miedo y la violencia. Inclusive en las escuelas se utilizaba el castigo físico, de la mano del dicho: “La letra con sangre entra”. Hoy tenemos muy claro que el castigo físico en el aula es ilegal, ¿y en casa? El chirlo, el grito y la humillación son moneda corriente en los hogares, tanto que gran parte de las familias admite usarlos en la crianza, “porque no hay otra forma”. **Sí hay otras formas, pero conllevan más**

tiempo y una crítica de la propia crianza, que a veces puede ser dolorosa y compleja. No es que antes se hizo “todo mal”, es que no se sabían las consecuencias psíquicas a corto y largo plazo que generan la violencia y el abandono.

Hoy sabemos que dejar llorar a un bebé pequeño genera una sensación tal de desamparo que el bebé no llorará más... porque sabe que nadie irá a consolarlo. Sabemos también que los niños y las niñas que padecen y observan violencia en el hogar usarán esos recursos con otras personas porque no tienen otro ejemplo. Y así, una cadena enorme de maltrato que está en nuestras manos desarmar.

La crianza respetuosa no es una crianza sin límites, abnegada en cada capricho y deseo de los niños y las niñas. **La crianza respetuosa tiene en cuenta las necesidades y los deseos de los adultos cuidadores, siempre comprendiendo que la relación es asimétrica, y que los niños y las niñas no pueden ponerse en el lugar de adultos ni viceversa.** También hace hincapié en construir límites saludables. Los límites no son un castigo, ni un reto, ni un enojo, son un borde seguro, un lugar de referencia, sumamente necesario para la construcción de la psiquis de esa pequeña persona que acompañamos a crecer.

La alimentación es una actividad que ejercemos múltiples veces en el día desde el día del nacimiento. **Hablar de alimentación respetuosa parece una exageración, pero siendo que la mayor parte de nosotros recibimos gritos, burlas y frases desagradables a la hora de comer, no me parece tema menor hablar de ello.** Frases como...

“Siempre me obligás a gritarte, ¿ves lo que hacés?”.

“¿Estás esperando que me enoje para comer de una vez?”.

“Acá se come todo porque yo lo digo”.

“Vamos aflojando con los postres, ¿no? Si no, nadie te va a querer”.

“Si lo vomitás te lo voy a hacer tragar de nuevo”.

“Voy a llamar al médico para que te ponga una inyección si no comés”.

... son violencia, lisa y llanamente. No se las diríamos a nuestro compañero de trabajo ni a nuestros amigos, y sin embargo no tenemos problema en decírselo a las niñas o los niños, en nuestro afán de que coman.

Repensar estas frases y actitudes, y empezar a pensar en vincularnos más sanamente con los alimentos es fundamental para frenar la ola de enfermedades relacionadas con la mala alimentación que estamos atravesando como sociedad.

Respetuoso es, también, ofrecer alimentos saludables. Y aquí tiene sin duda un rol fundamental el Estado, desde muchos lugares, como con las leyes de etiquetado nutricional, la educación alimentaria, los subsidios a la canasta básica... En Argentina existe hoy una política económica llamada “Precios Cuidados” que subsidia una lista de productos “básicos”. Dentro de esos productos encontramos gaseosas, bebidas alcohólicas, golosinas y galletitas, todos productos cuyo consumo reedita en problemas de salud y mayor gasto en esa salud a corto y a largo plazo. En la lista encontramos UNA fruta, la manzana, y UNA verdura, la papa. Y listo.

Pero también ese rol lo tenemos los mapadres, quienes somos los cuidadores principales. “No puedo no darle gaseosa porque yo tomo” y “Yo no pienso apagar la tele durante la comida porque me gusta mirar” son frases muy comunes y hablan de adultos/as a quienes les es difícil construir sus propios límites. También nosotros tenemos que tenernos mucha paciencia y repensar qué nos sucede con esto, y cómo poder dar el ejemplo que queremos dar. **Lo que nosotros tengamos en casa, es lo que tendrán para comer las niñas y los niños. Las infancias no pueden elegir qué ponemos en la mesa, sí pueden decidir qué cantidad comer, o no, y en qué tiempo hacerlo,** como veremos más adelante.

¿Cuál es el enorme problema? El *marketing*, la publicidad, lo que creemos que es saludable, y también los profesionales que no se actualizan. Si en la tele aparecen por semana más de sesenta publicidades de alimentos no saludables diciendo que lo son, y que son fuente de calcio, fósforo, proteínas y quién sabe qué más, “avalados por la ciencia” y hasta por gente de guardapolvo blanco y matrícula en pantalla, es muy probable que los consumamos creyendo que es lo mejor que puede haber. Las empresas de leche de fórmula, por ejemplo, tienen una división especial para ambientar consultorios de centros pediátricos: regalan mesitas y sillitas, anotadores, juguetes... Todo con una publicidad sumamente sutil pero muy clara.

Durante una pila de años, los pediatras dimos (me incluyo) una listita muy específica de productos –no de alimentos, de productos– para iniciar la alimentación complementaria. Hoy por hoy desaconsejamos la mayor parte de esos productos, porque la ciencia nos mostró que traen muchos problemas

y ningún beneficio. Entonces, todo va cambiando, y seguir la línea de la ciencia puede ser agotador, pero es imprescindible para la salud y el respeto de las infancias.

La cultura de la delgadez, las calorías y lo *light*

Todos los que crecimos en los 90 hemos contado calorías, llenado el changuito de paquetes verdes, y creímos firmemente que todo lo que diga *light* y *diet* es más sano. La caloría es una unidad de energía, y los alimentos nos dan mucho más que energía: nos dan nutrientes: ladrillos, cemento y hasta la mezcladora para mantener nuestro cuerpo en funcionamiento armónico. **Hablar hoy por hoy de contar calorías es erróneo, porque no importa que un producto tenga pocas o nulas calorías: si es un brebaje lleno de colorantes y otros aditivos, ni a nuestras células ni a nuestra microbiota le hará bien y nos enfermará.**

El culto al cuerpo perfecto, a ser como una imagen determinada e inalcanzable, dado que muchas de las imágenes que nos muestran están retocadas digitalmente, causa mucho dolor y mucho daño. Lentamente vamos cobrando conciencia y, hoy por hoy, aparecen en la publicidad cuerpos diversos, que muestran que todas las personas somos distintas y no nos tenemos que parecer a otra para disfrutar de nuestros cuerpos.

El miedo y el placer

El miedo a que los niños no coman es profundo y visceral. Tiene mucho que ver con las raíces culturales de los pueblos: siempre, en la historia de nuestra familia, hubo alguna generación que pasó hambre, y el recuerdo es fuerte y latente. No hay lugar para dejar parte de los alimentos del plato.

Ya no tenemos tanto miedo a que los niños y las niñas mueran de hambre

en nuestras casas, pero la ansiedad sobre el tema persiste. “No me importa qué coma ni cómo, mientras que coma”, es algo que escuché más de una vez de familias amorosas y muy preocupadas por la salud de sus niños y niñas, llegando a este extremo por la angustia que les genera la situación. Se suma a esto la inseguridad alimentaria exacerbada por la pandemia de COVID-19 y el aumento de la inestabilidad económica familiar.

Una vez que esos niños y niñas entran en la preadolescencia, se les plantea todo lo contrario, sobre todo a las niñas. Hay que comer menos, hay que comer poco, hay que adelgazar. Y tooodo este camino alimentario se arrastra a la edad adulta, y a la imposibilidad que tenemos como adultos de autorregular lo que comemos, a sentir hambre y saciedad, o inclusive a sentirnos bien con nuestros cuerpos.

Todas estas imposiciones culturales se llevan puesto al placer. El bebé, que es puro sentido, come por hambre y come por placer; necesita estar a upa pero también lo pide porque lo disfruta; succiona no para que entre comida a su pancita, sino porque lo relaja y lo hace feliz. El bebé que empieza la alimentación complementaria y manotea un brócoli, le es muy placentero tocarlo, ¡le están facilitando algo que deseaba mucho, que es hacer lo que los adultos hacen!, y va mucho más allá de llevárselo o no a la boca. A medida que va creciendo, esa personita se va adentrando en la cultura, y empieza a haber preferencias, momentos, situaciones para compartir como recreos, cumpleaños y fiestas. Creemos que lo “rico” se come solo en situaciones especiales, hablamos de “permitidos” y de “compensar”. Y la realidad es que toda la alimentación podría ser placentera. Nos merecemos no comer por inercia, sino por placer. Nos merecemos recorrer ese camino, de nuevo, de la mano de los chicos, con los ojos curiosos de aquellos que quieren aprender.

Para seguir leyendo

PARA FAMILIAS Y PROFESIONALES

- Leboyer, F. *Shantala. Arte tradicional de masaje para bebés* (1.a ed.), Gaia Ediciones, Barcelona, 2013.
- Muñoz, L. Curso de Educadores de Masaje Infantil de la Asociación

Internacional de Masaje Infantil (IAIM), 2020.

- Krasnoff, C. Curso Virtual “Masaje para bebés: fomentando el tacto nutritivo”, 2021.
- Muñoz, L. *Masajes para bebés. Sana sana y algo más*, Editorial Kier, Buenos Aires, 2015.
- Montanyola, R. M. J. *La crianza feliz*, La Esfera de los Libros, Madrid, 2009.
- González, C. *Comer, amar, mamar*. Espasa, Barcelona, 2011.
- González, C. *Bésame mucho*, Editorial Planeta, Buenos Aires, 2012.
- Jové, R. *La crianza feliz*, La Esfera de los Libros, Madrid, 2009.
- Raschkovan, I. *Infancias respetadas*, Editorial Aique, Buenos Aires, 2019.
- Unicef. (2017). *Crianza sin violencia: Guía práctica para evitar gritos, chirlos y estereotipos*. Recuperado de:
<https://www.unicef.org/argentina/media/1206/file/Gu%C3%ADa%20CSV>.
- Tuñón, I. y Sánchez, M. E. *Situación de las infancias en tiempos de cuarentena. Impacto del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio por COVID-19 en el AMBA*. Documento de investigación. 1.a ed., Educa, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2020.

Breve historia de la alimentación
infantil: **la epidemia de malnutrición**

La infancia está llena de
mordisquitos pequeños,
migas en las camas,
sabores nuevos en la boca.
Tenemos entre manos su
confianza, su sonrisa y su salud.



Vivimos sumergidos hace años en una pandemia mundial, y no es la de COVID-19: en los últimos años se observó un aumento exponencial de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), que les restan años y calidad de vida a las personas, tanto a los adultos como a los niños. ¿Y por qué sucedió eso? Porque nuestros cuerpos están inflamados, tratando de combatir los estímulos nocivos a los que los exponemos continuamente.

Los llamados “primeros mil días” comprenden los doscientos setenta días, aproximadamente, de gestación, y los dos primeros años de vida extrauterina. **Desde hace varios años, sabemos que estos primeros mil días es un tiempo crítico en el desarrollo de las niñas y los niños. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se “programan” diversas funciones del organismo, que van a funcionar de cierta manera debido a esa programación.** Esta programación puede generar, a largo plazo, consecuencias negativas como enfermedades, o al revés, tener un metabolismo sano.

Un ejemplo claro es lo que sucede con los bebés que tienen, por alguna razón, bajo peso al nacer. Se plantea que estos bebés, cuya nutrición dentro del útero tuvo alguna alteración, tienen un metabolismo “ahorrador”, es decir, sus cuerpos debido al bajo peso tienden a guardar nutrientes “por si después no hay”, y tienen mayor riesgo de obesidad en la adultez. Este metabolismo ahorrador, justamente, se organizó en la vida intrauterina.

Veamos ahora cómo se relaciona esto con las denominadas **“enfermedades crónicas no transmisibles” (ECNT), aquellas enfermedades que se prolongan en el tiempo, afectando la salud general de la persona, y que no se pueden transmitir directamente a otra.** Hoy por hoy, sabiendo más de microbiota, lo de “no transmisibles” está empezando a ser discutido, pero eso lo veremos más adelante.

Esas ECNT ocurren por una serie de factores que se conjugan: tienen una parte genética, pero lo que más pesa es el ambiente al que estamos expuestos. Sus causas tienen que ver con la mala alimentación, la exposición al tabaco, la falta de actividad física y la microbiota poco saludable. **Las ECNT atraviesan todas las edades, todos los estratos socioeconómicos, todos los países del mundo, y nos tocan de cerca a cada uno de los seres humanos.**

Todos tenemos un abuelo que toma una pastilla para la presión, otra para la diabetes y otra para el colesterol. Todos pensamos que la “presión alta” es algo frecuente, con lo que no hay nada que hacer más que medicarse. Y no. No lo es. Y no solo eso: cada vez hay más chicos con diabetes, con caries (¡sí, también son una ECNT!), con asma, y todo esto va a repercutir en su crecimiento y desarrollo. Las ECNT atentan contra la calidad de vida de las personas y generan un enorme gasto de salud.

¿Pero esto no pasaba antes? Sí, pero muchísimo menos. Claramente, algo sucedió en el mundo que hizo que las cifras de personas enfermas y fallecidas por hipertensión, diabetes, cáncer, enfermedades pulmonares y otras subieran vertiginosamente.

Los primeros mil días de vida son una enorme oportunidad para prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles. No existe la salud perfecta, y no podemos controlar todas las variables. Pero sí podemos trabajar en garantizar los derechos de las personas, y aportar información libre de conflictos de interés para poder conocer y, de esa manera, elegir.

¿Y cómo llegamos hasta acá? Para poder relacionar causas y consecuencias, hagamos un poco de historia.

Breve historia de la alimentación infantil

Esto de que los médicos demos listitas para empezar la alimentación complementaria es bastante nuevo. Antes se iba al médico solo por enfermedades, o muy de vez en cuando. La incorporación de la prevención en salud, junto con estrategias de salud pública como la potabilización del agua o las vacunas, generó que aumentara la sobrevivencia de las personas y disminuyera la mortalidad infantil. Muchos bebés que antes fallecían prontamente, ahora son adultos y adultas gracias a los trasplantes de órganos, las cirugías cardíacas, los cuidados del bebé prematuro y otras tecnologías. Los bebés comían lo mismo que el resto de la familia, porque tampoco había otra cosa. El poder elegir alimentos especiales para los bebés tiene que ver con la disponibilidad que hoy tenemos de alimentos.

Con el paso del campo a las ciudades, y a los horarios de trabajo rígidos, la lactancia se complejizó todavía más, y aún en el 2021, en la mayoría de los

países no tenemos licencias de mapaternidad que se ajusten a las necesidades de salud y economía de una familia. Mucho menos en ese momento de la historia. Al no contar con leche humana, y al morir los bebés por tomar una fórmula compuesta básicamente por agua poco segura, harina y azúcar, se les empezó a dar alimentos en forma muy temprana, incluso en los primeros días de vida. Lo único que puede comer un bebé de esa edad es un alimento líquido... Y ahí surgen los “cereales de biberón”.

La vida se medicalizó, y un montón de procesos fisiológicos, como el nacimiento y la alimentación, pasaron a ser de indicación médica. En la jerga médica, muchos obstetras dicen que “hacen partos”, los pediatras indicamos las famosas “listitas” de alimentos y en la bibliografía aparece que las familias se “aventuran” a tomar decisiones sobre el modo de alimentación de sus hijos e hijas. Sí, claro que se aventuran, porque justamente la crianza es una aventura, y la responsabilidad, el disfrute y la angustia de transitarla no es del profesional, sino de esa familia. Los profesionales tenemos que dar la información más actualizada posible para que las familias puedan elegir (y estar actualizado es también una forma de respeto hacia los consultantes y la propia profesión).

En el medio se perdieron miles de tradiciones culturales, ya no es la familia la que transmite los saberes alrededor del comer. **Las empresas convencieron a miles de profesionales que la leche de fórmula era mejor que la leche humana, y que las harinas medidas en una caja diciendo que son “para bebés” eran alimentos saludables,** aunque ni siquiera podamos definir qué contienen esas cajas.

La sugerencia hoy por hoy de las sociedades científicas es iniciar la alimentación complementaria en algún momento rondando los 6 meses, cuando el bebé esté listo, y ofrecer, de forma perceptiva, alimentos saludables que también coma la familia. Claro está que si los miembros de esa familia crecieron comiendo ultraprocesados y no conocen otras opciones, los bebés a la larga comerán esos ultraprocesados.

Por todos lados, en la publicidad y en la escuela, inclusive el pediatra, nos dicen que los ultraprocesados son buenos, necesarios y lo mejor para la salud. La galletita dice que tiene calcio, el postrecito dice “no pierdas ni un día del crecimiento de tus chicos”, el batido dice que mientras aprende a comer, ese producto le aporta todos los nutrientes, que no te preocupes... El brócoli no tiene una etiqueta diciendo qué tiene, la manzana tampoco, las legumbres están escondidas en una góndola en sus envases aburridos y telúricos. No

existe “Legumbrón”, el superhéroe legumbrero en la tele, pero los yogures sí tienen un personaje fatigado que al comer el producto se llena de energía. Y todo eso impacta directamente en lo que consumimos. Todos queremos lo mejor para las infancias que están bajo nuestra responsabilidad, pero si la publicidad y el entorno nos dicen todo el tiempo que lo mejor está en un paquete, es difícil sustraernos de eso.

Pocos conservamos recetas ancestrales, o el cuaderno de cocina de la bisabuela o del bisabuelo. **No sabemos cuáles eran los sabores que paladeaban nuestros antepasados, y por eso no se los podemos transmitir a nuestros hijos e hijas, y tenemos que empezar de nuevo a construir una cultura de disfrute y salud.** Eso, en un mundo que nos exige trabajar como si no criáramos, y viceversa, es agobiante, pero también es un desafío que muchos estamos dispuestos a tomar, en el tiempo que sea necesario.

¿Qué son los ultraprocesados?

Podemos clasificar a los alimentos de muchas maneras. Una de ellas es la que surgió en la Universidad de San Pablo, Brasil, y que la Organización Panamericana de la Salud adoptó hace unos años como guía útil para orientarnos en los consumos. Esta clasificación se denomina NOVA, y divide a los alimentos en 4 grupos según su grado de procesamiento.



ALIMENTOS SIN PROCESAR O MÍNIMAMENTE PROCESADOS: los alimentos sin procesar son partes de plantas o animales que no han experimentado ningún procesamiento por parte de la industria. Los alimentos mínimamente procesados son alimentos sin procesar que se modifican de maneras que no agregan ni introducen ninguna sustancia nueva (como grasas, azúcares o sal), pero que pueden implicar que se eliminen ciertas partes del alimento. Incluyen frutas frescas, secas o congeladas; verduras, granos y leguminosas; nueces; carnes, pescados y mariscos; huevos y leche.

INGREDIENTES CULINARIOS PROCESADOS: son sustancias extraídas y purificadas por la industria a partir de componentes de los alimentos u obtenidas de la naturaleza. Acá encontramos los aceites, otras grasas, la

sal, las especias. No se consumen solos, sino que enriquecen otros platos, y se usan para cocinar y para tener sabores más interesantes y placenteros.

ALIMENTOS PROCESADOS: los alimentos procesados se elaboran al agregar grasas, aceites, azúcares, sal y otros ingredientes culinarios a los alimentos mínimamente procesados, para hacerlos más duraderos y, por lo general, más sabrosos. Aquí encontramos el pan, los quesos y las conservas.

PRODUCTOS ULTRAPROCESADOS: chequeemos primero la denominación: acá dejamos de hablar de alimentos o ingredientes para hablar de “productos”. Son formulaciones industriales elaboradas a partir de sustancias derivadas de los alimentos a las que se les agregan aditivos como saborizantes, perfumes y colorantes para que sean más deseables, y otros aditivos que hacen que duren mucho tiempo en la góndola. Suelen venir listos para consumirse y tienen mucha publicidad, tanto en los medios como muchas veces en los congresos profesionales. Entre otros (muchos) ultraprocesados, encontramos: gaseosas, jugos artificiales, margarina, galletitas, cereales para bebés, papas fritas de bolsa, patitas de pollo congeladas, sopas de sobre, salchichas, hamburguesas, gelatinas.

Esta clasificación, sin duda, no es perfecta (dudo que exista una clasificación perfecta de los alimentos), pero es una excelente forma de guiarnos en la transición a una alimentación más sana.

Lo que se sugiere:

- **BASAR** la alimentación en alimentos mínimamente procesados, combinados con ingredientes culinarios.
- **INCLUIR** procesados de buena calidad.
- **EVITAR** ultraprocesados. Es claro que, dado el mundo en el que vivimos, suele ser una de las cosas más difíciles de transitar.

Diet, light y la cultura de las dietas

Como niña crecida y criada en los 90, fui testigo y viví en carne propia la cultura de la dieta, inculcándonos, sobre todo a las niñas, que era fundamental estar delgadas para ser queridas y exitosas. El maltrato constante hacia nuestros cuerpos era y es moneda corriente, con muy poca mirada hacia la salud y el disfrute. La comida fue transformada en algo que tiene que generar culpa, sobre todo si no hay “autocontrol”. **La responsabilidad de comer “mucho” o “mal” es depositada en las personas, ignorando la publicidad agresiva, ignorando que durante toda la infancia fuimos empujados a comer todo el plato sin importar nuestras ganas, e ignorando que los ultraprocesados que vende la misma industria que vende los batidos milagrosos, y las dietas, generan la necesidad imperiosa de seguir comiéndolos, justamente por sus componentes.**

El concepto de 80/20, o de “porción justa”, donde se “habilita” a comer “mal” o tomarse “permitidos”, justamente es condenatoria, y no tiene base científica. Si hay “permitidos”, entonces hay “prohibidos”, y se basa, una vez más, en la culpa. Sumado a que muchos de los profesionales que promueven este tipo de dietas suelen trabajar para las marcas que generan productos que incluso tienen el sello de “porción justa” (y en otros países tendrían sellos de advertencia, como veremos más adelante).

Cuando hablamos de que se recomiendan evitar los ultraprocesados, no es una prohibición. Es información que lamentablemente no es masiva, porque no está bancada por ninguna publicidad de ninguna empresa. No, no sos un mal mapadre por darle ultraprocesados a tus hijos e hijas si no tenés la información y todo el mundo te está diciendo que lo mejor que podés darle es un postrecito. Pero una vez que accedemos a la información, tenemos más herramientas para decidir sobre algo tan trascendental como nuestra salud y la de los niños y las niñas.

Eslóganes y ultraprocesados de dietética

Todo muy lindo, pero entonces, ¿qué comemos? ¿Todo de dietética, integral? ¿Vegano? Sí, cuando empezamos a recibir toda esta información, todo es

confusión. Cuando yo empecé a cambiar mi alimentación, iba a la dietética y compraba productos creyendo que eran mucho mejores que los del kiosco: barritas de cereal, almohaditas, aritos de “avena”. Y no... Las barritas de cereal y los alfajores industriales que se venden en muchas dietéticas tienen tantos o peores aditivos que los que se venden en el kiosco, en envases verdes o que sugieren salud. Inclusive muchas veces se usa el veganismo dentro del comercio para vender ultraprocesados como saludables. **Que algo contenga harina integral, o no tenga derivados animales, o esté en una dietética, no lo hace sano per se.**

¿Cómo elegir, entonces? Volviendo a la clasificación NOVA, priorizar alimentos del grupo uno: frutas, verduras, legumbres, cereales, frutos secos, semillas, alimentos de origen animal, combinarlos con ingredientes para hacer comidas, e incorporar alimentos procesados saludables. En las dietéticas sí encontramos buenos alimentos: generalmente una gran cantidad de legumbres, cereales y especias, que podemos ir probando y descubriendo para incorporarlos en nuestra cocina. En el capítulo 14 -“Recetas, *tips* y secretos para comer saludable (y muy rico) en casa”- nuestro muchas preparaciones con legumbres y cereales, que la Sabrina de hace algunos años atrás ni siquiera se hubiera imaginado que se podían hacer. ¡Les recomiendo mucho la torta de lentejas, que tiene gran éxito como parte de las viandas del jardín!

¿Qué pasa con el azúcar?

Nuestro cuerpo obtiene la energía para funcionar a través de metabolizar los alimentos que ingerimos, y cuando esto no alcanza, de quemar las reservas guardadas en diferentes órganos. Los hidratos de carbono son una importante fuente de energía, y muchas veces confundimos “hidrato de carbono” con “azúcar agregado”. Hay muchos tipos de hidratos de carbono, más simples y más complejos, y el cuerpo los metaboliza de diferentes formas.

La OMS define al azúcar libre como todos los monosacáridos y disacáridos añadidos (por eso le decimos también “azúcar agregado”) a los alimentos y bebidas por el fabricante, cocinero o consumidor, además del azúcar presente de forma natural en la miel, los jarabes, los jugos de frutas y

los concentrados de jugos de frutas.

Es importante destacar que el azúcar libre puede tener consecuencias fisiológicas diferentes que las del azúcar intrínseco (hidrato de carbono) presente en las paredes celulares intactas de las plantas, en las frutas, en las hortalizas o en la leche. Es muy distinto cómo se metaboliza el azúcar intrínseco de una fruta vs. cómo se metaboliza la cucharada de azúcar que se le agrega a una infusión.

Y es importante saber que **no existen requerimientos dietéticos de azúcar libre para bebés y niños. NO necesitamos agregar azúcar para “funcionar”, ni para que los chicos crezcan, ni para que se desarrolle el cerebro. Más bien, el azúcar agregado puede traer consecuencias negativas.**

Las sociedades científicas NO sugieren el consumo de azúcar libre antes de los 2 años porque:

- **Genera una estimulación constante del sistema de recompensa.** El cerebro pide más y más azúcar (esto sucede sobre todo con los azúcares industriales como el jarabe de maíz de alta fructosa, que no genera saciedad), y se pierde la autorregulación de la ingesta que naturalmente tienen los bebés, las niñas y los niños.
- **Puede generar preferencia por el sabor dulce y posteriormente rechazar otros sabores de alimentos** (más adelante veremos la importancia del procesamiento sensorial de los sabores).
- **Cubre en poco volumen la necesidad energética diaria de los niños.** Es decir, ya con unas pocas cucharadas de azúcar, su cuerpo sentirá que no necesita consumir más energía, aun cuando no haya recibido los nutrientes necesarios, y es probable que no desee comer otros alimentos de mejor calidad nutricional. De esta manera, los niños y las niñas que consumen muchos productos azucarados tienen más riesgo de anemia, y déficit de vitaminas y otros nutrientes.
- **Los azúcares libres aumentan muchísimo el riesgo de caries y disbiosis odontológica.**

- **El consumo de altos volúmenes de azúcares libres, sobre todo en bebidas, puede generar malabsorción, dolor abdominal, gases, distensión y diarrea crónica.**
- **Cuando se consume azúcar libre constantemente, la insulina se mantiene elevada** (la insulina se eleva con el consumo de alimentos para traer dentro de la célula los nutrientes que van a dar energía y almacenarlos). Esto genera que el cuerpo se desensibilice a la insulina, y responda menos a la misma, y el azúcar en vez de meterse a la célula, quede circulando en el cuerpo provocando efectos indeseados, y sí, predisponiendo a la diabetes. Cada vez vemos más niños y niñas con insulinoresistencia y diabetes.
- **El alto consumo de productos con azúcar libre genera más riesgo de enfermedades cardiovasculares a largo plazo.**
- **Se está estudiando la relación entre alteraciones del desarrollo y el consumo constante de azúcares libres.** El consumo continuo de azúcares libres podría afectar la concentración y el sueño en la infancia.

El problema es que el azúcar libre tiene muchísimos nombres, y es muy difícil a veces reconocerlo en las etiquetas de los productos que compramos. Algunos ejemplos:

SACAROSA, JARABE DE MAÍZ DE ALTA FRUCTOSA, GLUCOSA, MIEL DE CAÑA, EDULCORANTE DE MAÍZ, MIEL DE MAÍZ, DEXTROSA, FRUCTOSA, CONCENTRADO DE JUGO DE FRUTAS, MELAZA, MIEL, MALTOSA, MALTODEXTRINA, LACTOSA, GALACTOSA, ZUMO DE AGAVE, JARABE DE AGAVE, JARABE DE ARROZ INTEGRAL, JUGO DE CAÑA, JARABE DE CAÑA, AZÚCAR MORENO, JARABE DE GLUCOSA DE MAÍZ, AZÚCAR MASCABO, AZÚCAR RUBIA, AZÚCAR INTEGRAL, AZÚCAR DE COCO, MAÍZ DULCE, ISOGLUCOSA, ISOMALTULOSA, EDULCORANTE DE MALTA, AZÚCAR DE ARCE, SIROPE DE

ARCE, AZÚCAR EN POLVO, JARABE DE ARROZ, JARABE DE SORGO, EDULCORANTES DE ALMIDÓN, AZÚCAR DE MESA.

- ¿Pero no es mejor el azúcar mascabo o la miel que el azúcar de mesa? No necesariamente. Tal vez tengan menos procesos de refinado, pero no dejan de ser azúcares libres, y así actúan.
- ¿Y los jugos naturales? Los jugos naturales exprimidos de fruta también actúan como azúcar libre, porque se elimina su fibra y se absorbe el azúcar de la fruta rápidamente.
- Pero después de los 2 años, ¿puede comer azúcar? Como ya mencioné, no “hay” que ofrecer azúcar libre obligatoriamente solo porque un niño o una niña cumplió 2 años. Pero es bastante seguro que, antes o después, se va a encontrar con productos azucarados por la vida, y si globalmente su alimentación es variada y saludable, no va a ser un drama, sino una eventualidad. El Hospital Garrahan diseñó en 2018 una infografía sobre el máximo de azúcar libre, los invito a consultar el gráfico en el capítulo 8.
- ¿Qué pasa si hago comidas caseras pero les agrego azúcar, porque de otra manera mi familia no las acepta? Todo lo que se haga en el hogar tendrá infinitamente menos aditivos y azúcares que un ultraprocesado. El camino de aprender a comer mejor tiene muchas instancias y ya empezar a cocinar casero ES UN MONTÓN. Así que tengámonos paciencia en este proceso que puede llevar meses o años. No es la cucharada de azúcar que la abuela le pone a un pan con manteca para la merienda el problema real, son los miles de productos industriales que, aunque no lo sepamos, nos hacen consumir muchísima azúcar durante años, con graves perjuicios para la salud.

¿Qué pasa con los aditivos?

El ser humano ha buscado diferentes formas de conservar los alimentos, para guardarlos para después (generalmente ese después era el invierno, cuando crecen relativamente pocas frutas y verduras, y es más difícil el trabajo de proveerse de comida). Para esto, deshidrató, fermentó e hizo conservas para defenderse del implacable trabajo de los microorganismos, que también buscan su alimento. Un pan enmohecido, para nosotros, puede ser sinónimo de tirarlo a la basura, pero hace doscientos años, representaba la pérdida de horas de cultivar el trigo, cosecharlo, molerlo, amasarlo, prender el fuego para cocinarlo...

Los alimentos del grupo 1 y 3 de NOVA no duran muchos días generalmente. Al ser alimentos con poco o ningún procesamiento, se oxidan rápidamente y son degradados por los microorganismos. Esto es algo bueno: son alimentos reales, parte de un ecosistema. Los ultraprocesados, en cambio, pueden durar años en una góndola, y tener exactamente el mismo sabor a través de los siglos. No me digan que no es extraño comer un puré de una papa que se cultivó hace tres años, ¿no? Bueno, es lo que hacemos. ¿Por qué los ultraprocesados se mantienen impolutos en sus envases sin perder el sabor? Porque tienen aglutinantes, cohesionantes, colorantes, edulcorantes, emulsificantes, espesantes, espumantes, estabilizadores, “mejoradores” sensoriales como aromatizantes y saborizantes, conservadores, solventes...

El problema es que esos aditivos no son inocuos. Por un lado, generan sabores que realmente no existen: el “sabor a frutilla” es el sabor que a alguien se le ocurrió que tiene una frutilla. Pero las frutillas no son todas iguales y no todas tienen el mismo sabor. Entonces, si le presentamos a los chicos continuamente el “sabor frutilla” siendo un **sabor artificial, unido a azúcares y grasas, es probable que después rechacen la fruta de verdad, primero porque no la conocen, y segundo porque su sabor es distinto, probablemente más suave y menos estridente.**

Entre los aditivos encontramos a los **edulcorantes**. Un mismo producto puede tener varias formas de azúcar y también incluir varios edulcorantes, aunque sea un pan de mesa o una salsa de tomate. Los edulcorantes generan alteraciones negativas en la microbiota con efectos adversos en el metabolismo de la insulina y el azúcar, y en muchos países los productos que

tienen edulcorantes contienen la advertencia: “Evitar en niños”.

Hay estudios *in vitro* que plantean que los **emulsificantes**, como las lecitinas y los mono y diglicéridos, pueden generar mayor permeabilidad intestinal, generando mayor inflamación y alterando la composición y la localización de la microbiota.

Los **colorantes** son tema aparte. Existen colorantes naturales y artificiales. El rojo carmín, por ejemplo, que se encuentra en yogures, chicles, caramelos, gelatinas, helados, maquillajes, hamburguesas, embutidos y productos con “sabor frutilla”, deriva de un insecto llamado “cochinilla”. Las cochinillas se secan y de ahí se consigue el colorante, pero como este producto es muy caro (se necesitan cien mil cochinillas hembras para obtener un kilo de colorante), se prefiere elaborarlo sintéticamente en un laboratorio. El colorante rojo carmín sintético se asoció con eczemas, asma, trastornos del sueño e hiperactividad.

Otro capítulo lo escribe la tartrazina, un colorante naranja amarillento que puebla las góndolas, dado que se encuentra en muchos productos. Como otros colorantes, la tartrazina parece estar relacionada con el insomnio, la hiperactividad y las enfermedades alérgicas. Todos los alimentos que contienen tartrazina y son comercializados en la Unión Europea deben incluir en su etiquetado, además de una indicación explícita de su presencia, una leyenda donde se lea claramente: “E-102 (o Tartrazina): puede tener efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños”. Su uso está prohibido en Noruega y en el Reino Unido.

En 2018, la Asociación Americana de Pediatría publicó un documento donde manifestaba su preocupación con respecto a los aditivos alimentarios, tanto los directos –ya mencionados– como los indirectos (sustancias que por ejemplo se encuentran en los envases de los alimentos). **Muchas de estas sustancias pueden actuar, además de lo ya expuesto, como disruptores endocrinos, es decir, como si fueran hormonas en el organismo y causar efectos adversos.** Este documento sugiere que se requiere una revisión urgente de las políticas de la Food and Drug Administration (FDA) para los aditivos alimentarios, dado que se han incrementado muchísimo desde el año 2000, generándose también un efecto acumulativo de los mismos en las personas. Refieren que las familias de menores ingresos económicos son las que más consumen estos productos con aditivos, y que tendrían mayor impacto en su salud. Sugieren, para disminuir la exposición a aditivos alimentarios:

- Priorizar el consumo de frutas y verduras frescas o a lo sumo congeladas.
- Evitar las carnes procesadas (salchichas, por ejemplo), sobre todo durante el embarazo.
- Evitar calentar la leche humana o fórmula en el microondas en envases de plástico (podría provocar migración de pequeñas partículas del plástico a la leche).
- Evitar lavar plásticos en el lavavajilla.
- Usar alternativas al plástico como vidrio o acero inoxidable cuando sea posible.
- Mirar el código de reciclado en los envases de plástico, y evitar los que tengan el número 3 (cloruro de polivinilo-PVC), 6 (poliestireno, el de las bandejas de comida del súper y los vasitos de café), y 7 (otros plásticos).
- Promover el lavado de manos previo a manipular comidas y bebidas, y lavar todas las frutas y verduras, sobre todo cuando no puedan ser peladas.

Los **agrotóxicos**, que en muchos lugares se utilizan en forma indiscriminada, rociando escuelas y viviendas, merecerían un libro aparte. Allá por el año 2009, yo era docente de Embriología de la Universidad de Buenos Aires, y el científico Andrés Carrasco hablaba en sus seminarios de los efectos del glifosato (un herbicida muy utilizado) en el desarrollo embrionario. Más voces y más investigaciones se han sumado a estas denuncias, pero queda mucho camino por recorrer para que las personas puedan tener salud sin ser envenenadas.

Conflictos de interés y salud pública

La primera vez, allá por el año 2018, que hablé en mis redes de la composición de un postre lácteo industrial y por qué no lo sugeríamos para bebés, tuve muchas respuestas indignadas y violentas. Pero la que más me llamó la atención fue: “No puede ser tan malo; si no, no lo venderían”.

¿Por qué se venden tanto estos productos? ¿Por qué tienen tanta publicidad, inclusive con profesionales que los sugieren en la tele? ¿Por qué sus marcas auspician congresos médicos, regalan vasos térmicos, dan becas para cursos y financian investigaciones? ¿Por qué si sabemos que estos productos hacen mal a la salud se venden a mansalva, sin restricción de publicidad? ¿Por qué hay profesionales *influencers* de la salud que promocionan en sus cuentas productos ultraprocesados?

Todas las personas tenemos conflictos de interés, porque cargamos con una historia, una cultura y un sistema de creencias que acompañan nuestro accionar. Un conflicto de interés se define como aquella situación por la cual las decisiones de una persona y la integridad de sus acciones están indebidamente influenciadas por un interés secundario, de tipo generalmente económico o personal. Un ejemplo claro de conflicto de interés es el del entonces médico inglés Andrew Wakefield, quien en 1998 falseó y publicó un artículo diciendo que la vacuna contra el sarampión, rubeola y paperas causaba autismo. Wakefield trabajaba para una empresa farmacéutica que quería imponer su propia vacuna contra esas mismas enfermedades. El trabajo de Wakefield fue dado de baja de la revista donde había sido publicado, y a él se le quitó la matrícula, pero el daño ya estaba hecho.

Son comunes en el ámbito científico los conflictos de interés: excelentes investigadores que trabajan investigando cuestiones de alimentos financiados por las mismas empresas que generan esos alimentos, consensos de alimentación infantil bajo la dirección de empresas de leche de fórmula, y mil ejemplos más. Esto refuerza la importancia de una lectura crítica cuando buscamos información científica o hacemos cursos de actualización.

Los productos se siguen vendiendo, aunque no hagan bien a la salud, porque con la publicidad y sus paquetes llenos de promesas, se convence a las personas de lo contrario. Se siguen vendiendo porque se compran, y porque mucha gente gana mucho dinero con ellos. Cuando la sociedad deja de comprarlos, porque ciertas informaciones llegan a más personas, cambian esos productos para que se sigan comprando. Por ejemplo, ahora los yogures juran y rejurán que no tienen sacarosa (azúcar blanca) agregada, ni jarabe de maíz de alta fructosa, porque las personas buscamos eso, productos sin

azúcar. Esto es técnicamente cierto, pero vemos sus componentes y tienen maltodextrina, otro azúcar, y edulcorantes... Esta “lavada de cara” actual de los productos es similar a la que sucedió hace treinta años con el *boom* de lo *light*, lo *diet* y el color verde de los paquetes.

Es por esto que necesitamos urgentemente medidas de salud pública como el etiquetado frontal de alimentos. Chile fue el primer país que lanzó esta ley, por la cual los productos que excedan el perfil de nutrientes que sugiere la Organización Panamericana de la Salud llevan sellos negros en su paquete advirtiéndolos a los consumidores. No prohíbe su compra, ni siquiera le pone impuestos a estos productos (otra medida de salud pública que se podría tomar), simplemente le da información clara a los consumidores para poder elegir comprarlos o no. La ley de etiquetado frontal, además, regula la publicidad, sobre todo la dirigida a la niñez: por ejemplo, prohíbe la presencia de personajes en los paquetes, que tengan juguetes o figuritas, y si un producto tiene sellos, no puede decir que tiene “nutrientes” agregados y no se puede vender en entornos escolares.

El Comité de Nutrición de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (ESPGHAN) sugiere las siguientes medidas urgentes de salud pública:

- Campañas de educación pública sobre el impacto en la salud de la alta ingesta de azúcar libre y los beneficios de reducir esos niveles.
- Mejorar el etiquetado de alimentos y bebidas para alertar a los consumidores sobre el contenido de azúcar libre.
- Más restricciones en la comercialización y publicidad de productos azucarados.
- Normas para limitar el azúcar libre en las comidas preescolares y escolares.
- Medidas fiscales, como impuestos sobre productos azucarados, e incentivos para alimentos saludables.

Y podríamos agregar, la importancia de declarar conflictos de interés a

nivel profesional, y regular urgentemente esta cuestión, que afecta directamente a la salud pública.

El impacto ambiental de lo que comemos

Si hay algo que nos traen los ultraprocesados, es envoltorios. De plástico, de papel plastificado, de aluminio, incluso paquetes dentro de otros paquetes. Plástico que hace que el producto sea más caro, y que tiene un solo uso: a partir del momento en que se abre, simplemente pasa a ser parte de los residuos contaminantes del planeta.

Estamos en un momento crítico, donde el cambio climático, los agrotóxicos y las pandemias golpean fuertemente a la humanidad. Cada pedazo de carne que comemos implicó litros de agua utilizados para hacer crecer a la vaca. Cuando pedimos *delivery*, muchas veces los alimentos vienen envueltos en toneladas de plástico descartable.

Apostar a los negocios locales, al circuito agroecológico, a las familias emprendedoras, es parte de la contribución al medioambiente que podemos tener en nuestros consumos diarios. Cuando empezamos a cocinar y hacemos una montaña de legumbres para freezar e ir sacando para nuestras comidas, disminuyen los paquetes y los plásticos, y estamos colaborando con un circuito más sano para nuestra salud.

“Le vas a robar la infancia”

La infancia debería ser exploración, tardes en la plaza, manos pringosas de fruta cortada en verano. Debería ser juego, panza llena, pies calentitos, abrazos seguros. La infancia debería ser descubrir pajaritos, pintar hojas de otoño, bailar con las manos e inventar la letra de las canciones. La infancia va mucho más allá de las golosinas y los juguetes que les compramos con profundo amor.

Creemos que las frutas no son tan divertidas como el chocolate de

paquetito, y que a los chicos no les pueden gustar tanto. Yo escribo esto, y a la vez me asombro del amor de mi hijo por las manzanas, y en el fondo mi paladar criado a ultraprocesados no puede entender cómo le gustan tanto, pero a la vez me da felicidad verlo. Con las frutas aprendimos los colores, los números, armamos pilas de mandarinas, cortamos manzanas para una torta, jugamos a hacer rodar las naranjas, contamos las semillas de la sandía, hicimos caminitos de arándanos, comimos frutillas con crema en un restaurante en vacaciones, probamos caqui por primera vez y aprendimos a decir “paciencia” en la cola de la verdulería.

Acompañar las infancias nos da una nueva oportunidad para recorrer el camino de la alimentación placentera, con salud, porque la salud también debería ser patrimonio de la infancia. Dentro de lo que podemos hacer como familias, aprender a dar un ejemplo que los chicos puedan observar e imitar, y poder nosotros mismos vincularnos más amablemente con el alimento, es un gran desafío a transitar desde el respeto y el amor.

Para seguir leyendo

PARA FAMILIAS

- Barruti, S. *Malcomidos. Cómo la industria alimentaria argentina nos está matando*, Planeta Argentina, Buenos Aires, 2013.
- Barruti, S. *Mala leche* (1.a ed.), Planeta Argentina, Buenos Aires, 2019.
- Ríos, C. *Come comida real. Una guía para transformar tu alimentación y tu salud*, Ediciones Paidós, Buenos Aires, 2019.
- Basulto, J. *Se me hace bola. Cuando no comen como queremos que coman*, DEBOLSILLO, Barcelona, 2013.

PARA PROFESIONALES

- Organización Panamericana de la Salud. (2016). Alimentos y bebidas ultraprocesados en América Latina: tendencias, efecto sobre la obesidad e implicaciones para las políticas públicas. *PAHO*. Recuperado de:

<http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/7698>

- Monteiro, C. A.; Cannon, G.; Levy, R.; Moubarac, J. C.; Jaime, P.; et ál. (2016). NOVA. The star shines bright. *World Nutrition*. Recuperado de: <https://worldnutritionjournal.org/index.php/wn/article/view/5>
- World Health Organization. (2015). Guideline: sugars intake for adults and children. *WHO*. Recuperado de: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/149782>
- Roviroso, A.; Zapata, M. E.; Gómez, P.; Gotthelfd, S.; Ferrante, D. (2017). Alimentos y bebidas publicitados en canales infantiles de Argentina: frecuencia, duración y calidad nutricional. *Arch Argent Pediatr*, 115(1):28-34/28. Recuperado de: <https://www.sap.org.ar/docs/publicaciones/archivosarg/2017/v115n1a06.pdf>
- Ministerio de Salud de la República Argentina. (2017). *Disminuir el consumo de bebidas azucaradas para cuidar la salud*. Recuperado de: <http://www.msal.gob.ar/ent/index.php/home/6-destacados-slide/425-disminuir-el-consumo-de-bebidas-azucaradas-para-cuidar-la-salud>
- Riveros, M. J.; Parada, A.; Pettinelli, P. (2014). Consumo de fructosa y sus implicaciones para la salud; malabsorción de fructosa e hígado graso no alcohólico. *Nutr. Hosp*, vol. 29, N.º 3. Recuperado de: <http://dx.doi.org/10.3305/NH.2014.29.3.7178>.
- Kasangian, J. H. (2010). Jarabe de maíz de alta fructosa y su relación con la obesidad. *Intramed*. Recuperado de: <https://www.intramed.net/contenido.asp?contenidoID=67306>
- Paglia, L. (2019). The sweet danger of added sugars. *Eur J Paediatr Dent*, 20(2):89. DOI: 10.23804/ejpd.2019.20.02.01.
- Chi, D. L. y Scott, J. M. (2019). Added Sugar and Dental Caries in Children: A Scientific Update and Future Steps. *Dent Clin North Am*, 63(1):17-33. DOI: 10.1016/j.cden.2018.08.003.
- Fidler Mis, N.; Braegger, C.; Bronsky, J.; Campoy, C.; Domellöf, M.; Embleton, N. D.; Hojsak, I.; Hulst, J.; Indrio, F.; Lapillonne, A.; Mihatsch, W.; Molgaard, C.; Vora, R.; Fewtrell, M. (2017). ESPGHAN. Committee on Nutrition. Sugar in Infants, Children and Adolescents: A Position Paper of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Committee on Nutrition. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*, 65(6):681-696. DOI: 10.1097/MPG.0000000000001733.
- Rinninella, E.; Cintoni, M.; Raoul, P.; Lopetuso, L. R.; Scaldaferri, F.; Pulcini, G.; Miggiano, G.; Gasbarrini, A.; Mele, M. C. (2019). Food

Components and Dietary Habits: Keys for a Healthy Gut Microbiota Composition. *Nutrients*, 11(10):2393. DOI: <https://doi.org/10.3390/nu11102393>.

- Yee, A. Z.; Lwin, M. O.; Ho, S. S. (2017). The influence of parental practices on child promotive and preventive food consumption behaviors: a systematic review and meta-analysis. *Int J Behav Nutr Phys Act*, 11;14(1):47. DOI: 10.1186/s12966-017-0501-3.
- Del-Ponte, B.; Quinte, G. C.; Cruz, S.; Grellert, M.; Santos, I. S. (2019). Dietary patterns and attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD). A systematic review and meta-analysis. *J Affect Disord*, 252:160-173. DOI: 10.1016/j.jad.2019.04.061.
- McCann, D.; Barrett, A.; Cooper, A.; Crumpler, D.; Dalen, L.; Grimshaw, K.; Kitchin, E.; Lok, K.; Porteous, L.; Prince, E.; Sonuga-Barke, E.; Warner, J. O.; Stevenson, J. (2007). Food additives and hyperactive behaviour in 3-year-old and 8/9-year-old children in the community: a randomised, double-blinded, placebo-controlled trial. *Lancet*, 370(9598):1560-7. DOI: 10.1016/S0140-6736(07)61306-3.
- Bakthavachalu, P.; Kannan, S. M.; Qoronfleh, M. W. (2020). Food Color and Autism: A Meta-Analysis. *Adv Neurobiol*, 24:481-504. DOI: 10.1007/978-3-030-30402-7_15.
- Bateman, B.; Warner, J. O.; Hutchinson, E.; Dean, T.; Rowlandson, P.; Gant, C.; Grundy, J.; Fitzgerald, C.; Stevenson, J. (2004). The effects of a double blind, placebo controlled, artificial food colourings and benzoate preservative challenge on hyperactivity in a general population sample of preschool children. *Arch Dis Child*, 89(6):506-11. DOI: 10.1136/ad.2003.031435.
- Rowe, K. S. y Rowe, K. J. (1994). Synthetic food coloring and behavior: a dose response effect in a double-blind, placebo-controlled, repeated-measures study. *J Pediatr*, 125(5 Pt 1):691-8. DOI: 10.1016/s0022-3476(94)70059-1.
- Vojdani, A. y Vojdani, C. (2015). Immune reactivity to food coloring. *Altern Ther Health Med*, 1:52-62. Recuperado de: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25599186/>
- Lane, M. M.; Davis, J. A.; Beattie, S.; Gómez-Donoso, C.; Loughman, A.; O'Neil, A.; Jacka, F.; Berk, M.; Page, R.; Marx, W.; Rocks, T. (2021). Ultraprocessed food and chronic noncommunicable diseases: A systematic review and meta-analysis of 43 observational studies. *Obes Rev*,

22(3):e13146. DOI: 10.1111/obr.13146.

- Trasande, L.; Shaffer, R. M.; Sathyanarayana, S. (2018). Food Additives and Child Health. *Pediatrics*, 142(2), e20181408. DOI: <https://doi.org/10.1542/peds.2018-1408>.
- Salvia, A.; Tuñón, I.; Musante, B. (2012). La Inseguridad Alimentaria en la Argentina. Hogares Urbanos. Documento de trabajo. *Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA*. Recuperado de: <http://uca.edu.ar/es/observatorio-de-la-deuda-social-argentina>

El primer bocado: **embarazo, lactancia y alimentación**

¿Cuánto dura la teta?

¿Días, semanas, meses o años?

Quién sabe, ¿no?

Lo importante es que siempre, siempre
bailaremos con nuestra música.

Tu manito se apoyará en mi pecho,
te rodearé con olor a mamá.

Y seré tu abrigo, tu punto de partida,
tu vuelta a casa.



La alimentación de una persona inicia en su vida intrauterina. **Cómo se haya nutrido la persona gestante, lo que consume en el embarazo y las vicisitudes que vayan sucediendo, tendrán que ver con el crecimiento y desarrollo a futuro del bebé.**

Los sentidos del bebé se van desarrollando y agudizando a medida que pasan las semanas. Las experiencias que atravesamos durante el embarazo, el ambiente en donde nos movemos y lo que sentimos, será parte de la historia de nuestros hijos e hijas. Sí, todo, porque en el mundo hay alegrías y también hay tristezas, y son parte de una energía universal que no podemos ahorrarles a las infancias, pero sí podemos acompañar a atravesarlas con amor.

Los embarazos a veces nos toman por sorpresa. Otras veces son buscados y planeados con mucho tiempo. En algunas familias llegan después de una o más pérdidas. No importa cuántos hijos e hijas tengamos: siempre somos primerizos para recibir a una nueva persona en nuestra vida.

El embarazo siempre es un impacto, cambia nuestras vidas. Y si hablamos de alimentación, podemos pensar que gran parte de lo que consumimos durante el mismo, tendrá que ver con la construcción de ese nuevo cuerpo (o cuerpos) en proceso.

Es por esto que **el embarazo es un momento ideal para repensar la alimentación**. Solo como un ejemplo: los sabores pasan al líquido amniótico, siendo percibidos por el feto y formando parte de la construcción de sus recuerdos alimentarios y de su paladar.

La placenta es un órgano transitorio formado tanto por tejidos maternos como por tejidos fetales. Actúa como barrera y protección, genera hormonas que mantienen el embarazo, garantiza que pasen los nutrientes y anticuerpos necesarios, frena microorganismos que pueden ser dañinos. Es una gran ingeniería biológica de la naturaleza. El problema es que cuando todo el organismo está inflamado por la alimentación deficiente y en estado de disbiosis (ver capítulo 4, “Somos microbiota”), existe mayor probabilidad de complicaciones alrededor de la gestación y del crecimiento posterior de ese bebé.

Vivimos en una cultura que le rinde culto a lo que considera “cuerpos

perfectos”, que felicita los embarazos pero que también le pregunta a las mujeres luego del nacimiento: “Che, ¿no te quedó un bebé adentro? Por la panza, digo”, que critica todos los cuerpos posparto posibles. Y en pos de esa cultura, nuestra nutrición suele estar basada en productos que creemos sanos pero que no lo son.

Transitando mi primer embarazo decidí hacer una consulta con una nutricionista, para asegurarme de nutrir bien a mi hijo. Los veinte minutos que duró la entrevista, la profesional los dedicó a plantearme que debía bajar de peso (y no, no tenía un peso “por encima” de la tabla según mi talla) y que comiera cosas *light*: salchichas *light*, yogures *light*, margarina *light*. También me dijo que no comiera frutos secos ni legumbres porque engordaban mucho. Yo sabía poco y nada de alimentación en ese momento, no tenía la menor idea de la importancia, por ejemplo, de las grasas saludables, pero tuve la lucidez para darme cuenta de que no era por ahí la cosa, y no volver.

Algo que aprendí durante estos años de búsqueda, es que **no es posible hablar de alimentación infantil: hay que hablar de alimentación familiar**. La progresión en la alimentación complementaria, que inicia alrededor de los 6 meses, suele ser un encuentro cercano de las familias con la frase: “Se me acaban las ideas, no sé qué hacerle de comer que sea saludable”. Es por esto que es aconsejable que los hábitos saludables de alimentación inicien antes del nacimiento: para que ya estén establecidos, para que sea más fácil atravesar el maremágnum del puerperio y del cansancio con unas hermosas legumbres ya remojadas, congeladas y listas para usar.

Algunas cuestiones familiares alrededor de la alimentación en el embarazo:

- **Comer rico.** Sí, comer rico. Probar nuevas comidas, en la medida de lo posible, transitando la comida como una experiencia de a dos (o más). Los primeros meses pueden traer náuseas, así que hacerlo con precaución.
- **Aprender a cocinar, si no es un hábito de esa familia.** Todos, no solo la mamá, dado que todos serán parte de la vida alimentaria de ese bebé por nacer. Es una responsabilidad de toda la familia.
- **Si la persona gestante trae alguna cuestión de selectividad**

alimentaria desde la infancia (en gran parte de los adultos sucede esto), puede ser una oportunidad para trabajarla con profesionales.

- **Priorizar frutas, verduras, frutos secos, legumbres y cereales integrales**, dado que por su alto contenido de fibra, alimentan a la microbiota saludable y ayudan al tránsito intestinal.
- **Si se consumen productos de origen animal, priorizar si es posible aquellos de pastura (carne, huevos) y los pescados.**
- **La hidratación con agua es fundamental.** Evitar gaseosas y jugos industriales.
- **Es el momento ideal para dejar de consumir productos ultraprocesados**, que dañan la microbiota y generan un estado de inflamación metabólico que debemos empezar a considerar y a tratar. Incorporar alimentos simples en preparaciones caseras (simples, también, no hace falta que sea nada muy elaborado) y evitar los ultraprocesados es el primer paso.
- **Estar acompañadas/os como familia por un/a profesional empático y actualizado es un gran regalo que le podemos brindar a nuestros hijos e hijas.**

Suplementos durante el embarazo

- **El ácido fólico es un compuesto que tiene que ver con la correcta división de las células.** Participa activamente en el embrión, y tiene un papel fundamental en el cierre del tubo neural, que es la estructura que va a dar origen al sistema nervioso central. Se vio que suplementar con ácido fólico durante la planificación del embarazo y los primeros meses del mismo disminuye las malformaciones durante este proceso del desarrollo.

- En embarazadas que no consumen productos de origen animal, los consumen en pequeñas cantidades o por alguna razón tienen déficits en la absorción de ciertas vitaminas, **es importante controlar y suplementar con vitamina B12.**
- **El suplemento de hierro tendrá que ser considerado en forma individual.** Es muy importante evitar la anemia durante el embarazo dado que el bebé acumulará sus reservas de hierro durante la gestación, por lo cual son importantes los depósitos maternos.
- **La vitamina D es un compuesto que actúa en múltiples tejidos,** entre ellos, en el sistema inmune, por lo cual es fundamental medirla y suplementar en caso de deficiencia.
- Hoy por hoy conocemos **el papel fundamental del DHA –ácido docosahexaenoico– (omega 3) en el embarazo,** que tiene que ver con el desarrollo del sistema nervioso fetal. Es importante evaluar la alimentación y si es necesario, ofrecer suplementación.

La leche

La leche humana es un tejido cambiante, hasta podría decir que es un órgano transitorio propiedad del binomio madre-hijo. La leche humana viene a reemplazar a la placenta, es una exteroplacenta que forma parte del proceso de exterogestación. **La placenta transmitió alimento, defensas y sabores, y a partir del nacimiento, la lactancia también lo hará.**

El proceso de lactancia inicia durante el embarazo, en el cual la glándula mamaria atraviesa numerosas modificaciones. Las células crecen, se dividen, se especializan y a partir de la semana 16, producen calostro, que puede salir hacia el exterior o no, y no es ningún predictor de tener mucha o poca leche. Inclusive pueden salir gotas de un pecho y no del otro, y también es normal.

Los primeros días, la leche es el calostro, casi invisible, denso, amarillento e impecable para las necesidades del bebé. **No es leche blanca ni sale abundante, porque el bebé está aprendiendo a coordinar la succión, la**

deglución y la respiración, y no podría manejar más volumen, además de que su estómago es muy pequeño. Los bebés practican succionar y tragar intraútero, se chupan la mano, los pies y el cordón umbilical, y en el momento del nacimiento, si este se produce a término, ya tienen la capacidad de hacerlo. Los bebés prematuros deberán madurar esa capacidad en la vida extrauterina y puede ser necesario alimentarlos por otros métodos (sonda orogástrica o nasogástrica, por ejemplo) mientras su sistema nervioso madura este reflejo.

Luego, alrededor de las 48 o 72 horas desde el alumbramiento de la placenta (no importa si es por parto vaginal o cesárea), se produce la leche tal como la conocemos. La “subida” de leche puede generar molestias, tensión en el pecho, calor, escalofríos, o nada de eso. No me cansaré nunca de recomendar tener una asesora de lactancia o puericultora ya conocida previamente para que nos acompañe en este proceso, ayudando con la prendida y evitando la congestión mamaria y otras molestias comunes.

El recién nacido puede estar todo el día prendido en el pecho, y es esperable y deseable que busque el calor, el olor, los sonidos de su persona más conocida durante todo el día, y desee lógicamente estar a upa. Hasta hace muy poco era alimentado sin esfuerzo a través del cordón umbilical, que ahora cuelga en su ombligo cerrado por un clip, y que en breve solo será un recuerdo. No nos queda claro a quién le pareció una buena idea que los bebés estén en una cunita fría separados de sus mapadres en el ámbito hospitalario, o peor aún, en una *nursery*. Los bebés necesitan el contacto constante para su supervivencia.

A partir de su nacimiento, los bebés están a cargo de su propio alimento. Si no piden, si no abren la boca, si no succionan, no habrá comida en sus pancitas, y morirán de hambre. Sí, parece exagerado pero no lo es: el bebé no sabe que estamos ahí atentos acerca de cuánto pis y caca hace, y hace cuántas horas comió. Recién está descubriendo nuevas posiciones (piensen que el bebé nunca estuvo “acostado” en la vida intrauterina, por ejemplo), la fuerza de la gravedad, el roce de las telas sobre su piel; está empezando a regular su temperatura; a usar sus pulmones; a comprender que puede hacer sonidos y que esto genera que venga alguien a tomarlo en brazos y alimentarlo. Es un proceso enorme para su cerebro y para sus sentidos. Le exigimos mucho, muchísimo a los bebés, sin ponernos en su lugar.

Anidamos intensamente para cuando llega el bebé, hasta viajamos para comprar ajuares. Pero **los bebés necesitan bien poco: piel y leche. Los**

bebés se nutren del contacto y de la leche que ingresa a sus cuerpecitos. Y ambas cosas las necesitan todo el tiempo: a demanda.

La demanda

La extero-gestación es el proceso por el cual el bebé continúa madurando fuera del útero. No es un proceso optativo ni una palabra de moda, es un tiempo que el bebé necesita, de intenso contacto, para que su cerebro siga creciendo y se adapte al medio.

“Los bebés demandan mucho”. Más que demandan mucho, necesitan mucho, durante muchos años. ¿A qué edad un ser humano es realmente independiente? En nuestra cultura planteamos la mayoría de edad recién alrededor de los 18 años. Esto tiene que ser muy, pero muy tenido en cuenta cuando decidimos ser mapadres. No seremos mapadres de un bebé mucho tiempo, sí seremos responsables de una vida durante décadas.

Un bebé sabe cuándo tiene hambre y cuándo está saciado. **El estirar a dos/tres/cuatro horas el intervalo entre las tomas es contraproducente y dañino para la lactancia.** Algunas cuestiones sobre el tema:

- **Idealmente esperamos que el bebé que nace sin ninguna complicación de salud pueda prenderse al pecho a la brevedad después de su nacimiento.** Para esto tenemos que priorizar el confort de la familia, ofrecerle un ambiente tranquilo, íntimo, donde conocerse y encontrarse de este lado del mundo. El contacto piel con piel, el olerse, el besarse y el evitar separaciones innecesarias, es parte del establecimiento de la microbiota y de la construcción de vínculos entre esa familia que está naciendo.
- **La mayor parte de las dificultades que encontramos en la lactancia tienen que ver con intervenciones innecesarias:** violencia obstétrica; separar al bebé de su mamá; ofrecerle tetinas, chupetes o leche de fórmula tempranamente; no permitir un ambiente calmo para la diada; comentarios poco constructivos; escaso apoyo del entorno y escasa formación de los profesionales de salud sobre la lactancia.

- **No es posible que un bebé que toma teta se “sobrealimente”.**
- **La leche humana se digiere en unos cuarenta y cinco minutos, incluso menos.**
- **En un recién nacido se esperan muuuchas tomas por día** (unas doce, por poner un número), es decir que probablemente se pase el día pegado al pecho. Esto le da información a la teta, y al sistema endocrino y nervioso de su mamá: hay que producir más leche.
- **Cuando son más grandes, pueden pedir pecho, tomar unos segundos, distraerse y volver a pedir a los cinco minutos.**
- **Puede hacer una toma muy cortita porque tiene sed, por ejemplo.**
- **Que se despierte de noche para buscar el pecho no significa que se quede con hambre.** El sueño de los bebés es madurativo, los ciclos de sueño más cortos los protegen de la muerte súbita (sí, sí, la naturaleza es muy sabia) y necesitan buscar el calor del adulto para volver a conciliar el sueño.
- **“Estirar” el tiempo entre tomas con chupete no se recomienda.** Tampoco se recomienda ofrecer chupetes o tetinas a bebés cuando aún no se ha establecido la lactancia, pues puede causar confusión tetina-pezón.



Es fundamental durante la lactancia observar la transferencia de leche. Los bebés succionan no solo para comer, sino porque los calma y los relaja, a esto se lo llama “succión afectiva”. Pero, cuando están comiendo, se escucha el tragar y las succiones son más profundas. Los bebés no toman leche humana del pezón: toman de lo que llamamos “complejo areola-pezón”, introduciendo gran parte de la glándula mamaria en la boca. El pezón, de hecho, queda muy atrás y arriba en la boca, cerca del paladar blando, y allí sale la leche exprimida para ser tragada. Los movimientos de la mandíbula y de la lengua tienen vital importancia en la transferencia de leche.

¿Cómo sabemos que la transferencia de leche es efectiva? El bebé hace pis y caca, gana peso, y el pecho se drena fácilmente, produciendo leche mientras el bebé succiona. Cuando no hay transferencia efectiva de leche, puede haber problemas en la producción, porque la teta no es un almacén, es una fábrica: si está llena todo el tiempo, produce menos porque interpreta que hay menos demanda. Esto se debe a una proteína presente en la leche llamada FIL (factor inhibidor lácteo), que justamente regula que la leche se produzca a demanda.

Cuando “estiramos” las tomas o introducimos tomas con biberón en el medio, la glándula mamaria interpreta que hay menos demanda, y lógicamente produce menos.

- **¿Cuánto tiempo la lactancia tiene que ser a demanda?** El tiempo que la diada quiera. Durante el primer año, la leche es el principal alimento de los bebés, y es necesario que sea a demanda. Si se desea reemplazar tomas, por ejemplo, destetar de noche, es bastante posible

que sea necesario incorporar fórmula. Después del primer año, muchas veces la demanda inclusive aumenta, y aún más después del segundo año (a veces toman como recién nacidos, ¡al mismo tiempo que van dejando los pañales y te cuentan qué hicieron en el jardín!). Y aquí muchas veces es necesario para las mamás armar espacios y tiempos en los que se sientan cómodas para amamantar. Se puede trabajar con puericultoras para ordenar las tomas si es lo que se desea. Hay tantas formas de hacer las cosas como familias, y todas son respetables.

Antes de la lactancia

Durante la gestación tenemos un tiempo valioso para reflexionar alrededor de la lactancia y de nuestros deseos. **La lactancia es un hecho social: no es solo responsabilidad de la persona que amamanta, ni del sistema de salud (que bastante daño le hace), sino de todo el entorno que rodea esa diada.**

Las madres escuchamos tantas frases y mitos alrededor de la lactancia que no sabemos para dónde correr. “Yo no te di la teta porque la fórmula es lo mismo”, “En nuestra familia no tenemos leche”, “Seguro no vas a poder porque tenés los pechos chicos”, “Llora por hambre, no te encapriches y dale mamadera”.

Pocas veces escuchamos un: “¿Qué es lo que vos querés?” o “Estás haciendo todo genial, te hago la comida, te lavo los platos y te voy a comprar unos chipacitos para merendar” o “Tengo esta amiga puericultora que atiende en tal lado, ¿quieren que los acompañe a una consulta?”.

Entonces, conectarse con los propios deseos, con la propia historia y con la información es fundamental. ¿Queremos amamantar? ¿Es algo que soñamos? ¿Queremos esperar al nacimiento para decidirlo? ¿Sabemos cómo es la lactancia? ¿Tenemos a quién recurrir si hay algún problema o tenemos dudas? Todo sentimiento es válido, somos personas distintas con historias diferentes.

Algunas sugerencias que me hubiera gustado tener antes de que naciera mi primer hijo:

- **Puede ayudar mucho durante el embarazo acercarse a grupos de lactancia o de crianza**, escuchar a otras mujeres y familias contar sus experiencias y vivencias, y armar tribu.
- **Hablar con el grupo familiar acompañante de nuestras decisiones y lo que nos gustaría que sucediera.** A veces la falta de acompañamiento no es por mala voluntad, sino por desconocimiento. Ofrecer información confiable.
- **Aun cuando creas que sabés de lactancia, y más aún si lo creés porque sos profesional de la salud y escuchaste clases del tema, sugiero tener el contacto de una puericultora a mano**, y si se puede conocerla antes del nacimiento, mucho mejor.
- **La consulta prenatal con el o la pediatra, si es posible, es una gran opción** para iniciar los controles con alguien de nuestra confianza que nos acompañe en la lactancia.

Algunas preguntas frecuentes sobre la lactancia

¿Qué pasa si no deseo amamantar? La decisión la toma cada persona. Las asesoras de lactancia, obstétricas, puericultoras y otros profesionales que acompañamos las lactancias, acompañamos TODAS las lactancias. Tenemos la obligación de dar toda la información necesaria para que las decisiones se basen en deseos y no en mitos externos, pero **nunca juzgar ni obligar a nadie a hacer algo que no desea**. Como no hace falta ninguna preparación de los pezones ni de los pechos para la lactancia, si decidimos no amamantar durante el embarazo y luego cambiamos de opinión, no habrá ningún problema.

¿Por qué los profesionales tienen el deber de dar

información sobre lactancia? Porque a través de innumerables investigaciones, tenemos mucha información acerca de cómo la leche humana es un fluido único, que varía todo el tiempo y se adapta a las necesidades del cachorro humano. Inclusive hay investigaciones que plantean un “flujo retrógrado”, es decir, que la saliva del bebé entraría dentro de los conductos mamarios y la glándula mamaria tendría respuestas biológicas en base a eso (llevar mayor cantidad de anticuerpos o que la leche tenga más agua cuando hace calor, por ejemplo). Hablar de lactancia es urgente, y no solo dentro de los ámbitos dedicados a la crianza, sino en horario central de todos los canales de televisión. Hemos perdido la tradición y el acompañamiento a las familias que desean amamantar, planteando que la leche de fórmula es más sencilla e igual de sana. La lactancia sufrió numerosos golpes a través de la historia, la mayoría de ellos ligados al mercantilismo y la monetización de las personas. Las nodrizas siempre existieron, dado que antiguamente se criaba en la familia-tribu, y cuando una mujer fallecía o se enfermaba gravemente luego del parto, estaban los brazos y los senos de otra mujer para amamantar al recién nacido. Los sucedáneos de la lactancia, como leche de otros animales o infusiones, también existen desde que el mundo es mundo (hay reliquias de viejos biberones utilizados en la Roma Antigua), pero no se utilizaban a menos que fuera indispensable dado que escasos bebés sobrevivían. Desde las esclavas nodrizas utilizadas porque no estaba bien visto amamantar en diversas sociedades –como en las Antiguas Grecia y Roma–, hasta la migración masiva hacia las urbes industriales para trabajar en las fábricas, el camino de la lactancia fue tomando diferentes rumbos.

¿Cómo y por qué apareció la leche de fórmula? A partir de la Revolución Industrial y los grandes cambios sociales que se inician en esa época, las madres perdían los días de salario que implicaba el nacimiento de sus hijos, y volvían rápidamente a trabajar, dejando al bebé a cargo de sus hermanos o de algún familiar. Ese bebé era alimentado con lo que había: agua con azúcar, té, leche de algún animal, y solo si tenía suerte, era amamantado por otra mujer. Como tampoco se sabía acerca de esterilizar los implementos y ni siquiera había agua potable, los bebés morían rápidamente de desnutrición y de diversas infecciones. En este ámbito tan propicio, la leche de fórmula aparece como “salvación”. Pero las leches de fórmula eran

rudimentarias, mezclas de harina, azúcar, agua y con suerte algo de leche animal. Algunos bebés sobrevivían, porque estos preparados tenían las suficientes calorías como para mantenerlos vivos hasta iniciar la alimentación complementaria, que empezaba en forma muy precoz. La leche de fórmula se empieza a promocionar como un invento fabuloso que mantiene el sistema funcionando: ya no hace falta pensar en licencias de maternidad para que los bebés sean amamantados, total existe un fluido “exactamente igual”. Algunos años después de iniciarse el uso masivo de la leche de fórmula, empezaron a verse las consecuencias. Las primeras fórmulas no contaban con grasas, fundamentales para el desarrollo del cerebro infantil, ni tampoco con vitaminas esenciales para los bebés. Se le empezó a agregar a la fórmula aceite de hígado de bacalao y jugo de naranja, para paliar la desnutrición y el escorbuto, y, nuevamente, se vendió como “igual que la leche humana”. El desarrollo de la tecnología de la leche en polvo hizo que esta se extendiera por todo el planeta. Las empresas de leche de fórmula apuntaron a las familias directamente, regalando ajuares, biberones, chupetes, cursos de lactancia y nutrición gratuitos e infinidad de regalos más para, al mismo tiempo, entregar folletos y muestras de sus productos. Hoy con el *boom* de las redes sociales, realizan consultorios virtuales, charlas en vivo con profesionales reconocidos y acciones con *influencers*. La dinámica, regulada por el Código de Sucedáneos de la Lactancia Materna desde 1981, no ha variado mucho.

El mayor *target* de estas empresas somos nosotros, los profesionales. En 2004, Fernando Vallone, presidente de Lacmat (una ONG sin fines de lucro que ha cumplido un gran papel en la defensa de la lactancia materna), denunciaba al periódico *Página 12* que “una de las cátedras de pediatría de la UBA aceptó que Mead Johnson se hiciera cargo de preparar un CD con los apuntes de estudio: lo entregan gratis a los estudiantes junto con un folleto sobre sus leches maternizadas, y en cada página aparece el logo de la empresa, la conejita maternal”. “Nos usan de kiosco”, explicaba Mónica Waisman en esa misma nota, titular de la, en ese momento, Subcomisión de Lactancia Materna de la Sociedad Argentina de Pediatría, hablando de las empresas que sustentan congresos médicos. Una de las primeras en denunciar estas prácticas, ya en 1939, fue Cicely Williams, una médica jamaicana que observó que en países con escasos recursos y altísima mortalidad infantil, una empresa de productos alimenticios empleaba a mujeres vestidas de enfermeras para ir a las casas de la vecindad y convencer a las nuevas madres

de que su leche condensada azucarada era un sustituto preferible de la leche humana, anunciándola como “ideal para bebés delicados”. En 1974 se publica el informe periodístico *The baby killer*, una investigación de Mike Muller que denunciaba cómo las empresas introducían la leche de fórmula en países del tercer mundo, donde no se utilizaba usualmente, para luego irse y dejar a las personas con peores problemas que antes.

¿Por qué cuento todo esto? Porque muchas veces, al hablar de lactancia caemos fácilmente en el personalismo, en el juego de la culpa y en las comparaciones entre maternidades. La culpa es otra excelente herramienta para las empresas: el juego, muchas veces mediatizado, de “quién es más o menos madre” según cómo se alimenta, se duerme o se viste al bebé, que no debería ni ser puesto en la balanza, le sirve a la industria para enfrentarnos entre madres, socavar nuestra confianza, hacernos sentir mal y seguir diciendo que sus productos son iguales a la leche humana.

Ser profesional de la salud y no acompañar la lactancia deseada por ignorancia, conflictos de interés o creencias sin fundamentos es, sencillamente, mala praxis.

Entonces, ¿cuál es el mayor problema de la leche de fórmula? Indicar leche de fórmula puede ser necesario médicamente, sí, al igual que puede ser necesaria una cesárea para salvar vidas y puede ser necesario usar un respirador con un bebé que no puede respirar por sí mismo. Pero para indicarla, deberíamos estar seguros de que la familia podrá acceder a la misma todo el tiempo que la necesite, que tenga agua potable, que sepa prepararla, que pueda esterilizar los biberones, que los biberones sean de un plástico que no resulte tóxico, que sepa cómo se conserva. Y pocas veces esto sucede. El indicar leche de fórmula muchas veces no busca reemplazar la lactancia, sino que se plantea como “transitorio”, pero termina sucediendo esto último infinita cantidad de veces por indicaciones sesgadas y poco fisiológicas. Y no ayuda que las leches de fórmula sean de venta libre en supermercados, kioscos, farmacias y redes de venta *online*. Si una leche de fórmula es necesaria, debería ser cubierta por la obra social o por el Estado, sin comprometer el 35 % del salario de la familia, como es calculado que lo hace hoy día (año 2021). Necesitamos informar sobre lactancia, ante todo a los profesionales que trabajan con familias, para que dejemos de informar desde creencias y folclore profesional de muchos años, desde clases ofrecidas

en la residencia y en los congresos por las mismas empresas de leche de fórmula, y empezamos a transmitir evidencia. Necesitamos tener herramientas para acompañar a aquella persona que desea amamantar y también a la que no. Nos falta mucho, pero ahí vamos.

¿Y qué pasa cuando no hay leche humana disponible?

Las razones por las cuales se contraindica realmente la lactancia son muy escasas, dado que, por ejemplo, la mayor parte de los medicamentos son compatibles con la misma (la web www.e-lactancia.org tiene una excelente base de datos sumamente confiable para buscar medicamentos o incluso tratamientos estéticos). Algunos de estos casos son personas que amamantan en tratamiento con quimioterapia o radioisótopos; personas que amamantan VIH+, sobre todo sin tratamiento antirretroviral (dado que se está estudiando la posibilidad de lactancia en personas que amamantan indetectables); y personas que amamantan consumidoras de sustancias que puedan pasar a la leche y afectar al bebé (cocaína, alcohol, etc.). Hay razones congénitas por las cuales el bebé tal vez necesite otra leche, aunque son muy raras: déficit congénito de lactasa, algunos tipos de galactosemia (una patología del metabolismo de los hidratos de carbono por la cual no se puede metabolizar la galactosa, que es parte de la lactosa). También puede suceder que la mamá haya tenido alguna cirugía mamaria extensa que haya afectado la glándula, ya sea su tejido productor de leche o los nervios que tienen que ver con la eyección de la misma. Por fuera de estas cuestiones, el porcentaje estimado de personas que por alguna razón fisiológica no pueden amamantar es menor del 3 %. Generalmente, cuando vemos problemas en la lactancia, no son de la glándula mamaria ni de su capacidad para producir leche, sino de intervenciones e indicaciones poco correctas: por ejemplo, esperar cierta cantidad de horas para amamantar, o amamantar una equis cantidad de minutos, o no tener espacio en el trabajo para extraerse leche.

La Organización Mundial de la Salud sugiere, en orden decreciente de fortaleza de la recomendación:

- ***Ofrecer leche humana directamente del pecho.***
- ***Ofrecer leche humana de la propia madre extraída.***

- ***Ofrecer leche humana de banco pasteurizada.***
- ***Ofrecer leche de fórmula.***

En casos de emergencia, el Ministerio de Salud de Argentina sugiere como última opción ofrecer leche de vaca diluida según la edad, con agregados de azúcar y aceite (debido a que al diluirla, pierde calorías y nutrientes, y hay que agregárselos de alguna manera). Esto lamentablemente sucede a menudo por la pérdida de la lactancia y la imposibilidad de comprar leche de fórmula, y es una de las principales razones de anemia en la infancia. La leche de vaca sin diluir no es apta para el consumo de menores de 1 año, y sobre todo menores de 6 meses: puede causar hemorragias intestinales, predisponer a alergias, desplazar alimentos más nutritivos y dificultar la absorción de hierro.

¿Qué son los bancos de leche? Un Banco de Leche Humana es un servicio especializado, responsable por la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna. Realiza actividades de recolección de leche de la persona que amamanta y que la dona solidariamente, la procesa, controla su calidad, la clasifica, conserva y distribuye. De esta manera ayudan a salvar las vidas de muchos bebés hospitalizados de alto riesgo. También lleva adelante investigaciones, así como actividades de desarrollo tecnológico, información y educación. Una vez, Martín Sapag, uno de los fundadores del Banco de Leche Humana de la provincia de Neuquén, me dijo algo más o menos así: “No se dona el ‘excedente’ de leche, porque nunca sobra la leche, se extrae con esfuerzo y energía. Se dona leche del propio hijito o hijita, se le regala leche a otro bebé con ese mismo amor para que esté tan sano y feliz como el propio”. Me hago eco de estas palabras porque es verdad: no es donar “lo que sobra”, es donar algo muy valioso y es donarlo con profundo amor. Los bancos de leche, y por consiguiente, los bebés internados, se nutren de ese trabajo voluntario y altruista de esas madres y de las personas que forman parte del banco. La leche humana hace que los bebés prematuros tengan muchísimas menos infecciones y se eviten complicaciones graves como la enterocolitis necrotizante, una enfermedad en la cual el intestino del bebé muchas veces se perfora y es necesario operar. Acompañar a las mamás de “neo” para que se extraigan leche para alimentar a sus bebés y, a la vez,

contar con leche donada, es una apuesta para la salud de esos bebés y su más rápida recuperación.

En nuestro país, actualmente existen ocho bancos de leche:

- BLH Neuquén.
- BLH Chaco.
- BLH Córdoba.
- BLH Corrientes.
- BLH La Plata.
- BLH Mendoza.
- BLH Río Negro.
- BLH Sarda (CABA).

Todos asesoran a las madres que desean ser donantes y buscan que la donación sea lo más cómoda posible para una mamá que, además, está puérpera. La mayoría recoge la leche en los domicilios de esas mamás, o en centros comunitarios, jardines de infantes y otros puntos de recolección de la comunidad. Toda la leche es analizada y procesada para ser segura para los bebés. Si bien la leche donada se prioriza para bebés de alto riesgo, cualquier bebé podría recibirla. Si hubiera muchos más bancos de leche, habría mucha más leche donada, porque muchas personas que amamantan tienen el deseo de donar y no tienen un banco de leche cercano. Tal vez habría tanta leche que no se pensaría en la leche de fórmula como primera opción después de la leche humana. Debemos empezar a ponerlo en la mesa como posibilidad, porque mejoraría la vida y la salud de miles de personas a corto y largo plazo. No, no es imposible ni improbable. Solo debemos trabajar por ello.

La leche de fórmula

La leche de fórmula es un constructo de lo que se cree que tiene la leche humana en cada momento de la historia. Antes se creía que la leche humana tenía agua, azúcar y algunas proteínas, y así la vendieron como “igual”. Luego, se encontró que tenía grasas, así que le agregaron aceites (aunque para los bebés menores de 6 meses, por ejemplo, durante mucho tiempo se vendió como mejor la “descremada”). Hubo un período enorme en el que se dijo que

la leche humana era peligrosa porque la madre tenía bacterias en el pecho que podían matar al bebé, así que se promocionó la fórmula como limpia, higiénica y estéril. Hoy sabemos de microbiota y de la importancia positiva de esos gérmenes, y el discurso cambia: ahora las fórmulas tienen uno que otro probiótico, microorganismos vivos. Y así hasta el infinito, mientras sigamos descubriendo cosas.

La leche de fórmula, hoy, es leche de vaca modificada bioquímica y nutricionalmente para cubrir las necesidades nutricionales del bebé. En otros países, existe leche de fórmula de cabra, y también de proteína de soja y de arroz (de estas últimas hablo en el capítulo 11, sobre “Alimentación basada en plantas en la infancia”). Tenemos que pensar que además de las nutricionales, hay necesidades inmunológicas, sensoriales y microbiológicas que no están cubiertas por la misma.

¿Esto quiere decir que hay que juzgar a quienes deciden alimentar a sus bebés con fórmula? No, porque nadie tiene derecho a opinar sobre las decisiones ajenas. Simplemente quiere decir que todos merecemos tener la información, y que cuando los profesionales de la salud indicamos una fórmula láctea por la razón que sea, debemos sopesar estos riesgos.

¿Cuáles son los riesgos de la leche de fórmula?

Riesgo microbiológico

La OMS sugiere, en caso de utilizar leche de fórmula, como primera opción la leche fluida, que viene preparada y cerrada al vacío. Pero esta opción es sumamente cara, y por una cuestión económica, se suele preferir la leche en polvo.

La leche de fórmula en polvo no es estéril, y puede contener microbios entre el polvo. Se han encontrado leches de fórmula contaminadas con *Enterobacter sakazakii* y la *Salmonella enterica*. A medida que pasan los días con la lata abierta, se acumulan otros microorganismos en su interior. Para reconstituir la leche de fórmula, se sugiere hervir agua, luego dejarla enfriar unos 30 segundos y en ese momento echar el polvo como indique la caja. El agua caliente a más de 70° inactiva las bacterias que mencioné anteriormente. Luego, se deja enfriar hasta la temperatura que suele preferir el bebé (se

puede poner la mamadera cerrada bajo el chorro de agua fría de la canilla). **Hervir el agua no es por una cuestión del agua en sí, que presuponemos potable ya de base, sino porque es necesario inactivar las posibles bacterias del polvo.** Lo ideal es prepararla en el momento que se va a utilizar, aunque se puede guardar y transportar la fórmula reconstituida previamente. Nunca se sugiere calentar ni leche humana ni leche de fórmula en el microondas: se calienta en forma despareja, algunas zonas se calientan mucho y otras quedan frías, y eso puede quemar al bebé.

Dice la OMS:

¿Qué debo hacer si no dispongo de agua hirviendo y debo preparar un biberón?

- La forma más segura de preparar una toma es utilizar agua que haya sido hervida y enfriada a no menos de 70 °C.
- Si no puede disponer de agua hirviendo, tal vez desee utilizar preparaciones para lactantes líquidas estériles.
- También puede preparar las tomas utilizando agua potable limpia a temperatura ambiente y administrar el alimento de inmediato.
- Las tomas preparadas con agua a menos de 70 °C deben consumirse inmediatamente; no deben almacenarse para utilizarlas más adelante.
- Deseche todos los restos de tomas al cabo de dos horas.

Preparación inadecuada

Es muy común que, ante su alto costo, las familias preparen la leche de fórmula con más agua de lo que indica la lata, generando un fluido muy aguado que no es efectivo nutricionalmente para el bebé y lo pone en riesgo. Por el contrario, a veces se concentra demasiado y esto genera una sobrecarga de sodio y proteínas muy difícil de manejar para los riñones del bebé. **Es muy importante asesorar a las familias para que tengan la información**

correcta sobre la preparación de la leche de fórmula si es que esta será incorporada.

Riesgo inmunológico

La leche humana contiene compuestos bioactivos que le aportan al bebé parte de su inmunidad mientras su sistema inmune se va desarrollando y madurando. Entre estos compuestos encontramos anticuerpos contra todos los microorganismos a los que estuvo expuesta su mamá (vacunas, infecciones, enfermedades), células de la inmunidad (o sea, le pasamos directamente glóbulos blancos para que den una mano), lactoferrina (una maravilla biológica que mata bacterias, participa en el metabolismo del hierro y a la vez estimula el crecimiento de las neuronas y su metabolismo), prebióticos y probióticos que compiten con las bacterias nocivas, y muchas otras sustancias más. Estas **sustancias beneficiosas no se le pueden agregar a la leche de fórmula, porque varían de día a día y tienen que ver con la historia inmunológica de la misma.** Se está probando agregarle probióticos, pero no queda claro aún si realmente serían beneficiosos (y generalmente tienen uno o dos probióticos versus los seiscientos que tiene la leche humana). Esta información nos da la pauta de que los bebés alimentados exclusivamente con leche de fórmula tienen mayor riesgo de tener enfermedades infecciosas, y lo vemos en las estadísticas: suelen tener más infecciones respiratorias y gastrointestinales. ¿Todos los bebés que tomen fórmula se enfermarán? No, seguramente no, pero es un factor de riesgo.

Monotonía sensorial

La leche humana cambia de sabor todo el tiempo, según lo que consume la mamá, y esto le da un panorama neurológico de construcción de sabores al bebé que es muy importante para la alimentación de toda la vida. La leche de fórmula tiene el mismo sabor siempre, generalmente dulce. Algunos expertos sugieren cambiar la marca de leche de fórmula cada tanto para abrir el panorama de sabores, pero a los bebés no les caen bien todas las marcas. Entonces, ¿qué hacemos? Con fórmula o con leche humana, iniciar la alimentación complementaria con un abanico de posibilidades y sabores distintos es importante y es lo que se sugiere, y evita continuar con esta

monotonía sensorial.

Nociones de hambre y saciedad, y alimentación a demanda

Este es uno de los problemas más importantes de la alimentación con biberón, ya sea con leche extraída o con leche de fórmula: la indicación de “equis mililitros cada tantas horas”. **La alimentación de un bebé no tiene horarios ni cantidades: tampoco si es alimentado con biberón.** ¿Pero cómo puede ser? ¿No tiene que tomar una cantidad específica? No. Lo ideal sería ofrecer el biberón cada vez que el bebé tiene signos de hambre, al igual que se ofrecería el pecho, y permitir que lo suelte cuando no tenga más hambre, para volverlo a ofrecer cuando lo vuelva a pedir, y así. Veamos un gráfico para comprenderlo mejor:

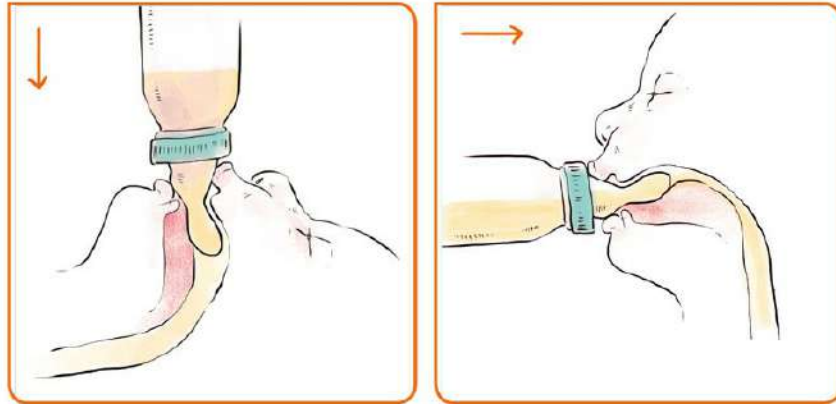


Es posible que los bebés pidan leche cada tres horas, y también es posible que pidan cantidades más pequeñas una vez por hora varias veces durante el día.

Se asume que la lactancia con fórmula es “más fácil y ordenada” y no, no lo es. Implica poner el cuerpo, mirar a los ojos, estar atentos a las señales del bebé. El problema es que hasta nos venden “almohadones sostenedores de mamaderas” para no tener que tener al bebé a upa, cuando ese hacer upa también es nutritivo e importante.

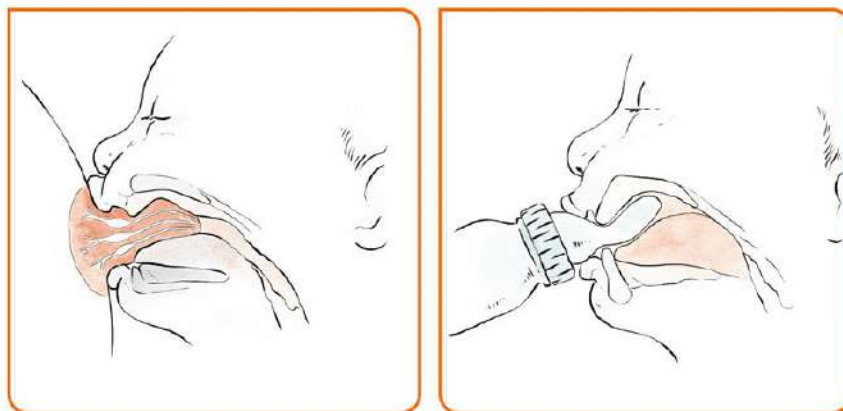
Otra cuestión con relación a la saciedad tiene que ver con la forma en que es administrado ese biberón. “No se llena nunca, traga todo y quiere más y

más”, nos dicen las familias. Con el biberón la leche cae, y el esfuerzo del bebé se traduce en regular esa leche que cae para no atragantarse, y tragar. **Si ofrecemos el biberón en forma vertical, con el bebé acostado, la leche ingresa en “caída libre” y el bebé traga sin pausa, sin demasiado registro de lo que ingresa a su estómago.**



Si ofrecemos el biberón en forma horizontal, con el bebé lo más sentado posible, el bebé tiene que realizar un esfuerzo para manejar esa leche. Si, además, vamos retirando el biberón cada cierta cantidad de succiones para darle tiempo al bebé para registrar el ingreso de esa leche, la alimentación será mucho más consciente y a demanda. Este último método se llama “método Kassing” y una puericultora puede ayudar a llevarlo a cabo (sí, las puericultoras también acompañamos a la hora de ofrecer el biberón).

Con respecto a los tipos de mamadera, son todos más o menos parecidos, pero es importante **evitar aquellas mamaderas de cuerpo blando**, porque hay una tendencia a “exprimir las” y ofrecer la leche a chorros, que pueden generar atragantamientos o mayor cantidad de problemas con la regulación.



Recordemos también que la leche extraída o la leche de fórmula se puede ofrecer en vasito, en cuchara o con técnicas como dedo-jeringa, desde el nacimiento. También en casos que haya deseo de lactancia y sea necesario complementar por alguna razón, se puede ofrecer en relactador, estimulando la succión de la teta al mismo tiempo. **A partir de los 6 meses se sugiere introducir el vasito de boca abierta junto con la alimentación complementaria, para ofrecer agua y posteriormente la leche que tome ese bebé.** Los biberones y las tetinas utilizados a largo plazo pueden generar malformaciones en el paladar y el rostro, y afectar los dientes, generando problemas para respirar, hablar y comer.



Plásticos y sus riesgos

No todos los plásticos son seguros para el uso de biberones. Algunos plásticos al calentarse puede desprender microplásticos y nanoplásticos diminutos que se transfieren a la leche. Aún no están claros los efectos de esto en la salud infantil, pero por estas razones se sugiere no utilizar el biberón en el microondas, evitar recalentarlo, utilizar biberones de plásticos sin bisfenol A (un disruptor endocrino) y empezar a apostar, nuevamente, por los viejos biberones de vidrio.

Enfermedades crónicas no transmisibles

La falta de lactancia y sus factores protectores, y el aumento del consumo de leche de fórmula, junto con el inicio temprano de la alimentación complementaria con ultraprocesados y otras cuestiones de la modernidad, trajo una pandemia: la de enfermedades crónicas no transmisibles. **Los niños no amamantados tienen más riesgos de presentar diabetes, hipertensión, enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias intestinales, alergias alimentarias, celiaquía y otras patologías.** Sabiendo esto como profesionales, ¿no es una responsabilidad enorme que debemos tomar el actualizarnos y empezar a cambiar esta sociedad llena de publicidades por acciones para sostener las lactancias deseadas?

¿Qué pasa si un bebé necesita realmente leche de fórmula?

Mi hijo mayor nació con una patología congénita llamada quilotórax congénito. Alrededor de sus pulmones, entre sus pleuras, se acumuló en algún momento de la última semana del embarazo un líquido rico en lípidos, probablemente por alguna falla congénita en su sistema linfático. Nació muy grave, de urgencia, y tuvieron que trabajar arduamente para que llegara a respirar. Recién empezó a mejorar cuando drenaron ese líquido a través de un tubo que salía de su tórax minúsculo y que tuvo durante semanas.

Sacarme leche en la neo fue para mí un espacio de refugio, de sentir que yo podía hacer algo más por él, además de pasar horas a su lado contándole cuentos. Los primeros días estaba tan grave, tan al borde de la muerte, que fue poco el calostro que podían pasarle. Y luego, resultó que mi leche, por el contenido de grasa normal de la leche humana, no era la mejor opción. En ese momento, la única opción de una leche baja en lípidos era un preparado de fórmula. Hoy, los centros de salud que cuentan con bancos de leche “descreman” la leche humana y se la pueden suministrar al bebé.

Cuando me lo dijeron se me rompió el corazón una vez más. Pero me agarré desesperadamente de dos palabras: “No puede recibir tu leche por ahora”. Y seguí yendo al lactario cada dos horas, esperando con paciencia ese “por ahora”. Y ese momento llegó antes de lo que esperamos, porque pronto se drenó todo ese líquido que no le permitía respirar y su cuerpecito no lo

volvió a producir. Se fue el tubo, se fue el respirador, le empezaron a pasar de a poco mi leche, la empezó a tolerar bien y a los 25 días de vida, lo pude tener en brazos y en la teta. Teta que transitamos en forma exclusiva los meses que compartimos juntos, y fue lo último antes de decirnos adiós.

Entonces, sí. **La leche de fórmula, los preparados medicamentosos, pueden ser necesarios y son una herramienta tecnológica útil, bien utilizada, con responsabilidad e información.** Salir de conceptos como “realización”, “éxito” o “buena madre” alrededor del uso o no uso de los mismos es fundamental también para poder elegir con claridad. Trabajar en la deconstrucción del concepto patriarcal de “culpa” será probablemente una tarea muy ardua dentro del feminismo, que debe incluir las mapaternidades y las infancias.

El respeto a las infancias no se da por la forma de alimentar, sino por lo que llamamos “alimentación perceptiva”: observar al bebé, sus necesidades, sus ganas, sus tiempos. Acunar, aupar, dar sostén con el cuerpo será imprescindible mínimamente durante los primeros meses de vida, y también es nutrir. Siempre, todo lo que hagamos desde el amor y el respeto, le mostrará a nuestras hijas y a nuestros hijos justamente eso: el amor y el respeto. Y ese es un mensaje, con nuestros actos, mucho más poderoso que todo lo que podamos decir durante el resto de nuestra vida.

La leche humana a través de los años

A lo largo de los siglos, y en prácticamente todos los lugares del mundo, la lactancia materna ha sido la norma hasta los 2-3 años de edad. No es sino hasta comienzos del siglo xx en los países industrializados cuando, a raíz de la aparición y extensión del uso de los sucedáneos de leche materna y los cambios sociales, se generaliza el destete prematuro de los bebés. Desde el punto de vista evolutivo, la lactancia materna es una clave fundamental en el desarrollo de nuestra especie. Su interrelación con la fertilidad de las mujeres y con la supervivencia de los niños hace de la lactancia un elemento de estudio primordial en la historia del género humano.

Diversos trabajos en paleofisiología y antropología establecen que la edad del destete espontáneo en Homo sapiens sapiens ocurre entre los 2,5 y los 7 años.

Asociación Española de Pediatría

No existe una “edad de destete”. Tampoco un momento en que la leche deje de nutrir, ni que se vuelva agua, ni que haga daño, ni que se pudra, ni que genere diarrea. La edad de destete la tiene que decidir la díada, a menos que ocurra algo extraordinario que implique el consejo médico acerca del tema (tratamiento quimioterápico de la persona que amamanta, por ejemplo).

El destete tiene muchas veces que ver con miradas culturales de condena hacia un niño o una niña que camina, habla y toma pecho. Cuando me preguntan: “¿Por qué se mira mal a las madres que deciden dar biberón?”, mi respuesta es: “Se mira mal cualquier decisión que tomen las madres”. Y este es uno de esos casos: una madre que decide seguir amamantando después del año seguramente reciba más de un comentario condenatorio sobre el tema.

Algunos datos sobre la leche humana después del año de vida:

- Las concentraciones de anticuerpos aumentan después del segundo año de lactancia.
- La concentración de la ya mencionada lactoferrina a los 48 meses de lactancia (si, 4 años) es similar a la del calostro.
- Hay estudios que muestran las relaciones positivas entre la duración de la lactancia materna y la estructura de la materia blanca del cerebro, consistentes con mejoras en el rendimiento cognitivo y conductual.
- Se relacionó mayor tiempo de lactancia con mayor desarrollo del lenguaje y del desarrollo visual, menor riesgo de enfermedades autoinmunes, mejor salud mental en la vida adulta y mejor adaptación social.
- En las madres, se reduce un 15 % el riesgo de diabetes de tipo 2 por cada año de lactancia, disminuye el riesgo de enfermedad coronaria, mejora el perfil lipídico, genera protección contra fracturas por osteoporosis, y disminuye un 94 % el riesgo de cáncer de mama y un

37 % el riesgo de cáncer de ovario con lactancias mayores a 36 meses.



Esto de ninguna manera implica la obligación de amamantar 2, 4 o 7 años. Eso será decisión del bebé y de la persona que amamanta, de acuerdo con sus preferencias, su entorno, su trabajo, su tiempo y cómo se siente alrededor de la lactancia. Simplemente implica tener información fehaciente sobre el tema para no escuchar voces desactualizadas que dicen que la lactancia produce problemas psicológicos en los chicos u osteoporosis en las madres. Se pueden hacer durante la lactancia todos los controles clínicos, ginecológicos y odontológicos que necesite la madre durante ese período, puede recibir vacunas y casi todos los medicamentos (ante la duda, se puede chequear en www.e-lactancia.org).

La lactancia es una responsabilidad social

Escribí en *Hoy no es siempre*, mi primer libro, que la lactancia es una responsabilidad social, y no hay día en el que no lo vuelva a sostener. **La lactancia y la crianza son parte de la supervivencia de la especie y nos compete a todos como sociedad, no solo a los mapadres y a las personas que amamantan.** Esta sociedad, en vez de cuidar a los bebés y a sus mapadres, pone infinitas trabas para la salud: las licencias de mapaternidad vergonzosas, la falta de lactarios, la falta de formación de los profesionales de

la salud, las miradas juzgadoras ante cualquier cosa que decida la familia...

Hace poco paseaba por la calle con mi hijo de 2 años en su portabebés. Pocas veces tiene ganas de usarlo, pero venía cansado y me lo pidió con mucho amor. Así que los dos estábamos disfrutando del día de otoño, caminando despacito mirando las hojitas caer y charlando sobre las mismas. Tuvimos la mala suerte de cruzarnos (en una ciudad con pocos habitantes y medio vacía) con una señora que decidió contarnos todo lo que opinaba sobre que él estuviera en un portabebés. “¿Qué edad tiene? ¡Está muy grande para estar a upa! ¡Le vas a hacer mal! A ver, nene, vamos caminando, dale”. Los dos la miramos asombrados y la dejamos seguir camino hablando sola. Esa mujer no sabía de dónde veníamos, cuál era nuestra historia, si estábamos paseando o volviendo del trabajo, si el niño en cuestión podía caminar o no. Nomás decidió prejuizar, opinar y dar órdenes. Ahora que lo pienso, debería haber sacado una teta y ofrecérsela a hijo para horrorizarla un poco más.

Todos fuimos esa señora alguna vez, y dijimos cosas que no correspondían. Yo he indicado fórmulas innecesarias y he dicho “no come por la teta”, y que mejor le dieran ultraprocesados que me parecían buenísimos. No podemos llevar el tiempo atrás, pero podemos pedir disculpas, aprender de nuevo y trabajar a nivel personal y político para generar mejores condiciones de salud para todos y todas.

No hay una manera perfecta de criar, ni de alimentar, ni de transitar el día a día de nuestras familias. Cada familia es diferente, tiene una historia personal y un atravesar diario que solo lo conocen quienes están allí. Todo lo que se haga desde el amor y el respeto hacia las infancias merece ser abrazado y acompañado. Seguro, más que seguro, están haciendo todo muy bien. Ánimo.

Para seguir leyendo

PARA FAMILIAS Y PROFESIONALES

- Vazquez, V. *Leche de madre: Guía para una lactancia informada y desprejuiciada*, Planeta Argentina, Buenos Aires, 2020.
- González, C. *Un regalo para toda la vida* (3.a ed.), Temas de hoy,

Barcelona, 2015.

- La Leche League International. La Leche League International y Pelayo, C. *El arte femenino de amamantar*, Alianza Editorial, Madrid, 2005.
- Mayo, M. J. G. *Etnopediatría: Infancia, biología y cultura*, Spanish Edition, (1.a ed.), Editorial Ob Stare, Madrid, 2017.
- Vivas, E. *Mamá desobediente. Una mirada feminista a la maternidad*, Ediciones Godot, Buenos Aires, 2020.
- Padró, A. *Somos la leche*, Grijalbo, Barcelona, 2017.
- Olza, I. *Lactivista*, Spanish Edition, (1.a ed., 1.a imp. ed.), Editorial Ob Stare, SL, Madrid, 2013.
- Barruti, S. *Mala leche* (1.a ed.), Editorial Planeta Argentina, Buenos Aires, 2018.
- E-lactancia. Disponible en: www.e-lactancia.org

PARA PROFESIONALES

- Hernández Aguilar, M. y Aguayo Maldonado, J. (2005). La lactancia materna. Cómo promover y apoyar la lactancia materna en la práctica pediátrica. Recomendaciones del Comité de Lactancia de la AEP. *Anales de Pediatría*, 63(4), 340–356. DOI: <https://doi.org/10.1157/13079817>.
- Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización Panamericana de la Salud (OPS), Ministerio de Salud de la Nación. Dirección Nacional de Maternidad e Infancia, UNICEF (2013). *Lactancia, promoción y apoyo en un hospital amigo de la madre y del niño*. Módulo 3. [Internet]. Buenos Aires. Disponible en: [https://datos.dinami.gov.ar/nutricion/material/modulo 3.pdf](https://datos.dinami.gov.ar/nutricion/material/modulo%203.pdf)
- Wikipedia. (2021). Cicely Williams. Wikipedia, la enciclopedia libre. Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Cicely_Williams
- Infosalus. (2020). Recomendaciones para evitar la liberación de microplásticos en la preparación de biberones de leche de fórmula. *Infosalus*. Recuperado de: <https://www.infosalus.com/nutricion/noticia-recomendaciones-evitar-liberacion-microplasticos-preparacion-biberones-leche-formula-20201020073636.html>
- Secretaría de Salud de la República Argentina, plataforma SUMAR. Curso básico de Lactancia Materna, 2019.
- Pérez Bravo, M. D. (2020). Maternidad(es) y lactancia(s): Los debates sociales en torno a la lactancia materna. *South Florida Journal of*

Development. DOI: <https://doi.org/10.46932/sfjdv2n2-006>.

- Belintxon-Martín, M.; Zaragüeta, M. C.; Adrián, M. C.; López-Dicastillo, O. (2011). El comienzo de la lactancia: experiencias de madres primerizas. *Anales del Sistema Sanitario de Navarra*, 34(3), 409-418. DOI: <https://dx.doi.org/10.4321/S1137-66272011000300007>.
- Gitz, E. (2020). Lactancia materna: debates teóricos sobre su presencia en la identidad femenina y en las representaciones de la buena maternidad. *Revista Científica de UCES*, 25(2). Recuperado de: <https://publicacionescientificas.uces.edu.ar/index.php/cientifica/article/view>
- Cosecha Roja. (2020). La lactancia deseada es una responsabilidad social. *COSECHA ROJA*. Recuperado de: <http://cosecharoja.org/la-lactancia-deseada-es-una-responsabilidad-social-2/>
- Aguilar, M. J. *Conceptos, definiciones e historia de la lactancia. Nodrizas*. En María José Aguilar (dir.), *Lactancia Materna* (pp. 1-13), Elsevier, Madrid, 2005.
- Ministerio de Salud de la Nación (2010). La alimentación de los niños menores de dos años. Resultados de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud. ENNyS 2010. Buenos Aires: Ministerio de Salud de la Nación; 2010. 60 p. Disponible en: [alimentacion-de-ninosmenores-de-2-anos.pdf](#)
- Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación (2019). Resumen ejecutivo. Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud. ENNyS 2. Disponible en: http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001565cnt-ennys2_resumen-ejecutivo-2019.pdf
- Asociación Española de Pediatría. (2018). Lactancia materna en niños mayores o “prolongada”. *AEPED*. Recuperado de: <https://www.aeped.es/comite-lactancia-materna/documentos/lactancia-materna-en-ninos-mayores-o-prolongada>
- Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría. *Lactancia Materna: guía para profesionales*. Monografías de la AEP n.º 5, Ergón, Madrid, 2004.
- FAO/OMS. (2007). Preparación, almacenamiento y manipulación en condiciones higiénicas de preparaciones en polvo para lactantes: directrices. *WHO*. Recuperado de: <http://www.who.int/foodsafety/publications/micro/pif2007/en>
- Página 12. Sociedad. (15 de agosto de 2004). “A los médicos nos usan de quiosco”. *Página 12*. Recuperado de:

<https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/39665-13733-2004-08-15.html>

- Apple, R. D. (1986). Advertised by our loving friends: The Infant Formula Industry and the Creation of New Pharmaceutical Markets, 1870-1910. *Journal of the History of Medicine and Allied Sciences*, 41(1), 3-23. DOI: <https://doi.org/10.1093/jhmas/41.1.3>
- Boatella, J. (2010). Estrategias, tipos y composición de los primeros preparados destinados a la alimentación infantil. *Rev Esp Nutr Comunitaria*; 16(4):194–200. Recuperado de: <https://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-nutricion-comunitaria-299-pdf-X1135307410211255>
- Pearson, W. J. (1930). Common Practices in Infant Feeding. *Postgrad. Med J.*, 1930 Dec; 6(63):38-43. DOI: 10.1136/pgmj.6.63.38.
- Reporter, G. S. (2013). Nestlé baby milk scandal has grown up but not gone away. *The Guardian*. Recuperado de: <https://www.theguardian.com/sustainable-business/nestle-baby-milk-scandal-food-industry-standards>
- Muller, M. (1974). *The baby killer: A War on Want investigation into the promotion and sale of powdered baby milks in the Third World. War on Want*. Disponible en: <http://archive.babymilkaction.org/pdfs/babykiller.pdf>
- Vallone, F. (2009). Pequeños grandes clientes: La publicidad de sucedáneos de la leche materna en dos revistas pediátricas de Argentina entre 1977 y 2006. *Salud Colectiva*, 5(1), 87. DOI: <https://doi.org/10.18294/sc.2009.232>.
- OMS. (2010). Razones médicas aceptables para el uso de sucedáneos de la leche materna. *Pediatría Atención Primaria*, 12(48). DOI: <https://doi.org/10.4321/s1139-76322010000600018>.
- Lawrence, R. A., y Lawrence, R. M. *Breastfeeding E-Book: A Guide for the Medical Professional*, English Edition (8.a ed.), Elsevier, Ámsterdam, 2015.
- Curso Leche Humana: Alimento Terapéutico del Siglo XXI. Universidad Juan Agustín Maza, 2021.
- Curso Avanzado de Lactancia Materna. Ramé. Embarazo y Lactancia, 2020.

Somos ecosistema: **microbiota y más**

Todo lo que le damos al bebé, nos lo damos a nosotros mismos.

Entre ese todo, el vaivén de la microbiota. Microbiota que hasta condiciona nuestros gustos, sentires, deseos.

Más bacterias que ser humano, nos obliga a pensar en el humilde papel que cumplimos en el ecosistema universal.



Seguramente, todos en algún momento escuchamos hablar de la “flora intestinal”, unas bacterias que estaban en el intestino y cumplían varias funciones. Así también lo aprendí yo en la facultad, sin demasiadas vueltas más.

Pero pocos años después, cuando aparecieron nuevas tecnologías para estudiar esas bacterias, el concepto “microbiota” surgió como un *boom* que vino a revolucionarlo todo. Ya no solo nos interesa saber cómo funciona cada tipo de célula, ni cómo se relacionan las células entre ellas y su entorno: ahora resulta que esas bacterias actúan como si fueran parte de nuestro cuerpo y hay que investigar cómo tratarlas bien.

La microbiota es el conjunto de microorganismos que nos habitan, participando en nuestro día a día como un órgano de distribución difusa que cumple múltiples funciones. Sin la microbiota, los seres humanos no sobreviviríamos, así como no sobrevivimos sin hígado o sin pulmones.

Es importante comprender que no somos seres aislados, transitando la vida sobre el planeta por nuestra cuenta, sino que **somos un ecosistema en constante e intenso desarrollo. Tenemos más células de microorganismos que células “propias” en el cuerpo.**

¿Cómo se forma y evoluciona la microbiota a lo largo de la vida?

Existen teorías contrapuestas acerca de cuándo tenemos un primer contacto con los gérmenes con los que conviviremos en la primera etapa de la vida. Algunos equipos de investigación plantean que la primera exposición se da en la vida intrauterina. Explican que se han encontrado colonias bacterianas en la placenta, similares a las encontradas en el meconio de los recién nacidos. Otros equipos plantean que probablemente el útero esté libre de

gérmenes y que su presencia es meramente patógena, y que el primer contacto se da durante el nacimiento.

Independientemente de cuándo es el primerísimo contacto, sí sabemos **que la microbiota de la persona gestante va a influir en la microbiota de ese bebé.** Inclusive se plantea que hay influencia de la microbiota previa al momento de la concepción. Si bien esto se sigue estudiando profundamente, ya se está hablando del papel de la microbiota en la fertilidad, de la microbiota del semen, y de cómo la microbiota de la boca tiene que ver con la capacidad de concebir.

La microbiota oral merece una mención aparte en este asunto. Todo el cuerpo sufre cambios durante el embarazo, y la boca también. Hay modificaciones en la microbiota oral, y se ha relacionado la mala salud de la boca con la preeclampsia (aumento de la presión arterial con repercusión en el embarazo) y con los nacimientos prematuros. ¿Por qué? Porque el desequilibrio de la microbiota oral genera inflamación, y esa inflamación repercute en el resto del organismo. **Es fundamental el cuidado odontológico durante el embarazo, y una parte fundamental del cuidado de ese bebé.**

Sabemos que la microbiota de la persona gestante impacta en el metabolismo del bebé, y estudios recientes muestran que incluso hay relación con el comportamiento de los niños y las niñas a corto y largo plazo. **Los hijos de madres con una microbiota desfavorable producto del consumo de alimentos de baja calidad nutricional, muy inflamatorios para el organismo, presentaron más dificultades en el desarrollo y el comportamiento, y mayor prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles.**

¿Solo la microbiota del embarazo? No. Se habla de un concepto que son los “cuatro trimestres”: ¡la microbiota de la persona tres meses antes de la concepción ya tendría influencia posterior en el desarrollo fetal!

Microbiota y nacimiento

No quedan dudas de que el primer gran impacto de microorganismos se da en el momento del nacimiento. Los bebés nacidos por parto vaginal estarán expuestos a la microbiota de la vagina y de la zona perineal de la madre. No

es un dato menor que gran parte de los bebés nacen con el rostro hacia la zona anal, embadurnándose de fluidos maternos. **El parto no es prolijo ni limpio, y está bien que no sea así. En esa impregnación de sustancias, los microorganismos ingresan al tracto digestivo del bebé y a su vía aérea, y colonizan también su piel.** ¿Por qué el bebé no se enferma si está viviendo un *shock* de bacterias y otros microorganismos variados? Porque su sistema inmune es muy inmaduro, porque cuenta con anticuerpos maternos, porque necesita esos microorganismos para sobrevivir... Y por otras razones que aún no conocemos. Las bacterias más abundantes en el intestino de los recién nacidos por parto vaginal son los lactobacilos y las bifidobacterias.

Cuando un bebé nace por cesárea, la colonización es muy distinta, sobre todo si no hubo un trabajo de parto previo. El primer contacto es la piel de la mamá, los campos quirúrgicos y las manos del obstetra, con lo que la colonización se da por bacterias distintas, entre ellas: *Staphylococcus*, *Enterococcus*, *Klebsiella*, *Clostridium perfringens*.

Sobre las cesáreas tenemos claras varias cosas: que son un procedimiento médico que salva vidas, que tienen riesgos y que la tasa de cesáreas sin indicación médica precisa es muy alta. Sabemos que el nacimiento por cesárea por sí solo modifica la instalación de las primeras bacterias en el intestino del bebé, siendo un factor predisponente a enfermedades alérgicas (especialmente alimentarias, rinitis y dermatitis atópicas) y a trastornos metabólicos. Entonces, la cesárea como vía de nacimiento tiene que ser elegida haciendo un balance entre esos riesgos y la preservación de la vida y la salud de la madre y del bebé.

Yo conocí a mi hijo mayor con vida porque tuve una cesárea de urgencia. De otra manera, él hubiera muerto. Y sí, agradezco la existencia de esta tecnología médica que nos permitió a ambos sobrevivir a ese momento. Pero también atravesé y conozco miles de historias de cesáreas porque el obstetra se va de vacaciones, porque “no te vas a bancar el trabajo de parto”, porque “es lo mismo”, porque es 23 de diciembre... Y la lista podría continuar. También por decisión propia de la persona gestante. ¿Valen la pena los riesgos a corto y largo plazo, ahora que los tenemos tan claros? **Todas las personas gestantes deberían contar con esta información sobre la microbiota, y de esa manera, poder tomar decisiones con dicha información.** Las decisiones sobre el propio cuerpo son de la persona que gesta, ¡es su cuerpo! Y como profesionales, tenemos que informar y acompañar.

Existen estudios acerca de colocar una gasa estéril en la vagina de la madre y luego del nacimiento por cesárea, pasarla por la boca y las manos del bebé para “sembrar” los microorganismos. Si bien la idea es útil y se está estudiando, es interesante pensar en qué huella neurológica deja en el desarrollo del bebé tener una gasa y un dedo enguantado como primer contacto de algo en la boca, y cómo esto podría afectar la lactancia y posterior alimentación.

Microbiota y alimentación

El segundo gran impacto, y tal vez el más importante en la construcción de la microbiota, es la alimentación de ese bebé. La leche humana contiene miles de bacterias, las sustancias que generan esas mismas bacterias, el alimento para esas bacterias, y otros componentes que ayudan a madurar el intestino.

El intestino de los recién nacidos es inmaduro y permeable, podemos pensarlo como un colador que deja pasar muchas sustancias a la sangre. No es que esté “mal”, tiene lógica: miles de sustancias nutritivas y protectoras, como anticuerpos y células maternas, pasan al torrente sanguíneo del recién nacido ya con la primera mamada de calostro. Hoy sabemos cosas que parecen ciencia ficción, como que la leche humana tiene células madre que irían a los tejidos del bebé y formarían parte de diversas estructuras de su cuerpo, como por ejemplo, el intestino. Estas células madre ayudarían a “cerrar” los espacios entre las células y de esa manera, hacer al bebé menos vulnerable.

Cuando el bebé es alimentado precozmente con leche de fórmula, las proteínas son diferentes a las de la leche humana, y el sistema inmunológico del bebé puede generar reacciones ante las mismas, reconociéndolas como extrañas y dando el primer paso en la generación de alergias alimentarias. La leche de fórmula no contiene anticuerpos ni esas células madre de las que hablé previamente, ni microorganismos que ayuden a colonizar el intestino (aun cuando las empresas les están agregando probióticos). Aquí radica la importancia fundamental de informar sobre lactancia, y en el caso de que esta no pueda darse, contar con bancos de leche humana para tener el alimento necesario para ese bebé.

La lactancia es tan importante para el desarrollo de la microbiota,

que se considera el factor individual más importante en la determinación de una microbiota intestinal saludable en el niño o la niña en los primeros 6 meses de vida. Inclusive existen estudios que muestran que bebés nacidos por cesárea y amamantados exclusivamente, mostraban a esa edad una microbiota similar a los nacidos por parto vaginal, y también amamantados.

- **Mi bebé nació por cesárea y tomó fórmula. ¿Qué puedo hacer para mejorar su microbiota?** Siempre se puede ayudar a nuestra microbiota a estar más sana. En este caso, la alimentación saludable es fundamental, como lo es en niños y niñas más grandes y adultos. Una alimentación basada en alimentos reales y lejos de los ultraprocesados es la base de una microbiota saludable, como veremos luego.
- **¿Qué pasa con los antibióticos? ¿Y con otros medicamentos?** Sobre los antibióticos también tenemos mucho que decir. Son una gran herramienta y previenen miles de muertes y secuelas de las infecciones bacterianas todos los años, pero también vemos un uso indiscriminado de los mismos. El 75 % de las infecciones respiratorias altas (mocos, tos) en la infancia se produce por virus, no por bacterias, y sin embargo, muchos de esos niños y niñas reciben antibióticos. El antibiótico no es selectivo: matará todos los gérmenes que pueda matar según su composición, inclusive parte de la microbiota que residía tranquilamente en el cuerpo de esa persona. Esos gérmenes pueden tardar varios meses en volver a crecer, y sabiendo que tienen funciones metabólicas y de protección, justamente dejan a esa persona más vulnerable. Es por esto que es fundamental estar seguros de que ese cuadro necesita antibióticos antes de prescribirlos, hacer foco en la importancia de alimentarse sanamente durante y después del cuadro, y nunca automedicarse.
Además de los antibióticos, otros medicamentos puede generar alteraciones en la microbiota. Los medicamentos que cambian el pH de una zona del tracto digestivo, como por ejemplo los que se usan para el reflujo en los bebés, pueden generar disbiosis (desbalance de

la microbiota) y hacer que ese bebé esté más vulnerable a otros microorganismos. Es por esto que realmente es necesario estudiar el reflujo si nos parece patológico para confirmarlo, y no sobremedicar reflujos fisiológicos, porque es una cuestión riesgo-beneficio.

La microbiota genera un “metaboloma”, es decir, de su procesamiento de los medicamentos genera diversos metabolitos (sustancias) que van a la sangre. De acuerdo con cómo esté la microbiota, ¡los medicamentos que se consumen vía oral se van a procesar y funcionar de diferentes maneras! La microbiota puede incrementar o disminuir la biodisponibilidad de un fármaco, y también puede incrementar o disminuir su toxicidad. Entonces, que quede claro: la “pastilla para la presión” no ejercerá una función tan útil si no se realiza un cambio de hábitos, dado que la eficacia de los fármacos también puede estar mediada por la microbiota.

Nacer antes: bebés prematuros

Otro factor que afecta a la microbiota es la edad gestacional con la que nace el bebé. Los bebés prematuros nacen con sus órganos muy inmaduros con relación a un bebé nacido a término. Entre ellos, el intestino, que es más permeable y con menos barreras de protección. Estos bebés además suelen pasar tiempo en neonatología, a veces están muy graves o son muy pequeños para poder mamar y suelen recibir antibióticos por diversas condiciones.

Hoy por hoy se ofrece leche humana a los prematuros lo más pronto posible, aunque sea colocando gotitas de calostro dentro de las mejillas del bebé. También se está estudiando el uso de probióticos (más allá de los que posee la leche humana) para proteger a estos bebés. **No es menor el papel del contacto nutritivo: los bebés no se nutren solo de leche, necesitan la voz y el contacto, aunque sea dentro de una incubadora, de sus mapadres. La familia es el eje fundamental de la recuperación.**

Los bebés prematuros muchas veces reciben antibióticos porque son muy vulnerables a los microorganismos patógenos. Además, suelen permanecer internados un tiempo variable, durante el cual se colonizan con la microbiota del hospital y no de su hogar. El método canguro, que implica que los bebés que están estables estén en contacto directo con el calor del cuerpo de sus

mapadres durante mínimo veinte horas al día, no solo le da la posibilidad al recién nacido y a su familia de abrazarse, olerse, latir al mismo tiempo, sino que también colabora en la transferencia de esa microbiota de casa, que espera a ese bebé ansiosamente con una cunita preparada.

El inicio de la alimentación complementaria y la microbiota

Empezar a incorporar alimentos diferentes a la leche en el sistema digestivo del bebé, genera cambios que vemos macroscópicamente cambiando los pañales (pedazos de comida en la caca, por si no se entendió). Cuando empezamos a ofrecer el brócoli o el *muffin* de zapallito, las bacterias se encuentran con nuevos nutrientes, y también con nuevas bacterias que vienen con esos alimentos. Sí, los alimentos no son estériles, vienen con una carga microbiana que ni la sanitización más estricta puede cambiar. Y eso es bueno, porque convivimos con los microorganismos sanamente.

Con el inicio de la alimentación complementaria, empiezan a cambiar algunas bacterias, y la microbiota, de a poco, se empieza a parecer a la microbiota de los adultos. Existen estudios que comparan la microbiota de los bebés que se alimentan con papillas y los bebés que se alimentan con el método BLW (Baby Led Weaning, lo veremos más adelante). La poco sorprendente conclusión es que no importa demasiado el método, sino qué tipo de alimentos reciben esos bebés, y la cantidad de fibra en esos alimentos.

Entre los 2 y 3 años, la microbiota pasa a ser muy similar a la de los adultos, volviéndose bastante estable, hasta que la persona llega a la vejez, donde vuelve a cambiar para volverse nuevamente menos diversa.

Los cambios en la microbiota infantil van a tener influencia en su salud y en el desarrollo del sistema inmune. La disbiosis está asociada con varias patologías a corto y largo plazo. De ahí la importancia, fundamental, de proteger a las personas gestantes y a las infancias nutricional y microbiológicamente.

¿Qué hace la microbiota que es taaaan importante?

La microbiota tiene diversas funciones:

Inmunológicas

- Las bacterias “pelean” por su territorio, y evitan que otras bacterias nos dañen. Esto ocurre en el intestino, la piel, la vía respiratoria, la vagina y todo lugar donde haya microbiota.
- Le explican al sistema inmunitario qué es propio y qué es ajeno.
- Degradan toxinas que ingresan al organismo evitando que se absorban.

Nutritivas

- Las bacterias hacen una parte de la digestión, que el ser humano no puede. Degradan la fibra alimentaria y, con ella, generan compuestos que el organismo utiliza para su beneficio. Es decir, ellas comen, y lo que producen a partir de su comida es algo aprovechable para nosotros.
- De la digestión de la fibra salen los ácidos grasos de cadena corta. Mencionaré tres muy importantes:
 - El butirato, principal fuente de energía para las células del intestino. También participa en el metabolismo de la glucosa, y cuando hay células con ADN dañado que pueden volverse malignas, el butirato induce su destrucción.
 - El propionato, que va al hígado, regulando ciertos procesos de generación y almacenamiento de la glucosa, y tiene que ver con el ciclo del hambre y la saciedad.
 - El acetato, que participa en el metabolismo del colesterol, sirve para el crecimiento de otras bacterias y también se cree que tiene que ver con la regulación del apetito.
- Facilita la absorción de minerales, como el calcio, el hierro y el magnesio. Uno puede ingerir mucho calcio, pero si la microbiota está dañada, junto con la falta de ejercicio y vitamina D, poco

absorberemos.

- Genera vitaminas y aminoácidos.
- Interviene en la motilidad intestinal (cómo el intestino se mueve, de acuerdo con los impulsos nerviosos que generan sus propias neuronas –¡sí, el intestino tiene neuronas propias!– e interactúan con la microbiota).

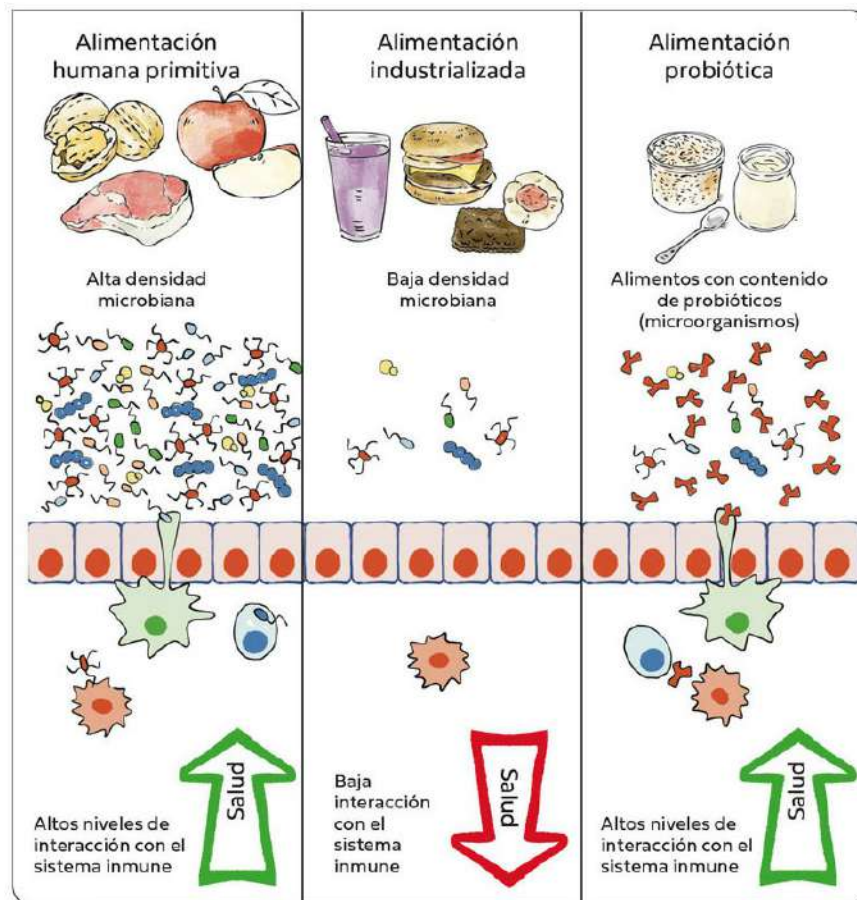
La microbiota también influye en el estado de ánimo y en el comportamiento, porque genera neurotransmisores, es decir, sustancias que actúan con el sistema nervioso interviniendo, por ejemplo, en la tolerancia al dolor o en la percepción del mundo. Podríamos decir que la microbiota seguramente también influye en cómo elegimos pareja: según la microbiota de nuestra piel, tendremos distintos aromas (transpirar no genera olor, son las bacterias las que lo hacen), y nadie reproduciría la especie si no le gusta el olor que tiene esa otra persona...

- ¿Qué tiene que ver lo que comemos con la microbiota? Lo que comemos va a actuar de forma directa en nuestro metabolismo celular, pero también va a actuar sobre la microbiota intestinal, la que más conocemos hoy en día. Al comer ingerimos sustancias que serán metabolizadas por nuestro cuerpo, y otras que serán metabolizadas por la microbiota. La microbiota “come” fibra y de esa digestión genera productos que entre otras cosas contribuyen a la barrera intestinal. Cuando no se consume fibra (legumbres, cereales integrales, frutas, verduras) y se consumen ultraprocesados, la microbiota saludable disminuye y predominan bacterias que producen inflamación. Los ultraprocesados afectan a la microbiota de diversas maneras: su contenido de edulcorantes, su falta de fibra, sus colorantes, sus aromatizantes...

La microbiota se fue haciendo cada vez menos diversa con los cambios de alimentación de la humanidad. De pasar de ser cazadores-recolectores a la agricultura, pero sobre todo, al pasar de los alimentos reales a los industriales, estériles, sanitizados, metidos en un paquete impoluto y todos iguales. Esto genera mayor garantía de inocuidad, sin duda, y menor tasa de enfermedades transmitidas por alimentos, pero también impactan en forma negativa en la diversidad

bacteriana del intestino.

¿Hay que comer alimentos con microorganismos? ¿Existe una determinada cantidad de microorganismos que tenemos que incorporar por día? Estas son preguntas que se está haciendo la ciencia actualmente. Cada vez que comemos un alimento, incorporamos una cierta cantidad de microorganismos. Tomarse un mate, por ejemplo: ¿se pusieron a pensar cuántos gérmenes puede tener la yerba? Convivimos con esos microorganismos, nuestro cuerpo aloja a los que le sirven y ataca a los que no. Los alimentos fermentados podrían ser una opción para mejorar la diversidad de microorganismos de nuestro intestino, consumidos regularmente.



Adaptado de *J Nutr*, Volume 150, Issue 12, December 2020, Pages 3061–3067.
Disponible en: <https://doi.org/10.1093/jn/nxaa323>.

- ¿Cuál es la microbiota más sana? No está aún muy claro, porque se cree que los tipos de microorganismos incluso varían

de forma geográfica (no son los mismos los de personas que viven en China que los que están en personas de México). Sí se plantea la importancia de la diversidad dentro de la microbiota. **En personas con enfermedades crónicas se observó falta de diversidad en su microbiota**, tanto intestinal como en la piel, por ejemplo, de personas con dermatitis atópica.

Se cree que esta pérdida de la diversidad tiene que ver con la falta de contacto con la naturaleza, el aumento de las cesáreas, el sobreuso de la leche de fórmula y los antibióticos, y el consumo de productos ultraprocesados. El hiperhigienismo se cree que también tiene un papel en esto: hace años nos venden productos que matan el 99,9 % de los microorganismos... Y la realidad es que no necesitamos matar todo lo que nos rodea, porque también es parte de nuestro ecosistema. Los jabones antibacteriales, por ejemplo, solo deberían ser usados por las personas que hacen cirugías, y no para lavarse las manos en casa. Sí, estamos en medio de una pandemia donde corren ríos de alcohol en gel, y sin duda, lo necesitamos cuando estamos fuera de casa, pero después, con lavarse con jabón común basta.

Una alimentación sin ultraprocesados, aditivos, edulcorantes, perfumes de cosas que el producto no tiene ni colorantes misteriosos, y rica en fibra, que nuestro intestino no puede digerir pero nuestra microbiota sí, puede ayudar a mantenernos saludables.

Eje intestino-cerebro. ¿Por qué insistimos tanto en cuidar la microbiota?

Los microorganismos están en todos lados, pero sobre todo tenemos conocimiento de los microorganismos que habitan en el intestino, sobre sus funciones e interacciones.

Les pido que recuerden la última vez que comieron muy mal durante días. *Pizza* durante cuatro noches a la semana, por ejemplo. ¿Cómo se sintieron? ¿Qué les pedía el cuerpo? Aunque seamos personas de comer mucha comida chatarra, en algún momento el cuerpo dice “BASTA” y nos pide agua fresca

y alguna fruta. Esa es la microbiota hablando.

El intestino y el cerebro cuentan con casi la misma cantidad de neuronas, que se comunican en forma bidireccional. El cerebro manda información, como por ejemplo cuando estamos estresados y en riesgo (situación de examen que genera ganas de defecar, por dar un ejemplo... fino), y el intestino reacciona. Asimismo, en el intestino se genera el 90 % de la serotonina y dopamina, dos neurotransmisores fundamentales, y la microbiota tiene un papel fundamental en ello. Miren la importancia de evaluar la alimentación cuando hay cuestiones de salud mental a trabajar...

Este eje intestino-cerebro es fundamental para comprender los procesos de salud y enfermedad. Pero hoy por hoy también se habla de eje intestino-pulmón, relacionando la disbiosis intestinal con trastornos respiratorios; eje intestino-piel; o intestino-hueso... Y así infinito, relacionando la microbiota intestinal y sus funciones con la salud global del organismo.

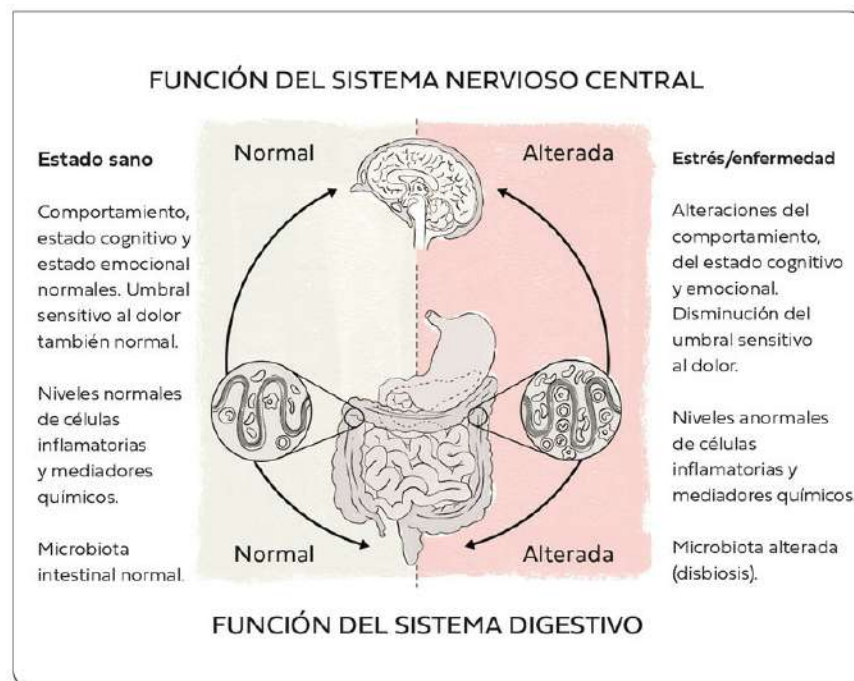


Imagen: Mind-altering microorganisms: the impact of the gut microbiota on brain and behavior. (2012) Oct; 13(10):701-12, Epub 2012 Sep 12, Nat Rev Neurosci. DOI: 10.1038/nrn3346.

Disbiosis, inflamación y permeabilidad intestinal

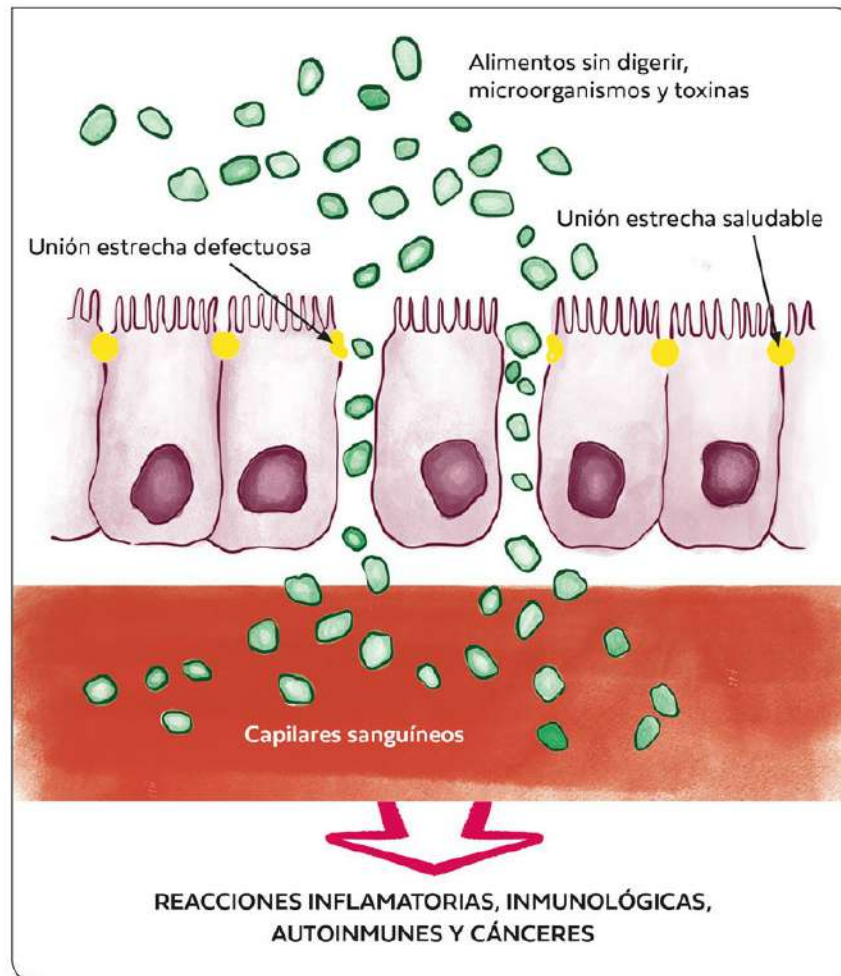
¿Qué pasa cuando hay un desbalance de la microbiota, también llamado disbiosis? **La disbiosis implica un sobrecrecimiento de las bacterias y hongos poco saludables, con una disminución de la diversidad bacteriana.** Se altera la composición, el metabolismo (cómo funciona) y en ocasiones la distribución de la microbiota.

Esto último vemos por ejemplo en el SIBO (en inglés, Small Intestine Bacterial Overgrowth), en el que bacterias que normalmente forman parte del colon, migran hasta el intestino delgado, donde no deberían estar. En el colon, esas bacterias harían cosas importantes y útiles, pero en el intestino delgado, interfieren en la digestión y absorción.

¿Y por qué esas bacterias del intestino grueso migraron al delgado? Porque claramente encontraron allí un lugar apto y feliz para crecer, probablemente porque hubo un cambio en el pH (por ejemplo, por el consumo de un medicamento) o de la movilidad de esa zona (poscirugía, medicaciones, estrés).

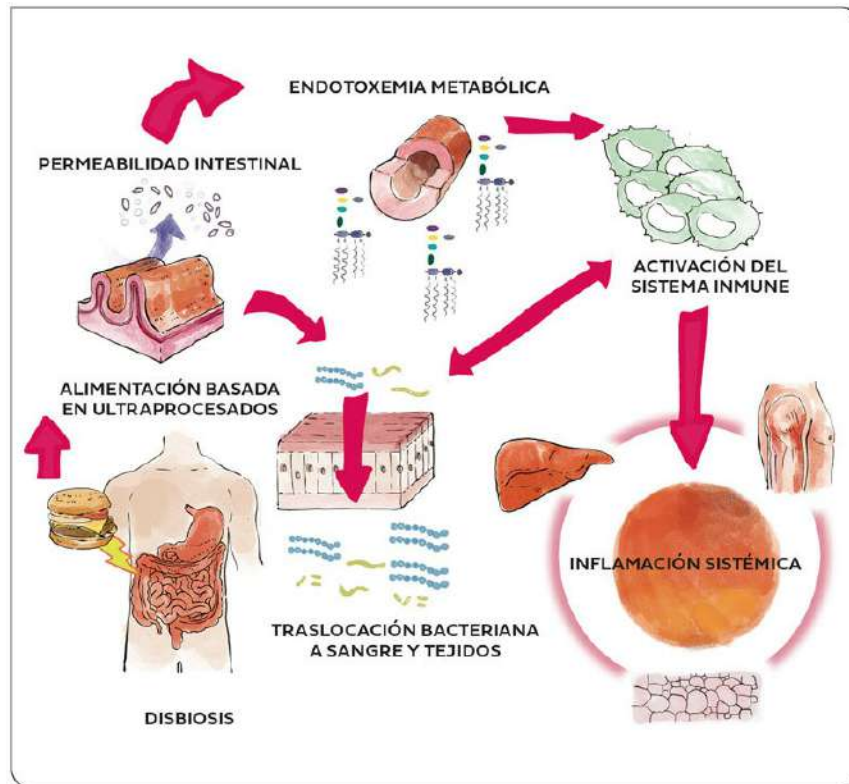
¿Qué síntomas tiene la disbiosis? Muchos y muy inespecíficos: gases, diarrea, dolor abdominal, distensión, rechazo a algunos alimentos, fatiga. Sí, ya sé. ¿Cómo diferenciamos estos síntomas del cansancio del día a día, del trabajo, de la crianza, de vivir en sí? ¿Existen estudios que den diagnóstico de disbiosis? Sí, existen test como el de aire espirado, y también existen algunos estudios de sangre y de materia fecal que no se hacen en todos los laboratorios. ¿Sirven? Colaboran, sí. Pero la sospecha diagnóstica y la confirmación dependen de la observación del profesional, el examen físico y la charla con el consultante, más que de un estudio, y generalmente lo confirmamos con la respuesta a los tratamientos. **¿Los niños y las niñas tienen disbiosis? Mucho más de lo que creemos. La mala alimentación es superfrecuente en pediatría, y los efectos los vemos en múltiples sistemas: digestivo, piel, respiratorio...**

Cuando se produce una disbiosis intestinal, la barrera intestinal se rompe y el intestino se vuelve más vulnerable y permeable. Las uniones entre las células intestinales se vuelven más laxas, y comienzan a pasar a la sangre sustancias no digeridas, toxinas, bacterias y otras sustancias que generan una endotoxemia metabólica. ¿Qué es esto? Un proceso inflamatorio crónico que activa al sistema inmune y genera que todo el cuerpo esté inflamado permanentemente.



Adaptado de: Fasano A. (2020). All disease begins in the (leaky) gut: role of zonulin-mediated gut permeability in the pathogenesis of some chronic inflammatory diseases. F1000Res. Jan 31;9:F1000. Faculty Rev-69. DOI: 10.12688/f1000research.20510.1. PMID: 32051759; PMCID: PMC6996528

Imagínense tener una rodilla inflamada durante muchos meses o años, que duele y que cuesta moverla. Cuanto más tiempo pase así, más difícil será utilizarla. Bueno, es lo mismo en nuestras arterias, en nuestro hígado, en nuestra piel. **Esta inflamación da lugar a enfermedades crónicas inflamatorias, autoinmunes e inclusive predispone al cáncer.**



Fuente: adaptación de Burcelin, R.; Serino, M.; Chabo, C.; Blasco-Baque, V. y Amar, J. (2011).

Enfermedades crónicas “no transmisibles” y microbiota

Según la OMS, el término “enfermedades crónicas no transmisibles” (ECNT, las mencionamos en el capítulo 2, sobre la pandemia de la malnutrición) se refiere a un grupo de enfermedades que no son causadas principalmente por una infección aguda, dan como resultado consecuencias para la salud a largo plazo y con frecuencia crean una necesidad de tratamiento y cuidados también a largo plazo.

Estas enfermedades generalmente tienen mucho que ver con los factores ambientales. El tabaco, por ejemplo, se cobra más de 7,2 millones de vidas al año (si se incluyen los efectos de la exposición al humo ajeno). A la hipertensión se le atribuye el 19 % de las muertes a nivel mundial (sí, mundial, incluso en los países donde la gente muere por falta de agua potable,

también muere por hipertensión).

Sin embargo, **hoy que conocemos el papel de la microbiota en la salud y en las ECNT, y sabiendo que esa microbiota es parcialmente heredable sobre todo en el momento de la colonización intestinal del bebé, se pone en duda el concepto de “no transmisibles”**. Esto nos lleva a poner aún más el foco en el cuidado de la persona gestante, en la planificación del embarazo y en la información brindada a las familias.

Epigenética y concepto DOHaD

Las enfermedades crecen exponencialmente y eso no se puede explicar por los genes. Se plantea hoy que la influencia de esos genes representa solo un 20 % de las causas de las enfermedades. Sin embargo, la expresión de esos genes va cambiando debido a la epigenética. **¿Qué es la epigenética? Es la denominación que se le da a aquellos mecanismos que actúan sobre los genes y generan que algunos se expresen y otros no.**

Todos tenemos los mismos genes, y todos somos diferentes. Esto se debe a las influencias del ambiente que hacen que algunos se “prendan” y otros se “apaguen”. **Los genes tienen la información para dirigir las estructuras y los procesos que forman parte del organismo, pero a la vez, esa información es modulada por procesos ambientales, y sí, ahí tiene acción la microbiota.**

De acuerdo con las bacterias que tengamos en nuestro cuerpo, se “programa” la expresión de nuestros genes, los cuales no solo codifican el color del pelo o de los ojos, como solemos ilustrar, sino que tienen que ver en, por ejemplo, cómo reacciona nuestro páncreas a los alimentos, cómo crecen nuestros músculos, cómo reaccionan nuestros glóbulos blancos a las enfermedades...

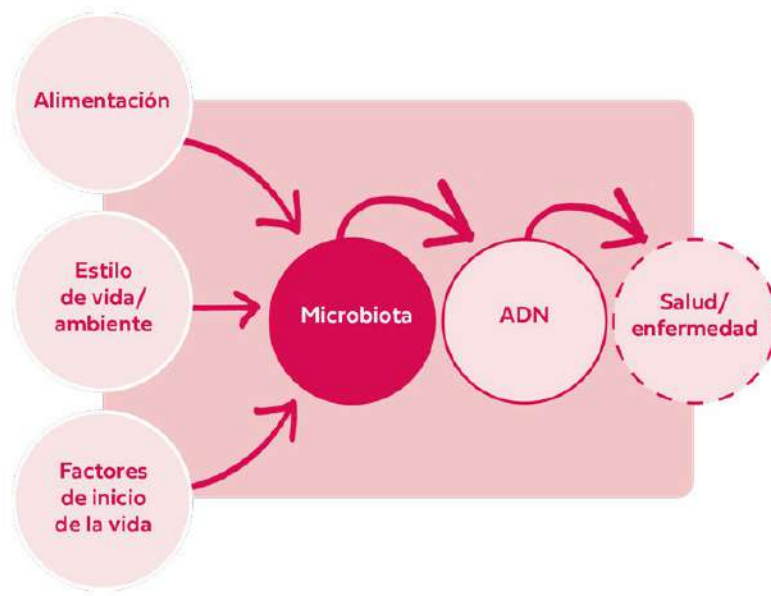
El ejemplo más ilustrativo es el de las abejas. Todas las abejas tienen los mismos genes, pero una de ellas pasa a ser la reina, que es de mayor tamaño, pone huevos y puede vivir durante años. Las otras son obreras, más pequeñas, viven semanas y son estériles. ¿Pero no tienen los mismos genes? Sí, pero a la reina se la alimentó con jalea real desde que era una larva, mientras que el resto de las abejas se alimentó de polen y néctar. Esa jalea real tiene una proteína llamada “royalactina”, que se cree que actúa sobre su genoma y le da

el “fenotipo” de abeja reina, metilando una porción de ADN para “silenciar” un gen. ¿Qué es metilar? Un cambio molecular que sufre una porción de ADN que genera que no pueda ser expresada. La metilación y el enrollamiento del ADN son dos formas de cambios epigenéticos.

Entonces, volviendo, “tener un gen para algo”, es decir, un “genotipo”, o un largo historial de familiares con una enfermedad “x” (alergias, por ejemplo), no es una “condena”, si bien hay condiciones donde los genes tienen un papel muy importante como factor de riesgo. Hay mecanismos epigenéticos que trabajarán sobre esos genes. ¿Conocemos todos esos mecanismos? No. ¿Podemos controlarlos? Tampoco, al menos no por ahora. Pero sí **sabemos que la microbiota actúa en esos cambios epigenéticos, y también sabemos, sobre todo, lo que le hace MAL a esa microbiota. Y así podemos tratar de mejorar nuestra salud y la de nuestra familia.**

El concepto DOHaD (Development Origins of Health and Disease), traducido como “origen de la salud y enfermedad”, justamente describe cómo todos los estímulos ambientales, entre ellos la alimentación, programan en el útero el metabolismo fetal a través de mecanismos epigenéticos, formando los pilares de la salud y la enfermedad a lo largo de la vida.

¿Y si ya pasaron los primeros 1000 días? ¿No hay nada que hacer? Hablar de los primeros 1000 días es algo simplemente estimativo que tiene que ver con promover la prevención, pero no son una barrera temporal para mejorar la salud. Si podemos mejorar nuestra calidad de vida con la alimentación, por ejemplo, a los 30 años, por supuesto podemos hacerlo a los 3. **Los cerebros de las niñas y los niños son muy plásticos, todo el tiempo están aprendiendo cosas nuevas, y armando y desarmando circuitos. Los circuitos que más se usen van a ser los que más se desarrollen: si un niño o una niña está recibiendo todo el tiempo azúcar (que la industria pone en lugares tan inverosímiles como un pan integral o una salsa de tomate), lógicamente su cerebro va a esperar que ese azúcar esté llegando todo el tiempo y va a pedirlo.** Si ese cerebro está expuesto al color, aroma y textura de múltiples alimentos, va a tener que trabajar para comprender qué es eso y cómo asimilarlo. Siempre se puede hacer algo para mejorar la salud. Siempre.



Probióticos, prebióticos, simbióticos, postbióticos y más. Su uso en pediatría

Mucho se está hablando de estos conceptos, y también hay mucha publicidad alrededor. Veamos un poco qué son y para qué sirven.

Probióticos

Los probióticos **son microorganismos vivos que, administrados en cantidades adecuadas, confieren beneficios para la salud del consumidor.** Estos beneficios podrían facilitar la digestión y la absorción de nutrientes, y fortalecer el sistema inmunológico. Para que algo sea caracterizado como probiótico, tiene que cumplir diversas condiciones:

- Que la cepa esté identificada (género/especie/subespecie).
- Que las cepas bacterianas estén caracterizadas *in vitro*.

- Que tengan resistencia al pH gástrico y a la bilis, porque tienen que llegar intactos al intestino para cumplir su función (y esto no es fácil, porque justamente estas sustancias del tubo digestivo tienen una función protectora, ¡imagínense que pasara cualquier microorganismo!).
- Que ensayos *in vivo* e *in vitro* demuestren el/los efecto/s probiótico/s adjudicado/s.
- En cuanto a la seguridad, la cepa probiótica no debe ser riesgosa para la salud, y para esto debe haber muchas pruebas que lo aseguren.

Un probiótico se caracteriza por pertenecer a un género y a una especie, y finalmente, a una cepa específica (por ejemplo, *Lactobacillus rhamnosus* GG). Todo esto se tiene en cuenta para indicar una CANTIDAD adecuada, para una condición de salud específica.

1. ¿Entonces? Escuché que tenía que tomar probióticos para mejorar mi salud.

¿Qué desearías mejorar de tu salud? ¿Cuáles son las cuestiones que preocupan? ¿Cómo es la alimentación? ¿Cómo es la actividad física, el trabajo, el descanso, el cuidado de la salud mental? Antes de ir a tomar “algo”, hay que evaluar todas esas cuestiones y observar si amerita ofrecer un probiótico, y para qué. De otra manera, seguimos buscando la salud inmediata en la farmacia. Los probióticos también pueden no caer necesariamente bien, inclusive en algunas personas generar más distensión abdominal. Por eso es importante el acompañamiento profesional.

2. ¿Qué pasa con el kéfir, la kombucha, el chucrut y los alimentos fermentados? ¿Son probióticos? ¿Mejoran mi salud?

Hace un tiempo estaba en la cola de la verdulería, y una persona charlaba con la verdulera, y le contaba que estaba usando aceite de oliva, que hacía bien al corazón. En la otra mano, tenía una botella de gaseosa. El aceite de oliva es genial, sin duda, pero solo no puede hacerle frente a la agresión para el organismo que representa, por ejemplo, una gaseosa llena de sodio, cafeína, colorantes, edulcorantes y quién sabe qué más. No es un alimento el que nos hace bien, es un conjunto, un hábito, un día a día.

El kéfir, el chucrut, la kombucha y otros, son alimentos fermentados. La fermentación es un proceso históricamente utilizado por el hombre para la preservación de alimentos, y hoy se sabe que estos tienen muchos efectos beneficiosos. No los podemos llamar puntualmente “probióticos”, porque no sabemos qué microorganismos tienen, y si realmente hacen bien a la salud (ya vimos que esas son las características que tiene que cumplir un probiótico para ser llamado así). Traen una carga bacteriana que puede ayudar al intestino, y además contienen postbióticos (ver más adelante).

Hoy por hoy se considera que los alimentos fermentados podrían contribuir a una mayor diversidad de los microorganismos beneficiosos en las dietas, colaborando con el sistema inmunológico y ayudando a metabolizar ciertos alimentos. De hecho, existen trabajos que proponen que justamente el consumo de productos estériles, impolutos, metidos en bolsas y todos iguales, es parte del enorme problema de falta de diversidad bacteriana que tenemos como sociedad.

El problema es querer tomar estos alimentos para “mejorar la salud”, volviendo al concepto de “fármaco-alimento”: algo que queremos consumir y que rápidamente nos sane o nos proteja de la enfermedad. Y eso no existe. Los fermentados pueden ayudar a una salud mejor, de la mano de aumentar el consumo de vegetales y disminuir las carnes y los ultraprocesados. Sin esta segunda parte, es poco lo que pueden hacer por nosotros.

Bueno, entonces, ¿consumimos sí o no fermentados? Sobre todo si los consumimos por placer, claro que sí. A mí me encanta el chucrut y hasta tengo una vasija hermosa de cerámica para fermentar. Pero no lo como por bueno, lo como por rico y porque le da un sabor diferente, ácido, picante a mis comidas. Probemos, investiguemos, juguemos con los alimentos, al igual que los chicos, y conectemos con lo que nos gusta y nos hace bien.

En el capítulo 8, “Pequeño manual BLW ilustrado”, hablo de fermentados en la infancia.

3. ¿Qué pasa con el yogur?

El yogur es un alimento fermentado, y puede contener bacterias probióticas (hay yogures con probióticos agregados). El problema es que se vende en forma de ultraprocesado industrial, con numerosos

saborizantes, perfumes y colorantes, que colaboran al desbalance de la microbiota. Un yogur casero (que nada tiene que ver en sabor y textura con el industrial) podría aportar bacterias útiles, en el marco de una alimentación variada. En niños, podría ser parte de la alimentación después del año aproximadamente, por ser un lácteo (ver el capítulo 7, “Alimentación complementaria: guía práctica”).

4. ¿En qué casos están indicados los probióticos en pediatría?

Hoy por hoy existe evidencia de que los probióticos, de una cepa específica y en una dosificación específica, tienen beneficios en:

- Prevención de enterocolitis necrotizante y sepsis (infección grave) en prematuros, sobre todo si no reciben leche humana.
- Diarrea asociada a antibióticos.
- Diarrea aguda.

Y podrían tener beneficios en:

- Alergias alimentarias y atopías (por ejemplo, dermatitis atópica).
- Cólicos del lactante.
- Prevención de la diarrea intrahospitalaria.
- Enfermedad inflamatoria intestinal.
- Prevención de enfermedades infecciosas respiratorias y gastrointestinales.

Recordemos que la leche humana tiene una enorme cantidad de probióticos. En los bebés que se alimentan con leche humana (no importa la cantidad, ya que en una gota encontramos miles de microorganismos y otros compuestos beneficiosos), el uso de probióticos comerciales de frasco no tendría gran sentido (a menos que haya alguna patología que lo amerite), siendo más económico y saludable para toda la familia enfocarnos en alimentación y hábitos familiares que impactarán en la salud de ese bebé a corto y largo plazo.

Si bien se utilizan probióticos en las leches de fórmula, su uso aún no tiene beneficios comprobados y algunas sociedades científicas no lo sugieren. La preparación de la leche en polvo con agua a 70 grados para garantizar

inocuidad también inactivaría esos probióticos, que podrían tener de todos modos algún beneficio como postbióticos.

Prebióticos

Los prebióticos son el alimento de los microorganismos, o más científicamente, el sustrato que es utilizado selectivamente por microorganismos huéspedes del ser humano y que confiere beneficios para la salud. La comida de la microbiota, en fin.

Los prebióticos:

- a) Deben ser resistentes a la digestión en el intestino delgado.
- b) Ser fermentados por bacterias en el intestino grueso.
- c) Estimular selectivamente la actividad de una o de un número limitado de bacterias en el intestino grueso, lo que conduce a un efecto benéfico.

Los prebióticos comprenden sobre todo a la fibra y a las grasas saludables, especialmente las fuentes de omega 3, omega 6 y omega 9, como los frutos secos y algunos pescados. La fibra nos la venden en paquetitos en la dietética, o agregada a cosas tan inverosímiles como una leche para niños mayores (¿por qué la leche tendría fibra?). Pero es mucho más sencillo: la fibra se encuentra en las frutas, las verduras, las legumbres, los frutos secos y los cereales (sobre todo integrales).

La fibra se divide en fermentable y no fermentable, y las dos son importantes para la salud intestinal, pero puntualmente la fermentable va a actuar como prebiótico y a alimentar a las bacterias saludables.

Las pectinas, los beta-glucanos, el almidón resistente, los mucílagos, los galactooligosacáridos y otros, contenidos en alimentos tan inocentes como la zanahoria, la manzana, la avena, la papa, la banana, los cítricos, las cerezas, los pomelos, el lino, la chía, las legumbres, los cereales y en cientos de otros más del grupo de los “no procesados”, tienen prebióticos que ayudarán a nuestra microbiota. Los prebióticos no se compran en la farmacia: vienen de la tierra.

Para los lactantes, los prebióticos son el tercer ingrediente más importante de la leche humana. Cuando se estudiaba la misma y poco se sabía de microbiota, no se entendía por qué la leche humana tenía tanta cantidad de algo que el bebé no podía absorber. Luego se comprendió que la leche humana le da al bebé tanto las bacterias para poblar su colon como el alimento para que esas bacterias puedan sobrevivir y armar su colonia feliz.

Simbióticos

Los simbióticos **son una combinación de probióticos y prebióticos. La leche humana es un claro ejemplo de simbiótico.** Un producto solo puede ser denominado “simbiótico” si ha demostrado inducir un efecto beneficioso superior al que se obtiene con la suma de los generados separadamente por sus integrantes, porque justamente se estimula con el prebiótico al desarrollo y las funciones de los microorganismos probióticos.

Postbióticos

Los postbióticos se están investigando. Tienen mucho camino para recorrer, con miras de ser el futuro. Son microorganismos no viables (bacterias muertas, o pedacitos de bacterias) y metabolitos de esas bacterias producidos por un proceso fermentativo que, cuando son administrados en cantidades adecuadas, producen un efecto benéfico en el consumidor.

Los postbióticos **no son organismos vivos, sino productos de esos organismos y trocitos de los mismos, que aun así tienen un efecto bioactivo positivo en la persona que los recibe.** Tendrían menor riesgo y menor posibilidad de efectos adversos, y hoy por hoy se utilizan, por ejemplo, en cremas para la dermatitis atópica.

Cuando comemos un pan de masa madre, no comemos los microorganismos probióticos que hicieron la fermentación del pan, porque murieron con el calor, pero sí sus postbióticos.

¿Cómo cuidar la microbiota de nuestra familia?

La información sobre microbiota es abrumadora, y es tentador pensar en que hay cosas para comprar y tomar que van a solucionar todo rápidamente. Pero no, porque **la microbiota no es algo eventual: es un órgano variable, difuso, parcialmente heredable, que tiene impacto en toda la vida.** La salud de la microbiota, de nuestro organismo, de cómo se expresan nuestros genes y de qué le transmitimos a nuestra descendencia, dependerá del estilo de vida, y sabemos que no somos los únicos que tienen que ver con eso.

Las políticas de salud son fundamentales en este camino: ¿cómo se puede sostener la lactancia materna, por más buena que sea, si las licencias de maternidad son paupérrimas? ¿Cómo se prioriza el parto vaginal si la violencia obstétrica está a la orden del día? ¿Cómo se puede mantener una alimentación saludable si los subsidios gubernamentales van para las empresas de ultraprocesados? Todo tiene que ver con todo, y en la misma frase debemos hablar de procesos moleculares, de respeto a las infancias y de políticas de salud.

Entre las acciones que podemos tomar individual y colectivamente para el cuidado de la microbiota, se pueden mencionar:

- **Promover la alimentación saludable de toda la población.**
- **Desalentar el consumo de productos ultraprocesados,** a través tanto de las políticas públicas como del consumo personal.
- **Consumir alimentos reales, basando la alimentación en plantas** (lo cual no implica ser necesariamente vegetariano o vegano, pero sí bajar la cantidad de carnes). Para tomar, preferir el agua y no los jugos llenos de colorantes.
- **Aportar información fehaciente sobre la gestación y el nacimiento, y acompañar decisiones informadas.**
- **Promover, alentar y proteger la lactancia materna.**
- **Promover el contacto piel con piel y el hacer upa a los bebés.**
- **Evitar el uso de jabones antibacteriales en el hogar para la**

higiene habitual.

- **Colaborar con el uso racional de antibióticos y otros fármacos.**
- **Promover el contacto con la naturaleza y el conocimiento de la soberanía alimentaria.** Permitir que los chicos jueguen en el pasto, se ensucien un poco más y tengan contacto con animales.
- **Promover la actividad física y la exposición a la luz solar.** La vitamina D tiene un papel importante en nuestro cuerpo, actuando como hormona y teniendo impacto en la microbiota. El movimiento es fundamental en el desarrollo: ir a la plaza, jugar a saltar, andar en bici, jugar a esconderse debajo de las sillas...
- **Saber que la alimentación siempre va a tener un impacto en la salud,** y que diversas condiciones de salud mental o de neurodesarrollo y comportamiento, como el autismo, presentan habitualmente disbiosis intestinales cuyo abordaje puede ayudar a que esas personas tengan una mejor calidad de vida.

El estudio de la microbiota se encuentra en marcha y avanza a velocidad vertiginosa, pero no paro de pensar en todo lo que falta por descubrir, y que probablemente este texto que están leyendo hoy sea obsoleto en un par de meses o años. Bienvenida la ciencia, aquí estaremos para recibirla.

Para seguir leyendo

PARA FAMILIAS

- Documental *Microbirth*, Alto films, 2014.
- Yong, E. *Yo contengo multitudes*, Penguin Random House, Buenos Aires, 2017.
- Raele, F. D. *Medicina ancestral y epigenética*, Editorial Planeta, Buenos

Aires, 2019.

- Troncoso, L. *Los primeros 1000 días de tu hijo*, Editorial Planeta, Buenos Aires, 2019.
- Blaser, M. J. *SOS microbios. Cómo nuestro abuso de los antibióticos aviva las plagas modernas*, DEBATE, Barcelona, 2019.

PARA PROFESIONALES

- Dawson, S. L.; O'Hely, M.; Jacka, F. N.; Ponsonby, A. L.; Symeonides, C.; Loughman, A.; Collier, F.; Moreno-Betancur, M.; Sly, P.; Burgner, D.; Tang, M. L.; Saffery, R.; Ranganathan, S.; Conlon, M. A.; Harrison, L. C.; Brix, S.; Kristiansen, K.; Vuillermin, P. (2021). Maternal prenatal gut microbiota composition predicts child behaviour. *EBioMedicine*, 68, 103400. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2021.103400>.
- Arrieta, M. C.; Stiemsma, L. T.; Amenyogbe, N.; Brown, E. M.; Finlay, B. (2014). The intestinal microbiome in early life: health and disease. *Front Immunol*, 5:427. DOI: 10.3389/fimmu.2014.00427. PMID: 25250028; PMCID: PMC4155789.
- Sarkar, A.; Yoo, J. Y.; Ozorio Dutra, S. V.; Morgan, K. H.; Groer, M. (2021). The Association between Early-Life Gut Microbiota and Long-Term Health and Diseases. *J Clin Med*, 10(3):459. DOI: 10.3390/jcm10030459.
- Bienenstock, J.; Kunze, W.; Forsythe, P. (2016). The microbiome-gut-brain axis and the consequences of infection and dysbiosis. *Am J Gastroenterol Suppl*, 16; 3: 33-40. Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/310571960_The_Microbiome-Gut-Brain_Axis_and_the_Consequences_of_Infection_and_Dysbiosis
- Carabotti, M.; Scirocco, A.; Maselli, M. A.; Severi, C. (2015). The gut-brain axis: interactions between enteric microbiota, central and enteric nervous systems. *Ann Gastroenterol*, 28: 203-9. Recuperado de: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4367209/>
- Schoeler, M. y Caesar, R. (2019). Dietary lipids, gut microbiota and lipid metabolism. *Reviews in Endocrine and Metabolic Disorders*, 20:461–472. Recuperado de: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31707624/>
- Collado, M. C.; Vinderola, G.; Salminen, S. (2019). Postbiotics: facts and open questions. A position paper on the need for a consensus definition. *Beneficial Microbes*. Recuperado de:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31965850/>

- Fujimura, K. E.; Slusher, N. A.; Cabana, M. D.; Lynch, S. V. (2010). Role of the gut microbiota in defining human health. *Expert Rev Anti Infect Ther*, 8(4):435-54. DOI: 10.1586/eri.10.14.
- Schwarzenberg, S. J.; Georgieff, M. K.; AAP COMMITTEE ON NUTRITION. (2018). Advocacy for Improving Nutrition in the First 1000 Days To Support Childhood Development and Adult Health. *Pediatrics*, 141(2):e20173716. Recuperado de: <https://pediatrics.aappublications.org/content/141/2/e20173716>
- Moreno Villares, J. M.; Collado, M. C.; Leis Trabazo, M. R.; Sáenz de Pipaon, M.; Moreno Aznar, L. A. (2019). Los primeros 1000 días: una oportunidad para reducir la carga de las enfermedades no transmisibles. *Nutr Hosp*, 36 (1): 218-32. Recuperado de: <https://www.nutricionhospitalaria.org/articles/02453/show>
- Organización Mundial de la Salud. (2014). Plan de aplicación integral sobre nutrición materna, del lactante y del niño pequeño. Ginebra. OMS. Recuperado de: <http://www.who.int/nutrition/publications/CIPdocument/es/>
- Álvarez-Calatayud, G.; Leis, R.; Pérez, J.; Boggio, C.; Bodas, A.; Tolín, M.; et ál. *Probióticos en Pediatría*, Marcos A. Editor. Inmunonutrición, 2.^a ed. Panamericana, Madrid, 2019.
- Álvarez-Calatayud, G.; Guarner, F.; Requena, T.; Marcos, A. (2018). Dieta y microbiota. Impacto en la salud. *Nutr Hosp*, 35 (n.º extra 6): 11-5. Recuperado de: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112018001200004
- Houghtheling, P. y Walker, A. (2015). Why is Initial Bacterial Colonization of the Intestine Important to Infants and Childrens Health? *Journal of Pediatrics Gastroenterology and Nutrition*, Vol 60, Number 3, 294-307. Recuperado de: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25313849/>
- Marco, M. L.; Hill, C.; Hutkins, R.; Slavin, J.; Tancredi, D. J.; Merenstein, D.; Sanders, M. E. (2020). Should There Be a Recommended Daily Intake of Microbes? *The Journal of Nutrition*, Volume 150, Issue 12, Pages 3061–3067. DOI: <https://doi.org/10.1093/jn/nxaa323>.
- León-Pedroza, J. I.; González-Tapia, L. A.; Del Olmo-Gil, E.; Castellanos-Rodríguez, D.; Escobedo, G.; González-Chávez, A. (2015). Inflamación sistémica de grado bajo y su relación con el desarrollo de enfermedades metabólicas: de la evidencia molecular a la aplicación clínica. *Cirugía y*

Cirujanos, 83(6), 543–551. DOI:

<https://doi.org/10.1016/j.circir.2015.05.041>.

- Espín, J. B. *Probióticos: luces y sombras*, pág. 191-200. Curso de Actualización Pediatría, AEPap (ed.), Lúa Ediciones 3.0, Madrid, 2018.
- Román Riechmann, E. y Álvarez Calatayud, G. (2013). Empleo de probióticos y prebióticos en pediatría. *Nutrición Hospitalaria*, 28(Supl. 1), 42-45. Recuperado de: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112013000700010&lng=es&tlng=es
- Smith, P. A. (2015). The tantalizing links between gut microbes and the brain. *Nature*, 526(7573):312-4. DOI: 10.1038/526312a. PMID: 26469024.
- Camacho-Cruz, J.; Rusinky Pinilla, L.; Salazar Peña, D.; Sanabria Dueñas, S.; Rojas Carvajal, D.; Burbano Castillo, N.; Ruiz Peña, R.; Palacino Sanz, R.; Martínez Quesada, S.; García Salazar, A.; Abdala Galvis, N. Microbiota intestinal en pediatría. *Repert Med Cir*. DOI: <https://doi.org/10.31260>.
- Experto Universitario en Microbiota en Pediatría y Neonatología. Tech Universidad, 2020.
- I Curso Online de Microbiota y Probióticos. Asociación Civil GENUP, 2020.
- Curso de Actualización Autoadministrado sobre Microbiota. Sociedad Argentina de Pediatría, 2020.
- Curso de Actualización. Nutrición y microbiota. Conceptual Nutrición, 2020.

Desarrollo infantil de la mano de la alimentación

Mamá me cuenta que vio muchas hojitas en su vida.
Dice que hay de colores. Secas. Felices y mustias.
Aterciopeladas, gorditas, en forma de estrella.
Pero yo, mamá, es la primera vez que las veo.
La primera vez que las toco,
que las estrujo,
que hacen ruidito.
Mamá, esta se me enredó en el pelo,
esta rompe rapidito,
esta tiene rico sabor pero se me pegó en la lengua.
Ay, ¿qué es esto en la cara?
Cierto, el viento.
Las hojitas tienen olor a mandarina, a malvón.
Algunas me pinchan un poco.
A esta la miraré fijo un ratito.
¿Qué pasa si la sacudo?
¿O si la golpeo contra otra hojita?
Papá, mirá, es una hojita. ¿No son fascinantes las
hojitas?



El desarrollo infantil es un tema fascinante, del cual se podrían escribir varios libros. Llevo muchos años recopilando información acerca de cómo funciona cada pedacito del cuerpo con relación a la alimentación. Lo que les comparto en este capítulo son algunas nociones básicas sobre el desarrollo vinculado con la alimentación, para que como familia tengan información acerca de por qué existen ciertas sugerencias pediátricas con relación a la misma.

También quise compartirles que hay otras formas de desarrollarse y de comer, porque me parece fundamental que todas las personas estén representadas en este libro. [\(1\)](#)

Desarrollo de la boca y aledaños: el sistema estomatognático

El sistema estomatognático es una región que comprende estructuras del cráneo y de la cara, y que incluye muchas estructuras que forman parte de las funciones de respiración, masticación, deglución y fonación. **Es una zona fundamental en la alimentación**, así que hablaré brevemente de ella y de su desarrollo.



La deglución está presente desde la octava semana de la gestación como un reflejo. Los bebés tragan líquido amniótico, y alrededor de la semana 24, ya tienen reflejo de succión. En las ecografías los podemos ver succionándose el pulgar, los piecitos, el cordón umbilical, practicando para cuando tengan que procurarse su propio alimento.

La lactancia es una incomparable danza en donde deben coordinarse la succión, la respiración y la deglución. Se creía que hasta la semana 32, esa coordinación no era posible (pensando en bebés nacidos antes de término), pero algunos estudios mostraron que inclusive a las 28 semanas, se puede observar un reflejo de búsqueda eficiente y un buen acople al pecho, con asistencia adecuada de los profesionales de la salud.

El bebé lleva al complejo areola-pezones dentro de la boca y lo mantiene en su interior, creándose un sello donde participan la lengua, los labios y las mejillas. La lengua exprime la leche contra el paladar y la lleva hacia la región posterior de la boca con un movimiento ondulante de adelante hacia atrás. El pezón se encuentra bastante posterior, en la unión del paladar duro y blando. Si el pezón está más adelante, es posible que se lastime.

Todos estos movimientos generan un gran aprendizaje en el bebé, y a

medida que van pasando los días, pasa de ser un reflejo a algo aprendido. **Después del nacimiento y en la primera hora después del parto, aparece un gran impulso neuronal de succionar, y por eso luchamos tanto por la importancia de respetar el nacimiento y el contacto ininterrumpido del bebé con su mamá en sus primeras horas. Esa succión es la primera forma de comer, la que dará el puntapié a toda la vida alimentaria.**

No es igual la succión que se genera con un biberón. En el biberón, la leche cae en continuado, y la lengua no “exprime” la tetina, sino que permanece quieta, con un leve movimiento de vaivén, funcionando como una válvula que intenta regular la leche que sale. En los casos en los que las mamaderas más modernas requieren mayor esfuerzo del bebé para tomarlas, implican trabajo de músculos diferentes a los que se utilizan para la teta (para tomar la teta, por ejemplo, los músculos maseteros hacen un gran trabajo, y para la mamadera, sobre todo actúan los músculos buccinadores). **Si las mamaderas o los chupetes son ofrecidos a bebés muy pequeños, se corre el riesgo de que el bebé “aprenda” a tomar leche del biberón y luego le cueste recordar la forma en la que lo hacía con la teta.** Esto se llama “confusión tetina-pezón” y es la razón por la cual no se sugieren chupetes ni biberones durante el primer mes de vida o hasta que la lactancia esté establecida. Si es necesario suplementar a un bebé por alguna razón de salud, se le puede ofrecer leche en cucharita, vasito o relactador.

¿Qué pasa con el chupete?

¡El chupete! Es un objeto de estudio fascinante, sobre todo cuando la gente dice que el bebé “usa la teta de chupete” (siendo el chupete un objeto creado en la modernidad... y la teta ya sabemos). El chupete ha sido relacionado con la prevención de la muerte súbita durante el sueño, aunque hoy por hoy sabemos que la mayor protección se da con la lactancia materna a demanda.

Invité a Verónica Barreyro, odontopediatra y docente del posgrado de Odontopediatría de la Universidad Maimónides (MN 29 872) a contarnos un poco más acerca de los chupetes:

Hoy en día, gracias a la ciencia, se sabe que no es necesario el uso de chupete, ya que el mismo se asocia a alteraciones en la

cavidad bucal que van a repercutir no solo en las formación y desarrollo de las estructuras que la componen, sino además en la deglución, fonación y respiración.

La Sociedad Argentina de Pediatría recomienda su uso luego del mes de vida o cuando la lactancia se encuentra bien instaurada. Si bien no hay consenso entre los diferentes artículos científicos sobre cuál es la tetina menos perjudicial, aparentemente la fisiológica (aquella que es aplanada con ambos lados iguales) sería la más recomendable por sobre la anatómica (aplanada de un lado y redondeada del otro, con una ligera curvatura), en lo que sí coinciden todos es en que la tetina redonda o con forma de cereza es la que mayor cantidad de alteraciones trae aparejadas.

Debemos tener en cuenta que la tetina sea flexible, con el cuello o puente (unión de la tetina con el escudo) lo más fino y largo posible, ya que esto va a hacer que los labios puedan estar más en contacto y, por ende, la boca más próxima al cierre.

A la hora de elegir el material, siempre optar por silicona libre de bisfenol A (BPA) por sobre los de látex. El látex se deteriora mucho más rápido y corremos el riesgo de una sensibilización temprana al mismo, que con el tiempo puede terminar provocando una alergia.

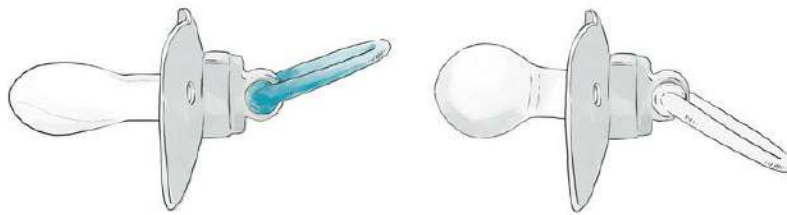
El escudo debe poseer orificios para aireación para que la piel pueda respirar y, en lo posible, tener cierta flexibilidad para que en caso de accidente no provoque lesiones en la cara.

En cuanto a la arandela o argolla, hay muchos modelos que ya no la traen incorporada, ¡y eso está genial! ¿Por qué? Y la respuesta es nada más y nada menos que para que no lo tengan colgado y a libre disponibilidad durante el día. El chupete debería ser ofrecido en el momento de necesidad del bebé. Para minimizar el riesgo de las posibles alteraciones por el uso del chupete, son los adultos quienes deben gestionar su uso.

No debe venir con ningún aditamento o accesorio adosado del estilo peluche o muñeco que sume peso al mismo, ya que eso también va a influir en la posible alteración de la boca.

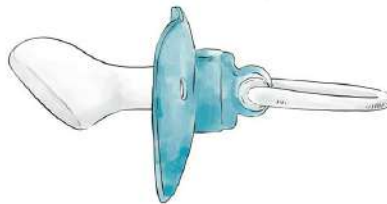
No hace falta cambiar el talle del chupete, excepto en caso de que el escudo quede pequeño.

No hay mejor chupete, sino menos malo.



En algunas situaciones, el chupete nos puede servir como herramienta terapéutica: por ejemplo, estimular la succión en bebés prematuros, o como un estímulo calmante durante un procedimiento doloroso (por ejemplo, una vacuna) cuando no se cuenta con el pecho materno. Algunos bebés tienen mucha necesidad de succión, y el chupete, siempre que no se ofrezca para dilatar un pedido de alimento o contacto, puede ser una opción.

Si bien el chupete se ha relacionado con la prevención de la muerte súbita del lactante, es importante recordar que el factor más importante para evitar la misma es la lactancia materna a demanda. Si el chupete termina complicando una lactancia deseada, no es negocio.



EL CUIDADO DE LA BOCA

El cuidado de la boca es imprescindible para su desarrollo.

Antiguamente, los pediatras decíamos que no había que cepillar los

dientes hasta los 3 años, ¡una locura! ¡Imagínense un diente sin lavar durante tres años! Hoy sabemos que los dientes se higienizan desde el primero que sale, y la consulta odontológica es fundamental en el embarazo, período neonatal y ante la erupción del primer dientito.

¿Se puede ir al odontopediatra aun si no tiene dientes? ¡Sí! Nos ayudará a prevenir y nos dará información acerca del inicio de la higiene bucal. Antes de que salga el primer diente, se puede higienizar las encías del bebé al menos una vez por día con una gasa húmeda o un dedal de silicona, más si consume leche de fórmula o ya inició la alimentación complementaria. Esto alivia y estimula las encías, y va generando el hábito de la limpieza.

Una vez erupcionado el primer diente, podemos comenzar a cepillarlo con un cepillo pequeño apenas manchado con pasta de dientes con flúor (1100 a 1400 ppm de flúor). Allí podemos pedir una consulta con el odontopediatra para que vaya evaluando la higiene y la salida de los dientes. Si está todo bien, posteriormente se realizará un control cada 6 meses-1 año.

Es importante el uso del hilo dental en cuanto dos piezas estén en contacto, y levantar SIEMPRE el labio superior al lavar. ¡Los mapadres deben repasar el lavado hasta al menos los 8 años!

La alimentación saludable es fundamental para el mantenimiento de una boca sana. Algunas recomendaciones: es importante mantener una alimentación baja en azúcares refinados y productos industrializados, y lavar los dientes inmediatamente después de haberlos consumido. No dormir con la mamadera en la boca, dado que aumenta el riesgo de otitis, y las leches de fórmula tienen alto contenido de azúcar. No hay estudios serios que relacionen la lactancia más allá del año con aumento del riesgo de caries. Evitar los jugos en general: jugos, gaseosas, “leches” vegetales compradas y demases, tienen muchííííísimas azúcar y varios edulcorantes, también dañinos.

Movimientos masticatorios

La masticación no es innata, sino que es una actividad motora, sensorial y oral adquirida. Se inicia cuando los bebés se empiezan a llevar las manos a la boca, y continúa cuando empiezan a agarrar objetos como juguetes, trapitos y mordillos con diferentes formas y texturas. ¡Esos estímulos preparan la cavidad oral para la aceptación de los alimentos!

Existe, hasta alrededor de los 4-5 meses, el llamado “reflejo de extrusión”. Cuando tocamos la punta de la lengua de un bebé de 2 o 3 meses, la lengua sale. Este es **un reflejo que le permite a los bebés “capturar” la teta desde el inicio de la lactancia, y va desapareciendo a medida que pasan los meses.** Cuando se indicaba alimentación complementaria desde los 3-4 meses, era común que los bebés empujaran la cuchara con la lengua. Esto solía ser interpretado como “no le gusta” o “no quiere comer”. Inclusive he escuchado a profesionales recomendar empujar la lengua hacia abajo con la cuchara y “tirar” la papilla en la parte de atrás de la boca para obligar a comer. ¡No, no y no, por favor! Esto puede generar consecuencias muy terribles con relación a la alimentación, vinculándola a un acto de obligación y desagrado, inclusive de náusea.

Hoy por hoy, que sugerimos empezar la alimentación complementaria recién a los 6 meses, casi no tenemos que preocuparnos por el reflejo de extrusión.

- “¿Cómo me doy cuenta si mi bebé tiene o no reflejo de extrusión?”. Si el bebé se lleva objetos a la boca y los explora con la misma, está dejando de sacarlos “para afuera”, y está perdiendo este reflejo.
- “Mi bebé se mete mucha comida en la boca y la escupe. ¿Tiene reflejo de extrusión?”. No, si tuviera reflejo de extrusión, no podría meterse la comida en la boca directamente. Es común que los bebés que inician la alimentación complementaria se metan mucha comida en la boca, y cuando inteligentemente ven que no la pueden tragar, la escupen. Esto se puede mantener por un tiempo, inclusive nos sucede en ocasiones a los adultos. Si llenarse la boca de comida es algo común en el bebé y persiste a través de los meses, sería bueno consultar, dado que tiene

que ver también con la experiencia sensorial de la presión y textura sobre la boca, y a veces necesitamos la mirada de una especialista en terapia ocupacional.

Entre los 4 y 6 meses, los bebés aprenden a hacer movimientos masticatorios verticales, trabajando mucho la lengua en la formación del bolo alimenticio para tragarlo, una vez que inicia la alimentación complementaria.

Alrededor de los 8 meses, la lengua empieza a hacer movimientos laterales, mejorando la capacidad de gestionar alimentos más sólidos.

¿Podemos ayudar a los bebés en esto? ¡Sí, claro! Justamente ofreciéndoles texturas variadas: el aprendizaje va de la mano de la experiencia. Las características de los alimentos como sabores, texturas y aromas proporcionan y colaboran con el desarrollo de la masticación, que madura en respuesta a esa diversidad. El cerebro percibe diferentes sensaciones y crea nuevas estrategias para gestionarlas.

Las primeras semanas de masticación no son muy eficientes: por eso siempre insistimos en comenzar a ofrecer texturas suaves y sencillas. Un brócoli al vapor, una palta madurita, un puré de legumbres. No hay apuro, con las semanas, los movimientos se empiezan a coordinar y vamos a ir aumentando las texturas.

- “¿Puede empezar la alimentación complementaria si no tiene dientes?”. Sí, claro que sí. Los bebés inician el aprendizaje de la masticación con sus encías, y de a poco empiezan a erupcionar los dientes. ¡Inclusive hay bebés que no tienen dientes hasta los 13-18 meses! Ofrecer diferentes texturas más allá de la papilla también ayuda a que salgan los dientes, porque masticar algo más sólido genera que el tejido de las encías se vaya afinando y a los dientes les cueste menos salir.
- “Le están saliendo los dientes y no quiere comer”. Es muy común que la salida de los dientes les genere molestias a los bebés, babeen más y estén algo irritables. Esos días a veces no tienen ganas de jugar con la comida y solo quieren upa. Es normal y sano, y ningún bebé fue hospitalizado nunca por la salida de

los dientes. Son algunos días y pasa. Se pueden ofrecer helados de leche humana o fórmula, algún helado de frutas si ya tiene más de 6 meses, mordillos fríos, cosas para morder... y paciencia. No se recomiendan los geles anestésicos porque generan riesgo de asfixia con la propia saliva y riesgo de metahemoglobinemia, una patología en la que la sangre no puede darle oxígeno a los tejidos.

Para aprender a masticar es importante la postura plena del bebé, como ya hemos visto cuando hablamos de desarrollo motor. Estar sentado en un *bebesit* a 45 grados de inclinación o en un cochecito, o no tener apoyo para los pies, puede en algunos niños generar dificultades en el aprendizaje del masticar.

Entre los 8 meses y los 2 años va aumentando la eficiencia en el masticar, vemos mejor manejo de los alimentos y menos arcadas y toses. Sin embargo, la masticación sigue desarrollándose en conjunto con el resto del organismo, por lo que, por ejemplo, no se sugiere ofrecer frutos secos enteros hasta al menos los 4-5 años.

Importancia de las texturas

Dice la Organización Panamericana de la Salud:

Los alimentos complementarios deben ser lo suficientemente espesos para mantenerse en la cuchara y que no se escurran hacia fuera. Generalmente, los alimentos que son más espesos o más sólidos tienen mayor densidad de energía y nutrientes que los alimentos aguados o muy blandos. Cuando el niño come alimentos espesos o sólidos, resulta más fácil darle mayor suministro de kcal e incluir una variedad de ingredientes ricos en nutrientes, como alimentos de origen animal. Existen pruebas sobre la presencia de una “ventana crítica” para incorporar alimentos “grumosos” (con pedazos de alimentos): si estos son administrados más allá de los 10 meses de edad, se puede incrementar el riesgo posterior de sufrir problemas de

alimentación. Si bien el continuar con alimentos semisólidos puede ahorrar tiempo, es importante para el crecimiento óptimo del niño que la consistencia de los alimentos se incremente de manera gradual y con la edad.

Es sumamente importante ofrecer diferentes texturas para que su cerebro pueda percibirlas y aprender, de a poco, a manejarlas. **No hay problema en iniciar la alimentación complementaria con papillas si eso es lo que más nos convence como familia, pero a los 10 meses, tanto los bebés que iniciaron con papillas como los que hicieron BLW, deben estar comiendo lo mismo.** Para más info sobre cómo progresar las texturas, te invito a pasar por la guía práctica para la alimentación complementaria del capítulo 7.

Reflejo de náusea

Algo que nos asusta muchísimo en el inicio de la alimentación complementaria son las arcadas y toses. ¿Se va a ahogar? ¿No le gusta? ¿Pone esas caras porque le parece horrible?

Las arcadas y toses son esperables y son una muestra de que la vía aérea se sabe defender. Los bebés se atragantan y tosen con leche humana, se atragantan y tosen con papillas, se atragantan y tosen haciendo BLW. Es decir, aprender a alimentarse incluye tropiezos, al igual que aprender a caminar.

Sin embargo, hay un dato fundamental que nos puede ayudar con el miedo a las arcadas.

Los adultos tenemos el reflejo de náusea muy posterior, llegando a la zona de la úvula (la “campanita” de la garganta). Cuando un trozo de comida llega a esa zona sin ser digerido por nuestra boca, se prende una alarma: “¡La vía aérea está en peligro!”, le dicen los nervios al cerebro. Entonces, el cerebro manda impulsos nerviosos diciendo: “¡Bueno, chicos, entonces saquen eso de ahí!”. Y aparece la arcada y la tos.

El cuerpo es tan sabio, que en los bebés, ese reflejo está mucho más adelante en la boca. **Cuando hacen una arcada, no es porque el trozo de comida llegó al fooooondo de la garganta, sino que está más adelante,**

cerca de los labios, y por las dudas, el cerebro decide sacarlo para afuera. A medida que el bebé va creciendo, ese reflejo se va haciendo cada vez más posterior. Fascinante, ¿no?

La mamadera

La mamadera, o biberón, tal como la conocemos, es un invento del siglo XIX. En un principio, se usaban vejigas de animales para la tetina. Claro que en esa época no se tenía muy claro el tema de la higiene... por lo que además, terminaba siendo una causa directa de muerte y enfermedad infantil.

Muchos niños y niñas transcurren sus primeros años comiendo comidas procesadas o utilizando la mamadera por largo tiempo. **El uso prolongado de la mamadera se asocia a problemas en la masticación, en la respiración (mayor riesgo de ser respiradores bucales, por ejemplo), y genera mayor riesgo de otitis media y de presentar caries tempranamente.** Uno de los principales problemas del biberón es que el paladar y la boca se van “moldeando” alrededor de esa estructura rígida que es la tetina. Esto no pasa con la teta: la teta se adapta a la boca, en cambio la boca se adapta a la tetina.

La mamadera no debería ser un lugar de ofrecimiento de agua, jugos, gaseosas, cereales ni nada que no sea leche. ¿Y cómo se ofrece el agua cuando inician la alimentación complementaria? En vaso, como veremos en el capítulo 7.

En los niños que toman leche en mamadera, a partir del año es aconsejable ir transicionando al vasito. ¿De golpe? No, claro que no. **Retirar la mamadera bruscamente puede ser angustiante para el niño, por eso es importante, como adultos, estar conscientes de la importancia de realizar esta transición pero también de acompañar los tiempos necesarios.**

Muchas familias me cuentan que la mamadera es un objeto de apego, relacionado con el sueño y con estar a upa de mamá o papá. Retirar la mamadera es un destete, y no suele ser sencillo. Pero hay algo que es fundamental: a nuestras hijas y nuestros hijos no les gusta especialmente ni la mamadera ni la teta, les gusta estar con nosotros. Les gusta que los pongamos cerca de nuestro cuerpo y los arrullemos, y esperemos con paciencia su sueño, ya sea dándoles la teta o el biberón. Cuando se inicia un proceso de

destete, ya sea de teta o de mamadera, habrá momentos complejos en los que tendremos que aprender que hay infinitas formas de dar amor además de esa.

- “Mi hijo no toma leche si se la pongo en vaso, pero en la mamadera se la toma toda”. Bueno, de allí la importancia de saber que la leche de vaca no es algo fundamental en la alimentación, y que no importa si no se la toma, siempre que ofrezcamos alimentos variados y saludables. Tomar el vaso de leche como algo imprescindible es algo simplemente cultural. No amerita continuar usando mamadera, con todos los riesgos que esta ofrece, solo por ofrecer leche.

Consejos para la transición de mamadera a vaso

- **Presentar vasito que sea liviano y fácil de manipular.** Hay muchos vasos en el mercado que son aparatosos y con múltiples chirimbolos: complican más de lo que ayudan. Más sencillo, mejor.
- **Explicarle claramente el porqué iniciamos ese proceso a los niños y las niñas.** Que sabemos que le gusta mucho la mamadera pero que le va a hacer mal a los dientitos y que es importante ir diciéndole adiós.
- **¿Con tapa o sin tapa?** Como quieran. Puede ser más sencillo tener un vasito con tapa que uno abierto en las primeras manipulaciones. Si es verano y es fácil que se seque la ropa, podemos ofrecer sin tapa y jugar con el agua. Idealmente, ofrecer un vaso común desde el inicio de la alimentación complementaria.
- **¿Con sorbete o sin sorbete?** De nuevo, como quieran. Un bebé que utiliza mamadera y está en transición puede aceptar un vasito con sorbete más fácilmente.
- **Las tomas nocturnas suelen ser las más difíciles de cambiar.** Mejor empezar con una toma, por ejemplo, la del almuerzo, y en vez de ofrecerla en mamadera, ofrecerla en vaso.
- **Paciencia, mucha paciencia.** El proceso puede durar semanas; de hecho, es muy similar a un destete. Evitar los retos y la angustia.

Tiempo al tiempo.

Desarrollo intestinal

El intestino de los bebés ha estado trabajando en el tiempo intrauterino. El bebé traga líquido amniótico, que es filtrado en los riñones, y el intestino no tiene una gran movilidad. Pero a las pocas horas del nacimiento, nos encontramos con la primera caca, ¡el meconio! Esta caca es negra y muy pegajosa. A medida que van pasando los días, la caca va adquiriendo el color mostaza usual de los bebés pequeños.

El intestino del recién nacido es bastante permeable, es decir, que las uniones entre las células que lo conforman no son tan estrechas como en los adultos. Esto hace que el bebé sea más susceptible a infecciones: las bacterias podrían pasar por esos agujeros entre las células directo a la sangre. Sin embargo, existe un mecanismo fundamental de protección: la lactancia. **La leche humana, empezando por el calostro, tiene diversas sustancias que estimulan al intestino a ir madurando**, y además aporta células madre que se cree que ayudan a “emparchar” esos agujeros: **la pared intestinal va madurando al mismo tiempo que se va estableciendo la microbiota.**

La motilidad es la capacidad del sistema digestivo de contraerse y relajarse, y de esa manera ir llevando la comida desde la boca hasta el ano. La motilidad del intestino del recién nacido es mucho menor a la del adulto, y es una de las causas por las que es tan común que los bebés tengan reflujo gastroesofágico fisiológico: el estómago se vacía más lento de lo que hará más adelante.

EL REFLUJO GASTROESOFÁGICO

El reflujo gastroesofágico es definido como el pasaje del contenido del estómago hacia el esófago, llegando inclusive a la boca. En los bebés, esto es sumamente común, y se pueden definir dos situaciones diferentes:

- **Reflujo gastroesofágico fisiológico:** son los llamados “vomitadores felices”. Estos bebés suelen regurgitar o vomitar varias veces al día, no ocurriendo esto durante el sueño. Los vómitos no se asocian a otros síntomas, son bebés que crecen bien, aumentan de peso y están de buen humor aunque recién hayan vomitado. Esto habla de un reflujo fisiológico, que suele resolverse solo entre los 6 y 18 meses. No necesitan medicación ni ningún tratamiento específico.
- **Reflujo gastroesofágico patológico o enfermedad por reflujo gastroesofágico:** estos bebés también tienen reflujo, pero encontramos otros síntomas asociados. Entre ellos podemos encontrar pérdida o escasa ganancia de peso, broncoespasmos a repetición, estridor laríngeo (llanto que se escucha muy agudo), arqueamiento hacia atrás constante (también llamado síndrome de Sandifer), episodios de apneas, anemia y otros síntomas.

Ante la sospecha de un reflujo gastroesofágico patológico, el pediatra debe evaluar si, según los síntomas (que como vemos, son variados), corresponden estudios como la seriada esófagogastroduodenal (SEGD) y la pHmetría. En algunos casos con síntomas claros, se evalúa también comenzar tratamiento farmacológico empírico y observar la evolución, comprendiendo siempre que la medicación podría tener impacto en la microbiota y evaluar el riesgo-beneficio. Siempre se requiere la derivación con gastroenterología infantil y la evaluación de posibles alergias alimentarias.

Antes, o junto con el tratamiento farmacológico, se indican medidas higiénico-posturales, por ejemplo, no acostar al bebé enseguida después de haber tomado la leche, elevar la cabecera de la cama a 30° y evaluar qué volumen de leche se le está aportando, si este se alimenta solo con fórmula. La lactancia materna siempre es un factor protector y no se indica su suspensión, ni su reemplazo por fórmulas antirreflujo o deslactosadas. Adelantar la alimentación complementaria por la presencia de reflujo no es una práctica avalada por la bibliografía.

Alrededor de los 4 a 6 meses, esa motilidad mejora, y aumenta la contractilidad (la capacidad de contraerse para llevar el bolo alimenticio) y el estómago se vacía más eficientemente. Una razón más para evitar la alimentación complementaria temprana: si el estómago aún tiene que aprender a vaciarse de leche, imagínense si le agregáramos otros alimentos... Realmente no estaría preparado para recibirlos.

Las enzimas (proteínas que trabajan en la digestión de los alimentos) vienen de diferentes lugares del sistema digestivo: hay en la boca, en el estómago, en el hígado, en el páncreas. Inclusive la leche humana envía sus propias enzimas: en la leche encontramos los lípidos (grasas) y la lipasa, la enzima o tijera que la propia leche tiene para asegurarse de que ese lípido se corte y sea posible absorberlo. Muchas de las enzimas de un recién nacido funcionan “a media máquina”, y van aumentando su cantidad y calidad a medida que el intestino va creciendo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que **antes de al menos los 6 meses, el intestino NO está preparado para digerir otras cosas que no sea leche, y si estas se incorporan, no le generarían ningún beneficio al mismo.** El estómago, por ejemplo, es menos ácido que el estómago del adulto, y esta “hipoacidez” lo vuelve más vulnerable: si ingresan bacterias dañinas, serán más difíciles de frenar porque no alcanza el ácido para destruirlas.

A partir de los 6 meses, las enzimas gastrointestinales sufren un desarrollo muy veloz, al que también ayudan los alimentos ofrecidos, dado que estimulan la secreción de esas enzimas.

Si esperamos mínimo a los 6 meses para iniciar la alimentación complementaria, los bebés serán capaces de digerir incluso legumbres y otros tipos de alimentos con fibra, dado que las enzimas y la motilidad gastrointestinal están preparadas para ello. Llegando al año, las enzimas son muy similares a las del adulto, y la microbiota sigue desarrollándose, como explicamos en el respectivo capítulo.

Antes de los 6 meses, según las investigaciones con las que contamos al momento de escribir este libro, no se sugiere indicar ningún alimento más allá de la leche humana o la fórmula. **Sociedades científicas como la Asociación Española de Pediatría o la Sociedad Argentina de Pediatría advierten que la introducción de alimentos que no sean leche humana o de fórmula, o como ultimísima opción leche de vaca diluida, pueden generar mayor riesgo de alergias alimentarias y disbiosis, interferir con la absorción del hierro y del zinc, y aumentar la posibilidad de**

infecciones gastrointestinales y respiratorias.

¡Tiempo al tiempo! Los bebés tienen toda una vida para comer, no apuremos el asunto por ansiedad de los adultos.

Desarrollo renal

Los riñones son órganos que filtran la sangre constantemente, excretando sus sustancias de desecho. No solo hacen eso, sino que se encargan de múltiples funciones de balance del cuerpo sobre sustancias como el sodio, el potasio, el calcio y muchas más. Además, participan en el metabolismo de la vitamina D, en el control de la presión arterial y en la formación de glóbulos rojos.

El trabajo de los riñones empieza dentro del útero, filtrando la sangre del bebé y generando orina que va a formar parte del líquido amniótico. Cuando hay poco líquido amniótico, una de las cosas a las que hay que prestar atención es al desarrollo renal fetal. Los riñones se siguen desarrollando hasta la semana 35 aproximadamente, independientemente de que el bebé haya nacido o no. Es por esto que los riñones de los bebés prematuros aún son más inmaduros y requieren más control.

En los bebés nacidos a término, la filtración es de un 25 % con respecto al valor del adulto, porcentaje que se duplica entre los 2 y 3 meses de edad.

Recién a los 6 meses, los riñones alcanzan un funcionamiento de alrededor del 80 % de la función adulta. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de esa edad, no están preparados para filtrar una carga de proteínas, sodio, calcio, potasio y otros componentes que contienen los alimentos. Un alimento, aunque no tenga sal agregada, contiene sodio. La leche humana, por ejemplo, tiene 16 mg de sodio cada 100 ml, y la leche de vaca tiene 95 mg de sodio cada 100 ml, una de las tantas razones por las que no se sugiere leche de vaca hasta mínimo el año de vida. Si los riñones del bebé están sobrecargados, les costará más mantener el equilibrio en el cuerpo, y sobre todo en bebés muy pequeños puede ser peligroso.

Alrededor del año de vida, los riñones tienen una función similar a la de los adultos y pueden tolerar mejor diferentes concentraciones de sustancias que se encuentran en los alimentos.

Desarrollo inmunológico

Los bebés reciben, en la vida intrauterina, anticuerpos por parte de su mamá. Estos anticuerpos se van destruyendo en los primeros seis meses, es decir, tienen una vida útil corta. Durante esos meses, el bebé va recogiendo estímulos inmunológicos de su ambiente, entra en contacto con miles de bacterias y otros microorganismos que lo estimulan a formar sus propios anticuerpos. Además, gracias a la tecnología actual, recibe vacunas que lo empiezan a proteger de enfermedades graves.

Los bebés amamantados también reciben anticuerpos, células de la inmunidad, factores de crecimiento, células madre y bacterias buenas a través de la leche humana.

Además de todo esto, el intestino tienen sus propios “focos” de células de la inmunidad, y estas células también producen anticuerpos, sobre todo del tipo IgA. **Esta inmunidad propia del intestino empieza a ser más eficiente alrededor de los 4 a 6 meses, y se vuelve más estable alrededor de los 3 años.**

Introducir alimentos por fuera de la leche humana durante los primeros seis meses puede ser peligroso a nivel inmunológico: en cada alimento conviven muchas bacterias, y eso está bien y hasta es saludable, pero innecesario para bebés pequeños. La leche de fórmula en polvo, como ya hablamos en el capítulo 3 sobre lactancia, no es estéril y es importante prepararla correctamente.

¿Debo darle hierro y vitaminas a mi hijo/a?

Hierro

En Argentina es muy muy alta la cantidad de personas –niños o niñas, adolescentes e inclusive adultos– que tienen anemia ferropénica, es decir que por falta de hierro, sus glóbulos rojos no son capaces de llevar correctamente la sangre a los tejidos.

Para paliar esta situación, desde los organismos oficiales de salud pública

se decidió, además de promover el consumo de alimentos ricos en hierro y fortificar la harina de trigo con el mismo, indicar suplemento de hierro a todos los bebés.

Sin embargo, en 2017, la Sociedad Argentina de Pediatría publicó un consenso donde sugería ofrecer el suplemento solo a los bebés con riesgo de tener anemia ferropénica. Estos grupos de riesgo son:

- Bebés prematuros, porque no llegaron a llenar los depósitos de hierro en la vida intrauterina.
- Bebés gemelares.
- Bebés que tuvieron alguna hemorragia en el período neonatal.
- Bebés con bajo peso de nacimiento.
- Niños de término alimentados con leche de vaca sin fortificación (recordemos que la leche de vaca tiene un pobre contenido de hierro, genera microhemorragias intestinales y dificulta la absorción de hierro de los alimentos).
- Niños de término alimentados a pecho que reciben alimentación complementaria inadecuada con bajo contenido de hierro: este es el quid de la cuestión. Si los primeros meses de alimentación complementaria los transitamos a zapallo y palta, y nada más, el hierro va a faltar y será una indicación de suplementación. Por eso la importancia absoluta de jerarquizar alimentos con alto contenido de hierro.
- Niños con patologías que impliquen malabsorción o pérdida crónica de hierro.
- Adolescentes con pérdidas menstruales excesivas.
- Adolescentes embarazadas.

A estos grupos hay que sumarles indicaciones individuales, por ejemplo, madres que estuvieron muy anémicas en el embarazo. **Es muy importante comprender que la anemia ferropénica se puede prevenir, idealmente antes de cursar el embarazo. Otro punto fundamental es el corte oportuno del cordón umbilical.** El cordón umbilical tarda de uno a tres minutos en dejar de latir (aunque idealmente, si fuéramos menos intervencionistas, ni haría falta usar un reloj...) y durante el tiempo que sigue latiendo, continúa bombeando sangre al bebé, que así aumenta sus depósitos de hierro corporal en, aproximadamente, un 30 %.

Luego del nacimiento, la leche humana es la mejor fuente de hierro, que es el que mejor se absorbe. Siempre la priorizaremos por encima de otras fuentes.

¿Por qué no se piden análisis de sangre antes de dar suplemento de hierro?

Porque es justamente preventivo, no es tratamiento. Suponemos que los depósitos de hierro de esa persona están bien y buscamos mantenerlos así. Si se requiriera tratamiento, la dosis de hierro sería diferente.

¿Cuándo se empieza a dar el suplemento de hierro?

Depende. A los bebés prematuros o de bajo peso, desde el primer mes. Luego las recomendaciones varían entre los 2 y los 6 meses para iniciar. Suele indicarse hasta los 12-18 meses, dependiendo de cada bebé.

Vitaminas

Vitamina D

Existe consenso en que el suplemento de vitamina D sería necesario mínimo durante el primer año de vida. La vitamina D se obtiene en un 80 % del sol, y en un 20 % de la alimentación (se encuentra en algunos peces de mar).

Vivimos en una sociedad que vive dentro de departamentos y casas, con escasa exposición solar, insuficiente sobre todo en la época invernal. Es por esto que la mayor parte de la población tiene déficit de esta vitamina, que hoy sabemos que actúa como hormona en diferentes tejidos, no solo el óseo como se creía antiguamente. Entre otras cuestiones, tiene un papel fundamental en el sistema inmune.

La deficiencia de vitamina D debe ser pesquisada y tratada en el embarazo, y durante el primer año de vida del lactante ofrecerle al bebé 400 UI de vitamina D por día. Hay estudios que están buscando justamente suplementar a las mamás para aumentar la vitamina D en la leche humana y evitar suplementar a los bebés, pero aún no son concluyentes.

En Argentina, la vitamina D diaria para lactantes viene asociada a vitamina A y vitamina C. En mi libro anterior escribí que no terminaba de comprender esta asociación farmacéutica (las vitaminas A y C estarían

cubiertas por la leche humana o fórmula), y dos años después, sigo sin una respuesta.

En época de aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia de COVID-19, la exposición solar bajó aún más y tuvimos que suplementar preventivamente a muchas niñas y muchos niños. Seguimos evaluando el impacto de esta pandemia en las concentraciones de vitamina D de los chicos y su efecto en la salud.

Vitamina B12

Los niños con una alimentación basada en plantas, vegetariana, vegana, que muestren déficit de laboratorio o que tengan alguna dificultad en la absorción de nutrientes, deben ser suplementados con vitamina B12 por un profesional idóneo en el tema (ver capítulo 11: “Alimentación basada en plantas en la infancia”).

Otras vitaminas

Es importante saber que las vitaminas no abren el apetito, ni se pueden ofrecer como caramelos (a pesar de que algunas se vendan como caramelos, llenos de azúcar). **Las vitaminas son medicamentos y su consumo cuando no es necesario podría causar daños en la salud.** En la farmacia nos bombardean con propaganda diciendo que tomando tal o cual cosa se previenen los resfríos y se aumentan las defensas. Pues no, no hay nada dentro de un solo paquete que mantenga la buena salud. La única intervención que se vio que era efectiva es cambiar los hábitos en general, y si es desde la infancia, muchísimo mejor.

Desarrollo motor. Movimiento libre y alimentación complementaria

En el útero, los bebés tienen una vida muy activa. Son acunados por sus madres todo el día, abrazados apretadamente por el útero y abrigados por el

tibio líquido amniótico. Duermen unas veintilargas horas al día, alternadas por períodos de movimiento: pataditas, rotaciones, chuparse la mano, probar sus músculos.

Luego del nacimiento, las sensaciones cambian absolutamente. El bebé pasa a estar a merced de la gravedad, hace frío, tiene que alimentarse solo. Desde el momento del nacimiento, empieza a formarse una nueva imagen neurológica de lo que es el cuerpo.

El cerebro empieza a registrar formas, sensaciones, peso, movimiento. Esas imágenes cerebrales se van repitiendo hasta formar el patrón corporal que nos acompañará en la adultez. Cuando vemos a un bebé de 2 o 3 meses absorto con sus manos, abriendo y cerrando el puño, mirándolo, acercándolo y alejándolo de su cara, metiéndoselo incansablemente en la boca, estamos viendo a una persona formando su esquema corporal, la imagen que nuestro cerebro tiene de nuestro cuerpo.

El bebé empieza a adquirir pautas de maduración desde la cabeza a los pies. Primero, fija la mirada (las primeras semanas, los bebés pueden tener una mirada más errática e inclusive cruzárseles los ojitos). Luego, acompaña con la mirada los movimientos del otro. El sostén de la cabeza, que se da entre los 2 y los 3 meses, es un hito fundamental. Un bebé sin ningún compromiso neurológico lo logrará solo, sin necesidad de hacerle hacer ejercicios, ponerlo panza abajo ni forzar posturas incómodas.

En los 40, una pediatra húngara llamada Emmi Pikler hizo estudios observacionales en el orfanato que dirigía. Ella observó que los niños y las niñas en un contexto de cuidado, con un ambiente cómodo donde podían moverse libremente, eran capaces de alcanzar los hitos del desarrollo motor sin necesidad de que el adulto forzara las posturas. Los adultos estamos apurados: ponemos a los bebés en andadores, en sillones “de aprendizaje”, los agarramos de los brazos para que se paren y otras mil acciones que tienen que ver más con nuestra ansiedad que con lo que necesita un bebé.

Hablar de movimiento libre no implica no abrazar a nuestro bebé ni dejar de darle la mano cuando nos la ofrece. No hay posturas erradas para tomar a un bebé a upa, y apoyarlo sobre nuestro pecho o nuestro hombro no es “verticalizarlo”. Al contrario, el bebé necesita del cuerpo de la persona adulta que lo ama, necesita sentir su movimiento y su calorcito. Hay mucha información y experiencias posturales que les damos a nuestros bebés cuando los tenemos a upa y los abrazamos.

El otro lugar para pasar el día, además de los brazos, es el piso. Una

manta, una colchoneta y el piso mismo (no enloquecer con la limpieza) son buenos lugares para jugar y explorar. No hacen falta gimnasios ni otros aparatos (si los tenemos en casa, está perfecto y se pueden usar, pero no es una “necesidad”). El piso es un excelente lugar para empezar a probar posturas distintas, observar que hay un mundo fuera de los brazos de los mapadres y experimentar nuevos movimientos. No se trata de dejar al bebé solito en el piso, cosa que probablemente no le guste, sino acompañarlo, contarle cosas, leerle libritos... Regalarle tiempo.

El bebé se va desarrollando, y su columna se va fortaleciendo. Cerca de los 6 meses, tiene la fuerza necesaria para mantenerse erguido. Algunos bebés logran sentarse por sus propios medios alrededor de los 6 meses, pero son los menos. Otros son sentados por sus familias y se mantienen bien en esa postura, y posteriormente llegarán por su cuenta. Otros bebés se desplazan y gatean, y luego llegan a la posición de sentado. La mayoría llega solo a esa posición entre los 8 y 9 meses. Las combinaciones son infinitas. **Solemos pensar el desarrollo como hitos, y no como procesos. “¿Ya se sienta?”. “¿Ya camina?”. En vez de observar las infinitas posturas intermedias que hay para llegar a esos hitos.**

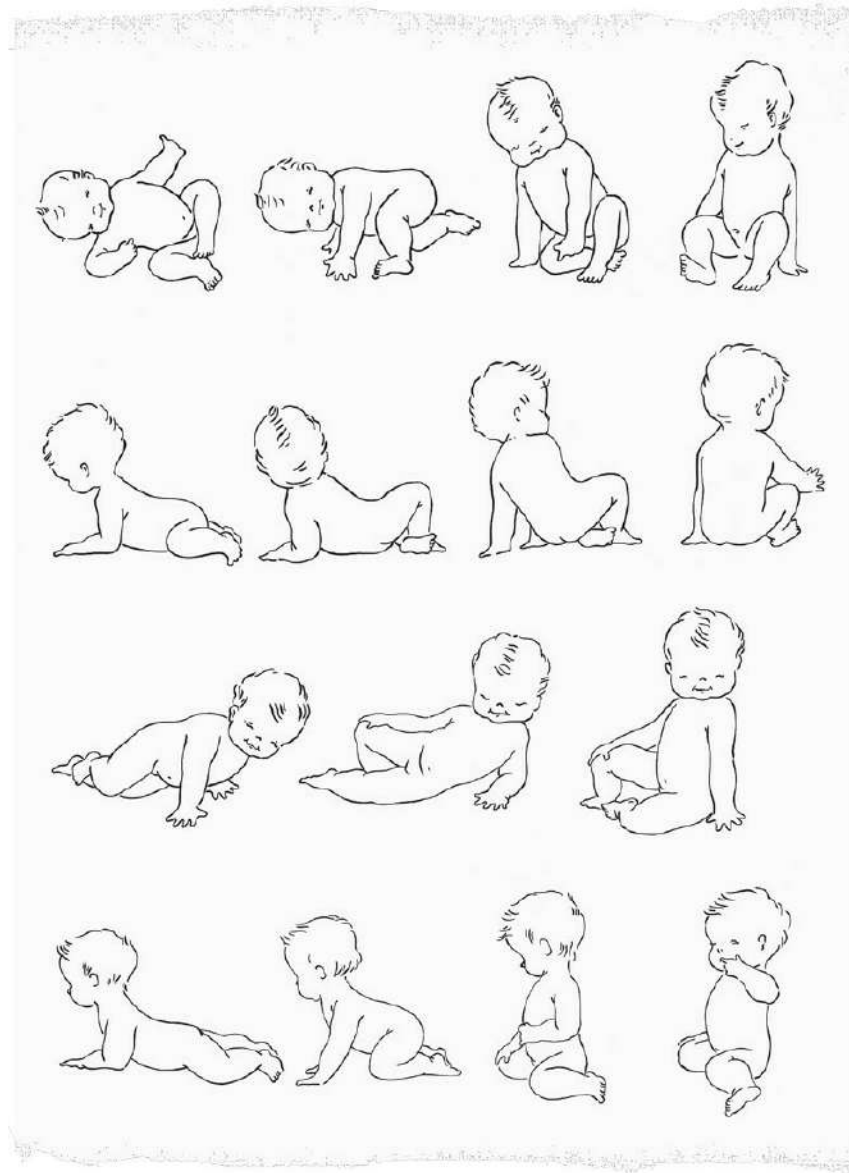
El valioso trabajo de Pikler justamente nos da la pauta de que los bebés pueden llegar a las diversas posiciones sin necesidad de “ponerlos” en ellas. Pero no se limita solo a hablar de movimiento, sino que desarrolla pautas para los cuidados y actividades cotidianos con los bebés, para el desarrollo de su autonomía y del amor propio a largo plazo. ¡Y esto va mucho más allá de las pautas motoras!

Un bebé que fue sentado puede encontrar mucho placer en esa posición. ¡Disfrutemos y acompañémoslo! Y, a la vez, mostrémosle otras experiencias de juego y disfrute.

Movimiento libre no es desarrollo sin acompañamiento profesional. Una mirada respetuosa del desarrollo infantil implica también estar atentos a señales de alarma e intervenciones amorosas y oportunas. La atención temprana del desarrollo infantil (antes llamada “estimulación temprana”) no está reñida con el movimiento libre. Los primeros años están llenos de oportunidades para el desarrollo y es importante la observación y el acompañamiento oportuno. No todos necesitamos lo mismo de la misma manera, y observar eso también es respeto hacia las infancias.

Entonces, para empezar la alimentación complementaria, ¿tiene que llegar a la posición sentado solo o mantenerse sentado? Para empezar la

alimentación complementaria, el bebé tiene que tener sostén cefálico sin duda, y poder mantener una posición erguida, la cual protegerá su vía aérea.



Distintas formas en las que un bebé que se mueve libremente puede llegar a la posición de sentado por sus propios medios. Adaptado del libro *Moverse en libertad*, de E. Pikler, 1984.

Sabemos que la alimentación complementaria puede iniciar alrededor de los 6 meses, ¡no necesariamente el día que cumple 6 meses! Podemos esperar un poco más para iniciarla, pero no mucho más allá de los 7 meses. ¿Por qué? Porque necesitamos ofrecer otros alimentos ricos en hierro, y propiciar el desarrollo sensorial con los alimentos.

Si el bebé está interesado en los alimentos, ya no tiene reflejo de extrusión, pero aún no se sienta por sus propios medios o se cae para los costados en la sillita, no se sugiere atarlo ni ponerle almohadones alrededor. Lo que podemos hacer es apoyarlo en nuestra falda, y ofrecerle información postural con nuestro cuerpo de adulto. No es sentarlo, no es intervenirlo, no es forzar posturas, sino acompañar en esa posición a un nuevo proceso.



No se come con la boca: se come con todo el cuerpo. Todos los movimientos que va conquistando el bebé son también parte del desarrollo de la alimentación. Por ejemplo, en algunos textos se plantea que el gateo favorecería los movimientos de la lengua hacia los costados (lateralización), la masticación y la formación de la articulación entre el cráneo y la mandíbula (témporomandibular). El rolar, pararse, desplazarse de costado, caminar, todo, pero todo, está relacionado con habilidades que tendrán que ver con la alimentación.

Cuando elegimos una sillita (ver el capítulo 7, “Alimentación complementaria: guía práctica”), es útil pensar en la comodidad de la postura. Para que el tronco esté erguido, y sea más sencillo masticar y tragar, es importante el posicionamiento de la pelvis. Y para darle firmeza a la pelvis, hay que apoyar los pies. **Pies apoyados, pelvis estable, espalda y cuello erguidos, son pautas que acompañan y ayudan a la alimentación.** No, no siempre nos sentamos prolijamente: niños, adolescentes y adultos a veces comemos hechos un bollo de brazos y piernas. Esto es porque ya tenemos otro control sobre la postura, hemos aprendido a través de los años.



A medida que el bebé vaya creciendo y aprendiendo a desplazarse, le va a interesar menos estar sentado con la comida, y más descubrir su entorno. Es normal que no quiera estar en la silla, que quiera bajarse, que tenga más ganas de chupar el piso que la palta. Paciencia, es un período. Más adelante, con el caminar, pasamos a la etapa “deambulador”. Deambulador: dícese de la persona pequeña llena de energía que circula incansablemente por el hogar. Los deambuladores a veces quieren comer y a veces no, y también es esperable. También gustan de llevarse comidita en la mano y esconderla adentro del sillón. Hay que tener mucho cuidado con el riesgo de atragantamiento, y ofrecerles alimentos aptos.



Apoyar al bebé en nuestra falda, de cara al plato, dándole información con nuestro cuerpo. Así el bebé podrá tener las manos libres y jugar con la comida.

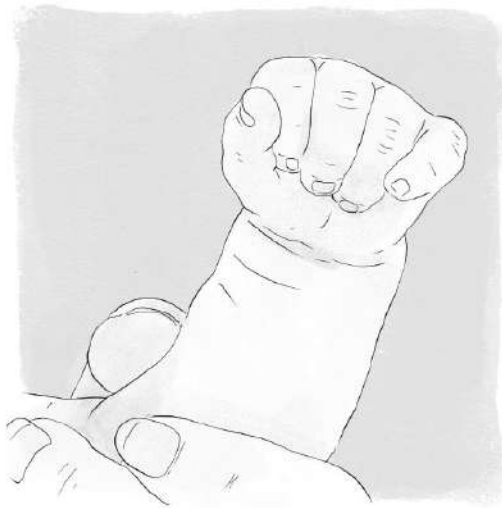
La motricidad se sigue construyendo durante toda la vida. No corre igual un niño de 2 años que uno de 4: el de 4 tiene mayor seguridad en su movimiento, se tropieza menos, tiene mayor coordinación. De allí la importancia de observar procesos y no solo hitos. Nos encanta el día donde “aprendió” a caminar porque tenemos filmados esos increíbles primeros pasos, pero la realidad es que el proceso de caminar lleva muchas semanas y se sigue afianzando en los siguientes años.

La infancia y la adolescencia son momentos cruciales en la conformación del sistema muscular y óseo. **Propiciar el juego, el esparcimiento al aire libre y el deporte desde el placer es fundamental.** El cuerpo crece como un todo: los músculos están fuertes y sostienen a las articulaciones y acompañan a que los huesos crezcan fuertes. ¡Las neuronas siempre pueden aprender nuevas cosas! Nunca es tarde para ponerse en movimiento, y el impacto en la salud siempre es positivo.

Desarrollo de la motricidad fina

La mano y la capacidad de llevarse objetos a la boca también se van desarrollando rápidamente durante el primer año de vida. Cuando nacen, los bebés tienen las manos arrugaditas y cerradas. Si tocamos la palma, cierran la mano, dado que aún está presente un reflejo que se llama “prensión palmar” (agradecida de que lo tengan, ¿no es lo más que te agarren un dedito?). A medida que pasan las semanas, las manos se van abriendo y se van acercando a la boca, donde alrededor de los 2 meses serán babeadas intensamente.

Es normal y sano que los bebés se lleven manos y pies a la boca durante horas. En los primeros meses, no suele tener que ver con la erupción de los dientes, los cuales suelen salir alrededor de los 6 meses (¡cada bebé es distinto! Algunos sí tienen dientes antes). Están experimentando y explorando. ¡Paciencia!



A veces, para evitar el hábito de chuparse el dedo a largo plazo, se sugiere, erróneamente, no permitirle al bebé la mano en la boca, o aún peor, reemplazarlo por un chupete. Esto solo coarta su autodescubrimiento, con posibilidad de consecuencias negativas en el futuro.

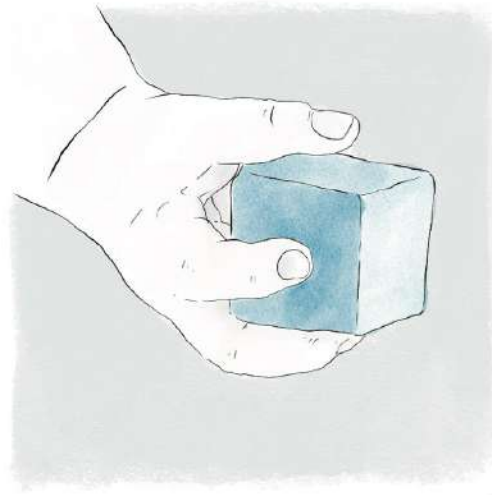
Pero ¿chuparse el dedo no le va a deformar el paladar? A medida que el bebé va creciendo, va encontrando otras formas de descubrirse, aunque sigue usando la boca para evaluar cosas (juguetes, arena, cosas misteriosas que encuentra en el patio...). La necesidad y el hábito de succión no nutritiva, para calmarse, baja, y alrededor de los 2 años (en cada niño varía), es deseable evitar el chupete o que se chupe el dedo. Si el niño tiene esa necesidad aún, tenemos que acompañarlo y evaluar las causas para evitar consecuencias indeseables.

Alrededor de los 3-4 meses, ambas manos ya han llegado a la línea media, y se han encontrado entre ellas y en la boca. Los bebés se miran las manos y comienzan a comprender que pueden utilizarlas en forma voluntaria. Empieza a surgir la posibilidad de tomar y soltar un objeto. Cerca de los 6 meses, además, se pueden transferir objetos de una mano a la otra. Esto muestra que los hemisferios cerebrales se comunican entre ellos, mandándose información.

El poder permanecer erguido, sentado, le permite al bebé seguir separando los brazos del cuerpo. Y eso aumenta la capacidad de los dedos y la mano para realizar movimientos más finos.

En un inicio, el bebé toma los alimentos con toda la mano, cerrando la palma. Es por eso que los trozos de alimentos deben ser grandes: un bebé de 6 meses no podría tomar alimentos pequeños porque aún no puede

hacer la pinza.



Tomar los objetos, golpearlos y revolearlos, es fundamental para desarrollar nociones de espacio y de permanencia. “Esto se cae y mamá lo levanta... ¡Qué maravilla! Lo haré de nuevo”. La pinza va empezando a aparecer, primero como una “tenaza” entre el índice, el anular y el pulgar, con los dedos extendidos. Luego, esa pinza se vuelve más precisa, flexionando los dedos para agarrar cosas más chiquititas.

Poder jugar con la comida es fundamental para acompañar este desarrollo. Sentir diferentes texturas, apretar, desarmar, organizar los elementos en el plato, embocarle a la boca, ofrecerle a mamá, son eventos deseables y esperables en este proceso. Es por esto que se plantea que **el Baby Led Weaning podría contribuir al desarrollo de la motricidad fina y la gruesa en los bebés y niños: no es lo mismo tocar activamente la comida que simplemente abrir la boca para recibir una cuchara.** Esto no quiere decir que los bebés que inician la alimentación complementaria con papillas no se desarrollen bien: si permitimos tocar y jugar, y vamos aumentando las texturas, seguramente vayan por el mismo camino.



Importante: **se sugiere no limpiar las manos y la boca del bebé constantemente** por dos cuestiones. Una, que es importante que se ensucie: la mugrecita de la comida sobre la piel da información al cerebro sobre esa manito, brazo o cabeza. La segunda, limpiar todo el tiempo puede provocar una sensación de rechazo en el bebé, de sentir que ensuciarse es algo incorrecto, y generar problemas en la alimentación por esa razón (no querer tocar distintas texturas, no aceptar que los alimentos se mezclen, etc.).

Todos estos procesos se dan al mismo tiempo que el bebé desarrolla su motricidad gruesa, su sensorialidad, su capacidad de masticar y deglutir. **Cuando un bebé logra hacer la pinza fina, ya tiene la coordinación ojo-boca-mano bastante dominada, y ya hizo un recorrido interesante en masticar y gestionar alimentos, si le permitimos descubrir diferentes texturas.** Entonces, para cuando puede hacer la pinza fina con las manos, generalmente ya puede recibir en la boca con seguridad trozos de alimentos más pequeños.

La mano sigue desarrollándose. Señala, acaricia, se entera de que ahí no hay que tocar porque está caliente. Alrededor del año y medio, aman agarrar lápices y crayones, y hacer obras de arte en las paredes de la casa. Apretar masas, revolear tierra, dar un manotón durante un berrinche... Todas esas son experiencias que involucran la mano en el siguiente año.

Aprender a usar los cubiertos requiere una nueva habilidad, que no se da de un día para otro: es importante ofrecerlos, permitirles jugar con ellos y mostrar cómo los usamos nosotros. El cubierto es algo cultural, y de hecho hay muchos alimentos que comemos con la mano. ¿Cómo aprenden a usar los cubiertos? Mirádonos, y nosotros acompañando. Seguramente sea

necesario dar un acompañamiento motor y sensorial (por ejemplo, poner la mano del adulto sobre la mano del niño o niña) para ciertas cuestiones como aprender a cortar. Dar el ejemplo siempre es la pieza fundamental.

Dentro de las actividades de la vida diaria, aparece la mano como herramienta fundamental para cuestiones como lavarse los dientes o atarse los cordones. Sí, exacto: atarse los cordones también tiene que ver con la higiene dental y, por supuesto, con la alimentación.

Aprender a escribir requiere infinita coordinación motora del ojo y la mano, de la postura y, por supuesto, de la intervención del lenguaje. El apoyo de los pies tiene que ver con dónde se posiciona la lengua, por ejemplo. Es por esto **que cualquier intervención que vayamos a sugerir en salud en una persona (hacer un tratamiento odontológico con aparatos, por ejemplo, o hacer deporte) tendrá un impacto en todos los sistemas.** Los otorrinolaringólogos, por ejemplo, tienen un dicho: “Un niño puede comer maní entero cuando es capaz de escribir la palabra maní”. Esto es parte de lo que les contaba antes: **los procesos de desarrollo están íntimamente ligados.**

Desarrollo sensorial

Ya en la vida intrauterina, los sentidos del bebé están alertas y en desarrollo. Sienten la presión de las paredes del útero, responden cuando una mano los acaricia desde afuera, escuchan los sonidos y hasta perciben sutilmente la luz. Cuando nace, la vía auditiva está lo suficientemente desarrollada como para oír bien, y puede diferenciar gustos y olores. Puede ver el contraste de colores y por ello, logra ubicar el pezón de su mamá, más oscuro que el resto del cuerpo.

Si un bebé nace sin complicaciones de salud y se coloca encima del vientre de su madre, es capaz de arrastrarse hacia la teta por sus propios medios, masajeando además la zona uterina con los piecitos y ayudando a la retracción del útero. Este viaje primitivo, este recorrido primario sobre la piel de la persona que más conoce en el universo se llama *breast crawling*, y es la primera receta de alimento en este universo. El bebé llega a la teta atraído por su aroma, por su color, por su calidez. Se sabe que el pecho materno aumenta

su temperatura después del nacimiento del bebé, ofreciéndole un lugar donde regular su temperatura. El bebé llega, mira, huele, lame, toca. Después de todo eso, abre grande la boca y, por primera vez, atrapa el pezón. **Este primer contacto es decisivo, imprime en el cerebro huellas sensoriales que participarán en todo el desarrollo de esa persona.**

Lamentablemente, los protocolos institucionales no le dan el tiempo a las diadas para vivir este proceso, que muchas veces dura más de una hora. A veces, inclusive, hay nacimientos hermosos y respetuosos, pero después se lleva directamente al bebé a la teta, interviniendo en ese reconocimiento autónomo que es capaz de hacer el bebé. Recuerdo que cuando nació mi hijo menor por cesárea, me lo pusieron directamente en la teta y quisieron acomodarle la cabeza mirando ansiosamente si se prendía. Sí, nos encanta que los bebés se prendan a la teta apenas nacen, pero necesitamos darles un tiempo de reconocimiento, una intimidad para conocerse, una recuperación de la adaptación respiratoria.

Aquí queda aún más clara la necesidad de no separar a la mamá del bebé apenas nace, a menos que una situación de salud extraordinaria lo amerite. Se puede pesar al bebé más tarde, se puede medir otro día, se pueden poner las vacunas y la vitamina K en un par de horas con el bebé ya en la teta. **Los procedimientos médicos en bebés sanos no son urgentes: sí es urgente que el bebé se conozca con su familia y tenga tiempo de entremezclar sensorialmente con esas personas que fueron y serán su hogar.**

El tacto es fundamental para el bebé, se nutre de las caricias, del vaivén del upa. El contacto disminuye las hormonas de estrés y provee la relajación necesaria para el crecimiento y el desarrollo del bebé. ¿Es mucho tenerlos todo el día a upa? No, pero está mal visto en nuestra cultura, y los adultos creemos que el bebé tiene que estar en la cuna o en el cochecito para que nosotros hagamos otras cosas. Es importante saber, inclusive antes de pensar en mapaternar, que la mapaternidad implica poner cuerpo y alma de pleno, sobre todo los primeros meses de vida, cuando el bebé nos necesita para sobrevivir. Para esto, sin duda, necesitamos apoyo del exterior, mejores licencias de mapaternidad, y profesionales empáticos y actualizados que nos acompañen.

El sentido del gusto, que va de la mano del olfato, es estimulado ya en la vida intrauterina. **Se sabe que la construcción de los sabores tiene que ver con los diferentes sabores que toma el líquido amniótico, según lo que coma la persona gestante.** Posteriormente, la leche humana también cambia

de sabor según la ingesta de la mamá, e inclusive puede cambiar de color (se ha visto leche verdosa en madres que consumen altas cantidades de espinaca, por ejemplo. Esto no genera nada malo para el bebé). **La alimentación durante el embarazo y la lactancia es tan importante para la mamá como para el bebé.** Como la leche de fórmula tiene un sabor uniforme, dulce, los niños alimentados con fórmula exclusiva no tienen esa experiencia de sabores antes de empezar la alimentación complementaria. ¿Esto quiere decir que van a tener problemas? No necesariamente, pero en el caso de que exista alguna dificultad en la alimentación, es algo a tener en cuenta.

Es importante, desde el inicio de la alimentación complementaria, presentar diferentes sabores, colores, texturas, temperaturas, aromas. Esto estimula los sistemas sensoriales, y mientras más variada sea la oferta, mayor cantidad de estímulos se construyen. Es muy común que niños a los que se les ofreció gran variedad desde el inicio de la alimentación complementaria se pongan selectivos alrededor de los 2 años, y que posteriormente vuelvan a comer distintos colores y texturas.

El incorporar productos ultraprocesados tempranamente en la alimentación infantil es un gran problema. Esos productos son hiperpalatables, es decir, excitan el paladar y los centros de recompensa en el cerebro, que piden más y más. El azúcar libre, la sal, el glutamato monosódico y otros aditivos tienen esa función: que comamos más y más de ese producto. ¿Por qué la gaseosa tiene tanto sodio? Porque eso hará que tengamos más sed... y tomemos más gaseosa. El cerebro de los primeros mil días –tal como vimos al comienzo del libro– es muy maleable: mientras más estímulos se les dé a ciertas zonas, más se desarrollarán esas zonas. Si todos los estímulos son dulces, por ejemplo, por ofrecer cereales infantiles y postrecitos, el sistema de recompensa cada vez necesitará más dulce para satisfacerse, y se rechazarán otros sabores. Esta es solo una de las cuestiones por las cuales los organismos científicos no sugieren el consumo de ultraprocesados: la monotonía y el “embotamiento” sensorial.

Si ya ofrecimos ultraprocesados, ¿se puede revertir? Sí, por supuesto. Lo podemos hacer los adultos, imagínense los bebés, las niñas y los niños. Las neuronas aprenden todo el tiempo cosas nuevas.

La integración sensorial es el proceso por el cual el cerebro recibe e interpreta la información que proporcionan los sentidos para poder vivir en este mundo, y que este adquiera sentido para nosotros. A partir de la integración sensorial, podemos juntar las partes para comprender el todo. Por

ejemplo, comer un helado implica ver el color del helado, la forma del cucurucho, la sensación de frío en las manos, el sabor dulce y blando en la boca, el movimiento de la lengua para lamerlo, la coordinación de la cuchara para comerlo, etc. El cerebro procesa todos esos estímulos en lo que creemos que es solo una actividad: comer un helado.

La integración sensorial también implica la memoria y la planificación. Cuando viene rodando una pelota, tendemos a patearla. Cuando alguien levanta la mano para saludarnos, repetimos el gesto. Esto se denomina “comportamiento adaptativo” y tiene que ver con nuestra relación con el entorno. No todos tenemos el mismo procesamiento sensorial, y justamente el concepto de integración sensorial ofrece una forma de describir diferencias individuales, de preferencias y tolerancias. Las personas procesamos la información de diferentes maneras que también tienen que ver con el placer y el displacer, ligadas también a experiencias emocionales.

La alimentación está íntimamente ligada a la integración sensorial desde el momento del nacimiento. La alimentación complementaria es un momento fundamental de aprendizaje y de desarrollo de los sentidos, por eso no es lo mismo ofrecer un puré de todo mezclado, color marrón, en el que licuamos tres verduras diferentes, que ofrecer un puré de brócoli al vapor pisado con tenedor. No es lo mismo dar un cereal de caja, de color blancuzco y de textura semilíquida, que dar un trozo de durazno blando con cáscara peludita. No es lo mismo ofrecer fideos blancos con un poco de aceite en el plato, que ofrecer fideos de arvejas, de color verde, acompañando varias verduras.

Ofrecer la posibilidad de descubrir cada alimento, su color, su aroma, su textura, es fundamental para la percepción y la aceptación de cada alimento. Y aquí también interviene el juego, del que hablaremos más adelante.

En ocasiones nos encontramos con dificultades en el procesamiento sensorial: niños y niñas que no toleran ciertos colores, o que la sola presencia de alguna textura les genera arcadas. No es para preocuparnos si nuestro niño no quiere comer tomate por un par de semanas, es muy común, y también puede ser que simplemente no le guste cierto alimento. Pero **si se rechaza un grupo entero de alimentos o hay franco displacer en toda la alimentación, amerita la consulta con un equipo especializado.** De esto hablaremos en el capítulo 9 sobre neofobia y selectividad.

Jugar es parte del comer

El bebé aprende jugando. Todo es un mundo de exploración, de aprendizaje y de deseo. Primero aprende jugando sobre el cuerpo de otros, estirando la cabeza para alcanzar la teta y tratando de enfocar los ojos para poder ver mejor el fascinante rostro de quien le está cantando tan lindo. Después empieza a explorar un poco más allá: aparece el piso, el afuera, el empezar de a poquito a entender los límites del cuerpo y su relación con el entorno.

Comer es la actividad más compleja que realiza el ser humano porque, además de todo lo que tiene que hacer el cuerpo, implica siempre a un otro. Comer es un acto social, desde la primera mamada hay otra persona presente. Por eso insistimos tanto en que hacer BLW jamás se traduce con “dejar comer al bebé solo”. **La presencia del adulto, y cómo ese adulto transita también la alimentación complementaria y su propia alimentación, va a tener que ver con la alimentación de ese bebé.**

Insisto en este libro una cantidad extraordinaria de veces sobre el “dejar jugar” con la comida Y sin embargo, dada la enorme cantidad de preguntas sobre el tema que recibo todos los días, no puedo dejar de hacer hincapié en ello. **Jugar es parte del comer.** Tocar, empujar, barrer de la mesa, revolear, aplastar, golpear, oler, gustar, mirar y otra cantidad infinita de verbos es parte del comer. Jugar es importante, es más importante que meterse el alimento en la boca y tragarlo. Nos da mucho miedo que nuestro bebé no coma, por eso tenemos que tener claro que la alimentación complementaria es complementaria, y la leche humana o de fórmula es el principal alimento el primer año de vida. Comer, come: come leche.

¿Y después? ¿Qué pasa cuando no come a los 2 años, a los 4 años, a los 9 años? Cuando esto sucede, ante todo revisar las expectativas. Un ejercicio útil es preguntarnos cuánto creemos que tiene que comer nuestro hijo o hija. Inclusive, dibujarlo en un plato. Después, evaluar si realmente hay un problema a ser abordado. ¿Qué cosas sí come? ¿Dónde come? ¿Cómo crece? Mucho de esto lo veremos más adelante en el capítulo 9 sobre neofobia y selectividad.

Permitir el juego es fundamental, pero nos han educado en que los modales son importantes, y que levantarse de la mesa y tocar el huevo con la mano son señales de falta de respeto al adulto todopoderoso que con el sudor de su frente obtuvo el alimento y encima lo cocinó. ¿No les genera infinita

angustia cuando estuvieron mucho tiempo en la cocina y el *muffin* de harina de sorgo orgánica cultivada en una maceta mágica de Traslasierra termina en la boca del perro? Porque a mí sí, créanme. Estoy, y ustedes también, educada en la cultura de vaciar el plato aunque no tenga hambre y comer todo aunque nos dé arcadas, porque otra persona lo hizo para nosotros. Y con esto no estoy despreciando el enorme esfuerzo que hacen las familias por llevar un plato de comida a la mesa, al contrario. Busquemos estrategias para que el juego no sea algo que nos duela.

Permitir jugar, habiendo sido criados en ese paradigma, es un acto de amor enorme. Buscar estrategias para permitir ese juego también. Si me angustia mucho que mi hijo tire la comida, tal vez tenga que ponerle menos comida en el plato. Si me genera miedo extremo y hasta llanto que no se lleve comida a la boca, o si empecé la alimentación complementaria hace una semana y siento mucho desasosiego porque “ya probé todos los métodos y no come nada”, hay que buscar ayuda. Tal vez en un grupo de mapadres de bebés de la misma edad, tal vez en profesionales de la salud mental. Porque, en serio, ¿cómo transitamos nosotros nuestra propia alimentación? Seguimos creyendo que hay “permitidos” y “prohibidos”, y que comer rico y saludable es imposible. Nos seguimos castigando y premiando con comida. Eso hemos aprendido y eso debemos repensar. ¿Queremos que nuestros hijos e hijas crezcan así?

Limpiar da trabajo, sí, pero desdramaticemos un poco el asunto. Existen mil millones de baberos, manteles “para piso” para recoger migas y pedazos de comida, y si tenemos un perrito, seguramente nos servirá de aspiradora canina. Los niños y las niñas no son prolijos. Pintan paredes, se embadurnan de caca y llenan la cama de migas aunque estemos atrás todo el tiempo. Los años pasan y seguramente se convertirán en adultos tan perfectos como nosotros, que siempre tenemos todo limpio y prolijo... o no.

El juego, sobre todo en la primera infancia, implica un otro. Los bebés, a medida que crecen, van desarrollando lo que se llama “atención conjunta”: miran algo, miran a su mapadre como preguntando, vuelven a mirar. Necesitan nuestro apoyo y compañía para que les expliquemos qué es esa bolita de plumas que canta en el árbol. “Un pajarito, mi amor”, les decimos, y vuelven a mirar, contentos por la respuesta. Con la comida es igual. No es solo ofrecer el platito, es contarles qué les ofrecemos, cómo lo cocinamos, qué color tiene, qué vamos a comer nosotros. ¿Nos gusta a nosotros esa comida? ¿Lo comíamos de chicos? Todo ese juego tiene también

implicancia en el desarrollo del lenguaje.

El bebé mirará, tocará, inclusive nos ofrecerá cosas de su plato y querrá cosas del nuestro. Es muy común el “solo quiere comer lo que nosotros comemos” y “solo quiere comer lo que hay en nuestros platos, del suyo no toca nada”. ¡Pero claro! Lo que hacemos nosotros es superinteresante, somos superpersonas maravillosas con superpoderes, a sus ojos. **Descomprimir la hora de comer, comer en el piso, comer en la mesita baja, hacer pícnic en el pasto y apostar a las “picadas” (poner diversos alimentos en la mesa, que se toman y comen con la mano), son buenas opciones para evitar batallas en la mesa.**

“¿Comerá alguna vez mi bebé?”. Sí, seguramente, en algún momento se llevará alimentos a la boca y los comerá. Y también aprenderá a usar los cubiertos, y a sentarse en la mesa, y a tener en veinte años reuniones de trabajo que incluyan café y medialunas. Aprenderá a comer en casa de amigos, y será adolescente y comerá *pizza* en las fiestas de quince años. Paciencia y amor.

“Todo el mundo me dice que es grande para la teta, que es un malcriado porque come con la mano, que come poco y que el vecino tiene la misma edad y pesa el doble”. Si la gente invirtiera el tiempo que invierte en opinar sobre la vida ajena en traernos comida cocinada, hacernos las compras o pagarnos las cuentas, cuánto más fácil sería el puerperio y la crianza, ¿no es cierto? Esta es nuestra aventura, y la de nuestros hijos. Otras personas, inclusive los profesionales en las redes, pueden ofrecernos consejos y diferentes miradas, pero es nuestro momento, nuestro patrimonio, nuestra experiencia y nuestras decisiones, y en caso de que nos equivoquemos, serán nuestros errores y nuestro aprendizaje. Y en eso también puede haber risas y disfrute. Yo no me arrepiento de haberle ofrecido a mi hijo mayor papillas de palta y carne triturada: era lo que yo sabía en esa época, lo que consideraba mejor, y que con el mayor amor del mundo le preparé y ofrecí, y nos divertimos mucho jugando al avión. Guardo esas experiencias con amor y satisfacción, a pesar de que después descubrí otro mundo alimentario, más saludable, para mi niño menor. Pero este es mi camino, y cada paso dado es con amor y respeto, y eso

es lo único que importa. A quienes nos dan opiniones no pedidas les agradecemos por la preocupación y hasta por el amor, porque muchas se hacen desde justamente el ofrecer algo que la otra persona considera como importante... Y seguimos esta aventura.

“Desea... ¿Le puedo dar?”. Los bebés nos miran y quieren imitarnos, incluso en nuestra hora de comer. Eso no quiere decir que “tengan hambre” o que “deseen comida”. Quiere decir que somos su ejemplo y nos imitan. Inclusive algunos hacen movimientos al estilo “masticar”, que ya dijimos que empiezan a aparecer alrededor de los 4 meses. Sin embargo, los adultos somos nosotros y tenemos la responsabilidad de tomar decisiones sobre la salud de los chicos. ¿Les puede hacer mal iniciar la alimentación complementaria antes de los 6 meses? La respuesta es SÍ, puede ser nocivo a corto y largo plazo, y parte del respeto hacia las infancias es ser conscientes con su salud. No hay ningún beneficio en comenzar la alimentación complementaria antes de los 6 meses de edad.

“Tiene 8 meses y ni siquiera toca la comida”. Muchos bebés no están interesados en los alimentos por un tiempo bastante largo. Aquí tenemos que observar precisamente esto: el juego. Si están jugando, paciencia, ya llegará. Ahora, si ni siquiera toca un alimento, hay que evaluar la causa. Si es prematuro, ¿cuál es su edad corregida? ¿Cómo está el ambiente? ¿Come en un horario aparte de la familia? ¿Qué le ofrecemos? ¿Está cómodo en la silla? Todas estas cuestiones pueden ser abordadas en la consulta pediátrica y buscar estrategias para la alimentación, o la interconsulta con otro profesional que nos pueda dar otra mirada. Filmar al bebé durante la hora de la comida puede ser una herramienta interesante para llevar a la consulta y evaluar estas cuestiones.

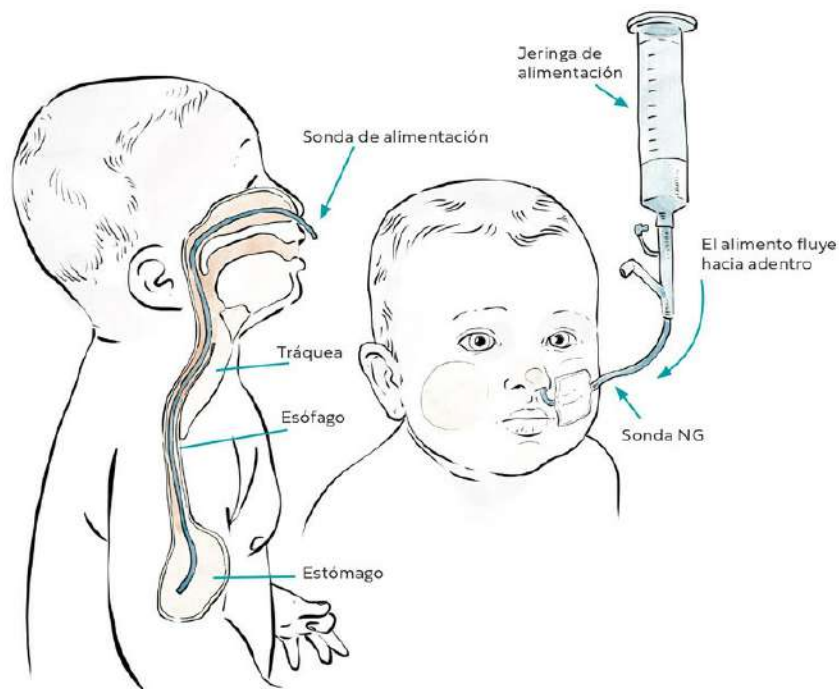
No siempre se come con la boca: sonda nasogástrica, botón gástrico y alimentación parenteral

La sonda nasogástrica

Es un fino tubo de plástico flexible que se introduce en la nariz, pasa por el esófago y llega al estómago. Por dicho tubo se pueden pasar medicaciones, líquidos y alimentos líquidos. También se puede utilizar para extraer sustancias del estómago si es necesario. Hay sondas nasogástricas (nariz-estómago), orogástricas (boca-estómago), nasoduodenales (nariz-duodeno) y así.

¿Por qué se colocan? Se utilizan para asegurar el aporte de líquidos, alimentos y medicaciones a una persona que por alguna razón de salud no puede ingerirlos de otra manera. Es muy común, por ejemplo, en los bebés prematuros, cuya succión puede ser débil aún y necesitan un aporte de leche por la sonda.

Algunos bebés, niños y niñas necesitan la sonda por un tiempo largo, porque se encuentran en tratamiento por una patología crónica. Sus cuidadores generalmente están muy cancheros con los cuidados de la misma. A la sonda hay que lavarla después de usar instilando agua potable, hay que cambiarla cada tanto, hay que tener cuidado que el adhesivo no lastime la piel de la carita...



El botón gástrico

Un botón gástrico es una sonda de silicona transparente que se coloca a través de la piel del abdomen hasta el estómago. Esa sonda en otros casos puede también llegar al yeyuno, más lejos del estómago, si la persona lo requiere. Por allí se introducen medicamentos, suplementos y alimentos.

Entre otras indicaciones, el botón gástrico se coloca en los casos en que la alimentación por sonda nasogástrica se prolonga mucho y es preciso contar con otra vía de administración de nutrientes con más facilidad. También puede ser necesario cuando hay una patología que no permite la deglución eficiente y ponga en riesgo a la persona.



La alimentación parenteral

Es la administración de los nutrientes a través de una vena, sin participación del sistema digestivo. Cuando no se puede usar el aparato digestivo por una

enfermedad o se necesita reposo digestivo, o cuando el aparato digestivo funciona parcialmente y de forma insuficiente, a veces se necesita completar la nutrición de forma parenteral.

- “Las personas que se alimentan a través de sonda nasogástrica, botón gástrico o alimentación parenteral, ¿comen también por la boca?”. A veces sí y a veces no. Algunas veces hay que usar estos recursos cuando la persona está internada y muy grave, y no está en condiciones de alimentarse por boca, en otras es necesario que sean parte del tratamiento de una enfermedad progresiva o tratamientos largos. Sin embargo, en la medida de lo posible, se busca que sean ayudas transitorias, ¡por lo que es importantísimo no dejar de estimular la boca! Los músculos y nervios que no usamos se aburren y a la larga dejan de funcionar. ¿Y qué profesionales participan? Principalmente, fonoaudiólogas, terapistas ocupacionales y odontopediatras, en conjunto con el pediatra de cabecera y otros profesionales que acompañan al niño y a la familia. El lavado de dientes y el cuidado de la cavidad oral también son fundamentales, aunque no se reciban alimentos en la misma. Contribuye al procesamiento sensorial y evita dolores y enfermedades como la caries, que pueden ser complejas de solucionar.

Diversidades en el desarrollo infantil

No todas las personas nacen con la misma cantidad de semanas de edad gestacional, ni les funcionan igual los músculos, ni respiran de la misma manera. Algunas personas –en este caso hablo de infancias– viven con traqueotomías (un dispositivo colocado en la tráquea a través del cuello para poder respirar), comen a través de un botón gástrico o necesitan asistencia para desplazarse. Algunas personas requieren sondarse (introducir una sonda en la uretra) para poder vaciar la vejiga. Otras tienen dificultades en la comunicación y/o en el procesamiento sensorial. Otras presentan alergias a

ciertos alimentos o tienen alguna cuestión renal que implica comer con menos sodio.

Todas estas personas viven, juegan, aman y son amadas, se enojan y, por supuesto, comen. Y no hay razón para pensar que ese comer no pueda ser algo placentero.

Cuando leemos, por ejemplo, bibliografía sobre Baby Led Weaning, muchas veces se interpreta que solo puede implementarse ese “método” en niños de término, sin ninguna patología de base. Pero si pensamos que el BLW justamente replica la alimentación perceptiva, en la cual se atienden las necesidades de hambre y de saciedad, los signos de satisfacción y displacer, se incita a la persona a tocar, explorar y encontrarse con los alimentos... ¿Por qué no podría ser posible? **BLW no es comer en trozos, es relacionarse sanamente con la comida.**

Que un niño o una niña tenga disfagia (dificultad para tragar), por ejemplo, y tenga que recibir alimentos blandos, no quiere decir que no pueda tocar, mirar, oler y jugar con el alimento. Que una persona tenga que requerir asistencia para su alimentación, no quiere decir que no tenga gustos y preferencias sobre el sabor, color, aroma y textura de esa comida. Que un bebé requiera equipamiento para mantener una postura que no le genere riesgo de atragantamiento, no quiere decir que tenga ganas de comer en el momento en que lo sentamos, como le pasaría a cualquier bebé.



La alimentación es mucho más que ingerir nutrientes. Es mirar la

expresión del otro, es jugar a ordenar tomates, es ver qué cara pone mamá cuando el plato se cae al piso. Es compartir la tortilla con el perro y aprender los colores con la ensalada. Es cerrar los ojos cuando la mandarina es muy ácida y hacer lío cuando hay que lavarse los dientes después de comer. Es quedarse dormido antes de la cena y es aprender a explicar que tenés hambre. Y todo eso, de diferentes formas, así como diferentes somos, es parte de comer, y parte de ser niños.

A modo de conclusión

Entonces, consideramos que un bebé puede iniciar la alimentación complementaria cuando:

- Tiene al menos 6 meses (de edad corregida en bebés que han nacido prematuros).
- Mantiene la posición de sentado.
- Ha perdido el reflejo de extrusión.
- Tiene interés por los alimentos.

Pero estas pautas, como vimos, son solo un breve resumen de todos los procesos que vive el cuerpo del bebé a través de los meses, y van conduciendo a integrarse en la plenitud de los procesos sociales y nutritivos que vive una persona. No podemos medir “cuán maduro está el intestino” ni hay que hacerle una prueba a los riñones para ver si están aptos para recibir otros alimentos, pero sí **comprender cuán complejo es el proceso y no desesperar cuando los bebés “solo” juegan con la comida durante algunas semanas al iniciar la alimentación complementaria.**

Por último, las infancias con discapacidad y sus familias también atravesarán el proceso de alimentación, y probablemente las pautas de inicio no serán las mismas, sino que dependerán de qué apoyos requieran esa familia y ese bebé, niño o niña. La importancia de contar con un equipo de profesionales que trabajen en conjunto (pediatra, fonoaudióloga, nutricionista, terapeuta ocupacional, kinesiólogo, odontopediatra, puericultora, etc., etc.) es fundamental, **comprendiendo que los niños y las**

familias son los protagonistas del proceso, y la importancia de acompañar sus gustos, costumbres y cultura. Por ello, dejo en la bibliografía recursos para familias y profesionales que necesiten o busquen ahondar en el tema.

¿Son muchas cosas? Sí, claro. Abruma pensar que acompañaremos este camino de una o más personas. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué NO hay que hacer? Parece muy difícil y, sobre todo, aterrador equivocarse. Pero el camino de la crianza implica aprender tanto como enseñar, y mostrar este mundo luminoso y extraño. **Todo lo que sea lejos de la violencia y hecho desde el amor, no es un error, es una experiencia, un aprendizaje, una manera de hacer las cosas lo mejor que podemos en ese momento con la información que tenemos.** En un mundo donde los medios nos bombardean con cosas que “necesitamos” para bebés (andadores, cunas que se mecen solas, saltarines, etc.), más las voces del entorno, más la tentación de comparar con el hijo del vecino o la hermanita, es difícil tener paciencia y acompañar a nuestras hijas y nuestros hijos en su desarrollo. Pero podemos, con información y un acompañamiento amoroso en salud, disfrutar cada uno de esos momentos únicos e irrepetibles. Esta es nuestra aventura. Que nadie opine, que nadie obligue. Es nuestra, con nuestros errores y aciertos. Es nuestra, con nuestro disfrute. Animémonos a transitarla.

Para seguir leyendo

PARA FAMILIAS Y PROFESIONALES

- Toldi, R. P. (2015). Ya lo he sentado ¿Ahora qué? *Teta-à-Porter*. Recuperado de: <https://tetaaporter.com/2015/11/09/ya-lo-he-sentado-ahora-que/>
- Caballero, M. *Guía de alimentación para personas con Síndrome de Down*, Ediciones Díaz de Santos, Madrid, 2014.
- Hospital San Joan de Déu. (2016). Sonda nasogástrica en enfermedades metabólicas. *Guía metabólica*. Recuperado de: <https://metabolicas.sjdhospitalbarcelona.org/noticia/sonda-nasogastrica-enfermedades-metabolicas>

- Hospital San Joan de Déu. (2018). Botón gástrico en enfermedades metabólicas. *Guía metabólica*. Recuperado de: <https://metabolicas.sjdhospitalbarcelona.org/noticia/boton-gastrico-enfermedades-metabolicas>
- Fernández-Vegue, M. (2018). RECOMENDACIONES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA SOBRE LA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA. Asociación Española de Pediatría. Recuperado de: https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/recomendaciones_aep.
- Escuela Especial Ñielol. Instituto de Rehabilitación Teletón Temuco. (2014). Manejo de la disfagia neurogénica en niños, niñas y jóvenes con parálisis cerebral. *SENADIS*. Recuperado de: <http://www.senadis.gob.cl/areas/salud/documentos>
- Confederación ASPACE. (2018). Guía de alimentación. Recomendaciones para personas con parálisis cerebral y otras discapacidades con grandes necesidades de apoyo sobre alimentación y deglución. *ASPACE*. Recuperado de: https://aspace.org/assets/uploads/publicaciones/3bcc8-guia_texturizados_final.pdf
- YouTube Alma Palau, Nutrición y Dietética en Discapacidad. Disponible en: <https://www.youtube.com/channel/UCwxw2HgGNQtCKHrC0cuEpCw/feat>

PARA PROFESIONALES

- Abanto, J.; et ál. *Primeros días del bebé y salud bucal: ¡lo que necesitamos aprender!* Compendio CIOSP. Volumen 1. Editora Napoleao Ltda., Brasil, 2020.
- Mansur, J. L. (2018). Vitamina D en pediatría, embarazo y lactancia. *Arch Argent Pediatr*, 116(4):286-290 Recuperado de: <https://www.sap.org.ar/docs/publicaciones/archivosarg/2018/v116n4a33.pdf>
- Organización Panamericana de la Salud. (2010). *La alimentación del lactante y del niño pequeño*. Capítulo Modelo para libros de texto dirigidos a estudiantes de medicina y otras ciencias de la salud. Recuperado de: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44310/9789275330944_sp;jsessionid=A26F08D6595B14EE5E1994EC6EDA4D65?sequence=1
- Lázaro Almarza, A. y Martín Martínez, B. (2010). Alimentación del

lactante sano. *ERGON*. Recuperado de:

https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/alimentacion_lactante.pdf

- Santos Prieto, D.; Mai Thu, Q.; Véliz Concepción, O. L.; Grau Ábalo, R.; Hurtado Aguilar, L. (2016). Maduración de la deglución en niños de dos a cinco años y sus hábitos alimenticios. *Medicentro Electrónica*, 20(2), 104-111. Recuperado de: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30432016000200003&lng=es&tlng=es
- Brunner-López, O.; Fuentes-Martín, M. J.; Ortigosa-Pezonaga, B.; López-García, A. M. Grupo de Especialización de Nutrición Pediátrica de la Academia Española de Nutrición y Dietética. (2017). Texturas evolutivas en la introducción de nuevos alimentos. *Academia Española de Nutrición y Dietética*. Recuperado de: <https://www.academianutricionydietetica.org/archivos/Nutricion%20pediat>
- De Carvalho, G. D. El amamantamiento bajo la observación funcional y clínica de la odontología. *SAP*. Recuperado de: <https://www.sap.org.ar/docs/organizacion/subcomisiones/lactancia/lacsub3>
- Romero-Velarde, E.; Villalpando-Carrión, S.; Pérez-Lizaur, A. B.; Iracheta-Gerez, M. D. L. L.; Alonso-Rivera, C. G.; López-Navarrete, G. E.; García-Contreras, A.; Ochoa-Ortiz, E.; Zarate-Mondragón, F.; López-Pérez, G. T.; Chávez-Palencia, C.; Guajardo-Jáquez, M.; Vázquez-Ortiz, S.; Pinzón-Navarro, B. A.; Torres-Duarte, K. N.; Vida-Guzmán, J. D.; Michel-Gómez, P. L.; López-Contreras, I. N.; Arroyo-Cruz, L. V.; Pinacho-Velázquez, J. L. (2016). Consenso para las prácticas de alimentación complementaria en lactantes sanos. *Boletín Médico del Hospital Infantil de México*, 73(5), 338–356. Recuperado de: <https://doi.org/10.1016/j.bmhmx.2016.06.007>
- Coriat, L. *Maduración psicomotriz en el primer año de vida*, libro digital, autoeditado. Licencia de Creative Commons, 1974. Recuperado de: <https://www.lydiacoriat.com.ar/libro/inicio.html>
- Serrano, P. *La integración sensorial en el desarrollo y aprendizaje infantil*, Narcea S. A. de Ediciones, Madrid, 2019.
- Serrano, P. y de Luque, C. *Motricidad fina en niños y niñas. Desarrollo, problemas, estrategias de mejora y evaluación*, Narcea S. A. de Ediciones, Madrid, 2019.
- Delgado, V. y Contreras, S. *Desarrollo psicomotor. Primeros años*, Mediterráneo, Santiago, 2015.

- Cámpora, H. Deglución de la A a la Z: *Fisiopatología, evaluación, tratamiento*, Ediciones Journal, CABA, 2019.
- Bampa, S., Longuini, E. y equipo docente. *Psicomotricidad y fonoaudiología*, Editorial FEDUN, CABA, 2019.
- Rodriguez, S y Sommers, J. (2020). Curso avanzado de lactancia materna (CALM), Ramé. *Embarazo y Lactancia*. Recuperado de: <https://rameargentina.com.ar/>
- Argüelles, M., et ál. *Tratado de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica de la Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica*, Editorial Océano/Ergon, Barcelona, 2011.
- Chokler, M. *Los organizadores del desarrollo psicomotor: del mecanismo a la psicomotricidad operativa*, Cinco, Buenos Aires, 2005.
- Pikler, E. *Moverse en libertad: Desarrollo de la psicomotricidad global*, Narcea, Madrid, 1984.
- Actis, A. *Sistema estomatognático. Bases morfofuncionales aplicadas a la clínica*, Editorial Mediterráneo, Buenos Aires, 2014
- Ruiz Brünner, M. M. (2021). DIPLOMATURA EN NUTRICIÓN EN PARÁLISIS CEREBRAL. Universidad Católica de Córdoba. *Fundación Jean Sonet*. Recuperado de: <https://fjs.ucc.edu.ar/curso.php?id=17405>

1. Agradezco especialmente a Paula Galo, kinesióloga; María Fernanda Iroumé, terapeuta ocupacional; Dalma González, fonoaudióloga; y Verónica Barreyro, odontopediatra, por sus aportes en este capítulo. Con ellas y otros/as colegas aprendí la importancia de prestar atención a ciertos signos y a trabajar en transdisciplina.

Crecimiento, aumento de peso y curvas de crecimiento

Crece y crece, junquito bello,
que el viento sople y te eleve hasta el cielo,
que los dedos gordos hagan tope en los zapatos
y una marquita más en la puerta hagamos.

Crece y crece, pero no dejes de abrazarme,
cada vez más cerca tu cabeza de mi hombro



Las curvas de crecimiento son esas famosas “tablitas” que usamos los pediatras, nutricionistas y otros profesionales de la salud para acompañar el crecimiento de bebés e infancias. **Son una herramienta más dentro de un contexto de otras herramientas y parámetros.** Una persona no es un grupo de números ni un puntito en una tabla. Es importante aclararlo antes de entrar en tema.

¿Para qué sirven las curvas de crecimiento?

Estas curvas sirven para ver la progresión del crecimiento. En cada control de salud, vamos viendo si ese bebé crece en la misma curva o alrededor de ella. Al principio, las curvas suben muy rápido, esto se debe a que los bebés, durante los primeros meses, crecen con mucha velocidad, y muchos de ellos, a los 6 meses llegan a doblar el peso del nacimiento (¡imagínense pasar, por ejemplo, de pesar 60 kg a pesar 120 kg en seis meses! Ni queriendo podríamos hacerlo). **Después de los 6 meses, los bebés empiezan a aumentar menos de peso, y eso es normal, nunca más crecerán tan rápido como al principio.**

Muchas familias se asustan cuando ven que el bebé que empezó la alimentación complementaria, “no come nada”, y encima empieza a crecer más lento. Pues bien, esto es lo esperable. Así funcionan los bebés, en general. Inclusive puede, algún mes, mantenerse en el mismo peso. ¿Y qué hacemos? Vemos cómo está el bebé, qué hace (generalmente a esa edad se empiezan a mover mucho más), cómo hace pis y caca, qué se le ofrece para comer. Si todo eso está bien, simplemente observamos, que también es un acto de salud.

Veamos algunos ejemplos para los cuales son útiles las curvas de crecimiento:

María tiene 1 año y en este control pediátrico pesó 8,500 kg. María nació con 3 kilogramos, a las 39 semanas de edad gestacional. En todos sus controles pediátricos creció sobre la curva del percentil 15. Los vecinos de la familia de María dicen que está muy flaquita y en el vacunatorio le preguntaron si era prematura, entonces su papá le pregunta al pediatra cuánto tendría que pesar y qué hacer porque están muy preocupados. María es una bebé muy feliz, empezó a dar sus primeros pasos y le gusta bailar la música que escuchan sus mapadres. En el consultorio se ríe mucho cuando le muestran un títere y abraza a su mamá.

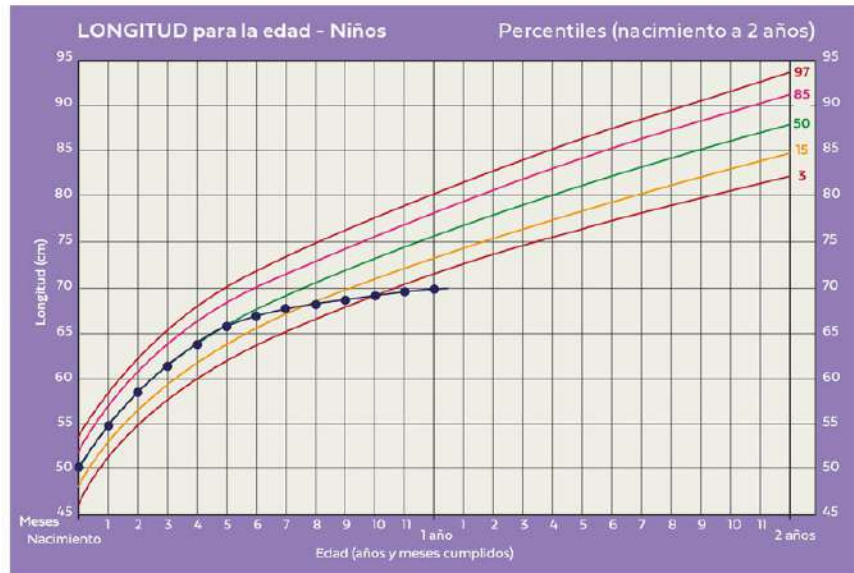


Patrones de crecimiento infantil OMS.

María es una niña sana. No es “muy flaquita” y es preciso no patologizar esto. Simplemente tiene esa contextura. Miremos por la calle: las personas tienen diferentes tamaños, alturas, pesos. No son todas iguales, los bebés tampoco. Vamos a consultar sobre la alimentación de María como haríamos con cualquier bebé, **pues la alimentación es la base para la salud, pero no porque estemos “preocupados” por su peso.** Y también le recordamos a los vecinos que no hay que opinar sobre el cuerpo de nadie, tampoco sobre el de un bebé.

Veamos otro consultante:

Juan Pablo tiene 15 meses. Nació a término, pesando 3,400 kg y midiendo 50 cm. En sus primeros 4 meses, su longitud se mantuvo sobre la curva del percentil 50, pero posteriormente empezó a crecer mucho más lento y hoy por hoy, su talla está por debajo del percentil 3.



Patrones de crecimiento infantil OMS.

¿Tiene Juan Pablo un problema en su salud? No lo sabemos, pero amerita evaluarlo. **Para esto sirven las tablas: no nos dicen si hay un problema, pero nos dan información valiosa para poder actuar.** Cuando el crecimiento, dibujado en tablas, “cruza” muy para abajo o muy para arriba las curvas, hay que prestar atención.

¿Y de dónde salieron las curvas de crecimiento? ¿Quién las hizo?

En Argentina tenemos y utilizamos dos tipos de curvas:

- Las curvas creadas con arduo trabajo por los médicos H. Lejarraga y

J. Orfila, publicadas en 1987. **Estas tablas se confeccionaron con varias muestras de niños de distintas provincias del país**, que representan todos los sectores sociales de niños sanos que viven bajo condiciones razonables de salud. Y describen el crecimiento de niños sanos del país en un momento histórico determinado. Estas tablas incluyen muestras de grupos de población de un marco muy amplio de sectores y niveles sociales, tal como ocurre con las tablas nacionales de la mayoría de los países.

- Por otro lado, entre 1997 y 2003, la Organización Mundial de la Salud llevó a cabo un estudio en el que participaron 8440 lactantes y niños pequeños saludables alimentados con leche humana con antecedentes étnicos y entornos culturales muy diversos (Brasil, Ghana, India, Noruega, Omán y Estados Unidos de América). Estos bebés eran alimentados con leche humana exclusiva hasta los 4 meses, con madres no fumadoras y que contaban con buenas condiciones de salud. **A partir de allí se confeccionaron las curvas, hasta 5 años, que se adoptaron en Argentina para su uso en 2013.**

¿Representan las curvas a todos los niños y las niñas?

No, claro que no. Siempre hay un sesgo en la confección de esas curvas: de base, en la curvas OMS hablamos de bebés amamantados exclusivamente hasta los 4 meses, pero no tenemos registrado el crecimiento de niños amamantados hasta los 2 años. Tampoco sabemos qué comieron en sus primeros años esos niños con los que se armaron las curvas. ¿Y si vivieron a puro ultraprocesado?

Entonces, las curvas ayudan pero no definen, son un punto de referencia para el profesional de la salud y no deben ser un “cuco” para indicaciones erróneas. Podemos imaginar cada curva como el carril de la autopista. No importa por cuál carril vaya cada niño, lo que nos importa es que no dé volantazos y se pase bruscamente de carril.

Existen otras curvas de crecimiento confeccionadas para algunas situaciones como la parálisis cerebral, el síndrome de Down, el síndrome de Turner, la acondroplasia y otras. En esos niños y niñas utilizamos específicamente esas tablas.

Para los bebés prematuros, tenemos que utilizar su edad corregida para percentilar, hasta los 2 años.

¿Por qué medimos la cabeza?

Los y las pediatras medimos la cabeza porque, además de observar el desarrollo neuromadurativo, **nos da una pauta de cómo está creciendo el cerebro y el cráneo**. En algunas patologías, por ejemplo, un bloqueo de la circulación de líquido cefalorraquídeo por una masa, aumenta el diámetro de golpe, y hay que estudiarlo, y cuanto antes, mejor. En otros casos, si vemos que el diámetro no aumenta en varios controles, hay que evaluar por ejemplo que los huesitos del cráneo no estén fusionados. (Los huesos del cráneo de los bebés están separados justamente para permitirle salir por el canal de parto y posteriormente para que el cerebro crezca).

Les cuento esto no para asustar a nadie, sino para enfatizar la importancia de los controles de salud y contarles por qué hacemos lo que hacemos en la consulta, explicándoles a los bebés que les vamos a poner una vincha redivertida, como Rambo (¡muy *millennial* la referencia!), para medirles la cabecita.

¿Qué pasa con los niños y las niñas que crecen en percentiles “bajos”?

Primero hay que preguntar qué considera la familia que es un bebé “normal”. En mi práctica con familias, muchos de los bebés que me consultaban como “muy flaquitos”, estaban en las curvas de percentil 50 y percentil 75.

Entonces, hay una percepción muy cultural sobre el tema, muchas veces no de la familia, sino del entorno: “La abuela dice que lo ve muy flaco”, “El primo tiene la misma edad y pesa el doble”, “En el jardín dicen que come muy poco”.

Las curvas más “bajas” no son patológicas ni son niños “muy delgados”: si un niño crece en el percentil 3, por ejemplo, (la curva más baja) y siempre creció así y es sano, no nos genera una preocupación abrumadora. Es su curva de crecimiento. Y si es un niño que juega, se desarrolla, canta, baila y se quiere tirar de la cama, está bien. **El percentil 3 puede ser tan sano como el percentil 50.**

Si el niño está por debajo del percentil 3, la probabilidad de que pertenezca a la población de niños sanos es menor del 3 %, o si lo miramos de otra manera, es parte del 3 % de la población sana que pesa eso. ¿Amerita ver qué sucede? Sí, es una señal para que el pediatra y la familia actúen, pero si vemos que está todo bien, simplemente es cuestión de seguir observando y acompañando en la crianza.

Otro tema, como aclaré antes, es si venía creciendo en la curva del medio (percentil 50) y de repente pasó a la curva del percentil 3: ahí tenemos que estudiar qué pasó. También hay que evaluarlo con relación a su talla. **Cada niño es un mundo y hay mil factores a evaluar.**

Que un niño o una niña cambie bruscamente de percentil o tenga un percentil menor a 3, no es indicación de abandonar la lactancia, suplementar con leche de fórmula o sugerir agregar mucha azúcar, dulce de leche y salsa blanca a las comidas. Amerita, si es pequeño y la mamá desea amamantar, evaluar la técnica de lactancia y trabajar con puericultoras. Además, hay que observar si el bebé no está cursando alguna infección (la infección urinaria tiene muchas veces como único síntoma el mal progreso de peso), revisar su pesquisa metabólica (por ejemplo, cómo está la hormona tiroidea, examen que se le hace al nacer a todos los bebés), chequear los antecedentes del embarazo, evaluar la función cardíaca y la presencia o no de reflujo gastroesofágico patológico...

Ofrecer la leche de fórmula como primera opción que soluciona todos los males es, en muchas ocasiones, tapar otro problema y hacer un ejercicio incorrecto de la profesión.

“Tiene bajo peso, ¿qué le doy? ¿Necesita un suplemento?”

Si una niña o un niño realmente presenta un problema en su aumento de peso, lo primero no es dar un suplemento, sino encontrar la causa. En bebés pequeños es fundamental trabajar con profesionales que se dediquen a la lactancia si es el caso, o revisar la preparación y administración de la fórmula. Muchas veces está mal diluida y le aporta menos calorías de las que el bebé necesita. Observar otros signos como las cacas, evaluar la posibilidad de infecciones o de otra causa orgánica.

En niños más grandes, revisar la alimentación, las actividades, la escolaridad. ¿Qué se le está ofreciendo en el plato? ¿Cómo se siente el niño o la niña? ¿Juega, corre? ¿Cómo va su desempeño escolar? ¿Existe alguna causa que comprometa a alguno de sus órganos que pueda generar mayor gasto calórico? ¿Cómo está el corazón? ¿Cómo están los riñones? ¿Hay algún signo de alergia alimentaria? ¿O de malabsorción?

Hay mucho que preguntar e indagar cuando un niño o una niña presenta bajo peso o alguna alteración sobre su crecimiento. Recién cuando conozcamos toda la historia, podremos encarar las posibles soluciones. A veces, en las redes sociales nos preguntan: “Mi hijo está bajo de peso, ¿qué puedo darle?”. Me atrevo a pensar que el 75 % de esos niños por los que nos preguntan está en un peso adecuado, y el otro 25 % merece, por su salud, una consulta completa y no una indicación aislada.

Los suplementos hipercalóricos, que encontramos a esta altura hasta en el kiosco, son preparaciones nutricionales formuladas para niños y niñas que tienen una indicación médica precisa para recibirlos. Desnutrición, imposibilidad de comer (por ejemplo, algunos tratamientos de quimioterapia generan ampollas en la boca que hacen muy dolorosa la ingesta), necesidad de calorías extra, etc. No son para todos los chicos, mucho menos como “reemplazo de la merienda”, como lo publicitan en las redes sociales. Tampoco son “la formulación que les da todos los nutrientes mientras aprenden a comer”, como también nos sugieren los agentes de propaganda médica que nos visitan en los consultorios.

Si una niña o un niño realmente necesita aumentar su peso, es fundamental trabajar en conjunto con nutricionistas para encontrar la

estrategia adecuada. Si el niño o la niña “come poco”, o realmente hay una cuestión de neofobia, o de selectividad extrema, tendremos que trabajar también con otros profesionales. Las indicaciones como ponerle mucha azúcar para que tenga más calorías o darle cereales en la mamadera no son adecuadas: **el problema no son las calorías, son los nutrientes que tenemos que darle a ese cuerpito en crecimiento. Y en ese camino nos tienen que acompañar los profesionales, y no la publicidad o el “qué dirán”.**

Medicamentos para “abrir el apetito”

La ciproheptadina es un antihistamínico, es decir, un medicamento antialérgico. Actúa sobre diversos receptores en el cuerpo, y cuanto menos preciso es un fármaco, más efectos secundarios se pueden originar. Somnolencia, mareos, sequedad de boca, sed, náuseas, alucinaciones... Inclusive puede interferir en la secreción de la hormona de crecimiento. No hay trabajos que constaten fehacientemente su eficiencia para “abrir el apetito”, y su uso no se recomienda. ¿Por qué le daríamos un medicamento a un niño o una niña que está sano? **Cuando tenemos que prescribir medicamentos, es porque hay una causa que lo amerita. Comer una cantidad que satisfaga a la familia no es una de esas causas: el costo de esa expectativa no lo puede pagar el niño o la niña.** No solo eso: hasta es posible que, medicando algo que en realidad tendríamos que estudiar, estemos tapando síntomas que nos indican que algo anda mal y que podríamos pesquisar a tiempo.

Infancias con baja talla

Cuando un niño o una niña crece por debajo del percentil 10, se considera, después de los 2 años, que presenta talla baja. Esto no es necesariamente una patología: ¡hay que ver primero cuánto miden los

mapadres! Porque existe la “baja talla familiar” que, como su nombre lo indica, tiene que ver con la genética de la familia. Si ambos mapadres miden 1,60 m, no podemos esperar que un niño mida 1,80 m a los 19 años. Tal vez suceda, pero no es lo más común. También existe lo que llamamos “madurador lento”, que son varones que pegan el “estirón” puberal más tarde que sus compañeros, sin afectar la talla final.

Por otro lado, hay que evaluar todo el crecimiento y desarrollo de esa niña o ese niño, su desarrollo madurativo, sus antecedentes. Luego, evaluar lo que llamamos “velocidad de crecimiento”, es decir, un cálculo que se divide entre los centímetros que ha crecido y el tiempo transcurrido. Y, posteriormente, evaluar si se requieren más estudios o el acompañamiento de un/a endocrinólogo/a infantil.

Existen niños y niñas que crecen en el percentil 3 de talla y que no presentan ninguna patología, y es por eso que es tan importante la mirada de la persona en sí y no del montoncito de números.

Obesidad y sobrepeso en la infancia

Este es uno de los temas más complejos de la pediatría contemporánea. Es preciso aclarar, antes de comenzar, que **no existe la obesidad por lactancia materna exclusiva, siendo, además, la lactancia un factor protector.**

La obesidad se define a través de un índice llamado “índice de masa corporal” (IMC), que se utiliza a partir de los 2 años de edad. Este índice, como todos, nos sirve de referencia para evaluar al peso con relación a la talla, pero le faltan datos para evaluar salud. El IMC también se percentila, y si el niño o la niña se encuentra sobre el percentil 85, habría que considerar sobrepeso, y si está por encima del percentil 97, habría que considerar obesidad.

Tenemos otros índices como, por ejemplo, la circunferencia de la cintura, que se correlaciona con la grasa que está dentro del abdomen y suele mostrar cambios más fidedignos que el IMC.

El problema generalmente no es la obesidad en sí, sino la malnutrición oculta. Los niños y las niñas dejan prontamente la lactancia (muchas veces gracias a profesionales que no acompañan las mismas), son

alimentados precozmente con productos industriales, se les brindan más productos azucarados dentro de su escolaridad y luego consumen grandes cantidades de ultraprocesados porque “no comen otra cosa”.

Independientemente de cuál sea su peso, su salud está en riesgo.

Si un niño presenta sobrepeso u obesidad, no buscamos un descenso de peso hasta por lo menos los 9 años, sino mantener el peso actual, fomentar el consumo de alimentos saludables y la actividad física. Será necesario acompañar el descenso de peso solamente en casos donde peligre la salud inmediata del niño o la niña: por ejemplo, niños que hacen apneas de sueño, presentan signos de insulinoresistencia (la previa a la diabetes) o dolor en las articulaciones.

Es fundamental que comprendamos que el grave problema son los productos de mala calidad consumidos y la falta de movimiento, más que el peso de la niña o el niño. Por eso, el abordaje no es que “el niño o la niña baje de peso y coma sano”, sino que haya un cambio de hábitos saludables en toda la familia. Que el niño coma una comida “para adelgazar” y el resto de la familia otra, es inviable. Es fundamental evitar los ultraprocesados –sobre todo jugos, gaseosas, yogures bebibles y otros productos para beber– y promover una alimentación que alimente a la microbiota saludable. El movimiento es una pieza clave también para la salud y el desarrollo de niñas y niños.

No existe la nutrición infantil, existe la nutrición familiar. Los chicos no eligen qué se compra ni qué se pone en la mesa. “Pero me pide...”. Sí, claro, pero eso es dejar de lado nuestra responsabilidad como mapadres y depositarla en los chicos, y es una carga muy pesada que no les corresponde. Trabajar en equipo pediatría y nutrición, e inclusive psicología, intercambiando miradas y saberes, y escuchando a la familia, comprendiendo que los procesos son graduales para que sean sostenidos en el tiempo, es una pieza muy importante de este camino.

Para seguir leyendo

PARA FAMILIAS

- Rey, M. B. (2016). Talla baja. *Comunidad SAP*. Recuperado de: <http://comunidad.sap.org.ar/index.php/2016/03/21/talla-baja/>
- World Health Organization. (2017). Sobrepeso y obesidad infantiles. *Organización Mundial de la Salud*. Recuperado de: <https://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/es/>
- González, C. *Mi niño no me come*, Editorial Planeta, Ciudad de México, 2014.

PARA PROFESIONALES

- Ibáñez Toda, L. y Marcos Salas, M. V. *Abordaje de la talla baja*, pág. 85-94, AEPap Curso de Actualización Pediatría 2015, Lúa Ediciones 3.0, Madrid, 2015.
- Lejarraga, H. (2007). Consideraciones sobre el uso de tablas de crecimiento en la Argentina. *Arch Argent Pediatr*. Recuperado de: https://www.sap.org.ar/docs/archivos/2007/arch07_6/v105n6a15.pdf
- Organización Panamericana de la Salud. (2014). Plan de acción para la prevención de la obesidad en la niñez y la adolescencia. *PAHO*. Recuperado de: https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11373:plan-of-action-prevention-obesity-children-adolescents&Itemid=4256&lang=es
- Setton, D. y Fernández, A. *Nutrición en Pediatría*, Editorial Panamericana, Buenos Aires, 2014.
- Sociedad Argentina de Pediatría, Comité Nacional de Nutrición. (2015). Obesidad: guías para su abordaje clínico. *SAP*. Recuperado de: www.sap.org.ar/docs/publicaciones/archivosarg/2016/v114n2a26.pdf
- Curso Universitario de Posgrado en modalidad virtual en Obesidad en Edades Pediátricas, Universidad del Hospital Italiano de Buenos Aires, 2019.
- Curso de Obesidad en Edades Pediátricas, UNICEF. Sociedad Argentina de Pediatría, 2021.

Alimentación complementaria: **guía práctica**

Te doy mis manos para acompañarte,
y vos me das la oportunidad de conocer
el mundo de nuevo.

Te doy leche, y me das risas.

Te doy mis comiditas, lo quemado de mis sartenes.

Mi dolorido camino alimentario, que se
emparcha y recompone.

Te doy mi tiempo, mi cansancio, lo poco
que sé.

Y me das tu amor incondicional e infinito.

Tu mirada llena de admiración.

Tu vocecita de pajarito.

Pronunciando mi nombre.

Mi yo renombrada.

Mi nombre nuevo.

Mi nombre, mamá.



Entonces, ¿cuándo empezar la alimentación complementaria?

Los bebés pueden iniciar la alimentación complementaria cuando:

- Tengan 6 meses de edad cronológica en bebés de término o de edad corregida (en la mayoría de los bebés prematuros).
- Tengan sostén cefálico y capacidad de mantener el tronco erguido.
- Hayan perdido el reflejo de extrusión.
- Les interese explorar alimentos.

Estas pautas son necesarias para el inicio de la alimentación complementaria, tanto sea con papillas como practicando BLW (desarrollaremos esto más adelante en este capítulo).

La autorregulación. Alimentación perceptiva

Los bebés nacen con un chip fabuloso: el de la autorregulación para comer. No se las enseña nadie: viene “de fábrica”. Pensemos lo siguiente: ¿se puede obligar a un bebé a tomar el pecho? ¿Puede tomar leche en la mamadera si no tiene hambre?

La respuesta es no. Si no tiene hambre, el bebé no abrirá la boca para tomar el pecho, o escupirá la mamadera, o rechazará el alimento con la lengua. **Los bebés tienen muy claro cuándo no tienen hambre o están llenos.**

Ahora, pensemos más allá de los bebés: ¿podemos obligar a una persona a comer? Podemos castigar, chantajear, premiar, coaccionar. Pero OBLIGAR, a menos que coloquemos algún tipo de vía directa hacia el estómago, es imposible. No se puede obligar a alguien a comer; siempre, de alguna manera, depende de la voluntad del otro.

¿Cómo comemos los adultos? ¿Nos autorregulamos? ¿O vaciamos el plato para no molestar a quien nos cocinó, aunque no tengamos hambre? O peor, ¿tenemos muchas ganas de comernos todo el plato porque está rico, pero dejamos parte porque “queda mal” que alguien con un cuerpo que no encaja en los cánones hegemónicos se coma “todo”? ¿Comemos por hambre o porque es el único rato que tenemos en el trabajo para comer? ¿Terminamos la bolsa de papitas compradas porque queríamos terminarla? ¿O porque es un producto diseñado para no dejar de comer?

Generalmente, las situaciones que ilustran las preguntas anteriores hablan de un consumo de alimentos con poca conciencia y autopercepción. No sabemos cuándo tenemos hambre porque nos regimos con los horarios del trabajo o de otras actividades, y no con la percepción de nuestras necesidades. No sabemos cuándo tenemos hambre porque nos convencieron de que había que comer cada “tres horas” o hacer seis comidas para “activar el metabolismo” y... adelgazar, que al parecer es la única forma de salud.

Un bebé de pecho que se alimenta a demanda come todas las veces que quiere en el día. A medida que va creciendo, va disminuyendo o aumentando las tomas: algunos días más, otros menos. Es común que los lactantes de dos años tomen más que los recién nacidos (y escribo esto, paciente, con mi hijo de 2 años en la teta). A veces lo hacen por hambre, otras por sed, otras porque se sienten mal, otras simplemente por la necesidad de contacto. Esos bebés saben que la teta les provee lo que necesitan, y cuando esa necesidad está suplida, sueltan la teta y a otra cosa.

Esa percepción, esa autorregulación, es lo que queremos para **toda la vida de esa persona. Queremos que bebés, niñas, niños y adolescentes sean capaces de darse cuenta de su hambre y saciedad, de poder elegir cuándo tienen ganas de comer y cuándo no.** Sin duda, muchas veces comemos por una cuestión social y no por hambre (cumpleaños o fiestas, por ejemplo), lo

cual es saludable y lógico. Lo que no es lógico es comer cada tres horas independientemente del hambre, o seguir sosteniendo que el desayuno es una comida mágica que no puede faltar.

Existen muchas opiniones de expertos y posicionamientos de sociedades sobre la alimentación infantil, sin duda. Pero todos, todos, TODOS, coinciden en un punto: NO OBLIGAR A COMER, y respetar los tiempos de la infancia. Y eso tenemos que promover y acompañar independientemente del “método” que elijamos.

¿QUÉ ES LA ALIMENTACIÓN PERCEPTIVA?

La Organización Mundial de la Salud, en su capítulo “La alimentación del lactante y del niño pequeño” de 2010, sugiere practicar la **alimentación perceptiva** desde el inicio de la alimentación complementaria:

- Alimentar a los lactantes directamente y asistir a los niños mayores cuando comen por sí solos, respondiendo a sus signos de hambre y satisfacción.
- Alimentar despacio y pacientemente y animar a los niños a comer, pero sin forzarlos.
- Si los niños rechazan varios alimentos, experimentar con diversas combinaciones, sabores, texturas y métodos para animarlos a comer.
- Minimizar las distracciones durante las horas de comida si el niño pierde interés rápidamente.
- Recordar que los momentos de comer son períodos de aprendizaje y amor, hablar con los niños y mantener el contacto visual.

Fuente: OMS.

¿Los bebés solo comen papilla?

Ustedes y yo seguramente iniciamos nuestra alimentación complementaria a los 3 o 4 meses de vida. Esa era la norma hasta el año 2001, cuando **la OMS determinó que había suficiente evidencia científica para afirmar que la leche humana o la de fórmula tenían todos los nutrientes necesarios para alimentar a un bebé durante los primeros 6 meses de vida.** La alimentación complementaria pasó a iniciarse a los 6 meses, y los pediatras se revolucionaron, se resistieron (como nos pasa a todos con todo lo nuevo) y finalmente se actualizaron.

La cuestión es que esta sugerencia abrió un nuevo panorama al cual adaptarse: no son iguales la postura y las habilidades de un bebé de 6 meses que las de un bebé de 3 meses. Un bebé de 3 meses no puede agarrar una cuchara y llevársela a la boca voluntariamente: recién está descubriendo que las manos sirven para acercar objetos. Un bebé de 3 meses no puede tomar un brócoli y deshacerlo con las encías sin correr el riesgo de atragantarse.

¿Qué puede comer un bebé de 3 meses? Hoy sabemos que lo único que debería comer es leche, pero en esa época en la cual creíamos que ese bebé tenía que comer, era lógico pensar en ofrecerle algo parecido a la consistencia de la leche. Es decir: papillas líquidas.

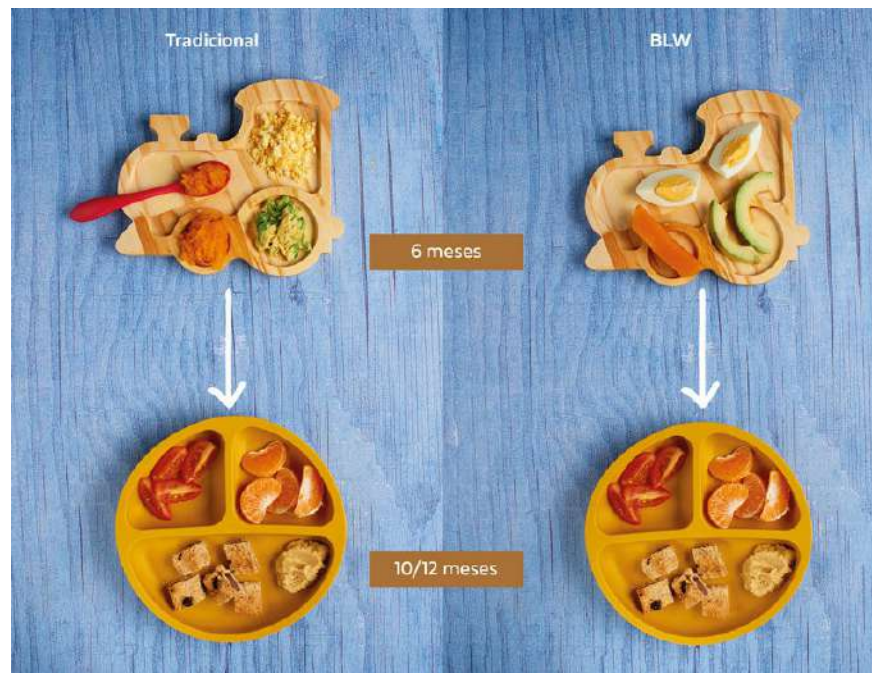
Ya hablamos al principio del libro sobre cómo se mete en este momento la industria: el mercado está plagado de “cereales para el biberón”, *pouchs* misteriosos y otras supuestas soluciones mágicas.

Todo esto llevó a un paradigma cultural: “Los bebés empiezan a comer con papillas”. Y, hoy por hoy, con más información, podríamos cambiarlo y decir: “Los bebés podrían empezar a comer con papillas si esa es la decisión de la familia, entre todas las opciones”.

Preparar papillas y progresar texturas

La OMS, en su capítulo “La alimentación del lactante y del niño pequeño” de 2010, habla de iniciar la alimentación complementaria con papillas espesas, que se puedan mantener en la cuchara y que no se escurran hacia afuera. Si

nuestra decisión es empezar a comer con papillas, es importante que sean “pisadas” y no “licuadas”, que incluyan textura y grumos, y sobre todo, que esas texturas vayan aumentando a medida que el bebé vaya adquiriendo nuevas habilidades. **Alrededor de los 10 meses, como ya hemos dicho en capítulos anteriores, todos los bebés, independientemente del método utilizado para iniciar la alimentación complementaria, deberían estar comiendo alimentos semisólidos y sólidos, pues es importante para el desarrollo de la masticación y la deglución.**



HACER EL AVIONCITO

En algunos lugares he leído que hacer BLW es “el fin del avioncito”. Bueno, permítanme decirles que no opino lo mismo. El avioncito es una tradición, un mimo de abuelas, abuelos y mapadres felices. Nadie hace un avioncito para embucharle comida a un bebé en la boca: lo hacemos porque somos felices haciéndolo, y pensamos en nombres de aeropuertos y realizamos firuletes en el aire que hacen reír al bebé. ¿Por qué no hacer avioncito si nos hace felices y si a nuestro bebé le divierte? Siempre que respetemos sus ganas y no busquemos obligar a comer...

todo estará más que bien.

Ejemplos de papillas

(encontrarán más ideas en el capítulo 14)

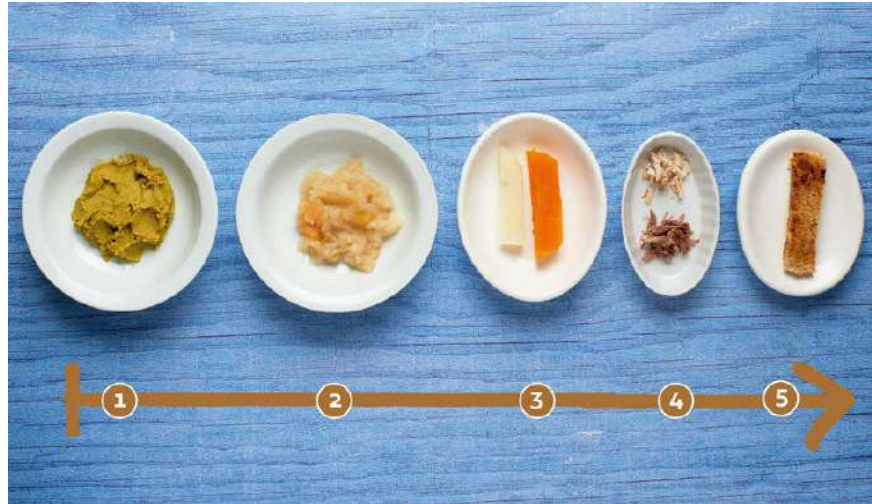
- Pasta de palta con ajo
- *Baba ganoush*
- Puré de arvejas con aceite de oliva
- Hummus de garbanzos
- Postrecitos de porotos y banana



¿Cómo voy progresando las texturas?

Este camino que voy a describir no tiene por qué ser lineal. Simplemente es una orientación para aquellas familias que desean iniciar la alimentación complementaria con papillas y no encuentran herramientas para ir aumentando las texturas. Este “caminito” se lo agradezco a la Dra. Ruiz Brünner y su equipo (en la bibliografía encontrarán su trabajo para más info).

1. **Textura procesada:** se obtiene procesando los alimentos con electrodomésticos (licuadoras, minipimers). Son texturas suaves, homogéneas y sin grumos, que no requieren masticación. No se sugieren para el inicio de la alimentación complementaria, dado que es importante que los bebés perciban otras texturas, pero nos sirven para presentar untables y otras preparaciones.
2. **Textura puré:** son alimentos modificados con el uso de un tenedor o pisa papas, que pueden contener trozos pequeños de las verduras o alimentos blandos. Por ejemplo, banana o pera pisada. No requieren masticación, pero sí coordinación dentro de la boca.
3. **Textura blanda:** son alimentos fáciles de desarmar con una cuchara o un tenedor, de consistencia suave. Los bebés inician la masticación con las encías con estas texturas, y a gestionar los alimentos. Por ejemplo, una manzana al vapor o un brócoli cocido. La textura blanda es la que usamos al inicio del BLW.
4. **Textura sólida/firme, trozos pequeños:** son alimentos que han sido modificados mecánicamente y se encuentran en pequeños trozos. Requieren menos esfuerzo de masticación, pero demandan coordinación en la boca. Por ejemplo: carne de vaca cortada.
5. **Textura sólida/firme, trozos grandes:** son alimentos firmes que se consumen en bocados, que requieren mayor tiempo en la cavidad bucal y mayores habilidades de masticación. Suelen ser alimentos secos, fibrosos y/o crocantes. Por ejemplo: galletitas, pan tostado, carne asada, milanesa, verduras fibrosas.



Como se puede observar, de a poco se van aumentando las texturas para que el bebé pueda ir experimentando, practicando y volviéndose un experto en la gestión de alimentos. Si le ofrecemos banana o zapallo pisados varios días y luego una galletita crujiente, ese bebé que de repente tiene que manejar algo que es duro, que no sabe masticar y que tiene miguitas, está en riesgo de atragantamiento. Sin embargo, es algo que se sigue recomendando en las listas de alimentación complementaria de muchos profesionales que plantean que el BLW es peligroso. ¡Seamos coherentes con los mensajes a las familias!

Algunas preguntas, afirmaciones y mitos frecuentes sobre ofrecer papillas

- **¿Está mal dar papillas?**

Claro que no. Es una opción para muchas familias.

- **¿Dar papillas es posible en una crianza respetuosa?**

Por supuesto. La crianza respetuosa está relacionada con la alimentación, como vimos previamente, pero no tiene que ver con el tipo de método para iniciar la alimentación complementaria. No hay una lista que hay que ir cumpliendo: porteo, pies descalzos, BLW... ¡Ninguna de esas cosas nos aseguran una crianza respetuosa! Respetar los tiempos y las ganas del bebé es lo importante, simplemente eso.

- **“Dar papillas es más limpio y sencillo”**

Disiento muchísimo con esta afirmación. La alimentación complementaria es exploración, y la exploración no es prolija: todo será un enchastre en los primeros meses, y eso está bien y es sano. A medida que el bebé va creciendo, se vuelve un poco más limpio, pero no esperemos pulcritud.

Con relación a la sencillez, son opiniones, así que todas son válidas según la experiencia. Detesto rallar manzana, así que en mi experiencia, me fue más sencillo asar manzanas al horno y comerlas con mis hijos. O, en la planificación de comidas, pensar qué iba a comer yo y adaptarlo a ellos. Otras personas pisan purés con infinito amor y me han dicho que hacerlo les resulta más rápido. Así que queda a criterio de cada uno.

- **“Los bebés necesitan papillas porque no tienen dientes”**

Hay bebés que tienen dientes desde los 2 meses, o nacen con dientes, y eso no significa que puedan masticar un trozo de carne. El desarrollo de la masticación y la deglución tiene sus tiempos, y lo he abordado en el capítulo 5. Los bebés no mastican con los dientes, mastican con las encías. Y aquí aparece algo crucial: la importancia de masticar. Ir probando diferentes texturas, no solo las blandas o cremosas. El impacto de las distintas texturas sobre las encías también ayudará en el proceso de dentición.

- **“Como toma fórmula, tiene que empezar la alimentación complementaria a los 4 meses”**

No hay ninguna bibliografía que sustente esta afirmación. Los bebés que no reciben leche humana tienen más riesgo de padecer alergias, y hasta lo que se sabe hoy (año 2021), adelantar la alimentación complementaria previa a los 6 meses aumentaría ese riesgo.

- **“Aunque tiene menos de 6 meses, como tiene dientes, hay que empezar con la alimentación complementaria”**

La presencia de dientes no es indicación de inicio precoz de la alimentación complementaria. Hay que evaluar todo el desarrollo (ver capítulo 5 sobre desarrollo infantil), y como ya dijimos varias veces, el sistema renal, el digestivo y el inmunológico no estarían preparados para iniciar la alimentación complementaria antes de los 6 meses.

Hablemos de Baby Led Weaning (BLW)

Si me preguntaran una definición del Baby Led Weaning (o “alimentación dirigida por el bebé”, una de sus tantas traducciones al castellano), respondería que **es una manera, basada en la alimentación perceptiva, de presentarle alimentos de buena calidad nutricional al bebé que inicia la alimentación complementaria, de tal forma que sea capaz de tomar los alimentos con sus manos y llevarlos a la boca, adaptando su textura, tamaño y forma a sus habilidades neuromadurativas.**

Hablando de traducciones, Baby Led Weaning también se traduce como “destete dirigido por el bebé”. Cabe explicar que la palabra *weaning* (en inglés) no significa “destete” por “dejar la teta”, sino por “incorporar otros alimentos aparte de la teta”.

A mí no me gusta decir que el BLW es un “método”, porque no es nada nuevo. La alimentación complementaria, antes de que Gerber y Nestlé inventaran la primera papilla comercializada alrededor del 1900 y que los pediatras fuéramos los “indicadores” de las primeras comidas, era de esta manera. No hemos descubierto nada. Al revés: **el BLW implica empezar a desestructurarse, a disfrutar, a percibir al bebé como persona y parte de la familia, y que el comer sea un momento de experimentos y disfrute.**

El BLW plantea:

- Sentar al bebé a la mesa con toda la familia; que no haya un momento “diferente” para que coma el bebé.
- Ofrecer al bebé las mismas comidas que consume la familia, adaptadas a su desarrollo, sin necesidad de preparar alimentos “especiales” (ver próximo capítulo).
- Permitir que se alimente por sí solo, usando las manos o los cubiertos, según la edad.
- Recordar que la leche humana o de fórmula es la base de la nutrición durante el primer año de edad: no reemplazar ni espaciar tomas para

“que tenga más hambre”.

Algunas preguntas frecuentes sobre BLW

- **¿Todos los bebés pueden hacer BLW?**

Se considera que todo bebé que cumpla las pautas madurativas propuestas para el inicio de la alimentación complementaria está apto para realizar BLW. Si el bebé tiene alguna condición de salud que comprometa estas cuestiones madurativas, simplemente se tratará de buscar la forma en que esa persona disfrute y experimente la comida tanto como cualquier otro bebé.

- **¿Trae algún beneficio iniciar la alimentación complementaria con BLW por sobre hacerlo con papillas?**

Actualmente, no existe evidencia de que si respetamos las señales del bebé (lo que ya definimos como “alimentación perceptiva”), sea mejor un “método” que otro. Se han propuesto ciertas ventajas del BLW como, por ejemplo:

- Posible menor riesgo de obesidad, resultado de una mejor autorregulación de la ingesta.
- Mejor aceptación de alimentos y texturas a largo plazo.
- Mejor calidad de alimentos ofrecidos.
- Efectos favorables sobre la actitud de la familia hacia la alimentación del bebé: familias informadas y empoderadas, con mayor disfrute del momento.
- Habilidades motoras del bebé más desarrolladas en el ámbito de la alimentación.

Personalmente, podría brindar mi opinión como pediatra y como mamá: lo importante es el disfrute del momento. Es entender que la alimentación complementaria es una oportunidad única y que ese bebito que se mancha la frente de palta pronto será un escolar que come pochoclo en un campamento. Cuando escribí *Hoy no es siempre*, mi hijito era un bebé de 6 meses que desarmaba bollitos de mijo y los investigaba con fruición. Hoy tiene 2 años, sabe decir “frutilla” y apretar la tecla de la licuadora cuando hacemos heladitos.

Van creciendo y nuestros miedos cambian, y no comprendemos cómo pensamos alguna vez que nunca iban a aprender a comer.

En los últimos años, acompañé a unas 300 familias en el consultorio, y más de 3000 pasaron por los talleres. Es muy lindo escuchar los relatos una vez iniciada la alimentación complementaria. No, no crean que todos esos relatos son tranquilos y despreocupados, para nada: ¿quién no mira con ansiedad a su bebé las primeras veces que se lleva algo a la boca? ¿Quién no se pregunta: “Che, hace dos días que solamente toma teta y come durazno, ¿estará bien?”, más de una vez? Pero los años van pasando y esos bebitos van creciendo, pasan por mil etapas, se escolarizan, van a la colonia, hacen amigos, van a cumpleaños y su mundo social se hace cada vez más amplio. Y muchos de ellos, gracias a sus familias informadas, siguen eligiendo alimentos sanos y variados a largo plazo, y crecen sanos y fuertes. ¡La satisfacción es enorme!

Si te entusiasma hacer BLW, adelante, con información y curiosidad por este nuevo mundo. Si no les parece como familia una buena opción, no pasa nada. Disfruten.

- **¿Qué dice la Sociedad Argentina de Pediatría sobre el BLW?**

En su curso para profesionales llamado “Programa Nacional de Actualización Pediátrica: Nutrición” (2020), la Sociedad Argentina de Pediatría plantea al BLW como una posibilidad, junto con la alimentación tradicional con cuchara, instando a los profesionales a interiorizarse sobre el tema y a aportar información fidedigna a las familias para poder decidir.

- **¿Qué dicen otras sociedades científicas sobre el tema?**

El BLW es descripto por numerosas sociedades científicas alrededor del mundo, como la Asociación Española de Pediatría (2018) y el Departamento de Salud de Cataluña (2016). Las guías alimentarias de Brasil, Canadá, Australia, Gran Bretaña y otros países sugieren fuertemente la alimentación perceptiva, compartir la mesa con la familia y los alimentos simples y ricos en nutrientes.

¿Tiene desventajas el BLW? Hablemos del estudio BLISS

Dijimos que el BLW propone incorporar al bebé a la mesa familiar, y no preparar comidas especiales, sino adaptar las comidas que consume el resto de la familia para el bebé. El problema es que **si la familia no cambia sus hábitos poco saludables, el bebé estará en riesgo de no recibir los nutrientes adecuados**, sobre todo el hierro. Este es un gran interrogante con relación al BLW. ¿Reciben los bebés los nutrientes necesarios? Los que son alimentados con cuchara, ¿están en menor riesgo nutricional?

Los artículos científicos al día de la fecha indican una respuesta positiva al primer interrogante, con un condicional: sí; si a los bebés se les ofrecen alimentos de buena calidad nutricional, los nutrientes necesarios estarán cubiertos. Si les ofrecemos únicamente zapallo y papa durante semanas, no; no importa la forma en que los ofrezcamos: no tengo nada en contra de esos vegetales, pero su contenido de hierro es mínimo y no cubrirá las necesidades de ese bebé.

En 2015, a consecuencia de estas preguntas y a otros potenciales riesgos del BLW —como que el bebé tenga más riesgo de atragantamiento— se publica un estudio realizado en Nueva Zelanda llamado “Baby Led Introduction to Solids (BLISS)”.

En dicho estudio, se comparaba a un grupo de familias que habían sido asesoradas durante el embarazo y durante los primeros meses de vida sobre el BLW, con otro grupo al que no se le brindaba esa información específica. Ambos grupos también eran constantemente asesorados por profesionales formados en lactancia, para acompañar el sostenimiento de la misma.

Para el estudio BLISS, se les sugerían a las familias participantes las

mismas pautas que para iniciar el BLW. Se destacaba la importancia de la presencia de mapadres atentos, de no apurar al bebé, de no meterle comida en la boca y de ofrecer alimentos con texturas adaptadas.

Destaco el siguiente cuadrito que se les brindaba a las familias con información:

NO ESPERES QUE:

- Tu bebé coma algo en las primeras presentaciones de comida. Una vez que descubra que sus nuevos juguetes tienen rico sabor, primero los chupará, después los masticará y posteriormente empezará a tragarlos.
- Tu bebé se coma un trozo entero de comida si aun no ha desarrollado la habilidad de llevarse la comida a la boca.
- Un bebé pequeño tenga una “dieta perfecta”. A veces vas a pensar que tenés un bebé “mañoso” o “mal comedor”. Traten de relajarse y permitir al bebé que experimente con los alimentos, a medida que se vaya familiarizando con los alimentos y con comer, va a aumentar la aceptación de sabores y texturas.

El estudio BLISS también sugería a las familias ofrecer siempre alimentos de alta calidad nutricional, presentando en el plato:

- **Un alimento rico en hierro (carnes, legumbres).**
- **Un alimento rico en energía (carbohidratos, grasas).**
- **Una fruta o verdura.**

De este estudio, se tomaron varias variables en general para sugerir a las familias que realizan BLW. Entre ellas, esta última recomendación:

“Sugerimos siempre ofrecer estos alimentos de buena calidad nutricional, en cada comida”. ¿Comerá el bebé toda esa comida? Algunos bebés sí, pero lo más probable es que dejen gran parte. Seguimos confiando en su regulación.



Alimentos ricos en hierro



Alimentos ricos en energía

Las profesionales que diseñaron y trabajaron en el estudio BLISS publicaron una gran cantidad de trabajos sobre el tema, y llegaron a varias conclusiones, aún en desarrollo:

- El BLW, adaptando las texturas y los tamaños a las habilidades del bebé, no tiene mayor riesgo de atragantamiento que las papillas.
- Practicar BLW no tendría un efecto protector con relación a la obesidad infantil, pero sí ayuda a la aceptación a largo plazo de una mayor diversidad de alimentos.
- Practicar BLW ofreciendo alimentos de alta calidad nutricional (un alimento rico en hierro, uno rico en energía y frutas/verduras en la misma comida) no generaría mayor riesgo de anemia y ni otros déficits de nutrientes como el zinc.

Es muy importante que los profesionales nos sigamos formando en el tema. **¿Es el BLW posible para todas las familias? No, pues cada familia es un mundo, pero con información adecuada, es posible que sea una buena opción para muchas.**

BLW mixto

En ocasiones, hay familias que desean practicar BLW pero sus bebés concurren al jardín o quedan a cargo de cuidadores que no se animan a implementarlo (como abuelos con muchas recetas de purecitos guardadas con amor para sus descendientes). ¡La realidad de todas las familias no es la misma! Y las recomendaciones tienen que adaptarse a cada una. No hay problema, **lo ideal es instruir a los cuidadores a respetar la exploración y las ganas del bebé.**

No subestimemos a los abuelos: en mis talleres y charlas han venido muchísimos y han compartido con cariño sus ideas y lo que se hacía en su época, y escuchado las novedades. Lo que “se hacía antes” no estaba MAL, y esto es importante. Simplemente no se tenía la misma información que ahora,

y los tiempos han cambiado. Hace cien años, un bebé con un peso “límite” para su edad tenía menos posibilidades de sobrevivir. Hoy, la mayoría de las infancias también tienen malnutrición, pero por exceso de calorías de mala calidad. El problema, ahora, es otro.

¿Puedo iniciar la alimentación complementaria con papillas, o en forma mixta, o hacer BLW y cada tanto dar un puré, si respeto la autorregulación? Ya hemos dicho que sí, porque aquí lo importante es permitir que el bebé experimente.

¿Y qué ofrecemos primero? Las frutas y verduras suelen ser uno de los primeros alimentos que ofrecemos. ¿Es obligatorio? No, es algo cultural: podríamos empezar la alimentación complementaria con porotos, con carne, con hongos comestibles o con cualquier cosa que sea parte de nuestra alimentación cotidiana (excepto algunos alimentos que pueden hacer mal, ya los veremos más adelante).

Comenzar la alimentación complementaria con frutas y verduras está muy bien, pero es importante saber que no tienen un gran contenido de hierro ni de otros nutrientes importantes, así que **desde el inicio hay que variar todos los grupos de alimentos**. ¿Es posible? Sí, es posible. En el próximo capítulo, “Pequeño manual BLW ilustrado”, les cuento cómo presentar cada uno de los grupos de alimentos.

BLW y riesgo de atragantamiento

Mientras escribía este capítulo, abrí una encuesta en redes sociales preguntando cuál era el mayor mito sobre el BLW. Copiaré frases textuales:

“Me dijo el pediatra que se podía morir ahogado”.

“Que están enseñando a ahogar a los bebés”.

“Se va a ahogar, a asustar y no va a querer comer nunca más”.

“Que se ahogan porque no están preparados para eso”.

“Como no tienen dientes, se van a ahogar”.

“Están salteando pasos”.

“Es un peligro, solo sirve para hacer enchastre y malcriar”.

“Es tan peligroso que se sugiere un curso de RCP para hacerlo”.

El miedo al ahogo es la principal preocupación de las familias que deciden hacer BLW, y no ayudan las voces ajenas que asustan, mucho menos si estas son de profesionales. Ante este cuestionamiento, existen muchos estudios científicos (uno de ellos el BLISS antes mencionado) que compararon bebés que comían papillas con bebés que hacían BLW. Adivinen: la respuesta fue que ambos grupos hacían arcadas por igual. Al final del capítulo, pueden encontrar las referencias de los estudios correspondientes.

¿Por qué el BLW, bien practicado, es seguro? Porque, justamente, no se ofrecen alimentos sólidos que no se puedan deshacer ni de formas redondeadas que puedan obstruir la vía aérea. Se sugiere la cocción de los vegetales, como la manzana y la zanahoria, y evitar los alimentos esféricos. Los frutos secos no se indican enteros hasta los 4 años al menos. Inclusive es importante evaluar la textura de las galletitas y de otras preparaciones, aunque sean caseras.

Durante años, se sugirieron papillas, postrecitos y galletitas rígidas del tipo *bay biscuit*. Estas galletitas crujientes tienen un mayor riesgo de atragantamiento que un brócoli, pero en ese momento a pocos les preocupó. Lo mismo con la indicación precoz de alimentación complementaria: sugerir alimentos antes de los 6 meses, por cuestiones madurativas, tiene mucho más riesgo de asfixia que esperar a que los bebés muestren las pautas de desarrollo requeridas.

En los adultos, el reflejo nauseoso se produce cuando un estímulo entra en contacto con la parte posterior de la garganta o la base de la lengua, provocando la contracción de los músculos de alrededor de la faringe y ocasionando una arcada. La arcada, por lo tanto, es un mecanismo que empuja el alimento lejos de la vía aérea, si este es muy grande, para ser tragado. En los bebés, este reflejo se gatilla mucho más adelante en la lengua, activándose más rápido que en los adultos, con el estímulo más lejos de la vía aérea.

Por lo tanto, **la arcada es normal y natural, y no es necesario intervenir.** Lo más probable es que el niño tosa una o dos veces y se ponga rojo, uno se asuste mucho, y a los diez segundos, gestione ese trocito y siga jugando como si nada. Es inclusive posible que vomite, porque el reflejo nauseoso se completa.

¿Qué hacemos? Participar del momento, evitar la angustia extrema. Evitar sacar al bebé de la silla y golpearle la espalda o meterle la mano en la boca.

¿Por qué? Porque si hacemos eso, hay más riesgo de mover el trocito que el bebé estaba manejando bien y realmente causar la asfixia.

¿Cuándo nos asustamos? Cuando no hay tos, no hay respiración ni sonido. Eso es un ahogo y puede ocurrir con cualquier tipo de alimentación o cuerpo extraño pequeño. En ese caso es preciso realizar la maniobra de desobstrucción o maniobra de Heimlich, que muestro en detalle un par de párrafos más adelante. Puede haber cambio de color o desmayos también.

¿Cómo prevenimos? No ofrecemos pedazos pequeños ni partículas que puedan ir fácilmente a la vía aérea (maní, pochoclo), y nunca dejamos a un bebé comiendo solo (ni siquiera si iniciamos la alimentación complementaria con papillas).

Siempre es útil hacer un curso de primeros auxilios donde nos enseñen la maniobra de desobstrucción. Ojalá nunca la usemos, pero los niños son exploradores natos y la primera exploración siempre es con la boca. Es más probable que se atragante con una piedrita que tomó del jardín que con la comida.

Los bebés se atragantan y tosen con la leche humana. Se atragantan y tosen con las papillas. Se atragantan y tosen haciendo BLW. Es decir, aprender a alimentarse incluye tropezos, al igual que aprender a caminar.

El cuerpo de tu hijo es sabio y está listo para comer. Confía en él.

Maniobra de desobstrucción en lactantes (maniobra de Heimlich)

Hay que tener en cuenta el peso del niño a la hora de realizar las maniobras de desobstrucción. Por este motivo es muy importante utilizar las piernas como sostén cuando sujetamos al lactante y no hacerlo “en el aire”.

1. Observar la boca del bebé. Si el objeto se observa fácilmente, cerca de los labios y se puede extraer, hacerlo. Si está en el fondo de la garganta o no se visualiza, no intentar sacarlo por el riesgo de empujarlo más adentro en la vía aérea y empeorar la situación.



2. Tomar al lactante con un brazo y colocarlo boca abajo.
3. Sentarse y apoyarlo sobre la pierna del mismo lado, que estará levemente estirada y hacia abajo.
4. El rostro debe ser tomado sosteniendo el mentón, con cuidado de no presionar los ojos ni el cuello.
5. Realizar 5 golpes secos y moderadamente fuertes entre ambos omóplatos.



6. Si no escupe el cuerpo extraño, girar al bebé boca arriba sobre el otro brazo y realizar presión torácica con dos dedos en el medio del tórax

(sobre el esternón, a la altura de las tetillas). Hacer 5 compresiones.



7. Esta secuencia (5 golpes boca abajo, 5 compresiones boca arriba) se debe repetir hasta que expulse el cuerpo extraño o que el bebé pierda la conciencia. De suceder esto, es necesario comenzar con las maniobras de RCP.

Maniobra de desobstrucción para niños mayores

Esta maniobra se suele usar aproximadamente desde que los bebés se vuelven deambuladores, y es muy similar a la que utilizamos en adolescentes y adultos.



1. Ante un cuadro de asfixia, arrodillarse al lado del niño y explicarle que lo vamos a ayudar.
2. Arrodillarse o pararse detrás del niño y rodearlo con los brazos de modo que las manos queden en la parte delantera de su cuerpo. Formar un puño con la mano y colocar el pulgar levemente por encima del ombligo. Agarrar el puño con la otra mano y realizar compresiones rápidas hacia arriba y hacia adentro del estómago.
3. Seguir con las compresiones hasta expulsar el objeto y hasta que el niño o la niña pueda RESPIRAR, TOSER O LLORAR. Si el niño pierde la conciencia, comenzar con las maniobras de RCP.

Es conveniente, como mencioné antes, realizar un curso de primeros auxilios inclusive antes de que nazca nuestro bebé. ¿Para qué? Para poder practicar con muñecos, por ejemplo, y tener incorporada la maniobra en caso de haber algún episodio de este tipo. Los bebés son exploradores, y si bien es

común la asfixia por alimentos no adaptados (sobre todo frutos secos enteros), es más común encontrar botones, piedritas y pilas de botón (muy peligrosas) en la vía aérea de niños que han sufrido una aspiración accidental.



Algunas preguntas, afirmaciones y mitos frecuentes acerca del BLW

- “Un bebé alimentado con biberón no puede hacer BLW”. La succión de un bebé que se alimentó siempre con biberón es un poco distinta a la de un bebé que se alimenta directamente del pecho materno (lo vimos en el capítulo 5, sobre desarrollo). Sin embargo, esto no condiciona para nada la práctica de la alimentación perceptiva. Como dijimos en el capítulo 3 sobre la leche: siempre a demanda, observando las necesidades del bebé.

- “Si hacemos BLW no puede comer ninguna papilla porque se confunde”. Los adultos comemos muchas papillas. El puré de papas, ni más ni menos. A mí me gusta mucho, sobre todo con aceite de oliva y pimienta. También me gusta mucho la pasta de chocoporotos, el *baba ganoush*, el guacamole, el helado e infinidad de otros alimentos en forma de papilla. Los bebés que hacen BLW no se van a confundir si alguna de sus comidas es untable o cremosa. Los bebés son esponjitas de conocimiento, su cerebro está ávido de experiencias. La experiencia de comer un purecito es más que válida y no, no los “confunde”. El problema estaría en dar solamente papillas durante muchos meses y luego ofrecer de golpe y porrazo un alimento semisólido o sólido. Si el bebé no tuvo tiempo de practicar y explorar... sí, tendrá más riesgo de atragantamiento.
- “Hacer BLW es dejar que el bebé coma solo, sin la presencia o asistencia del adulto”. Para nada. Hablamos al principio de la importancia de la presencia del cuidador, de su mirada atenta y de su ejemplo. Con respecto a la asistencia, es sencillo: por más que los bebés se lleven alimentos solos a la boca, no se deja de asistirlos. Se les ofrecen los alimentos, se les hacen muchas sonrisas, hablamos de lo rico que está, nos reímos, sacamos fotos, le damos en la manito un pedazo de banana, les cargamos una cuchara con algún puré y se lo ofrecemos para que se lo lleven a la boca, les damos una mano con el vaso de agua. Hay INFINIDAD de pequeños momentos, ya sea ofreciendo papillas o BLW, en los que el adulto participa en esa alimentación, porque comer es un acto social. La diferencia troncal es no obligar a comer. No meter comida en la boca a la fuerza. No insistir con “un bocado más” cuando claramente esa pequeña persona no lo desea. Hace un tiempo me contaron una indicación pediátrica que consistía en distraer al bebé para meterle la cuchara en la boca, presionar la lengua hacia abajo con la cuchara y volcar el contenido de la misma atrás de la lengua para que lo tragara. Se le había informado a la familia que esto era fundamental para que la bebé comiera y subiera de peso. Toda esta indicación, desde el

principio hasta el final, es justamente lo que no sugeriríamos. ¿O acaso a ustedes les gustaría que les metieran comida hasta la garganta? Calculo que no, y lo más probable es que vomiten o se ahoguen. Y sí, esto también les pasa a los bebés. Y agrego algo más: si hay algún problema con el peso, hay que averiguar qué sucede médicamente (¿alergias?, ¿reflujo?, ¿bebé absolutamente sano simplemente de contextura pequeña?); si realmente sucede algo, tratarlo en forma interdisciplinaria. Obligar a comer no es nunca la solución.

- “Hacer BLW es dar pedazos sólidos y el bebé no está preparado para eso”. Por supuesto, el bebé, cuando inicia a comer, no está preparado para darle un mordisco a una manzana ni para masticar un turrón de Navidad. Y justamente es lo que plantea el BLW: ofrecer texturas ADAPTADAS a cada edad. Las primeras texturas serán muy muy similares a las que ofreceríamos si empezáramos la alimentación complementaria ofreciendo puré.
- “Como hago BLW, puedo ofrecer alimentos “alergénicos” desde el inicio y lácteos recién después del año”. Una confusión muy común. Lo veremos más adelante, pero los bebés que inician con papillas también pueden comer frutilla o huevo desde el inicio de la alimentación complementaria, y tampoco deberían recibir lácteos de vaca hasta el año ni alimentos ultraprocesados. No tiene que ver con la forma de iniciar la alimentación complementaria, sino con nueva evidencia en relación con los alimentos que estamos ofreciendo a las infancias y su impacto en su salud.
- “Si tiene 10 meses y siempre le di papillas hechas con procesadora, ¿puedo empezar a darle trozos más sólidos?”. Si el bebé comió siempre procesado, debe hacer el caminito de aprender a masticar y a tragar alimentos más sólidos,

por lo que tendrá que hacer una transición, como vimos al comienzo del capítulo, progresando texturas.

- “Hacer BLW desperdicia mucha comida”. En cualquiera de las dos formas (o tres, si pensamos en el BLW mixto) de iniciar la alimentación complementaria, habrá una exploración, un descubrimiento y un poco de enchastre. No tomemos como “desperdicio” algo que le aporta a nuestro bebé herramientas que va a utilizar toda su vida. Simplemente ofrezcamos porciones pequeñas para evitar que una gran cantidad de alimento no llegue a la boca y sí al piso.
- “Haciendo BLW no va a aprender nunca a usar cubiertos”. Hace poco me dijeron esto y también que “cada vez se veían más chicos que no aprendían a usar el tenedor”. Sentí que me hablaban de una NUEVA pandemia que generaría gente comiendo con la mano en un almuerzo laboral a los 45 años. Bueno, esto no pasa. Los bebés aprenden a usar los cubiertos si se los ofrecemos y les damos el ejemplo, así como con el tiempo aprenden a usar el lápiz, la lapicera fuente y la tarjeta del subte.
- “Comencé con BLW pero hacía arcadas y me dio miedo”. Las arcadas y la tos, como explicamos antes, son parte del aprendizaje. Tienen que hacerlas si las necesitan. Hablan de que ese bebé es perfectamente capaz de defender su vía aérea. Los bebés se atragantan con leche, saliva, papillas, trozos blandos... Cuando sucede la arcada, es porque el trozo está lo suficientemente lejos de la vía aérea como para expulsarlo, y hay aire pasando.
- “Tengo pánico a que coma y le pase algo. ¿Puede seguir con leche?”. Este miedo es muy común y esta frase la escuché muchas veces. Tenemos que poder permitir el crecimiento de las infancias. No se trata de no tener miedo, se trata de buscar

herramientas para transitar ese miedo. Los bebés necesitan iniciar la alimentación complementaria como parte de su desarrollo natural, y nos necesitan a nosotros para acompañarlos. Cuando empiezan a moverse, rolar y pararse, también hay tropiezos. Cuando se suban a una bicicleta, seguramente se caerán un par de veces. No podemos meterlos en una burbuja para que no se lastimen. Si el miedo y la angustia de los mapadres o cuidadores son insoportables, es una gran opción no reprimir esos sentimientos, sino buscar asistencia con profesionales de la salud mental para que los acompañen a desarrollar estrategias.

Utensilios utilizados en la alimentación: sillita, babero, vaso, cucharas...

¿Qué sillita de comer elijo?

Es importante que el bebé esté sentado cómodo y por sus propios medios, y no atado a la silla. Algunas sillas tienen correas y arneses de seguridad, y están muy bien, pero no tienen que apretar ni mantener posturas a las que el bebé no haya llegado solo. También tienen que permitir poder sacarlo de la silla en el caso de una situación de asfixia.

Hay miles de sillitas en el mercado, de todos los precios. En el caso de poder elegir, les dejo estas sugerencias:

- **Que sea fácil de limpiar** (fundamental, necesitamos que la vida sea un poquito más sencilla).
- **Que permita que el bebé coma cerca de la familia.** Algunas tienen una mesa tan grande que el bebé queda muy alejado y no puede ver lo que hacen los adultos (y sabemos que los bebés aprenden con el ejemplo).

- **Que tenga apoyo para los pies.** Imagínense comer con los pies colgando: puede ser algo muy molesto y distractor. Para poder enfocarnos en los alimentos que hay en nuestra mesa, tenemos que lograr un control motor de nuestro cuerpo: alinear pies, cadera, tronco, hombros, cuello y cabeza. ¡Es un montón! Y lo hacemos todo el tiempo en forma inconsciente, porque lo aprendimos en algún momento. ¿Cuándo? Cuando éramos bebés. Los bebés están logrando ese equilibrio, experimentando, probando y formando conexiones entre las neuronas. Aportarles una superficie estable para apoyar los pies les puede proporcionar información posicional adecuada para focalizar su atención en la exploración del alimento.

Opciones recomendadas

Booster: es económica y práctica. Se adapta a las sillas de la casa o se puede poner en el piso.

Silla clásica: muchas veces heredada de hermanos, primos y amigos. ¡Está muy bien! Evaluar que no tenga correas que aprieten la panza o que hagan difícil sacar al bebé de la silla en el caso de una obstrucción.

Silla evolutiva: ofrece un buen apoyo para los pies y permite ir regulando las alturas y posiciones hasta que el niño o niña quiera usarla (¡o hasta la adultez!).

Silla y mesita baja: grandes aliadas para deambuladores.

Torre de aprendizaje: artefacto muy útil para que los bebés curiosos que ya se ponen de pie nos acompañen en el día a día. Pueden comer parados en su lugar en la mesa y participar en el preparado de los alimentos, dado que la torre los pone a la altura “de los grandes”.



Silla tipo booster



Silla clásica



Silla evolutiva



Silla y mesita baja



Torre de aprendizaje



Opciones que es mejor evitar

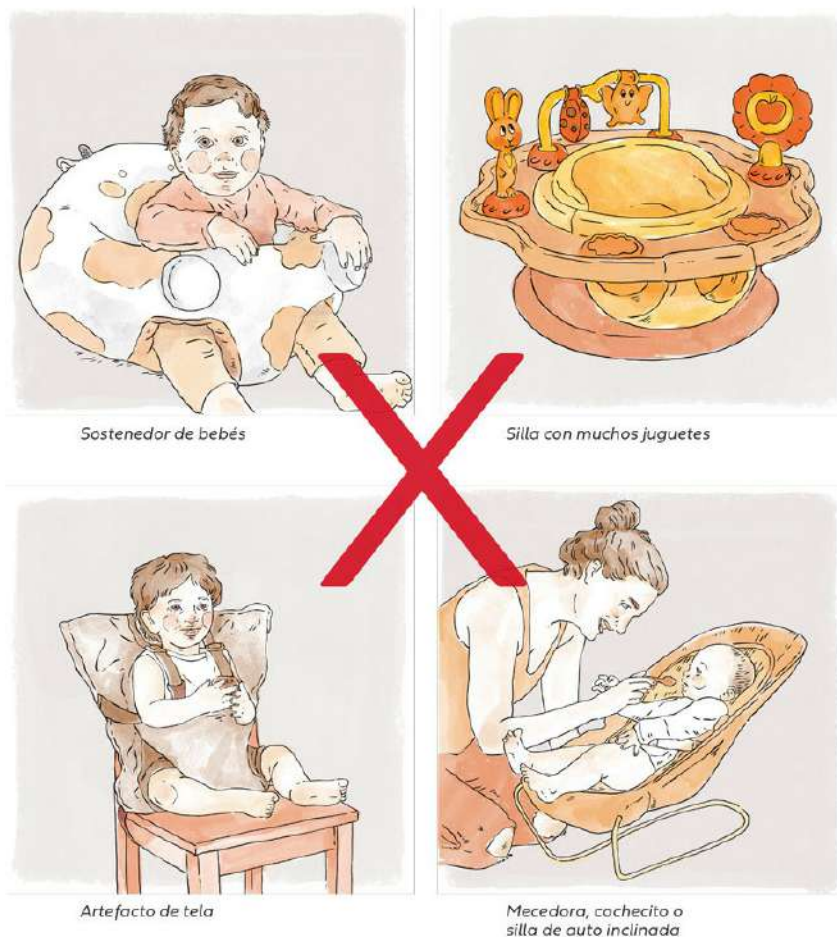
Si el bebé no mantiene erguido el tronco, tal vez no sea el momento para iniciar la alimentación complementaria y haya que esperar un poquito más. Es importante no forzar posturas con correas o artefactos. Si es preciso iniciar la alimentación complementaria porque, por ejemplo, el bebé ya tiene más de 7 meses y es preciso incorporar otros nutrientes y presentar otras texturas (ver capítulo 5 sobre desarrollo), el cuerpo del adulto puede proveer el sostén necesario, sin forzar posturas ni atar al bebé a una silla (ver más adelante).

Los sostenedores de bebés: “cosos” que mantienen al bebé en una postura a la que no llegó por sí mismo. Hay una especie de pelela muy común en otros países, donde la cola del bebé cae en un espacio debajo de sus rodillas, manteniendo una postura forzada y que no recomendaría para tragar y digerir.

Las sillas con muchos juguetes, luces, sonidos y pantallas. Estos chiches pueden ser distractores importantes. La idea es que jueguen y exploren con la comida y lo que la acompaña, sin otros artefactos que puedan interferir.

Los artefactos de tela que sujetan al bebé a la silla. Si el bebé aún es pequeño, queda “colgando”, además de que son difíciles de desabrochar en el caso de una emergencia.

No se recomienda alimentar a un bebé sentado en una mecedora, un cochecito o una silla del auto inclinada. Es necesario que el tronco y la vía aérea estén erguidos para la correcta deglución y para prevenir el riesgo de aspiración y asfixia.



¿TENGO que comprar una sillita de comer? No. Los bebés, en realidad, son muy baratos: compramos muchas cosas porque nos dicen que son necesarias para ellos, pero a larga, y aún más con cada hijo o hija que llega a nuestra vida, nos damos cuenta de que realmente necesitamos muy pocas. Podemos sentar al bebé en nuestra falda y que coma desde allí. En poco tiempo va a querer comer de pie y podrá hacerlo parado en una silla común (siempre supervisado por un adulto) o en una torre de aprendizaje. En unos meses más, seguramente le gustará comer paseando por ahí, y la silla quede abandonada... sirviendo de espacio de almacenaje de ropa para doblar.

La silla, como todo, es una opción. A veces le prestamos mucha atención a las cosas para comprar, porque así nos hemos educado y nos lo dice la publicidad, pero en realidad, la aventura está en otro lado.

Comer sin sillita

Cuando un bebé cumple las otras pautas madurativas adecuadas para el inicio de la alimentación complementaria, pero aún no se sienta solo, debemos evaluar muchos factores. Uno de ellos es la edad: podemos esperar hasta los 7 meses para que inicie, pero los estudios nos sugieren no mucho más dado que necesitamos incorporar hierro y otros nutrientes más allá de la leche. Entonces, la opción para no forzar una postura ni atar al bebé a una silla es apoyarlo sobre el cuerpo del adulto, de cara al plato, y que el cuerpo del adulto le dé el sostén necesario para que el bebé pueda concentrarse en usar sus manos y proteger su vía aérea. **El bebé debe tener sostén cefálico para poder hacer esto.**

¿Lo estamos “sentando” sobre el cuerpo del adulto? No, le estamos dando sostén, generando lo que llamamos “diálogo tónico”: ambos cuerpos se brindan información ida y vuelta, ajustan posturas, se acompañan. No estamos forzando ninguna postura.



Las personas somos diversas

Las personas somos diversas. Muchos bebés, niños y niñas atraviesan ciertas condiciones físicas y funcionales que requieren apoyo más allá de la elección de la sillita. Por ejemplo, en los casos de hipertono muscular (los músculos se contraen “de más”) o hipotono muscular (los músculos tienen menor “tono”, están más blanditos y deben hacer más esfuerzo para mantenerse en una postura). En estos casos, el equipo profesional que acompaña seguramente asesorará a la familia para encontrar la postura y los elementos que mejor se adapten, pero no quería dejar de aportar información sobre el tema.



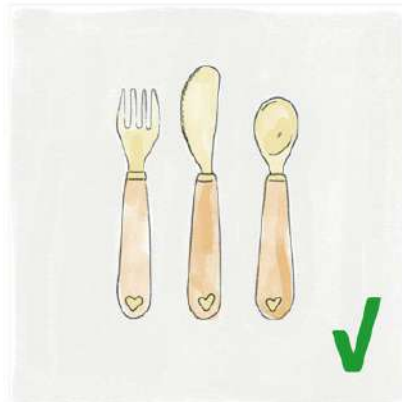
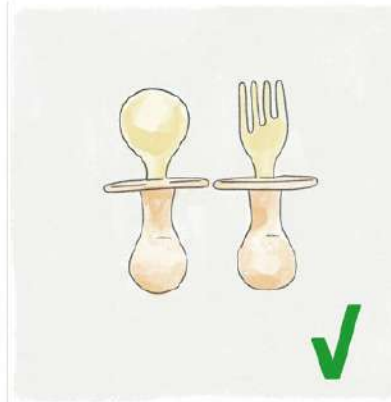
Platos, vasos y cubiertos

Podemos ofrecer los cubiertos desde el inicio de la alimentación complementaria. No esperemos que los usen como lo haría un adulto: eso se alcanza alrededor de los 2-3 años, con el mayor desarrollo de la motricidad fina y de la coordinación mano-ojo-boca.

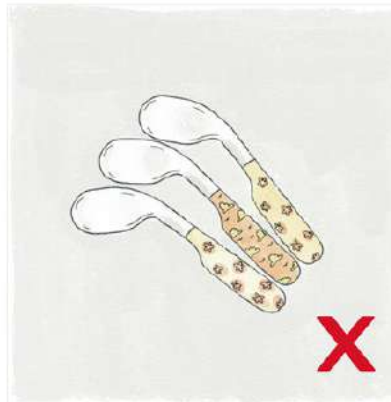
Elijamos cubiertos pequeños, livianos y sencillos. Importante: que el tenedor pinche. No hace falta que el bebé se enoje por querer imitar a los adultos y tener una herramienta inútil que no pincha en la mano. Hay unas cucharas dobladas en el mercado que pueden ser útiles para algunas infancias, sobre todo si la alimentación debe ser asistida, pero para niños y niñas que pueden tomarlas con sus manos no tienen objeto. No le demos muchas vueltas, simple es mejor.

Opciones que recomiendo

Estos cubiertos con tope son útiles para bebés pequeños, porque el mango se adapta bien a la manito y pueden ser precargados fácilmente.



Cubiertos simples, con forma y función de cubiertos.



Evitar "cosos" extraños.

Respecto a **los platos**, existen de todo tipo en el mercado. De madera, plástico, vidrio, silicona y muchas opciones más. La realidad es que podría ser que no necesitemos plato directamente, ya que podemos poner la comida sobre la bandeja de la mesa. Otros bebés usarán el plato del adulto, si están sentados en su falda, aunque está bueno ofrecerles su propio plato, dándoles un lugar en esa mesa familiar.

No importa mucho el material del plato (cuidado con los platos de madera, no se puede cortar en ellos porque se generarían rayas donde se acumularían gérmenes). Idealmente, sugerimos que tengan pocos dibujos para no distraer demasiado de la comida. ¿Es necesario que tenga divisiones? No. Las divisiones pueden ser útiles para guiar al adulto o para los niños generalmente más grandes, que prefieren visualizar los alimentos por separado; pero no son imprescindibles.

¿Y qué tipo de vasos? Para que un bebé sea capaz de usar un vaso, hay que permitirle jugar con él y aprender a usarlo. El primer líquido que

debería recibir un bebé más allá de la leche humana/fórmula es agua potable, en vasito, evitando el uso de la mamadera. Esta última es una herramienta útil para ofrecer leche cuando el pecho no está disponible. Esa debería ser su única función, y en cuanto los niños sean capaces de usar vaso, en lo posible no más allá de los 18 meses, retirarla en un proceso tan respetuoso como es el del destete. Hay miles de vasos en el mercado y aquí les cuento sobre algunos, pero si tuviera que aconsejar a una familia, **sugeriría un vaso común de boca abierta**. Les cuento por qué:

Vaso abierto. Es el que vamos a preferir desde el inicio de la alimentación complementaria. Al principio, el bebé se va a mojar, sin duda, y aquellos que comiencen a comer durante el verano serán afortunados (y sus mapadres tendrán menos trabajo. ¡No fue mi caso con ninguno de mis dos hijos!). Pero de a poco, el equilibrio, la coordinación motora y los músculos faciales se alinearán de tal manera que el bebé dominará el vasito y a medida que vayan pasando los meses, se mojará menos. Priorizamos vasos pequeños, livianos, que entren en la mano del bebé. Les podemos colocar un poquito de agua potable, ofrecerlos y permitirles jugar. ¿Podemos asistirlos? Sí, claro, podemos sostenerles el vasito y mostrarles cómo beber, siempre sin obligarlos. Los bebés aprenden por imitación: si ofrecemos el instrumento y les permitimos explorar, más nuestro ejemplo diario, pronto serán muy felices de imitarnos. El uso del vaso abierto también colabora con la generación de los límites entre el afuera y el propio cuerpo. El agua se cae si agarramos el vaso de esta manera y no se cae si lo agarramos de otra. El agua se queda en la boca si yo la cierro y se cae si la abro. ¡Qué experiencia fascinante! Y como si fuera poco, jugar con el agua, a meter y sacar cosas del vaso (el vaso lleno de pedacitos de comida es típico en las mesas infantiles), a trasvasar, ¡también es parte del proceso de control de esfínteres!

Ejemplos de vaso abierto (todos valen)



Vaso con escotadura: tiene un rebaje en un borde que facilita la ingesta de líquidos (en aquellos niños, niñas o jóvenes que puedan ingerirlos) debido a que se los puede ingerir sin hacer hiperextensión de cabeza.



Vaso con piquito blando: son similares a la mamadera; pueden ser una opción para salir o para empezar, si nos da miedo ofrecer el vaso abierto. A veces tienen válvulas antivuelco que hacen que los niños y las niñas tengan que succionar para que salga el agua, algo que activa continuamente los músculos buccinadores (si inflan los cachetes, esos músculos pueden tocarse, son los que se ponen redonditos), en detrimento de los músculos que se usan para tomar agua en un vaso abierto. El desarrollo en exceso de los músculos buccinadores, entre el uso de la mamadera y este tipo de vasos, a largo plazo genera arcadas dentarias estrechas y, consecuentemente, falta de espacio para dientes y lengua. Algunos de estos vasos tienen tantos chirimbolos que pueden ser pesados, aparatosos y difíciles de maniobrar para un bebé.



Vaso 360 o antivuelco: una buena opción para las salidas o para lugares donde los bebés no se puedan volcar líquido encima. En el día a día se prefiere una opción de boca abierta, dado que los vasos 360 enseñan a tomar líquidos sorbiendo. Un dato no menor: es importante limpiarlos desarmándolos por completo, pues tienen una especie de “rejilla” por debajo de la goma que es importante lavar para que no se formen hongos.



Vaso con bombilla: puede ser un buen complemento al vaso abierto para cuando salimos de casa. Similar a los vasos con piquito, genera un mayor uso de los músculos buccinadores y un posicionamiento de la lengua poco saludable. No son tan sencillos de higienizar correctamente. ¡Seguimos prefiriendo el vaso abierto común!



Baberos

El babero es algo para el adulto. ¿Por qué? Porque es un buen aliado para ensuciarse menos si el bebé lo usa. Inclusive hay un tipo de baberos que tiene mangas (muy útil para salir a comer a otro lado que no sea nuestra casa), y

otro que tiene un bolsillo donde cae la comida. Solo diré que mi hijo menor odió los baberos profundamente; hasta que yo me daba cuenta y se los sacaba, era todo un drama. A muchos pacientes e hijos de amigos les pasó lo mismo. **Si el babero es un obstáculo para comer porque molesta, aprieta o da calor... ¡chau babero!**

¿Qué hacemos con la suciedad? Una opción es que el bebé coma solo con el pañal, y bañarlo o limpiarlo con un trapito después de comer. Otra es ponerle una ropa viejita (recordemos que como los bebés crecen rápido, dejan la ropa atrás también rápidamente). Otra opción es ponerle una remera vieja nuestra o algo que no usemos. Y, sobre todo, saber que al principio todo es un enchastre, pero de a poco se vuelve menos sucio y más fácil de limpiar. Y sí, se puede bañar al bebé después de comer o de tomar la leche. No le hará nada a su digestión.

Utensilios no recomendados y #CososMarketineros

El chupete para fruta

El chupete para fruta es un elemento que se popularizó hace pocos años. Se trata de un recipiente de silicona con agujeros (una especie de tetina pero más ancha) o una red donde se puede colocar la fruta adentro y ofrecérsela al bebé. Este tipo de artefactos suelen estar inspirados en elementos que se usan dentro de algunas terapias, por ejemplo, en la estimulación sensorial de la boca en personas que se alimentan por botón gástrico. **La industria de cosas para bebés los toma y los trae a lo cotidiano, creando una necesidad que no existe.**

Yo medité muchísimo acerca de comprarlo para mi hijo mayor, aun cuando él comía gajos de naranja con una destreza asombrosa a los 7 meses. Me recuerdo parada frente al stand pensando: “Daaaale, comprale, debe estar rebueno” (nota: no lo compré porque no llegué a tiempo. Estoy segura de que a la larga lo hubiera comprado y hoy estaría tirado en algún cajón de la cocina). Unos años después pude abrazar a esa mamá indecisa tratando de comprar lo mejor para su bebé, esa mamá que fui, tomármelo con humor e incluir ese “coso” dentro de los **#CososMarketineros, artilugios que no tienen ningún uso más que llenarle los bolsillos al fabricante.**

Siempre será infinitamente mejor que los bebés tomen, toquen, estrujen y aprendan del alimento en su empaque original: ninguno, o mejor dicho, la planta. Como no solemos cosechar nuestras propias frutas, vamos un paso más: es ideal que toquen el alimento tal como es, con sus colores, formas, aromas y densidades, y no adentro de una red o un pedazo de silicona. Estos materiales alteran la percepción de los alimentos y no son recomendables. Probablemente solo tomen el jugo y no reciban la fibra.

Confiemos en los bebés. Si están listos para empezar a comer y los alimentos están bien adaptados, los riesgos se minimizan.



La cuchara biberón

La cuchara biberón no está muy difundida en Argentina, pero en las fotos de bebés europeos se ve bastante. Es una cuchara con un reservorio adosado, donde la papilla acuosa va cayendo en la cuchara y el bebé la va comiendo. Es una excelente idea para los casos en los que necesitamos aportar leche fuera del pecho de la mamá y no deseamos ofrecer tetinas, o el bebé rechaza la mamadera. Es decir: es un buen artefacto para ser usado con leche. En Argentina se venden algunas importadas que no aclaran de qué material son, por lo que no sugeriría utilizarlas por bebés a menos que la marca certifique que son seguras.

En cambio, usar esta cuchara para ofrecer comida es un problema: el bebé no se lleva cosas a la boca, no ve los alimentos, sino que le van cayendo en la

cuchara. Es muy difícil también regular la cantidad de comida así, ya que la misma es totalmente líquida.

Nuevamente, como con el chupete de frutas, puede ser herramienta más para niños que se encuentran en un proceso terapéutico alrededor de la alimentación, pero no para uso masivo.



Papillas en pouch

El *pouch* es un envase chato, una especie de bolsa rectangular con un pico de plástico donde se suelen ofrecer papillas. No permite el contacto visual ni táctil con la papilla que tiene adentro: todo va directo al tubo digestivo. Estos artefactos, utilizados con frecuencia, podrían contribuir a alteraciones en la integración sensorial, y a la neofobia y la selectividad (que ya veremos en detalle en el capítulo 9). A nivel ecosistema, no son reutilizables, por lo que resultan un desperdicio de mucho plástico y de otras sustancias por su uso único.



El ambiente a la hora de comer: adúlteros disponibles

Qué difícil es a veces ordenarnos para crear una “hora de comer”. En un mundo de hiperconectividad, en el cual el celular suena todo el tiempo, en el que la productividad y la rapidez son altamente valoradas, la alimentación es un trámite, algo que “hay que hacer” muchas veces mientras hacemos otras cosas. Ese es nuestro mundo y el mundo en el que crecen las infancias. La pandemia y la cuarentena por el COVID-19 magnificó estas cuestiones: con un pie estábamos haciendo la comida y con las manos y orejas hablando por Zoom y por celular.

La bibliografía sobre alimentación infantil sugiere un ambiente tranquilo y relajado. Sin ninguna duda, adhiero a esta indicación, pero, por sobre todo, la sugerencia fundamental es la presencia de un adulto. Y cuando digo “presencia”, hablo de una persona adulta disponible para solucionar un episodio de atragantamiento pero también para hacer contacto visual con el bebé, la niña o el niño, jugar con la comida, charlar sobre los colores del zapallo y las frutillas, apilar trocitos de papa y, sobre todo, para

mostrar, inclusive inconscientemente, la manera en que comemos en nuestra cultura en general y en esa familia en particular. Aquí les comparto algunas recomendaciones a tener en cuenta.

Medidas anticipatorias

Los bebés, los niños y las niñas nos escuchan atentamente. Para ellos somos una especie de personajes maravillosos, somos el lugar seguro, un ser enorme que todo lo puede hacer y que es hermoso imitar. Y aunque aún no tengan un lenguaje hablado que los adultos puedan comprender, se comunican y entienden muchas de nuestras palabras y gestos. **Explicarle a los bebés que ahora nos vamos a sentar y que vamos a ponerles el babero (o no) porque vamos a comer todos juntos, es un hermoso ejercicio desde el inicio de la alimentación complementaria.** Explicarles también que es superdivertido, que pueden jugar todo lo que gusten y que vamos a estar con ellos a su lado, que nos miren atentos, que les vamos a mostrar cosas lindas que se hacen con la comida.

Pantallas en la mesa

Ana tiene 10 meses. Su familia refiere que no come nada, a menos que tenga la tablet adelante. Si le ponen Peppa Pig, se come el plato entero y no deja nada. La familia pregunta si está bien.

Las pantallas son parte de nuestra vida. No sería correcto hablar mal de ellas: nos comunican, nos entretienen, son parte de nuestro trabajo y de los estudios. En 2020, plena pandemia de COVID-19 mediante, muchos niños y niñas tuvieron continuidad escolar y atención médica gracias a las pantallas (y otros tantos no la tuvieron: un grave problema de gestión pública). Sin embargo, **las pantallas a la hora de la comida son un problema. ¿Por qué? Porque ya hablamos que necesitamos nuestros sentidos en plenitud**

para comer: la visión y la audición también se ocupan de la comida. Y si estos sentidos están “bloqueados” porque los ojos y oídos están pendientes de la tele o el celular, perdemos parte de la experimentación en la comida.

Muchos niños “sí comen” si están frente a una pantalla. ¿Por qué? Porque su atención está en otro lado, y la comida ingresa al cuerpo sin un registro claro de sus colores, texturas y sabores, y sin establecer un vínculo con la actividad de comer. Así como ingresa con poco registro, también hay **poco registro de la autorregulación**. Es decir, es probable que coman de más o de menos por estar abstraídos frente a una pantalla.

Para que un niño o una niña coma frente a una pantalla, hay uno o más adultos que ofrecieron esa pantalla. Y no es un juicio de valor, pues puede haber habido un centenar de razones por las cuales sucedió eso. Simplemente es un hecho, y no es algo beneficioso para bebés, niñas y niños. Ante todo podemos buscar prevenirlo, pero si ya sucedió, trabajar en herramientas para que no siga pasando.

¿Entonces? Es parte de la construcción de límites. Los límites son bordes seguros que vamos construyendo en la crianza. No son sencillos muchas veces y nadie “la tiene clarísima”, sino que haremos nuestro propio camino. Cuando ponemos un límite, tenemos que tener claro por qué y para qué lo ponemos. Que nuestro hijo quiera comer en el plato de dinosaurio y no en el plato verde, si existe esa posibilidad, no es un capricho y no hace falta gastar energía en eso.

¿Qué estrategias podemos usar?

- Explicar con claridad por qué decidimos (nosotros, los mismos adultos que ofrecimos las pantallas) que no sean más parte de la hora de la comida.
- Explicar que antes no sabíamos que era algo que no estaba bueno, pero que ahora necesitamos sentarnos a comer todos juntos y charlar.
- Que nosotros tampoco vamos a usar pantallas durante la comida (y cumplir dejando el celular lejos).
- Transar momentos donde sí podemos usar las pantallas (antes de comer, antes de ir a jugar), sin utilizarlas como premios o castigos por

la cantidad comida.

De nuevo, las pantallas (¡esta vez, las de los adultos!)

Nos encontramos en el auge de las redes sociales y de compartir cada momento de nuestra vida. Esto lleva muchas veces a lo que llamamos *sharenting*: mostrar en las redes imágenes de la cotidianeidad de niños y niñas.

Las infancias actuales han nacido en este mundo y las redes y pantallas son parte de él. Sin embargo, **filmarlos y compartir cada ingesta de alimento que hacen podría ser contraproducente**. De base, hay un adulto con un celular recto filmando adelante de su cara, tapando parte de la misma. Esa cara es fundamental para el bebé que está aprendiendo a comer: es la cara que le brinda seguridad y la cual imita.

¡A todos nos gusta tener recuerdos de nuestros bebés! Los días pasan muy rápido y las habilidades se desarrollan con prodigiosa velocidad. Pero tengamos en cuenta que el hecho de filmar y compartir constantemente todos los actos de una persona pequeña puede no ser la mejor idea, y hablando específicamente de alimentación, hasta podría no ayudar en este proceso. Cuando compartimos imágenes y videos, también nos exponemos a comentarios y opiniones, que pueden no ser amables, y en el cansancio de la crianza, eso puede minar nuestra confianza como mapadres en este proceso aventurero que es probar y decidir.

¡No se quiere quedar sentado!

Pedirle a un deambulador que se quede sentado durante toda la comida es como pedirle que explique el teorema de Pitágoras. **No lo hacen de caprichosos, ni de maleducados, ni por “malos comedores”. Lo hacen porque lo necesitan: sus cuerpecitos están aprendiendo y probando el movimiento, y necesitan practicarlo todo el tiempo.** Quedarse en una mesa el tiempo que pretendemos los adultos (que, además, nos gusta hacer

“precomida”, picada, comida, postre y sobremesa, sobre todo cuando estamos tranquilos y disfrutando) es básicamente imposible.

¿Qué hacer? ¡Permitirlo! **En ese momento del desarrollo suelen comer poco e investigar mucho. Y es muy lógico.** Lo veremos más adelante cuando hablemos de neofobia, selectividad y el miedo a que no coman nada.

En cambio, si el bebé es pequeño, sobre todo en los primeros meses de la alimentación complementaria, y se lo observa incómodo en su silla, está bueno revisar varias cuestiones. ¿Es cómoda la silla? ¿Realmente se mantiene completamente erguido? ¿Se resbala en la silla? ¿Hay algún broche que le molesta? ¿Puede apoyar los pies? ¿Cómo es el ambiente?

Ir a comer afuera con bebés e infancias

Durante el primer año de mi hijo, trabajé mucho afuera de casa y él me acompañó muchas veces. Comimos afuera seguido, y mientras fue pequeñito, no fue muy complicado (reconozco que se me ha caído rúcula sobre su cabecita dormida). Pero ¿qué pasa cuando los bebés comienzan a deambular?

Ante todo tenemos que comprender que **un restaurante o local de comidas no es un lugar hecho para bebés, niñas o niños. Ir a comer afuera es una actividad de adultos que podemos compartir con nuestros niños, pero no deja de ser una actividad de adultos.** Y no, no va a volver a ser como cuando no éramos mapadres.

No podemos esperar que un bebé espere pacientemente el plato ni que cuando llegue se siente a comerlo con prolijidad. Menos aún si se trata de deambuladores. Para paliar esto, podemos llevar *snacks* de fruta deshidratada, por ejemplo, para ir ofreciendo mientras esperamos.

Como dijimos, los deambuladores necesitan mover el cuerpo, caminar, gatear y explorar. Es lógico que quieran bajarse de la silla e ir a curiosear. Sugiero tener en cuenta esto para elegir el lugar adonde vamos a comer: que sea amplio y si es al aire libre, mejor, sobre todo en épocas de COVID-19. Una pizzería en una zona urbana céntrica puede no ser la mejor elección.

Con respecto a la comida que se ofrece, sugiero **elegir siempre algo bien cocido, dado que no podemos saber cómo se lavan las verduras, por ejemplo.** Evitar albóndigas o hamburguesas por riesgo de síndrome urémico hemolítico.

Es poco probable que no se ensucien o no ensucien el lugar. Esto es lógico, ya sea que coman papillas o trozos: la alimentación es un momento de exploración. También pueden sentirse incómodos en un lugar que no es el habitual y no comer “nada”. Es una posibilidad y no es grave. Simplemente les ofrecemos más tarde alimentos saludables y listo, cuando tengan hambre, comerán.

¡Paciencia! En la infancia los días son largos, y los años son cortos.

Cantidades y variedad

Es importante que ofrezcamos alimentos de a poco y observar la respuesta de los bebés, las niñas y los niños. No existe una cantidad específica. Los bebés se autorregulan, como dije al principio del capítulo. **Ofrecemos, observamos y vamos aumentando la cantidad a medida que el bebé lo pida.**

Si ofrecemos mucha cantidad de golpe, seguramente haya mucho enchastre. Hay personas a las que les preocupa el desperdicio de comida, y esto es totalmente válido. ¿Qué hacemos con esto? Ofrecemos de a poquito, observando qué hace el bebé, qué nos pide, qué cara pone y cuánto lo disfruta.



Pero si no come “mucho”, ¿va a estar bien nutrido? Sí, porque hasta el año de vida, los bebés son lactantes. La leche les provee gran parte de los nutrientes necesarios. Pero incluso si toman teta, hay una brecha de nutrientes, sobre todo de hierro, que es preciso aportar con la alimentación complementaria. Por eso es importante ofrecer alimentos de alto valor nutricional y no productos superfluos. La cantidad la decidirá el bebé. **La alimentación complementaria es complementaria, valga la redundancia, a la leche humana o de fórmula que reciba ese bebé.**

¿Y si no come NADA? Es recurrente el miedo por esta cuestión. **Cada bebé tiene su tiempo de exploración y no podemos apurarlo.** Vemos que el bebé de nuestra amiga come “de todo” y el nuestro mira el brócoli y nada más. Entonces aparecen las frases innecesarias de la familia, del pediatra, del entorno: “No come porque vos no le das en la boca”, “No come porque no le das papilla”, “No se nutre porque se queda con hambre”. Aparecen personas sugiriendo retirar la teta porque es la culpable, y encima, nuestro bebé crece “poco” en los controles pediátricos...

Creo haber sido clara en que la alimentación complementaria es complementaria. La leche es el alimento principal (y van...). **Si quitamos la leche, lo estaremos privando de algo que realmente sí lo nutre** y que si pudiéramos encontrar en la góndola del supermercado, no dudaríamos en invertir todo nuestro sueldo allí. Sí, es posible que el bebé aumente “poco” o menos que en los controles anteriores, lo cual es lógico porque **nadie nunca volverá a crecer al mismo ritmo que creció en los primeros 6 meses.** Comer, comen. ¡Comen leche, sea humana o de fórmula!

¿La teta antes o después?

Es importante saber que si “salteamos” tomas a propósito para que tenga “más hambre” y coma más, eso probablemente no suceda, tanto si el bebé se alimenta con leche humana como si toma fórmula. **Para ese bebé, la alimentación complementaria es un juego y la leche es su comida.** Estará fastidioso y no entenderá por qué no le damos alimento si lo está pidiendo claramente.

Las comidas no reemplazan las tomas de leche, siendo la leche humana o de fórmula el principal alimento el primer año de vida. La leche humana

nunca se vuelve agua ni deja de nutrir. Sin embargo, a veces se insiste con que hay que dar la leche SIEMPRE antes de sentarlo a la mesa... Y eso tampoco es algo rígido a cumplir. Si observamos al bebé, sabremos cuándo tiene hambre y cuándo no. Entonces, **ofrezcamos la leche en relación con su hambre, no con un horario. Puede ser antes, durante o después de la hora de la comida.**

¿Cómo sé si se llenó?

Pensemos por un momento por qué necesitaría una persona estar “llena”. ¿Qué es estar “lleno”? ¿No sentir hambre? Perfecto, eso es sencillo: los bebés se autorregulan, entre la alimentación complementaria y la leche, y comen lo que necesitan.

Una percepción muy común es sentir que los bebés se despiertan más de noche cuando inician la alimentación complementaria porque “se quedan con hambre”. Los bebés se despiertan de noche porque necesitan saber que estamos ahí, porque su sueño es evolutivo y porque, en realidad, todos nos despertamos muchas veces de noche, solo que los adultos tenemos la habilidad de conciliar el sueño nuevamente muy fácil. **Muchos bebés de 6 meses en adelante necesitan aún las tomas nocturnas de teta o de mamadera, y esto no es porque se quedaron con hambre de la cena, sino porque estas tomas también tienen una connotación de satisfacción, de cercanía y cuidado.**

¿Y si sigue comiendo sin parar?

Algunos bebés AMAN comer. Todo lo que les presentemos entra en su cuerpecito simpático con gran entusiasmo. Y como los bebés que “no comen nada”, esto a veces genera preocupación.

Mientras ofrezcamos alimentos de buena calidad nutricional, no hay de qué preocuparse. Tampoco podemos saber si esto va a perdurar en el tiempo, o si cuando el bebé aprenda a gatear, tendrá otros intereses y

empezará a comer menos. Ahora, ¿qué pasa cuando el bebé se come tres bananas grandes en cada comida? Puede ocurrir, me consta. Bueno, tenemos que tener en cuenta que para que un bebé coma tres bananas, hay un adulto que le alcanzó tres bananas o hay tres bananas a su alcance. Si comemos solo un tipo de alimento, por más bueno que sea, no vamos a tener todos los nutrientes que necesitamos. Entonces, algunas opciones a tener en cuenta en estos casos pueden ser:

- Servir el alimento pero no dejar “más” a la vista.
- Establecer “momentos” de comensalidad, de estar sentados a la mesa, y dejar esto claro. “Uhh, ¡qué ricas las bananas que comimos! Ahora vamos a jugar, ¿dale?”.
- Sí, los bebés, los niños y las niñas son observadores agudos y saben perfectamente dónde guardamos los alimentos: heladera, alacena, etc. A medida que van creciendo, los van a buscar solos o nos señalan lo que desean. Entonces hay que explicarles claramente por qué, por ejemplo, no podemos comer más pasas de uva. Explicar con palabras sencillas que sabemos que les gustan mucho, que a nosotros también nos resultan muy ricas, pero que en exceso nos pueden caer mal y hacernos doler la panza. Validar la frustración, porque es muy probable que ocurra, pero saber que tomamos esta decisión por su salud; eso también es parte de la crianza respetuosa.
- Algunas infancias que presentan déficit en el procesamiento sensorial (lo charlamos en el capítulo 5 sobre desarrollo). Por ejemplo, niños y niñas con autismo pueden no sentir saciedad y presentar mucha selectividad hacia ciertos alimentos, consumiendo grandes cantidades de algún comestible puntual. En estos casos, se trabaja con el equipo de apoyo: terapia ocupacional, psicología, pediatría. También muchas veces hay que evaluar cuestiones de salud intestinal y microbiota, y hacer cambios en la alimentación global.

¿Cuántas veces al día le doy de comer?

Al inicio de la alimentación complementaria, se sugiere ofrecer una o dos comidas al día. ¿Por qué? Por practicidad: estamos todos aprendiendo.

Estas comidas pueden ser las que la familia elija: desayuno y almuerzo, almuerzo y merienda, almuerzo y cena.

En mucha bibliografía se sugiere que se inicie con las comidas más “tempranas”, pero no tiene que ver con la digestión, sino con la predisposición del bebé y de los adultos. Más temprano estamos más descansados (aunque hayamos dormido poco) y generalmente con más paciencia. También puede ser útil ofrecer las primeras comidas al inicio del día para evaluar si algún alimento genera alguna reacción adversa (ver más adelante en este mismo apartado).

¡Pero todas estas sugerencias, no son más que sugerencias! En algunas familias, el único momento en que se reúnen a la mesa es en la cena, y la alimentación complementaria puede comenzar en esa comida sin ningún problema, disfrutando del momento.

¿Y cuándo ofrezco una tercera o cuarta comida? Cuando quieran. Cuando vean que el bebé la desea; está integrado en la mesa y la pasaría bien al recibirlas. Muchos bebés se quedan dormidos antes de la cena y esto es absolutamente normal. Dejémoslos dormir, que es lo que necesitan en ese momento, y disfrutemos de la cena nosotros.

Antes se usaba sugerir una comida a los 6-7 meses, dos comidas a los 8-9 meses y cuatro comidas entre los 10 y 12 meses. No está mal, simplemente es un poco “rígido” y está bueno ir sopesando las necesidades de cada familia.

Aquí les comento el ejemplo de una familia amiga. Importante: es solo un ejemplo. Así se sintieron ellos cómodos en el inicio de la alimentación complementaria. Si tu familia se siente cómoda con otras opciones, también está bien. Acá decide la familia, y la familia marca los tiempos, de la manito del bebé o de los bebés (¡recordemos que en la familia puede haber mellizos, trillizos y más!).

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Desayuno	Banana	Palta	Mandarina	Palta	Hummus	Huevo duro	Pollo desmenuzado
Almuerzo	Palta	Zapallo	Banana	Huevo duro	Brócoli	Palta y brócoli	Brócoli, mandarina y palta
Merienda						Polenta	Panqueques de banana
Cena							

¿Y qué pasa si no come a la hora de la comida y me pide comida dos horas después?

Primero, **no reemplazar esa hambre por productos de picoteo (galletitas, nos entendemos), sino volver a ofrecerle lo que sobró de la comida o un equivalente.** ¡Sí, se puede ofrecerle un arbolito de brócoli y unos fideos las cuatro de la tarde! No pasa nada. Va a ser más sano que darle una vainilla.

¿Cuántos alimentos le pongo en el plato?

Al principio, vamos presentando de a poquito, de a un alimento. Que “haga caras” no quiere decir que no le guste, simplemente lo está descubriendo. Una vez introducidos varios alimentos, comenzamos a combinarlos, procurando asegurar un alimento rico en hierro, uno rico en energía y una fruta o verdura. No, puede que el bebé no se coma los tres alimentos y puede también que no coma ninguno. Ya hemos visto esto varias veces: lo importante es ofrecer, tener paciencia y dar el ejemplo.

¿Cuántas veces le presento el mismo alimento para evaluar alergias?

En mucha bibliografía figura la sugerencia de ofrecer en tres comidas consecutivas o durante tres días seguidos un mismo alimento “nuevo”, a veces acompañado de otro que ya sabemos que el bebé tolera, para evaluar alergias e intolerancias.

Esta recomendación puede no seguirse a rajatabla. Recordemos que hasta hace poco, la alimentación complementaria comenzaba con unas galletitas que tenían alrededor de quince ingredientes, y nadie se preocupaba mucho por si el bebé tenía o no una reacción adversa a los mismos. Por si no me creen, dejo los ingredientes de una de las galletitas más populares del mercado “para bebés”:

Harina de trigo enriquecida (hierro, ácido fólico, tiamina, riboflavina, niacina), azúcar, aceite de girasol alto oleico, jarabe de glucosa, extracto de malta, permeado de suero en polvo, sal, leudantes químicos (bicarbonato de amonio, bicarbonato de sodio), emulsionantes, monoglicéridos de ácidos grasos, diglicéridos de ácidos grasos, lecitina de soja, mejorador de la harina (metabisulfito de sodio), vainillina.

Entonces, tranquilidad. Sugiero, sí, seguir esta recomendación para la introducción de **huevo y frutos secos, que son respectivamente la segunda y tercera alergia alimentaria más común en Argentina después de la alergia a la proteína de leche de vaca (APLV)**. También sugiero presentar estos alimentos durante el día y no durante la noche, donde es más difícil ubicar o concurrir a un servicio médico en caso de alergia que lo requiera.

Sin embargo, no hace falta que sean tres comidas consecutivas o tres días consecutivos. Volvamos al ejemplo anterior. Esta familia ofreció huevo en tres comidas:

- En el almuerzo del jueves, después de ofrecer palta a la mañana (alimento ya conocido por el bebé).
- En el desayuno del sábado.
- En la merienda del domingo, formando parte de un panqueque de banana.

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Desayuno	Banana	Palta	Mandarina	Palta	Hummus	Huevo duro	Pollo desmenuzado
Almuerzo	Palta	Zapallo	Banana	Huevo duro	Brócoli	Palta y brócoli	Brócoli, mandarina y palta
Merienda						Polenta	Panqueques de banana
Cena							

¿Qué pasa con los alimentos “alergénicos”? Frutos rojos, huevo, pescado, frutos secos...

Durante muchos años, se planteó retrasar algunos alimentos, como el huevo, por el riesgo de alergias. Actualmente, ese concepto está en desuso porque, **excepto los lácteos de vaca, la investigación científica sugiere que introducir alimentos cerca del inicio de la alimentación complementaria tendría un efecto protector con relación a las alergias.** Es decir, al revés de lo que se pensaba antes: si esperamos hasta el año para ofrecer, por ejemplo, huevo, existe más riesgo de alergias.

Desarrollaré con más detalle el tema de las alergias alimentarias en el capítulo 13, pero quiero introducir aquí algunos conceptos básicos:

- Las reacciones adversas a alimentos no suelen aparecer en la primera exposición a los mismos, sino en la segunda o tercera vez que prueban el alimento en cuestión.
- Existen muchas reacciones adversas, alérgicas y no alérgicas. Puede ser una erupción en la piel que se resuelve sola, diarrea o vómitos, rechazo constante a ese alimento (los bebés son muy sabios), etc. Lo más grave que podría pasar en un pequeño porcentaje de la población, sería una reacción anafiláctica, caracterizada por inflamación de la vía aérea y falta de aire. Esto requiere atención médica inmediata en guardia.
- En ocasiones, las reacciones adversas no son a los alimentos en sí, sino a químicos y compuestos que hay en su composición si es un alimento industrial (ver los mil ingredientes de una galletita que vimos unos párrafos antes, por ejemplo), a sustancias propias de su empaquetamiento o a químicos que se utilizan en su cultivo (por ejemplo, agroquímicos en su cáscara).
- Los frutos rojos, como las frutillas y cerezas, consumidas en gran cantidad, pueden causar un leve enrojecimiento o picazón alrededor de la boca, que no es una alergia, sino una respuesta a un componente

de dichos frutos (la histamina). Esto también sucede, por ejemplo, con la berenjena o el tomate. Se pueden introducir desde el inicio de la alimentación complementaria sin problemas.

- Existen muchas infancias con alergias alimentarias declaradas antes del inicio de la alimentación complementaria; sobre todo, bebés alérgicos a la proteína de la leche de vaca. Estos bebés deben contar con un equipo interdisciplinario de seguimiento: pediatra, nutricionista, alergista y gastroenterólogo, como mínimo. Ese equipo debe acompañar el proceso de alimentación de esa familia, evaluar la microbiota de la misma y hacer sugerencias con relación a las características particulares de cada caso.

Para seguir leyendo

PARA FAMILIAS

- Organización Panamericana de la Salud. (2010). La alimentación del lactante y del niño pequeño. Capítulo Modelo para libros de texto dirigidos a estudiantes de medicina y otras ciencias de la salud. Recuperado de: https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/IYCF_model_SP_web.pdf
- Ruiz Brünner, M. M.; Cieri, M. E.; Luciano, S.; Masala, M. M.; Rodriguez Marco, M. P.; Urbisaglia, M.; Valfré, M. A.; Cuestas, E. (2019). Atlas fotográfico de consistencias de alimentos para el tratamiento de personas con disfagia. *UNC*. Recuperado de: <https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/11398/Atlas%20fotogr%c3%sequence=1&isAllowed=y>
- C.H.A.S.E. for Life. *Maniobra de Heimlich para bebés y niños de bolsillo*. Recuperado de: http://chaseforlife.org/spanish/CM_broch_SPAN_web.pdf4
- Daniels, L.; Heath, A. L.; Williams, S. M.; Cameron, S. L.; Fleming, E. A.; Taylor, B. J.; Wheeler, B. J.; Gibson, R. S.; Taylor, R. W. (2015). Baby-Led Introduction to SolidS (BLISS) study: a randomised controlled trial of a baby-led approach to complementary feeding. *BMC pediatrics*.

Recuperado de: <https://doi.org/10.1186/s12887-015-0491-8>

PARA PROFESIONALES

- Cameron, S. L.; Heath, A. L.; Taylor, R. W. (2012). How feasible is Baby-led Weaning as an approach to infant feeding? A review of the evidence. *Nutrients*. DOI: 10.3390/nu4111575. PMID: 23201835; PMCID: PMC3509508.
- Brunner-López, O.; Fuentes-Martín, M. J.; Ortigosa-Pezonaga, B.; López-García, A. M. Grupo de Especialización de Nutrición Pediátrica de la Academia Española de Nutrición y Dietética. (2017). Texturas evolutivas en la introducción de nuevos alimentos. *Academia Española de Nutrición y Dietética*. Recuperado de: <https://www.academianutricionydietetica.org/archivos/Nutricion%20pediat>
- Taylor, R. W.; Williams, S. M.; Fangupo, L. J.; Wheeler, B. J.; Taylor, B. J.; Daniels, L.; Fleming, E. A.; McArthur, J.; Morison, B.; Erickson, L. W.; Davies, R. S.; Bacchus, S.; Cameron, S. L.; Heath, A. M. (2017). Effect of a Baby-Led Approach to Complementary Feeding on Infant Growth and Overweight: A Randomized Clinical Trial. *JAMA Pediatr*. DOI: 10.1001/jamapediatrics. PMID: 28692728. PMC5710413.
- Daniels, L.; Taylor, R. W.; Williams, S. M.; Gibson, R. S.; Samman, S.; Wheeler, B. J.; Taylor, B. J.; Fleming, E. A.; Hartley, N. K.; Heath, A. M. (2018). Modified Version of Baby-Led Weaning Does Not Result in Lower Zinc Intake or Status in Infants: A Randomized Controlled Trial. *J Acad Nutr Diet*. DOI: 10.1016/j.jand.2018.02.005. PMID: 29803269.
- D'Auria, E.; Bergamini, M.; Staiano, A.; Banderali, G.; Penderzza, E.; Penagini, F.; Zuccotti, G. V.; Peroni, D. G. (2018). Baby-led weaning: what a systematic review of the literature adds on. *Ital J Pediatr*. DOI: 10.1186/s13052-018-0487-8. PMID: 29724233; PMCID: PMC5934812.
- Santos Prieto, D.; Mai Thu, Q.; Véliz, C. O. L.; Grau Ábalo, R.; Hurtado Aguilar, L. (2016). Maduración de la deglución en niños de dos a cinco años y sus hábitos alimenticios. *Medicentro Electrónica*. Recuperado de: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30432016000200003&lng=es&tlng=es
- Chapin, M. M.; Rochette, L. M.; Annest, J. L.; Haileyesus, T.; Conner, K. A.; Smith, G. A. (2013). Nonfatal choking on food among children 14 years or younger in the United States, 2001-2009. *Pediatrics*. DOI:

10.1542/peds.2013-0260.

- Fangupo, L. J.; Heath, A. M.; Williams, S. M.; Williams, L. W. E.; Morison, B. J.; Fleming, E. A, et ál. (2016). A baby-led approach to eating solids and risk of choking. *Pediatrics*. DOI: 10.1542/peds.2016-0772.
- Rowan, H.; Lee, M.; Brown, A. (2019). Differences in dietary composition between infants introduced to complementary foods using Baby-led weaning and traditional spoon feeding. *J Hum Nutr Diet*. DOI: 10.1111/jhn.12616.
- De Carvalho, G. D. *El amamantamiento bajo la observación funcional y clínica de la odontología Subcomisión de Lactancia Materna SAP*. Recuperado de:
<https://www.sap.org.ar/docs/organizacion/subcomisiones/lactancia/lacsub3>

Pequeño manual BLW ilustrado

Bienvenidos a la aventura.

Anímense, experimenten, prueben.

No hay una forma correcta.

Simplemente hay muchas personas disfrutando
el camino feliz de la comida y su libertad.



Durante muuuchos años, los pediatras entregamos listas de alimentos en el consultorio, con un orden más basado en las creencias y la historia personal de cada profesional que en la ciencia. Hoy, de a poco, vamos cambiando este camino, sobre todo porque comprendimos que la alimentación es un pilar fundamental de la salud.

Numerosas sociedades científicas sostienen que, salvo algunas excepciones que detallaré más adelante, la mayor parte de los alimentos que consume la familia pueden ser adaptados para los bebés según su edad. De hecho, en 2018, la Asociación Española de Pediatría publicó este cuadro orientativo que despeja gran parte de nuestras dudas:

Calendario orientativo de incorporación de alimentos

ALIMENTO	0-6 meses	6-12 meses	12-24 meses	> 2 años
Leche humana				
Fórmulas adaptadas (en caso de no estar con LM)				
Cereales, frutas, hortalizas, legumbres, huevo, carne, pollo, pescado, aceite de oliva				
Leche entera, yogur, queso tierno (pueden ofrecerse en pequeñas cantidades a partir de los 9 o 10 meses)				
Sólidos con riesgo de atragantamiento (frutos secos enteros, manzana o zanahoria cruda, etc.)				Por encima de los 3 años
Alimentos superfluos (azúcares, miel, chocolatada, galletitas, cereales con azúcar, facturas, embutidos)	Cuanto más tarde y en menor cantidad, mejor (siempre a partir de los 12 meses)			

Modificada de "Recomendaciones para la alimentación en la primera infancia",
Agència de Salut Pública de Catalunya, 2016.

Entonces, tu bebé puede comer, de forma adaptada a ella/él y desde el inicio de la alimentación complementaria:



En las siguientes páginas, les mostraré diversas formas de presentar los alimentos. Por favor, no lo tomen como una guía a rajatabla: simplemente es algo orientativo. ¡Anímense a vivir la propia aventura, a cocinar y cortar las cosas de otra manera, a mirar a sus bebés y ver qué les gusta más! ¡Y disfruten del proceso!

Tamaños, texturas y formas

Tamaños

Al inicio de la alimentación complementaria –como vimos en el capítulo de desarrollo–, la motricidad fina y la gruesa de los bebés están en pleno desarrollo y aún no son capaces de hacer pinza. Por lo tanto, es preciso ofrecer trocitos de un tamaño que sean capaces de tomar con la mano entera, y que sobresalgan para poder llevárselos a la boca. Generalmente, para esto se utiliza como referencia el dedo índice del adulto (aunque es muy relativo, lo importante es que lo pueda agarrar el bebé).





A medida que el bebé va creciendo y aprendiendo a hacer pinza (alrededor de los 9-10 meses), podemos achicar los trocitos. De hecho, a veces los bebés nos obligan a eso: dejan de estar interesados en los trozos grandes y pueden estar minutos enteros absortos en pescar una lentejita. Mirar al bebé y sus deseos es fundamental, y además, divertido.

Texturas

Cuando empezamos a ofrecer alimentos, es necesario que estén muy muy blanditos: que podamos aplastar el trocito entre los dedos fácilmente y se desarme. ¡Muy parecido a un puré!

Si deseamos ofrecer puré, tratemos de que no sea un licuado, sino que tenga grumitos –es decir, textura– y que sea de un solo alimento, para que el bebé pueda sentir colores y aromas específicos. Las diferentes texturas, además, ayudan a la percepción de los sabores.

A medida que el bebé vaya creciendo y desarrollando nuevas habilidades, vamos progresando las texturas. Sin miedo, de a poquito. Tenemos que permitirle experimentar para que se desarrollen sus músculos, sus neuronas, sus nervios, sus preferencias...



¿Cómo consigo la textura adecuada? ¿Debo ofrecer todo cocido? Algunos alimentos tienen la textura adecuada sin necesidad de hacerles ningún proceso: la palta, el kiwi, la banana... Estos alimentos se pueden consumir crudos sin ningún problema, siempre que estén bien higienizados.

A otros alimentos tendremos que cocinarlos, cortarlos o molerlos, pero no porque no se puedan comer crudos, sino porque su textura es rígida o quebradiza, o porque su forma es esférica y podrían generar riesgo de asfixia. Por ejemplo: la manzana, la zanahoria, los frutos secos, las legumbres.

Si hay que cocinar para hacer la textura más blanda, se puede cocinar al vapor, hervido, en la sartén, en el horno, en la olla a presión, en la olla eléctrica... En lo que tengan y gusten.

¿Se puede cocinar en microondas? Sí, se puede, no altera las propiedades nutricionales de los alimentos, aunque se utiliza más para calentar que para cocinar. Cuidado con calentar alimentos con este aparato porque calienta en forma desigual: habrá zonas tibias y zonas hirviendo.

¿Algún tipo de cocción es mejor? Cocinar al vapor conserva más los nutrientes que hervir, porque cuando hervimos, parte de ellos pasan al agua. Sin embargo, si hacemos todas las comidas al vapor, puede que pronto sucumbamos al aburrimiento.

Los bebés pueden disfrutar de todas estas formas de cocción, y más. Cuando vamos ofreciendo diferentes alimentos y variando las formas, aparecen más oportunidades de probar nuevos sabores. ¿Probaron unos tomates al horno con romero? ¿O unas manzanas asadas en las mañanas de invierno? Nosotros empezamos a descubrir, junto con ellos, un nuevo

universo de texturas, colores y sabores.

Formas

Los alimentos que tienen formas esféricas NO son aptos para bebés que están iniciando la alimentación complementaria dado que tienen un alto riesgo de asfixia. ¿Por qué? Porque pueden obstruir la vía aérea fácilmente. Arándanos, garbanzos, frutos secos, rodajas redondas de alimentos como el tomate *cherry* o las salchichas (aunque nunca sugeriríamos ofrecer salchichas, ¡a nadie!), son peligrosos para los bebés. Entonces, ¿no hay que ofrecer garbanzos ni arándanos? No, simplemente hay que adaptarlos. A los arándanos podemos aplastarlos, usarlos en preparaciones o cortarlos en cuartos. A las legumbres esféricas podemos usarlas en pastas trituradas, harinas y otras preparaciones que veremos más adelante.



Cómo ofrecer frutas

El ser humano tiene un gusto innato por el sabor dulce, como vimos antes. Sin embargo, no todas las frutas son dulces: algunas son ácidas, otras no

tienen mucho sabor. No hay que tenerle miedo a lo ácido, recordemos que para el bebé, es todo nuevo, se están formando las zonas del cerebro donde se reconocen sabores y no hace falta privarlo de esa experiencia.

Algunas consideraciones sobre la fruta

- **Idealmente elegir fruta de estación.** ¿Cómo sabemos que es de estación? Es la más abundante y barata en la verdulería. Por ejemplo, en otoño, las mandarinas, y en verano, la sandía. Si compramos fruta que no es de estación, es porque seguramente hizo un largo camino para llegar a la verdulería, viniendo inclusive de otros países –con la huella de carbono que eso implica– o que estuvo guardada mucho tiempo en heladera. Esto no apunta a no comer NUNCA cosas exóticas o no comprar una naranja en diciembre –esa naranja siempre será más sana que una galletita–, pero sí tener la información para elegir.
- **Si la fruta es orgánica o agroecológica, mejor.** Si no lo es, pelarla, porque la mayor parte de los pesticidas se concentra en la cáscara.

ORGÁNICO	AGROECOLÓGICO
Es una certificación oficial que garantiza al consumidor una producción limpia de agrotóxicos y un uso responsable de los recursos del ambiente. Esta certificación es costosa y difícil de afrontar para los pequeños productores.	La producción agroecológica incluye, además de lo anteriormente citado, un enfoque que considera también a las familias productoras, el trabajo cooperativo, el desarrollo sostenible y local. No cuenta con certificación formal en Argentina.



¿Qué pasa con las semillas? Hay que tener cuidado con las pequeñas y duras como las de la sandía, los cítricos y las uvas. Las semillas de frutillas, kiwis, arándanos y tomates se pueden comer sin problemas, las veremos en la caca y es algo totalmente normal.

Al igual que con las verduras, hay muchas frutas que “se pueden”, pero su tamaño o forma es complicada de presentar al inicio de la alimentación. Por ejemplo, unas frutillas pequeñas en un bebé que aún no hace pinza. Simplemente podemos presentarlas en preparaciones o esperar un poco más, no hay apuro.

Algunos ejemplos de presentación de frutas

Banana

La banana es un *hit* tanto para los bebés que hacen BLW como para los que comen papillas. Es dulce, es fácil de cortar y de pisar, endulza preparaciones y tiene una textura muy buena para empezar.

A algunos bebés no les gusta que se les resbalen los alimentos y se “enojan”. Paciencia, acompañaremos muchas frustraciones como esa durante toda la vida de nuestros hijitos. La próxima vez, el cerebro del bebé sabrá que tiene que apretar diferente y mandará esa orden a la manito, y la siguiente

manipulará los trozos sin que se le resbalen.

Podemos también ofrecer el trocito con un pedacito de cáscara o rebozado con alguna harina de frutos secos molida bien fina.



Manzana y peras

La manzana es otra opción muy común. Sin embargo, hay que tener cuidado, porque su textura suele ser dura y quebradiza, pudiendo los bebés atragantarse fácilmente con ella.

Lo más común es presentar la manzana rallada (tengo en casa el rallador de plástico que usaban mi abuela y mi madre...), lo cual sabemos que es una opción, pero para ofrecer en trozos no nos sirve (personalmente, además, ¡detesto rallar manzana!).

Las peras son similares, pero como tienen más contenido de agua, muchas veces están blanditas y se pueden ofrecer sin cocinar. Inclusive son grandes aliadas para endulzar preparaciones porque se hacen fácilmente puré.

Para que las manzanas y algunas peras más rebeldes tengan una textura suave, tendremos que cocinarlas. Cuando las pinchemos con un tenedor sin tener que hacer fuerza, sabremos que están listas. A medida que el bebé va creciendo, no necesitaremos que sea tan blandita, pero no se sugiere ofrecerla cruda hasta por lo menos los 3 años (claro que esto depende de cada bebé).

Otra opción para bebés que ya están cancheros y tienen dientes es ofrecerla en láminas crudas muy finitas. Cuando ya hacen pinza, podemos ofrecerla en cubitos cocidos. Inclusive le podemos agregar canela u otro

condimento, para disfrutarla en familia. En el capítulo 14 les muestro algunas técnicas sencillas.



Cítricos (naranja, mandarina, pomelo, limón)

El otoño-invierno es la época de los cítricos. Más ácidos, más dulces, más jugosos; todos aportan fibra, agua y vitamina C, que ayuda a que se absorba mejor el hierro.

Se pueden ofrecer desde el inicio de la alimentación complementaria. A veces nos da “cosa” ofrecer un sabor ácido a un bebé, pero es importante que lo hagamos, porque necesitamos que pueda experimentar todos los sabores. Puede que haga alguna cara rara (cara rara no significa que no le gusta), pero después lo vamos a ver comiendo limón como si fuera la fruta más rica del mundo.

Los gajos suelen tener un tamaño apto para la manito, cuidando de sacar las semillas que son las que dan el riesgo de asfixia. Al principio, es más fácil sacarles la “pielcita” a los gajos para que puedan acceder fácilmente a la pulpa, pero a medida que los bebés van creciendo y adquiriendo nuevas habilidades, vamos a poder dejarla. Otra opción es cortar “al contrario” de los gajos y así nos evitamos pelarlos y es más fácil sacar las semillas (ver imagen).

¿Qué cítricos puedo incorporar? Todos. Naranja, mandarina, limón, pomelo... Todos sabores diversos e interesantes. También se pueden incorporar a preparaciones.

¿Y si arranco con papillas? Se pueden sumar a las mismas sin problemas, desarmando la pulpa.

Recordemos que es mucho mejor, siempre, ofrecer fruta entera, y no jugo, por más que sea exprimido. El exprimido no es algo “sano” para todos los días, puede ser un mimo, algo eventual, pero solamente nos aporta el azúcar de la fruta y no todos sus nutrientes, y no se recomienda en pediatría.



Durazno

El durazno y su primo, el pelón, son frutas típicas del verano. Dulces, jugosos, sencillos de abrir y con una pelusita que no hace falta pelar. Se pueden presentar sin necesidad de cocinar, en gajos o cubitos cuando ya hacen pinza.

Hay que evitar las presentaciones enlatadas “en almíbar”. El almíbar tiene azúcar o, peor aún, edulcorante.

Ciruela

Existen muchas variedades de ciruelas, lo cual se observa tanto en su cáscara como en su pulpa. ¡Hay ciruelas con pulpa de color amarillo, blanco, verde y rojo!

Dentro de sus azúcares naturales se encuentra el sorbitol, el cual, junto con la fibra que trae el fruto, genera un efecto laxante.

Es muy común que cuando un bebé está constipado, se le sugiera a la familia ofrecer el agua de cocinar las ciruelas (la compota de ciruelas, en fin). Varias aclaraciones sobre ello:

- Antes de los 6 meses, los bebés no deben recibir ningún líquido o alimento fuera de la leche humana, o de fórmula si es que toma esta última. Ni agua, ni jugo, ni té, ni compota.
- Si un bebé menor de 6 meses está realmente constipado (sabiendo que no todos los bebés hacen caca todos los días), hay que encontrar la causa y de esa manera, junto con su pediatra, encontrar la solución.
- La compota de ciruela puede ser una opción para el tratamiento de la constipación de un bebé mayor de 6 meses o de niños y niñas mayores, pero es importante tener en cuenta todos los factores que llevan a la constipación y no solo buscar un “remedio”. Lo charlaremos más adelante en el capítulo 12 sobre las cacas.

Uva

Las uvas son muy ricas y dulces, como caramelos. El problema es que son redondas y pequeñas, y además tienen semillas duras que tienen riesgo de asfixia.



Entonces, aquí algunas consideraciones para ser ofrecidas:

- Las ofrecemos cuando los bebés empiezan a hacer pinza.
- Las cortamos por la mitad a lo largo o en cuartos y retiramos las semillas.
- Antes de esto, podemos ofrecerlas en preparaciones.
- No hace falta pelarlas.

Frutilla

Las frutillas y otros frutos rojos se pueden ofrecer desde el inicio de la alimentación complementaria. Esto cambió en los últimos años, ya que previamente se sugería no ofrecerlos hasta el año por riesgo de alergia. Hoy las recomendaciones sugieren ofrecerlos tempranamente (lo volvemos a ver en el capítulo 13 sobre alergias alimentarias).

Algunos tips:

- Si el bebé es pequeño, elegir las frutillas más grandes y más maduras, que son más blandas.
- Las frutillas, arándanos y otros frutos rojos son de las frutas que más agroquímicos contienen. Idealmente elegir orgánicos o agroecológicos.
- Las “semillas” que están por fuera pueden consumirse sin problemas.
- Es común que los frutos rojos, como el tomate y la berenjena, produzcan un enrojecimiento de la piel producto de sustancias que se encuentran en la fruta (histamina). Esto no es una alergia, es una reacción esperable. Tranquilidad, consultarlo con su pediatra y ofrecer de a poquito.



Arándano

Acá en casa, la presencia de arándanos es efímera: duran pocos segundos cuando aparecen en la visión de un pequeñito de 2 años. Los arándanos son ricos, dulces, tienen un color precioso y son perfectos para guardar cual Pulgarcito, uno en cada esquina de la casa.

Los arándanos se relacionan con varios beneficios para la salud. Si bien los estudios están un poco flojos de papeles, se considera que podrían ayudar a evitar las infecciones urinarias, tener propiedades antiinflamatorias y ayudar a reducir el nivel de azúcar en la sangre. Por supuesto, todo esto no lo podría hacer el pobre arándano solo, sino que depende del resto de la alimentación y hábitos de la persona.

¿Cuál es el problema de los arándanos? Son redondos y pequeños, con riesgo alto de atragantamiento, como dijimos antes. ¿Entonces? Ofrecerlos cuando los bebés hacen pinza, partidos a la mitad o en cuatro.



- Previamente se pueden usar en preparaciones (*muffins*, panqueques, heladitos).
- Tienen unas semillitas minúsculas que probablemente veamos en la caca, al igual que sus cáscaras. Esto es normal y saludable.
- Dato de madre: ensucian mucho la ropa y son difíciles de limpiar.

Sandía y melón

La sandía es una fruta típicamente veraniega, con mucho contenido de agua, y muy fácil de comer para los bebés, al igual que su primo el melón. La cáscara es gruesa pero fácil de cortar. Es dulce e hidratante.

Es importante sacar las semillas. Puede dar fiaca, pero son peligrosas.



Granada

La granada es una fruta que se cultiva en Argentina pero no es muy popular. La incluyo porque es un fruto peculiar: tiene una cáscara dura y adentro muchas bolsitas acuosas rosadas con semillas.

Se puede ofrecer desde el inicio de la alimentación complementaria, pero tendrá más provecho hacerlo alrededor de los 9-10 meses, cuando empiezan a hacer pinza y se pueden entretener cazando los granos.

Maracuyá

El maracuyá o “fruta de la pasión” es una fruta originaria de Brasil. Tiene una cáscara rígida que cuando la cortamos muestra una pulpa gelatinosa con muchas semillitas. Estas semillas no son peligrosas debido a que están inmersas en esta matriz viscosa. Es muy rica en vitamina C y se puede ofrecer desde el inicio de la alimentación complementaria, ya sea con cuchara, en preparaciones o sorbiendo el contenido directo del envase cascaril.



Kiwi

Peludo por fuera, suave por dentro, se puede comer con cáscara y todo, desde el inicio de la alimentación complementaria, y no hace falta sacarle las semillas.



Pasas de uva, pasas de ciruela, dátiles deshidratados, etc.

Las frutas y verduras deshidratadas (como el tomate seco, por ejemplo) son vegetales sometidos a un proceso para quitarles la mayor parte de agua

posible, y de esa manera, conservarlos por un tiempo más prolongado. Esto hace que sus compuestos y sabores se concentren e intensifiquen.

A los chicos les encantan las pasas de uva, por ejemplo, porque son sumamente dulces, y comerían miles. Se pueden ofrecer las pasas de uva más grandes y carnosas desde que hacen pinza, pero es importante limitar la cantidad. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, suelen traer molestias gastrointestinales por la gran cantidad de fructosa que contienen. Además, por su sabor intensamente dulce, pueden generar preferencia y desplazar otros alimentos. Siempre es preferible la fruta fresca.

Cómo ofrecer verduras

Palta

La palta es una fruta alta en grasa saludable y fibra. Es muy recomendable para el inicio de la alimentación complementaria, porque cuando está madura, es muy blanda y fácil de gestionar para los chicos.

Si la palta está dura, es porque aún no maduró, podemos ayudarla envolviéndola con un papel de diario y poniéndola cerca de las bananas si tenemos (las bananas las ayudan a madurar).

Idealmente la cortamos en gajos. Si a los bebés se les resbala mucho, podemos dejar un pedacito de cáscara o pasar uno de los polos del gajito por harina de frutos secos bien molidos.

La palta no “cae pesada” ni “engorda”. Ya hemos hablado de lo importante que es disfrutar de los alimentos y no caer en la cuenta de calorías. Es una buena opción para bebés, niños, niñas, adolescentes y adultas/os.



Brócoli

¡La superestrella del BLW, el maestro Jedi de la BLWología, el vegetal verde que es un faro en el camino del aprendizaje en la alimentación complementaria! Hablamos del brócoli, sí.

Es un vegetal de la familia de las crucíferas, como la coliflor y el repollo. Las cabecitas que comemos son sus flores. Rico en fibra y calcio, también tiene carotenos y vitamina C, por lo que ayuda a la absorción del hierro.

Y, sobre todo, es muy muy fácil de ofrecer, porque tiene un tallito más firme y una “copita”, cual arbolito, que se desarma muy sencillo con las encías del bebé una vez que está cocinado. Como dije al principio del capítulo, se puede hacer al vapor, hervido, al horno... Jueguen con los ingredientes que algo va a salir.

Tomate

Una de las frutas más consumidas en este lado del mundo, es rica en agua e hidratos de carbono, con vitaminas del grupo B y minerales en su composición. El color rojo se lo da una sustancia llamada licopeno, que es un antioxidante, al igual que la vitamina C, que también es abundante en su composición. Esto hace al tomate un gran aliado para la absorción de otros nutrientes como el hierro.

¿Cómo presentarlo?

- En rodajas gruesas cortadas por la mitad, para que los bebés puedan tomarlas y chuparlas.
- En rodajas finas, para bebés que ya tienen dientitos.
- En trozos pequeños, para bebés que ya hacen pinza.
- En forma de salsa de tomate casera.
- Al horno, más blanditos.
- Tomates secos: sirve dejarlos remojando y ofrecerlos blanditos. También vienen conservados en aceite, y si no tienen sal, se pueden consumir desde el inicio de la alimentación complementaria si es una conserva segura.



¿Qué pasa con...?

- **Los tomates de lata:** los enlatados no se sugieren en la infancia por su alto contenido de sodio. Si se decide dar latas, importante tener en cuenta que no tienen que estar golpeadas ni hinchadas, por el riesgo

de botulismo.

- **Las salsas de tomate comerciales:** suelen ser ultraprocesados con alto contenido de azúcares, colorantes y conservantes.
- **El tomate triturado comercial (solo tomate en ingredientes):** si está rotulado y tiene las certificaciones de inocuidad pertinentes (RNAP y RNE), puede ser una buena opción.

ACERCA DEL RNE Y RNPA

Según lo establecido en el Código Alimentario Argentino (CAA), es necesario que los establecimientos productores, elaboradores y fraccionadores realicen, previo al inicio de sus actividades, los trámites de inscripción y autorización ante la autoridad sanitaria jurisdiccional competente. También deben registrar los productos alimenticios antes de comenzar a comercializarlos. Cuando la autoridad sanitaria autoriza/aprueba el establecimiento/producto, otorga un número de Registro Nacional. El Registro Nacional de Establecimientos (RNE) es una constancia de que la empresa ha sido inscripta en el Registro Nacional de Establecimientos, que la habilita para desarrollar la actividad declarada. Además, es un requisito para el posterior registro de sus productos en el Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA).

¿Las semillas del tomate son peligrosas? No, como están adentro de un mucílago –una sustancia gelatinosa–, no tienen mayor riesgo de atragantamiento. De todos modos, si esto genera inquietud, se pueden sacar y listo. ¿Dan apendicitis? No, no son causantes de apendicitis *per se*. ¿Hay que pelar los tomates? No necesariamente, aunque si no son orgánicos o agroecológicos, puede ser una buena sugerencia.

Zapallito

Hay diversos tipos de zapallitos. El *zucchini* y el redondo son los más conocidos (aunque en realidad el *zucchini* es primo del pepino). Se pueden comer con las semillas, dado que son blandas y no generan riesgo cuando están cocidos, pero si se sienten más seguros sacándolas, adelante.

Papa y batata

Existen muchísimas variedades de papas y batatas, que varían en tamaño, color y sabor. Todas son aptas desde el inicio de la alimentación complementaria, y muy aceptadas por los bebés, niños y niñas.

Son los vegetales más fáciles de ofrecer, dado que al hervirlas o hacerlas al vapor, se vuelven muy blandas.



¿POR QUÉ LES GUSTA TANTO LA PAPA?

A los deambuladores les fascinan los alimentos blancos: papa, fideos, banana. Esto tiene una lógica: tienen muchas calorías en poco volumen, y les sirven para recargar energía en poco tiempo. Al año y medio suele ser mucho más interesante caminar por todos lados que probar brócoli. Saber esto nos ayuda a tomar con tranquilidad esta preferencia, mientras seguimos ofreciendo otros alimentos. Lo veremos más en detalle en el capítulo 9 sobre neofobia y selectividad.

Choclo

El choclo es el fruto de la planta de maíz, y es considerado un cereal. Es amarillo, sabroso y... polémico. Hordas de comentarios en Internet condenan a “esas doctoras nuevas que promueven el BLW” por querer instigar a una matanza de bebés a manos del malvado choclo.

Pues no. El choclo puede ser ofrecido desde el inicio de la alimentación complementaria, pero yo soy más cautelosa y no sugiero ofrecer de entrada granos enteros, ni granos cortados, ni rueditas. Sugiero procesar el choclo, por ejemplo, y ofrecerlo en preparaciones: tortillitas, humita (muy común en el norte de Argentina), tamales, polenta o arepa de choclo.

Una vez que los bebés tienen más cancha en gestionar alimentos y empiezan a hacer pinza fina, ofrecería el choclo en forma de rueditas, con los granos cortados a la mitad.

Posteriormente, cerca del año, podemos ofrecer los granitos de choclo blandos para que los agarren de a uno, o directamente el choclo entero para que lo mordisqueen como ratoncitos, algo que les gusta mucho.

Es normal ver pedacitos de choclo en la materia fecal, tanto de niños como de adultos. El recubrimiento de cada uno de los granos no se digiere dado que nuestro intestino carece de la capacidad de hacerlo, pero genera mayor volumen en la caca y previene la constipación, además de ser un buen complemento para la microbiota.



Zanahoria

La zanahoria es una raíz comestible, que antiguamente se cultivaba por sus hojas y semillas aromáticas. Las hojas pueden ser consumidas también en croquetas o en pesto. Como la conocemos habitualmente, puede ser todo un reto al inicio de la alimentación complementaria. Es importante saber que no se sugiere ofrecerla cruda, porque tiene riesgo de atragantamiento por asfixia, dada su textura rígida y quebradiza. Tiene alto contenido de betacarotenos, los precursores de la vitamina A, y de otros compuestos importantes como el potasio, el calcio y las vitaminas del grupo B.

Para ofrecerla, debemos cocinarla bien, dado que al ser muy fibrosa, es posible que aunque esté blanda, pueda generar lo que llamamos “efecto proyectil”: cuando apretamos (como apretaría la encía de un bebé) un trocito, puede salir con fuerza e impactar en la vía aérea.

- Las zanahorias pueden ser cocinadas al vapor, hervidas, al horno, en la olla... Donde quieran mientras estén blandas.
- La mayonesa de zanahoria (ver en el capítulo 14 una receta de untable de zanahoria y porotos que es una delicia) es una buena y sabrosa opción para toda la familia.
- Si no nos animamos a ofrecerla entera, podemos rallarla y hacer tortilla de zanahoria rallada o budín de zanahoria (similar a la famosa *carrot cake*).

Berenjena

La berenjena, de un violeta sinuoso, es muy atrayente para los chicos en la verdulería. Se puede ofrecer al horno, dentro de un guiso, en forma de milanesa, adentro de una empanada y –mi presentación favorita– en forma de *baba ganoush*, un untable delicioso.

Es normal el enrojecimiento alrededor de la boca cuando comen berenjenas.

No hace falta sacarles las semillas ni caen mal.

Para comerlas en escabeche, esperemos un poco: hasta el año al menos,

por el contenido de sal. Y siempre teniendo en cuenta la importancia de que sea una conserva segura.

Acelga, espinaca y remolacha

Las hojas verdes son vegetales muy populares en la alimentación familiar. De hecho, cuando pensamos en “verdura” (palabra que viene de “verde”), solemos pensar en estas plantas. Sin embargo, vamos a encontrar en muchos textos que no se sugieren ofrecer hasta el año de vida al menos.

¿Por qué? Porque tienen un alto contenido de nitratos, una sustancia que cuando a través de los procesos digestivos se convierte en nitritos, puede causar una patología que se llama metahemoglobinemia. En la metahemoglobinemia, los tejidos no pueden obtener suficiente oxígeno y da como resultado el síndrome del bebé azul.

La cantidad de nitratos en los alimentos depende de dónde se cultivó, de cuánto sol le dio a la planta, qué fertilizantes usaron, etc. En Argentina no hay datos sobre el contenido de nitratos en los vegetales, por eso tomo las recomendaciones de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición como guía.

Hortaliza	Nivel medio (mg/Kg)	Hortaliza	Nivel medio (mg/Kg)
Acelga	1690	Puerro	345
Remolacha	1379	Judía verde	323
Lechuga	1324	Zanahoria	296
Apio	1103	Pepino	185
Espinaca ¹	1066	Patata	168
Calabaza	894	Cebolla	164
Lechuga <i>iceberg</i>	875	Pimiento	108
Nabo	663	Tomate	43
Calabacín	416	Guisantes	30

Fuente: Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on a request from the European Commission to perform a scientific risk assessment on nitrate in vegetables. *The EFSA Journal* (2008). Journal number, 689; 1-79.

1 En la opinión de EFSA se presentaron combinados los datos de espinacas frescas y congeladas, aunque debe tenerse en cuenta que el nivel de nitratos en espinacas congeladas es inferior al de espinacas frescas.

Como se puede apreciar en el cuadro, la mayor parte de los vegetales

tienen nitratos. Inclusive la lechuga o el apio tienen más nitratos que la espinaca, por ejemplo, y la calabaza juega cabeza a cabeza.

Las hojas verdes también tienen un alto contenido de oxalatos, que generan que el hierro que contienen se absorba pobremente. Sí, eso de que la espinaca aporta hierro es un gran chasco.

¿Entonces? La recomendación es que se pueden dar desde el inicio de la alimentación complementaria, pero se recomienda esperar al año. Si deseamos ofrecerlas antes porque son parte frecuente de nuestra mesa familiar, simplemente hay que presentarlas en pequeñas cantidades, y sin que sean el alimento principal, ni para todos los días. En la alimentación autorregulada es poco frecuente que los bebés coman enormes cantidades de acelga y espinaca.

ESPINACAS ACELGAS	Se recomienda no incluirlas antes del primer año de vida. 0-1 año.	En caso de incluirlas antes del año, procurar que: • El contenido de espinacas y/o acelgas no sea mayor de 35 gramos/día.
	En niños entre 1 y 3 años.	• No dar más de media ración de acelgas o espinacas (45 gramos/día, cantidad a modo de guarnición).
		• No dar espinacas y/o acelgas a niños que presenten infecciones bacterianas gastrointestinales.
VERDURAS COCIDAS	No mantener a temperatura ambiente (enteras o en puré). Conservar en frigorífico si se van a consumir en el mismo día; si no, congelar. El lavado y la cocción de las verduras (desechando siempre al final el agua resultante) ayudan a reducir el contenido de nitratos y también de oxalatos.	

Recuperado de:

http://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/para_el_consumidor/ampliacion/nitratos_hortalizas.htm

Y un dato para prevenir sustos: recordemos que la remolacha puede teñir el pis y la caca de rojo.

Kale (col rizada)

El *kale* es una verdura de hoja que se está volviendo muy popular. Contiene una bonita cantidad de calcio, y no tiene gran contenido de nitratos que puedan ser peligrosos para bebés. La hoja es fibrosa y puede ser difícil de masticar.

Al *kale* lo podemos presentar como:

- Chips de *kale* hechos al horno, en deshidratador o en la freidora de aire.
- Tortillas o tartas.
- Salteados, donde se vuelve más blando.

Para los chips de *kale*, que suelen llevar muchos condimentos o sal (ver las recetas del capítulo 14), mejor esperar unos meses de entrenamiento en la alimentación complementaria, dado que al ser crujientes, se desarman mucho. Las otras opciones las podemos ofrecer desde el inicio de la alimentación complementaria.

Cebolla, ajo y morrón

Los junto porque son mis favoritos para todas las comidas. Los tres pueden ser parte desde el inicio de la alimentación complementaria, sin miedo. Generalmente no son los protagonistas del plato, sino que dan sabor, ¡y qué sabor! Anímense a ofrecerlos cocidos al principio, por la textura; y cuando ya son más grandes y ustedes estén cortando cebolla, ofrecerles un trozo crudo. Suelen tener muy buena aceptación.

Cómo ofrecer legumbres

Las legumbres son alimentos poco apreciados en esta parte del mundo, considerando que el promedio de consumo anual por persona es de: ¡800 gramos!

Las legumbres vienen en empaques aburridos, no tienen mucha publicidad y están en la parte de abajo de la góndola del supermercado. ¿Por qué pasa esto? Porque son baratas, rinden mucho, son muy nutritivas y de gran calidad alimentaria. Y eso no les conviene a las empresas que venden ultraprocesados.

Son un alimento rico en proteínas, calcio, zinc y hierro. Animémonos a incorporarlas en nuestro día a día. Son tan baratas y sustentables que la OMS las pone dentro de los mejores alimentos para lograr Hambre Cero en el mundo. Contienen hierro, calcio y otros nutrientes importantes. También tienen una gran cantidad de proteínas. Sin embargo, para absorber el hierro más eficientemente, es importante combinar su consumo con alimentos con vitamina C. ¿Por ejemplo? Casi todas las frutas, y no solo las cítricas. La frutilla, el kiwi y el mango también tienen un alto contenido de vitamina C. Las verduras como el morrón, el brócoli, la coliflor y los repollitos de Bruselas también tienen una cantidad importante de vitamina C, pero como solemos cocinarlas, parte de ella se pierde.

Las legumbres se pueden ofrecer desde el inicio de la alimentación complementaria. ¿Pero no son redondas y chiquitas, lo que generaría riesgo de asfixia? Si las adaptamos, ¡no! Entonces... ¿cómo podemos ofrecer legumbres desde el inicio de la alimentación complementaria? Veamos:

- Como puré; o si hacen BLW, se puede ofrecer una cuchara precargada.
- Como croquetas o hamburguesas.
- En forma de harina: hay harina de lentejas, de arvejas, de garbanzos... Se puede hacer fainá, pan, galletitas, *waffles*.
- En forma de fideos (de arvejas, lentejas, garbanzos).
- En forma de falafel o de *nuggets* de legumbres.

- En forma de untables: hummus de garbanzos, porotos blancos procesados con remolacha, untable de porotos negros y oliva.
- Los porotos de soja se pueden ofrecer en forma de tofu, con el cual se pueden hacer múltiples preparaciones.

¿Y qué pasa con los antinutrientes? Los antinutrientes son sustancias que protegen a la semilla, y que en el cuerpo humano, al ser consumidos, bloquean o alteran la absorción de algunos nutrientes, disminuyendo su biodisponibilidad. Por ejemplo, las hojas verdes tienen calcio, pero al contener también oxalatos, ese calcio no se puede absorber y no se consideran fuente del mismo.

No son algo terrible e inclusive algunos tienen funciones beneficiosas para el organismo, como las lectinas, fosfatos y compuestos fenólicos que son antioxidantes. Nada es blanco o negro en este universo, y casi todos los alimentos tienen antinutrientes.

¿Qué pasa si consumimos los antinutrientes? Justamente, no aprovecharemos todos los beneficios de estos alimentos, y en algunas personas se generarán molestias gastrointestinales.

Entonces, ¿cómo removemos los antinutrientes? Con un doble método: primero remojar, fermentar o germinar, y luego cocinar. Para remojar, primero “lavaremos” las legumbres en un colador para limpiar la tierra y las impurezas. Luego las dejaremos remojando en agua varias horas.

Aquí, consejo de madre: existen tablas que sugieren la cantidad de horas por legumbre, pero ni siquiera intenté retener esa información. Se pueden dejar remojando toda la noche, cubiertas por una tela limpia, y listo. Y si hace mucho calor, se remojan en la heladera. A la mañana siguiente se cocinan, se porcionan y van a las comidas de la semana y al *freezer* (se pueden freezar las legumbres remojadas solamente, o remojadas y hervidas).

Al agua del remojo se le puede agregar unas gotas de vinagre o de limón, o inclusive un chorrito de kéfir para iniciar una fermentación.

Las legumbres remojadas se hierven, acá sí, diferente según la legumbre. A veces tardan bastante en ponerse tiernas, pero cuando las remoja previamente, ocupan menos tiempo en la olla. Se suele sugerir el uso de un alga *kombu* o laurel en el agua para aumentar la digestibilidad. Con una hojita de laurel no habría problema, pero las algas no se recomiendan en

la infancia por su alto contenido de iodo, hasta aproximadamente los 5 años.

El remojo y otros procesos necesarios para eliminar los antinutrientes también ayudan a la mejor biodisponibilidad del hierro.

¿Qué legumbres podemos usar? Cualquiera: porotos negros, rojos, blancos y mung; garbanzos; lentejas, lentejones; arvejas... Hay literalmente veinte mil opciones. Algunas personas después de hervirlas proponen “pelarlas” (sobre todo, los garbanzos). Esto genera texturas más sedosas cuando las procesamos, por ejemplo, para el hummus. Es opcional, no hace falta pelar las legumbres (yo jamás lo hice y probablemente jamás lo haré).

¿Las legumbres dan gases? Los gases intestinales son el resultado de la fermentación de diversos compuestos en el intestino a través de las bacterias que forman parte de la microbiota. Es un proceso sano, esperable y saludable. Si nunca comimos legumbres o tenemos una dieta baja en fibras y de pronto las incorporamos en la alimentación diaria, nuestras bacterias se pondrán tan contentas que harán una fiesta de fermentación y podemos sentir más gases. Este es un proceso momentáneo, dado que si persistimos con la buena alimentación, se regularizará.

En los bebés que inician la alimentación complementaria, la cantidad de gases dependerá de varios factores, por ejemplo, si son alimentados con fórmula, leche humana o lactancia mixta, dado que su microbiota es diferente. Generalmente no hay mayores inconvenientes, ¡los gases son normales!

Existen bebés, niños y niñas con alergias alimentarias, que generalmente están asociadas a una disbiosis (desequilibrio de la microbiota) y a un intestino permeable. Inclusive hay bebés con alergias a algunas legumbres o que no pueden consumir ciertas marcas de legumbres por la contaminación cruzada (tal vez son alérgicos a la proteína de leche de vaca o a la soja, y en la compra de legumbres sueltas hay contaminación). Todos estos casos particulares es importante charlarlos con el equipo tratante (pediatra, nutricionista, gastroenterólogo, alergista, etc.).

¿Se pueden usar legumbres de lata? **Las legumbres de lata son conservas y pueden ser útiles, pero no se sugiere ofrecerlas hasta los 2 años, por el alto contenido de sal que contienen.** Es importante observar que la lata no esté golpeada ni hinchada cuando la compramos, por el riesgo

de botulismo.

¿QUÉ PASA CON LA SOJA?

La soja es una legumbre de alto valor nutritivo. El problema es el sistema productivo donde se cultiva la misma, que agota los suelos y genera innumerables conflictos para el medio ambiente. Yendo específicamente al poroto de soja, ¿es malo para los niños? No. Es una legumbre más, posible en el mundo de las legumbres.

En el año 2001, con la grave crisis económica y social de Argentina, se comenzó a “reemplazar” la carne de los comedores populares por soja. La soja resultaba más barata y en ese momento se propuso como un alimento “milagroso” que cubría gran parte de las necesidades nutricionales. Sin embargo, la soja-legumbre que llegaba a los comedores no era orgánica, sino que tenía un alto contenido de plaguicidas, muchas veces no se cocinaba correctamente debido al desconocimiento (no se remojava, por ejemplo) y terminaba siendo la base de la alimentación de esas familias. La alimentación se comenzó a “sojizar” y se empezaron a vender, por ejemplo, bebidas de soja azucaradas, prometiendo que eran más sanas que la leche de vaca y que tenían más nutrientes.

En ese momento y en los años siguientes, la desnutrición y la mortalidad infantil aumentaron, producto de la debacle sociolaboral que acontecía. La anemia por falta de hierro creció: los niños no comían productos de origen animal por falta de dinero, y muchas veces su único plato de comida eran fideos y el único alimento con hierro era la soja. El problema era que si esa soja-legumbre no era remojada previamente, sus antinutrientes iban a generar aun menor absorción de hierro, y si no había frutas o verduras disponibles, el hierro se iba a absorber pobremente.

¿Cuál es la conclusión? El problema no es el poroto de soja: es que no se puede basar la alimentación en un solo alimento, sea una legumbre, una fruta o una achura. Siempre que se consuma un solo alimento o un solo tipo de alimentos, sin variar, van a faltar nutrientes.

Otro problema de la soja es que contiene isoflavonas, compuestos que

tienen similar actividad farmacológica que los estrógenos (un tipo de hormona predominante en las mujeres). Estos compuestos no son específicos de la soja: se encuentran también en los porotos, la naranja, el brócoli, la manzana, la cebolla, las semillas de lino, los cereales, algunas frutas, etc. Sí, como leen: la naranja también tiene compuestos similares a las hormonas. Pero, particularmente, la soja tiene más concentración de ellos que otros alimentos. ¿Afectan estos compuestos a los bebés, niñas y niños? Los estudios sugieren que si la soja fuera el principal alimento de estos niños, podría haber consecuencias negativas (aún en estudio). Pero siendo una legumbre más en el marco de muchos alimentos diversos, no sería un problema.

Entonces, ¿pueden comer porotos de soja los bebés, niños y niñas? Sí, pueden, con algunas pautas de seguridad:

- NO como base de la alimentación, y sí remojados y bien cocinados.
- Pueden comer tofu orgánico (preparación que se realiza con el poroto de soja y usualmente viene fortificado con calcio).
- Pueden consumir germinados (brotes) de soja.
- La mayor parte de la soja consumida no viene de los porotos ni de los brotes, sino de los ultraprocesados, donde se utiliza para “estirar” las preparaciones.
- NO se recomiendan las bebidas de soja, a ninguna edad. Suelen contener azúcares, sal y otros ingredientes insanos.
- No se sugiere el uso de salsas de soja por el alto contenido de sal.

Legumbres fabulosas para el inicio de la alimentación complementaria

- **Porotos negros:** se cocinan relativamente rápido y sirven de base para preparaciones dulces o saladas. En muchos países se utilizan como complemento para gran variedad de platos.
- **Garbanzos:** el alma del hummus, con cuya harina también se hace la fainá.
- **Porotos pallares** (también llamados porotos manteca, frijol ancho y otra serie hermosa de diferentes nombres): se desarman muy fácilmente después de cocidos. Es el típico poroto que usamos para los experimentos de la germinación, y que solemos comer en el locro, una comida típica de estas tierras.
- **Lentejas:** al principio no las ofreceremos enteras, sino pisadas o en preparaciones. En el capítulo 14, está mi favorita, como ya les conté: la torta de lentejas sin azúcar.
- **Porotos *mung* y porotos *aduki*:** luego de remojados tienen un tiempo de cocción corto, un sabor neutro que sirve para preparaciones dulces y saladas, y son fáciles de digerir.
- **Lentejas rojas:** no hace falta remojarlas, aunque se sugiere darles una lavada antes de hervirlas. Las ponemos en un colador debajo del chorro de la canilla, y podemos recoger el agua con un recipiente y usarla para regar las plantas, para no desperdiciar. Se hierven unos 10 minutos y quedan bien blanditas. Son buenas para sopas, guisos y para hacer hamburguesas, *muffins* y otras opciones.



Formas de consumir
legumbres

Cómo ofrecer cereales

Cuando pensamos en cereales para bebés, niñas y niños, generalmente se nos vienen a la mente tres cosas: unas espigas de trigo, una caja con un oso azul para preparar con leche en la góndola del súper, y un recipiente con hojuelas de maíz con un tigre naranja al lado. Eso es lo que ha hecho la publicidad en nosotros: no tenemos ni idea de cómo es un cereal de verdad, de dónde sale, en qué tierra crece. Y así nos venden cosas muy poco sanas mientras creemos que son sanas.

Algunos ejemplos de los “cereales” del supermercado:

- **Aritos “frutales”:** son una combinación de azúcar, harina, aceites, colorantes, conservantes y aromatizantes. Nunca, ni por casualidad, estuvieron cerca de una fruta.
- **Almohaditas:** ¿por qué? Porque se perciben como saludables, se venden en las dietéticas y se promocionan como “el *snack* para comer a cualquier hora”. ¿Saben qué son las almohaditas? Son galletitas. Una masa de azúcar, harina y aceite de mala calidad, rellenas de cosas de peor calidad.
- **Copos de maíz “sin azúcar”:** leyendo los ingredientes, el segundo ingrediente es el azúcar, aunque no estén “escarchados” con la misma.

Estas y cualquier forma geométrica de cereal son golosinas, realizadas con la HARINA de ciertos cereales, más azúcar, más aditivos. Lo que venden como “cereales de desayuno” son una especie de galletitas camufladas.

Los cereales de verdad son alimentos vegetales de los cuales utilizamos su grano. Dentro de los cereales, encontramos el trigo y el maíz –los más conocidos–, la avena, la cebada, el centeno, el arroz, el sorgo, el mijo, el teff. Tenemos también los pseudocereales, muy similares, pero que no contienen gluten: la quinua, el amaranto, el trigo sarraceno...

Todos se pueden incorporar desde el inicio de la alimentación complementaria.

¿Cómo usar los cereales?

- En su grano entero: ideal lavarlos, remojarlos unas horas y hervirlos. El remojo hace que se cocinen más rápido. Se pueden freezar remojados y luego cocinar, o freezar ya cocinados.
- Se pueden incluir en guisos, sopas y ensaladas.
- Podemos usar sus harinas: hay harina de quinua, de centeno, de avena, de trigo integral, de trigo refinado...
- Con las harinas, o incluso con el grano entero, podemos hacer galletitas, hamburguesitas, panqueques o tortillas. Podemos también freezar para tener.
- Los panificados caseros son una buena opción dentro de una alimentación variada: pan sin sal, masa de tarta, incluso *pizza*.
- Se pueden usar en forma de puré espeso, mezclado con frutas o con verduras, como la polenta, el mijo y la quinua.
- En forma de barritas (por ejemplo, barritas de polenta).
- En forma de preparaciones cremosas (arroz con leche, *porridge*).
- En bollitos (los bollitos de mijo son una gran opción y muy sencillos de realizar. ¡Básicamente hay que cocinar mijo y hacerlo bollitos!).
- En forma de fideos: hay fideos de quinua, de amaranto, integrales, con verduras...



**CEREALES DE
SUPERMERCADO**



CEREALES DE VERDAD

Algunas dudas comunes respecto a los cereales

¿Cuándo puede comer arroz solo sin riesgo de asfixia?

Cuando los bebés comienzan a hacer pinza fina, cerca del año de vida, se puede ofrecer el arroz en granos blandos para que lo “pesquen” con la mano y se entretengan con los granitos.

¿La avena hay que remojarla? Idealmente, sí. Se venden cuatro formas de avena:

- En grano entero, la menos conocida, que es similar al arroz.
- Arrollada, gruesa y fina.
- Instantánea.
- Harina de avena.

La avena arrollada es el grano de avena crudo aplastado por una máquina para formar la hojuela de avena. Por lo tanto, la avena arrollada está cruda, como está el arroz que compramos. Debemos cocinarla para digerirla más fácilmente, e idealmente remojarla.

Para remojar la avena, como cualquier otro cereal, se la cubre con agua y se la deja algunas horas (o toda la noche, más fácil). Se puede agregar un agente fermentador como un chorrito de kéfir, limón o vinagre, para ayudar al proceso de remojo. Al día siguiente se le saca el excedente de agua con una bolsa de tela finita para colar bebidas vegetales o un lienzo limpio, y la podemos usar para cocinar (galletitas, budines, panes, *porridge*, sopas saladas, hamburguesas, etc.).

La avena instantánea está precocida, pero no se ha remojado, por lo que conserva muchos de los antinutrientes. Se puede utilizar eventualmente sin mucho drama.

La avena, si bien no tiene gluten en su composición, en Argentina se guarda en los mismos silos que otros cereales con gluten, por lo que está

contaminada y no es apta para personas celíacas.

¿Qué pasa con el gluten? Según la *Guía de Práctica Clínica sobre Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Celíaca*, desarrollada por el Ministerio de Salud de nuestro país en 2017, no se retrasa la introducción del gluten en ninguna persona, tampoco en parientes cercanos de personas con celiacía. Retrasar su introducción generaría mayor intolerancia, y se sugiere presentar alimentos con trigo, avena, cebada y centeno a partir de los 6 meses y no más allá de los 7. Esta recomendación se encuentra en constante revisión.

Existen muchas personas con intolerancia al gluten no celíaca, o con alergia al trigo, todas condiciones diferentes a la celiacía. Esto no solo tiene que ver con el gluten *per se*, sino con la enorme cantidad de gluten que consumimos por día, y con nuestra microbiota tan afectada por el tipo de alimentación y de vida que llevamos.

¿QUÉ PASA CON EL ARROZ Y EL ARSÉNICO?

El arsénico es un elemento tóxico ampliamente distribuido en matrices ambientales en Argentina, especialmente en aguas subterráneas. El arsénico es responsable de varias afecciones en la salud humana; en Argentina cobra importancia el HACRE (hidroarsenicismo crónico regional endémico). En muchas regiones de nuestro país están estudiados los niveles de arsénico en agua de bebida, y en muchos casos se toman las medidas correctivas necesarias, pero se desconoce el aporte de este elemento a partir de los alimentos.

El arroz, por su forma de cultivo, es un cereal que absorbe más arsénico que otros. No existen muchos estudios que midan la concentración de arsénico en los cereales, pero se están estudiando técnicas para evitar cantidades dañinas. En un estudio publicado en 2020, el CONICET observó que más del 30 % de las muestras de arroz argentino tenían una mayor concentración de arsénico que la permitida por el Mercosur.

¿Dejamos de comer arroz entonces? No necesariamente.

Simplemente debemos tenerlo en cuenta para que el arroz no sea la base de la alimentación de niñas y niños, algo que es muy frecuente sobre todo en el segundo año de vida. Muchos “cereales para bebés” vienen a base de arroz, por lo que hay bebés pequeños que consumen la harina de este grano... ¡dos veces al día, todos los días!

Remojar el arroz horas antes de hervirlo también es una buena estrategia para eliminar parte de este compuesto.

Las bebidas vegetales no se recomiendan en general, pero sobre todo no se sugieren las bebidas de arroz, dado que el arsénico se encuentra aún más concentrado en ellas.

¿Cuándo puede comer pan? Los bebés pueden comer pan desde el inicio de la alimentación complementaria. El pan tiene tres ingredientes básicos: harina, levadura y agua. A esto se le agregan condimentos y alguna materia grasa, pero no mucho más.

En cambio, un pan industrial que se vende como “saludable” en el supermercado tiene estos ingredientes:

HARINA DE TRIGO ENRIQUECIDA, AGUA, AZÚCAR Y/O JMAF, HARINA INTEGRAL, SALVADO DE TRIGO, LEVADURA, GLUTEN DE TRIGO, ACEITE VEGETAL, SAL, GERMEN DE TRIGO, LECHE EN POLVO DESCREMADA, EMULSIONANTES: INS 471, INS 472E, CONSERVADORES: INS 282, INS 200, REGULADOR DE ACIDEZ: INS 330, MEJORADOR DE HARINA: INS 341I, AROMATIZANTE: ESENCIA DE MALTA, ANTIOXIDANTE: INS 300.

Los ingredientes en una etiqueta van de mayor a menor. Es decir, ese “pan integral” tiene más azúcar que harina integral. Ese pan industrial es un ultraprocesado y no se sugiere consumirlo, ni por niños ni por adultos.

Volviendo a la alimentación infantil, pueden comer pan casero sin sal desde el inicio de la alimentación complementaria, pero:

- El pan es una opción. No es para todos los días. Estamos acostumbrados a comer panificados sobre todo en el desayuno y el

almuerzo, pero eso es una cuestión cultural.

- El pan es muy bien aceptado por bebés, niños y niñas porque tiene muchas calorías que les aportan energía en poquito volumen. Ofrecer con moderación.
- En bebés ofrecer con un chorrito de aceite o con alguna pasta de legumbres untada, para agregarle grasas saludables.

¿Puede comer pan de masa madre? Sí, puede desde el inicio de la alimentación complementaria. La masa madre no usa levadura industrial, sino los propios microorganismos de la harina para fermentar. Cuando se cocina, se mueren los microorganismos, por lo cual no tiene probióticos, pero quedan los posbióticos que podrían ser beneficiosos para la salud (ver capítulo 4 sobre microbiota).

Cómo ofrecer carne, pollo, pescado...

Si tu familia consume alimentos de origen animal, es una buena sugerencia que incorporen estos alimentos desde el inicio de la alimentación complementaria. Las carnes de animales contienen proteínas, grasas y, sobre todo, hierro, que se absorbe de manera bastante efectiva en el organismo.

Se pueden ofrecer desde el inicio de la alimentación complementaria carnes de diferentes animales: vaca, pollo, pescado, cerdo. La clave con ellas es siempre cocinarlas bien y evitar la contaminación cruzada. Si podemos acceder a carnes orgánicas con animales criados fuera de *feedlots*, mucho mejor, aunque no suele ser muy sencillo acceder a esas opciones.

Más allá de las elecciones alimentarias de cada familia, es importante destacar que, aunque se consuman productos de origen animal, gran cantidad de sociedades científicas sugiere una alimentación basada en plantas y complementada con carnes, y no al revés.

Al inicio de la alimentación complementaria, se sugiere:

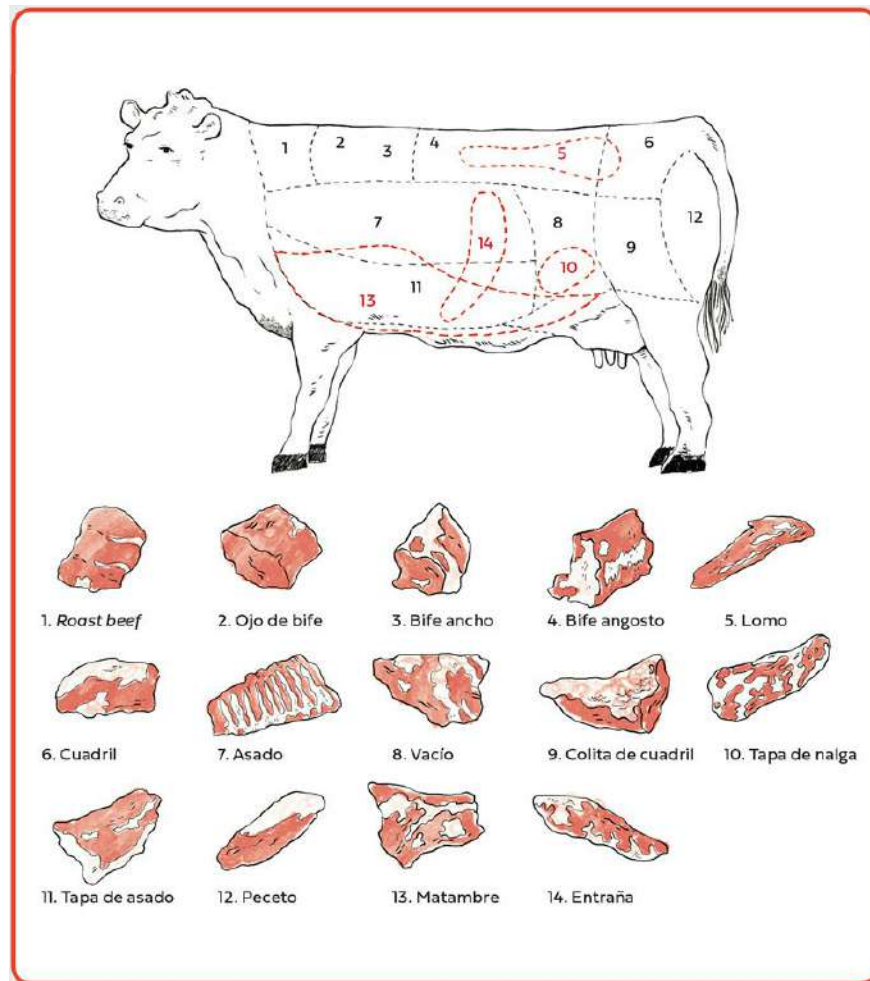
- Cocinar la carne de tal manera que se “deshilache”. Es decir, usar cocciones largas, o hervirla, para que sea fácil de desarmar para el bebé.
- Cortar la carne en contra de las vetas (fibras musculares) para que sea sencillo para el bebé desarmarla con las encías.
- Armar hamburguesas o *nuggets* de carne cocida previamente (nunca carne picada).
- Si no nos animamos a presentar trocitos, está la opción de “rallar” carne cocida y mezclarla con algún puré.

Carne de vaca

Se puede ofrecer cualquier parte de la vaca, siempre que la carne se cocine en su totalidad. No hace falta que las carnes sean siempre magras ni las más caras: podemos ir variando.

Me pareció importante compartir los diversos cortes de carne de vaca para saber qué parte del animal estamos comiendo, y no consumir por inercia.

PRINCIPALES CORTES VACUNOS



¿Puede comer hígado?

El hígado es un corte económico, y una posibilidad dentro de la alimentación complementaria. Su aporte nutricional se ve opacado por su gran cantidad de grasa saturada. Podría ser una opción si no hubiera capacidad económica de comprar otro tipo de carne.



¿Tienen que comer los bebés sesos de vaca para ser más inteligentes?

No, consumir el cerebro de la vaca no tendrá impacto directo en el desarrollo del bebé, porque este depende de muchas otras cosas.

¿Pueden comer carne asada?

Sí, si se cuida evitar la contaminación cruzada, se puede.

¿Por qué no pueden comer carne picada?

Nuestro país es tristemente campeón en síndrome urémico hemolítico (SUH), una patología que afecta los pequeños vasos sanguíneos del cuerpo como consecuencia de la liberación de la toxina de una bacteria. El SUH se contrae a través del consumo de carne mal cocida, sobre todo carne picada, leche no pasteurizada, agua no potable y verduras mal lavadas. El ganado vacuno es el principal reservorio de la *Escherichia coli* 0157:H7, la bacteria que produce esta toxina. En el faenamiento, la materia fecal del animal, contaminada con la bacteria, toma contacto con la carne.

Cuando cocinamos una carne, por ejemplo, un churrasco, cocinamos toda

la parte de afuera (la superficie contaminada por la bacteria) y la bacteria muere. En cambio, en la carne picada, esa bacteria queda mezclada entre todos los pedacitos de carne, y es muy complejo asegurar que en tooodas las superficies se haya eliminado la bacteria. Es por esto que **NO se sugiere ofrecer carne picada hasta mínimo los 5 años de edad.**

Si necesitamos hacer una preparación con esta presentación de carne (por ejemplo, empanadas, hamburguesas, albóndigas o pastel de papas), lo ideal es cocinar la carne completamente y luego procesarla.

En la cocina de casa, también es fundamental tener mínimo dos tablas distintas: una para la carne y otra para las verduras. **Evitar el contacto de la carne con otros alimentos, y lavarse las manos con agua y jabón después de manipularla.** El síndrome urémico hemolítico es una de las principales causas de diálisis y de trasplante renal en Argentina. Cuando era residente de pediatría, muchas veces tuve que participar en el proceso de diálisis de bebés, niños y niñas con SUH, y si bien es una estrategia que salva vidas, me pongo en el lugar de esos niños y no es algo feliz para atravesar. Sobre todo cuando se puede prevenir.

“Mi familia es vegana, pero me dijeron que sí o sí le tengo que dar carne al bebé para su crecimiento”.

El consumo de alimentos de origen animal es una elección y no una obligación. Numerosas sociedades científicas plantean que las dietas basadas en plantas sin productos de origen animal, bien planificadas, son aptas para todos los momentos vitales de la persona, inclusive el embarazo, la lactancia y la infancia.

Carne de pollo

Idealmente se prefiere ofrecer pollos de campo, que tienen mayor cantidad de músculo y menos grasa. La carne de pollo se desarma fácilmente, y si bien al principio es más sencillo ofrecer trozos que se desarmen, en poco tiempo podremos ofrecerle al bebé la pata de pollo para que la mastique.



Carne de pescado

El pescado es una carne blanda y muy sencilla de presentar. Es importante que el pescado esté fresco, aunque también se puede comprar congelado (y mantener la cadena de frío hasta llegar a casa). Comprar en pescaderías y preguntarle al pescadero cuál es el pescado más fresco es una buena opción. Para evitar las espinas del pescado, que a veces dan miedo, pasar la mano limpia por encima de la carne antes de cocinarla. Otra opción es desmenuzarlo y cocinarlo desmenuzado. Hay pescados con poco contenido de espinas, como el pollo de mar, el gallo de mar y el gatuzo, los cuales tienen cartílagos y no espinas.



¿ES UN PROBLEMA EL MERCURIO?

El mercurio es un elemento presente de forma natural en la corteza terrestre. La principal causa de las emisiones de mercurio es la actividad humana, sobre todo de la combustión de carbón en centrales eléctricas, calefacciones y cocinas; de procesos industriales, de incineración de residuos y de la extracción minera. Una vez liberado el mercurio al medio (generalmente como desecho industrial en ríos y océanos), ciertas bacterias pueden transformarlo en metilmercurio, otro compuesto que se adhiere fácilmente a las algas y el plancton. Los peces pequeños se alimentan de plancton y acumulan el metilmercurio, y luego son devorados por peces más grandes. Un pez grande en su vida come muchos peces pequeños, por lo que acumula mayor cantidad de metilmercurio en su cuerpo.

En ciertas regiones del mundo con alto consumo de pescado en la dieta y con una importante contaminación de los mares y océanos, se

sugiere evitar peces grandes en la alimentación de embarazadas y niños pequeños. Las especies de peces varían según el lugar del mundo donde nos encontremos. En Argentina existen estudios que indicarían que las concentraciones de mercurio (y otros compuestos nocivos en cantidades elevadas como plomo, cadmio, cobre y arsénico) en la carne de los peces está subiendo, y que hace falta más investigación sobre el tema.

Sin embargo, debido al escaso consumo de carne de pescado en la población general, no comprendería riesgo para la salud. En contexto riesgo-beneficio, la carne de pescado contiene hierro, vitamina D y omega 3 en los pescados grasos, y proteínas, además es sencilla para ofrecer, sobre todo cuando tenemos miedo por el riesgo de asfixia. Elegir un pescado fresco por encima de una carne roja es una buena opción cuando la familia consume animales.

En la pescadería solemos ver los llamados “lomitos de atún”, y nos preocupa porque hemos escuchado que el atún tiene mucho mercurio. Sin embargo, el atún que puede contener cantidades peligrosas de metilmercurio es el atún rojo (*Thunnus thynnus*) un pez importado del Mediterráneo y muy caro, que llega a pesar más de 150 kilos. Existen otros tipos de atún: de aleta azul, de aleta amarilla, de aleta negra y varios más. El que se enlata y/o se consume en nuestro país es importado, ya que estas especies no se capturan regularmente en la zona económica exclusiva argentina, donde opera la flota nacional.

La denominación común y comercial de las diferentes especies de atunes es algo que puede prestarse a confusión. El “lomito de atún” que se vende en la pescadería no suele ser atún, sino gatucho o pollo de mar. “Lomito de atún” es como decir “churrasco”: puede ser de diferente animal. Hay que preguntar cuando lo compramos. ¿Los bebés y niños pueden comer atún de lata? Preferentemente esperar a los 2 años para incorporar enlatados: suelen venir en conserva con sal agregada, y es preferible ofrecer el alimento fresco.

¿Qué pescados pueden comer los chicos? Peces de mar y de río: merluza, mero, abadejo, pacú, brótola, caballa (no la de lata, la de pescadería), surubí, salmón de río, etc. Se puede ofrecer desde el inicio de la alimentación complementaria.

¿Los bebés y niños pueden comer *sushi*? No se recomienda el consumo de pescado crudo en bebés, niños y embarazadas, porque el mismo puede contener larvas de *Anisakis simplex*, un parásito que puede generar vómitos, diarrea y reacciones alérgicas.

¿Es el salmón el mejor pescado? El salmón rosado que se ha puesto de moda en los últimos años, además de ser muy caro, generalmente proviene de las piscifactorías chilenas, una especie de corral de peces donde los alimentan con balanceado y se hacinan en grandes piletas. Este método de producción genera peces estresados, nadando en su propia caca, con mucha grasa y poco músculo. **No se sugiere un alto consumo de este pez.**

El salmón blanco que se pesca en la Costa Atlántica argentina en realidad no es un salmón, pero recibe ese nombre porque es similar. Puede ser consumido sin problemas.

¿Qué es el *kanikama*? El *kanikama* es la salchicha de mar: carne de pescado blanco picada, combinada con aditivos tales como clara de huevo, almidón, sal, sorbitol, azúcar, aceite vegetal, proteínas de soja y otros condimentos. Un ultraprocesado, en fin, y como todo ultraprocesado, no se recomienda su consumo.

¿Cuándo puede consumir mariscos? Los mariscos podrían ser introducidos desde el inicio de la alimentación complementaria si lo deseamos. Como es un alimento potencialmente alergénico, debe ser ofrecido solo y observar la respuesta del bebé por varios días.

Cómo ofrecer huevo

Hasta hace unos años se aconsejaba retrasar la introducción del huevo en la alimentación complementaria hasta el año de vida, dado que es un alimento con potencial alergénico.



Hoy por hoy, las investigaciones dicen lo contrario: **se puede ofrecer huevo desde el inicio de la alimentación complementaria, tanto la clara como la yema**, y eso generaría menor posibilidad de alergia. Siempre bien cocido, podemos ofrecerlo en trozos (ver foto), deshacerlo como puré o incorporarlo a preparaciones (tortillas, *omelettes*, *muffins*, hamburguesas de legumbres o cereales...).

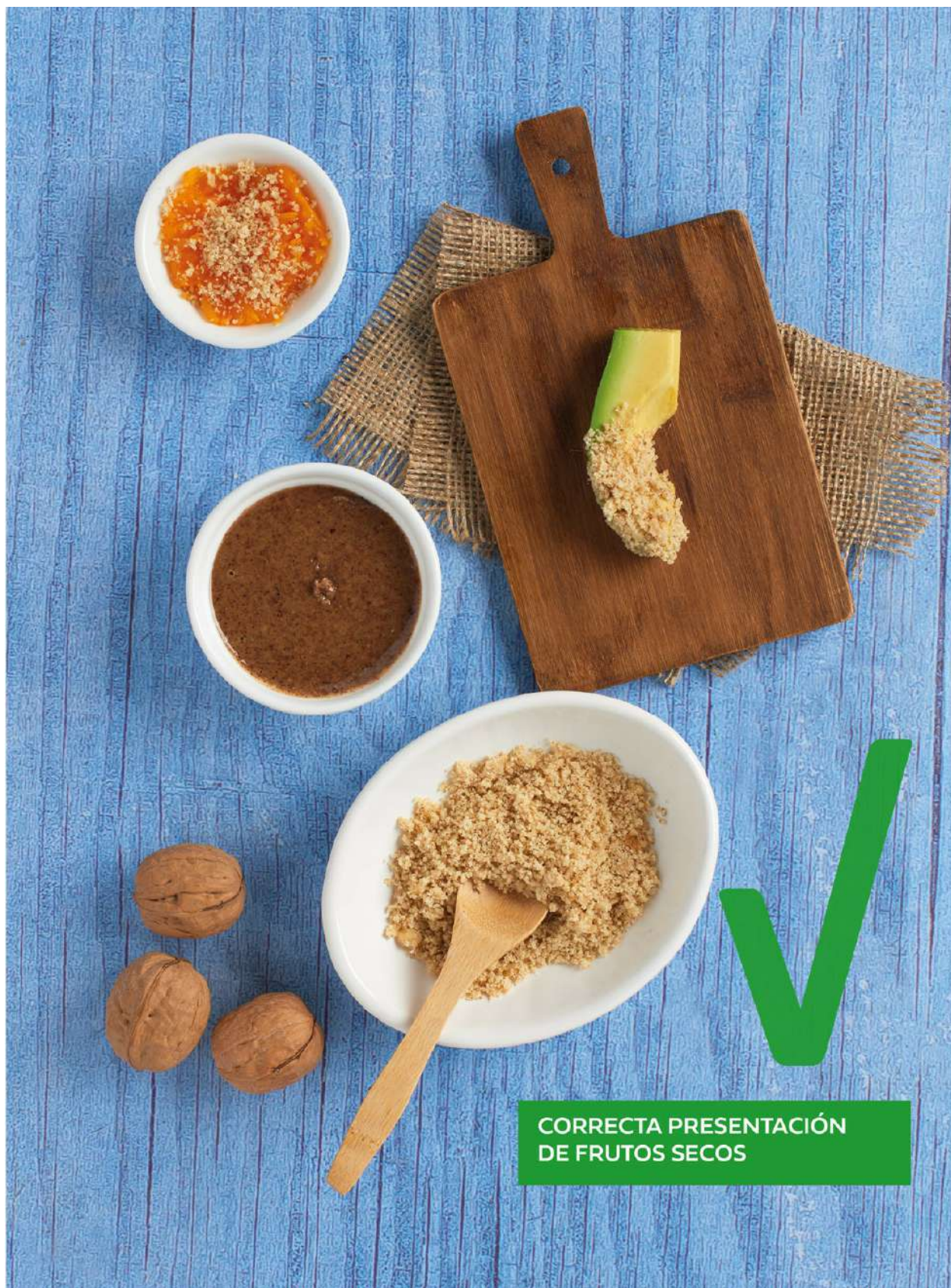
¿Cuántos huevos por semana? Va a depender del resto de la alimentación que se ofrezca. Uno por día es válido, pero reitero, depende del contexto. Se ha corroborado que los huevos de gallinas criadas en campo, y no hacinadas en corrales, tienen mayor cantidad de nutrientes. Es decir, si está la posibilidad de elegir huevos orgánicos o de lugares donde sepamos que las gallinas caminan y no están amontonadas en una jaula, mejor.

Para evaluar posibles alergias, podemos ofrecerlo tres días (no necesariamente consecutivos), preferentemente de día. Existen muchas manifestaciones diferentes de alergia alimentaria, pero por nombrar algunas, puede haber enrojecimiento de la zona en contacto, urticaria, vómitos, rechazo de ese alimento... Solo nos preocupamos cuando hay dificultad respiratoria, y amerita consultar.

Cómo ofrecer frutos secos



**INCORRECTA PRESENTACIÓN
DE FRUTOS SECOS**



CORRECTA PRESENTACIÓN
DE FRUTOS SECOS

Los frutos secos son muy buenos alimentos para iniciar la alimentación complementaria. Están llenos de calorías, grasas buenas e incluso hierro. Entre ellos se encuentran las nueces, las almendras, las avellanas, el girasol, las castañas de cajú, las castañas de Pará y las nueces pecán, entre otros. El maní, en realidad, es una legumbre, pero la incluimos en este grupo por su similitud nutricional.

¿Hay peligro de asfixia? [1] **Sí, con los frutos secos hay mucho riesgo de asfixia, por eso es fundamental adaptarlos. Son los principales cuerpos extraños que se extraen de la vía respiratoria baja cuando hay un caso de asfixia.** Inclusive siendo retirados por endoscopia no se termina el problema, dado que su consistencia oleosa irrita la mucosa respiratoria y puede llegar a causar neumonía (neumonía lipoidea).

Un niño o una niña no debería comer maní entero hasta que pueda escribir la palabra “maní” o, al menos, hasta los 4 años. Por eso debemos ofrecer preparaciones con frutos secos adaptados desde el inicio de la alimentación complementaria. [2]

¿Y la alergia? Desde hace años, las sociedades científicas habilitan el consumo de alimentos considerados “alergénicos” desde el inicio de la alimentación complementaria, postulando que, al revés de lo que se creía, esto generaría MENOS alergias alimentarias. Es conveniente ofrecerlos solos o con algún alimento ya conocido al menos en tres oportunidades para evaluar la respuesta (como vimos con el huevo, no hace falta que sean tres comidas seguidas ni tres días consecutivos). [3]

Formas seguras de ofrecer frutos secos

- **Untable de frutos secos:** remojar toda la noche y procesar con minipimer o licuadora con aceite de oliva y especias frescas. Si deseamos hacerlo dulce, combinarlo con dátiles rehidratados y cacao, más una pizca de agua. Podemos usar almendras, castañas de cajú o semillas de girasol. [4]
- **Pasta de maní u otro fruto seco comercial,** observando en la

etiqueta que solo nombre al fruto seco sin agregados (por ejemplo, que diga “maní”, sin otro ingrediente).

- **Ralladito vegetal:** procesar frutos secos con mortero o molinillo de café y agregarlos a purés o preparaciones.
- **Harina de frutos secos:** procesar frutos secos y utilizarlos en forma de harina.

Los frutos secos, reitero, son la principal causa de obstrucción por cuerpo extraño en la vía aérea en la infancia. Es nuestra responsabilidad ofrecerlos correctamente. No permitiríamos que nuestros hijos cruzaran corriendo una avenida aunque nos lo pidieran. Esto es lo mismo.

¿Cuándo pueden comer frutos secos enteros?

Se considera que para poder comer frutos secos enteros, los niños y las niñas tienen que tener una clara destreza motora y masticatoria, y esto se da alrededor de los 4-5 años.

Cómo ofrecer semillas (sésamo, lino, chía...)

Las semillas de sésamo, chía y lino tienen popularidad en los últimos años como “saludables”. Y sí, lo son: el problema es que para **obtener sus beneficios, necesitamos moler la semilla**. No sirve tirar unas semillas de chía sobre una tostada: saldrán en nuestra materia fecal exactamente como entraron.

Por lo tanto, hay que molerlas con un molinillo de café o un mortero. ¿Qué nos aportan? Sobre todo, omega 3, un ácido graso beneficioso para la salud. Si no las molem, nuestro cuerpo no podrá acceder a ese compuesto.

Cuando molem las semillas, los ácidos grasos se empiezan a oxidar y a perder su efecto. Se suelen vender en el mercado harinas de chía y de lino, pero no sería útil comprarlas dado que no sabemos hace cuánto están en la góndola y en qué condiciones están sus nutrientes.

Podemos usar las semillas molidas espolvoreadas en las comidas, tanto dulces como saladas. Las de lino y de chía también sirven para hacer linaza o “chilinaza”. Se mezcla una cucharada de semillas con tres de agua y se deja reposar para que las semillas desprendan una sustancia pegajosa llamada “mucílago”. Esta preparación se puede usar en reemplazo del huevo para ligar preparaciones.

El aceite de chía o lino viene de la prensión de estas semillas y también es rico en omega 3. El tema es que es bastante caro, y se pone rancio rápidamente por su oxidación: hay que guardarlo en la heladera.

Con las semillas de sésamo, la cuestión es bastante parecida: hay que tostarlas y molerlas, o simplemente molerlas, para absorber sus nutrientes (proteínas, calcio, vitaminas). De otra manera, solo harán bulto en la caca, cosa que no está mal, pero las volveremos a ver tal cual entraron sin llevarnos nada de ellas.

Con el sésamo se hace el *tahini*, una pasta deliciosa que sirve de acompañamiento, como untado y también como parte de otras preparaciones como el hummus. El aceite de sésamo tiene un sabor tostado muy sabroso para agregar a las comidas.

Y aquí la pregunta del millón: ¿todo esto se puede dar desde el inicio de la alimentación complementaria? La respuesta es SÍ. Desde el inicio y para toda la vida. Por supuesto que es importante evitar ofrecer semillas enteras sueltas por el riesgo de asfixia, pero molidas o hidratadas dentro del mucílago, no hay problema.

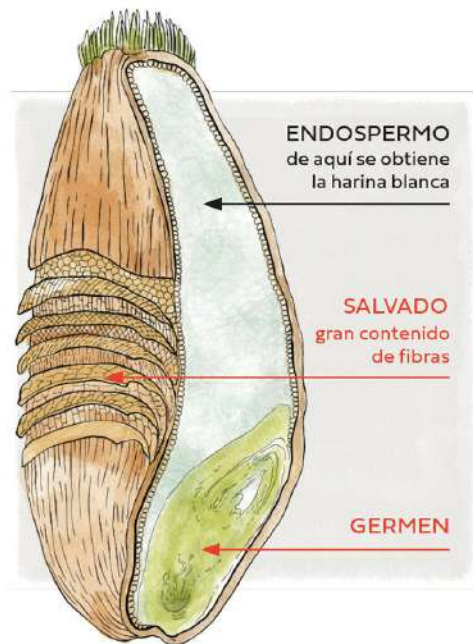
¡Existen muchas, pero muchas clases de harinas!

La harina es el polvo fino que se obtiene de los cereales, legumbres o frutos secos molidos y de otros alimentos ricos en almidón. El término “harina” proveniente del latín *farina*, que a su vez proviene de *far* y de *farris*, nombre antiguo del trigo. Por eso, cuando decimos “harina” así nomás, pensamos en la harina blanca de trigo y no aclaramos esto último. La realidad es que existen cientos de harinas:

- **Harinas de legumbres:** arvejas, lentejas, garbanzos, algarroba, lupino, etc.
- **Harinas de semillas:** chía, lino, sésamo, etc.
- **Harinas de frutos secos:** nuez, maní, girasol, etc.
- **Harinas de cereales y pseudocereales:** trigo, arroz, centeno, maíz, teff, quinua, sorgo, mijo, trigo sarraceno, avena, etc.
- **Harinas de algunas frutas,** como el coco.
- **Féculas, que es el resultante de la extracción del almidón de semillas, tubérculos y raíces.** Hay fécula de papa, de mandioca, de maíz, de trigo, de arroz. ¿En qué se diferencia con la harina? En que sus moléculas son exclusivamente de almidón, y nada más.

No solo existe un mundo gigante fuera de la harina blanca de trigo, sino que hay muchas variables dentro de las que mencioné. La más común es la versión integral de las harinas de cereales y pseudocereales, que conservan el salvado en su molienda y aportan fibra a las preparaciones. Antiguamente se sugería no ofrecen alimentos integrales hasta los 2 años porque interfieren en la absorción del hierro, cosa que es cierta, pero hoy sabemos que también son alimento para la microbiota, que ayuda a absorber el hierro. **Entonces, balance: ni toda harina refinada ni toda harina integral, ni toda harina de trigo ni toda harina de arvejas. Ir variando alimentos nos acompañará a recibir distintos nutrientes.**

Las harinas refinadas pelan la semilla, quitándole el salvado y el germen, y luego procesan el endospermo. Las harinas integrales conservan todos los componentes. El germen contiene el embrión de una próxima planta, con vitaminas, ácidos grasos y minerales.



Todas estas harinas pueden usarse desde el inicio de la alimentación complementaria. En mi cocina, las harinas novedosas aparecieron hace poco, y aún estoy en fase de exploración. Más allá de buscar recetas específicas experimento con recetas sencillas que sugieren poner solo harina de trigo, y, por ejemplo, si dice 1 taza de harina de trigo, pongo $\frac{3}{4}$, y al resto le agrego harina de lupino o de sorgo blanco, para ver qué pasa. A veces sale fabuloso, a veces sale horrendo. Es cuestión de experimentar.

Con las harinas salen infinitas preparaciones, desde panes hasta polenta, sopas, tortas, postres, rebozados. Es común escuchar en los medios que alguien “dejó las harinas” para “bajar de peso”, e inmediatamente ver una receta con harina de almendras. Las harinas existen, están ahí como una alquimia fabulosa a descubrir y aprender. Distintas harinas aportan distintos nutrientes, y ahí está la magia: la variedad.

¿Las harinas tienen antinutrientes? Sí, porque generalmente se procesan los cereales o las legumbres que las componen sin un proceso previo. En el mundo más ideal de los ideales, habría que remojar el cereal, por ejemplo, secarlo y luego molerlo. Y, claro está, no tiene mucha lógica económica con relación al tiempo. Ya hablamos que los antinutrientes no son veneno. No quedarnos siempre en la harina de trigo irá variando los nutrientes que consumimos, y así cubriremos todas las necesidades de nuestro cuerpo.

Algas y hongos

Las algas

Las algas son fundamentalmente marinas. Son altas en iodo, y algunas pueden contener metales pesados como arsénico o mercurio concentrados.

El iodo es un compuesto que actúa en el organismo, entre otras funciones, en la formación de la hormona tiroidea. La hormona tiroidea actúa en casi todos los tejidos: corazón, músculo, hueso, hígado, cerebro, etc., “encendiendo” el metabolismo. Si no hay suficiente iodo, o la glándula tiroidea funciona mal, se producirá el hipotiroidismo, interfiriendo negativamente en el desarrollo físico, mental e intelectual del bebé.

Las algas no son alimentos muy presentes en nuestros platos. No se consiguen fácilmente y son costosas. Sin embargo, últimamente están muy en boga los suplementos de ciertas algas como la espirulina, y con el *boom* del *sushi*, surgen muchas consultas sobre el tema. ¿Entonces?

- Hasta el año de vida no se sugiere el consumo de algas, excepto el agar-agar en preparaciones esporádicas.
- La leche humana o la leche de fórmula contienen el iodo que necesita el bebé durante su primer año de vida, y posteriormente, la leche humana ofrece todo el iodo necesario en los primeros años, si la lactancia se prolonga.

Tipo de alga	Iodo presente en mg cada 100 g
<i>Wakame</i>	3,9
<i>Dulse</i>	10,2
<i>Espagueti de mar</i>	10,7
<i>Kombu</i>	70
<i>Nori</i>	1,3

- Si no se han consumido nunca algas, el embarazo y la lactancia no son el momento para empezar a consumirlas.

- Las personas con hipotiroidismo o hipertiroidismo deben consultar a su nutricionista antes de consumir algas, así como las personas que se encuentran en tratamiento con fármacos antiagregantes y anticoagulantes.
- Al introducir las algas en la alimentación, es importante hacerlo en pequeñas cantidades.
- El alga *kombu* se utiliza para mejorar la digestibilidad de las legumbres (que nos caigan mejor, en otras palabras). Se suelen remojar y hervir las legumbres con dicha alga; para evitar la absorción del iodo que puede ser peligroso, descartar el alga y el agua después de la cocción. Si vamos a usar esa agua para sopas o preparaciones (por ejemplo, el aquafaba de los garbanzos hervidos), mejor no usar el alga *kombu* en esa cocción.
- Las algas *hiziki* contienen una gran cantidad de arsénico. No se recomienda su consumo.
- No se deben dar suplementos de espirulina o *chlorella* a bebés, niñas ni niños. Pueden contener toxinas llamadas “cianotoxinas”, que afectan el sistema nervioso y el hígado si son consumidas regularmente.
- El alga *nori*, que se utiliza para realizar los arrolladitos o *makis* en el *sushi* (no me aniquilen por decir “arrolladitos”, me parece tierno), tiene bajas cantidades de iodo. No se sugiere el pescado crudo para las infancias (ver en el apartado “Cómo ofrecer carne, pollo, pescado...” de este mismo capítulo), pero no sería el problema el alga. Existe una presentación de alga *nori* en copos que se puede utilizar a partir del año, pero espolvoreada apenas sobre otra preparación una o dos veces por semana.
- Las algas *wakame*, *dulse* y espagueti de mar tienen cantidades intermedias de iodo, y en niños mayores de 5 años, no deberían ofrecerse más de 2 o 3 veces por semana, siempre remojándolas y

tirando el agua del remojo.

Los hongos

Usamos los hongos en miles de preparaciones. Es un grupo de organismos que acompañan al ser humano desde el inicio de la civilización. El pan, el vino, la cerveza y los antibióticos son algunos ejemplos de cómo los hongos están integrados en nuestra vida.

Los hongos comestibles se pueden ofrecer desde el inicio de la alimentación complementaria. Son blandos y tienen una textura fácil de manipular. Los champiñones, las gírgolas y los portobellos son hongos que podemos ofrecer fácilmente. Inclusive se venden kits para cultivarlos en casa.



Los hongos se lavan justo antes de cocinarlos, pues absorben mucha agua. Con una materia grasa o un caldo, se pueden saltear; o rebozarlos cual milanesas. Hay muchas opciones y son muy sabrosos. No les tengamos miedo.

Fermentados (kéfir, chucrut, yogur)

El kéfir

Es una bebida producto de la fermentación del azúcar por parte de los tíficos, unas estructuras en forma de nódulos que en realidad son cultivos de bacterias y levaduras benéficas. Existe el kéfir de agua y el kéfir de leche (en el cual los nódulos son llamados “búlgaros”).

Hace miles de años que el kéfir se utiliza de diversas maneras y en distintas regiones del mundo. Al ser una bebida a base de cultivos de microorganismos, tiene un importante potencial probiótico y posbiótico, es decir, mejoraría la microbiota intestinal. ¿Por qué “potencial”? Porque todos los kéfir son diferentes: depende de lo que les damos de comer, de la temperatura y de lo que tiene el agua... En términos estrictamente científicos, no podemos saber si ese kéfir siempre va a tener microorganismos probióticos.

Entonces, ¿por qué consumimos kéfir?, ¿siempre hace bien? La respuesta es: depende. **Si vamos a consumir kéfir como un medicamento, pensando que es algo mágico que va a salvar nuestra salud, por ahí no lo es. Tomar kéfir sin repensar la alimentación global no tendrá ningún efecto.** Ahora, en el contexto de una alimentación variada basada en alimentos reales, incluir kéfir, ¡si nos gusta!, puede ser una opción.

¿Y los chicos? Como hablamos en el capítulo 4 sobre microbiota, no habría mejor fuente de probióticos que la leche humana. Y, posteriormente, basar la alimentación en alimentos prebióticos, que alimenten a la microbiota saludable, es fundamental. No sería una recomendación que tomen kéfir, dado que puede contener cierta graduación alcohólica producto de la fermentación de las levaduras que contiene. Pero creo que la pregunta fundamental es PARA QUÉ. Si queremos darle kéfir a un niño, una niña o un bebé para “mejorar su microbiota”, como si fuera un remedio, quizás no. Si se lo queremos ofrecer porque lo tomamos en familia, ¡adelante!, se puede ofrecer un poquito, diluido con agua, después del año, para “probar” y hacerlo sentir graaande.

Se puede consumir durante la lactancia por las madres lactantes (se puede chequear en www.e-lactancia.org), y con relación al embarazo, hay que consultar a los profesionales acompañantes. **Recordar que no “mejora la microbiota” per se.**

El chucrut

Es una comida tradicional a base de repollo fermentado. La fermentación de los alimentos acompaña a la humanidad desde hace siglos, porque antiguamente era una de las pocas maneras que había de conservar un alimento por mucho tiempo. Imaginate que pasás dos meses cultivando un repollo que será el único alimento que tendrás en todo el invierno. Querés que dure mucho, pero no tenés heladera ni *freezer*. Fermentándolo, o haciéndolo en conserva, durará meses. El chucrut, o *sauerkraut*, tiene dos ingredientes: repollo y sal. El contenido de sal es alto y es parte de la conservación. **Por este alto contenido de sodio, se sugiere ofrecerlo en pequeñas cantidades a partir del año.**

El yogur

El yogur es leche fermentada. Un yogur de verdad tiene tres ingredientes: leche (animal o vegetal), bacterias (más específicamente *Streptococcus thermophilus* y *Lactobacillus delbrueckii*, subespecies *bulgaricus*) y tiempo. **Los yogures hechos con leche de animales (vaca, cabra, búfala) no se sugieren incorporar hasta el año de vida**, por el mismo motivo que no se sugieren los lácteos: sus proteínas pueden lastimar el intestino del lactante e interferir en la absorción de hierro, propiciando la anemia. En las recomendaciones españolas, sugieren la posibilidad de incorporar yogur desde los 9-10 meses, en pequeñas cantidades. Estas “pequeñas cantidades” no son un potecito, sino una cucharada por día.

Los yogures realizados con leches vegetales podrían ser consumidos desde el inicio de la alimentación complementaria, pero generalmente son comerciales y contienen otros ingredientes que no se recomiendan, como azúcares y colorantes.

Después del año se puede consumir yogur. ¿Qué yogur? Yogur sin azúcar, y sin otro ingrediente que no sea leche y fermentos (las bacterias). Es casi una odisea encontrar estos yogures en el mercado, y generalmente se los rotula como “yogur para cocinar”. El yogur de verdad tiene una consistencia más líquida que el que conocemos comercial (porque

para que se vuelva “firme”, le agregan espesantes) y su sabor es más ácido. **Ninguno de los yogures bebibles que se venden es apto niños o niñas, puesto que todos tienen colorantes y aditivos sensoriales.**

¿Podemos hacer yogur casero con un yogur comercial? Sí, se puede hacer yogur casero y será más sano que comprar comerciales, dado que los aditivos quedarán más diluidos. Siempre es importante observar la higiene, las buenas prácticas y evitar la contaminación cruzada en la cocina. También se puede hacer yogur con *primers*, que son polvitos de bacterias que se venden en algunas dietéticas.

¿Se puede hacer yogur de leche humana? Esto me lo han preguntado muchas veces. Como poder, se puede. Pero la leche humana por sí misma tiene una altísima cantidad de probióticos, sobre todo cuando está recién salida de la teta. Si es por “agregarle” probióticos, probablemente ocurra lo contrario: se pierdan microorganismos beneficiosos. En resumen: tiene mucha mayor calidad “biótica” la leche recién salida de la teta.

Recordemos que los bebés no necesitan yogures ni postres para empezar a comer, porque hay un mundo hermoso de alimentos para descubrir antes de llegar a ellos.

Grasas saludables

Durante el desarrollo infantil, **sobre todo durante los primeros dos años, el consumo de grasas es fundamental para el crecimiento del cerebro.** En los primeros seis meses, las grasas aportan el 50 % de la energía consumida. La leche humana tiene toda la grasa que necesitan los bebés hasta esa edad, y va variando de acuerdo con sus necesidades. De hecho, después del año, la leche humana... ¡tiene aún más grasa!

Algunas fuentes de grasa saludable:

- **Frutos secos:** antes de los 4-5 años es peligroso darlos enteros, como ya vimos en este capítulo. Se sugiere molerlos, usarlos en forma de harinas o de cremas (por ejemplo, pasta de maní sin azúcar). [1]
- **Pescados:** si consumimos derivados animales, son una opción. Hay

pescados con casi nada de espinas, como el gatucho o el pollo de mar. Los pescados con ácidos grasos saludables del tipo omega 3 son el abadejo, el atún (preferiblemente no de lata, sino fresco) y la merluza.



- **Semillas de chía y lino:** aportan omega 3, un ácido graso esencial. PERO, para poder absorberlo, es preciso triturar las semillas, como vimos antes. También tenemos los aceites vegetales de chía y de lino, que hay que consumirlos rápido porque, como aceites de buena calidad, se ponen rancios rápidamente (¡van en la heladera!).
- **Palta:** es una fruta muy piola, muy fácil de presentar si hacemos BLW y simple de pisar si arrancamos con papillas. Su sabor es agradable y es rica en grasas. No es “muy pesada” y se puede ofrecer seguido.
- **Aceite de oliva:** que además, es producto nacional. El aceite de coco y los aceites de primera prensada como el de girasol, también son buenas opciones. Hay mucho barullo sobre el aceite de coco: que es malo por ser una grasa saturada, que es bueno porque tiene ácido butírico, etc., etc. Si vamos a elegir, me quedo con el de oliva, pero el aceite de coco queda bien en preparaciones dulces y es una opción (sin ser la panacea para todos los males de la humanidad ni un alimento mágico) en pequeñas proporciones.
- **Ghee y manteca:** el *ghee* es manteca a la cual se le extrajo la parte proteica y quedó solo la grasa. Este proceso no es exacto, por lo que no es apto para personas alérgicas a la proteína de leche de vaca. Al no contener tanta proteína de leche de vaca, el *ghee* sería una opción desde el inicio de la alimentación complementaria. La manteca es crema de leche batida, que se solidifica y se le extrae el suero. Es la parte grasa de la leche, con bajo nivel proteico. Si no hay ninguna otra opción de las previas, por no contener tanta proteína, se podría ofrecer para enriquecer preparaciones desde el inicio de la alimentación complementaria. Importante que en la lista de ingredientes de la manteca diga solo “crema de leche” y nada más. La

margarina es una grasa trans, y no es sugerible para nadie.

Endulzantes, edulcorantes no calóricos, cacao, especias...

El azúcar

Si no se sugiere el azúcar... ¿con qué endulzar? Primera cuestión: **¿necesitamos endulzar? El paladar de los bebés está abierto a todos los sabores nuevos, y no hace falta ponerle dulce a las preparaciones.** Ahora, puede ser que haya varios hermanos y que queremos hacer una torta para todos. O simplemente nos guste mucho el dulce y nos cueste algo no endulzado. En este mundo de la transición alimentaria, es importante que nos sea rico lo que estamos comiendo. Lo saludable puede ser rico, sabroso y atractivo para nuestro paladar, pero hay que darnos tiempo. Entonces, sin más vueltas, opciones para endulzar:

- **Frutas deshidratadas:** pasta de dátiles, pasta de pasas de uva, pasta de ciruelas deshidratadas. Se incorporan a las preparaciones y endulzan muy bien, aunque a veces cambian las texturas a las que estamos acostumbrados. Quedan genial en panqueques, budines y como corazón de una galletita pepa.
- **Frutas frescas pisadas o ralladas:** la banana, la pera y la manzana, pisadas o ralladas, endulzan muy bien por sí mismas. Mientras más maduras, más dulces.
- **Coco rallado.**
- Después de los 2 años, se puede endulzar con **miel, que endulza más que el azúcar con menos cantidad.** Recordar de todos modos que se

trata de un azúcar libre (ver apartado “Miel (hasta los 2 años)” en este mismo capítulo).

Edulcorantes no calóricos

Los edulcorantes fueron furor en los 90, en la época donde lo importante era estar flaco sin importar las condiciones de salud de la persona. La obsesión por contar calorías nos llevó a consumir estos brebajes y polvos del mal: los edulcorantes.

Casi nadie consume un edulcorante por placer. La mayor parte de las personas lo hace para no engordar o porque se lo sugirió un profesional de la salud.

Sin embargo, la evidencia hoy en día sugiere que **los edulcorantes no son inocuos y que tendrían un impacto negativo en la salud**. Entre los diferentes mecanismos a través de los cuales estos podrían desencadenar las distintas alteraciones, se ha propuesto que podrían interferir con las respuestas fisiológicas aprendidas que contribuyen a controlar la glucosa y el balance de energía, alterar la microbiota intestinal e inducir intolerancia a la glucosa, e interactuar con receptores del gusto en el sistema digestivo que desempeñan un papel en la absorción de glucosa y la secreción de insulina. Una joyita.

¿Qué pasa con los edulcorantes en la infancia? Que no hay suficiente evidencia para tener una respuesta concreta. Sin embargo, podemos empezar por pensar para qué necesitaríamos un edulcorante en bebés y niños, ¿no? Estudios han demostrado excreción de pequeñas cantidades de edulcorantes en la leche humana de madres que los consumían. Aún no queda claro el impacto en la formación de los sabores en el bebé ni en su microbiota.

Los estudios que existen se remiten a un concepto llamado IDA (ingesta diaria admisible), un nivel de ingesta diaria considerado “seguro” para todos. Según ese concepto, si no se supera, no serían peligrosos. Sin embargo, un estudio realizado en la ciudad de Buenos Aires a 2664 niños y adolescentes de 2 a 18 años en el año 2011, mostró que más de la mitad consume uno o más edulcorantes por día, generalmente en bebidas como jugos en polvo, jugos concentrados, jugos envasados, aguas saborizadas y gaseosas. En algunos edulcorantes como el ciclamato y la sacarina, el famoso IDA fue

superado. Es importante destacar que el consumo de jugos y gaseosas se duplicó en la Argentina desde el año 2000.

Entonces, ¿cuáles son las conclusiones en pediatría sobre el uso de edulcorantes?

- No se recomienda el uso de edulcorantes no calóricos en menores de 3 años (ninguno, tampoco estevia, dado que se están formando los sabores y no se sugiere ofrecer algo extremadamente dulce).
- Dada la poca evidencia de calidad sobre el uso de edulcorantes, no se recomienda, por encima de los 3 años, un uso sostenido ni prolongado.
- Los edulcorantes no calóricos podrían ser utilizados si se necesita una restricción calórica, y otras herramientas no son suficientes para lograrla.

En resumen: los edulcorantes son aditivos sensoriales que, a la luz de las investigaciones actuales, parecen tener un impacto negativo en la salud. Por lo tanto, no se recomienda su uso.

El cacao

El cacao amargo (no el polvo para chocolatada) se puede usar en preparaciones sin problemas desde el inicio de la alimentación complementaria, en pequeñas cantidades. Por ejemplo, si deseamos hacer panqueques, podemos poner una cucharada de cacao para toda la mezcla. Algunos autores indican aguardar al año para ofrecerlo. **El cacao tiene xantinas, compuestos que estimulan el sistema nervioso central, y también es antioxidante.** Al ser un estimulante, no se sugiere ofrecerlo a la tarde-noche.

El chocolate es una preparación hecha con cacao. Casi todos los chocolates tienen azúcar, así que se sugiere ofrecerlos después de los 2 años. Si deseamos hacerlos, que sea con pocos ingredientes y con alto contenido de cacao.

Las especias

¡Qué rico es usar especias! Las comidas toman características impensadas, ese pollo insulso y seco se vuelve sabroso con una materia grasa y unos polvitos mágicos, los porotos descongelados se vuelven una fiesta de sabores. ¡Aguante usar especias!

Las especias que se usan en la familia se pueden usar desde el inicio de la alimentación complementaria. Es importante saber que **se introducen como un nuevo alimento: es decir, junto con algún alimento presentado anteriormente, por ejemplo, para observar la reacción.**

Especias que a mí me gustan mucho:

- Provenzal (mezcla de ajo y perejil)
- Pimentón ahumado
- Polvo de hongos
- Cebolla deshidratada
- Tomillo
- Pimienta negra

Evitar especias muy picantes, sobre todo al inicio. Evitar también el anís estrellado, pues en bebés puede ser neurotóxico. Si nunca usaron especias, no es momento de experimentar con la comida que le van a dar al bebé. Primero prueben los adultos si es de su agrado y luego se podrá ofrecer en otras comidas. Recuerden que los bebés perciben sabores a través del líquido amniótico y la leche humana: el hijo o la hija de una mamá que siempre comió muchas especias, ¡ya conoce esos sabores!

La levadura nutricional

La levadura nutricional es el resultado del cultivo de un hongo llamado *Saccharomyces cerevisiae*. Ese cultivo se seca posteriormente y genera unas escamas que tienen un sabor similar al queso. Es fuente de vitaminas del grupo B, selenio, cromo y fibra.

La levadura de cerveza se obtiene durante el proceso industrial de la elaboración de la cerveza, que se hace con ese mismo hongo. El resultado es similar, solo que es otra forma de producirlo. Para bebés se puede agregar media cucharada al día en las comidas, y posterior al año, una cucharada.

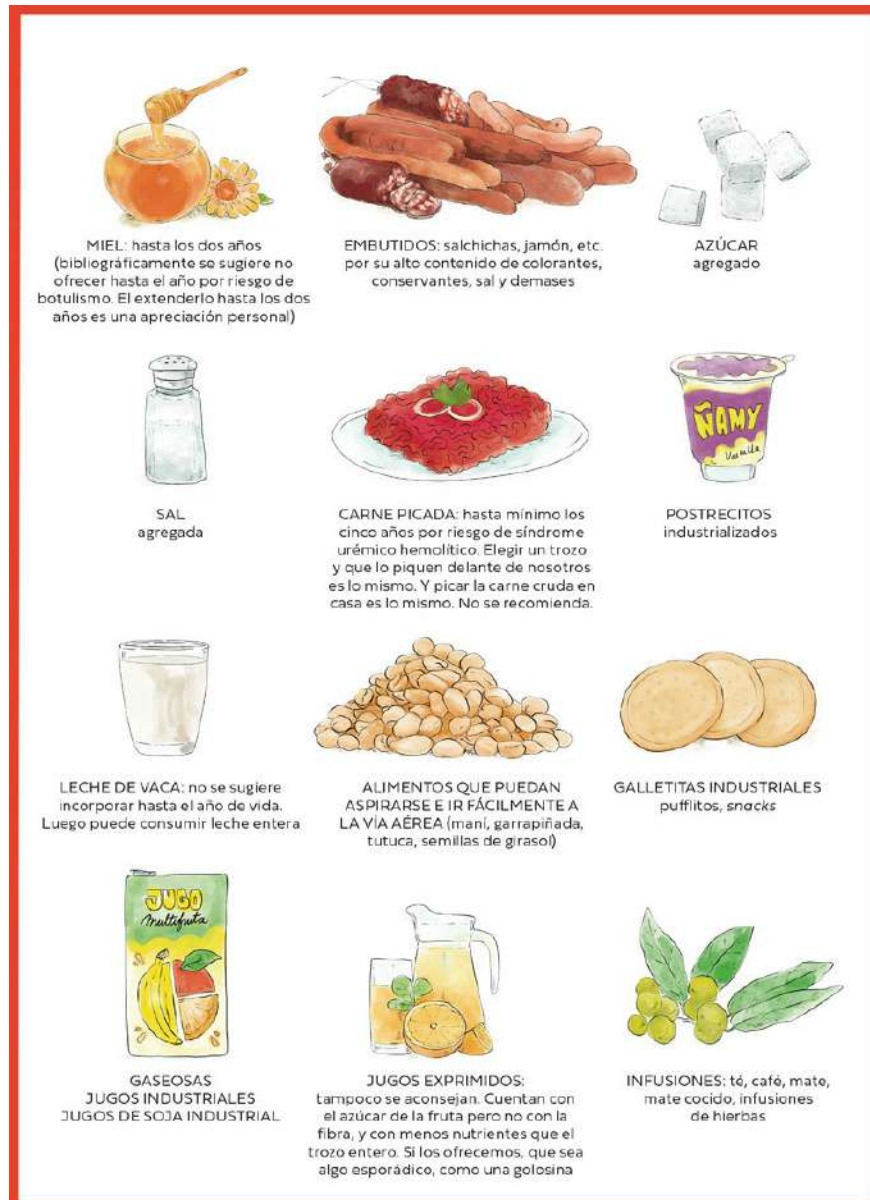
¿Cuándo ofrecer preparaciones?

¿Cuándo podemos hacerle una torta? ¿O un *muffin*? ¡Me quedo sin ideas de recetas!

Estas frases son muy comunes en todas las familias, y la respuesta es que no hace falta hacer recetas. **El formato “picada” (poner un alimento de cada grupo) en la mesa y que cada uno agarre, y ofrecerle lo mismo al bebé adaptado, es una buena opción.** No es más sana una tortilla de papas que ofrecerle una papa hervida y un huevo hervido. No es más sano hacer *muffins* todas las mañana que ofrecer fruta variada durante el día. No nos enloquezcamos con las recetas: van a llegar, de a poco, sin presiones.

Idealmente, las preparaciones las ofrecemos cuando ya probaron los alimentos por separado. Por ejemplo, antes de hacer *muffins* de pera, probar la pera sola, probar el huevo solo, y una vez que hicimos ese camino, hacer la preparación.

¿Qué alimentos NO se sugieren ofrecer?



La pediatría ha cambiado y...
 el puré con queso blanco,
 las verduras con salsa blanca,
 el yogur de vainilla firme,
 la gelatina y
 las galletitas o vainillas
... ya no se consideran buenas opciones

para la alimentación complementaria.

La pediatría y la nutrición cambiaron. ¡Menos mal! Esto quiere decir que la ciencia avanzó y que las cosas que decíamos hace diez, cinco o dos años, que estaban bien en ese momento, ahora no se pueden seguir aplicando porque encontramos nueva evidencia.

Es común que la “lista” que puse en el cuadro sea sugerida a las familias que arrancan la alimentación complementaria por los profesionales o por el entorno.

Hace varios años, ¡era lo que decían las guías alimentarias! Pero hoy ya no.

¿Por qué cambió tanto? Como ya venimos diciendo, porque aumentaron mucho lo que llamamos “enfermedades crónicas no transmisibles” y hay una clara relación con la alimentación deficiente en nutrientes y rica en aditivos que tenemos las personas desde hace más de treinta años. **Nuestra microbiota es menos sana y diversa, y la alimentación basada en ultraprocesados desde el inicio de la alimentación complementaria tiene un papel clave.**

¿Qué alimentos NO deberíamos ofrecer a bebés y niños?

- **Azúcares libres y agregados**



Cada 5 años, la Organización Mundial de la Salud revisa las recomendaciones con relación al consumo de azúcares libres. Azúcares libres son todos estos que figuran en la imagen. Son aquellos azúcares añadidos a los productos comestibles; más los azúcares naturalmente presentes en la miel, los jarabes, los jugos de frutas (no en las frutas enteras dado que los azúcares propios de las mismas se encuentran en una matriz y el cuerpo los metaboliza de otra manera. ¡Más fruta y menos juguitos!) y los concentrados de jugos de frutas, por ejemplo.

Estos azúcares se metabolizan en forma desfavorable para el organismo, generando daño en la microbiota, inflamación y mayor vulnerabilidad a enfermedades. El consumo frecuente y temprano de azúcares (y ahora se está estudiando que sucede algo similar con los edulcorantes) está relacionado con la alteración de la dopamina, un neurotransmisor que compone el sistema de recompensa. Cuando el cuerpo está en constante exposición al azúcar, cada vez necesita más para satisfacer el sistema de recompensa.

Los niños y bebés tienen la capacidad de autorregularse en la alimentación: consumen la cantidad de alimento que requieren, y no más ni menos. Esto cambia cuando no hay alimento disponible, por supuesto, pero también cuando están frente a un producto de diseño repleto de sustancias que activan su sistema de recompensa. **A veces, los niños consumen tanta**

azúcar en el desayuno, que su cuerpo percibe que no necesita más alimento durante el resto del día, y se vuelven “malos comedores”, cuando en realidad su cuerpo es muy sabio.

El consumo de azúcares está relacionado con la mala salud odontológica, las dificultades en el sueño e inclusive con el bruxismo.

Comparto el registro alimentario de una pequeña consultante (con permiso de su familia, quienes trabajaron muchísimo y lograron cambiarlo):



En esta familia, los abuelos estaban preocupados porque comía mucha banana, y tal vez era “muy pesada”. Y esos son los mitos que tenemos que desarmar: nos parece normal el yogur dos veces por día, aunque tiene cuatro veces más azúcar que una fruta, pero le tenemos miedo a las bananas.

El Hospital Garrahan hace un tiempo compartió una excelente infografía sobre las sugerencias acerca del consumo de azúcar según la OMS, la cual replico a continuación.

La Organización Mundial de la Salud recomienda disminuir el consumo de estos alimentos a lo largo del día según las diferentes edades

2 a 3 años	Hasta 15 g de azúcares libres/día	3 cucharadas
4 a 10 años	Hasta 20 g de azúcares libres/día	4 cucharadas
11 a 15 años	Hasta 25 g de azúcares libres/día	5 cucharadas
Más de 15 años	Hasta 30 g de azúcares libres/día	6 cucharadas

¿Cuánto azúcar consumen en tu familia?

ALIMENTO	CANTIDAD DE AZÚCAR cucharadas tipo té
Vaso de gaseosa común (200 cc)	5 
Lata de gaseosa común (355 cc)	8 
Botellita de gaseosa (600 ml)	12 
Cajita de jugo comercial (200 ml)	5 
Agua saborizada (600 ml)	8 
Gomitas (5 unidades)	3 
Caramelos (6 unidades)	3 
Chupetín	3 
Chocolatín (100 ml)	2 
Alfajor simple	4 

Los cuadros están tomados de la infografía que subió a su web el Servicio de Nutrición del Hospital Prof. Dr. Juan P. Garrahan.

El azúcar está en los lugares más inverosímiles: en el ketchup, las salchichas, los fideos, las leches “de seguimiento” 3 y 4 promocionadas como “sin azúcar”, en los copos de maíz “sin azúcar”, en yogures para bebés, galletitas, bebidas... y la lista continúa. Aprender a buscar estos nombres en las etiquetas y contar prontamente con una ley que exija rotulado frontal es vital para poder ser soberanos en nuestra alimentación. Poder elegir qué azúcar queremos consumir (si es que queremos consumirla), y también en la cantidad que deseemos y no en la que nos venden engañados.^[1]

• Productos ultraprocesados

Como hablamos en los primeros capítulos, estos productos no son saludables para ninguna persona de ninguna edad.

¿Qué ultraprocesados se suelen vender “para bebés” y niños?

Cereales para preparar con leche

En los primeros capítulos vimos que antiguamente se iniciaba la alimentación muy temprano, cerca de los 3 meses. Esos bebés solo podían comer papillas líquidas, por lo que la industria de los “cereales para biberón”, una mezcla de harinas, azúcar y aditivos, creció fuertemente. Vamos a leer la etiqueta de ingredientes de una de las marcas más comunes en los supermercados:

HARINA DE TRIGO, ALMIDÓN DE MAÍZ, AZÚCAR, CARBONATO DE CALCIO, FOSFATO DE POTASIO, VITAMINAS Y MINERALES (VITAMINA A, D, E, C, B1, NIACINA, PANTOTENATO DE CALCIO, B6, ÁCIDO FÓLICO, BIOTINA, SULFATO DE ZINC), FUMARATO FERROSO, CULTIVOS BIFIDUS, (BIFIDOBACTERIUM), AROMATIZANTE (VAINILLA).

Otra opción muy común es el preparado de harina de trigo y sémola (la sémola es harina molida más gruesa). Algunas opciones en el mercado también incluyen azúcar. E incluso las que no contienen “azúcar agregada”, al estar los cereales hidrolizados (procesados muy pequeños), actúan como azúcar en el organismo.

Cuando preparamos estos polvos, estamos haciendo una mezcla de harina y líquidos. Nada más. Si alguna familia desea ofrecer eso a un bebé, sugiero comprar harinas y hacerlo casero, para ver qué estamos comiendo. Estos productos son muy populares culturalmente. Cuando empecé a investigarlos, hasta me generó tristeza pensar que no le iba a dar la caja con el osito azul a mi hijo. Sí, tristeza. Ir a comprar la caja esa era un símbolo de amor familiar. Y para las familias que lo hacen hoy por hoy, también es un símbolo de amor, porque siempre queremos lo mejor para nuestras hijas y nuestros hijos. Estamos construyendo una nueva cultura, y eso no es fácil.

Potitos o pouchs de papillas

Hace unos años se incorporaron al mercado las papillas en frasquito o en bolsa con piquito (*pouch*). Muchos de ellas contienen azúcar y aditivos. La presentación en *pouch*, como hablamos en el capítulo anterior, no se sugiere porque no genera el contacto con el alimento, algo que es fundamental.

Postres lácteos o polvo de postre para preparar

Los “postrecitos” son muy populares, dado que fueron publicitados por profesionales en la televisión bajo el lema “No pierdas ni un día en el crecimiento de tu hijo”.

En realidad, las que no pierden nada son las empresas que venden estas cosas y la gente que cobra dinero por su publicidad. Las familias vemos esas publicidades y creemos que es lo mejor que podemos comprarles a nuestros hijos y a nuestras hijas. Por eso trabajamos tanto en la divulgación de que esto no es así; al contrario, son perjudiciales para la salud. Los postres lácteos, como su nombre lo indica, contienen leche de vaca, no sugerida hasta el año. Algunos de ellos están hechos con leche de fórmula, pero no dejan de tener varios tipos de azúcares en su composición. No solo eso: muchas veces en letra pequeña, esas empresas inclusive dejan claro que son productos sugeridos “a partir de los 3-4 años”.

Con respecto a los polvitos para preparar flanes y postres, basta con ver su composición.

Flan de caja

*AZÚCAR, SAL, MALTODEXTRINA, GELIFICANTE:
CARRAGENINA (INS 407), AROMATIZANTE ARTIFICIAL:
VAINILLA, EDULCORANTES NO NUTRITIVOS: ASPARTAMO
(INS 951), ACESULFAME-K (INS 950), COLORANTES:
TARTRAZINA (INS 102), AMARILLO OCASO (INS 110).*

¡Dos azúcares (azúcar, maltodextrina), dos edulcorantes, dos colorantes, sal y aromatizantes! A veces decimos: “Mi bebé no consume nada con sal”, pero en realidad, se la estamos ofreciendo a través de las preparaciones industriales sin saberlo.

Gelatinas

La gelatina es un gel compuesto por colágeno, una proteína que se obtiene procesando (por ejemplo, hirviendo) tejidos animales. Desde hace varios años, son populares estas “gelatinas en sobre”, productos ultraprocesados, indicándose muchas veces, debido a su textura, como inicio de la alimentación complementaria o como alimento de recuperación en los hospitales.

Basta con leer las etiquetas: el primer ingrediente suele ser azúcar. Es decir... ¡tiene más azúcar que gelatina! Y, además, suelen tener otros edulcorantes (por si no quedaba suficientemente dulce). **La gelatina es una golosina. No es apto para consumo de bebés. Tiene “sabor a frutas” pero nunca estuvo cerca de una fruta.**

Si tenemos muuuuchas ganas de comer gelatina, podemos mezclar fruta pisada, rallada o cocinada con agar-agar. El agar-agar es un extracto de algas con capacidad para gelificar. Queda muy similar a una gelatina, pero sin aditivos, y se puede ofrecer desde el inicio de la alimentación complementaria.

Mermeladas

La cultura de la “tostada con mermelada” para desayuno o merienda es muy común en nuestro medio. La mermelada, en sí, es (o debería ser) una conserva de fruta cocida en azúcar. Pero las mermeladas que venden en el súper... uf. Les dejo la lista de ingredientes.

*PULPA DE DURAZNO, FRUCTOSA, SORBITOL,
GELIFICANTE: PECTINA, ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO
(INS 330), AGENTE DE FIRMEZA: CLORURO DE CALCIO,
ANTIOXIDANTE: ÁCIDO ASCÓRBICO, EDULCORANTE NO
NUTRITIVO SUCRALOSA (3,9 MG/100 G), CONSERVANTES:
SORBATO DE POTASIO Y BENZOATO DE SODIO,
AROMATIZANTE: AROMA ARTIFICIAL DE DURAZNO,
CONTIENE: DIÓXIDO DE AZUFRE.*

Una mermelada que se jacta de tener sellos como “saludable”, tiene varios

azúcares (aunque promete no tener azúcar) y edulcorante. Siendo un producto ultraprocesado, no se sugiere en la alimentación de ninguna persona, y por supuesto, menos en bebés, niños y niñas.

Se pueden hacer mermeladas caseras con frutas, sin agregar azúcar, y sí se podrían ofrecer desde el inicio de la alimentación complementaria, y también usarse para endulzar preparaciones.

Galletitas

No es raro encontrar estos productos en listas de inicio de alimentación complementaria; con marca específica y todo, proponiendo darles galletitas a bebés de 6 meses o menos. De hecho, yo se las di a mi hijito mayor. En ese momento, nunca se me ocurrieron ciertas cosas que ahora sí tengo más claras:

- Todas tienen azúcar. Mucha. Y de hecho, tienen varios tipos de azúcares y edulcorantes, como el jarabe de maíz de alta fructosa, endulzante industrial de muy mala calidad nutricional, que genera daños en la microbiota intestinal y la “necesidad” de seguir comiendo dulce. [1][2]
- Salvo las vainillas, son duras, fáciles de romper y de que un trozo vaya a la vía aérea. **Es más peligroso dar galletitas que cualquier fruta adaptada a la mano de un niño.** [1][2]
- Existen marcas de galletitas que, gracias al *marketing* que utilizan, generan una falsa idea de que son mejores o más sanas que otras, cuando, si miramos los ingredientes y los comparamos, son todas muy similares. [1][2]

¿Se pueden ofrecer galletitas caseras? Sí, comprendiendo que no son indispensables y que tal vez no sean una opción para todos los días, o sí pero variando los ingredientes e incorporando en ellas verduras (zanahoria, zapallito rallado, remolacha), frutas, legumbres, cereales y frutos secos.

Yogures

Como ya mencionamos en la parte de “alimentos fermentados”, el yogur es el producto que se obtiene de la fermentación de la leche con dos bacterias específicas. En nuestro medio, el yogur muchas veces es el primer alimento de los bebés. Sin embargo, el yogur tal como lo conocemos es un procesado industrial.

Miel (hasta los 2 años)

La miel puede contener esporas de un germen llamado *Clostridium botulinum*. El intestino de los niños pequeños no puede digerir esas esporas, y estas pueden colonizar, germinar, multiplicarse y generar sustancias altamente tóxicas (toxina botulínica), sobre todo en menores de 1 año. El botulismo del lactante produce una parálisis flácida (se paralizan todos los músculos, inclusive los respiratorios y los que sirven para hacer pis). En ocasiones produce la muerte, o secuelas muy complejas de revertir. **La miel no debe ser ofrecida de ninguna manera, tampoco cocinada**, dado que las esporas no se eliminan con el calor.

Luego del año baja el riesgo de botulismo, pero la miel no deja de ser un azúcar libre, por lo que no se sugiere su introducción en la alimentación al menos hasta los 2 años.

Embutidos (salchichas, jamón, etc.)

No se sugieren, por su alto contenido de colorantes, conservantes, sal y demases. En una época se sugería incorporar tempranamente morcilla en la alimentación de los bebés. Hoy por hoy, no sugerimos esta opción por el alto contenido de sal y las cosas misteriosas que puede haber en una morcilla. Las salchichas, además, tienen una forma cilíndrica que al cortarla con los dientes, puede generar trozos redondos e impactarse fácilmente en la vía aérea. De yapa, dejo los ingredientes de un paquete de salchichas industriales “con queso”...

CARNE SEPARADA MECÁNICAMENTE DE POLLO, GRASA DE CERDO, AGUA, QUESO FUNDIDO (QUESO, SÓLIDOS LÁCTEOS, ESTABILIZADORES (E-407, E-410), SALES FUNDENTES (E-331, E-340), SAL, CORRECTOR DE ACIDEZ

(E330), COLORANTE (E-160A), PUEDE CONTENER TRAZAS DE PROTEÍNA DE HUEVO (E1105)), SAL, ANTIOXIDANTES (E-325, E-316), DEXTROSA, ESTABILIZANTES (E-451, E-466), AROMAS Y ESPECIAS, AROMA DE HUMO, CONSERVADOR (E-250). PUEDE CONTENER TRAZAS DE SOJA.

Sal agregada (al menos hasta el año)

Posterior al año se puede agregar una pizca de sal a la comida para el aporte de iodo (en nuestro medio la sal está iodada para prevenir el bocio endémico, un tipo de hipotiroidismo por falta de iodo).

Carne picada (hasta mínimo los 5 años)

Esta recomendación es debido al riesgo de síndrome urémico hemolítico, que ya vimos en este mismo capítulo. Elegir un trozo y que lo piquen delante de nosotros es lo mismo, y picarla cruda en casa es lo mismo. No se recomienda.

Leche de vaca

No se sugiere incorporar hasta el año de vida, luego puede consumir leche entera. La leche de vaca no es un alimento mágico que todo lo puede. Y no se recomienda su introducción en la alimentación infantil antes del año de vida. Pero ¿por qué? Porque las proteínas de la leche de vaca pueden lastimar el intestino de los bebés y causar microhemorragias. En conjunto con esto, el calcio de la leche de vaca compite con el hierro en su absorción, un nutriente que es crítico. Estos dos factores hacen que **el consumo de leche de vaca antes del año de vida sea una causa importante de anemia en bebés.**

Además, la leche de vaca tiene una elevada carga de solutos, mayor que la de la leche humana, ya que tiene de dos a tres veces más proteína y nutrimentos inorgánicos como sodio, potasio, cloro y fósforo, y no es adecuada para la capacidad de filtración renal del lactante.

Antes del año, los bebés deberían tomar solo leche humana. Si esto no es posible y no se cuenta con leche humana pasteurizada, la opción es leche de fórmula, que si bien es leche de vaca, está modificada para no causar estos efectos adversos. La leche humana siempre nutre y debe durar

lo que la familia decida. También es interesante recordar, para quienes sugieren destetar para dar una “leche de verdad”, que la leche humana tiene más calorías y más grasa que la leche de vaca, y su hierro se absorbe mejor.

Composición nutricional de leche humana y leche entera de vaca		
Componente	Leche humana	Leche entera de vaca
Cantidad de kcal	172	149
Proteínas - g	2.5	7.7
Grasas totales - g	10.8	7.9
Grasas saturadas - g	4.9	4.6
Carbohidratos - g	16.9	11.7
Calcio - mg	78.7	276.0
Potasio - mg	125.0	322.0
Fósforo - mg	34.4	205.0

“Milk and health”, 2020. Datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Todos los valores expresados en g cada 237 ml.

La leche de fórmula es costosa y muchas veces las familias no la pueden comprar, por eso se introduce tempranamente la leche de vaca en la alimentación de los bebés. En esos casos, es necesario rebajarla con agua y agregarle algunos suplementos que dependen de la edad del bebé y que deben ser indicados por el profesional a cargo. Es la última opción, de escasa calidad nutricional, y de ahí es que insistimos en la protección, promoción y sostenimiento de la lactancia con profesionales formados en el tema que puedan asistir a las familias, y que esto no sea un privilegio.

Después del año, es decisión de la familia ofrecer lácteos de vaca, pero si es así, no deben superar los 500 ml diarios de lácteos totales para no desplazar otros alimentos de mejor calidad nutricional. Evitar los lácteos descremados: se vio que el ácido butírico presente en los lácteos enteros tendría un impacto positivo en la microbiota.

¿Y el yogur y el queso? Tampoco los sugerimos hasta el año. Posteriormente, yogures naturales y quesos reducidos en sal, dentro de los 500 ml de lácteos totales máximos en el día.

En 2020, salió en la *New England Journal of Medicine*, un metaanálisis llamado “Milk and Health”. Este es un estudio que revisó muchos otros estudios y plantea estas conclusiones:

- Aunque durante mil años se tomó leche “por el calcio”, para evitar fracturas, como dicen las publicidades de yogur, las sociedades que más leche de vaca toman son las que más fracturas tienen.
- El calcio puede ser obtenido sin problemas de alimentos como *kale*, brócoli, tofu, frutos secos y porotos, y eventualmente, de alimentos fortificados.
- No existe evidencia científica que sostenga la recomendación de tres porciones de lácteos al día.
- En niños que no consumen leche humana, y sobre todo en ambientes donde no se cuenta con alimentos de buena calidad nutricional, la leche de vaca puede contribuir a mejorar la nutrición, dentro de un contexto y teniendo en cuenta sus riesgos. Es un alimento más y no la solución a todos los males.
- La leche descremada, que antes sugeríamos a partir de los 2 años, estaría relacionada con mayor aumento de peso y peor perfil metabólico.

Si hay algo que no es necesario en la vida de los deambuladores y de niños y niñas, son las leches “de continuación”. Se venden como leche 3, leche 4, leche Peques, Grow, Crecer, etc., etc. **Son leche de vaca con agregado de diferentes azúcares, que no aportarán ningún beneficio a pesar de su altísimo costo.**

Alimentos que puedan aspirarse e ir fácilmente a la vía aérea (maní, tutuca, garrapiñada, pipas de girasol)

La mayoría de los cuerpos extraños que se aspiran son orgánicos. Los alimentos representan del 60 % al 80 % de los cuerpos extraños en la vía aérea de los niños, y como vimos, los más comunes son las semillas y los frutos secos (principalmente, semillas de girasol y maníes).

Se sugiere fuertemente no ofrecerles a los niños, las niñas o a los bebés, alimentos (de cualquier tipo) mientras viajan en la butaca del

auto, porque aumenta el riesgo de asfixia.

El pochoclo –pororó o palomitas de maíz– puede ser ofrecido después de los 2 años, siempre observando no ofrecer las partes duras del maíz que no formaron el copito de pochoclo, que tienen alto riesgo de asfixia. ¡Es importante como mapadres conocer las maniobras de desobstrucción de la vía aérea! (Ver capítulo 7).

Gaseosas, jugos industriales, jugos de soja industriales

Las gaseosas y los jugos son los ultraprocesados más consumidos en el mundo. Hasta los que “no” tienen azúcar son productos de mala calidad, pues generan alteraciones en la microbiota y en la funcionalidad intestinal debido a sus colorantes y otros aditivos. Propician las caries y la mala salud bucal, y el alto consumo de colorantes se ha vinculado con la hiperactividad en la infancia. Inclusive vemos un tipo de diarrea particular (se llama “diarrea crónica inespecífica”) en niños que consumen muchos jugos. Los jugos de sobre son lamentablemente muy populares y se consumen en escuelas y comedores, para no dar “solo agua”. ¡Acostumbrarnos a tomar agua es fundamental!

Como ya mencionamos, los jugos exprimidos tampoco se aconsejan. Cuentan con el azúcar de la fruta pero no con la fibra, y con menos nutrientes que el trozo entero. Si los ofrecemos, que sea esporádico y como golosina (ver más abajo).

Las leches vegetales se realizan en forma casera y en forma industrial. Están muy de moda como “reemplazo” de la leche de vaca... pero la realidad es que no es necesario “reemplazarla”, sino tener nutrientes variados en la alimentación. **Las bebidas vegetales, a menos que estén fortificadas, no tienen casi nutrientes. Los nutrientes se quedan todos en el bagazo, la parte que queda en el colador. (El bagazo se puede utilizar para hacer otras preparaciones).** No se puede comparar la bebida vegetal con la leche de un animal: sería como comparar una mandarina y una merluza. Son cosas diferentes.

Las bebidas vegetales pueden ser utilizadas para cocinar desde el principio de la alimentación complementaria, pero cuidado: las industriales, que se compran en el supermercado, suelen contener azúcares y aditivos.

Infusiones

Es muy común en nuestra cultura que se relacionen las infusiones con el desayuno y el almuerzo, más aún en la época invernal. **¿Pueden los bebés y niños tomar té, mate cocido, café? La respuesta es que no es recomendable.** Los té de hierbas, como el anís estrellado, paico, boldo, manzanilla, etc., tampoco se recomiendan en niños por el alto riesgo de toxicidad, hasta por los menos los 4-5 años. ¿Por qué?

- Porque tienen sustancias que inhiben la absorción de hierro de otros alimentos consumidos. Esto puede generar o empeorar un cuadro de anemia.
- No tienen valor nutricional importante, ocupan lugar en la panza y desplazan otros alimentos que sí nutren. Además, son estimulantes del sistema nervioso central y pueden generar, por ejemplo, problemas para dormir.
- Los “tecitos de hierbas” (paico, anís estrellado, manzanilla) pueden ser tóxicos para los bebés y niños, causar diarrea, deshidratación, desequilibrios en el sodio y potasio del cuerpo, convulsiones y otros síntomas evitables. Hace poco apareció una “recomendación” de bañar a bebés chiquitos con té de manzanilla: es importante saber que esto es peligroso, porque se puede ingerir accidentalmente o absorber por la piel.

Es habitual que los niños y las niñas en Argentina consuman mate cocido en la escuela, o como desayuno o merienda, porque no hay otra cosa para ofrecer para llenar la panza. Esto es una deuda inmensa con la infancia, que atenta contra el correcto crecimiento y desarrollo, y también una responsabilidad del Estado. Necesitamos difundir esta información, que la comprendan los profesionales y poder transmitirla a las familias. Hay otras opciones para ofrecer que, a largo plazo, ahorrarán mucho dinero en salud.

¿Y qué le doy de comer cuando vamos por la calle?

Lo primero que tenemos que pensar es si **realmente necesitamos darle comida cuando salimos de casa. ¿Cuánto tiempo salimos? ¿Adónde vamos?** Si realmente es indispensable porque es mucho tiempo, podemos llevar frutas frescas o deshidratadas.

¿Qué le doy para tomar?

A partir de los 6 meses, el líquido a ofrecer es el agua potable, en pequeñas cantidades que puedan ser gestionadas por el bebé.

Los niños mayores de 6 meses no requieren otro líquido que no sea agua. Ni jugo de naranja, ni licuados, ni jugo en polvo dietético. No existe ningún jugo recomendado, al contrario, el consumo de jugos está asociado a múltiples trastornos como caries, diarrea, trastornos gastrointestinales, dolor abdominal, trastornos del sueño e insomnio, urticarias y alergias...

Si un niño no quiere tomar agua es porque no tiene sed. Los niños dicen que tomar agua “no les gusta” cuando tienen el acceso a bebidas dulces de elaboración industrial, ofrecidas por adultos. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad como adultos elegir qué les ofrecemos. Todas estas bebidas tienen una pobre calidad nutricional, tengan o no tengan azúcar, y desplazan el consumo de alimentos de mejor calidad. Los licuados conservan la fibra y son mejores, pero seguimos insistiendo en que no son para todos los días del año. Es muy diferente comerse una fruta a tomarse un líquido con un montón de frutas licuadas.

En un bebé que ya come, ¿qué le podemos dar en desayunos y meriendas? Ante todo, si toma, su teta: no hay mejor leche que la del mamífero de donde nacemos. Si no es así, puede tomar la leche que toma habitualmente, según la edad. Y si no quiere leche o decidimos no incluirla en la alimentación de nuestra familia, simplemente puede tomar agua, o comer frutas.

A modo de conclusión

Hay un mundo gigante de alimentos a ofrecer, y no alcanzarían todos los libros del mundo para abarcarlos. Esta es simplemente una guía práctica con muchas preguntas que he recogido a lo largo de talleres y experiencias, con muchas dudas propias y mucha lectura para dilucidarlas. Queda mucho por aprender, y cada familia es un mundo. **Anímense a experimentar, a preguntarse, a buscar, a jugar con los alimentos y las comidas, a probar cosas nuevas, a aburrirse y a empezar de nuevo.** Y, sobre todo, miren a sus hijos e hijas, y anímense a ver el mundo, un ratito, con sus ojos.

Para seguir leyendo

PARA FAMILIAS

- Fernández, O. *Mi niño come sano: Prácticos consejos y más de 90 recetas saludables* (1.a ed.), Ediciones Urano, México, 2019.
- Eilenberg, K. y Wosner, G. S. *Yo amo comer: Descubriendo los alimentos en familia*, Sudamericana, Buenos Aires, 2017.
- Sociedad Argentina de Pediatría. (2003). *Agua para la sed*. Recuperado de: <https://www.sap.org.ar/docs/publicaciones/archivosarg/2003/161.pdf>

PARA PROFESIONALES

- Asociación Española de Pediatría. (2003). *Consumo de zumos de frutas y de bebidas refrescantes por niños y adolescentes en España. Implicaciones para la salud de su mal uso y abuso*. Recuperado de: <https://www.aeped.es/comite-nutricion/documentos/consumo-zumos-frutas-y-bebidas-refrescantes-por-ninos-y-adolescentes-en-espana-imp>
- <https://www.aeped.es/comite-nutricion-y-lactancia-materna/nutricion-infantil/documentos/consumo-zumos-frutas-y-bebidas-refrescantes>
- Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Primera Cátedra de Toxicología. (2018). *Informe Técnico. Problemas vinculados con la*

distribución de soja en comedores comunitarios. Recuperado de:
<https://www.fmed.uba.ar/sites/default/files/2018-03/soja.pdf>

- Sociedad Argentina de Nutrición. (2012). *Germen de trigo*. Recuperado de: <http://www.sanutricion.org.ar/files/upload/files/germendetrigo.pdf>
- Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. (2016). *Arsénico en el arroz y el cereal de arroz: Lo que usted debe saber*. Recuperado de: <https://www.fda.gov/media/98265/download>
- Willett, W. C. y Ludwig, D. S. (2020). Milk and Health. *New England Journal of Medicine*, 382(7), 644–654. Recuperado de: <https://doi.org/10.1056/nejmra1903547>
- Organización Panamericana de la Salud. (2017). *Alimentos y bebidas ultraprocesados en América Latina: tendencias, efecto sobre la obesidad e implicaciones para las políticas públicas*. Recuperado de: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/7698/9789275318645_esp.pdf
- World Health Organization & World Health Organization. (2015). *Guideline: Sugars Intake for Adults and Children*. Recuperado de: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241549028>
- Sociedad Argentina de Pediatría. (2020). *Programa Nacional de Actualización Pediátrica Nutrición*.
- SAMEV. (2020). Posgrado en Nutrición Plant Based.
- Butí, C.; Cancino, F.; Ferullo, S.; Gamundi, C. (2015). *Diversidad y evaluación toxicológica de peces como indicadores de contaminación por mercurio, plomo, cadmio, cobre y arsénico, provincia de Tucumán, República Argentina*. Serie de la Conservación de la Naturaleza. 20. Recuperado de: <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/13035>
- Oteiza, J. M.; Barril, P. A.; Quintero, C. E.; Savio, M.; Befani, R.; Cirelli, A. F.; Echegaray, N. S.; Murad, C.; Buedo, A. (2020). Arsenic in Argentinean polished rice: Situation overview and regulatory framework. *Food Control*, 109, 106909. Recuperado de: <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2019.106909>
- Ministerio de Salud. ANMAT. (2020). *Alimentos autorizados y establecimientos habilitados*. Recuperado de: <https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados/alimentos/alimentos-autorizados-establecimientos-habilitados>
- De Michelis, A. y Rajchenberg, M. (2006). Hongos comestibles: Teoría y práctica para la recolección, elaboración y conservación. *Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria*. Recuperado de:

https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta_hongos_comestibles.pdf

- CONICET. (2019). *Evaluación de mercurio en alimentos y matrices ambientales: Estado de situación en Argentina*. Recuperado de: <https://rsa.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2020/06/Informe-mercurio-RSA-Noviembre-2019-FINAL-final-AC.pdf>
- Ruderman, V. (10 de octubre de 2019). “Buenos Aires: uno de cada cinco pescados que se venden no es lo que dice la etiqueta”. *LA NACIÓN*. Recuperado de: <https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/buenos-aires-uno-cada-cinco-pescados-se-nid2294923/>
- Secretaría de Agroindustria Argentina. (2014). *Ficha 27: incluí pescado en tu alimentación*. Recuperado de: <http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Nutricion/fichaspc>
- Traina, A.; Bono, G.; Bonsignore, M.; Falco, F.; Giuga, M.; Quinci, E. M.; Vitale, S.; Sprovieri, M. (2019). Heavy metals concentrations in some commercially key species from Sicilian coasts (Mediterranean Sea): Potential human health risk estimation. *Ecotoxicol Environ Saf. Epub*. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2018.10.056.
- Gaiolia, M.; Amoedoa, D.; González, D. (2012). Impacto del mercurio sobre la salud humana y el ambiente. *Arch Argent Pediatr*, 110(3):259-264. Recuperado de: <https://www.sap.org.ar/docs/publicaciones/archivosarg/2012/v110n3a18.pdf>
- Sylvetsky, A. C.; Gardner, A. L.; Bauman, V.; Blau, J. E.; Garraffo, H. M.; Walter, P. J.; Rother, K. I. (2015). Nonnutritive Sweeteners in Breast Milk. *J Toxicol Environ Health A*, 78(16):1029-32. Recuperado de: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5583633/>
- Olivier-Van Stichelen, S. y Rother KIand Hanover, J. A. (2019). Maternal Exposure to Non-nutritive Sweeteners Impacts Progeny’s Metabolism and Microbiome. *Front. Microbiol*. DOI: 10.3389/fmicb.2019.01360.
- Cavagnari, B. M. (2019). Edulcorantes no calóricos en embarazo y lactancia. *Revista Española de Salud Pública*, Recuperado de: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272019000100013&lng=es&tlng=es
- Garavaglia, M. B.; Rodríguez García, V.; Zapata, M. E.; et ál. (2018). Edulcorantes no nutritivos: consumo de los niños y adolescentes, y alimentos que los aportan. *Arch Argent Pediatr*, 116(3):186-191. Recuperado de:

<https://www.sap.org.ar/docs/publicaciones/archivosarg/2018/v116n3a04.pdf>

- Cavagnari, B. M. (2019). Edulcorantes no calóricos: características específicas y evaluación de su seguridad. *Arch Argent Pediatr*, 117(1):e1-e7. Recuperado de:
<https://www.sap.org.ar/docs/publicaciones/archivosarg/2019/v117n1a11.pdf>
- Vinderola, C. y Pérez-Marc, G. (2021). Alimentos fermentados y probióticos en niños. La importancia de conocer sus diferencias microbiológicas. *Arch Argent Pediatr*, 119(1):56-61. Recuperado de:
<https://www.sap.org.ar/docs/publicaciones/archivosarg/2021/v119n1a13.pdf>
- Rodríguez, H.; Cuestas, G.; Gregori, D.; et ál. Recomendaciones sobre la prevención de la aspiración de cuerpos extraños orgánicos. (2017). *Arch Argent Pediatr*, 115(5):512-516. Recuperado de:
<https://www.sap.org.ar/docs/publicaciones/archivosarg/2017/v115n5a29.pdf>
- Organización Mundial de la Salud. (2017). El mercurio y la salud. *WHO*. Recuperado de: [https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mercury-and-health#:~:text=La%20exposici%C3%B3n%20al%20mercurio%20\(incl](https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mercury-and-health#:~:text=La%20exposici%C3%B3n%20al%20mercurio%20(incl)
- Comité Nacional de Hematología, Oncología y Medicina Transfusional, y Comité Nacional de Nutrición. (2017). Deficiencia de hierro y anemia ferropénica. Guía para su prevención, diagnóstico y tratamiento. *Arch Argent Pediatr*, 115 Supl 4:s68-s82. Recuperado de:
https://www.sap.org.ar/uploads/consensos/consensos_deficiencia-de-hierro-y-anemia-ferropenica-guia-para-su-prevencion-diagnostico-y-tratamiento--71.pdf
- Restrepo, C.; Santamaría, A.; Manrique, R. (2021). Sleep bruxism in children: relationship with screen-time and sugar consumption. *Sleep Medicine: X Volume 3*. Recuperado de:
<https://doi.org/10.1016/j.sleepx.2021.100035>

Neofobia y selectividad. El miedo a
que no coman nada

Los mapadres podemos no saber.
Menos mal que se puede, porque no sabemos.
Porque de lo que han vivido, te pueden contar.
Pero lo nuevo, cuando para todos es nuevo,
Uy, qué difícil,
Qué misterio,
Qué vértigo.
Tendremos que aprender con vos.
Tendremos que mirar, con un poco de envidia,
A los horneros en nuestro alféizar,
Que llevan los bichitos para sus crías,
Sin dudar ni un segundo de sus proteínas.



Las dificultades en la alimentación son experiencias que impactan en lo cotidiano de las familias. **Ya sea desde una cuestión de expectativas, o por creer que un bebé tiene que comer de determinada manera, o porque hay algún problema orgánico, sentir que no podemos alimentar a nuestras hijas y nuestros hijos nos genera una angustia terrible.** ¿Cómo no va a comer? ¡Se va a desnutrir! Y ahí, muchas veces, de la mano del terror que nos da no verlos comer, más la enorme oferta mercantil de cosas supuestamente nutritivas, caemos en comprar y ofrecer solamente esa galletita o ese yogur que es lo único que comen.

Hace poquito lancé una encuesta informal en las redes sociales acerca de cómo les parecía que comían sus hijos e hijas. El 50 % de las personas marcó que comían demasiado poco, el 45 % marcó que comían demasiado, y el 5 % que estaban conformes con lo que comían niños y niñas. Obviamente esto no es un estudio científico y está sesgado a una pequeña muestra de personas, pero es similar a lo que vemos en el consultorio y en las charlas con otras familias que tienen hijos e hijas.

El concepto *picky eaters* se traduce de mil maneras, entre ellas “picoteador”, “quisquilloso para comer” o “malo para comer”. **Un niño catalogado como tal puede ser un picky eater como un proceso totalmente sano y normal del desarrollo, pero también por alguna cuestión de salud que debemos descartar.** Y a eso apunta este capítulo: a traer tranquilidad pero también a orientar la consulta si llega a ser necesario.

En otros casos, la selectividad es más pronunciada llegando a afectar el crecimiento y el desempeño de las actividades de la vida diaria. Aquí es importante una evaluación concienzuda del desarrollo y estar atentos a otras señales de alarma.

Todos los mapadres nos preocupamos alguna vez por la alimentación de nuestros hijos e hijas. Es parte de nuestra mirada amorosa, y también tiene que ver con nuestro camino alimentario transitado antes de la mapaternidad. Implica desandar ese camino y animarse a tomar esa mano pequeñita que nos muestra que existen otros.

Dificultades en la alimentación. ¿Qué es esperable?

Es esperable que nuestros hijos e hijas:

- Un día coman un plato entero y al día siguiente coman mucho menos.
- No quieran estar sentados en la sillita, sobre todo si están en el momento de descubrir nuevas habilidades motoras (caminar o gatear, por ejemplo).
- No quieran comer cuando están enfermos. Sí es importante que tomen líquidos y se mantengan hidratados.
- Dejen de comer de un día para otro algo que “les gustaba mucho antes”.
- ... Y que vuelvan a comerlo un tiempo después, más si la familia lo sigue incorporando a la mesa.
- Metan comida en el vaso de agua (¡clásico!).
- Sobre todo si son pequeños, manipulen la comida, se embadurnen la cara con los alimentos, los aplasten sobre la mesa y no los “coman”.
- A veces se metan mucha comida en la boca, y luego la saquen sin tragarla, como un juego.
- Tengan arcadas y toses en las primeras semanas de la alimentación complementaria, mejorando progresivamente.
- Alrededor del año y medio de vida en adelante, coman menor cantidad, no les interese demasiado la comida y no acepten nuevos alimentos.

Cuáles son los signos de alarma y cómo abordarlos

Son signos de alarma a los que hay que estar atentos si nuestros hijos e hijas:

- Luego de las primeras semanas de alimentación complementaria, tosan en cada comida.
- No toleren tocar, ver u oler ciertas comidas (algunos niños tienen arcadas a la simple vista de un alimento).
- Después del año de vida, no puedan manejar texturas semisólidas y sólidas.
- No consuman un grupo entero de alimentos (por ejemplo, que no coman ninguna fruta o coman solo banana).
- Durante un período prolongado en el tiempo desde el inicio de la alimentación complementaria, se metan mucha comida en la boca y la escupan, y esto pase muchas veces por semana.
- Se observe constantemente dificultad o dolor en la masticación o al momento de tragar.
- Solo acepten alimentos de una marca específica.
- Rechacen por completo ciertas texturas (blandas, crocantes, etc.).
- La hora de la comida sea un momento de continua tensión y sufrimiento.
- Exista real déficit en el crecimiento.

¿Cómo abordar uno o más de estos indicios? La primera consulta es con el/la pediatra de cabecera o médico/a de familia. Este es el/la profesional que va a evaluar en primera instancia al niño o la niña, escuchar a la familia y plantear las posibles interconsultas. **Vamos a descartar posibles causas orgánicas que puedan estar afectando la alimentación, expectativas de la familia y del entorno, evaluar qué sí come, cómo se come, dónde se come y otras cuestiones.** Claro que para esto, necesitamos tiempo, y tal vez no se pueda abordar por completo en una consulta necesitando varios encuentros para una correcta evaluación. ¡Es importante tenerlo en cuenta!

¿Qué edad tiene?

Si tiene menos de 1 año:

- Si el bebé “no come” y empezó hace pocas semanas la

alimentación complementaria, simplemente es cuestión de aguardar, ofrecer y observar. Y, sobre todo, tomarnos un ratito para pensar en las expectativas que tenemos con relación a comer.

- **Ayuda mucho, en la consulta, dibujar un plato y marcar cuánto esperábamos que comiera desde el inicio de la alimentación complementaria, o con cuánto nos sentiríamos satisfechos.** Es posible que sea mucho más de lo que puede meter un bebé en la pancita, teniendo en cuenta su tamaño. Fíjense lo que dibujaron, y miren el tamaño de su bebé. ¿Cuánto de ese bebé es estómago? No más que el tamaño de su puñito, aunque el estómago se estire.
- **La alimentación complementaria es complementaria,** y la leche humana (o fórmula) es el principal alimento durante el primer año de vida.

Si tiene más de 1 año:

- **Una vez que pasó la etapa exploratoria hiperinteresante de la comida, muchos bebés dejan de tener interés en los alimentos.** Esto tiene que ver con que su crecimiento se vuelve más lento (ya vimos que nunca volverán a crecer tan rápido como en los primeros 6 meses de vida), el mundo tiene otras dimensiones ahora que se pueden parar, desplazar y descubrir cosas emocionantes como el arriba y abajo, y que la puerta del lavarropas se puede abrir de determinada manera.
- **La neofobia –no aceptar alimentos nuevos– a esta edad tiene que ver con una cuestión evolutiva del ser humano.** Cuando el ser humano no vivía en ciudades, sino a campo abierto, los peligros acechaban fácilmente. Alrededor de los 18 meses, todos los bebés ya son deambuladores y tienen mayor capacidad para desplazarse y explorar por su cuenta, y también para encontrarse con situaciones adversas, como los frutos tóxicos de una planta, por ejemplo. En ese caso, la neofobia (no manotear el fruto de la planta y probarlo así como así) era un mecanismo de supervivencia. Pues bien, aunque ahora vivimos en departamentos y es poco probable tener acceso a plantas exóticas que crecen en la sabana, el mecanismo de supervivencia es el mismo, y es normal que rechacen alimentos nuevos, e inclusive algunos que ya comían antes.

¿Qué hacemos? Seguir ofreciendo alimentos sanos. Que estén en el campo visual, en nuestros platos, en la mesa. Cocinemos e invitémoslos a sentir el olorcito a comida. Que nos ayuden a lavar las frutas y verduras, que elijan alguna con un color divertido en la verdulería.

¿Por qué es importante que esté en el campo visual y en el de otros sentidos? Porque al mirar, oler y tocar un alimento se crean imágenes en el cerebro. “Eso no es nuevo, está muchas veces en la mesa de mi familia”, dice el cerebro, más allá de comerlo o no. **A veces necesitamos muchas exposiciones a un alimento (más de veinte) para aceptarlo. Sí, veinte. No dos ni ocho. Y a veces, inclusive más.**

Con 1 año de edad, la mayoría de los niños son capaces de ser independientes para llevarse alimentos a la boca con las manos y tomar de un vaso. Pero muchas veces se observa que, por miedo a que no coman lo suficiente, esta independencia se limita. Para dejarlos tranquilos, les cuento que **existen estudios (los dejo en la bibliografía) que relacionan a los bebés que autogestionan sus alimentos con una mayor ingesta nutricional que los que son alimentados en la boca.** ¡Así que a permitir explorar!

Una cosa más: tal vez simplemente a tu hijo o hija no le guste ese alimento. ¡Y está bien! Todos tenemos nuestras preferencias, que además van cambiando con el tiempo. A mí no me gustaba mucho el mate hasta que empecé la facultad, y ahora, por ejemplo, detesto el mate dulce (mis primeros mates nadaban en azúcar). Las papilas gustativas van cambiando y eso también está bien.

Si tiene más de 4 años:

- **Un niño o una niña que come pocos tipos de alimentos a esa edad, es muy selectivo, y/o solo acepta algunos colores o texturas, seguramente trae una selectividad de larga data.** Tomo esta edad de manera caprichosa: podría haber puesto 3 o 9 años. ¿Entonces no se puede hacer nada? Claro que se puede, dado que se puede inclusive tratar la selectividad en los adultos.
- **En niños y niñas mayores, hay que evaluar cómo es el resto del neurodesarrollo, el ambiente, la masticación y deglución, y otras cuestiones** que abordaremos a lo largo de este capítulo. Muchas veces se requiere paciencia y trabajo de hormiga para mejorar temas que comprometen la nutrición y la salud de estos niños y niñas, y los

resultados no son inmediatos. Generar un vínculo nuevo con la comida puede llevar tiempo, pero vale todo el inmenso esfuerzo y el amor puestos en ello.

Hablemos de antecedentes en su salud y crecimiento

¿Fue prematuro/a? ¿Estuvo en neonatología?

Se considera prematuro a aquel bebé nacido antes de la semana 37, según la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, no es igual el desarrollo y la succión de un bebé que nace con 37 semanas que el que nace con 40, por eso muchos de ellos necesitarán más apoyo para la lactancia si este es el deseo de la familia.

Los bebés prematuros tienen un camino de desarrollo que deben hacer afuera de la panza, cuando la mayoría de los bebés lo hizo adentro. Muchas veces requieren asistencia para respirar, para regular su temperatura y para comer mientras van creciendo. Es común que a los bebés prematuros se les coloque una sonda nasogástrica o una sonda orogástrica, mientras aprenden a succionar, por la cual se pasa leche directamente al estómago. Siempre el contacto con las personas amadas es fundamental para su desarrollo, aun en situaciones de gravedad. Apoyar una mano sobre el piecito, contarle cuentos o lo que sientan los mapadres en ese momento, son intervenciones fundamentales de la familia para la salud.

Las intervenciones en la cavidad oral, necesarias para mantener con vida y salud a estos bebés, como lo es el respirador o la sonda, en ocasiones generan una impresión negativa en el cerebro del bebé y posteriormente complican algunos procesos, como la lactancia o la alimentación.

Esto lo aprendí con mi primer hijo. La primera vez que lo pude poner al pecho tenía 20 y algo de días, unos 14 de respirador, varias transfusiones, dos tubos pleurales y otras infinitas intervenciones que agradezco que haya tenido para yo poder abrazarlo. Su succión se cansaba mucho y le costaba prenderse: era lógico, lo que más había tenido en la boca era un respirador y una sonda. La puericultora lo pesquisó y me propuso una pezonera, no porque hubiera problemas en el pezón, sino para que a él le sirviera como transición. Y así fue, y establecimos una lactancia materna exclusiva, dejando al poco tiempo

las pezoneras.

Algo que hoy, con más información, pienso que hubiera sido interesante trabajar, es que recuerdo que aunque mamaba bien, se le caía mucha leche por el costado de la boca, cosa que mejoró con el tiempo. Es posible que él no tuviera buen sello labial, por todo lo mencionado anteriormente, y hubiera estado bueno trabajar con una fonoaudióloga en forma temprana.

En bebés que tuvieron intervenciones en la boca en su etapa neonatal, o inclusive posteriormente (bebés y niños que han estado internados en terapia intensiva mucho tiempo), hay que pensar en las aversiones orales, el rechazar alimentos por esas experiencias negativas que les causaron molestia o dolor. No es que todos las vayan a tener, pero es un dato de importancia y muchas veces necesitamos trabajar con fonoaudiología y terapia ocupacional para que nos den su mirada sobre el tema.

¿Tomó o toma teta?

La lactancia, como hablamos en el capítulo sobre desarrollo, es el primer bocado, el entrenamiento de los músculos de la masticación y del rostro para comer. Además, los niños y las niñas amamantados estuvieron expuestos sensorialmente a muchos sabores durante el período de lactancia, mientras que los que solo han tomado fórmula, reciben solo el sabor dulce de la misma.

¿Los bebés amamantados nunca tienen problemas para comer? Claro que sí, porque no es el único factor, pero los estudios muestran que tienen menor chance de presentarlos.

Si no come, ¿le tengo que sacar la teta? No. La lactancia puede ofrecer un 40 % de las calorías y nutrientes que los niños y las niñas mayores de 1 año necesitan. Si le sacamos la teta para que coma otras cosas, le estamos sacando el mejor alimento que recibe. Es importante saber que la leche humana tiene más calorías que la leche de vaca, y su hierro se absorbe mucho mejor. También cuenta con factores de crecimiento, o sea, sustancias que ayudan a crecer a los tejidos. No hay una edad límite para amamantar, y no impacta negativamente en su desarrollo, al contrario.

¿Usa biberón?

El uso de la mamadera es muy popular, y culturalmente no se concibe la etapa de bebé sin alguna mamadera. Puede ser usada por mil razones: porque la familia lo desea, porque la mamá debe trabajar fuera de casa, en forma terapéutica para estimular la succión, etc.

Puede ser un utensilio útil, pero es preciso limitar su uso no mucho más allá de los 18 meses. Si hay que suplementar a un bebé recién nacido o muy pequeño, cuya madre desea amamantar, hoy por hoy no se recomienda una mamadera, sino un vasito o relactador.

Otro problema cultural que tenemos es creer que la mamadera “es más fácil” o “es un descanso”, o que el bebé puede tomarla solo. En el capítulo 3 sobre lactancia explico la importancia de ofrecer la mamadera a demanda, observando al bebé y respetando su saciedad. Todo esto impacta posteriormente en su alimentación.

El uso prolongado de la mamadera genera problemas en el desarrollo de los músculos faciales, y esto impacta en la respiración, masticación, deglución, habla y salud oral. Sumado a que contribuye a tomar mucha cantidad de leche y jugos, este es un antecedente muy importante a la hora de abordar las dificultades en la alimentación.

Cuando la mamadera es un elemento central de la alimentación de niños y niñas más allá del año y medio, y eso, además, trae dificultades con los otros alimentos, tenemos que trabajar pediatra, nutricionista y posiblemente fonoaudióloga. Las puericultoras pueden ayudar en el destete de la mamadera (¡sí, es un destete y debe tener el respeto que se merece!).

¿Cómo transitó la alimentación complementaria?

Ya les conté que no importa tanto el método elegido, y que el mundo no es una lucha entre BLW y papillas, mientras la alimentación sea perceptiva y que las texturas se progresen de más blandas a más sólidas. El problema es que, muchas veces por miedo del adulto, esto último no sucede y los chicos reciben papillas inclusive por años. Esto genera que no aprendan a masticar y tragar texturas más sólidas, y eso complica la alimentación. Esto, si es pesquisado, se trabaja con fonoaudiólogos que trabajan en deglución.

Otra cuestión es la exposición a alimentos, colores y sabores. Durante mucho tiempo se nos empujó a alimentar a los bebés con papillas blancas azucaradas de cereales de caja. Hoy sabemos que podemos ofrecer una multitud de alimentos de todos los colores, y a **cuantos más alimentos se**

haya expuesto un niño durante su primera etapa de alimentación complementaria, más aceptará luego de transitada la etapa de neofobia.

¿Presentó muchas infecciones respiratorias?

Es común que los niños y las niñas tengan de 8 a 12 infecciones respiratorias altas leves por año (antes del COVID-19, claro. Las cosas han cambiado un poco, pero a lo que voy es que es común que los chicos tengan mocos), causadas por virus en un 75 % de los casos.

Otra cosa es cuando los chicos tienen muchos episodios de bronquiolitis o neumonía. Ahí hay que pensar qué está sucediendo, y buscar un diagnóstico y un posible tratamiento. ¿Hay un componente alérgico? ¿Alguna alteración en la inmunidad? ¿Reflujo?

En niños y niñas con alteraciones del tono muscular, suele suceder que pequeñas cantidades de saliva o alimentos pasen a la vía aérea, y esto se denomina “microaspiraciones”, y pueden causar irritación e infecciones pulmonares. Es más raro, pero también puede suceder, que haya comunicación anatómica entre la vía aérea y la respiratoria, dado que ambas comparten un origen embrionario común.

Algo a tener en cuenta a partir de la pandemia de COVID-19, es que este virus causa pérdida del olfato y del gusto también en los chicos, y que muchas veces no pueden expresarlo más que con el rechazo a la comida. Suele ser transitorio, aunque el tiempo de recuperación varía de persona a persona, y más en la infancia. Paciencia y mucha exposición amorosa a texturas, olores y sabores puede ayudar.

¿Cómo es su crecimiento?

Evaluar el crecimiento es fundamental para ver si las dificultades en la alimentación se relacionan con una causa orgánica. Pero (siempre hay un pero), como expliqué en el capítulo 6 sobre crecimiento, no es tan importante la foto como la película: cómo viene creciendo esa niña o ese niño. Tal vez su percentil siempre fue bajo y come mucho, o siempre fue alto y come poco, o viceversa.

Una vez más, recordemos que las niñas y los niños nunca van a crecer tan rápido como en sus primeros 6 meses de vida. Algunos –siempre hablando de

niños y niñas sanos– no crecen más que uno o dos kilos en su segundo año de vida.

La selectividad alimentaria extrema SÍ puede condicionar el crecimiento, y generar déficit nutricional. Los niños altamente selectivos limitan su dieta a menos de 10 o 15 alimentos. Por eso es imprescindible buscar estrategias para abordarla.

La falta de crecimiento también nos tiene que orientar más allá de la ingesta. ¿No crece porque no come o porque su cuerpo gasta todas las calorías? ¿No come porque no quiere o porque le cuesta tragar? ¿Come “adecuadamente” y aun así baja de peso? La evaluación de factores como la anemia, la capacidad de deglutir, lo cardiológico (las afecciones cardíacas pueden causar mucho gasto metabólico), las enfermedades que generan malabsorción intestinal y otras, muchas veces es necesaria para descartar patologías que estén afectando la alimentación, y viceversa.

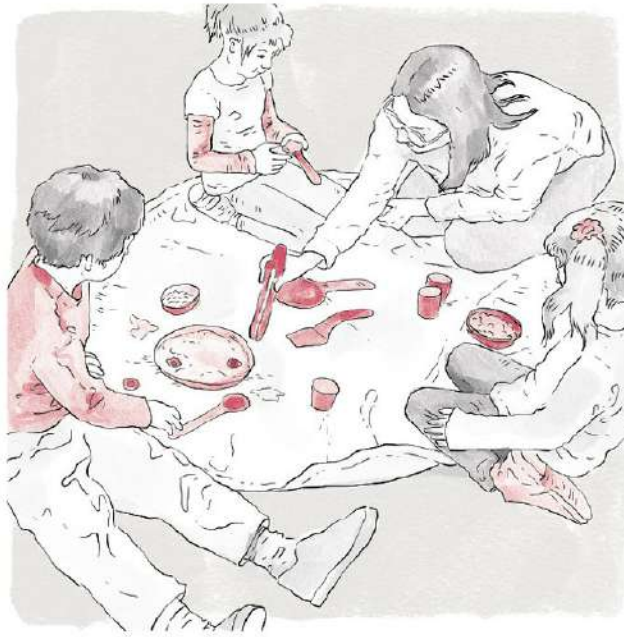
¿Cómo es su neurodesarrollo?

El neurodesarrollo es parte del aprendizaje en la alimentación. Ya hemos charlado del desarrollo neuromadurativo a muchos niveles que es necesario para la alimentación, no solo para el inicio, sino para su despliegue en los siguientes años. El desarrollo motor, la comunicación, el lenguaje y el desarrollo sensorial son grandes pilares del camino de la alimentación.

Las alteraciones en el neurodesarrollo pueden condicionar la relación con los alimentos, generando neofobia y selectividad extrema. En infancias con trastornos del espectro autista, es común observar que aceptan pocos alimentos, generalmente del mismo color o solamente de la misma marca, a tal punto que si la empresa cambia el envase, los niños y las niñas dejan de comerlo. Estas alteraciones se acompañan muchas veces de alteraciones de la integración sensorial, con mucha selectividad y rechazo de colores, aromas y texturas. Lo que hace o no hace un niño o una niña en su día a día nos orienta mucho: ¿toca el pasto? ¿Le gusta jugar con el agua? ¿Se anima a tocar otras texturas y temperaturas?

¿Qué hacer? Trabajar en conjunto con la familia, como siempre. Desde el consultorio del pediatra, con la evaluación de posibles disbiosis y otros problemas concomitantes como la permeabilidad intestinal, alergias e intolerancias, hasta la consulta y el tratamiento con otros colegas. ¿Qué colegas? Sobre todo terapeutas ocupacionales, que acompañarán en la

aproximación sensorial a esos alimentos y en las actividades de la vida diaria que implican el acto de alimentarse; nutricionistas, para asegurar el aporte de nutrientes; y profesionales de la salud mental para el acompañamiento familiar.



¿A QUÉ SE DEDICA LA TERAPIA OCUPACIONAL?

La terapia ocupacional es una disciplina que promueve autonomía y bienestar a través del uso terapéutico de las actividades mismas, desde el nacimiento hasta la muerte digna. Nuestro objeto de estudio es “la ocupación”, con la mirada puesta en el desempeño particular de cada persona. Escuelas, hogares, consultorios, contextos laborales, judiciales y sociocomunitarios son nuestros ámbitos de intervención. (María Fernanda Iroumé, terapeuta ocupacional, MN 3663).

¿Hay alguna condición de salud acompañante?

Las enfermedades agudas, como gripes o gastroenteritis, suelen generar inapetencia en las niñas y los niños. Imagínense cómo se sienten ustedes cuando tienen fiebre y mocos: de lo que menos tienen ganas es de comer.

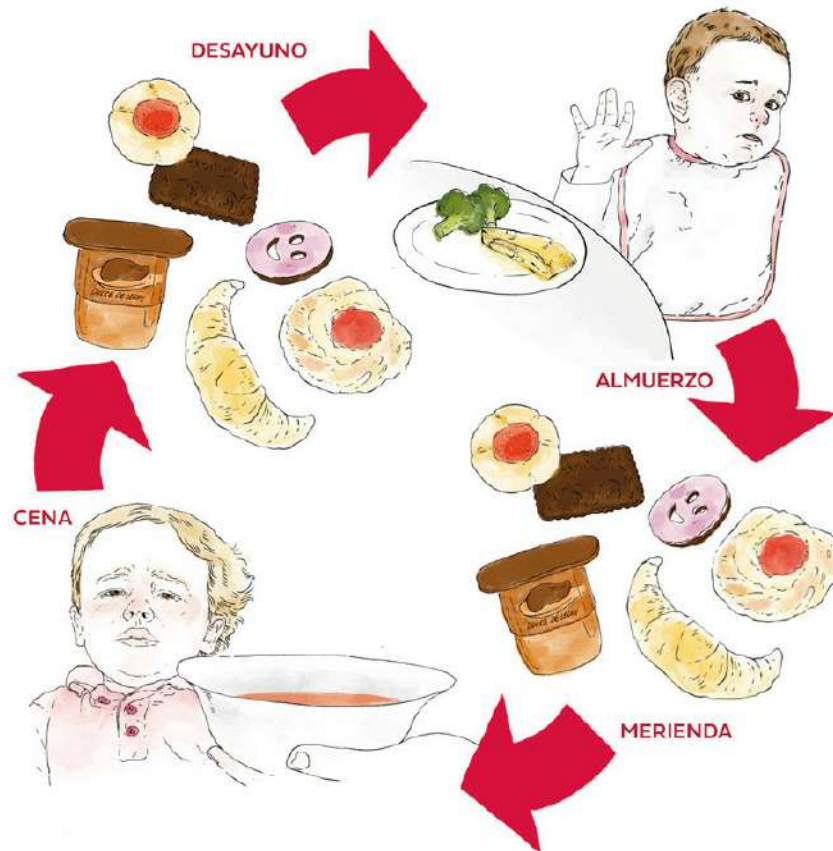
Mientras se mantengan hidratados, no es un problema. Si bajan un poco de peso durante esos días, suelen recuperarlo rápidamente después.

Las enfermedades o condiciones de salud crónicas conllevan un gran esfuerzo del niño o la niña que las atraviesa y de su familia. La alimentación es un acto fundamental que realizamos todas las personas, de una manera u otra, por lo que tiene absoluta injerencia en lo cotidiano de esa niña o ese niño. Teniendo en cuenta las manifestaciones de esas condiciones de salud, es importante asegurar los nutrientes, la autonomía, los gustos y el placer de esas personas. Es muy común que aparezcan frases como “pobrecito, tiene X enfermedad, cómo no lo vas a dejar comer un pancho, le arruinás la infancia”, porque está muy instalado en el imaginario popular que la única forma de disfrute es un ultraprocesado.

Algo fundamental en la evaluación de los problemas de la alimentación es la salud bucal. Si un niño o una niña tiene caries, inflamación de las encías, perdió piezas dentarias u otros problemas en la boca, puede que no coma porque tiene dolor o molestia. Es lamentablemente común ver niñas y niños de 3-4 años con pérdida de múltiples piezas dentales por caries, y familias (y pediatras) poco preocupadas porque “total son de leche”. Los dientes temporarios son fundamentales para el desarrollo de la masticación: ¿cómo aprenderá a masticar alimentos sólidos un niño o una niña que tiene dolor en las muelas por caries? Los odontopediatras aquí son fundamentales para la prevención y el tratamiento.

Además, no debemos olvidar a las niñas y los niños que por alguna enfermedad están cursando tratamientos que les aumentan o quitan el hambre, por ejemplo, tratamientos con corticoides en altas dosis o quimioterapia.

La quimioterapia, que se utiliza sobre todo para enfermedades oncológicas, puede generar náuseas, gusto feo e inclusive lesiones en la boca. Estas medicaciones, necesarias para la vida y la salud de esa niña o ese niño, también causan efectos en otros órganos y en el crecimiento, por eso es necesario un equipo transdisciplinario que acompañe.



Adaptado de: *Se me hace bola. Cuando no comen como queremos que coman*, Debolsillo, Barcelona, 2013.

¿Qué cosas sí come? Salir del “círculo del azúcar” y los ultraprocesados

El “círculo del azúcar” suele ser la causa más frecuente de infancias que “no comen nada”, sobre todo en edad escolar. El nutricionista español Julio Basulto ha resumido esta cuestión en un círculo muy acertado: los niños suelen desayunar (cuando desayunan) productos altísimos en azúcares, como chocolatadas, galletitas, postrecitos lácteos, facturas y mermeladas. A media mañana, suelen consumir en el colegio otros productos industriales: panchos, alfajores, pizzetas, medialunas con jamón y queso... Un solo vaso de leche con chocolatada para preparar puede contener más calorías (en forma de azúcar) de las que necesita esa niña o ese niño para todo el día. Los organismos infantiles son muy sabios: si ya no necesitamos más energía, ¿para qué vamos a seguir comiendo?

Esto genera que, a la hora del almuerzo, no tengan hambre. Además, **la**

excitación del paladar ante sabores dulces y aditivos hace que los alimentos reales no sean tan sabrosos para el cerebro. Culturalmente, presentamos mejores nutrientes en el almuerzo o en la cena, como “platos fuertes”, y al no aceptarlos, no los incorporan.

El hambre llega de nuevo a media tarde: merienda con galletitas y chocolatada, alfajores, más galletitas... Tanta azúcar, que por la noche de nuevo deja de ser atractiva la cena... Y ya es otro día.

Esto, sumado al cansancio de los mapadres tras largas jornadas de trabajo para que coman “algo”, resulta en que se suele recurrir a las comidas que sí aceptan: generalmente ultraprocesados con multitud de sustancias diseñadas para que sean atractivos para los chicos y las chicas, con mucho *marketing*, mucho sodio, muchos saborizantes, mucho jarabe de maíz de alta fructosa. Ahí aparecen las “patitas de pollo”, con casi nulo contenido de pollo, las salchichas, los fideos para todos los días...

¿Cómo se resuelve? Cortando el círculo. **Una vez descartadas otras patologías, es fundamental que lo que tengamos en casa y se les presente a los chicos sean alimentos saludables.** Sí, tal vez vayan a la escuela y estén expuestos a las galletitas y alfajores, sin duda. Pero en casa hay otras opciones. Si en casa no hay otras opciones, no hay posibilidad de elección.

El desayuno no es necesariamente la comida más importante del día, y obligar a comer ya vimos que no es una opción. ¿Pero puede ir a la escuela sin comer? Sí, si no tiene hambre, puede, llevándose un *tupper* con el desayuno para el recreo, que no necesariamente es un lugar de *snacks*, sino que puede ser un momento realmente nutritivo.

Empezar a pensar el desayuno y la merienda como momentos de alimentos reales, y no necesariamente de infusiones con panificados, está buenísimo para incorporar nutrientes de verdad en todas las comidas. Desayunar legumbres, verduras, huevos, fideos, quinua, palta, frutas, tortillas, frutos secos y mil combinaciones más, son buenas opciones para salir de ese círculo azucarado que tantos problemas trae a la salud.

Con relación a esto, uno de los problemas más grandes en la edad escolar es el consumo de jugos y gaseosas. Inclusive los jugos “sin azúcar” tienen grandes cantidades de edulcorantes y colorantes, que pueden afectar la microbiota. Una cajita de jugo puede tener casi todas las calorías que necesita en el día un niño o una niña de 4 años. Reitero, el cuerpo es muy sabio. ¿Para qué va a comer más, si ya tiene toda la energía necesaria? Reemplazar el jugo por el agua suele ser el primer paso del proceso. Si es necesario saborizar el

agua al principio con un poco de jugo de fruta exprimida, adelante, es más sano que el jugo comprado.

Frente a los ultraprocesados, la autorregulación no puede hacer mucho. Cuando le ofrecemos productos comestibles plagados de aditivos sensoriales a los chicos, el consumo siempre inclinará la balanza hacia ellos. De ahí la importancia de evitarlos en la alimentación.

Respecto a los lácteos, son objeto de enormes controversias, tanto en sus métodos productivos como en su función nutritiva. ¿Aportan nutrientes? Sí, sin ser imprescindibles en la alimentación. El “no come pero me toma la leche”, es una frase muy común. **Los lácteos de vaca, después del año, no deberían representar más de 500 ml totales en la alimentación de un niño o una niña, siendo lácteos simples, sin agregados de azúcar u otros aditivos.** La creencia de que la leche de vaca aportará todos los nutrientes necesarios viene de asociarla con, justamente, la leche humana, pero esto no es así. La leche tiene calcio, sí, pero es pobre en hierro y complica su absorción.

Además, para absorber ese calcio, no basta con comerlo: es preciso que la vitamina D esté en concentraciones adecuadas, la microbiota saludable, los músculos en movimiento... “Si no le pongo chocolatada o no se la doy en mamadera, no toma leche”, es otra frase común. Esto suele ser algo hasta positivo. Habla de que probablemente no tome esa leche por una cuestión nutricional, sino por la comodidad de la mamadera o el azúcar del chocolate. Disminuir el consumo de esas leches puede dejar espacio para otros alimentos más nutritivos.

¿Por qué es tan difícil disminuir el consumo de lácteos? Primero, porque culturalmente creemos que al no consumir lácteos, automáticamente se nos romperán los huesos. Pero también hay una cuestión fisiológica: los lácteos (sobre todo el queso) cuentan con casomorfina en su composición. La casomorfina es una exorfina, similar a una endorfina que se genera en nuestro cuerpo como consecuencia de la ingesta de, en este caso, la caseína. La acción es similar a la morfina, aunque muchas veces menor, y genera “necesidad” del lácteo. Es por esto que es muchas veces complejo disminuir su consumo.

En muchos casos de niños y niñas que “no comen nada”, la disminución de lácteos, sobre todo de la chocolatada, diversos postres y yogures, y de jugos, mejora radicalmente el cuadro. Es un camino que lentamente necesitamos transitar.

Picoteo y *oversnacking*

En el afán por verlos ingerir alimentos, muchas veces a los niños y las niñas se les ofrecen pequeñas cantidades de comida a lo largo del día. Está estudiado que aquellos que “picotean” tienen menores ingestas a la hora de sentarse a la mesa, y esto es percibido como que “comen poco”. La realidad es que comen la misma cantidad, o inclusive más, dado que la oferta es constante.

El *oversnacking* se refiere a la conducta de ofrecer colaciones constantemente. Por ejemplo, salir a caminar tres cuadras y llevar comida, o comprar golosinas solo porque se visita al pediatra (¡esto es superaprovechado por los kioscos que se instalan adentro o en la puerta de hospitales!). ¿Qué hago si tiene hambre en la calle? Bueno, primero habría que preguntarse cuánto tiempo estaremos afuera. Si es una hora, es poco probable que se necesite comida. En cambio, si viajamos dos horas en colectivo y sabemos que tendremos una espera larga, sí, seguramente se necesite algo de comer. En este último caso podemos llevar fruta, o comprar en la verdulería y pedir que nos la laven correctamente. **Pero, en general, tendemos a pensar que nuestros hijos e hijas morirán de hambre, y la realidad es que muy pocas veces nos pedirán comida cuando estemos afuera de casa.** Lo más probable es que nos pidan comprar algo del kiosco porque el paquete es precioso y atractivo, lo cual es diferente al hambre.

Evitar estas dos conductas es útil para el día a día. Ofrecer comida todo el tiempo no es necesario, confiemos en su hambre y saciedad.

¿Cómo come lo que come?

La manera de comer es muy importante para detectar problemas en la alimentación. ¿Se mete mucha comida en la boca? ¿Le cuesta tragar? ¿Tiene que extender la cabeza para atrás para tragar? ¿Le duele? ¿Traga sin masticar? ¿Necesita que le alcancen todos los alimentos a la boca o los toma solo? ¿Necesita que los colores y las texturas estén separados en el plato?

Muchos profesionales pueden hacer observación en domicilio de cómo come una niña o un niño, dado que es el lugar habitual de alimentación.

En el consultorio se puede evaluar también, pero es más complejo y menos sensible porque no será igual a lo que pasa en la casa. Una filmación de esos momentos también nos puede ayudar.



En ocasiones las infancias no toleran que los alimentos se toquen o mezclen, y prefieren que estén separados en el plato.

¿Cómo reacciona frente a diferentes alimentos y texturas?

Ante un alimento puede haber diversas respuestas que tienen que ver con la edad y el desarrollo del niño o la niña: entusiasmo, aceptación, charlar un rato sobre qué alimento es, nombrar el color y la forma, relacionarlo con algún personaje querido (como los Minions y las bananas, por ejemplo), tocarlo y no comerlo, llevarlo a la boca, tocarlo con los labios, volverlo a dejar en el plato. En todos estos casos hay acercamientos al alimento, aunque nos parezca que no. El hecho de llevarlo a la boca también lo acerca a la nariz y es interpretado así por varios sentidos.

También puede haber otro tipo de respuestas: empujar el plato con las manos, llanto intenso, arcadas y vómitos ante la sola vista u olor de alimento. Estas respuestas pueden demostrar asco, miedo, desagrado e inclusive enojo.

Los niños que tuvieron intervenciones orales negativas (como expliqué antes) pueden mostrar desagrado intenso en la alimentación. Otros niños ni siquiera logran tolerar la visión del alimento, y lo corren con el dorso de la mano para no tocarlo.

Otros niños tienen realmente miedo a la alimentación, producto de experiencias traumáticas que pueden tener que ver con algún episodio de atragantamiento o de violencia con relación a la comida.

Saber cómo es la reacción ante el alimento es fundamental para

definir el tratamiento a seguir. En muchos de estos casos necesitaremos un equipo interdisciplinario de terapia ocupacional, psicología y pediatría como base.

Ambiente y familia a la hora de comer

La crianza respetuosa sitúa a las infancias como personas a las que hay que acompañar y respetar. La relación de niños y adultos es asimétrica: los niños no pueden actuar como cuidadores de los adultos, y tampoco de sí mismos, es el adulto o adulta quien tiene la responsabilidad de velar por su salud y bienestar. La alimentación, con todas sus áreas, es parte de esa salud.

Los adultos elegimos qué ponemos en la mesa de casa, qué les brindamos a los chicos, pero no podemos decidir qué cantidad comen o en cuánto tiempo lo hacen. Venimos de una crianza en la que el adulto parecía saber cuánto aguantaba nuestro estómago, al grito de: “Hasta que no comas TODO lo que hay en el plato, no te levantás”.

La comida ha sido usada como forma de violencia innumerables veces: irse a dormir sin comer, abrirle la boca a la fuerza al niño/a, introducir comida y obligarlo a tragar, inclusive obligar a comer vómito cuando este sucede como consecuencia del estrés, la angustia y la sobrealimentación. Y si todo esto les parece terrible, quiero que sepan que muchas veces inclusive se hace en nombre del amor. La frase: “Un bocadito más, hacelo por mí”, es un claro ejemplo. El miedo a que los niños y las niñas no coman y se enfermen es infinito, y pareciera que no importa qué ni cómo: tienen que comer.

Ni en la crianza ni en ninguna relación es opción la violencia. La comida no debe ser usada como un castigo y tampoco como un premio. El comprar un helado porque “se comió todo” solo genera que el niño o la niña pierda su autorregulación y coma solo por complacer al adulto/a. Si queremos comprar un helado ese día, hagámoslo, independientemente de “cómo” comió, sin ponerle una responsabilidad al niño o la niña, que es del adulto.

Los niños nos creen, tanto que si todo el tiempo decimos “a vos no te gusta esto”, “ella come muy mal”, “la verdad es insoportable para comer”, seguirán lo que les digamos. **No se opina sobre el cuerpo ajeno y no se**

opina sobre la forma de comer, y está bueno que les transmitamos este mensaje a los chicos también.

No es raro que los niños y las niñas se bajen de la mesa y vayan a la heladera o a la alacena a buscar otro alimento que les gusta, o reclamen que se les cocine otra cosa, sobre todo después de los 2 años. Y ahí viene una de las tareas más difíciles de la mapaternidad: construir límites. El límite no es un reto, ni un castigo, ni algo negativo. No podemos complacer todos los deseos del niño o la niña porque allí se juega su salud.

Necesitamos límites. Un límite es algo frustrante, algo que no se le da, generando una situación de conflicto necesaria para el neurodesarrollo. Podemos construir un límite explicando que no, no se va a poder hacer otra comida. **¿Habrá enojo? Sí, es posible y saludable: esa infancia está aprendiendo a expresar sus deseos y descontentos. ¿Cómo acompañamos ese enojo? Validando y reforzando el límite amorosamente: “Yo entiendo que querés comer otra cosa, pero ahora preparamos esto”.** ¿Esto funciona? Si por funcionar esperamos que los chicos digan: “Ah, ahora entendí, padre”, y se sienten a la mesa, no, no lo creo sinceramente. Si por funcionar pensamos en una construcción a largo plazo, sí, ahí tenemos un punto.

Solo come lo que le gusta... ¿Tengo que cocinarle otra comida?

Si los chicos no quieren comer la comida pero aceptan una fruta, puede ser una opción dársela, pero cocinar un menú “especial” diferente al del resto de la familia no es algo que se recomienda. Sobre todo porque se perpetúa en el tiempo. Que nos acompañen en la cocina a hacer la comida desde muy pequeños es una gran estrategia para evitar esto: el involucrarse en la preparación del alimento y elegir qué especias poner o qué tomate cortar genera mayor aceptación posterior.

¿Quién más opina sobre la alimentación?

Ay, las opiniones ajenas. Sobre cuánto come, sobre qué come. Si le das cosas sanas, “no lo dejás ser feliz”; si aparece una golosina, “cómo le vas a dar

eso”; si tienen una discapacidad, “pobrecito, encima le restringís cosas ricas”; si tiene una alergia alimentaria, “un poquito no le va a hacer nada”.

Las familias luchamos cuerpo a cuerpo contra las opiniones ajenas. “Si siempre se hizo así, ¿por qué querés hacerte la moderna?”. No es casual que lo escriba en femenino: si bien muchos varones están muy involucrados en la alimentación de sus hijos e hijas, en las consultas es muchísimo más común ver mamás muy informadas tratando de “convencer” al padre y al resto de la familia de lo que están haciendo. Y cuesta, y agota, y a veces dan ganas de tirar todo por la borda... Sobre todo cuando vuelven de la casa de los abuelos con un juguito y un huevito con sorpresa.

Mi maestra en Formación de Masaje Infantil, Lis Muñoz, me enseñó algo excelente para estos momentos. Ella coordina grupos de abuelos y abuelas, en los que intercambian estas cuestiones. **“No estaba mal lo que hicimos antes, simplemente es antiguo”, es su frase de cabecera, entendiendo que el conocimiento avanza y sí, las cosas cambian todo el tiempo.** Esa frase es fundamental. No es que ellos hicieron las cosas mal. No es que “hicimos todo mal con nuestros hijos mayores”, como nos suelen referir las familias. Ahora se saben cosas que antes no se sabían. La ciencia avanza y la humildad ante ella es fundamental.

¿Qué comemos nosotros? ¿Cómo es nuestro recorrido alimentario?

Qué fuerte. Entre que hemos sido educados y educadas para terminar el plato, y luego para comer lo menos posible –sobre todo las mujeres, para estar delgadas y entrar en el talle único–, nuestro recorrido alimentario como adultos es una montaña rusa.

Hemos perdido la autorregulación, el deseo y la noción de qué es placentero o no. Multitud de personas adultas tienen trastornos de la conducta alimentaria desde muy pequeños, sus intestinos están enfermos y no conozco casi ningún adulto que no tenga algún problema gastrointestinal, tome medicación para la acidez, la hipertensión, la migraña y otras múltiples dolencias.

Existen muchísimos adultos con trastornos sensoriales no diagnosticados

con relación a la alimentación. No tolerar texturas, olores ni sabores, no poder masticar una manzana, no lograr definir cuál es su alimento favorito, elegir comidas de un solo color o con textura de puré solamente, aceptar menos de diez alimentos siendo todos ultraprocesados... Todo esto lo vemos en muchísimas familias, solo que hay que tomarse el tiempo para indagar. Mientras seamos productivos para un sistema de trabajo, al sistema no le importa cómo nos sintamos o cómo se deterioran nuestros cuerpos. Pero **cuando las dificultades de los adultos impactan en la alimentación de los chicos, ahí muchas personas empiezan a tomar conciencia de la importancia de desandar su propio recorrido.**

Si en casa solamente hay ultraprocesados, o el adulto solo come ultraprocesados, la alimentación de los chicos, por buena que sea los primeros seis meses de alimentación complementaria, no será de otra manera a largo plazo. No podemos pedirles que coman verduras si nosotros no comemos verduras.

De allí parte el ver **a la alimentación complementaria como una oportunidad para toda la familia**, y dejar de hablar de alimentación infantil y empezar a hablar de alimentación familiar. Muchos nutricionistas abordan la consulta desde esta premisa: conocer a todos los miembros de la familia y trabajar familiarmente con las particularidades y los gustos de cada uno.

Algunas familias establecen un tiempo de alimentación para los niños y las niñas, sobre todo cuando son pequeños o cuando “comen mal”, y otro para el resto de los integrantes. **Como aprendemos a comer por imitación, compartir todos la mesa puede ser una buena estrategia ante dificultades alimentarias.**

La suciedad

Hemos sido educados y educadas para la prolijidad y la pulcritud, tanto que lo transmitimos a las niñas y los niños. Hay familias que apenas se le escapa algo de la boca, se la limpian con una servilleta o “limpian” con una cucharita el borde del labio, o no le permiten tocar con las manos para no ensuciarse. **Pero explorar y experimentar con la comida es parte del desarrollo normal, independientemente del método elegido para empezar a comer.**

También es normal que a los niños en edad preescolar y escolar se les

caigan alimentos o se les ensucie la ropa. La motricidad gruesa y la fina aún están en desarrollo, y no lo hacen a propósito ni para molestar. Sí, sé que es una fiaca lavar montañas de ropa (me pasa), pero la mugre se lava y en algún momento se terminará el ensuciarse toooooo el tiempo.

Pantallas

Las pantallas son todo un tema, siempre. Pero a la hora de la comida, más aún. “Si le pongo los dibujitos, come todo”, es una frase común, porque nos importa generalmente más la cantidad que cómo come. Las pantallas embotan los sentidos, los niños no miran ni escuchan el alimento (sí, dije “escuchan”. En la comida hay sonidos, el tenedor sobre el plato, el crujir del alimento en la boca, la voz de mamá...), sino la tele. Ya lo comenté en el capítulo 7 sobre alimentación complementaria, pero lo refuerzo, pues algunas dificultades en la alimentación, ya sea con relación a comer mucho o poco, tienen que ver con la presencia continua de pantallas.

Afuera de casa

El “afuera” de casa, sobre todo la escuela, es un dolor de cabeza para muchísimas familias. Hacen faltas claras políticas gubernamentales para evitar la sobreexposición a alimentos no nutritivos, y altos en sal y azúcar, y que no tenga que ser una lucha individual de cada familia, teniendo a veces inclusive que solicitar notas al pediatra con condiciones que los niños no tienen para que no les den lácteos antes del año o vainillas dos veces por día.

El rol de la institución educativa en alimentación es fundamental para el crecimiento y desarrollo. Cada vez hay más escuelas trabajando por esto, y más familias y docentes aprendiendo juntos para darles a los chicos una mejor alimentación.

En el capítulo “Alimentación complementaria: guía práctica” hablo, más adelante, de comer fuera de casa con infancias. **Ir a comer afuera no es una actividad diseñada para niños y niñas, y pueden sentirse abrumados por**

el nuevo lugar, con mucha información en su entorno que les cuesta procesar. Esto puede suceder en un restaurante, pero también durante la visita a un familiar. Es muy posible que fuera de casa coman menos, no coman nada, o que no puedan quedarse en la mesa, y todas son cuestiones para acompañar con paciencia. Hablar con los otros adultos y recordarles que son adultos muchas veces es muy necesario, porque a veces aparecen frases como: “Ah, ella siempre come mal”, “Nunca comés nada”, “No le gusta nada”, o mucha insistencia sobre la alimentación, que causan un gran impacto en las niñas y los niños... Porque las infancias nos creen, y realmente creen que son así solo porque lo decimos.

Es común también que en casas ajenas y en otros ámbitos como la plaza le ofrezcan alimentos que no se consumen en casa, como galletitas o golosinas. Esto muchas veces aparece como conflicto, porque genera un choque: la otra persona está ofreciendo con cariño ese alimento, y rechazarlo es tomado como signo de descortesía.

No hace falta dar demasiadas explicaciones. Poner un límite puede ser una actividad amorosa. No hace falta enojarse, simplemente decir: “No, gracias”, y si nos preguntan por qué, decimos: “Porque no comemos eso”, pero no como una declaración de principios ni un juicio de valor a lo que consume el otro, solo ejerciendo nuestro derecho a poder elegir. Si la otra persona pregunta con interés (y respeto), podemos compartir información para que esa persona pueda procesarla, con sus tiempos, y tomar sus propias decisiones informadas

Estar bien sentados para comer bien

Si la silla genera mucha incomodidad, podría ser una dificultad para la alimentación. **Tener los pies colgando, no poder apoyarlos, quedar muy abajo de la mesa o no poder apoyar la espalda, distrae la atención y no permite dedicarla al alimento.** Como ya conté en el capítulo 5 sobre desarrollo, apoyar los pies es importante para masticar y tragar.

Es esperable que los deambuladores quieran pararse, salir de la silla, ir y venir. Es una necesidad de movimiento a la que hay que estar atentos: lo necesitan realmente. Se les puede permitir deambular, también pueden comer parados, por ejemplo, en una torre de aprendizaje en la mesa, como si fuera

su sillita. Otra opción es bajar a su nivel y armar pícnic, o comer en una mesita baja con él o ella.

En niños y niñas con discapacidad motriz que compromete el tono muscular, la posición al comer es aún más importante para evitar aspiración del alimento o posturas que causan dolor o malestar.

Trastornos de la conducta alimentaria (TCA)

La definición de “trastorno de la conducta alimentaria” es, al día de la fecha: una alteración persistente en la alimentación o en el comportamiento relacionado con la alimentación que lleva a una alteración en el consumo o en la absorción de los alimentos y que causa el deterioro significativo de la salud física o del funcionamiento psicosocial.



Popularmente, cuando pensamos en trastornos de la conducta alimentaria, pensamos en la anorexia nerviosa o la bulimia, de predominio en la adolescencia, aunque hoy por hoy se observa a edades cada vez más tempranas. Pero los trastornos de la conducta alimentaria son más amplios, y

entre ellos se describe el TERIA (o ARFID, en inglés), el “trastorno de evitación/restricción de la ingesta de alimentación”. A diferencia de otros TCA, los pacientes con TERIA no tienen problemas con su imagen corporal, sino que evitan los alimentos por disgusto o temor. Se da entre los 9 y los 16 años, con un promedio de edad de 12,9.

Los TCA, cualquiera sea, tienen un trasfondo mucho más profundo que la comida en sí, de ahí la importancia de llegar a un diagnóstico, no como etiqueta, sino para lograr establecer un equipo empático y un tratamiento a medida de cada niño, niña o adolescente, y de sus familias. Los profesionales de salud mental y el médico de cabecera darán el primer paso en este tratamiento, pero el acompañamiento de otros profesionales, como nutricionistas, docentes e incluso terapeutas ocupacionales, será fundamental.

Algunos consejos generales:

- Bajar las expectativas con respecto a cuánto tiene que comer y cómo tiene que comerlo.
- El pediatra puede solicitar un registro de alimentos completo de un par de semanas, donde también se registren las actividades de la vida diaria, para poder evaluar los alimentos y las ingestas.
- Ofrecer alimentos sencillos y evitar ultraprocesados. ¿Puede que los consuman fuera de casa? Sí, pero si los tenemos en casa también, como ya mencionamos, directamente no hay opciones.
- No tener en casa lo que no queremos que coman.
- Recordar que a veces se requieren más de veinte exposiciones a un alimento antes de que los bebés, las niñas o los niños lo acepten.
- No obligar a comer ni correrlos por toda la casa con comida.

- Si se han descartado problemas de salud y el niño o la niña crece y se desarrolla correctamente, y aún la alimentación genera una gran angustia para la familia, considerar buscar apoyo de profesionales de salud mental.
- Ofrecer el ejemplo comiendo nosotros mismos alimentos saludables.
- Evitar más de 500 ml de lácteos de vaca diarios después del año, sin azúcar ni agregados (recordando que los lácteos son alimentos opcionales). Realizar el destete del biberón en forma respetuosa a partir del año es importante.
- Las dificultades en la alimentación no son sinónimo de tener que destetar.
- Evitar usar la comida como premio, castigo o soborno.
- Limitar el tiempo en la mesa. Ningún niño o niña puede quedarse sentado más de 20-30 minutos.
- Permitir el enchastre. Todo se limpia.
- La alimentación es patrimonio de la familia, y el entorno debe respetarlo.



- Las niñas y los niños con discapacidad o enfermedades crónicas deben contar con un equipo que tenga en cuenta sus gustos, la cultura de su familia y sus necesidades nutricionales, motoras y sensoriales para la alimentación.
- La compra de alimentos tiene que incluir a los chicos. La verdulería tiene miles de colores, tiene frutas que pinchan, otras que son lisas y pequeñas, que se pueden apilar, armar caritas, jugar a hacerlas rodar. Pararse un rato y repasar todos los nombres y los colores como primer acercamiento puede estar buenísimo.
- Dejar a los chicos jugar e involucrarse en la cocina es una herramienta fundamental en todas las abordajes de dificultades en la alimentación. En la cocina hay millones de texturas, la harina es finita y suave, los porotos son gorditos, el maíz explota con el calor y hace pochoclo, las arepas se doran suavemente en la sartén... Todo se transforma y es fascinante verlo.
- El contacto con la tierra y el conocer de dónde vienen los alimentos (inclusive observar y dibujar el proceso de semilla-germinación-siembra), genera curiosidad y expectativa, y nos ayuda en el proceso. En Jacarandá, el centro médico del cual soy codirectora, gracias a Lucrecia Michelotti, de @huertaslulu, armamos un hermoso cantero con aromas, texturas y colores de plantitas para trabajar durante las consultas y terapias.

Las dificultades en la alimentación, tengan como base alguna enfermedad o simplemente nuestras expectativas, nos agotan y nos frustran como adultos. Saber que muchos procesos son parte del desarrollo genera un poquito de alivio, y que cuando no es así, hay mucho para hacer, también.

Jor Barral (@losalvarezbarral) es mamá de cuatro. Atilio y Benito, dos de sus hijos, tienen Leigh-Surf1, una enfermedad que afecta sus mitocondrias, que son el motorcito energético de las células. Por esto, Ati y Beni se cansan mucho, tienen muchas terapias y por suerte tienen una gran familia que los acompaña a jugar y reírse (mucho, también). Ellos usan botón gástrico para parte de su alimentación y traqueostomía para respirar bien, y ayudan a

cocinar, doblar la ropa, hacer lío en casa y enseñarnos que siempre, en algún lado, hay disfrute. Jor nos cuenta:

Cuando Sabri me invitó a participar para su libro, pensé inmediatamente: “¡Sí, obvio! Yo debo hablar de este tema porque me marcó”. Y cuando me sentaba a escribir lo que sentía, la verdad es que no encontraba palabras positivas. Traté de entender por qué no me resultaba fácil hablar de comer: básicamente yo pensaba que alimentarse era sinónimo de comer... Un tiempo después descubrí que prácticamente todos mis recuerdos eran nefastos, y ahí comencé a encontrarle sentido a esta falta de palabras y a la negación de decir. Decir sobre un tema que realmente me marcó a mí, a mi familia y a mis hijos. A tal punto que nos modificó para siempre.

Corría el año 2000 y yo terminaba la secundaria enterándome de que estaba embarazada, así que en 2001 nació mi primer hijo. Yo vivía con mi madre, ella intentaba ayudarme, y yo intentaba contradecirla todos los días... Mi hijo Alejo se alimentaba a base de galletitas dulces, milanesas, arroz y alguna papa frita, yo odiaba cocinar y mi mamá odiaba no saber qué cocinar, en fin, un círculo vicioso. Comía poco, lloraba bastante, pero los percentiles eran buenos, y como eran buenos, la comida seguía sin variedad ni identidad. Alejo se enfermaba de marzo a noviembre desde muy bebé, y hasta que tuvo 5 años, hacía broncoespasmos a repetición. Hoy lo atribuyo bastante a la mala calidad de la comida y al calefactor, que mi mamá me decía todo el tiempo que lo baje. Catorce años después de esa primera experiencia, llegó Atilio. Como nos llevó mucho tiempo diagnosticar el síndrome de Leigh, en principio yo parecía una madre como otras, que no daba en la tecla con la comida: tenía que hacer todo papilla, no habíamos podido sostener el pecho más de seis meses, daba leche en mamadera y chupete, el método BLW lo hacía ahogar, pensaba que todo lo estaba haciendo mal, juzgada por otros y por mí misma...

Fueron años durísimos, hasta que llegó el diagnóstico, la sonda de alimentación, la traqueostomía y todo lo que esas tres cosas en conjunto nos trajeron. Un tsunami de aprendizajes y de

profesionales en el recorrido, una transformación familiar y personal que aún está en proceso... Darle de comer a tu hijo y que tu hijo no coma es un proceso triste y angustiante. Puedo decir que hoy, después de cinco años y dos diagnósticos, el de Atilio de 6 años y el de Benito de 3 años (mellizo de Amalia, una excelente comensal y *coucher*), aprendí a ALIMENTAR a mis hijos, a llenarles la panza de amor, de paciencia, de dedicación; de sentarnos todos a la mesa; de hacer el lugar para la silla de ruedas en la mesa del restaurante; de cocinar la comida para la gastro y de buscar alternativas con consistencias seguras para la boca; de ponerles plato y cubiertos aunque no los usen; de usar recursos para disfrutar el momento de dar de comer en el formato que sea; de divertirnos; de pasarle compota en el recreo de la escuela haciendo ronda con sus compañeros que también meriendan, porque ahí también alimentamos: alimentamos a otros mostrándonos; de investigar y estudiar; de leer a otros padres y sus experiencias. También agradecer tener esta oportunidad que se renueva todos los días, la de tener un plato de comida (agradecer fuerte con cantos y tomados de las manos); aceptar sabiendo que tal vez no sea para siempre el placer del gusto de Ati pero que hoy está, entonces se disfruta de esa sonrisa y de esa boca abierta bien grande; y se sostiene como corresponde la cara de asco de Benito cuando se mete el primer pedacito de uva en la boca. Les deseo a todos los padres paciencia, y nunca jamás rendirse. Los chicos con el tiempo mejoran la calidad de sus comidas, pero somos nosotros realmente los que enseñamos a alimentarse. Les deseo la posibilidad de la dedicación y el encuentro de profesionales adecuados, que nos acompañen y que no nos pongan trabas, que confíen en nosotros y que no abandonen, o que abandonen si eso nos deparará un mejor futuro.

Para seguir leyendo

PARA FAMILIAS

- Curso *online* Neofobia y Selectividad. Escuela Argentina de BLW, 2021.
- Troncoso, L. *Los primeros 1000 días de tu hijo*, Planeta Argentina, Buenos Aires, 2019.
- Basulto, J. *Se me hace bola. Cuando no comen como queremos que coman. It Gets Complicated: When They Don't Eat How We Want Them to Eat*, Debolsillo, Barcelona, 2021.

PARA PROFESIONALES

- Shim, J. E.; Kim, J.; Mathai, R. A. (2011). STRONG Kids Research Team. Associations of infant feeding practices and picky eating behaviors of preschool children. *J Am Diet Assoc*, 111(9):1363-8. DOI: 10.1016/j.jada.2011.06.410. PMID: 21872699.
- Dovey, T. M.; Staples, P. A.; Gibson, E. L.; Halford, J. C. (2008). Food neophobia and 'picky/fussy' eating in children: a review. *Appetite*, 50(2-3):181-93. DOI: 10.1016/j.appet.2007.09.009.
- Disantis, K. I.; Collins, B. N.; Fisher, J. O.; Davey, A. (2011). Do infants fed directly from the breast have improved appetite regulation and slower growth during early childhood compared with infants fed from a bottle? *Int J Behav Nutr Phys Act*, 17;8:89. DOI: 10.1186/1479-5868-8-89.
- Carruth, B. R.; Ziegler, P. J.; Gordon, A.; Barr, S. I. (2004). Prevalence of picky eaters among infants and toddlers and their caregivers' decisions about offering a new food. *J Am Diet Assoc*, 104(1 suppl 1):s57-s64. Recuperado de: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14702019/>
- Carruth, B. R.; Ziegler, P. J.; Gordon, A.; Hendricks, K. (2004). Developmental milestones and self-feeding behaviors in infants and toddlers. *J Am Diet Assoc*, 104(1 Suppl 1):s51-6. DOI: 10.1016/j.jada.
- Curso *online* Feeding Littles, 2020.
- Curso *online* Inapetencia Infantil y Aversiones Alimentarias. Esfera Maternal, 2020.
- Curso *online* Pesquisa de Trastornos de la Deglución y la Conducta Alimentaria en Lactantes y Niños Pequeños. Abordaje interdisciplinario. Hospital Garrahan, 2019.
- II Jornada de Actualización en Disfagia y Conducta Alimentaria del Niño Pequeño, 21 y 22 de noviembre de 2019. Hospital Garrahan.

- Maiz, E.; Maganto, C.; Balluerka, N. (2015). Neofobia y otros trastornos restrictivos alimentarios en la infancia y consumo de frutas y verduras. *Revista Española de Nutrición Comunitaria* (pág. 150-157). DOI: 10.14642.
- Shim, J. E.; Kim, J.; Mathai, R. A. (2011). Associations of Infant Feeding Practices and Picky Eating Behaviors of Preschool Children. *Journal of the American Dietetic Association*, 111(9), 1363–1368. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jada.2011.06.410>.
- Beaudry Bellefeuille, I. (2014). El rechazo a alimentarse y la selectividad alimentaria en el niño menor de 3 años: una compleja combinación de factores médicos, sensoriomotores y conductuales. *Acta Pediatr Esp*, 72(5): XX. Recuperado de: <https://www.actapediatrica.com/index.php/secciones/nutricion-infantil/973-el-rechazo-a-alimentarse-y-la-selectividad-alimentaria-en-el-nino-menor-de-3-anos-una-compleja-combinacion-de-factores-medicos-sensoriomotores-y-conductuales#.YRUzVxNKhQI>
- Green, R. J.; Samy, G.; Miqdady, M. S.; Salah, M.; Sleiman, R.; Abdelrahman, H. M. A.; Al Haddad, F.; Reda, M. M.; Lewis, H.; Ekanem, E. E.; Vandenplas, Y. (2015). How to Improve Eating Behaviour during Early Childhood. *Pediatric Gastroenterology, Hepatology & Nutrition*, 18(1), 1. DOI: <https://doi.org/10.5223/pghn.2015.18.1.1>.
- Canale, M. I.; Gaitán, B.; Lucero, M.; Sommaro, E.; Shakespear, S. (2018). Trastorno de evitación/restricción de la ingesta de alimentos: un nuevo nombre, un viejo trastorno. Escuela de Nutrición. Universidad de Buenos Aires. *Revista Nutrición Investiga*. Recuperado de: <http://escuelanutricion.fmed.uba.ar/revistani/pdf/18b/rb/826c.pdf>

Alimentación en la etapa escolar y la adolescencia

Oiga... ¿ha visto por ahí a mi bebé?

Ese que me necesitaba todo el tiempo
y cuyos puñitos yo besaba.

Ese que se acurrucaba en mi pecho
y hoy ya no me entra en el cuerpo.

Ese que necesitaba que le pusiera el
pantaloncito y ahora

YO SOLO MAMÁ.

Ese con olor a fantasma de algodón,
ese que hacía burbujitas...

y ahora juega online con amigos.

Paso a paso, los días pasan
y hoy no es siempre.



Muchas familias se encuentran con la información sobre alimentación y hábitos saludables en su segunda o tercera mapaternidad, y es muy común escuchar frases como: “Con el primero hicimos todo mal y ahora es imposible que no coma ultraprocesados” o “Le dábamos cereales ultraprocesados como comida dos veces por día”.

Déjenme decirles algo: no hicieron “todo mal”. Hicieron lo mejor que podían hacer con la información que tenían. Lo que sabemos hoy día sobre los ultraprocesados no tiene demasiados años, y todavía en muchas universidades se siguen formando profesionales para indicar vainillas y un casete de queso fresco en las comidas. Ustedes hicieron lo mejor desde el absoluto amor y la falta de información profesional y cultural que manejamos como sociedad. Así que adiós culpa, que no colabora en este proceso.

No hay manera de hacer “todo bien” ni “todo mal”. **Hay cambios que son urgentes tomar sobre nuestras decisiones alimentarias, porque ahora sí sabemos que muchos productos dañan nuestra salud.**

Y sí, con los niños y las niñas en edad escolar y con los adolescentes es más difícil, porque salen del ámbito hogareño y están en espacios fuera de nuestro control. Eso está bien, porque viven en una sociedad y aprender a relacionarse con otras personas es importante. Pero hay mucho por hacer, y no caigamos en el “no se puede, ya fue”, porque nosotros seguimos siendo los responsables de la salud de esas infancias y somos los que elegimos qué alimentos traer a casa. Siempre se puede hacer algo. Siempre.

El dilema del des-ayuno. “Colaciones”, viandas escolares y el kiosco

El desayuno es la comida que rompe el ayuno, generalmente después de la noche. Con los bebés no suele haber mayor problema: desayunan teta, o

alguna fruta, o algo pequeño, y siguen el día. El tema con niños, niñas y adolescentes es que suele ser el preludio de actividades escolares o deportivas, y hay mucha insistencia acerca de que “es la comida más importante del día”.

Pues no, **el desayuno no es la comida más importante del día. Muchas niñas y muchos niños rechazan desayunar porque sencillamente no tienen hambre y su ritmo circadiano (los cambios que va sufriendo nuestro metabolismo durante el día) no les pide alimento en ese momento.** Entonces aparece la insistencia, el ofrecer chocolate para que se tomen sí o sí la leche, enojos, gritos, productos azucarados... ¡Todavía puedo sentir las náuseas que me provocaba tragar un vaso de leche fría antes del colegio a la mañana! No se obliga a comer. Nunca, tampoco en el desayuno, aunque nos preocupe posteriormente el rendimiento escolar. Otra cosa es cuando no hay desayuno que ofrecer, ahí hay un derecho vulnerado y una grave falencia estatal y social.

¿Y qué pasa cuando van al colegio por la mañana y no desayunan? Está bueno hablar con los chicos y ver qué les pasa. Si ellos se sienten bien, no habría problema en que no desayunen al momento en que se levantan. Si ellos no se sienten bien, tal vez tengamos que pensar en trabajar para modificar las rutinas de sueño, levantarnos un poco más temprano y ver si más cerca de la hora de entrar a la escuela les da un poco de hambre.

Un recurso muy útil es la vianda para el recreo. Nos hacen creer que el recreo es para snacks, y tal vez para algunos chicos es el verdadero momento del desayuno. El desayuno no tiene por qué ser una infusión y un panificado: podemos mandar preparaciones con legumbres, que les dan hierro y proteínas (ver el capítulo 14, ¡tiene muchas recetas!), tortilla de la noche anterior, frutas cortadas, frutas asadas, frutas deshidratadas, chipá, pan tostado con unas gotitas de aceite, fainá, milanesa cortada... Opciones de comida de verdad, que aporten nutrientes a ese cuerpo y esa mente en crecimiento.

Sí, ya sé: el kiosco. Cuando los chicos empiezan a salir de casa, aparece este elemento en el panorama, un sitio lleno de paquetes de colores, promesas de sabores y al que “todos van”. Es muy importante para los chicos esa cuestión de pertenencia, sentirse que son parte de los “grandes” que van a comprar “solos”. El problema es qué se ofrece en ese kiosco.

La ley de etiquetado frontal –que al cierre de este libro se estaba debatiendo legislativamente en la Argentina– incluye la regulación de los

entornos escolares, además de incorporar sellos negros de advertencia a los productos con exceso de azúcar, grasas, calorías, sodio y endulzantes artificiales: si un producto tiene sellos, no se podría vender en entornos escolares. Es interesante escuchar lo que relatan colegas chilenos: en ese país, los chicos comparan en el recreo los productos que llevan, y es menos *cool* tener algo que tiene más sellos. Esto genera una educación cultural de los componentes de los alimentos que ayuda a tomar mejores decisiones.

El kiosco no tiene por qué ser un “mal lugar”, pero tenemos que trabajar mucho para evitarlo. Estando en un entorno escolar, es parte de la educación de esas infancias, y es también responsabilidad de nosotros, mapadres, y del equipo docente respetar los derechos de las infancias y promover la “bien nutrición”.

Para la promoción de una nutrición saludable en la escuela, la OMS recomienda:

- Establecer regulaciones para que las comidas que se ofrecen en las escuelas, o para los alimentos y las bebidas que se venden en ellas, cumplan con las directrices sobre una nutrición sana.
- Eliminar en entornos escolares el suministro o la venta de alimentos no saludables como las bebidas azucaradas y los alimentos de alto contenido calórico y bajo valor nutricional.
- Garantizar el acceso a agua potable en las escuelas y los centros deportivos.
- Exigir que se incluyan actividades educativas sobre nutrición y salud en el plan de estudios básico de las escuelas.
- Mejorar los conocimientos básicos y competencias de mapadres/cuidadores en materia de nutrición.
- Ofrecer clases sobre preparación de alimentos a niños y niñas, sus padres, madres y cuidadores.
- Desarrollar el currículo de nutrición y educación alimentaria en colaboración entre los sectores de salud y educación. Capacitar docentes e integrar la educación en nutrición en los contenidos nucleares.
- Usar los jardines y las huertas de la escuela como instrumento para concientizar a niños y niñas sobre el origen de los alimentos.
- Fomentar la participación de mapadres y de la comunidad en

las actividades educativas.

Sin duda, queda mucho camino por recorrer, sobre todo en esta época de pandemia COVID-19. El acceso a agua segura, la adaptación de contenidos escolares hacia la salud y la presencia de mapadres –que trabajan todo el día– en contextos escolares, no es algo tan sencillo como enumerar una serie de consejos. Será un trabajo de conciencia de años, largo, pero que es necesario atravesar. Lo “poco” –que nunca es poco– que podamos ir haciendo, puede ser la diferencia en la salud de las niñas y los niños a corto y largo plazo.

Propuestas para la escuela

- Invitar a profesionales de la salud a charlar sobre la importancia de la alimentación saludable con personal de la escuela y familias. Inclusive se puede ofrecer en forma virtual.
- Invitar a compartir recetas de las familias todas las semanas.
- Jugar a armar viandas saludables con los chicos, proponiendo diversas frutas, verduras y otros componentes.
- Hacer un calendario de frutas de estación y qué preparaciones podemos hacer con ellas.
- Existen iniciativas muy positivas como “el día saludable”, el problema es que plantear que un día es saludable implica que el resto de los días no lo son, y no podemos resignarnos a ello. También a veces creemos que ciertos alimentos son saludables (los aritos de “cereal” de “frutas”, por ejemplo) y no lo son. Plantear el concepto de que el día saludable son todos los días, y la comida puede ser rica y saludable, es muy importante.
- Escuchar a las familias acerca de sus dificultades con relación a la alimentación saludable. ¿Tienen la información correcta? ¿Están interesadas en un cambio? ¿Tienen acompañamiento del pediatra, médico de familia o nutricionista?

Involucrar a los chicos y chicas constantemente en la cocina es una experiencia digna de ser vivida. Algunos pueden poner cara aburrida al

principio, pero a la larga se copan. Que aprendan a usar los utensilios, las harinas, los polvos misteriosos que hacen levar, mezclar levadura con bicarbonato y vinagre para hacer un volcán, hacer formas de galletitas monstruosas, bañar frutas en chocolate, hacer pinchos de verduritas... son todas opciones piolas para cocinar y a la vez involucrarlos con los alimentos. Tener un plantita en el balcón, aún más.

- ¿Qué hacemos si le mandamos alimentos saludables pero se quiere comer las galletitas del compañero en vez de la fruta? Es lógico, esas galletitas tienen todos los ganchos sensoriales para ser deseadas y comidas. No, no vamos a poder evitar que coman cada tanto una galletita, pero si nos resignamos y también mandamos galletitas, los chicos no tienen opción. Y contar con la opción del alimento saludable es fundamental.

- ¿Qué hacemos si en el jardín solo sirven galletitas? Justamente, podemos proponer algunos de los puntos ya mencionados explicando por qué no son una opción saludable. En la bibliografía de este libro hay abundantes documentos que pueden respaldar por qué tomamos ciertas decisiones alimentarias, aunque en realidad no deberíamos rendirle explicaciones nadie: la alimentación es patrimonio de la familia. Muchas veces los pediatras hacemos certificados para explicar esto a las escuelas. Suelo poner como diagnóstico: “Niño/a sano/a que desea seguir siendo sano/a”, pero no es aceptado y me sugieren certificar alguna condición como una alergia alimentaria para evitar darle al niño/a los alimentos que son insanos. Un certificado es un documento legal y no puede falsear información, así que es complicado ese tipo de acompañamiento. También genera una situación de exclusión, el niño/a que “come diferente” cuando en realidad todos los niños y las niñas de esa institución tienen el mismo derecho a que sus cuerpos reciban alimentos reales y no ultraprocesados.

• ¿Qué hacemos con los cumpleaños? ¿Le mandamos un *tupper* aparte? Ante todo, es interesante ver la mutación de los cumpleaños infantiles. Si bien siguen incluyendo mucha azúcar y productos de copetín, ya encontramos más frecuentemente opciones saludables como rueditas de choclo, zanahorias *baby*, tomates *cherry* y frutas. Muchas familias están deconstruyendo su patrón alimentario y se nota realmente ese esfuerzo colectivo. Pero si no es el caso, hay que evaluar la situación. A un niño o una niña no lo va a enfermar crónicamente comer una torta en el cumpleaños de su primo, sino el consumo constante de productos ultraprocesados durante todos los días de su vida desde temprana edad.

La alimentación “ideal”

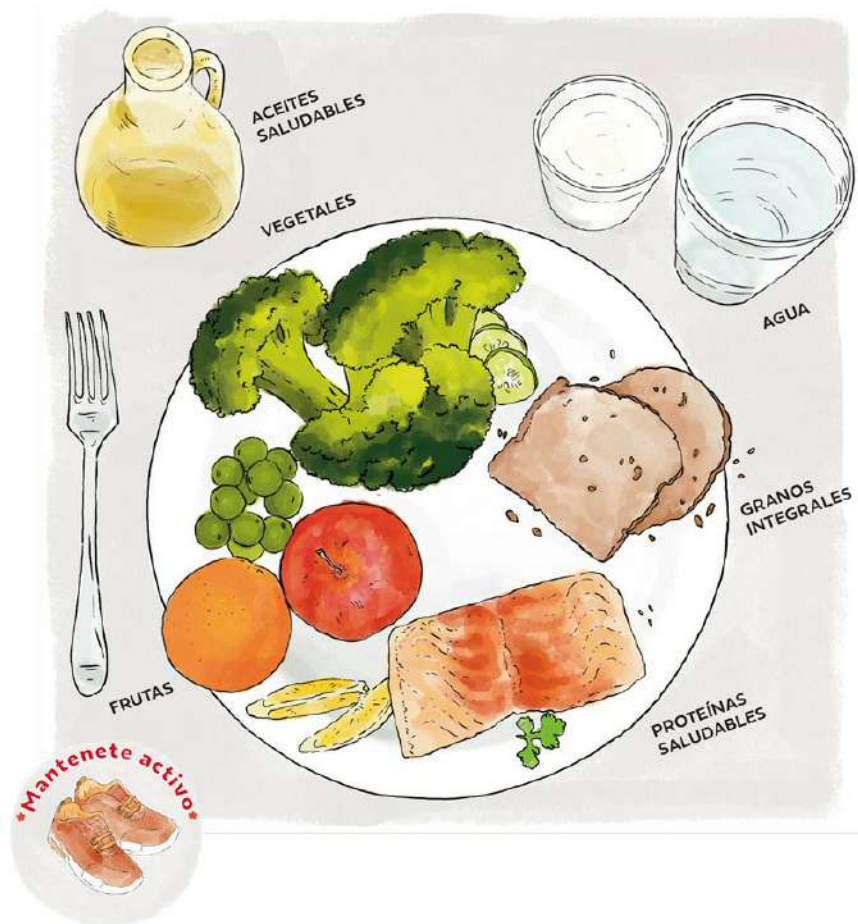
Como todo lo ideal, la “alimentación ideal” no existe. No se va a arruinar la microbiota, ni los dientes, ni el paladar de un niño o una niña porque en la escuela le convidaron algo que en casa no consumimos. **¿Queremos que lo consuma? Para nada. “¿Un poquito no pasa nada?”. Tampoco: nadie debería sugerir el consumo de esos productos.** Pero estamos en un proceso de deconstrucción cultural, y los niños y las niñas forman parte de la sociedad, entonces van a estar expuestos a estos productos. A pesar de que pasen mucho tiempo en la escuela, por ejemplo en situaciones de jornada completa o doble escolaridad, la comida de casa siempre será la más importante, junto con el ejemplo que demos los adultos convivientes.

La alimentación saludable es un derecho de todas las infancias. Muchos niños y niñas comen en comedores o en ollas populares, o dependen de los bolsones de comida que entrega el Estado. Esa comida suele ser de escasa calidad, y está generando que miles de personas se enfermen. Es urgente cambiar esto, jerarquizar el impacto nutricional, actualizar las guías alimentarias y asegurar una salud para todos y todas.

Los nutrientes

Sin variar demasiado del plato del cual venimos charlando para niños y niñas más pequeños, **el plato del escolar incluye básicamente lo mismo: alimentos ricos en hierro y proteínas, frutas y verduras, y alimentos ricos en energía.** Se sugiere que medio plato incluya frutas y verduras, y el resto, granos enteros (legumbres, cereales integrales) y otras proteínas.

- **Mientras más vegetales y más variados, mejor.** Colores y texturas diferentes aportan diferentes nutrientes. Es común que en algunos hogares solo se ofrezca papa, un poco porque los chicos la aceptan gustosos por las razones que ya hemos mencionado y otro poco porque es muy accesible económicamente, pero no se sugiere incorporarla todos los días ni en todas las comidas: necesitan otros nutrientes.



Adaptado de: © 2015 Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard. Para más información sobre El Plato para Comer Saludable para Niños, por favor visite la Fuente de Nutrición, Departamento de Nutrición, *Escuela de Salud Pública de Harvard*, <http://www.thenutritionsource.org>.

- **Las frutas siempre mejor enteras y no en jugo.** En niños y niñas en edad escolar fanáticos de los exprimidos, un vaso por día (unos 200 ml) podría ser aceptado en un contexto de una alimentación saludable, pero no es una sugerencia, al contrario.
- **Se sugiere ofrecer diversas variedades de legumbres y cereales, sobre todo integrales:** cebada, quinua, amaranto, avena, mijo, etc. (los pueden encontrar más adelante en este libro).
- **Es muy importante que la alimentación incluya legumbres y frutos secos.** ¡Hay mil formas de ofrecerlos! Recordar que para los menores de 4-5 años, los frutos secos enteros o en mitades son

peligrosos.

- **Si se consumen productos de origen animal, elegir en la medida de lo posible huevos de campo y carne de vaca y de pollo de pasturas.** Priorizar la carne de pescado. Limitar las carnes rojas y evitar los embutidos.
- **Las grasas son fundamentales para el desarrollo y el crecimiento infantil.** Evitar las grasas trans, consumir grasas saturadas en bajas cantidades y priorizar el aceite de oliva, chía y lino, los frutos secos, la palta y las semillas molidas como buenas fuentes de lípidos.
- **Para las familias que consumen lácteos, si existe la posibilidad de consumirlos con menor grado de procesamiento (siempre pasteurizados y con las correspondientes habilitaciones y trazabilidad), mejor.** No se sugieren más de 500-700 ml de lácteos totales (entre leche, yogur, queso, etc.) después del año de vida, y es importante incorporar otras fuentes de calcio además de los lácteos. No se sugieren en ningún caso las “leches de crecimiento” (leche 3, 4; “leche crecer”; “leche *preschool*”; etc.) ni los suplementos nutricionales sin indicación profesional.
- **Después de los 6 meses de vida, el agua es sugerida como bebida principal a cualquier edad.** Las gaseosas y los jugos (fluidos o de sobre) son un gran problema en la salud infantil, dado que tienen calorías vacías, inhiben la absorción de hierro, y generan un impacto en la microbiota, en el desarrollo y en la conducta.

El impacto de la anemia infantil

En la Argentina, la deficiencia de hierro es la causa más frecuente de anemia en el niño, especialmente en edad preescolar, con una prevalencia mayor del 35 % en menores de 24 meses. Esto se arrastra a la edad escolar y

a la adolescencia, y tiene que ver con la anemia materna, el corte temprano del cordón umbilical, las escasas tasas de lactancia y la poca oferta de hierro en los alimentos.

La introducción tardía de alimentos ricos en hierro, por ejemplo, legumbres o carnes, y la incorporación temprana de leche de vaca antes del año, más el consumo de infusiones, que compiten con el hierro e impiden su absorción, también son causas.

Un niño o una niña que come patitas de pollo industriales y puré cuatro veces por semana, no está teniendo ni de cerca el aporte de hierro que necesita. Es muy común encontrar en la edad escolar exceso de ingesta de leche y otros lácteos, y una alta cantidad de carbohidratos. Este tipo de alimentación, aunque pobre en hierro y otros nutrientes que intervienen en su absorción y metabolismo, es, por lo general, adecuada en calorías, lo que da como resultado un niño con deficiencia de hierro o anemia ferropénica, pero con peso normal, u, ocasionalmente, sobrepeso para su edad.

La anemia por falta de hierro puede causar múltiples síntomas, entre ellos, la falta de concentración, el escaso rendimiento escolar, la somnolencia, el dolor de cabeza, el cansancio y otros que tienen que ver en la incapacidad del glóbulo rojo de darle oxígeno a los tejidos. La hemoglobina, la proteína que se une al hierro, forma parte del glóbulo rojo y se encarga de esto último, lleva en su composición hierro. Cuando hay poco hierro en la dieta, hay menos hemoglobina.

El hierro también es un cofactor fundamental para el desarrollo del sistema nervioso, sobre todo en los primeros cinco años de vida. La falta de hierro durante esos años afecta la neurotransmisión.

El acceso a alimentos saludables y a consejos sobre alimentación es un derecho de las infancias para su neurodesarrollo.

Si ante síntomas decidimos realizar un estudio de sangre para evaluar la posibilidad de anemia, debemos pedir un análisis completo, evaluando también los depósitos de hierro. Si el análisis muestra anemia o deficiencia en los depósitos, además de ajustar la alimentación y pensar en la microbiota, debemos ofrecer hierro en suplemento, primero para tratar la anemia, y luego, justamente, para llenar esas reservas.

La publicidad antisalud

No elegimos nuestra comida por su calidad alimentaria. La elegimos por su publicidad. Y esto es clave en la época escolar, donde los chicos están más conscientes de lo que come el otro, del paquete con figuritas, del personaje de moda. La Fundación Interamericana del Corazón (FIC) hizo un análisis en 2017 acerca de la publicidad y las infancias:

- Casi nueve de cada diez alimentos que se publicitan durante los programas infantiles de TV tienen bajo valor nutritivo.
- Los postres (23,3 %), los lácteos (16,2 %), las bebidas azucaradas (13,2 %), las cadenas de comidas rápidas (12,5 %) y los *snacks* salados (7,9 %) son las cinco categorías de alimentos más publicitados.
- Se estima que los niños y las niñas argentinos están expuestos a más de sesenta publicidades televisivas de comida chatarra por semana.
- Una de cada cuatro publicidades de alimentos emitidas durante las tandas de los programas infantiles utiliza personajes animados y famosos, y una de cada tres de estas publicidades recurre a las promociones para publicitar los alimentos (como entrega de regalos, premios, sorteos, beneficios tipo “comprá uno y llevate uno gratis”, etc.).
- El 40 % de las publicidades apela a mensajes de salud y nutrición como “huesos fuertes” o “fuente de vitaminas y minerales”.

A esto hay que agregarle las publicidades de alimentos pocos saludables, leches de fórmula y medicamentos en revistas científicas y congresos profesionales. ¿Por qué la publicidad de medicamentos atenta a la salud? Porque las medicaciones tienen indicaciones específicas, y todas las medicaciones tienen efectos adversos. Como explicamos antes, también se generan alteraciones en la microbiota intestinal con las consecuencias que esto conlleva.

Estas empresas tienen inclusive una división de “ambientación de consultorios pediátricos”, donde regalan muebles, juguetes y papelería a diversos centros de salud. Cómo olvidar el diploma de “buen paciente” de Coca-Cola que regalábamos en el hospital a los chicos... Todas estas cuestiones impactan de alguna manera en nuestras decisiones, aunque creamos que no, y claramente si le entregamos una indicación a una familia en un papel con un membrete que dice: “La leche X es imprescindible para el

desarrollo mental de tu hijo”, estamos dando ese mensaje, aunque no sea nuestra intención.

La edad escolar es un target ideal para estas empresas, porque apelan al cariño que le tienen las niñas y los niños a ciertos personajes, películas e historias, y a la relevancia de compartirlo con sus pares. De aquí se desprende la importancia fundamental de la regulación de la publicidad de productos no saludables, como protección de las infancias. La ley de etiquetado frontal incluye regulación de estos entornos como punto principal.

Tamaño de las porciones

“Come mucho” o “come muy poco” son frases comunes en todas las consultas pediátricas. Y a medida que van pasando los años, sigue sucediendo. Aquí podemos diferenciar dos situaciones: si el niño o la niña consume habitualmente ultraprocesados o no.

Si los niños y las niñas tienen acceso a alimentos mínimamente procesados o no procesados, autorregularán su alimentación no importa la edad que tengan. A veces comerán mucho, cual pequeñas aspiradoras, y unos meses después, tal vez comerán un cuarto, para nuestra desesperación. En cambio, cuando consumen ultraprocesados, quizás consuman grandes cantidades de los mismos para después no comer otros alimentos. Aquí tendremos que trabajar en las dificultades en la alimentación, como podemos leer en el capítulo 9 sobre neofobia y selectividad.

El tamaño de las porciones varía de acuerdo con el hambre y la saciedad de los chicos. **Si ofrecemos alimentos saludables, confiemos en ellos. Si no, permitámonos buscar otras estrategias alimentarias para nuestra familia, de a poco.** El esfuerzo es gigante y siempre es desde el amor.

La importancia de la actividad física

Jugar, ejercitar y esparcirse es un derecho de las infancias y adolescencias.

Pero, además, es muy necesario para el correcto funcionamiento de los órganos, el cerebro, los huesos y los músculos. Hacer ejercicio al aire libre además ayuda a la exposición a la naturaleza, al aire fresco y al sol, y a la conversión de vitamina D en nuestra piel.

¿Qué hacemos cuando estamos en cuarentena? Una enorme pregunta muy compleja durante 2020 y 2021. Teletrabajo, clases *online*, la plaza lejos... Muchas veces apelamos a toda nuestra imaginación, pero es lógico que estemos “quemados” como adultos, con poca paciencia y mucho trabajo e incertidumbre.

Algunas opciones para hacer en casa:

- Correr los muebles para cambiar la disposición, y reconocer y habitar nuevos espacios en el hogar.
- Armar “carpas” entre dos sillas con una colcha y jugar a esconderse.
- Tirarnos todos en el piso, adultos e infancias, y jugar a pedalear en el aire al ritmo de la música.
- Jugar todos a rodar para un lado y para el otro con todo el cuerpo.
- Poner música que nos guste mucho y bailar.
- Hacer juntos clases de baile (hay muchas en Internet que son gratuitas).

Si podemos salir, hacer carreras, andar en bicicleta o triciclo, e ir a los juegos de la plaza, son opciones geniales y muy deseables para todos los días. Las plazas grandes guardan muchos secretos: en la que está cerca de casa tenemos “La Lomita” para bajar corriendo; “El Bebedero” (así, con mayúscula), que tira chorritos de agua; los bancos para trepar; los juegos para tirarse por el tobogán; muchas hojas en otoño para juntar y revolear al aire; una planta misteriosa y frondosa para escondernos... Todo puede ser un juego cuando dejamos un ratito el celular de lado y nos animamos a mirar.

Los deportes pueden ser practicados desde temprana edad como un hábito recreativo y saludable, siempre teniendo en cuenta los tiempos de esparcimiento y descanso de las niñas y los niños. No se sugiere la especialización deportiva antes de la pubertad, para garantizar un desarrollo armónico del sistema musculoesquelético, pero sí los espacios de iniciación deportiva, la socialización entre pares y los espacios de pertenencia.

Es común en niños y niñas de edad escolar y en adolescente el uso de videojuegos. Ya no tienen el cartucho de Sega para soplar en casa, sino que

los juegos son en línea y son espacios donde se encuentran y comparten. El problema es que muchas veces ocupan gran parte del día y generan sedentarismo. Entonces, **no desde la prohibición, sino desde el disfrute de otra variedad de experiencias, se sugieren construir límites al tiempo de pantallas. Respetar ese tiempo, que es importante para los chicos, preguntarles acerca de la experiencia de juego y aprendizaje (porque sí, también es un aprendizaje), y proponer otras actividades** al aire libre y experiencias deportivas o artísticas.

La pandemia de COVID-19 puso todo patas arriba y nos volvió a todos, a los chicos y a las chicas también, mucho más sedentarios, sin la posibilidad de salir de casa. Esto seguramente tenga mucho impacto en las enfermedades crónicas no transmisibles a corto y largo plazo. En el documento preliminar “Percepciones y Sentimientos de Niños Argentinos frente a la Cuarentena COVID-19” de la Sociedad Argentina de Pediatría, se plantean las siguientes percepciones:

- La mayoría de los niños, las niñas y los adolescentes revela que la escuela ocupaba gran parte de su vida (84,5 %).
- Resaltan las relaciones afectivas con sus respectivas familias y amigos (59 %).
- Los más pequeños (6 a 9 años) señalan más lo afectivo vinculado a una vida feliz y divertida (64,2 %).
- Los niños entre 10 y 14 años enfatizan el rol de la escuela y las actividades más rutinarias (89 %).
- Los adolescentes también destacan la escuela y una rutina diaria intensa: vida “activa”, “agotadora”, llena de actividades y que transcurrían la mayor parte del día fuera del hogar. Se sentían “libres” (84 %).
- Los niños, las niñas y los adolescentes han expresado mayormente sentimientos negativos –tristeza, desánimo, aburrimiento– respecto a la cuarentena (74 %).
- Quienes expresan felicidad o indiferencia en su mayoría (60 %), manifiestan que les gusta de la cuarentena la posibilidad de jugar videojuegos.
- El 60 % de los niños que empezaron a jugar rutinariamente a los videojuegos, asociaban su vida anterior a las actividades físicas. La mayoría de ellos señalan que la actividad física es una de las

principales actividades que extrañan de la vida anterior, por sobre las relaciones afectivas y las actividades al aire libre.

- “La tarea” fue la respuesta más frecuente cuando se les preguntó qué les producía enojo. El trabajo docente fue hercúleo y fundamental en estas épocas de virtualidad obligada, pero ante estos datos, sería interesante revisar esta indicación que genera tanto malestar.

Mientras escribo este libro, la pandemia aún no está controlada y los espacios de esparcimiento son mucho más limitados que hace unos años. Sin embargo, se abrieron las plazas, y si bien en forma intermitente, comenzó la escolaridad presencial, que les permite lugares de esparcimiento y encontrarse con amigos y amigas. Apostar al espacio público y al aire libre siempre que podamos es una importante recomendación.

Adolescencia: un mundo nuevo

La adolescencia es un período de enorme crecimiento y desarrollo. Este crecimiento vertiginoso se da en general entre los 10 y los 12 años en las mujeres, y unos dos años después en los varones (es muy variable individualmente). Es un período de mucha conciencia sobre la imagen corporal, donde el cuerpo varía de forma y la percepción del mismo influye en la autoestima y en la relación con los pares.

También es un momento en el cual hay un “despegue” de la familia, con la creación de otros espacios de pertenencia. Es muy importante el compartir con los pares, el involucrarse con el mundo exterior en la construcción de la propia identidad.

La alimentación en la adolescencia es compleja. Muchas veces comparten muchas comidas fuera de casa, con amigos y amigas, y suelen ser alimentos poco saludables. Como venimos planteando, es parte de salir a otros entornos y es esperable que esto suceda. Después, **dentro del hogar, sigue siendo nuestra responsabilidad no ofrecer alimentos que no sean sanos.**

Suele pasar que, además, los y las adolescentes salteen comidas, o arrastren una selectividad alimentaria desde la infancia. También el entorno influye en su percepción corporal, y en esta cultura de la dieta y de la

delgadez, no son pocos los adolescentes que inician dietas fuertemente restrictivas para perder peso, en detrimento de su salud. Los trastornos de la conducta alimentaria suelen evidenciarse en este momento de la vida.

“Si seguís comiendo pan, nadie te va a querer”, “Bajame unos gramitos más para el vestido de 15”, “Hay que llegar al verano”, “¡Qué linda que estás, cómo bajaste de peso!”... son frases muy comunes que solemos decir sin pensar, centrándonos en el peso y casi nunca en la salud. Por suerte estamos empezando a repensar estas cuestiones, y es fundamental trabajarlas desde el ámbito familiar y escolar, en el marco también de la Educación Sexual Integral. **No se opina sobre el cuerpo del otro, y no es una opción hacerlo.**

Que la alimentación sea un tema a tratar en ámbitos escolares desde el jardín de infantes nos permitiría que los adolescentes estén mucho más informados acerca de las elecciones alimentarias y de cómo impactarán en su vida presente y adulta. Es un período de mucho requerimiento nutricional porque el crecimiento es muy rápido, así que toda carencia de nutrientes tendrá un impacto a corto y largo plazo. Es un momento crítico para la salud ósea, por ejemplo.

Algunas sugerencias para esta etapa:

- **Darles información sobre su cuerpo y sobre su crecimiento.** No esperar la pregunta: esta puede incluso no aparecer, dado que hoy por hoy hay abundantes fuentes de información a mano, no siempre correctas. Y si bien hoy existe Internet, me recuerdo adolescente buscando info en el Encarta (¡qué *vintage*!) o en el diccionario Espasa Calpe, por no tener a quién preguntar. Así que la información, clara y certera, siempre.
- **Conocer qué están mirando nuestros niños, niñas y adolescentes en las redes.** Muchos *influencers* promueven dietas, suplementos y ayunos, o venden productos nutricionales sin fundamento científico.
- **Priorizar comidas en familia, las veces que sea posible.**
- **Involucrarlos en la cocina, con relación a sus gustos, y permitirles explorar sus habilidades.** Llevarlos a comprar ingredientes y que ellos los puedan elegir.

- **Continuar teniendo en casa alimentos sanos.** Incentivar el consumo de frutas y alimentos ricos en hierro, beber agua y evitar jugos, gaseosas y ultraprocesados.
- **La actividad deportiva es fundamental en esta etapa,** contribuye a un mejor desarrollo muscular y óseo, y a generar momentos de esparcimiento y grupos de pertenencia.
- **En niños, niñas y adolescentes con actividad deportiva es común que aparezca el pedido de “tomar suplementos”, también motivado por publicidades de referentes del deporte.** Explicar que antes de pensar en suplementos, hay que evaluar toda la alimentación.
- **Buscar canales en YouTube que les gusten a toda la familia y hablen de recetas, de alimentos o de cocina,** seguramente encontraremos intereses en común.
- **Tener acompañamiento de profesionales de la nutrición en esta etapa es muy importante.** Pueden concurrir solos a la consulta para poder hacer preguntas que a veces no se animan a hacer en presencia de los mapadres.
- **Escucharlos.** Comprender que ellos se van a equivocar al igual que nosotros nos equivocamos todo el tiempo, pero ofrecerles una base segura para buscar ayuda y consuelo.

La adolescencia es un gran desafío, como lo fueron los cólicos, los 2 años, el ingreso escolar y los múltiples hitos de la crianza. La alimentación en la adolescencia es una ventana de oportunidades para construir hábitos alimentarios para la edad adulta.

Para seguir leyendo

PARA FAMILIAS, aquí recomiendo distintos libros para leer junto a nuestros hijos e hijas, y trabajar en alimentación y salud:

- Grau, D. y Colombo, N. *Casamiento en la cocina*, Editorial Ojoreja-Pehuén, Buenos Aires, 2019.
- Browne, E. *La sorpresa de Nandi*, Editorial Ekaré, Caracas, 2019
- Lynch, A. *La vaca y la espinaca*, Editorial El Ateneo, Buenos Aires, 2019.
- Santecchia, J.; Borghetti, C.; Rijo, M. *Yo pregunto: Educación sexual desde los primeros años*, Editorial Chirimbote, Buenos Aires, 2019.
- Aladjidi, V. y Tchoukriel, E. *Inventario de frutas y verduras*, Editorial Faktoría K de libros, España, 2019.
- Alemany, E. Ilust. Wilhelm, J. *Amarillo limón el sol. Manual para cocinar con niños*, Editorial Periplo, Buenos Aires, 2014.
- Degliuomini, C. *El membrillo*, Editorial Periplo, Buenos Aires, 2018.
- Bilinkis, G. *Vida*, Editorial JA JE JI JO JÜ, Buenos Aires, 2020.

PARA PROFESIONALES

- Setton, D. y Fernández, A. *Nutrición en pediatría: Bases para la práctica clínica en niños sanos y enfermos* (1.a ed.), Editorial Médica Panamericana, Buenos Aires, 2014.
- Lorenzo, J.; Guidoni, M. E.; Díaz, M.; Marenzi, M. J.; Lestingi, M. E.; Lasivita, J.; Isely, M. B.; Bozal, A.; Bondarczuck, B. *Nutrición del niño Sano* (1.a ed.), Corpus, Buenos Aires, 2019.
- Lucile Packard Children's Hospital. (2012). Nutrición: edad escolar. *Stanford Children's Health*. Recuperado de: <https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=school-agedchildnutrition-90-P05389>
- Coalición Nacional para Prevenir la Obesidad en Niños, Niñas y adolescentes, con el apoyo de Unicef y la Federación Interamericana del Corazón. (2018). *Entornos escolares saludables: Recomendaciones para promover políticas escolares que prevengan la obesidad infantil en la Argentina*. Recuperado de: <https://bancos.salud.gob.ar/recurso/entornos-escolares-saludables>
- Sociedad Argentina de Pediatría. Subcomisión Derechos del Niño. Comité de Pediatría Social. (2020). *Percepciones y Sentimientos de Niños Argentinos frente a la Cuarentena COVID-19. Resultados Preliminares*.

SAP. Recuperado de:

https://www.sap.org.ar/uploads/archivos/general/files_doc-percepciones-y-sentimientos-de-ninos-argentinos-frente-a-la-cuarentena-covid-19_1606056649.pdf

- Escuela de Salud Pública T. H. Chan de Harvard. (2015). Para más información sobre El Plato para Comer Saludable para Niños, por favor visite la Fuente de Nutrición, Departamento de Nutrición, Escuela de Salud Pública de Harvard. *The Nutrition Source*. Recuperado de: <http://www.thenutritionsource.org>
- Guía alimentaria para la población argentina. 2018. *Ministerio de Salud Argentina*. Disponible en: http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001011cnt-2018-12_manual-aplicacion_guias-alimentarias poblacion-argentina.pdf
- ESPGHAN, 2018. Ingesta de azúcar, snacks, grasas. *ESPGHAN*. Recuperado de: http://www.espghan.org/fileadmin/user_upload/Society_Papers/Sugar_Inta_ESPGHAN_Advice_Guide._2018._Ver1..pdf

Alimentación basada en plantas en la infancia

Cremita de porotos,
harina de nuez,
perfume de limones,
curiosidad de niñez.
De la tierra generosa
al platito de jirafas.
Nos regala el mundo
Mil sabores para descubrir.



¿Qué es la alimentación basada en plantas? Es aquella donde la mayoría de los alimentos provienen de fuentes vegetales: frutas, verduras, legumbres, cereales, semillas, frutos secos. **No quiere decir necesariamente que no se consuman carnes u otros derivados animales. Simplemente, que la base alimentaria, el grueso de lo que se consume, está basado en plantas.**

Hay personas que no consumen carne pero consumen huevos, leche y otros derivados (ovolactovegetarianos), otras consumen pescado como única carne (pesco-vegetarianos), y otras personas solo consumen carne ocasionalmente (flexivegetarianos). Estas denominaciones, para mi gusto un tanto rígidas (no me place ubicarme en ninguna, por ejemplo), se relacionan más con lo que ponemos en el plato que con un posicionamiento ético, mientras que el veganismo, más allá de no consumir ningún derivado animal, es una mirada ante la vida y la sustentabilidad del planeta.

La alimentación basada en plantas está lejos de ser una alimentación basada en lechuga y zapallo. De hecho, si esto sucediera, no sería saludable, la alimentación no sería ni completa, ni variada, ni armónica, ni nada, y faltarían muchísimos nutrientes. Se piensa la alimentación basada en plantas como algo monótono, desde la carencia de lo que “no se puede” comer. Primero, no es que “no se puede”: no se elige, que es otra cosa. Pero pensar desde el “no” es el problema. La alimentación basada en plantas incluye cientos de alimentos de muy buena calidad nutricional, sabrosos y fáciles de conseguir y preparar. Muchísimas familias no comen ni legumbres ni frutos secos por falta de costumbre. ¿Pensamos que su alimentación es “restrictiva”?

Tener una alimentación basada en plantas no es sinónimo de comer bien. El mercado está plagado de ultraprocesados de mala calidad y dañinos para la salud bajo el rótulo de “naturales” o “veggies”. Comprar en la dietética no implica que sea algo necesariamente sano. Por eso es imprescindible el etiquetado frontal de productos, para poder decidir qué estamos comiendo. Mientras tanto, es superimportante aprender a leer los ingredientes de los productos: **si tiene más de cinco ingredientes y un montón de cosas que no entendemos qué son, es muy poco probable que sea bueno para comer.**

Otra acotación que reciben las familias que eligen este tipo de posicionamiento, es que culturalmente Argentina es un país que consume mucha carne, cosa que es cierto. Sin embargo, **las Guías Alimentarias para la Población Argentina plantean, en aras a la prevención de enfermedades y conservación de la salud, un plato que al menos lleve la mitad de alimentos basados en plantas.**

El “plato para comer saludable”, creado por expertos en nutrición de la Escuela de Salud Pública de Harvard, también plantea esta dinámica, sugiriendo además la disminución del consumo de carnes rojas y evitando las carnes procesadas (salchichas, embutidos).

Gran parte del consumo de alimentos en el mundo viene de la cría de ganado, el cual no pasta en el campo, sino que vive dentro de cobertizos comiendo alimentos balanceados y recibiendo antibióticos para evitar enfermedades. Disminuir la cantidad de carnes en nuestra alimentación, más allá del posicionamiento alimentario, comprendiendo que existen múltiples fuentes de proteínas y hierro, es una buena práctica.

Cada familia tiene su cultura y sus hábitos alimenticios. Los consejos del/la pediatra y de los/las licenciados/as en Nutrición relacionados con la alimentación, tienen que ver con preservar la salud infantil y evitar enfermedades a corto y largo plazo, y deben tener en cuenta estas costumbres, respetarlas y adaptarse a las mismas de la mejor manera.

¿Se puede tener una alimentación basada en plantas en el embarazo y durante la lactancia? ¿Y en bebés e infancias? ¿Es peligroso? Sí, se puede, adecuadamente planificada. La Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos manifestó, en 2016, que las dietas vegetarianas adecuadamente planeadas eran saludables y apropiadas para todas las etapas del ciclo vital (embarazo, lactancia, niñez, adolescencia, adultez), eran más sustentables y se asociaban con beneficios en la prevención de enfermedades crónicas. Si a la sociedad le preocuparan tanto las infancias que se alimentan a ultraprocesados, o las que no tienen ningún alimento durante días, como le preocupan las familias que deciden una alimentación basada en plantas, tal vez tendríamos menor cantidad de enfermedades crónicas no transmisibles y nuestros hijos e hijas tendrían una mejor calidad de vida a futuro.

¿Nos podemos enfermar teniendo una alimentación basada en plantas? Si no está bien planificada, sí, por supuesto. Por buenos que sean, si comemos solo zapallo y tomate, podemos enfermarnos. Es preciso que la alimentación incluya todos los grupos de alimentos en forma variada y completa, haciendo foco en los nutrientes. Y para esto, en una cultura especialmente “carnista”, es muy importante el acompañamiento profesional para llevar una alimentación basada en plantas completa, variada y saludable. Muchas veces tenemos la idea de que los y las nutricionistas nos van a “dar una dieta”, pero nada más alejado de la realidad. Una consulta incluye una charla sobre las actividades de esa familia o esa persona, los gustos, las preferencias, las posibilidades. No es lo mismo una familia cuyos miembros hacen *home office* que una familia que trabaja afuera del hogar muchas horas, no es lo mismo una familia monomarental que una donde hay varias personas cocinando. Y esto tiene que ser tenido en cuenta por el profesional. Nunca olvidaré la emoción que me produjo contarle a mi nutricionista que tenía ganas de comer algo rico a la noche mientras daba la teta: pensé que me iba a decir que no era posible, acostumbrada a tantos años de dieta. La respuesta de Vivi fue: “Dale, vamos a visibilizar esto y vamos a buscar algo rico y sano para la noche”. Cuando se lo conté a muchas amigas, no lo podían creer: estamos tan acostumbrados a la cultura de la dieta y el autocastigo, que escuchar a una profesional empática es un rayito de luz para el futuro.

¿Es posible la lactancia siendo vegana la persona que amamanta? Sí, es absolutamente posible y deseable. La leche humana siempre es nutritiva y la mejor opción para ese o esos bebés. Es importante que la persona gestante y que posteriormente amamantará esté suplementada correctamente con vitamina B12, para brindarle este nutriente al bebé (ver más adelante).

¿Hay leches de fórmula para bebés veganos? La lactancia es fuente protectora y nutritiva, y el único alimento recomendado los primeros 6 meses de vida. En familias que no desean amamantar, o que por alguna razón la alimentación del bebé implica leche de fórmula, y tengan un posicionamiento vegano, en el mercado argentino no existe al cierre de este

libro ninguna opción. Existe una leche de proteína de soja, pero entre sus componentes hay colecalciferol (vitamina D), que es extraída de la lanolina de las ovejas. Sin bien la marca declara que esa soja no es genéticamente modificada, no aclara si la misma es orgánica. En otros países hay hidrolizados de arroz, y otras opciones. Estas leches, tanto la de soja como la de arroz, no están diseñadas para familias vegetarianas ni veganas, sino que antiguamente se utilizaban para alimentar a los bebés no amamantados que eran alérgicos a la proteína de leche de vaca. Hoy sabemos que la proteína de leche de vaca y la proteína de soja tienen reacción cruzada, y estas fórmulas no se pueden ofrecer en la mayoría de los casos de APLV. Las fórmulas de soja solo se indican en caso de una deficiencia congénita de lactasa, en el que el bebé tiene una condición genética que le impide metabolizar la lactosa, y en algunos casos de galactosemia, otra patología metabólica. Es importante saber que estas NO son “leches vegetales”, son fórmulas de laboratorio pensadas específicamente para cubrir nutrientes necesarios en los bebés.

¿Qué pasa con las “leches” vegetales? Las “leches vegetales”, que básicamente parten de procesar frutos secos o semillas con agua, no son similares a la leche humana ni tienen nutrientes críticos que necesitan los bebés. Comparar una “leche vegetal” con la leche humana es como comparar una hoja de lechuga con un guiso de lentejas. NO se sugiere ofrecer “leches” de almendra, de avena, de castañas ni ninguna otra en la infancia como alimento nutritivo, pues no lo son, sobre todo las caseras. Las bebidas vegetales industriales suelen venir suplementadas con algunos nutrientes como el calcio o el zinc, pero también suelen tener otros aditivos (colorantes para que sean más blancas, por ejemplo, o azúcares para mejorar su sabor) que las convierten en ultraprocesados.

¿Se pueden usar bebidas vegetales para cocinar? Sí, se puede, desde el inicio de la alimentación complementaria, siempre que hayamos introducido la base de esa bebida previamente. ¿Qué significa eso? Que si vamos a cocinar con bebida vegetal de almendras, primero tendremos que haber ofrecido frutos secos y evaluar la reacción para evaluar alergias.

¿Qué pasa con los nutrientes? ¿Cómo “reemplazar” los que provee la carne? No es preciso consumir alimentos específicos,

sino nutrientes específicos que se encuentran en diversos alimentos. No es una cuestión de “reemplazar la carne”, o los huevos, o los lácteos: es buscar, dentro de los gustos y las posibilidades de las familias, alimentos que ofrezcan los nutrientes que necesitamos. La pregunta: “¿De dónde sacan las proteínas si no comen carne?”, yo la cambiaría por: “¿De dónde sacan las proteínas cuando lo único que se consume son galletitas?”. Generalmente, hay inmensa preocupación del entorno cuando una familia con niños/as tiene un posicionamiento vegetariano o vegano, y muy poca cuando su alimentación está basada en ultraprocesados. Cito textualmente a Miriam Martínez Biarge, pediatra especializada en nutrición basada en plantas en la infancia:

Cuando se analiza la ingesta de los niños vegetarianos y veganos se observa que en comparación con los no vegetarianos tienden a consumir más frutas, verduras y legumbres, por lo que su ingesta de fibra, vitaminas A, C y E, folato, hierro, magnesio y potasio suele ser mayor; mientras que el consumo de calorías totales, grasas saturadas, proteínas, vitaminas D y B12 y zinc es menor. Los niños y adolescentes vegetarianos y veganos suelen consumir menos bebidas azucaradas y alimentos procesados. En general, el patrón de alimentación de estos niños se acerca más a las recomendaciones oficiales actuales que las dietas occidentales típicas.

Diversos estudios muestran que el perfil de hierro de las niñas y los niños con una alimentación basada en plantas es similar o incluso mejor que la de aquellos con una alimentación “omnívora”. ¿Esto es porque son vegetarianos o veganos? En realidad, es más probable que sea porque el posicionamiento alimentario de sus familias implica mayor observación e información sobre la alimentación.

Algunas consideraciones sobre los nutrientes en una alimentación basada en

plantas

1. Incorporar frecuentemente

- **Legumbres:** son ricas en hierro, proteínas y zinc, ofreciendo también cantidades interesantes de calcio y de magnesio. Son buena fuente de fibra, hidratos de carbono complejos y sustancias antioxidantes. Ideal el remojo previo a la cocción para absorber mejor sus nutrientes. Se pueden ofrecer desde el inicio de la alimentación complementaria, y se pueden comer todos los días en distintas presentaciones y varias veces al día. En el capítulo 8 (“Pequeño manual BLW ilustrado”) y en el 14 (“Recetas”), encuentran muchísima más info sobre las legumbres, que tendrían que estar muy presentes cualquiera sea nuestro posicionamiento alimentario.
- **Frutos secos y semillas:** son alimentos muy ricos en nutrientes, especialmente proteínas, grasas de buena calidad, vitaminas (grupo B y E) y minerales (hierro, calcio, zinc, selenio), además de aportar fibra y antioxidantes, todo ello en pequeños volúmenes que suelen ser muy bien aceptados por las niñas y los niños. Se pueden ofrecer desde el inicio de la alimentación complementaria; nunca enteros, sino molidos, en harinas o cremas.
- **Frutas y verduras:** tienen el mismo papel y ocupan el mismo lugar en la alimentación de los niños vegetarianos y veganos que en la de los que no lo son. Es importante que todos los días sean consumidas, y que siempre haya exposición a las mismas.
- **Cereales:** tanto integrales como refinados, hay una enorme variedad de formas de consumir cereales.
- **Grasas:** son fundamentales en el desarrollo infantil. Incluir aceite de oliva o de girasol de primera prensada en frío es sumamente aconsejable. El aceite de lino y el de chía, que se consumen únicamente crudos, pueden ser una buena fuente de omega 3. Las

semillas molidas y los frutos secos son una importante fuente de grasas. Hoy por hoy se está estudiando el papel del omega 3 en el organismo, y de su relevancia en el neurodesarrollo y en la inmunidad; en algunos casos pueden pensarse suplementos dietarios a base del mismo.

2. Durante muchos años se habló de proteínas “completas” o “incompletas”, o de proteínas de “alto o bajo valor biológico”. Hoy ya no se utilizan estos términos y se considera que **una alimentación VARIADA contiene todas las proteínas necesarias** (es decir, si comemos únicamente porotos *mung* todos los días de la vida, y nada más... no va a pasar). No hay registros de déficits proteicos en personas con una alimentación basada en plantas bien planificada.

3. **El hierro se encuentra en numerosos alimentos de origen vegetal:** legumbres, frutos secos, pseudocereales (quinua, amaranto, algarroba), cereales (avena, harina de trigo enriquecida, cebada), semillas (zapallo, lino, sésamo) y también en la levadura nutricional; y para asegurar su absorción, se sugiere combinarlo con ciertos alimentos y evitar la combinación con otros. Veamos:

AYUDA A LA ABSORCIÓN DE HIERRO	INHIBE LA ABSORCIÓN DE HIERRO
Vitamina C (frutas, tomate, perejil, morrón)	Infusiones (té, mate, mate cocido, café)
Betacarotenos (zanahoria, zapallo, vegetales y frutas anaranjados, hojas verdes)	Cacao
Fructosa	Exceso de fibra
Remojo de legumbres	Lácteos
	Gaseosas, jugos de sobre
	Consumo crónico de antiácidos

4. El calcio suele ser una gran preocupación. Tradicionalmente se plantea que la única fuente fidedigna son los lácteos, pero **existen otros alimentos más allá de los lácteos que contienen calcio y pueden proveer una dosis adecuada**. Las necesidades de calcio van

variando a lo largo de la vida, y en su metabolismo intervienen también otros factores como la actividad física y la vitamina D. Dentro del mundo vegetal, las semillas (sésamo y amapola), los frutos secos (nueces, almendras), las legumbres y los vegetales bajos en oxalatos (brócoli, coliflor, *kale*) son buenas fuentes de calcio. Es importante charlar con un/a nutricionista para quedarnos tranquilos acerca del tema.

Vitaminas, minerales y suplementos

Vitamina B12

El único suplemento imprescindible para todas las personas vegetarianas y veganas es la vitamina B12. Esta vitamina es de origen bacteriano, se produce en el intestino de los rumiantes por fermentación del pasto que comen y se acumula en sus tejidos, que nos comemos. El problema es que cada vez menos vacas comen pasto, sino que son criadas en *feedlots* con alimento balanceado que tiene suplemento de B12 (sí, la vaca toma el suplemento). Esto no es tan efectivo como si comiera el pasto, por lo cual la pobre vaca tiene déficit de vitamina B12, y las personas que consumen carnes terminan teniendo déficit también.

La vitamina B12 forma parte de múltiples tejidos. Las alteraciones más frecuentes cuando falta son las hematológicas (anemia megaloblástica) y las neurológicas (retraso madurativo, déficit cognitivo, alteraciones motoras y déficit en el crecimiento, entre otras).

La vitamina B12 no se encuentra en los alimentos de origen vegetal, y debe ser suplementada en:

- Todas las personas veganas y la mayoría de las vegetarianas.
- Personas con escaso consumo de carnes.
- Personas con déficit de vitamina B12 medido por laboratorio.

Todas las embarazadas veganas y la gran mayoría de las vegetarianas deben estar suplementadas con vitamina B12, así como también las

madres lactantes. Las concentraciones de vitamina B12 en la leche dependen de las reservas maternas. Los bebés de familias que deciden una alimentación vegetariana o vegana deben ser suplementados desde los 6 meses en adelante.

Idealmente, deberíamos tener un análisis de sangre para evaluar la vitamina B12. Si no lo tenemos, se aporta una dosis de mantenimiento semanal. Si en algún momento es necesario sacar sangre, debemos, además de aprovechar para evaluar el hierro y sus depósitos, y la vitamina D que suele estar baja después de la cuarentena, pedir medición de vitamina B12 y homocisteína (un parámetro que nos ayuda a contextualizar los resultados). Para este análisis es importante dejar de tomar algunos días antes el suplemento, porque si no, los resultados no son fieles.

La vitamina B12 **no se obtiene** con:

- Espirulina ni otras algas.
- Verduras con tierra (son riesgosas en forma bromatológica).
- Germinados ni fermentados.

Es preciso evaluar la suplementación adecuada a las necesidades nutricionales de cada persona, no es lo mismo un adolescente que un bebé que recién empieza a comer.

Hierro

El hierro, como ya mencionamos, no estará necesariamente en riesgo en los niños y niñas con una alimentación basada en plantas si esta es completa y variada. **El suplemento de hierro no se sugiere en forma universal y habrá que evaluar cada caso en particular.**

Vitamina D

La vitamina D actúa en múltiples tejidos del organismo, como si fuera una hormona. **Tiene un papel fundamental en el desarrollo óseo y en la inmunidad.**

Los aportes de vitamina D vienen entre un 10 % a un 20 % a través de la

dieta (pescados grasos, aceite de hígado de bacalao, algunos hongos si es que fueron cultivados al sol), y un 80 % a partir de la exposición al sol. En la piel tenemos los precursores de esa vitamina, que se activan a raíz de esta exposición. En épocas invernales, de poca exposición, o lugares muy al sur (por ejemplo, Tierra del Fuego), puede ser precisa la suplementación, no tanto por tener una alimentación basada en plantas, sino por la falta de sol.

La alimentación basada en plantas es posible en todas las etapas de la vida. Numerosos estudios demuestran su beneficio para la salud y para el planeta. Es imprescindible que los profesionales nos actualicemos y trabajemos en conjunto en la alimentación de las personas a las que acompañamos. Muchos déficits en salud, como por ejemplo secuelas neurológicas por déficit de vitamina B12, podrían ser evitados si trabajáramos en forma interdisciplinaria. Podemos, y debemos hacerlo.

Para seguir leyendo

PARA FAMILIAS

- Martínez Biarge, M. M. *Mi familia vegana*, Roca Editorial, Barcelona, 2018.
- Basulto, J.; Manera, M.; Serrano, P.; Blanquer, M. *Alimentación vegetariana en la infancia*, Debolsillo, Barcelona, 2021.
- Basulto, J. y Cáceres, J. (Con la colaboración del pediatra Carlos González), *Dieta y cáncer. Qué puede y qué no puede hacer tu alimentación*, Ediciones Martínez Roca, Barcelona, 2019.

PARA PROFESIONALES

- Martínez Biarge, M. *Niños vegetarianos, ¿niños sanos?*, p. 65-77. En: AEPap (ed.). Congreso de Actualización Pediatría 2019. Lúa Ediciones 3.0, Madrid, 2019.
- González Urrutia, R. (2005). Biodisponibilidad del hierro. *Revista Costarricense de Salud Pública*, 14(26), 6-12. Recuperado de:

http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-14292005000100003&lng=en&tlng=es

- Comité Nacional de Nutrición. (2020). Dietas vegetarianas en la infancia. *Arch Argent Pediatr*, 118(4):S130-S141. Recuperado de: <https://www.sap.org.ar/docs/publicaciones/archivosarg/2020/v118n4a28s.p>
- Craig, W. y Mangels, A. (2010). Postura de la Asociación Americana de Dietética: dietas vegetarianas. *Actividad Dietética*, 14(1), 10–26. DOI: [https://doi.org/10.1016/s1138-0322\(10\)70003-1](https://doi.org/10.1016/s1138-0322(10)70003-1)

Hablemos de caca

El desconocimiento inmenso sobre nuestro propio cuerpo tiene que terminar.
Hablar en voz bien alta de sus procesos fisiológicos, conocer la información y las señales que nos da, y cuidarlo con amor, es parte de la construcción colectiva de la salud.



Por alguna razón, todo lo que le sucede a la materia fecal de los bebés, las niñas y los niños nos resulta fascinante. Desde el primer meconio hasta que los niños y las niñas adquieren la habilidad de ir al baño con la puerta cerrada, ¡tenemos en nuestra vida constantemente un primer plano de las cacas de otras personas!

Ejercicio antes de empezar: observar la propia caca durante dos semanas. Sí, tu caca de adulto o adulta. Frecuencia, color, forma, qué cosas se observan, si es blanda o dura, si flota, si se ven pedacitos de alimentos, si duele, si hay que hacer mucho esfuerzo. Sin miedo. No les sugiero dibujarla en un diario de cacas porque tal vez me miren más raro que de costumbre, peeeero... no estaría mal, eh.

Lo que vemos en la materia fecal tiene directa relación, claro está, con lo que consumimos. Los alimentos empiezan a modificarse en cuanto tocan la saliva, y a medida que transitan por el tracto digestivo, les van pasando diferentes cosas que van a hacer que los volvamos a encontrar, o no, en la materia fecal. La digestión implica romper los alimentos en miles de partículas para que lo que sea necesario mantener en el cuerpo, se convierta en algo absorbible por la sangre y utilizable para el organismo.

Parte de la digestión la hace la microbiota, entonces no es solo lo que comemos ni solo cómo funciona nuestro intestino: depende de los microorganismos que tengamos y cuán contentos estén. **La microbiota digiere cosas que nuestro intestino no puede, por ejemplo, la fibra.** Esto le sirve de alimento, pero también genera compuestos que el cuerpo requiere, como los ácidos grasos de cadena corta de los que hablamos en el capítulo 4 sobre microbiota.

Toda esto que les cuento es para hacer una introducción acerca de por qué la caca tiene formas, colores y texturas distintas, de acuerdo con lo que comemos, lo que absorbemos, lo que eliminamos, la microbiota... Los factores son múltiples y varían día tras día.

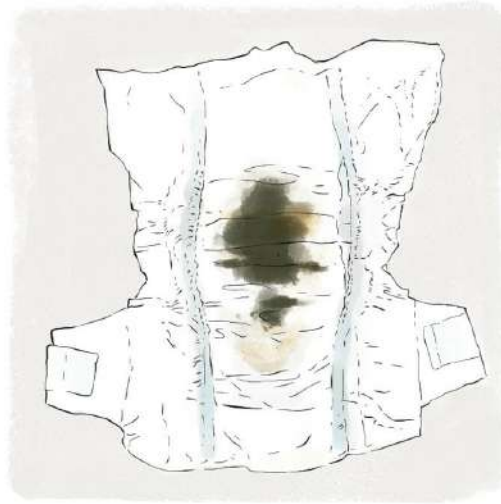
Empecemos por lo lindo: la caca de los bebés antes de la alimentación complementaria

Son cacas normales:

Meconio: es el nombre que reciben las primeras deposiciones del bebé. A veces, incluso, expulsan meconio dentro del útero (es un signo de que algo no anda bien, y recién se va a ver cuando se rompa la bolsa amniótica). Son cacas similares a la brea, negras y pegajosas.



Cacas de transición: un poco negras, un poco amarillas. El intestino del bebé se está librando del meconio y a la vez produciendo nueva caca. La leche humana, sobre todo el calostro, tiene efecto laxante y ayuda a este proceso.



Cacas color mostaza/doradas: son las cacas esperables de un bebé alimentado a pecho y de la mayoría de los que toman fórmula. Pueden ser grumosas, pastosas, pegajosas, incluso algo líquidas. Todas son normales.



Cacas verdes: no son por frío ni por estar descalzos. Las cacas verdes tienen varios significados. Si son verde claro, puede que el bebé esté tomando solamente la primera parte de la mamada, con mayor contenido de lactosa, y poco de la parte grasa. Si esto se suma a que el bebé tiene algún problema con el peso, es importante constatar la transferencia correcta de leche con una persona especialista en lactancia. Si son verde oscuro, puede ser por el suplemento de hierro. Si el bebé toma fórmula, como la misma contiene hierro y otros agregados, puede tener cacas normales de dicho color.



Los bebés tienen muy acentuado lo que llamamos el “reflejo gastrocólico”: comen y hacen caca. **El recién nacido puede hacer muchas, pero muchas cacas al día. No es diarrea, es algo esperable.** A medida que pasan los meses, esto va disminuyendo.

Son cacas para consultar:

Cacas negras: si el bebé comenzó a tomar hierro y las cacas se volvieron negras concomitantemente, es probable que sea el hierro el que les da ese color. La sangre digerida también puede tener color negro, consultar al pediatra si hay dudas.

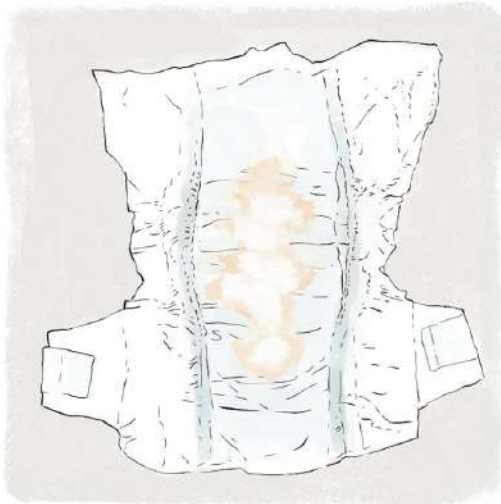


Caca con sangre: las cacas con sangre son motivo de pronta consulta.

Pueden tener orígenes diversos: bebé que mama de un pezón lastimado y traga un poquito de sangre, alergia a la proteína de leche de vaca, infección por rotavirus... En niños mayores es preciso descartar el síndrome urémico hemolítico (SUH). Es precisa una evaluación completa para definir y tratar su causa. Nunca son normales.



Caca blanca: la caca blanca (color tiza, no marrón clarita. Blanca o gris clara.) tampoco es normal. Generalmente habla de afectación hepática, y requiere una consulta urgente.



¿QUÉ ES LA DISQUECIA DEL LACTANTE?

Muchas veces parece que los bebés muy pequeños hacen fuerza para

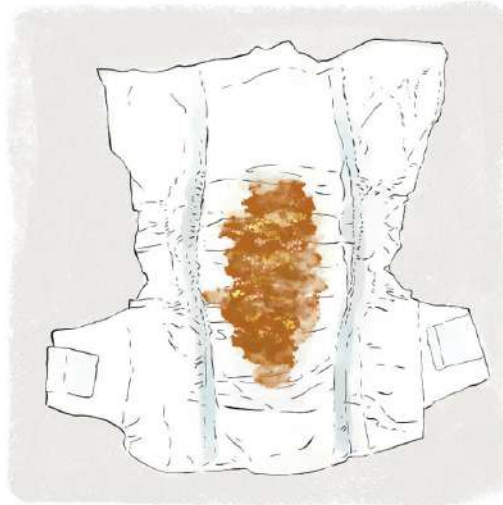
hacer caca y se ponen rojos, como si estuvieran estreñidos. Cuando logran hacer caca, la consistencia es normal, y dejan de llorar. ¡Paciencia! Eso se llama “disquecia del lactante”, y no es una patología, simplemente es una etapa madurativa. Aún tienen que aprender a abrir los músculos que están alrededor del ano en forma voluntaria cuando sienten que tienen que eliminar caca o gases. Puede durar hasta 6 meses.

Las cacas con el inicio de la alimentación complementaria

Cuando ingresan otros alimentos al organismo además de la leche, lógicamente la caca cambia. Y aparecen las preguntas: “Si veo el pedazo de zanahoria igual que como lo comió, ¿es que no absorbió nada? ¿Pasa todo de largo y no lo nutre? ¿Tiene un problema intestinal?”.

Es por esto que propuse el primer ejercicio caquístico: observar la propia materia fecal adulta, que cambia según lo que comemos y donde vemos también pedacitos de comida. **Hay componentes del alimento que no se van a absorber, como la fibra. Pedacitos de choclo, semillas y cascaritas de arándano, alguna lenteja tal cual como entró... Es normal y esperable verlos en la caca.** Las “semillas” de la banana, que se ven como puntitos negros cuando se corta, se ven en la caca como hilitos oscuros, que genera mucho miedo porque a veces parecen parásitos, pero no.

Las cacas, cuando se inicia la alimentación complementaria, cambian. En algunos niños y niñas siguen siendo blandas, pero con mayor consistencia, y sí, otro olor, porque ahora hay otros alimentos fermentados en el intestino además de la leche. Puede cambiar también la frecuencia, y a veces nos podemos encontrar con cacas tipo plastilina, o cacas que parecen “de adulto” y que nos dan impresión. La magia de mapaternar, le dicen.



Con restos de comida

Las cacas a través del tiempo

¿Cómo tiene que ser la caca del niño más grande, del adolescente y del adulto? Sobre todo, **no debe doler, ni la panza ni la defecación en sí. Si esto sucede, hay algo que debemos evaluar.**

Existe una escala de materia fecal (sí, claro, en ese mundo existe de todo) y no quiero privarlos de conocerla.

ESCALA DE HECES DE BRISTOL			
TIPO 1		Trozos duros separados, que pasan con dificultad.	ESTREÑIMIENTO IMPORTANTE
TIPO 2		Como una salchicha compuesta de fragmentos.	LIGERO ESTREÑIMIENTO
TIPO 3		Con forma de morcilla con grietas en la superficie.	NORMAL
TIPO 4		Como una salchicha o serpiente, lisa y blanda.	NORMAL
TIPO 5		Trozos de masa pastosa con bordes definidos.	FALTA DE FIBRA
TIPO 6		Fragmentos pastosos, con bordes regulares.	LIGERA DIARREA
TIPO 7		Acuosa, sin pedazos sólidos, totalmente líquida.	DIARREA IMPORTANTE

Los tipos 1 y 2 indican estreñimiento; los 3 y 4 son heces ideales, especialmente el 4, ya que son los más fáciles de defecar; los tipos 5, 6 y 7 son heces diarreicas.

Esta es una simpática herramienta que nos ayuda a trabajar en la mejora de los hábitos. No siempre las cacas serán “ideales”, pero si es algo que sucede recurrentemente, siempre se puede mejorar.

La caca nos da mucha información

Cuando una persona tiene una condición de salud para acompañar o resolver, conocer su ritmo evacuatorio y sus características es muy importante. Por ejemplo, en niños y niñas con trastorno del espectro autista vemos una franca diferencia en las deposiciones cuando se modifica la alimentación para hacerla menos inflamatoria. De ser diarreicas o duras constantemente se vuelven más formes, con más consistencia y más sencillas para evacuar. La caca de los bebés con alergias intestinales puede presentar sangre, y la de los niños y las niñas con enfermedad celíaca es de aspecto grasiento y muy olorosa.

Sentarse para hacer caca

Un *tip* relevante a la hora de defecar es la postura. La postura en 90 grados es la que habitualmente aprendemos y les enseñamos a los chicos, pero no es la que naturalmente ellos adoptan cuando hacen caca (fíjense que suelen ponerse en cuclillas). Esto sucede porque **al elevar las rodillas, se relaja un músculo que es el puborrectal, y permite que la fuerza para defecar tenga que ser menor y el proceso más sencillo.**

¿Cómo elevamos las rodillas? Poniendo un banquito a los pies del inodoro. Los niños y las niñas pueden aprender a usarlo así, y puede que les sea más sencillo el hacer caca.



Los gases

Los gases son producto de la fermentación de los alimentos en el intestino. Cuando la comida llega ya parcialmente digerida al intestino, una parte se va

a absorber, otra parte se va a ir por la caca y otra va a ser alimento de la microbiota en un proceso llamado “fermentación” que produce gas. **Todos los seres humanos tienen gases, solo que a los de bebés y niños les prestamos una atención desmesurada.** Los bebés tienen gases y no siempre tienen dolor por eso, simplemente están aprendiendo a gestionarlos y un airecillo que sale por atrás les es sorprendente. Muchas veces, en bebés pequeños, se confunde el sueño activo (durante el cual se mueven mucho a la noche) con los gases.

Cuando empieza la alimentación complementaria, lógicamente, se empiezan a fermentar otros alimentos y los gases cambian. **En sí no son patológicos, a menos que vengan acompañados por otras manifestaciones (dolor, inflamación abdominal, náuseas, etc.).** En esas situaciones, es preciso la consulta y evaluar qué está pasando.

También es normal que los gases aumenten cuando pasamos de una alimentación pobre en fibra a una rica en fibra. Por ejemplo, cuando incorporamos legumbres o frutas y no veníamos comiéndolas. Este proceso es temporal y en breve mejora.

Dato no menor, a los chicos les encanta hablar de gases, contar chistes y hacer el sonido pertinente. Que esto también nos invite a charlar, reconocer el cuerpo, las sensaciones, y a reírnos en familia sin vergüenza, está buenísimo.

Constipación, todo un tema

La constipación es la retención anormal de materia fecal (caca), con consistencia aumentada (dura) y dificultad al evacuar.

No tiene tanto que ver con la cantidad de veces que se haga caca en un día/semana, sino con la incomodidad que genera. **Cuanto más tiempo pasa la caca en el recto (la última porción del intestino grueso), más agua de la misma absorbe el intestino, generando que se vuelva más seca y difícil de evacuar.**

Dicho todo esto, vamos a hablar de la caca desde cero:

- **Durante el primer mes,** los bebés que toman leche humana suelen hacer caca varias veces al día (todos los días). Esto es más variable en

los que toman leche de fórmula, al ser muy distinta la composición.

- **Después del primer mes**, los bebés suelen hacer menos caca. Incluso los amamantados pueden no hacer caca por varios días (hasta 10, 15 o más...) y no sentirse molestos. Esto NO es constipación: no se sugiere dar laxantes o usar supositorios. Hay que esperar un poquito, sobre todo si el bebé está de buen ánimo y sin signos de estar molesto. No todo llanto es por molestias en la panza.
- **Cuando empieza la alimentación complementaria**, la caca cambia y muchos bebés se constipan. Ahí tenemos que evaluar el aporte de agua y los alimentos que brindamos.
- **Después del año** empieza la mayor cantidad de consultas. Es importante destacar que en gran parte de los casos, el cuadro depende de los hábitos alimentarios.
- **Luego de los 2 años**, sobre todo en el apuro por “retirar” los pañales, muchos niños y niñas retienen caca porque les da miedo, asco o angustia.

Para hablar de tratamiento, primero tenemos que ver cómo abordamos la constipación. Hay que conocer a la persona completa, a ese pequeño (o no tan pequeño) consultante: su historia, su gestación, su forma de nacimiento, el inicio y mantenimiento de la lactancia, las enfermedades previas, el consumo de antibióticos u otras medicaciones, el desarrollo madurativo, el lenguaje, el control de esfínteres, el contexto familiar, la ingesta de agua y de lácteos, y el registro de lo que consume todos los días (a las familias les solemos pedir un registro escrito) y de la actividad que realiza. Con todo esto también evaluamos cómo puede estar su microbiota, vital para charlar de cuestiones neurointestinales.

Luego pasamos al examen físico (siempre con permiso del niño y de la familia): vemos peso y talla, y cómo fue creciendo; hacemos el examen abdominal y neurológico; y observamos la zona perianal y la columna. No siempre hace falta en una primera instancia pedir otros análisis.

¿Cómo arrancamos el tratamiento?

“La dieta de los niños estreñidos, generalmente, carece de fibra y predomina el consumo de leche o yogur con poca ingesta de otros nutrientes”, se menciona en el artículo académico “Estreñimiento funcional en pediatría, diagnóstico y tratamiento”, de la Sociedad Argentina de Pediatría. **Los cambios alimentarios son FUNDAMENTALES para mejorar la constipación y la salud intestinal.** Ofrecer medicación como primera instancia si no vamos a cambiar los hábitos familiares puede ser un alivio pero a muy corto plazo.

Por ejemplo: Marilina tiene 19 meses. Hace caca dos veces por semanas, con mucho dolor. La familia tiene que ayudarla flexionándole las piernas y haciéndole masajes en la panza. Varias veces tomó laxantes, pero en cuanto hacía caca, se suspendía el tratamiento. Se le solicita a la familia de Marilina un registro de alimentación de una semana.

Fragmento:

Lunes

Desayuno: avena con leche.

Almuerzo: papa, arroz, tomate. Agua.

Merienda: leche con chipá.

Cena: fideos con tuco.

Además: 1 banana a la mañana y otra antes de dormir.

Martes

Desayuno: yogur firme de frutilla.

Almuerzo: milanesa de carne. Tomate.

Merienda: mate cocido con leche y galletitas dulces.

Cena: salchichas con puré de papas.

Además: 1 banana y 1 mandarina.

Sacando algunas frutas, la alimentación de Marilina constiparía al ser más evacuatorio del planeta. Además de esto, se observa un importante déficit de nutrientes en su alimentación, con varios productos ultraprocesados, falta de fibra y falta de consumo de agua. La familia de Marilina dice que ella come bien y que le compran lo mejor, de primera marca. Y en eso no hay duda:

venimos de creer que lo importante es que coman, no importa qué coman, y que los productos ultraprocesados son los mejores. La familia le ofrece a la niña esos alimentos con todo su amor, y eso es fundamental para trabajar la importancia de modificar esos hábitos que hoy por hoy le hacen mal. La constipación es molesta y dolorosa, y no se resuelve por completo con una medicación. **Aumentar el consumo de fibra y agua es fundamental como un primer paso, además de disminuir el consumo de lácteos y de productos ultraprocesados.**

El movimiento también es beneficioso para la función intestinal. Ir a la plaza, andar en triciclo y hacer algún deporte están dentro de las indicaciones para la salud de cualquier pequeño consultante.

Muchas veces, para lograr estos cambios, tenemos que trabajar de la mano de un gastroenterólogo y un nutricionista, pero no cada uno por su lado, sino en conjunto, trabajando en equipo e intercambiando ideas.

Lamentablemente, si ya hay una obstrucción fecal en el intestino, es preciso abordar de entrada este problema. Para eso, muchas veces necesitamos utilizar un laxante que puede ser por vía oral, o incluso requerir un enema. Estas prácticas deben ser indicadas por un profesional, e intentar que tengan que ser usadas la menor cantidad de veces y el menor tiempo posible. **Es muy muy importante no automedicar a los chicos con laxantes ni enemas, muchos de ellos pueden ser tóxicos.**

Cuando la constipación no responde a reales cambios alimentarios y a otros tratamientos terapéuticos, o hay alguna otra cuestión del examen físico, crecimiento o desarrollo de la niña o el niño que nos llama la atención, tenemos que pensar en otras causas de constipación dentro del terreno de lo orgánico. El hipotiroidismo, el síndrome de Hirschsprung (una patología que, por falta de inervación correcta del intestino, este se dilata), inclusive algunas alergias alimentarias podrían tener que ver con la constipación, y depende del pediatra su pesquisa.

Es común observar, a partir de la etapa preescolar, constipación por “retención”. Puede darse por muchas causas: dentro del proceso de control de esfínteres, por no querer usar el baño en la escuela o fuera de casa, y sobre todo, porque alguna vez el hacer caca les generó dolor y tienen miedo de que eso suceda de nuevo. La retención lleva a que el intestino absorba el agua de esa caca y esta se vuelva más seca y más difícil de defecar. En otras ocasiones, la materia fecal se puede “escurrir” y manchar la ropa, generando la impresión de que es diarrea, pero en realidad es materia fecal más líquida

que rebosa por los costados de la caca que está atascada.

Estas cuestiones son más complejas y es preciso observar cada caso individual. ¿El niño o la niña dejó los pañales o se los sacaron? ¿Puede subirse solo al inodoro? ¿Le cuelgan los pies o tiene un banquito donde apoyarlos? (A nadie le gusta hacer caca con los pies colgando). ¿Le preguntamos de qué tiene miedo si ese es el caso? Muchos niños y niñas sienten que pierden algo al hacer caca, o que la caca es algo sucio y malo, y les da temor o vergüenza que salga de su cuerpo. También puede pasar que se hayan lastimado un poco al hacer caca y tengan miedo al dolor. **De ahí la importancia de normalizar la caca, de explicarles que es algo que hacemos todos (podemos también mostrar ejemplos de animales haciendo caca) y evitar todo el tiempo destacar lo “asqueroso” que es.** Trabajar con profesionales de salud mental será una opción de acompañamiento importante para muchas familias.

Es importante que en la familia no se esté hablando todo el tiempo de la caca, de cómo hizo caca, de por qué no hizo, y que no se rete al niño o la niña por estas cuestiones. Es muy común que los mismos familiares que están preocupadísimos por lo que sucede con la caca del niño o la niña sean los que le regalen golosinas y jugos aunque los padres no adhieran. También evitar retos, gritos y regaños: a nadie le gusta estar constipado, y los niños y las niñas no tienen responsabilidad de ello.

Cuando no se hace caca por “falta de costumbre”, porque el cuerpo se acostumbró a avisar y que no le dieran bola, a veces sirve, después de la comida, sentarse un ratito en el inodoro. Sin obligar y concentrándose en lo que amerita, es decir, sin libros, revistas ni *tablets*. Un ratito, diez minutos como máximo, y probar hacer caca, para explicarle al cuerpo: “Che, aprovecharé este momento”. De a poco, junto con la alimentación saludable, le vamos a ir encontrando la vuelta.

Diarrea: información y pautas de alarma

Diarrea aguda

La diarrea aguda es el aumento de la frecuencia, fluidez y/o volumen de las deposiciones, con pérdida variable de agua y electrolitos, y cuya duración es menor de catorce días. La pueden producir virus, bacterias (la bacteria en sí o la toxina de una bacteria) o parásitos. También pueden ser producidas por alguna medicación, como los antibióticos.

El problema de la diarrea es que con el aumento de las deposiciones se pierde agua, y los bebés, niños y niñas tienen riesgo de deshidratarse rápidamente.

Si nuestro hijo o hija tiene diarrea, debemos ir a la guardia si:

- La diarrea es con sangre.
- No tolera líquidos ni pecho materno.
- No hace pis.
- Respira muy rápido, hunde las costillas.
- Tiene seca la boca y la piel.
- Tiene mucho dolor o mal estado general.

Si no sucede nada de esto y el niño o la niña está lo más feliz jugando aunque tiene diarrea, paciencia. Hay que esperar que el cuadro se resuelva solo, lo cual le implica al organismo eliminar el germen o la toxina causante, y además, reparar las células del intestino que están maltrechas. Por eso decimos que dura hasta catorce días. Si la diarrea dura más tiempo, hay que estudiarla.

¿Qué hacer en caso de diarrea?

- **Ofrecer líquidos.** Si tiene menos de 6 meses, poner más veces al

pecho u ofrecer fórmula si toma. Si tiene más de 6 meses, ofrecer también agua potable. NO ofrecer jugos, té ni mucho menos “gaseosa batida” o bebidas deportivas. Estas últimas son muy populares para estos cuadros, pero no deben usarse. Tienen mucho contenido de azúcar, jarabe de maíz de alta fructosa, colorantes y otros compuestos que dañan la microbiota y que pueden empeorar el cuadro dando más dolor abdominal y más diarrea. Y no tienen “sales minerales” como popularmente se cree.

- **Ofrecer alimentos sencillos, como todos los días.** La dieta “astringente” no se sugiere más hace muchos años. Se vio que el intestino se recupera más rápidamente cuando se le dan alimentos sanos y variados: frutas, verduras, legumbres, cereales, derivados animales, frutos secos adaptados... Evitar, como siempre, los productos ultraprocesados. Sí, también conviene evitar la gelatina.
- **Evitar ofrecer hojas verdes como acelga o espinaca,** porque en esas situaciones aumenta el riesgo de absorción de nitratos.
- **Evitar el uso de medicaciones antidiarreicas** (bismuto, loperamida, carbón activado), porque pueden ser tóxicas para los niños.
- **Si la diarrea es importante, el pediatra puede sugerir ofrecer sales de rehidratación oral (también llamadas sales OMS),** que se compran en la farmacia y pueden ayudar a evitar la deshidratación o revertir casos de deshidratación leve sin necesidad de internar al pacientito.
- **La leche deslactosada no mejora la diarrea.** Siempre priorizar la leche humana, que tiene probióticos, prebióticos y factores de crecimiento que les dicen a las células del intestino que es hora de repararlas.
- **Mantener la higiene y lavarse las manos con agua y jabón** cuando se está en contacto con las heces o se cambia el pañal.

- **Evitar que el niño o la niña vaya a la escuela esos días.**
- **Probióticos:** tremendo lío. Hasta hoy, sabemos que los probióticos pueden reducir la duración de la diarrea aguda aproximadamente un día (sí, un día), y en algunos estudios muestran mejoría de los síntomas en los primeros días. Parecería que *Saccharomyces boulardii*, *Lactobacillus GG* y, en menor medida, *L. reuteri DSM 17938* podrían ayudar. Sin embargo, su costo es alto y la evidencia es baja, así que hay que evaluarlo con relación a cada paciente, y hacer hincapié en otras medidas como la alimentación saludable y la lactancia materna a demanda.

Diarrea crónica

Se denomina así cuando el cuadro persiste más de dos semanas. A veces, es producto de una diarrea aguda que se sigue curando, y hay que reforzar la alimentación saludable y aguardar. Otras veces, sobre todo si es de larga data y está afectando el crecimiento y desarrollo del bebé, es fundamental estudiar qué está sucediendo. Las alergias alimentarias, la celiaquía y las enfermedades inflamatorias, entre otras, pueden ser su causa. Inclusive hay un tipo de diarrea crónica a la que se llamada “diarrea crónica inespecífica”, que se da justamente por el amplio consumo de azúcares en forma de jugos, galletitas y golosinas.

Los parásitos intestinales

Los parásitos pueden producir diarrea crónica, anemia, picazón en la zona perianal y la vulva (sobre todo a la noche, porque los parásitos salen del intestino por el ano y ponen huevos en esa zona), e inclusive patologías respiratorias, pero para sugerir “desparasitar” a un niño o una niña es importante realizar un estudio de materia fecal para definir qué parásito tenemos que atacar. **La desparasitación no está indicada de rutina, ni en**

forma masiva, salvo en áreas de alta prevalencia de uncinarias (un parásito), como es la zona del noroeste de nuestro país.

Para saber ante qué parásito estamos, es preciso ver al parásito (a veces vemos directamente el gusanito en la caca, en el pañal, en la ropa de cama o saliendo del ano) o hacer un análisis de materia fecal que consiste en juntar caca varios días en un frasco con formol, entre otros estudios posibles. Una vez identificado, se elige la medicación adecuada, y todas las personas convivientes deben hacer el tratamiento (sí, todas), además de lavar la ropa de cama y otras cuestiones.

No se ha encontrado relación entre los parásitos y el bruxismo, ni se producen por comer muchas golosinas. Son comunes en la infancia porque los chicos se rascan la cola, donde están los huevitos, y se meten la mano en la boca, por lo que se reinfectan y el ciclo sigue. La higiene de manos y de uñas es importante para cortar este ciclo.

Control de esfínteres: todo a su tiempo

Adquirir el control de esfínteres no es tarea sencilla. Los nervios y las neuronas que trabajan con las sensaciones y el control motor de las zonas involucradas tardan un tiempo importante, que varía según la persona, en desarrollarse. **Recién a los 18 meses este proceso se empieza a consolidar lentamente, y puede durar hasta los 4-5 años.**

No me detendré sobre el proceso de control de esfínteres en sí mismo, pero con relación a hablar de cacas, me parece imprescindible dejar claro que **los pañales no se “sacan”, sino que se dejan de manera paulatina.** Muchos niños a los que se les ha sacado el pañal porque “es verano”, porque “tiene que entrar al jardín sin pañales” o porque “ya está grande”, presentan importantes problemas de constipación, enuresis (hacerse pis encima) y hasta encopresis (hacerse caca encima).

El proceso de control de esfínteres es similar al proceso de aprender a comer, de aprender a caminar, de aprender a hablar. Tiene sus tiempos, sus idas y venidas, su acompañamiento amoroso. No podemos apurar procesos neuronales que requieren muchas repeticiones para establecerse correctamente.

Pañales de tela

Los pañales de tela modernos son una opción sustentable para el día a día de los bebés. Son sencillos de colocar y se lavan en el lavarropas, e **inclusive algunos bebés que presentan muchas dermatitis con los pañales descartables, mejoran con los pañales de tela.**

Estos pañales no generan constipación ni infecciones urinarias. Con lavarlos con el mismo jabón que el resto de la ropa basta, y la higiene se mantiene igual que con un pañal descartable cuando se cambian con regularidad.

Los pañales de tela tampoco interfieren en el desarrollo motor de los bebés por ser más abultados.

Creo que es importante recordar que los pañales descartables se usan hace alrededor de treinta años, y previamente, toda la humanidad utilizó pañales de tela, porque no había otra cosa, y no le generó problemas a nadie para sentarse, caminar, hacer caca ni aprender a controlar esfínteres.

Colostomía e ileostomía

Así como existen otras formas de comer, existen otras formas de eliminar los desechos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, existen personas cuyos riñones no funcionan bien y deben hacer un procedimiento llamado diálisis, por un catéter en el abdomen o un acceso vascular en el brazo. Otras personas tienen que usar una sonda en la uretra para hacer pis, o sondarse varias veces por día.



Asimismo, hay personas que tienen ostomías. ¿Qué es eso? Una comunicación que se realiza quirúrgicamente entre el intestino y el exterior. Esta comunicación se hace por muchas cuestiones, que pueden ser temporales o permanentes. Patologías donde hay que sacar parte del intestino, por ejemplo, en la enterocolitis necrotizante del prematuro, obstrucciones, patologías oncológicas, traumatismos, etc.

La materia fecal saldrá por un pedacito de intestino que se deja hacia afuera, en el abdomen, y se recogerá a través de una bolsa diseñada para tal fin, que se cambia regularmente. Es importante cuidar la piel alrededor de la ostomía para evitar infecciones.

Bajo el *hashtag* #ostomy se pueden encontrar muchas historias en las redes sobre personas que por alguna patología tienen colostomías o ileostomías, y comparten cómo estudian, trabajan, hacen deporte, atraviesan procesos médicos y de la vida cotidiana, y hasta cursan embarazos.



Para concluir con el asunto fecal

Hablar de caca, que nos da mucha risa y vergüenza, es fundamental. Es un proceso del cuerpo humano, al igual que lo es transpirar o generar saliva, y tenemos que normalizarlo. **Nuestra cultura nos hace esconder los procesos fisiológicos, y el resultado es una cantidad enorme de personas con trastornos intestinales.**

Muchos niños y niñas que sufren (sí, la palabra es sufren) de constipación vienen de mapadres que también tienen constipación. ¿Es genético? Más que genético, tiene que ver con un tipo de alimentación y de hábitos para ir al baño, más una microbiota compartida familiarmente. El inicio de la alimentación complementaria y el control de esfínteres son dos momentos donde se observan claros cambios en la caca, y el acompañamiento paciente, informado y respetuoso es importante.

Cuando le cambiamos el pañal a un bebé, o ayudamos a un niño o una niña más grande a limpiarse, es fundamental evitar el: “Uy, qué asco lo que hiciste” o “Ay, qué olor horrendo”. A ningún niño o niña le gusta desagradar a la gente que ama (a los adultos tampoco, en realidad), entonces creen que es algo que “no deben hacer”. Asimismo, pedirles permiso para cambiarlos, explicarles desde recién nacidos qué vamos a hacer cuando cambiamos el pañal, es también darles un mensaje muy poderoso: “Para actuar sobre tu cuerpo, hay que pedir permiso”. Y esto también es educación

sexual integral, como lo es nombrar las partes del cuerpo por su nombre. El pene, la vulva, el escroto, la pierna, el codo. Sin miedo.

Como dice el título de este capítulo: hablemos de caca, miremos la caca, sepamos de caca. Sin miedo y sin vergüenza, que seguramente esto reeditará en más salud.

Para seguir leyendo

PARA FAMILIAS

- American Academy of Pediatrics. (2017). El estreñimiento en los niños. *HealthyChildren.org*. Recuperado de: https://www.healthychildren.org/Spanish/health-issues/conditions/abdominal/Paginas/Constipation.aspx?gclid=Cj0KCQjwweyFBhDvARIsAA67M70J0I69Jq9tK0dzMycpRSSf-XWrSenu4U1UddyyyzEsx6cOF9N6x0aAszzEALw_wcB
- American Academy of Pediatrics. (2017). Asuntos emocionales y problemas para ir al baño. *HealthyChildren.org*. Recuperado de: <https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/toddler/toilet-training/Paginas/Emotional-Issues-and-Bathroom-Problems.aspx>
- Cabana, P. (2015). La constipación en los niños. *Comunidad SAP*. Recuperado de: <http://comunidad.sap.org.ar/index.php/2015/08/10/la-constipacion-en-los-ninos/>
- Guijarro González, M. J. (2012). Cuidados de enfermería en la ostomía digestiva pediátrica. *Anales de Pediatría Continuada*, 10(5), 290–294. Recuperado de: [https://doi.org/10.1016/s1696-2818\(12\)70101-4](https://doi.org/10.1016/s1696-2818(12)70101-4)
- Intermountain Primary Children's Hospital. (2015). Ostomía: cuidados en el hogar. Guía para los pacientes y sus familias. *Intermountainhealthcare.org*. Recuperado de: <https://intermountainhealthcare.org/ckr-ext/Dcmnt?ncid=521451657>
- Castro, S. y Avilés, R. (2017). Este es mi dragón. Convivir con una enfermedad inflamatoria intestinal. (Edición especial de distribución gratuita). *Fundación Más Vida*. Recuperado de: https://masvida.org.ar/wp-content/uploads/Este-es-mi-drag%C3%B3n-web_v-ARG.pdf

PARA PROFESIONALES

- Guarner, F. (2007). Papel de la flora intestinal en la salud y en la enfermedad. *Nutrición Hospitalaria*, 22(Supl. 2), 14-19. Recuperado de: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112007000500003&lng=es&tlng=es
- Grupo de Trabajo de Constipación del Comité Nacional de Gastroenterología Pediátrica. (2021). Estreñimiento funcional en pediatría, diagnóstico y tratamiento. *Arch Argent Pediatr*, 19(1):S39-S47. Recuperado de: https://www.sap.org.ar/uploads/consensos/consensos_estrenimiento-funcional-en-pediatria-diagnostico-y-tratamiento-116.pdf
- Lewis, S. J. y Heaton, K. W. (1997). Stool form scale as a useful guide to intestinal transit time. *Scand J Gastroenterol*, 32(9):920-4. DOI: 10.3109/00365529709011203.
- Moraes, J. G. D.; Motta, M. E. F. D. A.; Beltrão, M. F. D. S.; Salviano, T. L.; Silva, G. A. P. D. (2016). Fecal Microbiota and Diet of Children with Chronic Constipation. *International Journal of Pediatrics*, 1–8. Recuperado de: <https://doi.org/10.1155/2016/6787269>
- González Jiménez, D.; Díaz Martín, J.; Bousoño García, C.; Jiménez Treviño, S. (2010). Patología gastrointestinal en niños con parálisis cerebral infantil y otras discapacidades neurológicas. *Anales de Pediatría*, 73(6), 361.e1-361.e6. Recuperado de: <https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2010.03.003>
- Sociedad Argentina de Pediatría. (2003). Consenso nacional. DIARREA AGUDA EN LA INFANCIA. Actualización sobre criterios de diagnóstico y tratamiento. *SAP*. Recuperado de: <https://www.sap.org.ar/uploads/consensos/consenso-de-diarreas-agudas-en-la-infancia.pdf>
- García-Zermeno, K. R. (2021). Constipación crónica. Conceptos actuales desde la fisiopatología hasta el tratamiento. *Acta Gastroenterológica Latinoamericana*, 51(1). Recuperado de: <https://doi.org/10.52787/zrrj9030>
- Bonill de las Nieves, C.; Hueso Montoro, C.; Celdrán Mañas, M.; Rivas Marín, C.; Sánchez Crisol, I.; Morales Asencio, J. M. (2013). Viviendo con un estoma digestivo: la importancia del apoyo familiar. *Index de Enfermería*, 22(4), 209-213. Recuperado de: <https://dx.doi.org/10.4321/S1132-12962013000300004>

- Guarino, A.; Ashkenazi, S.; Grendel, D.; Lo Vecchio, A.; Szajewska, H.; Shamir, R. (2014). European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition/European Society for Pediatric Infectious Diseases evidence-based guidelines for the management of acute gastroenteritis in children in Europe: Update 2014. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*, 59: 132–52. Recuperado de: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18493225/>

Reacciones adversas a los alimentos:
alergias e intolerancias

En un mundo cada vez más contaminado, con alimentos repletos de aditivos y sustancias tóxicas acumulativas, se plantea que las alergias e intolerancias alimentarias podrían ser la respuesta de los cuerpos infantiles para tratar de defenderse de estímulos nocivos.

Este capítulo está dedicado a todas las familias que atraviesan estos procesos, con valentía e inmenso trabajo, y amor por sus hijos e hijas.



Las reacciones adversas a alimentos son las respuestas clínicas anormales que presentan algunas personas a la ingesta de un alimento, el cual es perfectamente tolerado por la gran mayoría de las personas. Entre ellas encontramos las alergias e intolerancias alimentarias.

Cuando a nuestros hijos e hijas les sospechan o les diagnostican una alergia alimentaria, se abre un sinnúmero de dudas, angustias y desorientación. ¿Cómo sé que es alérgico a eso y no a otra cosa? ¿Se podría haber evitado? ¿Es para siempre? Y, sobre todo, ¿QUÉ PODEMOS COMER?

Las alergias e intolerancias alimentarias van en aumento en los últimos años. Esto obedece a muchos factores ya expuestos en este libro: el aumento de tasas de cesáreas no necesarias, la escasa tasa de lactancia materna, el desbalance de la microbiota, los disruptores endocrinos, el hiperhigienismo, la falta de contacto con la naturaleza y otras vicisitudes de la vida moderna. Los mecanismos por los cuales el organismo genera alergias e intolerancias son diferentes, y lo hablaremos en este capítulo. **Es importante para las familias que atraviesan situaciones de alergias e intolerancias en alguno de sus miembros contar con un equipo interdisciplinario que las acompañe en su transitar.** No alcanza con que un profesional diga “bueno, coman sin lácteos”. Tiene que haber un nutricionista velando por la buena calidad nutricional de lo que come la familia teniendo en cuenta sus gustos, cultura y presupuesto.

En la bibliografía al final de este capítulo, verán varios libros y orientaciones para familias que transitan una o múltiples alergias alimentarias, ya que aquí hago hincapié en la alergia a la proteína de leche de vaca y la alergia al huevo, las más comunes.

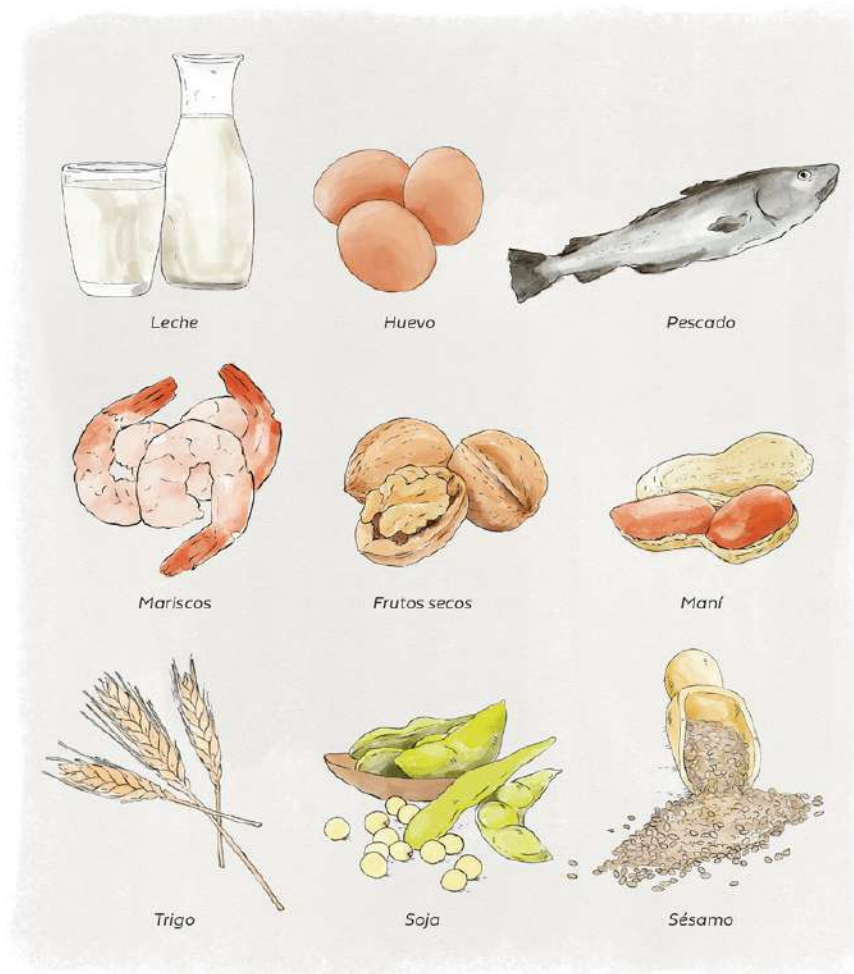
¿Cuál es la diferencia entre alergias e intolerancias? **Una alergia alimentaria es una reacción exagerada del sistema inmune a una proteína específica, que se produce luego de la exposición a un determinado alimento.** Esta respuesta inmune puede ser mediada por

anticuerpos, mediada por células de la inmunidad, o por ambos. Es por esto que cada niño o niña tiene respuestas diferentes y no se pueden comparar.

La intolerancia es una reacción adversa que se da cuando el cuerpo de una persona no puede metabolizar adecuadamente determinado alimento, produciendo un efecto nocivo. Por ejemplo, la intolerancia a la lactosa se da porque la persona carece o tiene bajas cantidades de la enzima lactasa, que es la que digiere la lactosa.

Alimentos alergénicos

Existen algunos alimentos que generan mayor porcentaje de reacciones alérgicas en las personas. Estos son el “grupo de los 8”, al cual en el año 2021 se le agregó oficialmente un noveno participante.



Como ven, ni los frutos rojos ni el kiwi están en la lista, y esto es porque no son alimentos en los que esté descripta una gran prevalencia de reacciones alérgicas. Por supuesto puede haber personas alérgicas a los frutos rojos, o inclusive puede haber reacciones alérgicas “cruzadas”, es decir, una persona que es alérgica al látex puede ser alérgica al kiwi, porque dichos compuestos comparten proteínas similares, aunque uno sea una fruta y el otro un compuesto sintético.

Hoy por hoy, como explico en el capítulo 7 sobre alimentación complementaria, no se sugiere retrasar la introducción de los alimentos de la lista de arriba, excepto los lácteos por razones que ya hemos explicado, que no se sugieren hasta el año de vida.

Alergia a la proteína de leche de vaca (APLV)

La alergia a la proteína de leche de vaca (APLV) es la primera alergia alimentaria en Argentina. Del 2 % al 5 % de los niños y las niñas menores de 2 años presentan esta alergia, con diferentes manifestaciones, y un estudio realizado entre 2004 y 2014 muestra cómo la prevalencia se triplicó en ese lapso de tiempo.

Una de las razones de esa alta prevalencia de APLV es la introducción temprana de la leche de fórmula. Recordemos que la leche de fórmula es leche de vaca modificada para ser tolerada y para que sus nutrientes sean absorbidos por el bebé, pero no deja de contener proteínas diferentes a las proteínas de la leche humana. El intestino del recién nacido es muy inmaduro y ante la presencia de la proteína de leche de vaca, puede reaccionar generando una respuesta inmune y una alergia concomitante. Muchas veces los bebés son separados de sus madres al nacer por protocolo médico (no protocolo de salud: eso no es salud, hablando por supuesto de bebés que no requieren asistencia médica inmediata por alguna condición) y se les administra leche de fórmula sin siquiera avisarle a las familias. Esto se denomina coloquialmente “biberón pirata” y es fundamental que los profesionales de la salud evitemos esa intervención cuando está disponible la lactancia o leche humana de banco.

Además de todo esto, hoy se está estudiando profundamente el rol de la vitamina D y sus acciones como hormona, y también su papel en las alergias. La mayor parte de la población tiene déficit de vitamina D, debido a las condiciones de vida (en el momento en que escribo este libro, exacerbado por la pandemia de COVID-19), y esto generaría respuestas inmunes no benéficas para el organismo.

- ¿Hay bebés con lactancia materna exclusiva desde el nacimiento que pueden tener APLV? Sí, porque ciertas proteínas de la leche de vaca pasan por la leche humana si la madre consume lácteos.

- **¿Cuáles son los síntomas de APLV?** Los síntomas van a depender del mecanismo inmunológico involucrado en la alergia de ese bebé, niño o niña. Si la alergia está mediada por anticuerpos, más específicamente por inmunoglobulina E (IgE), los niños y las niñas pueden presentar cuadros que van desde la alergia oral (coloración rojiza e inflamación de la boca y alrededor) hasta reacciones muy graves como la anafilaxia, en la que todo el cuerpo reacciona inclusive causando obstrucción de la vía aérea por inflamación de la misma.

Si la alergia está mediada por células (la llamamos “no mediada por IgE”), encontramos los típicos signos gastrointestinales, con diversas manifestaciones. Un síntoma muy frecuente es la caca con sangre. Importante saber que no toda caca con sangre es sinónimo de alergia alimentaria, pero que es importante consultar a la brevedad si aparece.

Hay síntomas que, encima, implican los dos mecanismos inmunológicos.

El reflujo, los cuadros respiratorios, la dermatitis atópica, el dolor abdominal, los vómitos y las diarreas frecuentes, son todos signos que debemos analizar pensando en una alergia alimentaria dentro del *pool* de diagnósticos posibles.

IgE	Mixtas IgE/ Células T	Células T
• Alergia oral • Urticaria • Angioedema • Anafilaxia	• Dermatitis atópica • Gastroenteritis y esofagitis eosinofílica	• Gastroenterocolitis • FPIES • Enteropatía • Proctocolitis • Gastritis

Fuente: Wasserman, S. y Watson, W. (2011). Food allergy. *Allergy Asthma Clin Immunol*, Suppl 1(Suppl 1):S7. DOI: 10.1186/1710-1492-7-S1-S7. PMID: 22166142; PMCID: PMC3245440.

- Los bebés que tienen alergia a la proteína de leche de vaca, ¿pueden comer carne de vaca? La cuestión es que la leche de vaca contiene DIFERENTES proteínas, y al decir “alergia a la proteína de leche de vaca”, no aclara a CUÁL

proteína es la persona alérgica. La leche de vaca contiene más de 40 proteínas: caseínas (alfa-S1, alfa-S2, beta y kappa caseínas) y seroproteínas (alfa-lactoalbúmina, beta-lactoglobulina, lactoferrina bovina, seroalbúmina bovina), e inmunoglobulinas bovinas. La leche humana no tiene beta-lactoglobulinas propias, pero se puede encontrar en pequeñas cantidades si la madre consume lácteos. Esta proteína es aquella para la cual se reporta el mayor número de sensibilizaciones tempranas.

Si la persona tiene alergia, por ejemplo, a la lactoferrina bovina, esta proteína también se encuentra en la carne de vaca y no podrá consumirla. Son la menor parte de los casos, dado que la mayoría de las alergias corresponde a hipersensibilidad a la beta-lactoglobulina, que inclusive disminuye con el calor o la fermentación (es por esto que algunas personas con alergia son más tolerantes al yogur o a las preparaciones cocidas).

- **¿Por qué mi hijo o hija tiene APLV?** Cuando una persona presenta alguna condición de salud, nos preguntamos muchas veces qué factores hicieron que sea así. Y a veces no hay una respuesta clara. Existe un componente genético: si ambos mapadres son alérgicos –cualquier alergia–, hay mayor chance de que hijos e hijas lo sean. Otros factores que desbalancean la microbiota como el nacimiento por cesárea, la introducción temprana de leche de fórmula, el hiperhigienismo, el consumo de ultraprocesados y los disruptores ambientales, como mencioné al comienzo de este capítulo, pueden colaborar. Esto no es una cuestión de culpa, es importante resaltarlo. Si nuestro hijo o nuestra hija tiene alguna condición de salud o algún factor de riesgo, no es que “hicimos las cosas mal”, sino que vivimos en un mundo en el que muchas acciones culturales deben cambiar para ser más sanas. Y en esto último sí podemos colaborar.
- **¿Cómo se diagnostica la APLV?** El único método para llegar a un diagnóstico es eliminar las proteínas de leche de vaca de la alimentación del niño o la niña, de la alimentación de la mamá que amamanta y también evitar la contaminación cruzada, de la mano de

un seguimiento interdisciplinario con pediatra y especialistas.

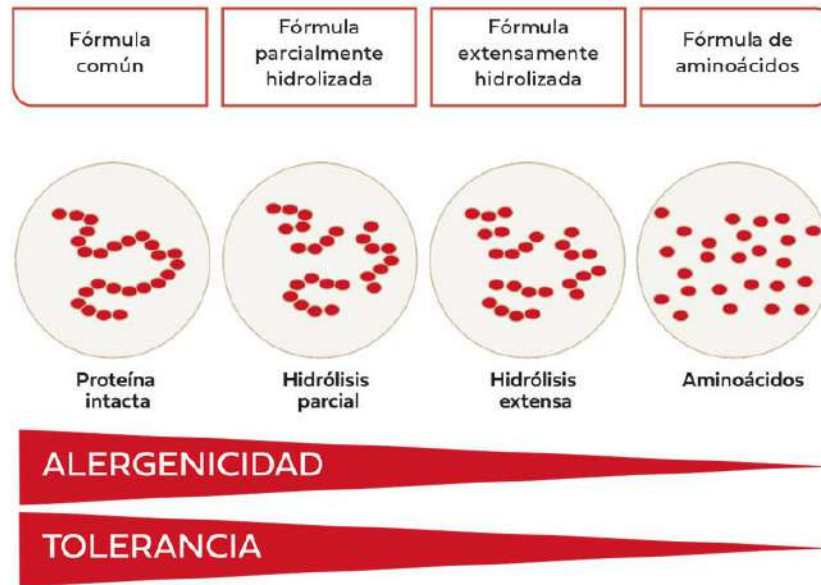
Si el bebé es alimentado exclusivamente a pecho y es menor de 6 meses:

- + Excluir de la alimentación de la mamá todo lácteo, derivado o traza durante dos semanas y evaluar cambios. A veces se requiere más tiempo para observar los efectos, pero observar luego de dos semanas puede ser una gran oportunidad para ajustar algunas cuestiones de la alimentación. Si el bebé no mejora nada, tenemos que consultar al equipo especialista los pasos a seguir.
- + Si el bebé mejora a cabo de dos semanas, se sugieren dos semanas más de dieta libre de lácteos, y después de la cuarta semana, se reintroduce la proteína de leche de vaca en la alimentación de la mamá (si se sospecha alergia mediada por IgE, esto no se realiza para evitar riesgo de anafilaxia). Si los síntomas vuelven, se confirma el diagnóstico. Si no vuelven, en un principio se descartaría APLV (recordemos que los síntomas son muy inespecíficos), pero nos deja atentos.

Si el bebé es alimentado a fórmula exclusivamente y es menor de 6 meses:

- + Dependiendo los síntomas, se indicará cambiar la leche por las llamadas “leches hidrolizadas”, en las que las proteínas de la leche de vaca están “rotas” y resultan menos alergénicas para algunos bebés. El problema es que son muy costosas y muchas veces de feo sabor. Es importante saber que la obra social o el sistema público debe cubrir el costo de estas leches dado que son necesarias para la salud del bebé.
- + Las fórmulas indicadas para bebés con APLV o sospecha de APLV son las extensamente hidrolizadas y las de aminoácidos (estas sobre todo si no funcionan las extensas o la alergia es muy grave). Las parcialmente hidrolizadas no tienen buen resultado.

Tipos de fórmula hidrolizada



Si el bebé hace lactancia mixta:

- + La mamá debe hacer la dieta y, además, debe ofrecerse una leche hidrolizada extensa.

Si el bebé tiene más de 6 meses:

- + Además de los cuidados con la leche, no debe consumir ningún producto con proteína de leche de vaca ni trazas.

Si buscamos confirmar o descartar APLV en un niño o una niña más grande, además de no consumir leche ni derivados lácteos, es importante observar las trazas.

No es indicación profesional suspender la lactancia. Inclusive, ciertos componentes de la leche humana hacen que la alergia sea menos grave. Otra cosa es si la mamá desea destetar por diferentes causas: siempre acompañaremos su deseo con información correcta.

Si la alergia se confirma, es preciso seguir con la dieta durante mínimo 6 meses, o hasta el año de vida del bebé, mínimo. Allí se sugiere realizar un “enfrentamiento” con la leche de vaca, siempre que se sospeche que la alergia se ha superado. Esto consiste en exponer a un bebé, niña o niño con APLV a cantidades pequeñas de proteína de leche de vaca en distintas formas, que se

van aumentando paulatinamente, y ver la tolerancia.

De nuevo, es importante que el o la profesional dé pautas claras de cómo realizarlo. No hay un desafío estandarizado, se realiza a la medida de cada familia: por ejemplo, si la familia no consume yogur ni dulce de leche, o tiene un posicionamiento alimentario vegano, claramente no se la obligará a consumir estos productos. Si el bebé toma pecho, se puede comenzar introduciendo alimentos en la dieta de la mamá: primero liberar trazas, luego proteínas de leche de vaca con algún tratamiento o cocción, como panificados o quesos duros. Luego se podría ofrecer yogur o dulce de leche, posteriormente leche fluida, y recién allí ofrecerle lácteos al niño o la niña. Si no es amamantado, este mismo camino de alimentos se podría ofrecer para el desafío después del año.

Si el niño o la niña vuelve a presentar síntomas, es que no ha superado la alergia y hay que continuar los cuidados y la dieta.

- **¿Y la leche deslactosada o descremada?** La leche deslactosada tiene reducción en el contenido de lactosa, con la misma cantidad de proteínas. La leche descremada tiene reducción en el contenido de grasa, con la misma cantidad de proteínas. Recordemos que el problema son las proteínas. Ninguna de estas leches es apta ni sugerida para la persona que amamanta ni para el bebé.
- **¿Hay que adelantar la alimentación complementaria en los niños y las niñas con APLV?** No, no hay evidencia que sustente esto. La lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses es el mejor factor protector de complicaciones a corto y largo plazo.
- **¿Con qué cocino si mi bebé tiene APLV?** Las preparaciones que llevan leche de vaca (que más allá de la alergia o no alergia, no se sugieren hasta mínimo el año de vida) se pueden hacer con leche humana, leche de la fórmula que utiliza el bebé o bebidas vegetales aptas. También, si es cuestión meramente de humedad de la masa, se puede usar agua o jugos de frutas.

- ¿Cómo tiene que estar formado el equipo que acompaña a una familia con APLV? No alcanza (y es incorrecto) decirle a la familia “no coma lácteos por un tiempo y vemos”. Es fundamental orientar con claridad cómo se inicia la prueba diagnóstica. El pediatra puede iniciar el proceso diagnóstico, y de confirmarse (y si no se confirma más aún, necesitamos más ojos y cabezas para pensar), es fundamental que exista un equipo para acompañar a esa familia. El equipo debe contar sin duda con gastroenterólogo/a, alergista y nutricionista (la alimentación de ese niño o esa niña y de su familia es fundamental en estos casos), y puede ser necesario también trabajar con puericultoras, terapeutas ocupacionales y odontopediatras.

- ¿Qué son las pruebas diagnósticas? La alergia a la proteína de leche de vaca no se diagnostica por estudios de laboratorio (¡lamentablemente! Sería más sencillo), sino a través del proceso que ya vimos. Una vez que se tiene el diagnóstico, se pueden hacer pruebas de sangre para definir si la alergia es o no mediada con IgE, aunque los resultados de las pruebas actuales que tenemos no son extremadamente fiables (en el 30 % de los casos, por ejemplo, se encuentran falsos negativos).

Existen también test cutáneos: el *prick test*, la intradermorreacción y las pruebas del parche. En las dos primeras se instilan alérgenos en la piel con un pequeño pinchazo y se observa la reacción. En la última, se coloca un parche en la piel durante 48 horas para ver la reacción. Ninguna de estas pruebas sirve para indicar gravedad: si la reacción es mucha o poca no importa, importa si hizo reacción o no.

También existe la prueba tipo RAST o IgE específica, que evalúa si existen anticuerpos específicos contra ciertas proteínas. Suena genial pero solo confirma la sospecha clínica y tiene muchos falsos positivos y falsos negativos.

- ¿Se usan probióticos? Al día de la fecha, no hay bibliografía clara ni contundente para indicar probióticos a bebés o madres de bebés con APLV. Recordemos que los probióticos son cepa-

dependientes y dosis-dependientes, y todavía no hay determinado probiótico que mejore los síntomas de la APLV. Sí se pueden pensar probióticos específicos si los profesionales observan alguna disbiosis a tratar en la mamá o algunas situaciones puntuales en el bebé, pero no por la APLV en sí.

- **¿Sirve evitar los lácteos y derivados en un próximo embarazo para prevenir en un próximo bebé la alergia?** Aún no hay evidencia que sustente esta premisa. Tampoco la sugerencia de darle a un hermano o hermana leche hidrolizada: siempre la lactancia materna será protectora.
- **¿Qué pasa con las vacunas?** Las vacunas que contienen combinación de las bacterias de difteria y tétanos son preparadas en un medio derivado de proteínas de leche de vaca y pueden contener nanocantidades (una forma de llamar a las cantidades ínfimas) de caseína, al igual que la poliovirus oral, que contiene alfa-lactoalbúmina. Ambas podrían ser responsables de anafilaxia en pacientes con APLV mediada por IgE. Se debe consultar al especialista en alergia para su aplicación en estos pacientes (solo los que tienen alergia mediada por IgE).

La vacuna oral para polio se discontinuó en Argentina en 2020 (¡gran logro epidemiológico para nuestro país!). Fue una gran estrategia para combatir la poliomielitis en América, pero gracias a que esta enfermedad está casi erradicada, no necesitamos más esa forma de vacuna.
- **¿Cómo nos damos cuenta si nuestro/a hijo/a mejora?** Porque los síntomas van mermando. Desaparece la sangre en la caca, mejora la piel, hay menos cuadros de infecciones respiratorias, los bebés están francamente de mejor humor. El moco de la caca, cosa que preocupa mucho a las familias, es lo último que suele desaparecer.

- ¿Qué pasa si el bebé o el/la niño/a no mejora? Hay que buscar otras causas de lo que le está pasando. Pero antes de eliminar otro alimento de la dieta, es necesario hacer la consulta con el o la profesional. Tal vez simplemente hay que ajustar ciertas cuestiones de contaminación cruzada, y no es que el bebé es alérgico a otros alimentos, sino que está en contacto con la proteína de leche de vaca indirectamente. Si todos los cuidados son tomados y aun así el bebé no mejora, hay que evaluar que sea alérgico a otro alimentos (se observa mucha reactividad cruzada con la soja, por ejemplo) u otro diagnóstico.
- ¿La APLV se revierte? La mayoría de los niños adquiere tolerancia luego de 1-2 años de tratamiento específico, y por experiencias clínicas, se conoce que el 95 % de ellos lo logra a los 3 años.
- Aunque revierta, ¿necesita tomar leche? No, no necesita. Es una opción para algunas familias, no una obligación. Se pueden obtener los nutrientes que traen los lácteos en otros alimentos.
- ¿Entonces le doy leches vegetales (almendras, maní, coco, soja, etc.)? Antes, a los niños y las niñas con sospecha de APLV se les recetaba leche de soja (no existían los hidrolizados extensos). La soja genera mucha reactividad cruzada con la proteína de leche de vaca, y no se sugiere. Si no hay otra opción, podría ofrecerse recién a los 6 meses, pero como dije antes, no es de primera elección. Las bebidas vegetales caseras no contienen nutrientes, son agua mezclada con algunos componentes del fruto seco o semilla. Las compradas pueden estar fortificadas, pero tampoco son una sugerencia.
- ¿Y las leches de otros animales (cabra, oveja, búfala)? Hay leches de otros animales más “parecidas” a la leche

humana. La de cabra, por ejemplo, o la de camella (sí, de camella). Algunos niños y niñas con APLV no reaccionan a leches de otros animales, pero como no sabemos a ciencia cierta quién lo hará y quién no, no se sugiere.

- ¿Cómo sé que no es alérgico/a a otra cosa? La proteína de leche de vaca comparte reactividad cruzada con la proteína de la soja, por lo que muchos de los niños y las niñas que son alérgicos a una, lo son a la otra. ¡Pero no todos! También muchos niños y niñas son multialérgicos, y reaccionan a alimentos variados como legumbres, frutos secos, carnes, cáscaras de algunas frutas. Por eso es importante el equipo profesional, para poder resolver dudas y evaluar síntomas. No se sugiere eliminar alimentos por cuenta propia, porque complica el diagnóstico, sino primero evaluar la contaminación cruzada y otros factores. Si realmente hay que restringir otro alimento de la alimentación del bebé o de la mamá, tiene que haber un nutricionista que ayude a balancear los nutrientes del resto de la alimentación para que no falte nada.

Alimentos e ingredientes a evitar

Las familias con niños y niñas con APLV y otras alergias alimentarias se convierten en expertas lectoras de etiquetas. **No basta con quitar los lácteos obvios: casi todos los productos industriales tienen alguna proteína de leche de vaca.** Dejo a mano este cuadro útil que aprendí en el Curso de Posgrado de Alergias Alimentarias del Hospital Italiano:

ALIMENTOS QUE DEBEN SER ELIMINADOS EN LA DIETA A LA LECHE DE VACA, LECHE Y DERIVADOS	ALIMENTOS QUE CONTIENEN LECHE O PRODUCTOS LÁCTEOS	INGREDIENTES QUE SE DEBEN BUSCAR EN LAS ETIQUETAS
Leche descremada o leche en polvo y sólidos lácteos Manteca Leche evaporada Yogur Nata, queso crema, crema agria Queso, queso en polvo o salsa de queso Cuajada Suero y productos del suero Queso <i>cottage</i> Leche condensada Grasa animal Dulce de leche	Gratinados Chocolate y dulces de crema Café crema Crema de alimentos, sopas crema Caldos deshidratados Turrón Helados Leche malteada Margarina (algunas de ellas, comprobar la etiqueta) Cremas Salsa blanca Harina rica en proteína Embutidos (salchicha, salchichón, otros) <i>Simplese</i> Amasados de pastelería	Lactoalbúmina Fosfato de lactoalbúmina Lactoglobulina Caseína o caseinato de sodio Caseinato de potasio Caseinato de magnesio Coágulo de caseína Lactosa (azúcar de la leche) Aditivos para dar sabor (caramelo, crema, azúcar negra, manteca) Condimento natural

Curso de Posgrado en Alergias Alimentarias, Hospital Italiano, 2017.

- Procurar no tener en la heladera ni al alcance de los niños aquellos alimentos que no se pueden consumir, para evitar equivocaciones, ingestas que les puedan hacer mal o angustia.
- Si come en el colegio, se recomienda hacer una copia de las indicaciones y entregarla al responsable del comedor o directivo a cargo. Avisar al kiosco.
- Se recomiendan las preparaciones “caseras”. Es difícil confiar en las comidas elaboradas fuera del hogar. Al comer fuera de su casa, comamos comidas sencillas y preguntemos específicamente al personal del restaurante sobre los ingredientes de las comidas en el menú (aunque siempre habrá contaminación cruzada y si nuestro hijo o hija tiene reacciones severas, es mejor evitar comer afuera).
- Deben evitarse los alimentos fritos y los preparados con rebozador comprado, incluso si ese rebozador no contiene productos lácteos. El aceite empleado para freír puede haber sido utilizado antes para freír algún otro alimento que sí contenía leche. La contaminación cruzada puede ser un problema, sobre todo en los servicios de “tenedor libre” en los cuales las cucharas para servirse pasan a menudo de un contenedor a otro (entre los que puede haber comidas con leche o

productos lácteos).

- Observar las etiquetas de los alimentos para evitar componentes lácteos y trazas.
- Evitar comprar suelto en la dietética, porque puede estar contaminado con proteína de leche de vaca. Leer hasta los envases de las legumbres...
- Si el bebé es lactante y la mamá hizo *stock* de leche, no debería usarlo hasta que se diagnostique o descarte la alergia. Si se confirma... ese *stock* no podrá ser usado para ese bebé. Sí, a mí también me duele en el alma. ¡Pero no hace falta tirarlo! Se pueden hacer preparaciones para el resto de la familia (¿asco? Pero si la leche de las tetas de la vaca la tomamos sin drama...).

La contaminación cruzada

La proteína de leche de vaca suele quedar adherida a diversas superficies, sobre todo el plástico o las esponjas de cocina.

Es por esto que, en muchos casos, sobre todo cuando no hay mejoría, se sugiere:

- Separar la vajilla que va a usar ese niño/a y la mamá que amamanta, y que no se mezcle con la otra. También recipientes plásticos de todo tipo. Intentemos usar distintos cuchillos (de los que usan todos los integrantes de la familia) para untar, y utilizar distintos utensilios para alimentos, que la gente podría tocar después de haber tocado algún producto lácteo. Inclusive no se sugiere compartir mate ni bombilla.
- Usar una rejilla y una esponja diferentes a las que usamos para el resto de la familia, lo mismo que los repasadores.
- El horno y el microondas pueden estar contaminados. Aquí hay varias opciones: podemos envolver la comida del niño o de la mamá con papel *film* o de aluminio, o con bolsas para horno (no de las que traen sabores); o podemos usar ollas que hornean exclusivamente para ellos, si tenemos la opción.
- La licuadora y la minipimer son difíciles de limpiar y no se recomienda usarlas a menos que sean exclusivas o con vaso de vidrio.
- Mamaderas y chupetes deben ser reemplazados cuando se inicia la dieta, porque puede haber proteína adherida al plástico.
- La mesita de comer, si es heredada, puede contener proteína de leche

de vaca de las comidas del bebé que la utilizó antes. Al ser de plástico, a veces no alcanza con lavarla y puede causar reacciones.

- Además de la alimentación es importante chequear que los productos de limpieza, cosméticos y medicamentos no contengan los ingredientes mencionados, porque también pueden generar reacción.

¿Siempre hay que ser tan estrictos con la contaminación cruzada?

No, dependerá de la severidad de los síntomas del bebé en cuestión.

La dieta del amor

Hacer la “dieta del amor”, como se suele llamar a estas dietas tan complejas en este mundo lleno de productos procesados, es un esfuerzo gigante que se conjuga con el puerperio, la angustia por ese bebé al que le pasa algo, el cuidado de otros hijos e hijas, y ahora le sumamos de yapa una pandemia.

Casi todo lo que se compra tiene en algún lado proteína de leche de vaca. Es agotador andar leyendo cada paquete, y renegando con las empresas que etiquetan mal (¡necesitamos urgente una ley de etiquetado de alérgenos en Argentina, que obligue a las empresas a etiquetar correctamente!). *Mails* a las marcas preguntando si el producto es apto, miles de comentarios en grupos de Facebook buscando información y, muchas veces, mucha soledad.

Buscar tribu es fundamental, pero también es importante saber que cada niño o niña es un mundo y no es útil comparar lo que le sucede a uno con lo que le sucede a otro. Sí es fabuloso compartir información, inclusive de profesionales actualizados y de lugares respetuosos donde ir a comer o a atenderse. Y, sobre todo, brindar una palabra de aliento cuando todo parece infinitamente cuesta arriba.

Los equipos que acompañan alergias alimentarias deben contar con psicólogos y otros profesionales de la salud mental para brindarle a la familia ese espacio. Puede haber enojo, angustia, ganas de revolear todo y salir corriendo. Son reacciones más que válidas, entre el cansancio y la confusión. Darles lugar y poder trabajarlas es importante.

Ultraprocesados y alergias alimentarias

Cuando un niño o una niña tiene una alergia alimentaria, es porque su cuerpo está reaccionando en forma exagerada y nociva a un alimento al que estuvo expuesto. Cabe preguntarse también qué sucede en su intestino, y cómo está su microbiota en pleno. Si esta microbiota está muy desbalanceada, además de los síntomas de la alergia, habrá otros síntomas de malestar. **Necesitamos que ese intestino esté sano más allá de la alergia alimentaria.**

Existen ultraprocesados “aptos” APLV y otras alergias, lo cual no los hace buenos alimentos. Algo que tiene tres azúcares, un edulcorante y colorantes no le hará bien a la microbiota de nadie, más allá de que no gatille una reacción alérgica. ¿Los ultraprocesados generan alergias alimentarias? La relación nunca puede ser lineal de causa y efecto, pero que contribuyen a la disbiosis y la permeabilidad intestinal, seguro, y pueden empeorar síntomas de la alergia.

Intolerancia a la lactosa

La intolerancia a la lactosa, que como bien dije antes, es diferente a la alergia a la proteína de leche de vaca, **es la incapacidad del organismo de metabolizar correctamente la lactosa, un azúcar presente en la leche (no una proteína).** Existen dos tipos de intolerancia a la lactosa:

- **La que es genética y extremadamente poco frecuente.** El bebé carece genéticamente de la enzima que corta la lactosa, inclusive la de la leche humana, y se observa desde la primera ingesta de leche. De acuerdo con la severidad del cuadro, en estos bebés se amerita la introducción de leche de fórmula deslactosada.
- **La más común, por edad o cuadros transitorios de gastroenteritis.** Desde los 3 años, se empieza a perder la función de la enzima lactasa en el intestino, y metabolizamos peor la lactosa. Lo mismo sucede cuando hay algún cuadro de infección en el intestino. Algunas poblaciones son extremadamente intolerantes a la lactosa. No es una enfermedad, es un proceso natural del cuerpo donde, si lo observamos atentamente, tal vez nos dice que no somos lactantes y que no

necesitamos litros de leche para sobrevivir después de determinada edad.

La intolerancia tiene diversas manifestaciones: diarrea, gases, dolor abdominal al consumir leche. El yogur y el queso suelen ser mejor tolerados porque tienen menor contenido de lactosa. Salvo en el caso de la intolerancia a la lactosa congénita, que requiere tratamiento médico, **es normal que paulatinamente vayamos perdiendo la capacidad de tolerar la lactosa.** No hace falta comprar leche deslactosada ni probióticos para metabolizar la lactosa de la leche (juro que ya se están vendiendo), simplemente empecemos a mirar los lácteos como una opción alimentaria y no una obligación ni una base para la buena salud.

Alergia al huevo

La alergia al huevo es la segunda más común en la infancia. Comparte, como otras alergias alimentarias, los factores de riesgo con la APLV. Algunas personas son alérgicas a la clara, otras a la yema y otras a ambos componentes. Es imposible separar la yema de la clara del huevo, porque hay proteínas cruzadas estructuralmente entre ellas. El huevo puede ser ofrecido desde el inicio de la alimentación complementaria, y evaluar la reacción del bebé al mismo (ver la guía práctica de alimentación en el capítulo 7).

- ¿Qué alimentos hay que evitar? Huevo y alimentos que lleven huevo, por supuesto. En los productos industriales, medicamentos, cosméticos y productos de limpieza, buscar y evitar ingredientes como la lecitina (la de huevo, la de soja se podría), lisozima, albúmina, coagulante, emulsificante, gloubina, livetina, ovoalbúmina, ovomucina, ovomucoide, otransferrina, ovovitulina, vitelina, E-16b (luteína, pigmento amarillo).
- ¿Qué pasa con las vacunas? Hay tres vacunas que se fabrican en medios que contienen huevo: la antigripal, la triple viral

(que protege contra sarampión, rubeola y paperas) y la de la fiebre amarilla.

La vacuna de fiebre amarilla se coloca solamente en situaciones donde el niño o la niña esté expuesto a dicha enfermedad, o viaje a una zona de riesgo. Para indicarla, hay que evaluar riesgo o beneficio. La vacuna antigripal se indica desde los 6 meses hasta los 2 años, o en grupos de riesgo (enfermedades crónicas, cardiopatías, etc.).

Estas dos vacunas contienen microgramos de proteínas de huevo, y sí, se aplican en niños con dicha alergia. Pero para niños o niñas que hayan presentado signos de anafilaxia, es preciso aplicarlas en un centro de salud con mayor complejidad, avisar al personal que vacuna y esperar un rato después de la aplicación para observar la reacción.

La vacuna triple viral contiene nanogramos de proteínas de huevo (mucho menos que microgramos) y se indica a los 12 meses y al ingreso escolar. Hace poco hubo un brote de sarampión en nuestro país después de muchos años de no estar presente la enfermedad. La vacunación es fundamental, así que se indica con las mismas pautas de cuidado que mencioné antes.

- **¿Cómo reemplazar el huevo en las preparaciones?** En muchas preparaciones es muy posible reemplazar el huevo y que quede muy similar. En otras no tanto, como un flan, por ejemplo. Habrá que buscar otro postre rico. Pero vamos a lo que sí nos sirve para unir preparaciones, o darles humedad.

Un huevo se puede “reemplazar” por:

- **Harina de garbanzo:** 3 cucharadas pequeñas.
- **Chía o lino:** 1 cucharada + 3 de agua. Dejar hidratar, se generará un gel que se llama “mucílago”, y se puede usar para ligar las preparaciones.
- **1 banana pisada.**
- **1 manzana cocida y pisada.**
- **Agar-agar** (una sustancia derivada de las algas que genera una gelatina).

Es cuestión de ir experimentando y probando lo que más nos sirve para la preparación que estemos encarando.

Celiaquía, alergia al trigo y sensibilidad al gluten no celíaca

Son entidades diferentes, aunque se parezcan en el nombre:

- **La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune, en la que el propio organismo ataca a la mucosa intestinal** (capa del intestino que trabaja en la absorción de nutrientes), generando una atrofia y disfunción de la misma, en personas genéticamente predispuestas. El cuerpo reacciona ante proteínas de alimentos, como el gluten, y ataca al propio organismo. Tiene muchas manifestaciones, no solo en el intestino. A veces, la sospecha diagnóstica viene a partir de observar anemia, alteraciones en los dientes, dermatitis o problemas en el crecimiento. De ahí la importancia de los controles de salud y el ojo clínico del profesional que acompaña. El tratamiento para la celiacía es evitar el gluten en cualquier forma. Las personas también deben tener mucho cuidado con la contaminación cruzada (similar a lo que se mencionó para APLV).

El gluten se encuentra fundamentalmente en el trigo, la cebada, el centeno y en la avena. En sí, la avena no contiene gluten, pero en nuestro país se utilizan las mismas máquinas para su cosecha, y los mismos lugares para su guardado, así que se considera que la contaminación es alta y no se recomienda su consumo.

- **¿Y qué se come? ¿Es para siempre?**

Muchas cosas tienen gluten, desde alimentos a medicamentos y cosméticos. Muchas. Culturalmente comemos kilos de harina de trigo por día, la mayor parte de nuestros panificados la contienen. Cuando decimos “harina”, pensamos en la harina de trigo. Pero existe un universo de opciones “harinescas” a descubrir. Harina de sorgo, teff,

amaranto, mijo, lupino y arroz son opciones que tal vez no hayamos escuchado siquiera nombrar antes. Existen, las encuentran en el capítulo 8 (“Pequeño manual BLW ilustrado”) y se pueden introducir desde el inicio de la alimentación complementaria. Es cuestión de aprender.

La enfermedad celíaca sí es para siempre. El tratamiento es excluir el gluten toda la vida. Esto que parece imposible seguramente al principio del asunto, es fundamental para la salud de esas personas.

- **¿Dónde consultar el listado de ALIMENTOS LIBRES DE GLUTEN (sin TACC)?**

http://www.anmat.gov.ar/Enfermedad_Celiaca/principal.asp

- **¿Dónde consultar el listado de medicamentos sin TACC?**

Si el envase no declara libre de TACC, se sugiere consultar directamente al laboratorio fabricante.

- **¿Dónde consultar sobre contenido de gluten (TACC) en productos cosméticos?**

cosmetovigilancia@anmat.gov.ar

- **¿Cuándo se debe introducir el gluten en la dieta de los niños y las niñas?**

Además de sugerir el mantenimiento de la lactancia materna como factor protector para disbiosis, en todo bebé, independientemente del riesgo genético (aunque tenga madre, padre y hermanos con celiacía), se recomienda introducir el gluten desde el inicio de la alimentación complementaria. Introducirlo tardíamente no modifica el riesgo de presentar enfermedad celíaca más adelante.

- **Si yo creo que mi hijo o hija tiene celiacía, ¿debería dejar de darle gluten?**

No hasta que no se hagan la consulta y las pruebas correspondientes. Puede tratarse de otra condición, inclusive de otra alergia alimentaria. Para certificar que una persona es alérgica al gluten es necesario hacer análisis de sangre y, casi siempre, una biopsia del intestino delgado. Obviamente que esto último puede dar miedo y por eso hay muchos

estudios buscando la manera de hacer un diagnóstico sin necesidad de pasar por ese procedimiento. ¡Ojalá pronto tengamos novedades sobre el tema!

- **La alergia al trigo se da por una reacción inmunológica a otras proteínas presentes en los cereales, las prolaminas (no el gluten).** Las personas alérgicas al trigo pueden serlo a otros cereales, como el arroz o el maíz. También algunas de estas proteínas se comparten con algunas cáscaras de las frutas. Que lío, ¿no? Menos mal que tenemos a los especialistas en alergia para trabajar con ellos y ellas.
- **La intolerancia al gluten no celiaca aún está en estudio. Son personas que si bien no parecen presentar una predisposición genética clara, el gluten genera cierto grado de inflamación intestinal y otros síntomas que remiten cuando se elimina de la dieta.** Como siempre, también es importante evaluar el contexto de la alimentación y la microbiota.

¡Qué difícil es educar a los adultos! Mucha gente del entorno no comprende realmente el esfuerzo y considera que “un poquito no hace nada”. Se escuchan frases como... “Dejaaaaalo comer un heladito, ¿qué le va a hacer?”. “Ah, sí, esto tenía crema, pero poquita, no creo que le haga nada”. “Le compré estas galletitas porque me pidió y me dio pena”. “Bueno, tranquila, ¡tampoco seas exagerada!”.

¿Cómo explicarle al entorno? Si vamos a comer con otras personas, HABLAR con el resto de los comensales ANTES de la reunión. Con adultos y niños. Explicar claramente que debemos tener ciertos cuidados y que eso no nos impide juntarnos y pasarla bien. ¿Podemos comer todos lo mismo? **Siempre el menú más inclusivo es el que no le hace mal a nadie.** Si el menú no puede ser igual para todos (por temas de gustos y costos), evitar insistir que “Juan come distinto”. Integrar, incluir, dejar estas pequeñas cosas de lado... Lo importante es la reunión.

Es fundamental remarcar los conceptos de TRAZAS, DERIVADOS y CONTAMINACIÓN CRUZADA (mucha gente ignora estas cuestiones). El concepto de “un poquito” también es trabajable. En este caso, un poquito puede hacer mucho daño. Subrayemos a los adultos que... ¡somos adultos! Y que estamos cuidando la salud de un niño. Si los adultos no podemos seguir

un límite que tiene que ver con la salud, muy difícil será construir límites con los chicos.

Solicitemos lavado de manos antes de tocar a un niño con alergias alimentarias. Casos severos de alergia a la proteína de leche de vaca, alergia al huevo o de celiaquía pueden provocar reacciones importantes solo al contacto. Por ejemplo, a un adulto que está comiendo galletitas que tienen trazas, aunque tal vez no lo sepa, le quedan miguitas en las manos, no se las lava, le hace upa a su sobrinito, y ese niño tiene una reacción severa y termina en el hospital. ¡Nadie quiere que los chicos se sientan mal ni se enfermen! Y esto amerita ser muy muy cuidadosos.

Intolerancias alimentarias y niños y niñas con trastorno del espectro autista

Muchos niños y niñas con diagnóstico de trastorno del espectro autista (TEA) presentan lo que llamamos “problemas médicos concomitantes al diagnóstico” (PMCD). Entre ellos encontramos diarrea, dolor abdominal, sinusitis, rinitis, constipación y más. Estas niñas y estos niños muchas veces no pueden expresarnos la molestia y el dolor, y suelen evidenciarse con ciertas conductas que a los adultos nos confunden: por ejemplo, apoyar constantemente la panza sobre la mesa para hacer presión, lo cual disminuye el dolor. **Estas molestias suelen ser tomadas como manifestaciones del autismo, y no como un problema de salud concomitante, y a raíz de eso, se dejan de lado y no se busca el alivio de los síntomas.**

Los niños y las niñas con TEA suelen presentar intestino permeable, disbiosis intestinal y déficit de nutrientes. Esto también se encuentra frecuentemente, hoy en día, en niños y niñas con un desarrollo de acuerdo con su edad, y tampoco se le da la importancia que merece. Pero comprendiendo el TEA como una encefalopatía (inflamación del sistema nervioso) crónica, sistémica (que comprende a todo el organismo) y DINÁMICA, es fundamental que trabajemos en estas cuestiones que, al mejorarlas, siempre mejorará la salud.

Dentro de los trastornos gastrointestinales que presentan los niños y las

niñas con autismo, se observa frecuentemente la intolerancia a la caseína (una de las proteínas de la leche de vaca), a la soja y al gluten. **No incorporar a la alimentación estas sustancias, junto con una alimentación sin ultraprocesados, puede mejorar la salud de muchas niñas y muchos niños.** Suele tildárselas de dietas “restrictivas” y de “no dejarles disfrutar nada” a niños y niñas que, además, suelen tener muchas terapias, médicos, estudios y otras cuestiones que afectan su vida cotidiana. El problema es que plantear esto tan livianamente tal vez es quitarle a una persona la posibilidad de llevar una vida sin dolor o molestias constantes.

El autismo tiene muchas facetas y no, no existe “la dieta que cura el autismo”, pero puede existir una alimentación placentera (sí, placentera) que disminuya síntomas que a nadie le gustaría tener.

No estamos acostumbrados a pensar en el impacto de la alimentación en nuestra salud como un acto preventivo y terapéutico. Sí, es muy complejo culturalmente explicarle al colegio, a la familia y al equipo terapéutico que vamos a cambiar la alimentación y que no le ofreceremos nada con azúcar, colorantes, caseína ni gluten. Sí, también es muy complejo aprender de cero a manejar harinas, endulzantes, legumbres y cereales nuevos, y que estos pasen a ser parte de nuestro cotidiano. Por eso, desde los profesionales, debemos acompañar a las familias con información actualizada, y trabajar en equipo todos juntos. La alimentación es patrimonio de la familia de cualquier niño o niña, y esta no tiene por qué dar explicaciones al entorno sobre las decisiones tomadas.

Se necesitaría otro libro para explicar detalladamente este tema, pero no quería dejar de mencionarlo, porque existe y merece ser nombrado. A las familias que están atravesando un momento así, las abrazo profundamente. Sepan que hay equipos amorosos y actualizados para acompañarlos, más en esta época de virtualidad donde podemos llegar a más rincones del país.

María Fernanda Iroumé, terapeuta ocupacional, estimuladora temprana, consultora de porteo y mamá de Fidel, nos cuenta:

Antes del diagnóstico de autismo de mi hijo, como profesional no avalaba ningún abordaje para el autismo que incluyera cambios en la dieta. Qué locura, porque en realidad, no sabía NADA de ese tema. Muchos prejuicios limitaban mi razonamiento: tenés que cocinar mil horas al día, la comida saludable es muy cara, a un nene con

selectividad alimentaria restringirle las opciones le agudiza su cuadro, no se puede comer casi nada, no vamos a poder dejarlo disfrutar de un caramelo, no va a poder ir al jardín ni a los cumpleaños...

La pandemia de COVID-19 nos dio un empujón, el factor social como barrera para el bienestar de mi hijo desapareció de un plumazo. Horrible, pero real. La incapacidad de adaptar los menús institucionales o las reuniones a las necesidades de otros, es algo que ocurre siempre (celíacos y APLV, más otras cuantas intolerancias y alergias alimentarias, bien saben de esta forma de discriminación).

Y hacia allá nos encaminamos. Consultamos con una biomédica y una nutricionista. Otros mapadres que ya estaban en este camino nos fueron ayudando a entender cómo organizarnos.

A los cinco días de empezar, mi hijo ya comía todas las frutas, entendía para qué servía la cuchara (nunca antes había podido aprenderlo), nos miraba a los ojos y mejoraba significativamente su calidad de vida.

Hoy, un año después, puedo confirmar que no cocino mil horas, sigo trabajando y haciendo posgrados (incluso sábados y domingos), compro en los negocios del barrio, gasto lo mismo que antes, porque ya no consumimos ultraprocesados (que cuestan un dineral), mi hijo come feliz todos los grupos de alimentos.

Y hoy, tres veces me dijo “mamá”.

El mundo de las alergias e intolerancias alimentarias se va ampliando a medida que, lamentablemente, las estadísticas de las mismas van en aumento. La información cada vez es más para profesionales y familias, y puede ser agotadora y confusa. De ahí la importancia de equipos de salud que se encuentren, conversen, intercambien opiniones y transmitan un mensaje coherente. Los grupos de mapadres son fundamentales en el acompañamiento del día a día, siempre comprendiendo que cada niño o niña es un mundo y el

abordaje es individual. Ojalá, desde lo colectivo, podamos urgente cambiar este sistema productivo que cada vez nos enferma más –empezando por las personas más vulnerables, las infancias– a costa de llenarles los bolsillos a unos pocos.

Para seguir leyendo

PARA FAMILIAS

- Marino, G y Smid, S. *SOS. Alergia Alimentaria*, PAIDÓS, Buenos Aires, 2016.
- Serra, J. *Mi bebé APLV* (1.a ed.). *Olivia*, Buenos Aires, 2019.
- Oyarzo Salazar, M. *Cocina Biomédica*. Editorial Planeta, Buenos Aires, 2018.

PARA PROFESIONALES

- Comité Nacional de Infectología, Comité Nacional de Alergia. (2018). Recomendaciones para la vacunación segura en niños con riesgo de padecer reacciones alérgicas a componentes vacunales. *Arch Argent Pediatr*, 116(Supl2):S34-S47. Recuperado de: https://www.sap.org.ar/uploads/consensos/consensos_recomendaciones-para-la-vacunacion-segura-en-ninos-con-riesgo-de-padecer-reacciones-alergicas-a-componentes-vacunales-94.pdf
- Mehaudy, R.; Parisi, C.; Petriz, N.; et ál. (2018). Prevalencia de alergia a la proteína de la leche de vaca en niños, en un hospital universitario de comunidad. *Arch Argent Pediatr*, 116(3):219-223. Recuperado de: <https://www.sap.org.ar/docs/publicaciones/archivosarg/2018/v116n3a15.pdf>
- Orsi, M.; Fernández, A.; Follett, F.; Marchisone, S.; Saieg, G.; Busonia, V.; Toca, C.; Tabacco, O. (2009). Alergia a la proteína de la leche de vaca. Propuesta de guía para el manejo de los niños con alergia a la proteína de la leche de vaca. *Archivos Argentinos de Pediatría. Published*. Recuperado de: <https://www.sap.org.ar/docs/publicaciones/archivosarg/2009/v107n5a17.pdf>

- Barrantes Rojas, M. y Ruiz Acuña, M. (2018). Supresión de la lactancia materna exclusiva en menores de seis meses con alergia a la proteína de leche de vaca. *Revista Enfermería Actual en Costa Rica*. DOI: <https://doi.org/10.15517/revenf.v0i1.32296>.
- Ercana, N.; Bostancib, I.; Ozmenb, S.; Tekindalc, M. (2019). ¿Existe una asociación entre la concentración de vitamina D y la alergia a la proteína de la leche de vaca durante la lactancia? *Archivos Argentinos de Pediatría*, 117(5). DOI: <https://doi.org/10.5546/aap.2019.306>.
- Loyacono, N.; Sanz, M. L.; Gerbi, M. D.; Martínez, L. M.; et ál. (2020). Problemas gastrointestinales, nutricionales, endocrinológicos y de microbiota en el trastorno del espectro autista. *Arch Argent Pediatr*, 118(3):e271-e277. Recuperado de: <https://www.sap.org.ar/docs/publicaciones/archivosarg/2020/v118n3a18.pc>
- Ferreira, M. L. y Loyacono, N. (2011). Rationale of an Advanced Integrative Approach Applied to Autism Spectrum Disorder: Review, Discussion and Proposal. *J. Pers. Med*, 11, 514. DOI: <https://doi.org/10.3390/jpm11060514>.
- Jyonouchi, H. (2010). Autism spectrum disorders and allergy: observation from a pediatric allergy/immunology clinic. *Expert Review of Clinical Immunology*, 6(3), 397–411. DOI: 10.1586/eci.10.18.
- Loyacono, N.; Ferreira, M. L.; Iermoli, R. *Trastornos del Espectro Autista (TEA). Enfoque integrador. Del arte de lo posible a la investigación puesta en práctica* (1.a ed.), Ediciones Globales, Buenos Aires, 2018.
- Wakida-Kusunoki, G.; Villasis-Keever, M. A.; Calva Rodríguez, R. G.; Choperena-Rodríguez, R.; Xóchihua-Díaz, L.; Flores-Huerta, S.; et ál. (2019). Consumo de leche de vaca en la edad pediátrica. Revisión de la evidencia científica. Documento de consenso de la Sociedad Mexicana de Pediatría. *Rev Mex Pediatr*, 86 (Supl. 1): S3-S16. Recuperado de: <https://www.medigraphic.com/pdfs/pediat/sp-2019/sps191a.pdf>
- Curso Virtual de Actualización sobre Enfermedad Celíaca para Médicos y Bioquímicos. Secretaría de Salud y Desarrollo Social de la Nación, Plataforma SUMAR, 2018.
- World Allergy Organization. (2010). Diagnosis and Rationale for Action against Cow's Milk Allergy (DRACMA) Guidelines. *Pediatric Allergy and Immunology*, 21, 1–125. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1399-3038.2010.01068.x>.
- Ministerio de Salud. Consenso sobre Enfermedad Celíaca, 2017.

Recetas, *tips* y secretos para comer
saludable (y muy rico) en casa

No importa si las
preparaciones salen mal.
No importa si justo ese día
tus hijos no las quieren comer.
Solo importa que se divirtieron,
y que lo hicieron con amor.



Estoy lejos de ser cocinera. ¡Incluso me daba un poco de vergüenza incluir recetas en este libro! Eso sí, me gusta hacer cursos de cocina, experimentar, equivocarme y aprender cosas nuevas.

Cuando empecé a entender el mundo de los alimentos reales, que lleva indefectiblemente a empezar a cocinar, tenía en la alacena legumbres olvidadas en bolsitas y frascos hacía años. Empezar a cocinar fue empezar a mover los elementos, a sacar todo de su lugar, a que las cosas se usen y se acaben, y se pruebe una nueva manera de hacer eso que salió mal o raro.

Gracias a la periodista especializada en alimentación Soledad Barruti, conocí a mi persona gurú de la cocina, Natalia Kiako. Gran parte del alma de mi cocina de hoy por hoy debo agradecersele a ella y sus recetas. Ante todo, por ayudarme a iniciar esa rotación de ingredientes tan necesaria: recuerdo cuando me regaló un frasco gigante de aceite de coco: ¡lo que me costó terminarlo (y en el medio, vencer esa idea incrustada en el cerebro de los nietos de inmigrantes de “guardar para después”) y el orgulloso mensaje que le mandé cuando vi el fondo del frasco! Nati hace magia, alquimia, comprende los ingredientes como casi ningún otro cocinero lo hace. Logra que todo tenga legumbres y cereales deliciosos, es la creadora de los #chocoporotos y de una inmensa cantidad de cosas ricas que, además, se pueden hacer en poco tiempo una vez que se logra algo de organización.

A mí no me gusta seguir recetas. Compró harinas “raras” y las mezclo con las originales, y así entraron a mi vida las harinas de lupino, sorgo, algarroba y tantas otras. Con más entusiasmo que pericia, me lanzo a hacer unos *muffins* de porotos a las doce de la noche o compro moldes de animalitos por Internet.

Cuando mi hijo menor empezó a comer, no me preocupé mucho por las recetas. Ofrecía alimentos muy simples, adaptados a su edad. La opción “picada” (colocar diferentes alimentos en la mesa para agarrar con la mano) me funcionaba bastante bien y sigue funcionando. Los dos nos divertimos y hay menos platos para lavar.

Fue cuando empezó el jardín y volvía con mucha hambre cuando terminé de encontrarle la vuelta a tener preparaciones listas para bajar del *freezer*, y

recetas fáciles para preparar juntos la noche anterior como vianda. Empecé a disfrutar muchísimo hacer esa vianda. Era la primera vez que nos separábamos unas horas, después de un año de pandemia y cuarentena, y tal vez era mandarle un pedacito de mí en una cajita. Cocinábamos juntos todas las noches, y así él aprendió a decir “harina” y a contar “uuunaaa, dooo, teees tazas”.

Las y los invito a **cocinar: es un acto revolucionario, que nos hace libres, porque siempre sabremos qué le estamos dando a nuestro cuerpo y nuestra salud.**

Qué alimentos tener en casa

Regla número uno: si está en casa, se usa. Si compramos el paquete del coso exótico en la dietética, se googlea cómo usarlo y se hace alguna comida con el coso a la brevedad. Las harinas se ponen rancias, los aceites también, los frutos secos pierden propiedades con el tiempo... El universo se oxida y se degrada naturalmente. Así que evitemos perder tiempo y usemos lo que hay en casa, que si se acaba pronto, es porque nos gustó mucho y hay que probarlo de nuevo.

Aquí una lista variada de básicos (y no tanto) para tener siempre a mano:

HARINAS

De trigo blanca

De trigo integral

De sorgo

De lupino

De mijo

De algarroba

De trigo sarraceno

De garbanzos

De arvejas

De arroz

De maíz (polenta)

De maíz fina precocida (para arepas)

FRUTAS Y VERDURAS

De preferencia, las de estación (las que están más baratas y en mayor cantidad en la verdulería o el bolsón). También podemos tener fruta deshidratada (pasas de uva, tomates secos, manzana deshidratada).

CARNES (si consumimos)

Pollo, vaca, pescado, etc. Evitar siempre la carne picada por el riesgo de síndrome urémico hemolítico (SUH). Si existe la posibilidad de conseguir carne de ganado pastoril o pollos orgánicos, mejor. Pescados piolas por tener pocas espinas: pollo de mar, gatuzo, gallo de mar. Pero cualquier pescado que no sea de criadero puede ser una opción.

FÉCULAS

De mandioca

De maíz

De papa

CEREALES

Avena (arrollada fina o arrollada gruesa)

Mijo

Quinoa

Trigo sarraceno

Arroz (yamaní, integral, etc.)

Trigo burgol/cuscús/sémola (todas variantes del trigo)

LEGUMBRES

Porotos (pallares, manteca, *cranberry*, *mung*, negros, *aduki*, regina, etc.)

Lentejas (lentejas, lentejas turcas, lentejones)

Garbanzos

Arvejas

HUEVOS

Los huevos marrones no son mejores que los blancos, simplemente, son dos especies de gallinas diferentes. Si podemos conseguir huevos de campo, fantástico. Suelen conseguirse en la dietética.

- **Tip: cómo ligar una preparación si no tengo huevo o no deseo usarlo:** 2 cucharadas de chía + 2 de agua y dejar aglutinar o 3 cucharadas de harina de garbanzos + 2 de agua.

FIDEOS

Los fideos son “el comodín” muchas veces. Se preparan muy rápido y a los chicos les gustan. Pero puede ser un problema cuando la base de la alimentación radica en fideos. Veamos algunas ideas para evitar esto: Ofrecer verdura con fideos, y no fideos con verdura. Que los fideos sean la segunda parte del plato, y no la primera.

- Ofrecer fideos de diferentes colores para evitar la preferencia por el color blanco.
- Ofrecer fideos de diferentes formas y texturas. Los integrales son más rugosos y los refinados se desarman más fácilmente en la boca. Los fideos de sopa de letras son divertidos para la sopa y los tirabuzones son geniales para empezar la alimentación complementaria porque son fáciles de agarrar. Los fideos largos pueden ser difíciles de manejar para niños pequeños.
- Ofrecer fideos de diferentes composiciones nutricionales. Hoy por hoy, hay fideos de arvejas, lentejas, garbanzos, amaranto, quinua, chía, *kale*, etc.
- Que nos acompañen a elegir los fideos que vamos a comer ese día.
- Si ofrecemos pastas rellenas, tenemos que saber qué tienen adentro. Los raviolos del súper que tienen una masa gris misteriosa no son una opción para nadie. Sí podemos hacer juntos pastas caseras, o comprar pastas confiables.
- Agregarles materia grasa saludable (aceite de oliva, aceite de chía o de lino, crema de frutos secos) y espolvorear con levadura nutricional, *rawmesan*, harina de semillas o frutos secos.
- Podemos hacer salsas caseras de mil formas. De tomate triturado, de

frutos secos, de verduras, etc.

¡Los fideos no son malos! Pueden ser aliados para la alimentación. Pero, por supuesto, si comemos siempre lo mismo, ¡nos van a faltar nutrientes! Así que es importante que aunque sea “lo único que come” (ver capítulo 9 sobre neofobia y selectividad), busquemos la forma de que la alimentación sea variada.

LÁCTEOS

Elegir simples, siempre pasteurizados, y enteros (no descremados). Si vamos a comprar yogur, que sus ingredientes no incluyan azúcares o ingredientes que no entendamos, ¡siempre mirar las etiquetas! Si podemos acceder a marcas de tambos biodinámicos, mejor. Siempre para mayores de un año, y totalmente opcionales.

FRUTOS SECOS Y SEMILLAS

Maní, girasol, almendras, nueces, castañas de cajú, chía, lino, sésamo, amapola, etc.

GRASAS

Aceite de oliva.

Aceite de coco.

Aceite de maíz o de girasol de primera prensada.

Ghee o manteca (esta última idealmente para después del año).

Aceite de lino o de chía (para agregar en crudo).

Los utensilios

Muchas personas tienen (tenemos) un cajón lleno de “cosos” absolutamente misteriosos que se supone que deberían ayudarnos a cocinar... pero no sabemos para qué son.

Les propongo limpiar el cajón, y darle al bebé, niño o niña todo lo que no pueda lastimarlo y le sirva para jugar (todo, ¡absolutamente todo es un juguete genial en la infancia!), y dejar los objetos que realmente nos dan una mano.

Les cuento mis preferidos:

- **Tazas y cucharas medidoras:** salen muy económicas en los bazares y sirven como medidas universales. Cuando una receta dice “una taza” o “media taza”, se refiere a esas tazas, no a la taza de café que tenés en la alacena. Este es un dato que me cambió la vida porque, de pronto, al respetar las cantidades, ¡las preparaciones salían bien! (no se rían).
- **Balanza de cocina:** puede ser digital o común. Ídem anterior, si respetamos cantidades, mágicamente todo sale mejor.
- **Jarra medidora:** en la misma línea que lo anterior.
- **Cuchillos que corten en serio:** el mundo es más feliz cuando tenemos cuchillos que cortan –¡uno, al menos!– y no andamos luchando con el serruchito de mango de madera que viene por *default* en cada casa de Argentina.
- **Tablas para picar diferentes para verduras y carnes:** fundamental tener una tabla para las carnes crudas, otra para las cocidas y otra para las verduras, como mínimo. Usar la misma tabla puede generar contaminación cruzada (que las verduras se contaminen con las bacterias de la carne, por ejemplo, y haya riesgo de SUH). Es importante que sean fáciles de lavar. Las tablas de madera están desaconsejadas, porque pueden acumular suciedad en los surcos. Cuando una tabla de plástico tiene muchos surcos, es hora de cambiarla.
- **Colador/bolsita para colar bebidas vegetales.**
- **Un buen pelapapas.**
- **Olla o sartén con antiadherente:** evitar aquellas cuyo antiadherente se despega, pues puede ser tóxico.
- **Cuchara para servir helado:** ¿y esto? Una magia que me enseñaron en un curso de pastelería. La cuchara para servir bochas de helado tiene la capacidad exacta de un *muffin* o un panqueque pequeño. Me sirve muchísimo para pasar las masas a los moldes.
- **Batidor y espátula:** fundamentales.

- **Moldes, asaderas, ollas y sartenes:** es mejor tener pocos y buenos. Vale la pena invertir en algunas piezas de buena calidad, porque hacen las cosas más fáciles. Los moldes de silicona son una buena opción también.

Los electrodomésticos

Fan. Fan absoluta. Me encantan los electrodomésticos y a la vez entiendo que muchos no son necesarios, pero son lindos, qué le vamos a hacer. La mejor parte es que probé muchos y les puedo contar los que realmente están buenos para nuestra cocina, o darle un nuevo uso a ese que está escondido en una alacena. Voy a mencionar varios, pero, importante: si no tienen electrodomésticos, no pasa nada. Se puede cocinar igual y hasta mejor. Simplemente son ayudas en la cocina.

- **Minipimer/procesadora/licuadora:** las tres son buenas opciones para hacer cremitas de legumbres o frutos secos. Si hay que elegir cuál comprar o que nos regalen una, sin duda es la minipimer, por su practicidad y porque generalmente incluye un utensilio para batir.
- **Molinillo de café:** ideal para triturar semillas (además de café, claro). Se puede suplantar por un mortero manual.
- **Microondas:** sí, se puede cocinar en microondas. No, no es dañino. El problema que tiene el microondas, como ya vimos, es que más que cocinar, calienta, y calienta en forma irregular: algunas zonas quedan hirviendo y otras frías. Esto genera el riesgo de ofrecer algo que pueda quemar al bebé. Por esto mismo, no se sugiere nunca para calentar biberones.
- **Vaporera eléctrica:** quiero mucho a la mía porque me acompaña hace diez años, pero no es imprescindible. Se puede lograr la cocción al vapor en una olla con cierre hermético y antiadherente con un dedo de agua, o con una “flor” de plástico o metal que se vende en bazares.
- **Freidora de aire:** un diez si hay lugar en la cocina, porque el aparato es grandote. En realidad, es un pequeño horno de convección que hace circular aire muy caliente por la cámara de cocción con un

ventilador de alta potencia, cocinando los alimentos por todos los lados a la vez. Esto da como resultado alimentos crujientes que toman menos tiempo en ser cocinados. Ahí se pueden hacer papas, batatas o zanahorias “fritas” (sin aceite), milanesas, *muffins*, croquetas, hamburguesas de legumbres y otras preparaciones, y también se puede usar para darle un golpecito de calor rápido a pancitos, *muffins*, chipás u otra preparación que esté freezada.

- **Olla al vapor eléctrica:** la incorporé a mi vida cuando mi hijo menor tenía 1 año aproximadamente y lamenté no haberla tenido a mano en mi puerperio inmediato. Es muy muy buena para hacer legumbres, cocciones largas para carnes, cocina al vapor, para dorar (cebolla por ejemplo), para hacer compotas y otras preparaciones. Se programa un tiempo determinado y se apaga sola cuando termina, teniendo la opción de mantener la comida caliente (por eso, cuando la conocí, la añoré para mi puerperio-colchón 24/7 de bebé).
- **Tostadora:** los panqueques, *waffles* y pan cortado en rodajas pueden salir directo del *freezer* a la tostadora. Allí se descongelan y quedan crujientes.
- **Wafflera:** la ventaja que tiene la wafflera es que se cocina el *waffle* (o panqueque cuadrado, seamos sinceros) de ambos lados al mismo tiempo. Y que al ser cuadrados, es más fácil almacenarlos y meterlos en la tostadora.
- **Deshidratador eléctrico:** este sí que es un chiche innecesario pero que no quería dejar de incluir. Los deshidratadores son máquinas que justamente ayudan a quitarles la humedad a los alimentos para poder conservarlos más tiempo. Allí se deshidratan las uvas para hacer pasas de uvas, las peras para hacer peras deshidratadas, las ciruelas, los tomates... Este proceso también puede hacerse al sol directo o con un deshidratador solar. Normalmente, los deshidratadores son grandes y para producción a gran escala, pero ahora se están produciendo unos pequeños para uso domiciliario, y si la familia consume estos alimentos regularmente, pueden ser útiles. Allí hacemos chips de *kale* y tomates deshidratados; y todas las frutas que quedan a medio masticar por casa, se convierten en frutita deshidratada para llevar de paseo.
- **Robot de cocina:** el *sumum* de los electrodomésticos. No lo probé yo, pero tengo amigos y amigas que sí y que lo recomiendan

ampliamente. Es un *mix* de otros electrodomésticos: cocina, bate, calienta, tritura, pesa, cocina al vapor, hace masas, pasteuriza, muele semillas... un poco de todo. Y además tiene una pantalla para elegir las recetas. Si la olla eléctrica estaba buena para el puerperio, me aventuro a decir que el robot de cocina puede ser un gran aliado.

***Tips* culinarios de una persona que no es experta en cocina**

“El que no hace, no se equivoca”, les conté que se decía mucho en mi familia, la cual no tenía una gran tradición culinaria. En los últimos años, cuando empecé a cocinar más, me equivoqué un millón de veces y descubrí un millón de cosas. ¡Les comparto algunas!

- **El polvo para hornear se mezcla con la harina ANTES de mezclarlo con la parte húmeda de las preparaciones.** Si no, no crece absolutamente nada. No mezclen el polvo para hornear con el huevo, la fruta u otra cosa, porque así no anda.
- **Precalentar el horno antes de hornear.** Y precalentar fuentes y sartenes antes de hacer fainá o panqueques te cambia la vida. Creeme.
- En cualquier preparación que lleve huevos y harina, **primero se baten los huevos (o la chía activada) y los otros ingredientes húmedos con un batidor**, y cuando se le agrega la harina, se sigue **mezclando** con movimientos envolventes y espátula. Les prometo que cambia todo.
- **No todas las harinas funcionan igual.** Las harinas que tienen gluten aglutinan las preparaciones (lógico), y no es lo mismo reemplazarlas por harinas sin gluten, de legumbres o de frutos secos. Si buscan explorar en harinas nuevas (y no por un tema de intolerancia al gluten), sugiero ir mezclando harinas novedosas con la harina que usan siempre e ir probando. Si realmente no pueden consumir gluten por un tema de salud, sugiero muchísimo que participen en algún taller de cocina porque hay un mundo de posibilidades.

- **Respetar las cantidades que dice la receta.** En serio.
- **Si algún panificado sale mal, nos reímos, lo cortamos, lo tostamos y hacemos galletitas desde nuestra desgracia.** También podemos hacer un Reel para Instagram y volvernos virales, quién te dice.
- **Si sos una persona que hace cuarenta cosas a la vez, comprate un timer para que te avise que pusiste una preparación al fuego.** De otra manera, quemarás muchas, muchas ollas (le pasó a una amiga).
- **Cocinar es jugar.** Por eso también nos parece que es “perder tiempo”, porque no le encontramos el disfrute. Prueben, jueguen, hagan lío. Se puede. Y los chicos nos acompañan.

Los chicos en la cocina

En algunos documentos de prevención de lesiones en la infancia, se sugiere prohibirles la entrada a la cocina a los chicos. Esto tiene una razón de ser, claro: evitar lesiones. Pero también es privarlos de estar en el lugar donde se elabora el alimento, se prueban sabores, se sienten diferentes temperaturas, los adultos mezclan cosas y dicen malas palabras cuando se equivocan (¿quién, yo? Nunca, nunca, claro).

Entonces, sin duda, prevengamos las lesiones no intencionales. **La sugerencia más importante es que SIEMPRE tiene que estar la mirada del adulto presente en un niño o una niña que está en la cocina. La responsabilidad es nuestra.** También es imprescindible explicarle al bebé, niña o niño que hay cosas que no puede hacer ni tocar pues es peligroso (y esto es parte también de la construcción de límites amorosos).

Otras pautas:

- Mantengamos los elementos de limpieza, insecticidas y medicamentos fuera del alcance de bebés, niñas y niños, y evitemos usar botellas o frascos de alimentos para comprar productos de limpieza sueltos.
- Cocinemos y calentemos siempre en las hornallas de la parte posterior de la cocina.

- Los mangos o manijas de los recipientes que están en el fuego deben orientarse hacia adentro para que los niños no puedan alcanzarlos.
- Cerremos la llave de entrada de gas en la cocina cada vez que no se la esté utilizando.
- Coloquemos protección en los enchufes.
- Mantengamos desenchufados los electrodomésticos.
- No dejemos cerca de la mesada elementos que los chicos puedan usar para trepar sin nuestra supervisión.
- Evitemos manipular cosas calientes con ellos a upa o en el portabebés. Un porteo seguro incluye no realizar actividades que generen riesgo para el niño y la persona que portea.
- Coloquemos trabas en los cajones que tengan objetos peligrosos (cuchillos, sacacorchos).

Dicho esto, en la cocina los chicos pueden:

- Ayudar a elegir los alimentos para ese día, desde la visita al almacén o la verdulería.
- Lavar los alimentos.
- Ayudar a pelar y a cortar (de acuerdo con la edad).
- Separar los gajitos de los cítricos.
- Colocar alimentos en la olla (con agua fría).
- Cascar huevos.
- Pisar papas.
- Colocar los ingredientes en el bol.
- Revolver la masa.
- Amasar.
- Cortar con formitas.
- Lavar utensilios.
- Ayudar a ordenar.
- Jugar con los *tuppers* y las ollas.
- Controlar los tiempos de cocción.
- Ir comiendo a medida que cocinan (siempre que sean preparaciones y alimentos aptos para ellos).

Y seguramente se les ocurrirán muchas opciones más a medida que vayan leyendo esta minilista. No todo es cocinar en sí. Muchas veces, sobre todo

con deambuladores, lo que creíamos que iba a ser una romántica sesión de cocina con fotos bellas, se convierte en un campo de batalla donde tratamos de explicarles con paciencia por qué no pueden comer harina o que nosotros necesitamos batir un poco también porque si no, nunca comeremos. Sí, eso pasa muchas veces, y seguirá pasando. No “se arruinó” el momento, sino que estamos aprendiendo algo diferente a lo que proponíamos. Puede que nos genere frustración, y hasta sintamos ganas, como adultos, de participar del berrinche. Y eso también se lo podemos contar a los chicos, y aprender todos de todos.

Recetas para arrancar la alimentación complementaria... y para cualquier edad

Estas recetas se siguen comiendo toda la vida, simplemente que cuando somos más grandes, a veces gustamos de agregarles algo de sal o de azúcar, porque estamos muy acostumbrados a las mismas (aunque no las necesitamos).

¿Para qué comidas? Para todas. **Se puede dar cualquier alimento sano en cualquiera de los horarios de la comensalidad.** Se puede desayunar con croquetas de arroz con palta, y se puede cenar arroz con leche. De todos modos, dejo algunos ejemplos de viandas y cosas para tener a mano más adelante.

Algunas opciones para agregarles a las preparaciones y así enriquecerlas y hacerlas más nutritivas:

- **Semillas de sésamo y lino molidas** → Agrega omega 3.
- **Frutos secos molidos (en forma de harinas) o cremas de frutos secos** → Agrega grasas saludables, calorías buenas y vitaminas.
- **Levadura nutricional (media cucharada por día)** → Agrega vitaminas del complejo B, hierro y zinc.

- **Aceite (oliva, lino o chía)** → Agrega grasas saludables omega 3 y omega 6

Y ahora sí, ¡arranquemos!

BÁSICOS (RECETAS QUE SON BASE PARA OTRAS RECETAS)

Pasta de dátiles

Ingredientes

12 dátiles remojados mínimo por tres horas.

Agua, cantidad necesaria

Procedimiento

Se procesa todo, y se usa esa pasta para endulzar. No hay medidas de equivalencia con el azúcar, va a depender del dulzor de los dátiles.

Tip: esta misma receta se puede hacer con pasas de uva, pasas de ciruela y pasas de arándanos (estas últimas son un poco más amargas).

¿Cuánto dura en la heladera? De 3 a 5 días como máximo.

¿Se puede freezar? ¡Sí! Se puede en recipientes herméticos o en cubeteras para ir descongelando de a cubitos.



Leche o bebida de coco

¿La leche de coco es para tomar? Si les gusta, bueno, pero no es una sugerencia nutricional. Más bien sirve para cocinar, y queda rica.

Ingredientes

2 tazas de coco rallado (comprar el común, no el “desgrasado”)

½ litro de agua hirviendo

½ litro agua natural

Procedimiento

Se licúa o procesa todo lo anterior, y se cuela con una bolsita para colar leches vegetales. El bagazo, lo que queda en la bolsita, lo usaremos para otras preparaciones. Van a ver que si ponen la leche en la heladera, puede que se arme una capa dura arriba. Es la grasa que se solidifica. Si la batimos, se calienta y se reincorpora.

Tip: esta misma receta se puede usar para hacer bebida vegetal con frutos secos (maní, almendras, girasol, etc.), de la misma manera.

¿Cuánto dura en la heladera? Unos 4 o 5 días.

¿Se puede freezar? Sí, yo suelo freezar en *tuppers* pequeños o en cubeteras.

Panqueques “base”

A partir de esta receta, las combinaciones son miles. ¡Cuando ya tenemos el “esquema” en la cabeza, se vuelve muy fácil!

Ingredientes

1 huevo

Endulzante a gusto (puede ser fruta pisada)

1 taza de líquido (bebida vegetal, leche humana, fórmula o de otro mamífero para mayores de 1 año, jugo de frutas)

¼ de taza de aceite

1 taza de harina (yo suelo mezclar harinas)

1 cucharada de polvo para hornear.

Procedimiento

Batir el huevo con el aceite, el líquido elegido y el endulzante. Mezclar la harina con el polvo para hornear, y luego integrar a la primera preparación. Si queda muy sólido, agregar más líquido. ¡Listo!

¿Cuánto dura en la heladera? Máximo por 4 días. No mejora con el tiempo, eh. Así que si vemos que pasan dos días sin comerlos, mejor subir al *freezer*.

¿Se puede freezar? ¡Sí!

Rawmesan vegetal

Además de que los lácteos no están sugeridos hasta el año de vida, el famoso queso rallado tiene poco de queso. Les sugiero que vayan a mirar qué tiene el “queso rallado” que se vende en bolsitas en el supermercado... Si deciden comprarlo, especial atención a que realmente sea queso rallado, dado que existe una versión de “aderezo a base de queso procesado con almidón”.

Una opción para dar sabor a las comidas es el *rawmesan* o “ralladito vegetal”. Es muy fácil de hacer con una minipimer o un molinillo de café. Esta combinación de semillas y especias se puede ofrecer una vez que los bebés ya lleven varias semanas de alimentación complementaria y hayan probado al menos los frutos secos (recordemos que nunca enteros) y las especias por separado. Después de ello, se puede incorporar a purés, cremitas, fideos, *muffins* y otras preparaciones para dar sabor y nutrientes.

Ingredientes

1 taza de frutos secos y semillas (girasol, sésamo, lino, chía, maní, almendras... Los que te gusten)
1 cucharada de levadura nutricional
1 cucharada de cúrcuma, otras especias (pimentón, ajo) si gustan, sal (si gustan y para mayores de 1 año)

Procedimiento

Se procesa todo junto y se guarda en la heladera, en un frasco, para preservar por más tiempo los aceites de las semillas.

¿Cuánto dura en la heladera? Ideal consumir en el lapso de 2 semanas como máximo (si es más tiempo, no sucederá nada malo, simplemente se aprovechan menos los nutrientes).

¿Se puede freezar? No hace falta, se puede guardar en la alacena o la heladera.

Frutas asadas

En invierno a veces da fiaca comer algo “frío”. Es lógico: el cuerpo no reacciona igual a todas las temperaturas. Nos pide descansar y bajar un cambio, a pesar de las exigencias laborales y escolares. También estamos enfrentando un escenario completamente nuevo de trabajo y estudio en el hogar. Cuando hay consumo de ultraprocesados (galletitas, jugos, golosinas...), el paladar se acostumbra a los azúcares industriales y “le cuesta” sentirle el gusto a las frutas y a otros alimentos más saludables. Meter las frutas al horno, sobre todo las manzanas y peras típicas del invierno, soluciona esos dos problemas. La actividad es sencilla: lavamos

bien las frutas (manzanas y peras son las elegidas) y así como están, con cabito, con corazón, con semillas, con todoooo (si tienen menos fiaca que yo, por supuesto les pueden sacar todo esto), las metemos al horno hasta que estén tiernas. Otra opción es cortarlas en cubitos y saltearlas en una sartén con un poco de materia grasa.

Los azúcares de la fruta se caramelizan, el sabor dulce se potencia y quedan supersuaves. Se pueden comer calentitas o frías, usar para preparaciones o agregar a la ensalada. También se pueden mezclar en el arroz con leche o en el *porridge* de avena. Se les puede agregar canela, cacao o algún endulzante si lo deseamos. Las combinaciones son infinitas.



¿Cuánto dura en la heladera? De 3 a 5 días como máximo.

¿Se puede freezar? ¡Sí! Al descongelarse, les cambia un poco la textura por el alto contenido de agua que tienen, pero podemos calentarlas en una sartén y quedan bien.

CREMITAS (que pueden ser papillas o untables)

¿Tu decisión como familia es arrancar con papillas? Buenísimo, como ya dijimos, eso es más que posible mientras observemos al bebé con respeto, le permitamos jugar con la comida y vayamos progresando las texturas. Estas preparaciones que propongo aquí pueden servir como acompañamiento para otras preparaciones en familias que hacen BLW, y como papilla en sí para las familias que deciden arrancar de otra manera. ¡La papilla no tiene por qué ser solamente banana pisada, manzana rallada y zapallo con aceite! Hay muchas opciones más interesantes.



Hummus de garbanzos

Para bebés, el hummus se puede ofrecer con cuchara o untado en preparaciones, sin especias al principio, se incorporan de a poco como si fueran nuevos alimentos. También se puede hacer un hummus más denso y ofrecer en forma de bolitas o palitos. El hummus es una comida tradicional de varias culturas de Oriente, y la receta incluye como ingrediente el *tahini*, una pasta de sésamo que le aporta más sabor. Sí, se le puede agregar para bebés, sobre todo si es algo tradicional de la familia de ese bebé: compartir

nuestras tradiciones y sabores familiares es lo más hermoso de esta aventura.

Ingredientes

1 taza de garbanzos cocidos
¼ taza de aceite de oliva
Jugo de limón c/n
Especias a gusto

Procedimiento

Se procesa todo. Si hay una licuadora o un *mixer* muy potente, queda muy sedoso; y si no, queda con textura. Ambas opciones están buenas. Si ven que a los ingredientes les cuesta integrarse, agregar un poquito de agua tibia.

¿Cuánto dura en la heladera? 2 o 3 días.

¿Se puede freezar? ¡Sí!

Baba ganoush

Básicamente, el *baba ganoush* es un puré de berenjenas asadas, con un proceso fascinante en el cual la berenjena... ¡explota! Vamos con la receta.

Ingredientes

3 berenjenas asadas
2 dientes de ajo
Un chorrito generoso de aceite de oliva
Jugo de ½ limón
Sal y pimienta (a partir del año)
Especias (también a partir del año, queda muy bien el pimentón ahumado)
Tahini (opcional)

Procedimiento

El primer paso es el mejor; se colocan las berenjenas sobre la hornalla, así, solitas, y se prende la misma. La piel de la berenjena se empieza a quemar, inclusive a hacer pequeños “pufs” explosivos. A medida que se quema un lado, la rotamos para que se cocine del otro (lo que yo hago es clavarle un tenedor en uno de sus lados para que me sirva para pivotar). Así hasta que

queda toda chamuscada. La dejamos enfriar un poco, le sacamos la piel carbonizada y la procesamos con los otros ingredientes. Tiene un sabor ahumado riquísimo.

Luego se mixea la pulpa de la berenjena con los demás ingredientes.

¿Cuánto dura en la heladera? 2 o 3 días.

¿Se puede freezar? No probé, pero podría ser. Tal vez cambie la textura. ¡Es tan rico que lo comemos todo de una!

Tip: la berenjena, al igual que el tomate, la frutilla y los cítricos, puede generar una reacción rojiza alrededor de la boca. Esto no es una alergia y se va solo en unos pocos minutos. Si la reacción se extiende y persiste, consultar con el pediatra.

Untable de girasol

Ingredientes

1 taza de girasol lavado y remojado toda la noche

2 dientes de ajo

1 cucharadita de sal (a partir del año)

¼ taza de aceite de oliva o girasol

Jugo de un limón.

Procedimiento

Todo esto se procesa, le pueden agregar otros condimentos que les gusten, y sirve para untar.

¿Cuánto dura en la heladera? 2 o 3 días.

¿Se puede freezar? Sí, se puede. Yo cuando lo descongelo suelo agregarle harina a ojo e improvisar unas galletitas, pues creatividad ante todo.

Untable de nuez

Podemos ofrecer este untable sin especias al principio. Si es la primera vez que se ofrecen frutos secos, dar de probar en tres ocasiones solos, o con alimentos que ya haya probado antes. Incorporamos las especias de a poco,

como si fueran nuevos alimentos.

Ingredientes

1 taza de nueces lavadas y remojadas toda la noche

¼ taza de agua

2 cucharadas de aceite de oliva

Condimentos a gusto

Unas gotas de jugo de limón.

Procedimiento

Se procesa todo con minipimer, y sale una especie de “quesito”.

¿Cuánto dura en la heladera? 2 o 3 días.

¿Se puede freezar? Sí, pero no queda lindo al descongelar. Mejor comer en el momento.

Untable de porotos y zanahoria

Lo podemos ofrecer una vez que el bebé ya haya probado zanahorias y porotos. Sin condimentos al principio; incorporamos las especias de a poco como si fueran nuevos alimentos.

Ingredientes

2 zanahorias hervidas o al vapor

1 taza de porotos blancos

¼ taza de aceite (o un poquito más)

1 diente de ajo

¼ taza de jugo de limón

Condimentos a gusto

Procedimiento

Ídem anteriores. Es muy muy rico.

¿Cuánto dura en la heladera? 2 o 3 días.

¿Se puede freezar? ¡Sí!

Crema de porotos negros

Como los untables anteriores, la ofrecemos desde el inicio de la alimentación complementaria, sin especias al principio. Ir incorporando las especias de a poco como si fueran nuevos alimentos.

Ingredientes

1 taza de porotos negros cocidos (se puede hacer con cualquier legumbre: lentejas, arvejas, otros porotos...)

Procedimiento

Procesarlos con licuadora, minipimer o procesadora, con un poquito de agua. Agregarles aceite de oliva, un apenitas de pimentón o de cualquier especia que usemos.

¿Cuánto dura en la heladera? 2 o 3 días.

¿Se puede freezar? Sí, aunque al descongelarse no queda muy simpática (podríamos usar esa pasta para hacer galletitas, por ejemplo).

Untable de remolacha

Spoiler: ensucia mucho, pero tiene un color muy divertido. Lo ofrecemos una vez que el bebé ya haya incorporado la remolacha y los porotos por separado previamente. Recordemos que sí se puede ofrecer remolacha antes del año, pero debe ser en pequeñas cantidades.

Ingredientes

1 taza de porotos blancos cocidos

1 remolacha pequeña cocinada al vapor o hervida

¼ taza de jugo de limón

¼ taza de aceite de oliva (u otro aceite)

Procedimiento

Procesar los porotos tiernos con un cuarto de taza de jugo de limón. Agregar la remolacha, procesar todo e integrar. Se puede untar sobre pancitos, tortillas, bastoncitos de pepino, zapallito o apio, u ofrecer en cucharitas

precargadas.

¿Cuánto dura en la heladera? 2 o 3 días.

¿Se puede freezar? Sí, pero no queda muy bien al desfreezar, por el contenido de agua de la remolacha.

PANES Y GALLETITAS

Pan sin amasar

(receta original de Natalia Rimondino)

¡El pan oficial de mi hogar alborotado! Si bien me gusta amasar, este pan me viene bárbaro para cuando estoy apurada. Ensucio poco e hijito me ayudar a revolver. La presencia de nuestros hijos en la cocina es una fuente de aprendizaje: sus manitos, sus caras, sus mordisquitos y también sus enojos, por supuesto, nos ayudan a encontrar nuevas maneras de acompañarlos. Lo podemos ofrecer desde el inicio de la alimentación complementaria, pero no es para todos los días (ver más info sobre el consumo de pan en el capítulo 8 “Pequeño manual BLW ilustrado”).

Ingredientes

2 tazas de harina (aquí usamos harina integral y sale muy lindo)

1 taza de agua tibia

2 cucharadas de levadura (seguramente se puede hacer con masa madre, pero es un nivel que aún no desbloqueamos)

1 cucharadita de azúcar

3 cucharadas de aceite (usamos de oliva)

Condimentos: orégano, pimentón, sal, provenzal... lo que gusten

Procedimiento

Mezclamos una taza y media de harina directo en el molde (yo lo hago directamente en la cacerola). Hacemos un huequito en el medio y ponemos el agua, la levadura y el azúcar (a este azúcar se lo van a comer las levaduras, sirve para darles *power*. No cuenta como azúcar libre). Se revuelve para que se integre todo, y se deja reposar media horita. Luego, se agrega la media taza de harina que falta, el aceite y los condimentos. Se integra todo de nuevo. Queda un engrudo rarísimo pero LES JURO que se vuelve pan. Se vuelve a dejar descansar por media hora. Después, simplemente, o lo metemos al

horno o lo llevamos a fuego corona unos 30-45 minutos. Desmoldamos, ¡y listo! En ciertas ocasiones, me ha pasado que la miga me queda un poco húmeda: en este caso, simplemente lo corto y lo tuesto.

¿Cuánto dura? Puede ir dentro o fuera de la heladera, y dura alrededor de una semana. Cuando se pone duro, bienvenidas las tostadas. Les pongo un poco de aceite de oliva y provenzal, y me quedan unas finísimas brusquettas.

¿Se puede freezar? Sí, se repuede.



Pizza de zanahoria

Esta receta se puede usar como base de *pizza* o simplemente como tostada para untar.

Ingredientes

300 g de zanahoria rallada

75 g de harina de garbanzos

Especias (provenzal, ajo, pimentón, polvo de hongos... las que gusten)

Procedimiento

Mezclamos la zanahoria rallada o triturada con la harina de garbanzos y las especias, y amasamos hasta que se haga una masa. Estiramos sobre una asadera pincelada con aceite y llevamos al horno a 180 °C. Cuando empiece a estar sequita, la sacamos y le colocamos los ingredientes arriba.

¿Cuánto dura en la heladera? Unos 5 días.

¿Se puede freezar? ¡Sí! Y podemos cortar cuadrados como galletitas, hacer pizzetas o prepizzas ya listas.

Galletitas de harina de maní

Habiendo probado la banana y el huevo por separado previamente, estas galletitas son una buena manera de incorporar frutos secos como el girasol en la alimentación complementaria.

Ingredientes

1 taza de harina de maní

½ taza de harina de sorgo blanco o trigo sarraceno o trigo integral

½ taza de aceite

½ cucharada de polvo

para hornear

2 huevos

¼ taza de azúcar o 10 dátiles procesados (recuerden que no se sugiere el

consumo de azúcar hasta, mínimo, los 2 años)

Procedimiento

Mezclamos los huevos, el aceite y el azúcar o los dátiles.

En otro bol, mezclamos las harinas con el polvo para hornear e integramos las dos preparaciones con movimientos envolventes. Mejor si dejamos descansar la mezcla un ratito antes de cocinarla, para que las harinas se hidraten.

Precalentamos el horno a 160°. Hacemos los bollitos y los aplastamos. Se meten al horno y ¡listo! Esperamos 15 minutos y ya tenemos preparadas estas increíbles galles de harinas divertidas.

¿Cuánto dura en la heladera? Unos 3 días.

¿Se puede freezar? Sííí, hasta 3 meses.

Pepas de porotos negros y algarroba

¡Importante haber probado previamente las legumbres solitas! Las preparaciones vienen después.

Ingredientes

1 taza de porotos negros cocidos

¼ taza de harina de trigo integral

¼ taza de harina de sorgo o de mijo o de arroz (o más harina de trigo)

2 cucharadas de harina de algarroba

Endulzante: ¼ taza de azúcar (para mayores de 2 años) o ¼ taza de pasta de dátiles

1 cucharada grande de aceite de coco.

Procedimiento

Se procesan los porotos con el azúcar o la pasta de dátiles y el aceite de coco. Luego se agregan las harinas y la algarroba con movimientos envolventes. Se deja descansar un ratito la masa en la heladera. Luego, se arman bolitas, se aplastan en una plancha y se les agrega un pedacito de manzana o pera asada en el medio. También se puede usar como corazón de la pepa una rodajita de banana, un pedacito de chocolate, un arándano que andaba por ahí o un fruto

entero para los comensales de más de 5 años. Se lleva a horno a 180° unos 10 minutos, se dejan enfriar y listo.

¿Cuánto dura en la heladera? Una semana aproximadamente.

¿Se puede freezar? Sí, inclusive se puede freezar la masa cruda. Yo hago de a montones y voy sacando.



BUDINES, TORTAS, MUFFINS Y PANQUEQUES

Torta de lentejas (mi favorita)

Antes de ofrecer la torta, habría que haberle ofrecido al bebé las lentejas y el huevo, varias veces y por separado. ¡Paciencia para las preparaciones! Es un camino, vamos de a poquito.

Ingredientes

- 2 huevos
- 1/3 taza de aceite
- 1/2 taza de azúcar o 1 taza de pasta de dátiles
- 1 taza de lentejas cocidas
- 1/3 taza de agua
- 1 taza de harina integral
- 1 cucharada de polvo para hornear
- 3 cucharadas de cacao

Procedimiento

Precalentar el horno a 180°. Mezclar en un bol la harina + el polvo para hornear y luego agregar el cacao. Es VITAL que todo quede bien mezclado. Mezclar en el recipiente de la minipimer o licuadora el aceite, el azúcar o dátiles y los huevos. Agregar las lentejas y procesar. Agregar los secos intercalando con el agua y seguir procesando. Servir la mezcla en un molde, si es de silicona, sin nada, y si es de metal o vidrio, enmantecar y enharinar antes. Poner a hornear a 180° durante unos 45 minutos.

¿Cuánto dura en la heladera? De 3 a 5 días en un *tupper* hermético.
¿Se puede freezar? ¡Sí! E ir bajando de a poco a medida que lo necesitemos.



Budín de frutos rojos

Podemos ofrecer esta delicia después de que el bebé haya probado los ingredientes principales por separado (huevo, frutos rojos, banana...) y no haya manifestado alergias. ¡Recordemos que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no sugiere el consumo de azúcares libres hasta los 2 años!

Ingredientes

2 huevos

½ taza de aceite (el que tengan, yo usé de coco)

¾ taza de pasta de dátiles o ¼ taza de azúcar (+ 2 años), o el endulzante que prefieran

1 taza de frutos rojos procesados con 1 banana

2 tazas de harina (la que tengan, usé de trigo integral)

1 cucharada de bicarbonato.

Procedimiento

Prender el horno para precalentar a 180°, o dejar la olla con antiadherente a fuego corona tomando calorcito. Mezclar los huevos y el endulzante. Luego, agregar el aceite y los frutos rojos con banana. En otro recipiente, mezclar bien el bicarbonato y la harina. Integrar la harina a la preparación anterior. Yo lo cociné en la olla antiadherente con *savarin* durante unos 40 minutos. En el horno sería aproximadamente el mismo tiempo a 180°. Para ver si está cocinado adentro, pinchar con un palillo. Si sale seco, ya está. [] [] [] []

¿Cuánto dura en la heladera? De 3 a 5 días como máximo.

¿Se puede freezar? ¡Sí! Suelo tener en el *freezer* budines freezados para la vianda.

Budín vegano de peras

Este es un budín húmedo que adentro tiene pedazos de fruta enteros (la pera). No tiene huevo, así que no hay que preocuparse porque “parece que queda crudo”. Es apto desde el inicio de la alimentación complementaria, una vez que ya se hayan incorporado los ingredientes de a uno (es decir, si el bebé ya comió pera, banana, pan casero, avena y dátiles en otro momento, también puede comer este budín).

Ingredientes

2 peras (mientras más maduras, mejor)

1 banana chica

1 y ½ taza de harina integral o cualquier harina

½ taza de avena arrollada (puede reemplazarse por más harina)*

½ taza de azúcar mascabo o pasta de dátiles

1 cucharada de canela

1 cucharada de bicarbonato o polvo para hornear

½ taza de aceite

½ taza de agua

Procedimiento

Mezclamos las peras cortadas en cubitos, la banana pisada, la harina, la avena, la canela y el polvo para hornear. En otro recipiente mezclamos el endulzante (azúcar o dátiles) con el aceite. Mezclamos todo y le agregamos el

agua. Se puede llegar a necesitar un poco más de agua, no es una masa muy espesa. Se pone en una budinera y va al horno a 180 grados por 30 minutos aproximadamente. Esperar que se enfríe un poco para desmoldar y cortar. ¡Frío es más rico!

¿Cuánto dura en la heladera? De 3 a 5 días como máximo.

¿Se puede freezar? ¡Sí!

***Tip:** la avena es la avena arrollada que se compra en la dietética. Puede remojarse antes y escurrir el agua, y ahí se pone menos agua de la que indica la receta. Podemos usarla también sin remojar, porque solo es para dar textura. También se puede usar avena instantánea o no usar avena.

Panqueques de limón

¡Es una gran idea para aprovechar los limones de invierno! Es apto desde el inicio de la alimentación complementaria, una vez que el bebé ya haya probado sobre todo el huevo por separado.

Ingredientes

1 taza de harina de trigo

1 cucharada de polvo para hornear

1 huevo, (reemplazable por una cucharada de chía activada en 3 cucharadas de agua)

¼ taza de aceite (yo usé de oliva)

½ taza de pasta de dátiles (+ 2 años podría ser una opción utilizar azúcar)

½ taza de jugo de limón

Ralladura de limón a gusto.

Procedimiento

Batir un poquito el huevo o la chía. Agregar el aceite, la pasta de dátiles y la ralladura de limón. Por otro lado, mezclar la harina con el polvo para hornear. Integrar ambas cosas y agregar el jugo de limón. Si queda muy denso, agregar un poco de agua. Calentar una sartén previamente pincelada con aceite, y cocinar vuelta y vuelta. []

¿Cuánto dura en la heladera? Unos 5 días.

¿Se puede freezar? Sí, se pueden hacer muchos, freezar e ir sacando de a poquito, e inclusive calentarlos en la tostadora.

Torta de coco y naranja

Esta torta fue un “invento” durante un viaje a un congreso de pediatría en el que mi hijo tenía 9 meses, cuando ya había probado previamente el huevo y la naranja. Como íbamos a alojarnos en un departamento, me llevé la minipimer y una cacerola pequeña. Medio de casualidad, surgió esta receta. Se desarma fácil, así que cuidado, hará muchas miguitas. Pero nos sirvió mucho para llevarla en un *tupper* y ofrecerla durante esos días que anduvimos de aquí para allá.

Ingredientes

1 taza de coco rallado

1 naranja

1 huevo (reemplazable por 3 cucharadas de harina de garbanzos)

2 cucharadas de aceite (yo usé de coco, puede ser cualquiera). No le puse ningún endulzante extra, eso queda a gusto

Procedimiento

Procesar todo, llevar a una olla chiquita a fuego corona durante unos 20 minutos. ¡Y listo! Si la hacen en el horno, a temperatura media por unos 20 minutos. Meter un palillo y sacarlo sequito es la forma de saber si está cocinada.

¿Cuánto dura en la heladera? De 3 a 5 días.

¿Se puede freezar? No es recomendable porque al no tener gluten, se desarma fácil.

Torta invertida de manzana

Esta receta es una versión que me regaló mi amiga María Fernanda Iroumé. Se puede ofrecer una vez que el bebé ya haya probado el huevo, y que le hayamos ofrecido manzanas solas previamente.

Ingredientes

2 manzanas (rojas o verdes)

1 huevo

4 cucharadas de harina de lupino y 4 cucharadas de harina de sorgo

½ taza azúcar o ½ taza de pasta de dátiles

½ taza de bebida vegetal o leche

¼ taza de aceite de oliva o coco

Un chorrito de esencia de vainilla.

Si le queremos poner caramelo (yo no lo hago, pongo las láminas de manzana a cocinarse con la olla apenas pincelada con aceite): ½ taza de azúcar y agua.

Procedimiento

En una olla con antiadherente, colocar el azúcar y un chorrito de agua a fuego medio con las manzanas cortadas en láminas y cubriendo la superficie de la olla o sartén. Por un lado, batir la clara de huevo a punto nieve (queda espumosa). Por el otro, licuar el aceite, la bebida vegetal, la yema y el endulzante. A esa mezcla incorporar la harina. Posteriormente, sumar a esa mezcla la clara batida y unir las preparaciones con movimientos envolventes y lentos.

Cuando las manzanas estén burbujeando en la cacerola, agregar la preparación y tapar. Se cocina en alrededor de 10 minutos.

¿Cuánto dura en la heladera? De 3 a 5 días.

¿Se puede freezar? Sí, se puede.



***Muffins* de porotos rojos**

Estos *muffins* se pueden ofrecer desde que el bebé haya probado por separado los frutos secos y las legumbres. No quiero ser repetitiva, ¡pero siempre menos o ningún azúcar es mejor!

Ingredientes

- 1 taza de porotos rojos cocidos
- 2 huevos
- ¼ taza de harina de sorgo o de lupino
- ¼ taza de harina de trigo integral
- 1 cucharada de polvo para hornear (también pueden usar bicarbonato)
- 5 dátiles hidratados (yo no suelo endulzar, se pueden obviar. Se pueden poner más, se pueden poner menos, pueden usar otro endulzante...)
- ¼ taza de aceite neutro
- 2 cucharadas de pasta de frutos secos (pasta de maní, de almendras, de nuez... La que quieran, es opcional).

Procedimiento

Se procesan los porotos y ahí mismo, en la procesadora, se suman los huevos, los dátiles, la pasta de frutos secos y el aceite. En otro bol se integran las harinas con el polvo para hornear. Si no tenemos harina de sorgo o de lupino, no pasa nada, ¡se hace con la harina que haya en casa! Siempre será más sano que algo comprado. Incorporar las dos preparaciones, mezclar con espátula. Dejar descansar unos 10 minutos, colocar la mezcla en moldes para *muffins* y llevar al horno precalentado a 180° a cocinarse por unos 20-30 minutos.

¿Cuánto dura en la heladera? Alrededor de 5 días.

¿Se puede freezar? Sííí, hasta 3 meses.



Muffins de ciruelas

¡Riquísimos! Para ofrecerlos a bebés pequeños, primero tendrían que haber probado por separado las ciruelas y el huevo, y sin azúcar hasta por lo menos los 2 años.

Ingredientes

5 o 6 ciruelas, depende del tamaño

2 huevos

2 tazas de harina (usé una taza de harina integral de trigo y una taza de harina de arroz. Podría haber usado una de trigo y una de harina de mijo, por ejemplo)

1 cucharada de polvo para hornear

½ taza de aceite (usé de oliva, pero pueden usar cualquiera)

½ taza de endulzante (banana pisada, azúcar o pasta de dátiles) ½ taza de líquido (agua, bebida vegetal, leche)

Procedimiento

Procesar las ciruelas en una licuadora o procesadora. Luego agregar en la misma licuadora los huevos con el aceite y el endulzante, y volver a procesar. Integrar la harina con el polvo para hornear en otro recipiente. Después hay que juntar todo en un bol, agregar el líquido y mezclar con movimientos envolventes (lo podemos hacer al ritmo de nuestro tema favorito, que seguramente sea *La Vaca Lola* o *Baby Shark*). Colocar la mezcla en un molde para *muffins*, decorar por encima con pedacitos de ciruela y llevar al horno a 180°. ¿Cuánto tiempo? Por 30-50 minutos, depende del tamaño de la preparación.

¿Cuánto dura en la heladera? Unos 3 días.

¿Se puede freezar? Sííí, hasta 3 meses.

Tip: está bueno etiquetar las cosas frizadas, con fecha y nombre, para no perderlas adentro del *freezer*.

Panqueques de banana y girasol

Habiendo probado la banana y el huevo por separado previamente, estos pancakes son una buena manera de incorporar frutos secos como el girasol en la alimentación complementaria.

Ingredientes

1 banana pasada y pisada

1 huevo

1 taza de harina (hice $\frac{1}{2}$ taza de harina integral de trigo y $\frac{1}{2}$ taza de harina de girasol. También puede ser toda harina de trigo. Tal vez en este punto se pregunten: “¿Cómo se hace la harina de girasol? ¿Se compra?”. Yo la hago moliendo semillas de girasol con un molinillo de café)

1 cucharada de polvo para hornear

1 chorrito de aceite (usé de coco) 1 cucharada de azúcar (opcional, porque la banana ya endulza)

Procedimiento

Batir el huevo con el aceite, y a esto agregarle la banana pisada y el endulzante. Seguir mezclando. En otro recipiente, mezclar la harina con el polvo para hornear, y luego integrar las dos preparaciones mezclando con espátula. Dejar reposar por 10 minutos; cocinar vuelta y vuelta en una sartén precalentada y pincelada con un poquito de aceite.

¿Cuánto dura en la heladera? Unos 3 días.

¿Se puede freezar? Sííí, hasta 3 meses.

Budín de banana y lupino

La harina de lupino es fácil de incorporar a las preparaciones. Tiene un sabor levemente amargo, al igual que la harina de quinua (que también podría ser utilizada para esta receta), entonces va muy bien con el dulce de la banana e inclusive iría muy bien en una preparación con cacao o algarroba. ¡Hoy por hoy, es mi harina “nueva” favorita! Una vez que el bebé haya comido banana y probado la tolerancia al huevo, se puede ofrecer. ¡Primero prioricemos alimentos y preparaciones simples!

Ingredientes

1 banana madura

1 huevo

$\frac{1}{4}$ taza de aceite (usé de oliva, pueden usar cualquiera)

1 taza de harina de trigo (integral, blanca, leudante. La que gusten)

1 cucharada de polvo para hornear (si usan harina leudante, no hace falta)

$\frac{1}{4}$ taza de harina de lupino

$\frac{1}{2}$ taza de líquido (usé agua. Se puede usar leche vegetal o, si consumen

leche, leche entera de vaca a partir del año)

¼ taza de azúcar (pueden reemplazarla por pasta de dátiles o no ponerle nada si el comensal tiene menos de 2 años, ya que la banana endulza).

Procedimiento

Pisar la banana. Batir el aceite y el huevo e incorporar la banana. Agregar el azúcar o la pasta de dátiles (o no ponerle nada de esto último). En otro recipiente, tamizar las harinas con el polvo para hornear. Luego, agregar el líquido. Unir las preparaciones con movimientos envolventes. Dejar reposar unos 10 minutos para que se hidraten las harinas (si pueden más tiempo, mejor). Cocinar en horno precalentado a 160° aproximadamente durante unos 40 minutos (depende del molde, yo usé uno para budincitos y tardó menos). Si pinchan con un palillo y sale limpio, ya está listo para degustar (¡dejar enfriar!).

¿Cuánto dura en la heladera? Unos 5 días.

¿Se puede freezear? Sí, se puede. Suelo cortarlo en rodajas para ir bajándolo más fácilmente.



Panqueques rosados de quinua y frutos rojos

Para probar estos panquequitos, la persona pequeña en edad tiene que haber comido (y no manifestado alergias): huevo (si se usa en la receta), frutos rojos y quinua por separado.

Ingredientes

1 taza de quinua cocida
½ taza de frutos rojos
2 cucharadas de pasta de dátiles
1 huevo o 3 cucharadas de “chilinaza” (chía o lino activados con agua)
½ taza de harina (la que gusten)
1 taza de agua o bebida vegetal
½ taza de aceite

Procedimiento

Procesar todos los ingredientes juntos. Calentar una sartén con aceite, y cocinar vuelta y vuelta.

¿Cuánto dura en la heladera? Unos 3 días.

¿Se puede freezar? Sí, de a montones..

Torta de remolacha

Esta receta incluye remolacha, huevo y cacao. Es importante que el bebé ya haya probado todos esos alimentos para ofrecer esta torta. Recordemos que sí se puede ofrecer remolacha antes del año, pero debe ser en pequeñas cantidades.

Ingredientes

1 taza de remolacha rallada
1 huevo
½ taza de pasta de dátiles
½ taza de aceite de oliva
1 cucharada de extracto de vainilla
2 cucharadas de cacao amargo

1 taza de harina de trigo
2 cucharadas de polvo para hornear

Procedimiento

Mezclar el huevo con el aceite, el extracto de vainilla y la pasta de dátiles (si gustan que sea más dulce, agregar más dátiles. También se puede hacer con azúcar para niños mayores de 2 años, u otro endulzante). Agregar la remolacha rallada, mezclar bien. Por otro lado, mezclar los secos (harina, cacao, polvo para hornear) y luego integrar a los húmedos. Si la preparación queda muy seca, agregar un poco de agua. Precalentar el horno a 180°. Verter la preparación en moldes y hornear hasta que pinchemos con un cuchillo y salga seco.

¿Cuánto dura en la heladera? Unos 5 días.

¿Se puede freezar? Como poder, se puede, pero no queda genial al descongelarla.

SALADITOS PARA TODA HORA

Fainá de arvejas

¡Una gran idea para ofrecer legumbres!

Ingredientes

1 taza de harina de arvejas

1 taza de agua

1 huevo (opcional)

1 chorrito de aceite

Especias a gusto (en casa usamos provenzal)

Si le agregamos polvo para hornear (1 cucharada), se transforman en panqueques más gorditos

Procedimiento

Primero mezclar la harina de arvejas con el agua y batir muy, pero muy bien para que no queden grumos (de entrada quedan muchos. *Tip*: ¡paciencia!).

Luego, agregar los demás ingredientes. Hay algo que es fundamental: dejar reposar la mezcla al menos durante 15 minutos para que se hidrate bien la harina (dato trascendental de la mano, por supuesto, de Natalia Kiako y sus talleres de harinas).

Después precalentar la sartén, pincelar con un poquito de aceite para que no se pegue, y cocinar vuelta y vuelta.

¿Cuánto dura en la heladera? Unos 5 días.

¿Se puede freezar? Claro que sí. Podemos hacer muchos y freezarlos (como la mayoría de las cosas). Es una gran idea para optimizar el tiempo.



Polenta cremosa y formitas de polenta

La polenta se puede comer así nomás o agregarle salsa y otros ingredientes (típico plato de invierno). Por su textura es una buena opción para ofrecerles a los bebés desde el inicio de la alimentación complementaria.

Ingredientes

1 taza de harina de maíz precocida (polenta)

3 tazas de leche humana, de fórmula o de vaca (para mayores de 1 año), o bebida vegetal o agua (también se pueden mezclar)

Especias a gusto Se puede agregar alguna verdura para darle color y onda (zanahoria rallada, espinaca, remolacha)

Procedimiento

Llevar el líquido a hervor con las especias y agregar la polenta como si fuera una lluvia finita (lo disfruto mucho, qué quieren que les diga). Revolver hasta que vuelva a hervir y dejarla unos minutos más. Cuidado, se quema fácil.

Apagar el fuego y agregarle las verduritas. Algunas personas también le agregan materia grasa para más sabor.

Para hacer formitas de polenta, colocar la preparación en moldes de silicona con la forma deseada (redondas, corazones, etc.) y llevar a la heladera.

Cuando se enfría, desmoldar y cocinar vuelta y vuelta en la sartén con una materia grasa.

¿Cuánto dura en la heladera? Mejor consumir en el momento si deseamos comerla como puré, porque se pone dura con el frío. Las formitas pueden durar unos 3 días en la heladera.

¿Se puede freezar? Las formitas sí. No sugiero freezar un mazacote de polenta.



Nuggets de tofu

Estos *nuggets* del bien se pueden ofrecer una vez que se haya descartado la alergia al huevo y a los frutos secos. Es importante que la harina de maní sea molida muy fina para evitar posibles atragantamientos.

Ingredientes

½ bloque de tofu orgánico cortado en cuadrados

1 huevo para el rebozado (se puede reemplazar por ¼ taza de harina de garbanzos + ¼ de agua)

Polenta o harina de maní, de girasol, levadura nutricional, semillas de sésamo o lo que deseen para rebozar*

Condimentos a gusto (en casa somos fanes de la provenzal y el pimentón ahumado)

Procedimiento

Batir el huevo con las especias, o mezclar la harina de garbanzos con el agua y las especias. Poner los cuadraditos de tofu en la mezcla y cubrir un ratito. Mientras, armar el rebozado mezclando la polenta, las harinas que quieran, las semillitas... (recuerden que para los bebés, las semillitas tienen que estar molidas). Rebozar los cuadraditos de tofu y cocinar en una sartén antiadherente pincelada con aceite (usé de oliva) bien bien caliente hasta que se doren.

***Tip:** ¿se puede hacer con pan rallado? Sí, claro, pero cuidado que el pan rallado que a veces se compra está mezclado con azúcar y conservantes (sí, leyeron bien, azúcar en el pan rallado).

¿Cuánto dura en la heladera? Unos 3 días.

¿Se puede freezar? Sí, totalmente.

Tortitas de papa

Si se usa huevo, estas tortitas se pueden ofrecer después de probar el huevo por separado. Si no es así, desde el inicio de la alimentación complementaria, primero sin especias, y luego ir introduciéndolas de a poco.

Ingredientes

3-4 papas

1 huevo (se puede reemplazar por 3 cucharadas de harina de garbanzos)

Cebolla salteada c/n

Kale picado o cualquier vegetal triturado c/n

Ajo picado a gusto
Especias a gusto

Procedimiento

Cocinar las papas al vapor. Pisarlas con un tenedor. Mezclarlas con el huevo y los demás ingredientes. Calentar una sartén con materia grasa y saltarlas vuelta y vuelta.

¿Cuánto dura en la heladera? 3 días.

¿Se puede freezar? ¡Sí!

Fideos de *zucchini*

Hay varias formas de hacer estos fideos. Pueden comprar un coso espiralizador que se consigue en bazares (yo lo tengo y es un gol), o se pueden hacer con el pelapapas, cortando láminas anchas del *zucchini* y luego con un cuchillo hacerlas finitas. Son ideales para todas las edades, desde que el bebé puede tomar trozos más pequeños.

Ingredientes

1 *zucchini* (se pueden hacer con zanahoria y otras verduras también)

Procedimiento

Cortar el *zucchini* en tiras largas y finitas. Calentar una sartén con un poquito de aceite de oliva y poner los fideos. Ir moviendo para que se cocinen, si están muy secos, agregar un poquito de agua. Se pueden acompañar con salsa de tomate casera (tomate + cebolla + ajo + condimentos ricos) o como gusten.

¿Cuánto dura en la heladera? Unos 3 días.

¿Se puede freezar? Por el alto contenido de agua de las verduras, no queda muy bien freezado. Pero se puede.



Hamburguesas de pollo y manzana

Animate a “juntar” cosas raras y sabores. ¿Pollo y manzana en la misma combinación? ¿Manzana salada? ¿Cebolla para bebés? ¡Claro que sí! Primero, presentar el pollo (si se consumen alimentos de origen animal), la manzana y la cebolla (y el huevo, si es el caso). Recién cuando el bebé haya probado los alimentos por separado, amerita empezar a hacer preparaciones. Sin apuro, hay una vida de tiempo.

¿Se pueden hacer con carne de otro animal? Sí, con pescado y también con carne de vaca. Recordemos que nunca se sugiere realizar preparaciones con carne picada de vaca hasta por lo menos los 5 años, por el riesgo de SUH. Si deseamos usar esa carne, tenemos que cocinar el trozo de carne entero y luego procesarlo y usarlo para preparaciones.

Ingredientes

250 g de carne procesada de pollo (cocinar previamente el pollo y luego procesar)

1 huevo o 3 cucharadas de harina de garbanzos

½ cebolla

1 manzana

½ taza de harina de avena o integral

Condimentos a gusto

Procedimiento

Precalentar el horno a 180°, picar la cebolla fina y rallar la manzana. En un recipiente, poner el pollo, el huevo previamente batido o la harina de garbanzos, la cebolla, la manzana y los condimentos. Incorporar la harina hasta conseguir una masa compacta que se pueda manipular con las manos. Formar bolitas con las manos y aplastar sobre la bandeja para horno cubierta con papel antiadherente. Cocinar durante 20 minutos dándole la vuelta a la mitad del tiempo.

¿Cuánto dura en la heladera? Entre 3 y 4 días.

¿Se puede freezar? Sí, hasta 3 meses.

“Hamburguesas” de zapallitos

Estas “hamburguesas” las podés hacer, además de con zapallitos, con verduras de diferentes colores (brócoli, zanahoria, remolacha), y de repente tenés... ¡hamburguesas multicolores de verdura! Recuerden que primero hay que ofrecer las verduras y el huevo por separado, y posteriormente, proceder a hacer preparaciones.

Ingredientes

2 zapallitos

1 huevo

1 diente de ajo

1 taza de harina integral

Especias a gusto

Procedimiento

Rallar los zapallitos con los agujeros grandes del rallador. Rallar también el ajo. Saltear en una sartén hasta que el zapallito esté cocido. Luego pasar la

mezcla a un bol. Agregar la harina, un chorrito de agua y el huevo; mezclar. Calentar la sartén, pincelar con un poco de aceite de oliva o manteca. Colocar la preparación de a poco, si no tenemos molde, dar forma con la cuchara. 5 minutos de cada lado... ¡y listo!

¿Cuánto dura en la heladera? Unos 3 días.

¿Se puede freezar? Sí, se pueden freezar muchas e ir sacando.

Locro vegano apto para toda la familia (receta prestada por Ivon Hensel)

Primero lo primero: vamos a necesitar una cacerola bien grande. Por el contenido de sal y de condimentos, diría que se puede ofrecer a partir de los 2 años. Se puede hacer una versión menos picante sin sal habiendo probado todos los condimentos antes, y en ese caso, se podría ofrecer desde el inicio de la alimentación complementaria.

Ingredientes

400 g de porotos manteca (o porotos blancos)

400 g de maíz blanco

2 zapallos anco grandes o 1 zapallo cabutia

2 cebollas grandes

½ atado de cebolla de verdeo

2 dientes de ajo

Aceite de oliva (bastante)

Sal, comino, tomillo, pimentón a gusto

Procedimiento

Remojar mínimo por 12 horas el maíz y los porotos. Hervir el maíz y los porotos con la sal, el comino, el tomillo y los dientes de ajo picados en dos litros de agua. ¡No escatimar condimentos! El agua se irá consumiendo de a poco.

Mientras se hierven, cocinar al vapor o al horno el zapallo hasta que esté tierno. Luego retirar el puré de zapallo e incorporarlo a la olla donde estamos hirviendo el maíz y los porotos. Por otro lado, para la salsa, cortar la cebolla y el verdeo; saltearlos en una sartén con aceite de oliva, sal y mucho, pero

mucho pimentón. Tiene que quedar bien bien rojo. Una vez que están blandos la cebolla y el verdeo, apagar la hornalla y sumarle abundante aceite de oliva. Se sirve el guiso con la salsa encima y es un manjar muy típico de fechas de fiesta patria, que en Argentina suelen caer en otoño o invierno.

¿Cuánto dura en la heladera? Unos 5 gloriosos días.

¿Se puede freezar? Sí, hasta 3 meses, inclusive, según el *freezer*, puede ser un poco más. Nada más feliz que descongelar una porcioncita de locro un día de frío.



Bastoncitos de pollo, arroz y palta

Ingredientes

- 1 taza de pollo previamente cocinado y procesado
- 1 palta blandita
- 3 cucharadas grandes de arroz cocido.

Procedimiento

Mezclar los ingredientes y dar forma de albóndigas o bastoncitos, con las manos húmedas. Si se desarmen mucho, agregar una cucharada de harina de garbanzos. Generalmente, apretando bien, se forman fácilmente los bastoncitos. Se pueden rebozar en alguna harina de semillas o frutos secos. Se sirven así como están, fríos.

¿Cuánto dura en la heladera? La palta se oxida pronto, así que sugiero consumirlos en el momento.

¿Se puede freezar? No, se desarmarán al descongelarse.



Muffins de lentejas turcas

Las lentejas turcas tienen la particularidad de que no necesitan remojo, apenas un pequeño lavado, y se cocinan rápidamente. ¡Son un diez! Estos *muffins* se pueden ofrecer desde el inicio de la alimentación complementaria, una vez que se haya descartado la alergia al huevo.

Ingredientes

1 taza de lentejas turcas cocidas
1 huevo o 3 cucharadas de harina de garbanzos
¼ taza de harina de trigo integral
1 chorrito de aceite de oliva
½ cucharada de polvo para hornear
Especias a gusto

Procedimiento

Procesar las lentejas con el huevo, las especias y el aceite de oliva. Agregar la harina y el polvo para hornear a la preparación. Colocar la mezcla en moldes para *muffins* y llevar al horno precalentado a 180° durante unos 20 minutos.

¿Cuánto dura en la heladera? De 3 a 5 días.

¿Se puede freezar? Sí, se repuede.

HELADITOS

Helado de leche humana o de fórmula

Estos helados, que simplemente implican poner en un molde para helados o en una cubetera con palitos la leche que toma el bebé, se pueden ofrecer a partir de los 3 meses aproximadamente. ¿Porque hace calor en verano? No, porque pueden ayudar a las molestias en la dentición. Evitar ofrecerlos a recién nacidos o bebés muy pequeños: si toman pecho, la leche tiene la temperatura exacta que necesitan en cualquier estación del año, no necesitan un helado. Recordemos que NO se sugiere iniciar la alimentación complementaria antes de los 6 meses mínimo.

Helado de kiwi y castañas de cajú

Estos heladitos verdes y nutritivos se pueden hacer con cualquier otra crema de frutos secos y con cualquier otra fruta, desde que el bebé haya probado ambas cosas; por ejemplo: crema de almendras y ananá, o crema de nueces pecán y frutillas.

Ingredientes

1 taza de castañas de cajú
10 pasas de uvas hidratadas
2 kiwis maduros

Procedimiento

Se procesan por un lado las castañas de cajú con las uvas hasta formar una crema. Luego se procesan los kiwis con un poco de agua. Rellenar el molde del helado primero con la crema de cajú y luego agregar el “licuado” de kiwi. Llevar al *freezer*.



Helado cremoso de banana

¡El más fácil del mundo!

Ingredientes

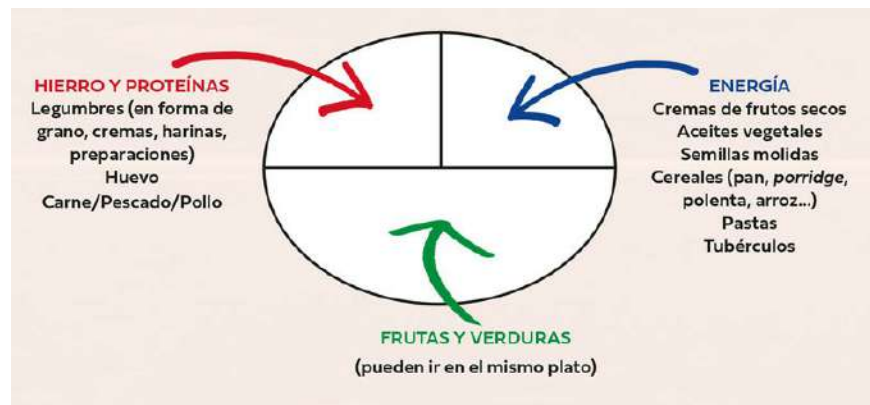
2 bananas muy maduras congeladas en trocitos más frutillas, o arándanos, o cacao amargo, o lo que queramos ponerle.

Procedimiento

Procesar todo con cuidado para no romper la máquina: a veces vamos a necesitar parar porque las bananas congeladas son muy duras. Pero de a poco, la preparación va tomando una consistencia cremosa y al ratito tenemos un muy rico helado. Hay que comerlo en el momento porque no se puede recongelar.

¿Cómo armar un plato?

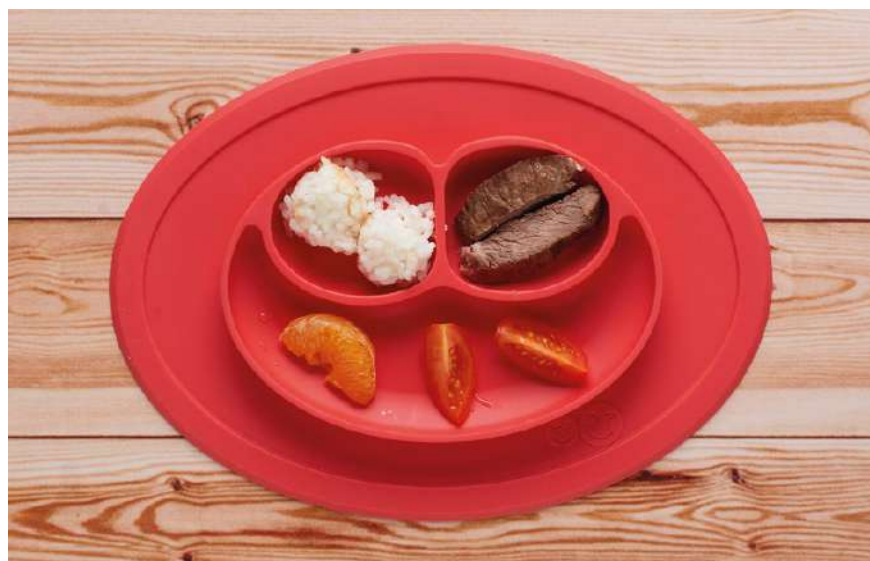
Hablamos en el “Pequeño manual BLW ilustrado”, en el capítulo 8, acerca de la importancia de presentar alimentos variados, ricos en hierro y en energía, y frutas y verduras como prioridades.



Para que esto no parezca una misión imposible, aquí algunas sugerencias:



Ejemplo 1 **Frutilla • Huevo • Palta • Trocito de pan con aceite de oliva**



Ejemplo 2 **Mandarina • Carne • Tomate • Arroz**



Ejemplo 3 **Brócoli • Bastoncitos de lenteja • Fideos de quinua • Sandía**

Ejemplo 4 **Bastoncitos de pollo, arroz y palta • Zanahoria al horno**

Ejemplo 5 **Puré de manzana asada (pisada con tenedor) • Polenta grillada con crema de nuez**

¿Y estos ejemplos para qué edades son? ¡Para todas! Adulto/a: el hierro, la fibra y todos los otros nutrientes son importantes para tus hijas e hijos...

pero también para vos. ¡No da lo mismo lo que comas! Sé que estás muy cansada (sí, hablo en femenino). Por eso merecés pensar en tu salud y tu cuidado. Todo el trabajo que están haciendo no es solo para los chicos, es para ustedes también. El pensar platos “completos”, con nutrientes variados, es para toda la familia. Tal vez, los bebés lo coman separado en un platito, tal vez nosotros lo mezclemos todo en un guiso, tal vez los deambuladores prefieran preparaciones para llevarse en la mano, y los adolescentes lo mismo pero solo en forma de milanesa. No importa la forma, importa que comamos variado, y que nos cuidemos. Todos.

SEGURIDAD A LA HORA DE COCINAR

La manipulación adecuada de los alimentos nos permite que al consumirlos, sean inocuos para la salud, y para prevenir las ETA (enfermedades transmitidas por alimentos). **Los niños son una población especialmente sensible a las ETA**, que pueden ir desde una simple diarrea hasta el síndrome urémico hemolítico, que puede producir desde secuelas renales hasta la muerte. Argentina es un país con mucho consumo de carne, y poco control del faenado y de la venta, y cocción de la misma, por lo que somos tristemente “campeones” del SUH a nivel mundial. Para prevenir esta enfermedad y muchas otras, aquí van ciertas pautas a seguir en la preparación de alimentos.

1. Lavar bien las frutas y verduras, de tal manera que no queden restos de tierra y suciedad.
2. Preparar una solución con 3 gotas de lavandina apta para alimentos por litro de agua (varía la cantidad de gotas según la marca, leer el envase), agitar y mantener las frutas y verduras en remojo por 10 minutos.
3. Escurrir, secar y almacenar en refrigeración si no se van a procesar en el momento.
4. Aquellas frutas y verduras que vayan a ser sometidas a una cocción, deben lavarse con agua potable antes de usarlas.
5. Los alimentos se descongelan bajándolos del congelador/*freezer* a la heladera o al microondas, y si su volumen es pequeño, se pueden cocinar directamente sin

descongelar. No se descongelan a temperatura ambiente.

6. Todo lo que se descongela hay que consumirlo; a menos que lo cocinemos, no puede volver al *freezer*.

7. La tabla de picar es un accesorio infaltable en cada familia.

Cuando tenemos que cortar diversos alimentos, debemos ser muy cuidadosos respecto a cómo utilizamos las superficies. Lo ideal es tener una tabla para cada producto: una para las verduras (previamente lavadas), otra para la carne, otra para el pollo, y otra para el pescado; y no mezclar carnes crudas con cocidas. La manipulación cuidadosa de los alimentos evita la contaminación cruzada y nos cuida de enfermedades transmitidas por los mismos, como la toxoplasmosis o el gravísimo síndrome urémico hemolítico. Lo ideal es que las tablas sean de plástico, no de madera, y que se renueven en cuanto empiecen a tener surcos que puedan juntar gérmenes. Deben ser prolijamente lavadas antes de cada uso.

8. Los platitos, biberones y otros utensilios deben ser libres de disruptores endocrinos como el bisfenol A y los ftalatos. Los platitos de madera (que pueden ver en algunas fotos de este libro) no sirven para cortar encima ni para colocar cosas húmedas: son simplemente para apoyar y presentar alimentos, manteniéndolos siempre secos.

Una yapa: la vianda

Empecé a hacer viandas cuando mi niño comenzó el jardín de infantes y descubrí una pasión profunda por las mismas. No, no puedo explicar la razón. Simplemente me divierte pensar qué puedo mandarle al día siguiente y qué podemos cocinar juntos la noche anterior. Suelo cocinar de más y mandar al *freezer*, para los días en que no llego a hacerlo. Creo que siento que mando un pedacito de mí en esa cajita, para acompañarlo en las horas que no nos vemos.

Para armar la vianda, primero pienso en la fruta o verdura que voy a

enviar. Trato de que sea algo fácil de comer y que no ensucie mucho. Peras, manzanas, uvas, frutillas, ciruelas, kiwi, bastoncitos de papa o batata al horno, espárragos, chauchas, choclo, ananá. Los viernes, si estamos en época de cítricos, es un buen día para mandar cosas que ensucien el guardapolvo si no hay otra fruta a mano: mandarinas o naranjas, por ejemplo, por la cantidad de jugo que tienen (¡así hay todo un finde para lavarlo!).

Después pienso en qué preparación voy a incluir. Yo preparo desayunos, otros mandan desayunos y almuerzos, y otros tantos, meriendas. No hace falta que el desayuno sea dulce y el almuerzo salado. Eso es simplemente cultural.

Ejemplos de viandas de desayuno

Lunes: frutillas + albóndigas de lentejas

Martes: uvas + galletitas de porotos negros

Miércoles: chauchas + budín de banana y lupino

Jueves: peras + tortillitas de papa

Viernes: naranja + galletitas de harina de maní

Algunas frutas se oxidan al ser cortadas, eso no es malo ni hace mal. A algunas personas no les gusta verlas así, y para evitar esto, podemos rociarlas con jugo de limón o de naranja.

Para cuidar la conservación de los alimentos, podemos **enviar las viandas dentro de un recipiente hermético y esto colocarlo dentro de una conservadora con un pack de frío en su interior.** El recipiente, con que cierre bien, basta, pero hay en el mercado una hermosa variedad de opciones con y sin divisiones; con y sin cubiertos; de plástico, de metal, de silicona. Queda en cada familia elegir el recipiente que más les guste y les sirva.

Existen también unos termos bajitos y anchos que sirven para la conservación de alimentos fríos o calientes. Idealmente, lo que no se consume en breve, debería ir a la heladera para preservar la inocuidad de los alimentos.

Alimentos para tener a mano

Mientras termino de escribir este libro, mi hijo crece. En las últimas dos semanas, aprendió a decir unas cincuenta palabras nuevas, y ayer entró a la cocina, me anunció claramente que tenía hambre, abrió la heladera, sacó una zanahoria cocida de adentro de un *tupper* y se fue muy tranquilo a alimentarse por ahí, ante la mirada estupefacta de su madre.

Entonces, como esto les sucederá a ustedes también, paso algunas sugerencias para tener en la heladera y en el *freezer*. **Recordemos que los chicos comerán lo que esté a mano.** Si a mano hay choclo, comerán choclo; si a mano hay galletitas, comerán galletitas.

Alimentos que podemos tener en la heladera preparados y a mano (las preparaciones duran como máximos unos 3 días en la heladera)

- Fruta, siempre fruta. Fruta lavada, variada y lista para ser devorada por pequeños predadores
- Huevos duros
- Cremas de alguna legumbre, dulces o saladas
- Brócoli cocinado
- Tortilla de papa
- Fainá
- Aceitunas, pepinos encurtidos, berenjenas en escabeche (para mayores de 1 año, por el contenido de sodio)
- Tomates *cherry*
- Tomates secos rehidratados
- Choclo
- Chauchas ya cocidas
- Zanahorias cocidas
- Bastones de papa o batata al horno
- Polenta grillada
- Milanesas cortadas en bastones, de legumbres o de carnes
- Pan casero
- Budines simples

Alimentos que podemos tener freezados

El *freezer* es salvador. Me encuentro cada mediodía de cuarentena mirando un tanto desesperada mi cocina, girando en 360°, pensando en qué magia saldrá en el día de hoy ante la mirada atenta de un niño y un perrito que vuelven famélicos de la plaza. Y de repente me acuerdo de que mi yo del pasado freezó esa porción de locro tan rico que se descongela en dos patadas en la ollita, y que lo puedo acompañar con unos pepinitos en vinagre y unas naranjas bien otoñales.

Me costó mucho aprender a usar el *freezer* y volverlo un aliado, pero hoy por hoy, le tengo un cariño intenso. Cuando cocino y sobra, y sé que no se comerá en la próxima comida, se va al *freezer*. Cuando compro un pan orgánico mágico de centeno cultivado por hadas en el rancho de Inodoro Pereyra en la pampa húmeda, el cual sé que no lo vamos a comer en dos días y pronto será alimento de hongos, lo corto y se va al *freezer* raudamente. **El 90 % de las cosas se pueden freezar, y las que no, hay que probar. Haciendo uno aprende.**

Les comparto algunas ideas

- Hamburguesas y albóndigas de legumbres.
- Budines (a mí me gusta hacer budines pequeños, o cortar un budín grande en rodajas y freezarlas).
- Masa cruda para cocinar, de galletitas, por ejemplo.
- Panqueques, *waffles* y *muffins*.
- Pan, galletitas caseras.
- Frutas y verduras congeladas (una buena opción para cuando compramos vegetales de más o cuando no llegamos a comprar y nos encontramos a las 9 pm en cuarentena y no sabemos qué hacer).
- Salsa de tomate congelada.
- Chipá crudo.
- Legumbres ya remojadas o ya cocidas.
- Cereales cocidos (arroz, trigo burgol, etc.).
- Tofu.
- Guiso o locro ya preparados.

¡Suerte y después me cuentan!

Para seguir leyendo

Libros de cocina que me gustan mucho y de los que saqué muchas ideas estos últimos años.

- Kiako, N. *Cómo como. Un manual de autoayuda en la cocina saludable*, Sudamericana, Buenos Aires, 2016.
- Kiako, N. *A cuatro manos. Cocina natural para compartir con los chicos*, Sudamericana, Buenos Aires, 2018.
- Martín, P. *La re-evolución de la cocina*, Urano, Buenos Aires, 2014.
- Lambertini, P. *Al natural*, Sudamericana, Buenos Aires, 2016.
- Di Cola, L. *Sin delantal*, Atlántida, Buenos Aires, 2017.
- Del Percio, P. *La movida del vegano*, Abrecultura, Buenos Aires, 2019.
- Lepes, N. *Ñam ñam. Manual para alimentar a un pequeño omnívoro*, Planeta, Buenos Aires, 2017.
- Gao, K. *Mon petit glouton. 70 recetas para bebés gourmet*, Qian Gao, Buenos Aires, 2016.
- Troncoso, L. *Fácil y nutritivo: Cocina para humanos de todas las edades*, Planeta Argentina, Buenos Aires, 2016.
- Luna, J. *Rico para bebés y para toda la familia*, Edición independiente, Montevideo, 2017.
- Luna, J. *Cocina en familia. Natural, integral, de estación*, Edición independiente, Montevideo, 2021.
- Curso de Manipulación Higiénica de los Alimentos, Buenos Aires, 2018.
- Curso Enfermedades Transmitidas por Alimentos, Sociedad Argentina de Pediatría, 2017.

Huerteando a todo ritmo

La soberanía alimentaria se construye
con la valentía de quien cuida una semilla
y relata su camino,
para que una nueva generación siembre
historia, alimentos y saberes.



Cuando mi niño estaba por cumplir 1 año, me puse a pensar en qué regalarle. Juguetes tenía muchos, y estábamos muy agradecidos por ellos, pero siendo tan pequeñito, no le interesaba tanto desenvolver regalos como golpear *tuppers* con cucharones. La idea llegó al ver que una amiga había contratado a Lucrecia para sembrar la terracita de su casa. **Y ahí se me ocurrió: le regalaríamos una HUERTA.**

Lucrecia y Abel llegaron un día de diciembre en su camioneta, viniendo desde lejísimo, con bolsas de tierra, canteros de madera, semillitas, verduritas y el corazón lleno de amor por su trabajo. Hijito tocó, metió las manos en la tierra, revisó la caja de herramientas, su compañero perrito le lamió la cara intensamente a Lucrecia. Nos llenaron el cantero de tomates, que crecieron como locos durante todo el verano. Acelgas, lechugas, berenjenas y apio se sumaron a nuestro balconcito soleado. Algunos prosperaron, a otros los dejamos ir agradecidos. Tuvimos que entender que para que la tierra respire y las plantas crezcan, cosechar, retirar de la tierra esa planta que con tanto amor criaste, también es importante.

Hijo disfrutó y disfruta enormemente de esa experiencia. Aprendió a regar antes de aprender a caminar. Comió tomates directamente de la planta, y le dijimos a algunos pajaritos voraces que esos eran nuestros frutitos y que les convidábamos otra cosa pero que no se los comieran. ¡Cosechamos un zapallo cabutia! Y nos divertimos con los zarcillos que se enroscaban a las rejas del balcón (inclusive una planta intrépida creció colgada hacia el piso de abajo y un zapallo gigante creció frente a la mirada atónita de los vecinos... ¡Había un zapallo colgando frente a su ventana!). Removimos tierra con un rastrillo pequeño, y no voy a negar que parte de esa tierra terminó en la boca. Cortamos hojitas de menta para oler e hicimos dibujos de las flores de la berenjena. Conservamos en un herbario las hojitas secas, con nombre y apellido, para recordar en algunos años lo lindo que fue haber compartido estos momentos juntos.

La experiencia huerta, contrario a lo que podríamos creer, no requiere miles de horas de trabajo ni de un campo gigante. Es un ratito a la mañana antes de empezar a trabajar, o a la noche antes de dormir, mirar

una plantita en una maceta, si se chamuscó, si sacó hojas nuevas, ¿de qué color son las hojas?, ¿cuántas son?, ¿qué aroma tienen? Regar tiene un trabajo gigante de coordinación: dónde mandar el chorrillo, hasta dónde llenar la regadera, cuánto mojarse (¡y tiene mucho que ver también con el control de esfínteres!). **Todo eso construye recuerdos y sensaciones en el cerebro de las infancias, que tienen que ver directamente con el acto de alimentarse, tanto de experiencias como de comida.**

Tips para huerteros con poco tiempo

(Por **Lucrecia Michelotti**, técnica en Jardinería y Horticultura Urbana.
@huertaslulu)

- **Toda semilla que cae en manos de una familia se puede germinar.**
La experiencia se puede hacer con semillas grandes, como la de la palta, o semillas chiquitas, como las del tomate. Ver que algo más pequeño que ellos, y que ellos cuidan, va germinando es una experiencia fascinante para los chicos. Es un proceso del cual se apropian y que genera maravillas. Los chicos tratan con amor la semillita, aprenden lo que hay adentro, entienden que en ese microchip hay... ¡una planta entera o un árbol!
- **Podemos pasar esas semillas a un recipiente con un poquito de tierra y ponerlo a la luz, a ver qué pasa.** Podemos usar las hueveras, un recipiente de plástico descartable, un *tupper* viejo que se pueda agujerear abajo. Los chicos empiezan a entender cómo funciona la luz en las plantas, cómo buscan al sol para crear su alimento. Acá se juega algo emotivo: a todos los seres vivos nos gusta que nos traten bien. ¿Cómo tratamos a la plantita? ¿Cómo nos gusta que nos traten? Poner en palabras sentimientos y emociones es parte del trabajo huertero.
- **¿Qué hacemos con la planta cuando crece? Podemos seguir adelante en una macetita, cuidándola y observando sus cambios.**
Si no tenemos un espacio para plantar un árbol en casa, se pueden circular los pequeños arbolitos a escuelas, espacios comunitarios, residencias de adultos mayores.
- **No posponer el deseo de germinar algo por no tener espacio, sino incorporar a otras personas a la experiencia,** trabajar en sociedad,

plantar en un espacio público y ponerle un cartelito: “¡Hola! Soy un arbolito de palta, me criaron en familia y me están cuidando”. ¡Invitar a otras familias a participar!

- **Consultar a gente especializada en huerta.** Muchas personas se dedican a ello hoy por hoy, y existe mucha información en las redes sociales. Nos pueden ayudar a determinar el sol y la sombra de nuestros espacios, su humedad, las plantitas que pueden ser parte de nuestra vida.
- **La frustración va a estar: algunas plantas se van a poner cachuzas y se van a morir, y es parte del ciclo y del aprendizaje.** Las infancias atraviesan las preguntas sobre los ciclos vitales con una sencillez abrumadora para nosotros, los adultos, y la huerta puede ser parte de trabajar estas cuestiones tan complejas.
- **Cuando se trabaja la huerta, aparecen muchas preguntas.** ¿Dónde viven las lombrices? ¿Por qué viven debajo de la tierra? ¿Qué comen? ¿Por qué las plantas tienen raíces? ¿Por qué se caen las hojas en otoño? El espacio de diálogo se abre, y si bien no sabemos todo, podemos buscarlo juntos y charlarlo en la mesa con relación a los alimentos que consumimos.
- **Para niños y niñas con dificultades en la alimentación, la huerta es un espacio de vinculación con los alimentos.** Existen, por ejemplo, flores comestibles, que a los chicos les fascinan y hasta se ponen a hacer preparaciones solamente para agregárselas.
- **Los chicos y las chicas llevan la información a la casa.** Empecemos a escucharlos. Démosles el espacio para contar sus descubrimientos que necesitan y merecen.

Las plantas por estación (hemisferio sur)

La naturaleza es muy sabia y, por ejemplo, en verano, cuando necesitamos mucha agua, nos regala frutos con mucha agua: sandía, melón, tomate, frutillas. En invierno predominan los cítricos con mucha vitamina C, que nos ayuda a absorber bien los otros nutrientes y da fuerza al sistema inmune.

Dejo una lista pequeña sobre los posibles cultivos por estación. Fíjense,

por ejemplo, que las lechugas y el perejil se pueden cultivar todo el año, así que... no hay excusa.

Cultivos de otoño/invierno	Cultivos de primavera/verano	Cultivos para todo el año
Brócoli	Tomate	Lechugas
Repollos	Pimiento	Rúcula
Coliflores	Berenjena	Acelga
Repollitos de Bruselas	Zapallo/zapallito/zucchini	Zanahoria
Espinaca	Sandía	Rabanito
Cebolla	Melón	Perejil
Puerro	Albahaca	Ciboulette
Ajo	Maíz	Verdeo
Escarola	Poroto chaucha	
Radicheta	Pepino	
Kale	Calabaza	
Pack choi	Papa	
Akusay	Batata	
Habas	Frutilla	
Arvejas	Luffas	
Cilantro	Cosmos	
Remolacha	Copetes (tagetes)	
Caléndulas		
Borrajás		

Agricultura urbana

La arquitectura urbana claramente no invita a arar la tierra y sembrar al voleo. Pero sí podemos tener un indicio de huerta en nuestro balcón, ya sea que le dé el sol todo el día o tengamos pura sombra. Las huertas verticales son una muy buena opción también.

En el consultorio tenemos un patio microscópico, en medio de la ciudad, todo gris y húmedo. No llega ni un rayito de sol. Por más que quisimos poner tomates y zapallos, desechamos la idea porque no prosperarían. Sin desesperar, apostamos por plantas que se llevan bien con la sombra: lazos de amor, algunas aromáticas, cactus, suculentas. Ese pequeño espacio es un lugar que también contribuye a nuestro trabajo: en algunas sesiones de fonoaudiología, terapia ocupacional, kinesiología o nutrición, nos acercamos

a nuestro cajoncito de plantas con olorcito, colores y texturas, y las usamos para aprender.

Una maceta con un perejil es mucho más que nada. Un poroto germinado en un frasquito es contacto con la naturaleza y aprendizaje acerca de dónde viene el alimento. **En un departamento o una casa sin patio ni balcón, germinar en una bandejita o usar las ventanas también es una opción.**

Y sí, las plantas se arrugan y se mueren muchísimas veces. Y eso también es aprendizaje, y un empezar de nuevo continuo, también para aprender.

La huerta como espacio social

Hace unos años, cuando aún circulaba por Twitter, me encontré con la experiencia de Fernanda en las huertas de barrios de Zárate. Ella contaba, en un relato lleno de fotos increíbles (tengo tatuada en la retina una foto en especial, en la que un preadolescente mira con infinito amor una planta de lechuga recién cosechada), cómo los espacios populares se transformaron en huertas, y cómo los chicos participaban con entusiasmo e infinitas GANAS del crecimiento de esas lechugas y choclos, que después eran parte de su alimentación cotidiana, a veces, los únicos vegetales que comían. Este espacio también los habilitaba a ser niños y niñas. La invité a contarnos un poco su experiencia:

Me llamo Fernanda de la Puebla y trabajo desde 2015 en políticas de participación ciudadana y descentralización en el territorio.

Mi experiencia comenzó de casualidad cuando empecé a trabajar en el Centro de Participación Municipal de Malvicino, en Zárate. La función administrativa del centro había migrado hasta convertirse en el único refugio que tenían los chicos del barrio. El día que llegué vi que el lugar contaba con una pequeña porción de tierra y que allí había ocurrido una experiencia de taller de huerta para adultos con el apoyo del INTA. En ese momento me sucedieron muchas preguntas sobre los espacios de

participación que había para los preadolescentes, y se me pasó por la cabeza volver a contactar con el INTA para la proveeduría de semillas, e intentar rehacer la huerta, pero esta vez, con la participación de los chicos.

Era mi primera vez en una experiencia de este tipo. No tenía idea de cómo hacer una huerta. Lo que sí tenía claro era la importancia de hacer partícipes a los chicos en todas las fases del proceso, para que la huerta se sostuviera en el tiempo, y generar sentido de pertenencia sobre el espacio.

Leímos los manuales que nos daba el INTA y juntos diseñamos la siembra pensando en cultivos asociados, y experimentamos sin miedo a equivocarnos. Aprendí junto a los chicos, y hacerlos parte del diseño de la huerta y que el aprendizaje haya sido colaborativo durante todo el proceso, potenció las relaciones entre ellos y disparó el ingenio, la imaginación y la reflexión.

Aprendimos que lo primero es seleccionar el espacio donde se va a hacer la huerta. Ver por dónde sale el sol y por dónde se esconde. Calcular cuántas horas de sol reciben las plantas. Después tenemos que ver qué queremos plantar y qué plantas se relacionan bien. Los tomates, por ejemplo, los pusimos contra la pared, porque no les gusta el viento. Cerca de los tomates, lechugas y albahaca. Porque si se llevan bien en la mesa, se llevan bien en la tierra.

Una vez que tenemos listo el espacio para cultivar, tenemos que planificar, en base al sol y a la asociación, qué vamos a poner. Yo puse plantas que crecen para abajo, mezcladas con plantas que crecen para arriba y plantas que sirven como tutor. Por ejemplo: maíz (choclo) al lado de los porotos, cuando estos crezcan, se los enreda con el maíz.

El cultivo por asociación es genial para no aburrirse. Las plantas se ayudan entre sí y crecen sanas y sin plagas. En los extremos, siembran flores: caléndulas, copetes, etc., porque espantan a los bichos malos y atraen a las abejitas, nuestras aliadas.

Nos sorprendimos juntos cuando vimos que al maíz blanco le salían unas patitas en el tallo que lo ayudaban a mantenerse, estoico, en pie. Nos alegramos con los primeros rabanitos. Se repartían las lechugas, las acelgas, las remolachas, las calabazas en función de lo que más le gustaba a cada uno. Aprendimos a disfrutar de los ciclos, nos tranquilizamos mirando un brotecito asomar. El conjunto de cosas que sucedían alrededor de la huerta era realmente mágico...

Lo principal es la participación ciudadana, porque sin participación, las políticas públicas no se sostienen en el tiempo. Los chicos encontraban un lugar donde se sentían escuchados e importantes, porque había gente que se preocupaba por las cosas que les preocupaban a ellos y no les imponían nada. Recuerdo que Martín, el Chacha y Evaristo andaban calzados con gomeras y el resto les tenía miedo, los prejuizaban. Se habían hecho la fama en el barrio de “terribles”, pero de a poco, charlando de cosas que a ellos les interesaban, surgió una relación preciosa con tres chicos que ya estaban señalados por el resto.

El factor ambiental en la vida de estos chicos es fundamental para que el deseo tenga continuidad a lo largo de su niñez y su adolescencia, se habilitaban las condiciones simbólicas que acompañan a las materiales para que la inclusión y la igualdad sean reales. Habían encontrado un lugar donde poder ser niños y ejercer como tales.

Con el Chacha, por ejemplo, sembramos, arreglamos la huerta y sacamos yuyos. Le enseñé a semillar los rabanitos y cosechamos las verduras que le gustaban. Ahora es el profesor de huerta y les enseña a los otros.

El espacio que armó Fernanda junto con los chicos les dio un lugar para no estar en la calle, donde podían ser niños, les dio un conocimiento y una sabiduría que van a llevar a todos lados, y a compartir, para siempre. No fue una pavada y costó. En palabras de Fernanda: “Sabía que era muchísimo laburo, pero no aflojé. Sabía también que no todas las familias iban a continuar la experiencia, pero no me desanimé. Mi idea era acercar el laburo

de la huerta a los pibes, para que aprendan a cuidar plantas que se comen y aprendan a comer”. Sin duda, lo lograron, todos juntos, y hoy nos enseñan a nosotros.

El compost

La mitad de los residuos que generamos son orgánicos. **El compostaje es un proceso de transformación natural de los residuos orgánicos mediante un proceso biológico de oxidación que los convierte en abono rico en nutrientes y sirve para fertilizar la tierra.** Es decir, el compost son los residuos orgánicos degradados que van a servir como alimento de otras plantas. A través del compostaje se puede reducir gran parte de la cantidad de basura que va a los basurales, dentro de bolsas de plástico.

Ok, ¿pero dónde pongo a compostar cosas en mi departamento o en mi casa pequeña? En casas que tienen jardín, se puede compostar directamente en el suelo, en un rincón del patio. Pero para los que no contamos con ese espacio, existen dispositivos cada vez más coquetos, llamados “composteras”, en forma de vasijas o cajas apilables en las cuales podemos meter nuestra basura orgánica y esperar este proceso de oxidación. No genera olor ni moscas (lo digo por experiencia). Podemos incluir lombrices en la compostera, que harán más efectivo el trabajo. Las composteras se pueden comprar o hacer en forma casera, con tachos grandes como los que se utilizan en las heladerías o incluso canastos como de ropa.

Compostar también requiere un aprendizaje. Hay que elegir qué residuos son los mejores para ese compost, separar la basura orgánica de la que no en la cocina, revolver cada tanto lo que hay dentro de la compostera para que ingrese oxígeno y los microorganismos estén más contentos, estar atentos al ciclo del compost, retirarlo y llevarlo a otras plantitas (por ejemplo, a la plaza). Pueden ser tareas lindas para encomendarles a los chicos, esas pequeñas “responsabilidades” que van tomando a través de los años con infinita seriedad. Y los chicos lo contarán en la escuela, lo dibujarán en los cuadernos, así otros chicos y chicas se enterarán, y ahí seguirá la hermosa rueda de la información compartida.

Para seguir leyendo

PARA FAMILIAS Y PROFESIONALES

- Tébar, C. *El huerto en casa al estilo Montessori*, (1.a ed.), Plataforma Editorial, Barcelona, 2017.
- INTA. (2017). Cómo hacer compost de forma práctica y sencilla. *INTA*. Recuperado de: <https://inta.gob.ar/documentos/como-hacer-compost-de-forma-practica-y-sencilla>
- Schonwald, J. y Pescio, F. J. *Mi casa, mi huerta: técnicas de agricultura urbana*, (1.a ed.), edición literaria a cargo de Daniela Novelli, ilustrado por José Mariano Luengo, Ediciones INTA, Buenos Aires, 2015.
- Herrera Bravo, C. M. (2018). Horticultura como medio de intervención: UNA MIRADA ECOLÓGICA DESDE LA TERAPIA OCUPACIONAL. *Revista Chilena de Terapia Ocupacional*, 17(2), 169. DOI: <https://doi.org/10.5354/0717-5346.2017.48143>.

Comer nos encuentra y nos reúne

Comer es el acto más complejo que realiza el ser humano. No solo involucra a múltiples sistemas del cuerpo humano, sino que involucra a un *otro*. Comer es un acto social, desde el bebé que se prende al pecho hasta el adulto que cocina para su familia en Navidad.

Comer nos convoca, nos encuentra, nos reúne. Nuestra cultura celebra la comida: las mesas en las fiestas crujen debajo de todos los platos sabrosos que se puedan compartir, y nadie iría a la casa de un amigo a tomar mate sin llevar algo para comer (o pedir disculpas por no haberlo llevado).

“Comer” viene del verbo latino *comedĕre*, que está formado por una raíz: *edere* (ingerir), de donde también derivan el *eat* en inglés y el *essen* en alemán, y el prefijo *com*, que significa “con otros”. Etimológicamente, “comer” significa “ingerir con otros”. En la misma línea, “compañero” significa “comer del mismo pan”, y remite a dos o más personas compartiendo el alimento cotidianamente, por consiguiente, la conversación, la vida y los desafíos. Y “alumno” no viene de “sin luz”, viene de “alimento”. Alumno es el que está alimentándose, el que tiene hambre voraz de aprender.

A partir de miles de mensajes sobre cánones de belleza e imposiciones de “salud”, nos han robado el placer de comer. A través de los años se fueron las recetas, y aparecieron los “permitidos”, los “prohibidos”, los polvos mágicos y hasta las zapatillas para bajar de peso. Nos preocupa horrores que las niñas y los niños no coman el plato entero, y en cuanto pisan la adolescencia, se los insta a dejar de comer. Somos seres humanos y habitamos este mundo de contradicciones, conflictos de interés e imposiciones culturales. Y dado que hay datos certeros de que todo esto condiciona permanentemente nuestra salud, es urgente tomar acciones.

Recuperar los aromas de la cocina, animarse a transitar experiencias nuevas sin miedo y con los ojos de las infancias, es en parte hacer un recorrido que no conocimos en nuestra experiencia alimentaria.

Encontrar los sabores de verdad y no los que inventó alguien en un

laboratorio, saber cómo es la florcita del garbanzo, ver desarmarse un poroto, apretar una masa aromática que está levando, desgajar una mandarina... es el camino para volver a conectarnos con los alimentos y, de a poco, repensar los sistemas alimentarios.

Que no nos roben las experiencias, los momentos compartidos a través de los alimentos, y la infinita diversión.

Gracias por permitirme acompañarles en este camino.

Para leer (¡sí, más!)

- Sztajnszrajber, D. (2010). *Alumno viene de alimento*. Disponible en:
<http://sztajnszrajber.blogspot.com/2010/05/alumno-viene-de-alimento.html>
- Aguirre, P. *Una historia social de la comida* (1.a ed.), Lugar Editorial, Buenos Aires, 2019.

Agradecimientos

El agradecimiento más grande a la persona pequeña con la cual convivo y, día tras día, me regala ver el mundo con sus ojitos curiosos. Gracias Lisandro por tu transitar en este mundo; es mi fortuna más infinita: que tomes mi mano para acompañarte en él.

A mi primer maestro, Juan Martín, que me mostró que el mundo está lleno de amor y belleza si nos atrevemos a verla.

A mis amigos y amigas, por el acompañamiento, la paciencia, la claridad de sus palabras y su corazón inmenso.

A mi familia, que adopta otras formas, crece y transita otros caminos de entendimiento y amor.

A Godzilla, compañero, perrito, *influencer*.

A María Funes, por el amor sincero en el cuidado de mi niño.

A mis gurús y amigas Soledad Barruti y Natalia Kiako, por su valentía, su compañía y por abrirme los ojos a un mundo hermoso de alimentos y placer.

A todo el equipo que me acompaña en el trabajo diario: Nadia Kiako, Lucía Bastita, Skills Comunicación. Agradecida por todos los momentos de seriedad, de risas, de *stickers* de WhatsApp y de mantener a flote el trabajo de muchos años cuando me sentía venir abajo.

A mi coequiper en la Escuela Argentina de BLW, Naida Porreca, por mostrarme que los sueños pueden dejar de serlo y convertirse en realidades; y a Pamela Spolidori por su ejemplo y apoyo en absolutamente todo lo que soñamos.

A todas/os las/os profesionales que revisaron el manuscrito, dando

consejos y sugerencias sobre temas de los que saben infinitamente más que yo. Entre ellos agradezco especialmente a María Fernanda Iroumé, Paula Galo, Dalma González, Carolina Antonietti, Virginia Vázquez, Martín Schneider, Lucrecia Michelotti, Fernanda de la Puebla, Verónica Barreyro, Viviana Videla Linares y Gabriela Carrasco, por sus aportes en diversos capítulos.

Al equipo de Jacarandá Salud, por acompañar la propuesta y brindar su trayectoria y compromiso para generar nuevas formas de atención.

A toda la comunidad que me acompaña y que enriquece día a día el trabajo y las ganas de aprender.

A todas las personas que me crucé en este camino trabajando para que la alimentación saludable sea respetada como parte del derecho a la salud en la infancia, y no como un privilegio.

A mis docentes y mis compañeras/os por regalarme esta vida de eterna aprendiz.

A mis pequeñas y pequeños consultantes, por el mundo de colores al que me trae siempre la pediatría.

A todos los emprendedores que participaron en las fotos de este libro: casi todos los platos de cerámica son de Ofelia Cerámica, hechos especialmente y con amor para este libro (@ofelia.ceramicas), los de maderita son de Pakape (@pakape.arg) y los de silicona son de Isatina (@isatinaok), excepto el de la página 191, que es de Rainbow Argentina (@rainbow.argentinaok). Las frutas y verduritas de tela son obra de Ponchi Market (@ponchiponchicomiditas) y las cacerolas Essen fueron brindadas para las fotos por Pamela Spolidori (@pamelaspolidori). Para las fotos de comidas y recetas, un agradecimiento grande a Biomarket Orgánico (@biomarket) y a la Dietética Rincón de Sabores (@dietetica_rds). Y qué sería de mí sin mi querida amiga Celeste Di Rosa, que me salva siempre y armó la indumentaria para las distintas fotos (@rechachi_indumentaria).

Al mismo tiempo, quiero agradecer a Hey Baby! (@heybabyeatgood),

Medio Limón (@mediolimondeLamor), Aloe Natural (@aloe.natural) y Onda Fit (@ondafit_lp), por ayudar a esta madre llena de trabajo a tener opciones sanas en el *freezer* y en la alacena para transcurrir el día a día.

A todo el equipo de Planeta, con quien transitó este libro, el cual fue una experiencia profundamente transformadora desde lo personal y lo profesional.

Este libro se empezó a escribir hace unos meses, con infinito entusiasmo y a gran velocidad. Pero, en el medio, nuevamente, uno de los pilares de mi universo se despidió. Nadia, amiga querida, te extraño infinito. Gracias por haber iluminado mi vida y la de todos los que te conocieron. Nunca te vamos a olvidar.

MENÚ SEMANAL

Compras

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

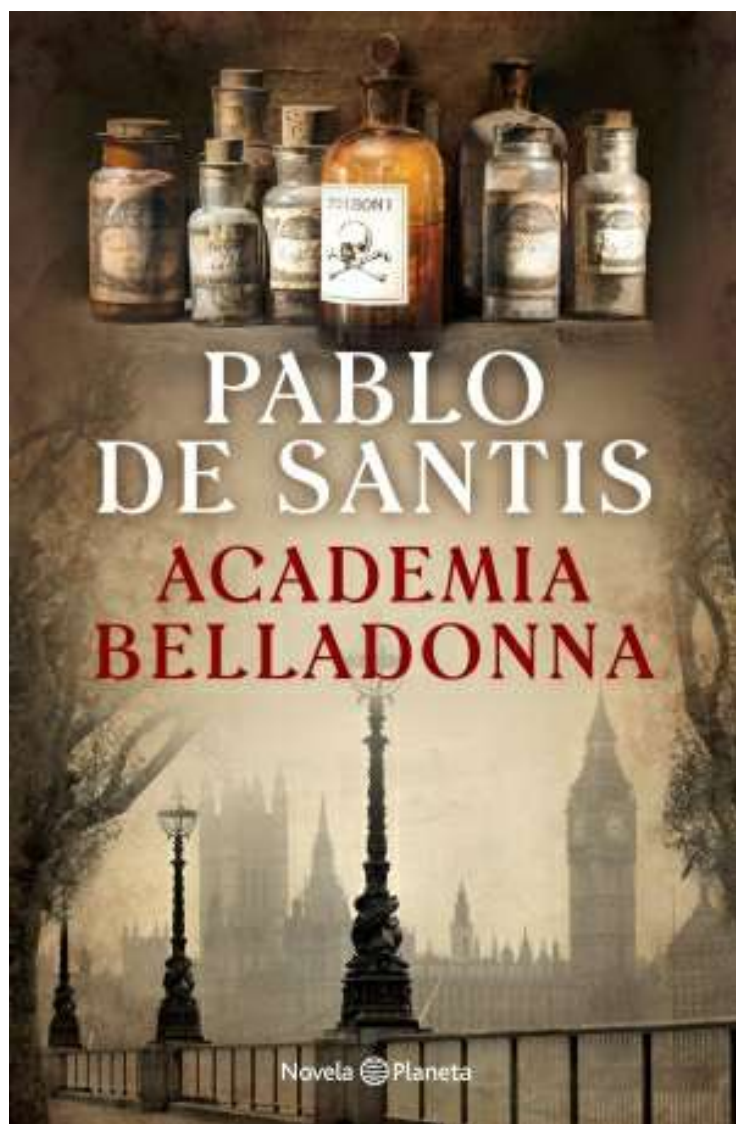
Grupo  Planeta

¡Seguinos!



¿Te gustó este libro? Te recomendamos...





Academia Belladonna

De Santis, Pablo

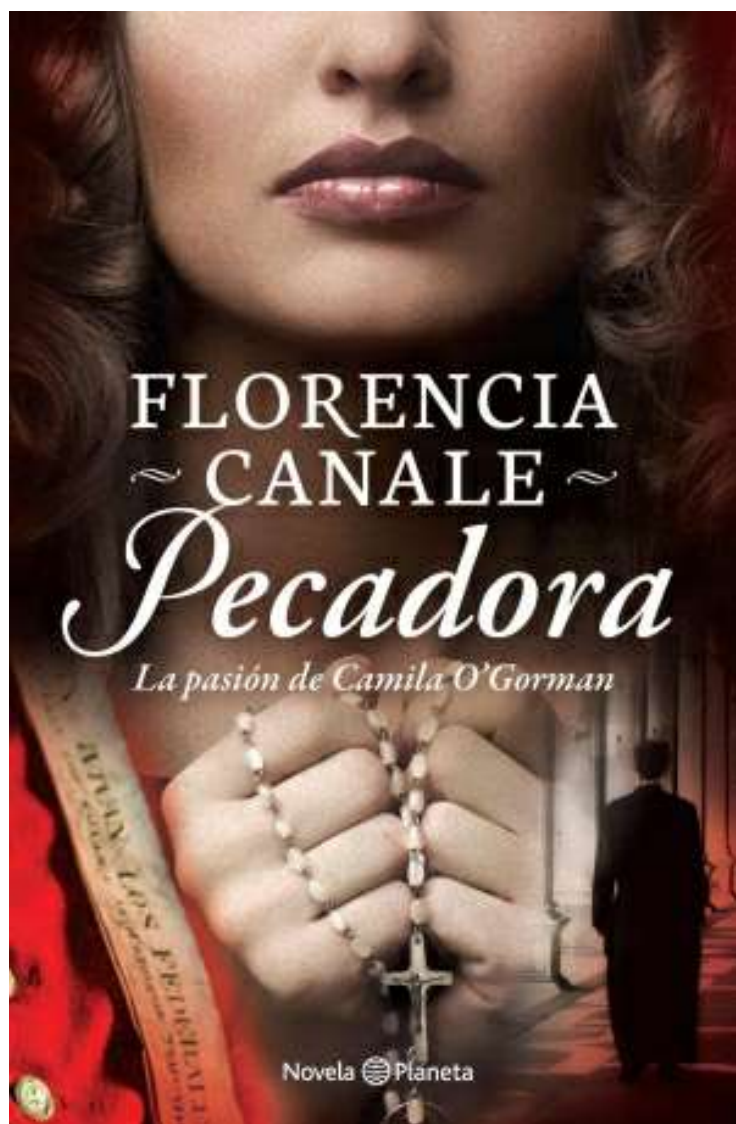
9789504974987

192 Páginas

[Cómpralo y empieza a leer](#)

Londres, 1932. Un pequeño negocio de venta de estampillas es la entrada a la Academia Belladonna, una escuela de asesinos. Hasta allí llega el joven Duncan Dix para aprender las técnicas que le permitan vengar la muerte de sus padres. Como un héroe trágico poseído por el pasado, el temperamental muchacho es guiado por el afán de justicia. Mientras dedica las primeras horas del día a doblar camisas en una gran tienda, a partir del anochecer se reúne con el resto de los aprendices en las aulas de la Academia Belladonna, dispersas en distintos enclaves de la ciudad, lugares propicios para ejercitarse en un tipo diferente de asesinato. Entre venenos, armas de fuego y cerbatanas, descubre el vínculo entre el crimen y la filatelia, conoce los riesgos del oficio, se asoma a la seducción y al amor y aprende a matar. Mientras avanza hacia la venganza fatídica, un cuarto cerrado lo espera: la habitación clausurada del pasado familiar. Con su habitual maestría, Pablo De Santis cuenta una historia atrapante donde el arte del crimen se realza con inteligencia, ligereza y originalidad; el espacio de aprendizaje a cargo de maestros inolvidables, las instancias imprevisibles de la investigación detectivesca que encara Dix y las pasiones que mueven a los personajes develan claves de la escritura misma y de un estilo inconfundible que lo confirma como un gran escritor.

[Cómpralo y empieza a leer](#)



Pecadora

Canale, Florencia

9789504974994

384 Páginas

[Cómpralo y empieza a leer](#)

Camila O'Gorman nació en 1828. Como si fuera un presagio de lo que vendría, ese mismo año las fuerzas unitarias al mando de Juan Lavalle fusilaron a Manuel Dorrego. Díscola y rebelde desde pequeña, Camila fue hija dilecta de su madre, motivo de preocupación constante para su padre y digna heredera del espíritu audaz de su abuela, la célebre Madame Périchon. Criada bajo los mandatos sociales y religiosos imperantes en la época, especialmente rígidos para las mujeres, protagonizó una loca historia de amor con un representante de la Iglesia, el padre Ladislao Gutiérrez. Transgrediendo todas las normas, la pareja dio rienda suelta a su ardor sin pensar en el después. Eran tiempos de Juan Manuel de Rosas y el incumplimiento de las leyes podía tener terribles consecuencias. Para estar a salvo, no bastaba con ser, también había que parecer. Pero "Camila quería ser libre como las heroínas de sus novelas. Libre para amar, sufrir, llorar, hasta para morir". Pecadora recrea en clave de novela la trágica historia de amor y pasión de Camila y Ladislao. Después de *La vengadora* y *La libertina*, Florencia Canale vuelve a retratar aquí a un personaje femenino intrépido e idealista, que luchó hasta el final contra las crueles imposiciones que pretendían cercenar su libertad.

[Cómpralo y empieza a leer](#)



Astrología para reencantar el mundo

Gaitán, Lu

9789504975014

480 Páginas

[Cómpralo y empieza a leer](#)

"Vivimos en un mundo de objetos inanimados, y esto es absolutamente funcional a la lógica de este sistema que busca extraer

máximos beneficios de todo lo que toca. Como dice Silvia Federici: "El mundo debía ser desencantado para poder ser dominado", haciendo alusión a la caza de brujas y la conquista de América". En esta nueva obra, Lu Gaitán, probablemente la astróloga argentina más sensible, nerd, curiosa y multifacética de la red, parte de la siguiente premisa: uno de los grandes problemas de la cultura occidental es que perdió el contacto con lo mágico y lo trascendente. Astrología para reencantar el mundo se propone entonces recuperar esa conexión. Es un libro para quienes no saben nada de astrología, para los que saben un poco, y para quienes saben más y quieren tener una perspectiva diferente. Es un manual completísimo en el que Lu reúne las respuestas a las mayores preguntas que se hizo a lo largo de su camino: qué es la astrología, cuáles son los mitos y las bases sobre los que se ha construido esta disciplina, y cómo se lee una carta natal, entre tantos otros temas. Y, sobre todo, es una invitación a ver la astrología con otros ojos, desde un posicionamiento ecofeminista, y a volver a encontrar la magia en todo lo que nos rodea para así fundar otras formas de vivir.

[Cómpralo y empieza a leer](#)

"Como en espejo con una Argentina que no fue, Canal 7 ha cargado con expectativas con las que ningún otro canal cargó: convertirse en la BBC u otra ilusión semejante. En este notable libro, resultado de una investigación exhaustiva y escrito con elegancia, Natalí Schejtman expone las tensiones (y la convivencia) de la política, los contenidos, el mundo gremial y las audiencias, y formula las preguntas urgentes sobre el destino de uno de los más misteriosos artefactos del país". MARTÍN SIVAK Después de ciento cincuenta entrevistas y la revisión de documentos públicos y archivos audiovisuales, Natalí Schejtman consigue la proeza de contar setenta años de historia argentina desde una óptica precisa y magnética: las idas y vueltas de su TV pública, de Evita a Sofovich, del levantamiento carapintada a 6, 7, 8. Entre la transmisión inaugural (el Día de la Lealtad de 1951) y el presente hubo cambios de edificio, de nombre, de logotipo, de programación, de relación con el poder y, sobre todo, de funcionarios. También se agigantó un mito: ese que sostiene que se trata, a la vez, de un elefante blanco y un agujero negro para el dinero de los contribuyentes. Schejtman, especialista en medios públicos internacionales, pone en cuestión ese y otros lugares comunes y recorre una historia que alterna momentos buenos, malos y horribles con nombres que hicieron grande a la televisión y otros que –aunque merezcan pasar al olvido– son ubicados en su justo sitio.

[Cómpralo y empieza a leer](#)



Palabras cruzadas NE

Rolón, Gabriel

9789504974949

336 Páginas

[Cómpralo y empieza a leer](#)

Hace poco más de diez años, Gabriel Rolón publicaba su segundo libro. Después del éxito rotundo y casi sin precedentes de *Historias de diván*, *Palabras cruzadas* llegaba a las librerías para reconfirmar el lugar central de su autor en la industria editorial de los últimos veinte años en la Argentina. Pero también –y en esto marca un verdadero hito–, terminaba de consolidar un vínculo inédito hasta ese momento entre el Psicoanálisis y un público lector cada vez más numeroso. Y no era para menos. En ese camino que el libro proponía –propone–, en ese tránsito desde el dolor hacia la verdad, los casos narrados dejaban honda su huella en quienes se atrevían al desafío. La angustia, los miedos, la sexualidad, el amor y el desamor, las adicciones y la soledad se dan cita en un viaje que paciente y psicoanalista emprenden juntos. Una travesía las más de las veces dolorosa, sí, pero que una vez cumplida se vive como transformadora, poderosa, irreductiblemente humana. En esta edición definitiva y revisada, que incluye un caso nuevo, Rolón se lee a sí mismo. Se anima a interpelar ese reflejo que le devuelve un espejo anclado hace más de una década, en una sociedad otra en la que los debates por las políticas de género, la legalidad del consumo de marihuana y los usos disruptivos de la lengua –de un idioma–, entre otras cosas, no tenían ni la visibilidad ni el peso específico que tienen hoy. Y es ahí, en ese gesto genuino, tan franco y veraz hacia los lectores (los de entonces, los de ahora), en donde el autor hace que *Palabras cruzadas* se vuelva, una vez más, un libro vital, orgánico, indispensable.

[Cómpralo y empieza a leer](#)